

Ensayo EUNACOM – Prueba 1

PRIMERA PARTE

1) ¿Cuál de los siguientes medicamentos suele usarse como profilaxis de migraña?

- a) Ergotamina
- b) Fluoxetina
- c) Sumatriptán
- d) Clozapina
- e) Amitriptilina

2) La alternancia eléctrica es característica de:

- a) Derrame pericárdico
- b) Pericarditis aguda
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Síndrome de Wolf-Parkinson-White

3) ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un criterio diagnóstico del síndrome X o síndrome metabólico?

- a) LDL alto
- b) HDL bajo
- c) Hipertrigliceridemia
- d) Hipertensión arterial
- e) Obesidad abdominal

4) El índice de ocupación de un hospital está dado por la relación entre:

- a) La duración promedio de las hospitalizaciones y el total de días-cama disponibles
- b) Los pacientes ingresados y el total de camas
- c) Los pacientes dados de alta y el total de camas
- d) Los días-cama ocupados y el total de días-cama disponibles
- e) La duración promedio de las hospitalizaciones y el total de días-cama disponibles

5) Un paciente de 35 años, consulta por cuadro de 4 semanas de evolución, de tos, con expectoración mucopurulenta, con estrías de sangre en algunas ocasiones, asociado a compromiso del estado general, baja de peso, fiebre intermitente y sudoración nocturna. Ha tomado amoxicilina en varias oportunidades, sin respuesta. Al examen físico destacan crépitos escasos, mayores en el ápice derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso pulmonar
- b) Bronquiectasias
- c) Cáncer pulmonar
- d) Linfoma
- e) Tuberculosis

6) Una paciente de 24 años, consulta por leucorrea amarilla y disuria. Al examen físico se observa dicha leucorrea, con paredes vaginales sin inflamación, sin embargo el cuello uterino se observa muy inflamado, con abundante secreción purulenta. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginosi bacteriana
- b) Candidiasis
- c) Tricomoniasis
- d) Gonorrea
- e) Vulvovaginitis irritativa

7) Una paciente Rh negativo cursa un embarazo de 28 semanas, sin inconvenientes. Se solicita prueba de Coombs indirecto que resulta negativa, al igual que la prueba de Coombs indirecto realizada a comienzos del embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar inmunoglobulina anti-D a la madre
- b) Solicitar ecografía obstétrica, con doppler de la arteria cerebral media fetal
- c) Solicitar prueba de Coombs directo
- d) Realizar cordocentesis y determinar el grupo sanguíneo fetal
- e) Dejar evolución espontánea, solicitando una nueva prueba de Coombs indirecto al final del embarazo

8) Un paciente de 24 años consulta por ardor epigástrico, irradiado a zona retroesternal, que aparece luego de comer y que se asocia a regurgitación frecuente de los alimentos. El examen físico es normal y la revisión por sistemas no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar pHmetría
- c) Solicitar manometría esofágica
- d) Iniciar omeprazol
- e) Realizar tratamiento erradicador de H. pylori

9) Un paciente de 67 años consulta por dolor abdominal asociado a fiebre. El dolor es constante, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen se aprecian en buenas condiciones generales, febril hasta 38°C, con FC: 100x', PA: 130/80 mmHg, hidratado y bien perfundido. El abdomen es blando, depresible, doloroso, especialmente en la FII, con resistencia muscular en dicha zona. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparotomía exploradora
- b) Realizar colonoscopia
- c) Iniciar clindamicina y paracetamol
- d) Iniciar ceftriaxona + metronidazol y solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Iniciar antiespasmódicos y sales de rehidratación oral

10) ¿Cuál de las siguientes opciones supone una MENOR gravedad en contexto de un trauma ocular?

- a) Hemorragia subconjuntival
- b) Discoria
- c) Hifema
- d) Disminución de la agudeza visual
- e) Enoftalmo

11) Un paciente de 30 años presenta un tumor testicular, que se confirma con ecografía, apareciendo como un nódulo sólido, redondo, de bordes regulares, de 3 cm de diámetro. Los marcadores tumorales resultan negativos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste y decidir manejo según hallazgos
- c) Realizar biopsia del nódulo por punción con aguja gruesa
- d) Realizar tumorectomía con biopsia intraoperatoria
- e) Realizar orquiectomía radical, por vía inguinal

12) Una mujer de 30 años presenta fenómeno de Raynaud en los dedos de las manos, que se ha ido intensificando y se ha agregado sensación de tirantez en la cara en el último tiempo. A lo largo de su evolución natural, probablemente presentará las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Elevación de las CK plasmáticas
- b) Hipertensión pulmonar
- c) Condrocálcinos
- d) Disfagia
- e) Esclerosis de los dedos

13) Los fármacos de elección para tratar los síntomas vasomotores perimenopáusicos son:

- a) Estrógenos
- b) Progestágenos
- c) Bloqueadores de calcio
- d) Antidepresivos
- e) Betabloqueantes

14) Un paciente cirrótico, por consumo de alcohol, consulta por compromiso del estado general, dolor abdominal y fiebre hasta 38,1°C. Al examen físico se aprecia ictericia, sensibilidad abdominal difusa, ascitis moderada, desorientación y asterixis. Se realiza paracentesis diagnóstica que demuestra salida de líquido amarillo, algo turbio, con 550 neutrófilos por mm³ y albúmina de 1,3 g/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Evacuar todo el líquido ascítico, sin necesidad de iniciar antibióticos
- b) Evacuar el líquido ascítico bajo cobertura antibiótica, con quinolonas o cefalosporinas de tercera generación
- c) Administrar una cefalosporina de tercera generación endovenosa y albúmina
- d) Solicitar pruebas hepáticas, hemograma y hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

15) Un niño de 3 años, con retraso del lenguaje presenta otoscopia con tímpanos rosados bilateralmente. No presenta otros síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar audiometría
- b) Solicitar impedanciometría
- c) iniciar amoxicilina oral
- d) Realizar adenoidectomía e instalación de colleras
- e) Observar evolución, controlando cada 3 meses

16) Un paciente de 70 años, diabético tipo 2, hipertenso, con antecedente de un infarto al miocardio hace 4 años, con buena función ventricular, en capacidad funcional 1, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, enalapril, aspirina y atorvastatina, presenta dolor precordial intenso, opresivo, asociado a disnea, desde hace 40 minutos. El examen físico constata un paciente taquipneico, bien perfundido, con FC: 101 lpm y PA: 146/100. La auscultación pulmonar demuestra RR3T, con presencia de R4 y . Se solicita electrocardiograma, que demuestra infradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar trombolisis inmediatamente
- b) Solicitar enzimas cardíacas y decidir manejo según resultado
- c) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar test de esfuerzo, una vez estabilizado el paciente
- d) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar coronariografía urgentemente
- e) Administrar aspirina y anticoagular con bomba de heparina, pasando a anticoagulación oral, con cumarínicos, una vez estabilizado el paciente

17) Un recién nacido prematuro de 30 semanas de gestación presenta un cuadro de compromiso de conciencia y rápido deterioro del estado general. Al examen se aprecia pálido, con la fontanela anterior abombada y en posición de descerebración. Usted sospecha una hemorragia periventricular. El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Electroencefalograma
- b) TAC con contraste
- c) TAC sin contraste
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Ecografía

18) Un paciente de 7 años, sin antecedentes de importancia, es mordido por su gato en la mano derecha, mientras jugaba con él. El gato es sano y tiene sus vacunas al día. Al examen físico se observan dos heridas punzantes de muy pequeño tamaño, sin exudado, en relación a la zona metacarpofalángica del dedo índice derecho, con escaso eritema circundante y mínimo dolor.

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar vacunación antirrábica y clindamicina
- b) Iniciar vacunación antitetánica y claritromicina
- c) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico
- d) Iniciar vacunación antirrábica y antitetánica y administrar ciprofloxacino
- e) Iniciar flucloxacilina por vía oral

19) Un paciente pesa 75 Kg y mide 150 cm. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad no mórbida
- e) Obesidad mórbida

20) Un niño de 8 años comienza con disestesias y debilidad de las cuatro extremidades, que han ido intensificándose al punto de imposibilitarle la marcha. Al examen físico se constata tetraparesia, con disminución del tono muscular y abolición de los reflejos osteotendíneos. Refiere haber presentado un cuadro de diarrea hace 10 días. El diagnóstico más probable es:

- a) Botulismo
- b) Poliradiculopatía desmielinizante
- c) Mielitis transversa
- d) Miastenia gravis
- e) Mononeuritis múltiple

21) Respecto a la hepatitis fulminante es cierto que:

- a) En Chile la primera causa es el consumo de alcohol
- b) Tiene muy baja mortalidad, pero con frecuencia evoluciona a cirrosis hepática
- c) Requiere de la presencia de ictericia y encefalopatía
- d) La Hepatitis A es una causa excepcional de hepatitis fulminante
- e) El tiempo de protrombina generalmente se encuentra conservado

22) La medida más importante para prevenir las convulsiones en una paciente embarazada, con preclamsia severa es:

- a) Administrar benzodiazepinas a partir de la semana 32 de gestación
- b) Indicar sulfato de magnesio oral a partir de la semana 32 de gestación
- c) Administrar benzodiazepinas endovenosas durante el trabajo de parto o ante la presencia de exaltación neurológica
- d) Administrar sulfato de magnesio endovenoso durante y después del parto
- e) Interrumpir el parto por cesárea al cumplir las 34 semanas de gestación

23) Un paciente con antecedente de daño hepático crónico, por hepatitis C, en etapa Child B, presenta hematemesis, asociado a ortostatismo. Se inicia reposición de volumen con cristaloides y se realiza endoscopia digestiva alta, con várices esofágicas de tamaño moderado, con signos de sangrado reciente, sin hemorragia actual. La conducta más adecuada para prevenir nuevas hemorragias es:

- a) Realizar ligadura de várices
- b) Realizar ligadura de várices e iniciar betabloqueantes no selectivos
- c) Iniciar betabloqueantes no selectivos
- d) Instalar un TIPS (Cortocircuito porto-sistémico transyugular)
- e) Iniciar omeprazol y betabloqueantes

24) ¿Cuál de los siguientes antecedente le debe hacer sospechar un diagnóstico distinto a un síndrome de intestino irritable?

- a) Deposiciones con mucus
- b) Alternancia entre constipación y diarrea
- c) Distensión abdominal
- d) Alza de peso
- e) Anemia ferropénica

25) Una paciente de 35 años, obesa, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea. Al examen físico se observa taquipneica, adolorida, con presión arterial de 90/60 mmHg y pulso de 120 lpm. La auscultación cardíaca demuestra RR2T sin soplos, y la auscultación pulmonar sólo demuestra escasos crépitos en la base izquierda. Se solicita electrocardiograma que demuestra presencia de una onda Q en DIII, asociado a inversión de la onda T en la misma derivación. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax espontáneo
- b) Infarto agudo al miocardio
- c) Disección aórtica
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Derrame pleural

26) Una mujer de 33 años, sintomática, acude a su control ginecológico anual, palpándose un tumor anexial derecho. El resto del examen físico es normal. Se realiza una ecografía transvaginal que demuestra un tumor ovárico derecho, de 4,5 cm, quístico, de paredes lisas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar niveles seriados de Ca-125
- c) Realizar biopsia por punción
- d) Realizar tumorectomía
- e) Realizar anexectomía derecha

27) Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja en la población adulta son:

- a) Angiodisplasias y pólipos
- b) Enfermedades inflamatorias intestinales y pólipos
- c) Cáncer de colon y hemorroides externos
- d) Divertículos y angiodisplasias
- e) Hemorroides externos y divertículos

28) Un paciente de 55 años, es ingresado al servicio de urgencias por cuadro de palpitaciones, disnea y desorientación. Al examen físico se observa mal perfundida, con presión arterial de 70/36 mmHg, pulso débil, regular, a 160 latidos por minuto. Se encuentra desorientada, taquipneica, con la piel sudorosa. La saturación arterial de oxígeno es 85% y se ausculta crépitos pulmonares difusos. El monitoreo electrocardiográfico es sugerente de flutter auricular. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma para confirmar el diagnóstico y decidir manejo según hallazgos
- b) Administrar propranolol endovenosos
- c) Administrar suero fisiológico y adenosina
- d) Realizar cardioversión farmacológica con amiodarona
- e) Realizar cardioversión eléctrica

29) Una mujer de 35 años, consulta porque presenta problemas para manejar. Cada vez que llega a un semáforo y la luz está en verde, debe seguir manejando en línea recta, aún cuando necesite doblar en esa esquina, de modo que sólo puede doblar cuando llega a la esquina y el semáforo está en rojo o cuando no hay semáforo. Esto le hace perder mucho tiempo y ella sabe que esas ideas son producidas por su mente y que son ridículas, pero siente que si dobla, tendrá un accidente, lo que la angustia mucho. El tratamiento de elección para la patología descrita es:

- a) Estabilizadores del ánimo
- b) Antidepresivos IRSS
- c) Benzodiazepinas
- d) Antipsicóticos atípicos
- e) Antipsicóticos típicos

30) Una paciente acude a su primer control obstétrico, con 7 semanas de amenorrea. Se realiza ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. Se solicitan niveles plasmáticos de subunidad beta de gonadotropina coriónica humana, que resulta 7.000 mUI/ml. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparoscopia
- b) Realizar histerectomía transvaginal
- c) Solicitar nueva beta-HCG y ecografía transvaginal en 48 horas
- d) Iniciar metotrexato
- e) Realizar legrado uterino

31) Un hombre de 45 años presenta placas eritematosas, descamativas, no dolorosas ni pruriginosas, de 1 a 5 cm de diámetro, en los codos, rodillas y zona lumbar, desde hace 30 días. Previamente había presentado lesiones similares, pero de menor tamaño, que habían desaparecido espontáneamente, luego de un tiempo. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple
- b) Liquen plano
- c) Dermatitis seborreica
- d) Psoriasis
- e) Pitiriasis rosada

32) Llega a la urgencia de un centro médico rural, un paciente de 15 años quien sufrió una caída de un caballo, resultando con intenso dolor y deformidad en el muslo, con pérdida de los ejes y una herida de 4 cm, por donde se asoma una punta ósea. La respiración, así como el pulso y la presión arterial son normales y no se observa hemorragia importante. Usted no cuenta con radiografías. La conducta MENOS aconsejable es:

- a) Realizar aseo con abundante suero fisiológico
- b) Administrar toxoide tetánico
- c) Poner bota larga de yeso, cerrada
- d) Iniciar antibióticos sistémicos
- e) Administrar analgesia endovenosa

33) El método diagnóstico de elección para la endometriosis es:

- a) Ecografía transvaginal
- b) Especuloscopia
- c) Ca 125
- d) Legrado biopsico
- e) Laparoscopia

34) Un paciente de 17 años consulta por ojo rojo derecho, con leve dolor y abundante secreción que al despertar se traduce en imposibilidad para abrir los ojos, ya que los párpados se encuentran pegados. Al examen presenta ojo rojo superficial, con abundante secreción purulenta en los fondos de saco palpebrales. El resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Ulceración corneal
- e) Blefaritis

35) Un paciente de 18 meses presenta detención de su crecimiento, asociado a diarrea crónica y malestar abdominal. Las deposiciones son blandas y brillantes y no se acompañan de sangre. En la analítica sanguínea general destaca anemia microcítica, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test del sudor
- b) Solicitar colonoscopia
- c) Solicitar test de Sudan de deposiciones y anticuerpos anti-transglutaminasa
- d) Solicitar parasitológico directo de deposiciones y coprocultivo
- e) Iniciar un régimen blando, sin residuos y antibióticos orales, evaluando respuesta en 2 semanas

36) Un paciente de 33 años presenta episodios recurrentes de dolor periocular derecho, muy intenso, asociado a lagrimeo, rinorrea y miosis ipsilaterales. El dolor dura cerca de 30 minutos y se presenta diariamente en la noche. El diagnóstico más probable es:

- a) Cefalea en racimo
- b) Neuralgia del trigémino
- c) Síndrome de Horner
- d) Epilepsia
- e) Uveítis aguda

37) Un paciente de 40 años presenta cefalea de inicio súbito, asociada a vómitos y diplopía. Al examen físico se observa hemianopsia bitemporal y parálisis del nervio oculomotor derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea
- b) Accidente vascular de troncoencéfalo
- c) Apoplejía hipofisiaria
- d) Esclerosis múltiple
- e) Meningitis tuberculosa

38) Una paciente de 35 años consulta por dolor epigástrico intenso, constante, asociado a vómitos, al que se le ha agregado ictericia. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y abdomen blando, depresible, sensible especialmente en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Las pruebas hepáticas demuestran un patrón colestásico y los parámetros inflamatorios, así como la lipasa son normales. Se solicita ecografía que muestra dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y analgésicos
- b) Iniciar analgésicos y realizar una colangiografía retrógrada
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis e iniciar analgésicos
- d) Realizar colecistectomía de urgencia
- e) Iniciar omeprazol endovenoso y solicitar una endoscopia digestiva alta de urgencia

39) Usted desea comparar la relación entre la insulinemia de ayuno y el índice de masa corporal. El mejor parámetro para calcular la significancia estadística es:

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) r de Pearson
- d) Análisis de varianza
- e) Prueba exacta de Fisher

40) Un niño de 6 años presenta un cuadro de fiebre, decaimiento y aparición de un exantema vesiculopustular, generalizado, pruriginoso, que se inició en la cabeza y progresó hacia el tronco y las extremidades. Algunas de las lesiones iniciales evolucionaron a costras. La complicación más frecuente de la patología descrita en la edad pediátrica es:

- a) Encefalitis
- b) Neumonía
- c) Shock tóxico
- d) Infección por cocáceas Gram positivas
- e) Hepatitis

41) Una paciente de 45 años consulta por baja de peso, diarrea crónica, sudoración, intolerancia al calor y palpitaciones de algunas semanas de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones generales, con piel fina, húmeda y caliente, con retracción palpebral bilateral y pulso regular a 115 lpm. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TSH y T4
- b) Solicitar T3 libre y T4 libre
- c) Solicitar tiroglobulina y TSH ultrasensible
- d) Iniciar betabloqueo y propiltiouracilo
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea, con yodo radiactivo

42) Una primigesta, cursando embarazo de 38 semanas + 3 días, inicia dinámica uterina, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen se palpa feto en cefálica, y se constatan 2 contracciones uterinas cada 10 minutos. El tacto vaginal demuestra borramiento de 70% y dilatación de 2 centímetros, con membranas íntegras. El monitoreo cardíaco fetal resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar rotura artificial de membranas
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar misoprostol intravaginal
- d) Administrar tocolíticos
- e) Enviar a domicilio, indicándole que reconsulte en unas horas

43) Un paciente de 41 años, hipertenso, con antecedente de estenosis aórtica, bien controlada con tratamiento farmacológico, debe realizarse una colonoscopia, por haber presentado hematoquezia en una oportunidad. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar evaluación previa por cardiólogo
- b) Realizar la sedación con barbitúricos, en lugar de benzodiazepinas
- c) Realizar la colonoscopia, sin preparación de colon
- d) Administrar amoxicilina oral y gentamicina endovenosa, previo al procedimiento
- e) Administrar ampicilina oral previo al procedimiento

44) La profilaxis antibiótica contra estreptococo beta hemolítico grupo B, durante el trabajo de parto, está indicada en todas las siguientes situaciones, excepto:

- a) Gestante diabética, con embarazo de 39 semanas, con feto grande para la edad gestacional
- b) Primigesta con embarazo de 36 semanas, con embarazo bien controlado
- c) Multípara de 2, cursando embarazo de 41 semanas, con antecedente de sepsis por SGB en uno de sus hijos anteriores
- d) Gestante de 40 años, cursando embarazo de 40 semanas con rotura de membranas de 24 horas de evolución
- e) Primigesta con bacteriuria asintomática por estreptococo grupo B

45) Un recién nacido de término, de 4 días de vida presenta ictericia de 2 días de evolución, que actualmente llega hasta los muslos. Al nacer pesó 3.980g y actualmente pesa 3.650g. Se ha alimentado con leche materna exclusiva. Al examen físico se ve de buen aspecto y no se encuentran otros hallazgos de importancia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prueba de Coombs directa, grupo y Rh, hemograma y decidir manejo según hallazgos
- b) Iniciar suplemento lácteo con fórmula e iniciar fototerapia
- c) Solicitar bilirrubina plasmática total
- d) Solicitar pruebas hepáticas con diferenciación de hemoglobina total y directa
- e) Realizar exangineotransfusión

46) Un paciente de 68 años, presenta hematuria en 3 oportunidades, sin otros síntomas. El examen físico resulta normal. Se realiza sedimento de orina que demuestra abundantes glóbulos rojos, sin dismorfia, sin otras alteraciones. El urocultivo resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cistoscopia
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Realizar biopsia prostática
- d) Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas y tiempos de coagulación
- e) Administrar ácido tranexánico

47) Los miomas que dan síntomas con mayor frecuencia son:

- a) Subserosos
- b) Submucosos
- c) Pediculados
- d) Intramurales
- e) Persistentes

48) Una mujer intenta ser el centro de atención la mayoría del tiempo, por lo que exagera las cosas, actúa como si sus relaciones fueran más profundas de lo que en realidad son, se viste provocativamente, tiene una actitud seductora y se siente incómoda cuando no la toman en cuenta, lo que le trae malas relaciones interpersonales, especialmente con otras mujeres. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad límite
- b) Trastorno de personalidad narcisista
- c) Trastorno de personalidad histriónica
- d) Trastorno de personalidad dependiente
- e) Trastorno de personalidad obsesiva

49) Un paciente de 10 meses presenta diarrea acuosa y fiebre hasta 38,5°C, de 24 horas de evolución. Inicialmente presentó vómitos en 2 oportunidades. Al examen físico se observa irritable, con signos vitales normales, llora sin lágrimas, presenta mucosas secas y la turgencia de la piel es normal. El examen abdominal presenta un abdomen blando, depresible, indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar régimen blando, sin residuos, indicar hidratación oral y antidiarreicos
- b) Iniciar hidratación oral, según plan A
- c) Iniciar antibióticos orales y sales de rehidratación oral, ofreciendo 200 cc luego de cada deposición diarreica
- d) Administrar sales de rehidratación oral a 50-100 cc/Kg en 4 horas y reevaluar
- e) Administrar un bolo de suero fisiológico de 20 cc/Kg, por vía endovenosa y reevaluar

50) La atención primaria en Chile se financia mayoritariamente a partir de:

- a) El aporte "per cápita"
- b) Los aportes municipales
- c) El copago de los trabajadores
- d) El aporte de los empleadores
- e) El 7% de los trabajadores

51) Un paciente de 70 años ingresa por una neumonía grave, en malas condiciones generales, cianótico. Se solicitan gases arteriales que muestran: PaO₂: 51 mmHg; PCO₂: 42 mmHg; Bic: 9 mEq/l y pH: 7,12. El diagnóstico gasométrico es:

- a) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria
- b) Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria
- c) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica
- d) Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica
- e) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis mixta

52) ¿Cuál de las siguientes opciones es una alternativa válida para la alimentación láctea de un lactante de 4 meses que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

53) Una paciente de 54 años consulta por artralgiás de manos, asociadas a rigidez matinal de una hora. Al examen se observa artritis de algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Artritis reumatoide
- c) Artrosis
- d) Artritis psoriática
- e) Artritis viral

54) Una mujer de 65 años, menopáusica hace 12 años, presenta menstruación de 2 días de duración, autolimitada. El examen físico, especuloscopia, tacto vaginal y ecografía transvaginal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar Papanicolaou
- c) Administrar progestágenos en altas dosis
- d) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
- e) Realizar biopsia endometrial

55) Un paciente de 46 años presenta diarrea de 6 meses de evolución, asociada a baja de peso de 10 kilogramos. Las deposiciones son brillantes, con gotas de grasa y en algunas ocasiones presentan alimentos sin digerir, como fideos o arroz. El examen físico sólo demuestra un abdomen levemente distendido, con ruidos hidroaéreos aumentados. El examen que debe solicitarse para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Test de hemorragias ocultas en deposiciones
- b) Colonoscopia
- c) Parasitológico
- d) Test de Sudán
- e) Anticuerpos antiendomisio

56) ¿Qué antibiótico NO debe administrarse durante el embarazo?

- a) Clindamicina
- b) Metronidazol
- c) Ceftriaxona
- d) Tetraciclina
- e) Clindamicina

57) Un paciente de 50 años, asintomático, se realiza tacto rectal que demuestra un nódulo indurado de 3 milímetros de diámetro en el lóbulo prostático derecho. Se solicita antígeno prostático específico, que resulta 1,2 ng/dl (VN: menor a 4,0 ng/dl). La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar antígeno prostático específico libre
- b) Realizar ecografía prostática y vesical
- c) Realizar RTU y biopsia
- d) Realizar biopsia prostática transrectal
- e) Resolver quirúrgicamente

58) Un recién nacido pretérmino, de 2 horas de nacido presenta dificultad respiratoria, caracterizada por taquipnea, quejido y aleteo nasal, con cianosis que responde a la administración de oxígeno al 40%. Se solicita radiografía de tórax que demuestra pulmones algo radiopacos, en patrón de vidrio esmerilado, con broncograma aéreo. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Hipertensión pulmonar persistente
- e) Neumonía neonatal

59) Una paciente de 33 años se realiza PAP que demuestra presencia de células epiteliales atípicas con displasia de grado moderado. Se realiza colposcopia que demuestra una lesión acetoblanca con algunos vasos visibles en su superficie. La biopsia demuestra una neoplasia intraepitelial de alto grado (NIE 3). La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, realizando PAP cada 3 meses
- b) Realizar aplicaciones de ácido tricloroacético y podofilino
- c) Realizar resección de la lesión, dejando un margen libre de 2 mm
- d) Realizar cono cervical
- e) Realizar histerectomía radical

60) Un paciente sufre una fractura de pierna, con inadecuada inmovilización, evolucionando con importante dolor distal, luego de algunos días. Al examen físico destaca dolor intenso a la movilización de los ortijos, con sensibilidad y pulsos conservados. La piel se aprecia adelgazada con disminución de los fanéneos. Se solicita una radiografía que demuestra osteoporosis moteada de los huesos del pie. El diagnóstico más probable es:

- a) Retracción isquémica de Volkman
- b) Lesión de los nervios interóseos
- c) Síndrome compartimental
- d) Lesión de la arteria poplítea
- e) Distrofia simpático-refleja

61) Un niño de 15 meses es traído por su madre ya que presenta fiebre e irritabilidad. Al examen físico destaca una faringe eritematosa con varias vesículas en el paladar blando, algunas de ellas ulceradas, en forma de aftas. Además presenta varias adenopatías cervicales pequeñas, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Primoinfección herpética
- b) Herpangina
- c) Amigdalitis estreptocócica
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Exantema súbito

62) Un paciente de 67 años, fumador de 45 paquetes-año presenta disfonía de 7 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico se observa cavidad oral normal y se palpa una adenopatía cervical anterior de 2 cm, de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Cáncer glótico
- c) Cáncer infraglotico
- d) Cáncer de pulmón con compromiso del nervio laríngeo recurrente
- e) Laringitis crónica

63) Un paciente de 50 años tiene una hernia inguinal indirecta de pequeño tamaño, asintomática. Hace 20 días sufre un infarto miocárdico transmural, tratado con angioplastia, con buena evolución. Actualmente está en tratamiento con aspirina y una estatina, con capacidad funcional normal. Se realiza test de esfuerzo que resulta normal y una ecocardiografía que demuestra una pequeña área hipoquinética en la pared anterior, con fracción de eyección normal. La conducta más adecuada para el manejo de la hernia inguinal es:

- a) Resolverla quirúrgicamente de manera electiva lo antes posible
- b) Programar la herniorrafia en 6 meses
- c) Realizar coronariografía y decidir momento de la cirugía según resultados
- d) Realizar herniorrafia de inmediato, bajo anticoagulación con heparina
- e) Observarla y resolverla quirúrgicamente sólo en caso de complicación

64) Una paciente múltipara de 4, cursando su quinto embarazo, de 35 semanas, presenta salida de líquido claro abundante, por genitales. No presenta dinámica uterina y el feto se palpa en céflica. Se realiza especuloscopia que resulta normal y test de cristalización que resulta positivo, con formación de cristales en patrón de hojas de helecho. El tacto vaginal no demuestra modificaciones cervicales y las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Realizar amniocentesis
- e) Realizar cesárea

65) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y glibenclamida, bien controlado, presenta cuadro de sudoración y temblor, seguido de desorientación y luego pérdida de conciencia hasta llegar a Glasgow 9. Se solicita realiza hemoglucotest que resulta 31, por lo que se administra suero glucosado al 30%, por vía endovenosa, recuperándose completamente a los pocos minutos, con hemoglucotest de control de 146. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar el alta, con dosis menores de metformina
- b) Indicar el alta, con dosis menores de glibenclamida
- c) Suspender los hipoglucemiantes orales y enviar a domicilio con insulina
- d) Solicitar hemoglobina glicosilada y decidir manejo según resultado
- e) Hospitalizar y mantener con infusión continua de suero glucosado, realizando hemoglucotest seriados

66) Una pareja busca concebir un embarazo desde hace 12 meses, sin haberlo conseguido. Ambos presenta algún grado de sobrepeso. Ella refiere reglas irregulares, con períodos de amenorrea de hasta 4 meses. El examen físico de ambos es normal. La causa más probable de la infertilidad es:

- a) Normal
- b) Factor masculino
- c) Anovulación
- d) Endometriosis
- e) Incompetencia cervical

67) Un niño de 6 años presenta 10 lesiones vesiculares intensamente pruriginosas, con halo eritematoso pseudopapular en cara, antebrazos y piernas, sin compromiso de tronco, muslos, brazos ni cuero cabelludo. El resto del examen físico es normal y no presenta otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Varicela
- d) Prurigo insectario
- e) Síndrome de pie-mano-boca

68) Un adulto mayor de 86 años, diabético tipo 2, mal controlado, con insuficiencia renal en hemodiálisis, inicia un cuadro de vómitos alimentarios, postprandiales, que se han ido intensificando en el último tiempo, siendo muy frecuentes. Ha bajado 10 kilogramos de peso en el último año y ha presentado 2 episodios de neumonía aspirativa. Se realiza endoscopia digestiva alta, radiografías baritadas y estudio de videodeglución, que son compatibles con una gastroparesia gástrica severa. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar alimentación con papilla, con uso de espesantes
- b) Iniciar omeprazol y domperidona
- c) Construir una gastrostomía para alimentación
- d) Alimentar por sonda nasoyeyunal
- e) Iniciar nutrición parenteral total

69) El instituto médico legal se encarga de:

- a) Confirmar los casos de VIH con westernblot
- b) Fiscalizar a las farmacias
- c) Inspeccionar el adecuado funcionamiento de los laboratorios
- d) Constatar la evidencia de una agresión sexual
- e) Adquirir insumos a bajo costo

70) Un paciente con historia de disnea de esfuerzos se realiza una espirometría, resultando:

Espirometría Basal: CVF: 52% (del teórico); VEF1: 48% (del teórico); VEF1/CVF: 82%

Postbroncodilatador: CVF: 55% (del teórico); VEF1: 52% (del teórico); VEF1/CVF: 84%

El diagnóstico más probable es:

- a) EPOC
- b) Asma
- c) Bronquiectasias
- d) Hipertensión pulmonar primaria
- e) Fibrosis pulmonar

71) Un paciente de 57 años se realiza un perfil bioquímico, como parte de un estudio de rutina por control de su hipertensión arterial, donde destaca calcio de 11,0 mg/dl (VN: 8,5-10,5), con albúmina de 3,3 g/dl. La creatinina, BUN, glicemia, fosfemia y transaminasas resultaron normales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar calciuria de 24 horas
- b) Solicitar cintigrama óseo
- c) Medir niveles plasmáticos de hormona paratiroidea
- d) Solicitar calcitonina plasmática
- e) No es necesario realizar ningún tipo de estudio adicional

72) Un paciente VIH, consulta por cefalea gran compromiso del estado general y fiebre hasta 39°C. Al examen está desorientado, con signos meníngeos, por lo que se realiza una punción lumbar que da salida a líquido turbio, con 886 células, con 86% de polimorfonucleares, 14% de mononucleares, con proteínas 78 mg/dl y glucosa de 25 mg/dl. Con los antecedentes entregados, el diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis herpética
- b) Meningitis bacteriana aguda
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Meningitis criptocócica
- e) Meningoencefalitis por toxoplasma

73) ¿Cuál de los siguientes fármacos es usado como terapia aversiva, para dejar de consumir alcohol?

- a) Bupropion
- b) Champix
- c) Naltrexona
- d) Disulfiram
- e) Fluoxetina

74) Un niño de 4 años sufre un golpe directo sobre el antebrazo izquierdo, evolucionando con deformación y dolor. Se solicita una radiografía que demuestra una fractura en tallo verde del radio y cúbito. Si se realiza una inadecuada inmovilización, la complicación más probable será:

- a) Síndrome compartimental
- b) Consolidación viciosa
- c) Pseudoartrosis
- d) Lesión del nervio radial
- e) Retracción isquémica de Volkman

75) Una mujer de 30 años consulta por un cuadro de astenia y diplopía fluctuantes de 2 semanas de evolución. Al examen físico se observa ptosis derecha y estrabismo divergente. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis del III par
- b) Síndrome de Guillain-Barre
- c) Miastenia gravis
- d) Polineuropatía
- e) Polimiositis

76) Un hombre de 23 años sufre un síncope en relación al ejercicio. El examen físico resulta normal. Se realiza un electrocardiograma que demuestra un ritmo sinusal y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecocardiografía
- b) Solicitar Holter de arritmias
- c) Iniciar iECAs y betabloqueo
- d) Solicitar coronariografía
- e) Indicar dieta hiposódica y ejercicio moderado y controlar en 3 meses

77) El método anticonceptivo de elección en una paciente que está amamantando, pero que ha iniciado sus menstruaciones, es:

- a) Anticonceptivo combinados orales
- b) Anticonceptivos combinados transdérmicos
- c) Anticonceptivos combinados inyectables
- d) Estrógenos solos
- e) Progestágenos solos

78) Un paciente de 84 años, diabético, hipertenso y con cardiopatía coronaria en tratamiento, consulta por una historia de algunos meses de evolución de olvidos frecuentes, que no afectaban mayormente sus actividades, sin embargo hace 3 días presenta desorientación y falso reconocimiento de sus familiares. Al examen se encuentra inatento, desorientado en el tiempo y el espacio, sin signos motores ni sensitivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Tumor cerebral
- d) Delirium
- e) Demencia por cuerpos de Lewy

79) Un niño se pone de pie, afirmado de algunos muebles, dice mamá y papá y desconoce a los extraños. Aún no logra caminar sin apoyo. ¿Qué edad tiene?

- a) 6 meses
- b) 8 meses
- c) 10 meses
- d) 12 meses
- e) 14 meses

80) Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 32 semanas presenta metrorragia y dinámica uterina dolorosa. Al examen físico se palpa el útero hipertónico, con 2 algunas contracciones uterinas. Se realiza especuloscopia que muestra la sangre saliendo por el orificio cervical externo y el tacto vaginal no demuestra modificaciones cervicales. Se auscultan los latidos fetales a 105 lpm. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Administrar corticoides e interrumpir el parto en 48 horas
- e) Administrar corticoides y tocolíticos e interrumpir el embarazo a las 34 semanas de gestación

81) ¿Cuál de las siguientes vacunas puede administrarse a un niño inmunodeprimido severo?

- a) Polio oral
- b) Trivírica
- c) Varicela
- d) DPT
- e) BCG

82) Un niño de 12 años, obeso, presenta un cuadro de baja de peso y astenia de 4 semanas de evolución. Además presenta poliuria. El examen físico es normal. Se solicita glicemia que resulta 244 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar insulina
- b) Iniciar metformina y glibenclamida
- c) Iniciar dieta y ejercicios y reevaluar al paciente en 30 días
- d) Solicitar prueba de tolerancia a la glucosa oral
- e) Solicitar insulina basal y postprandial

83) Un paciente de 34 años, presenta cuadro de 2 días de evolución, de náuseas, dolor abdominal tipo cólico, vómitos alimentarios y diarrea acuosa frecuente, a razón de 8 deposiciones por día. No ha presentado fiebre ni elementos patológicos en las deposiciones. El examen físico sólo demuestra ruidos hidroaéreos aumentados, sin deshidratación. El agente etiológico más probable es:

- a) Escherichia coli
- b) Shigella flexneri
- c) Salmonella typhi
- d) Entamoeba histolytica
- e) Virus

84) El tratamiento de elección del trastorno de angustia es:

- a) Benzodiazepinas
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos tricíclicos
- d) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- e) Neurolépticos

85) Una paciente de 32 años consulta por aumento de volumen cervical de consistencia dura. Al examen se palpa un nódulo en relación a la glándula tiroides, que se moviliza con la deglución. Se solicita TSH que resulta normal y una ecografía de cuello que visualiza un nódulo sólido de 2,3 cm en el lóbulo tiroideo derecho, sin adenopatías cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar punción con aguja fina y decidir conducta según hallazgos
- b) Realizar tumorectomía y biosia
- c) Solicitar niveles de calcitonina y tiroglobulina
- d) Administrar yodo radiactivo
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea

86) Un paciente de 65 años, alcohólico, vagabundo, consulta por baja de peso, fiebre y tos mucopurulenta, que en algunas ocasiones es hemoptoica. El examen pulmonar demuestra algunos crépitos gruesos, difusos, mayores en los ápices. Se realiza radiografía de tórax que muestra zonas de fibrosis, relleno y retracción en ambos lóbulos superiores. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento antibiótico, con amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar baciloscopías de esputo y cultivo de Koch
- e) Realizar broncoscopia y toma de biopsias

87) Un paciente de 20 años consulta por diarrea crónica, asociada a dolor abdominal, de 2 meses de evolución, que en el último tiempo se ha vuelto sanguinolenta. Presenta febrículas ocasionalmente y ha bajado 8 kilogramos de peso desde el inicio de los síntomas. Al examen físico se observa pálido, con abdomen distendido, blando, depresible y doloroso difusamente, con aumento de los ruidos hidroaéreos, sin palpación de masas ni visceromegalia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar parasitológico de deposiciones y coprocultivo
- b) Iniciar ciprofloxacino oral
- c) Solicitar anticuerpos antiendomisio y endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis, con contraste

88) Una mujer de 56 años detecta un nódulo de consistencia dura en la mama izquierda, de 3 cm. No se palpan adenopatías axilares. Se realiza mamografía que muestra un nódulo de 3 cm, denso, con bordes irregulares y microcalcificaciones agrupadas. Se realiza biopsia con mamótomo que demuestra presencia de un adenocarcinoma ductal infiltrante, de grado histológico moderado, con invasión vascular y con negatividad para receptores de estrógeno y progesterona. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar mastectomía radical, estudio de ganglio centinela y tamoxifeno
- b) Realizar mastectomía parcial, vaciamiento axilar y tamoxifeno
- c) Realizar mastectomía parcial, estudio de ganglio centinela y radioterapia postoperatoria
- d) Realizar mastectomía radical y vaciamiento axilar
- e) Iniciar quimioterapia y hormonoterapia

89) Una paciente de 65 años, diabética e hipertensa, con antecedente de cardiopatía hipertensiva y de fibrilación auricular paroxística, en tratamiento con amiodarona y acenocumarol. Su hipertensión arterial y su diabetes mellitus están bien controladas. Durante los controles de los últimos 6 meses se ha mantenido en ritmo sinusal, asintomática. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el acenocumarol y mantener la amiodarona
- b) Suspender el acenocumarol y la amiodarona
- c) Suspender el acenocumarol e iniciar aspirina
- d) Bajar la dosis de acenocumarol, para lograr INR cercanos a 1,5
- e) Mantener la amiodarona y el acenocumarol

90) Un niño de 4 años presenta un cuadro de tos de inicio súbito, evolucionando luego con tos con expectoración mucopurulenta. El examen físico no aporta mayor información y la radiografía de tórax muestra hiperinsuflación a nivel del lóbulo inferior derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Crisis asmática
- b) Neumonía
- c) Laringitis obstructiva
- d) Cuerpo extraño bronquial
- e) Bronquitis aguda

SEGUNDA PARTE

1) Un paciente de 57 años, con antecedente de arteritis de la temporal en tratamiento, consulta por astenia y debilidad muscular, especialmente de los músculos proximales. Refiere que ha subido de peso en el último tiempo. Al examen físico destaca presión arterial de 156/98 mmHg y adelgazamiento de las masas musculares de las extremidades con aumento del tejido adiposo, de disposición troncular y facial. Se observan además algunas estrías abdominales de color violáceo. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal
- b) Esclerosis sistémica progresiva
- c) Polimiositis
- d) Polimialgia reumática
- e) Síndrome de Cushing farmacológico

2) Un paciente de 67 años consulta por olvidos frecuentes, con afectación importante de la memoria reciente. También presenta dificultad para vestirse y para comer. Al examen físico se observa presencia de reflejos arcaicos, sin focalidad neurológica. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Hipotiroidismo
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Demencia vascular
- e) Delirium

3) El tratamiento de elección de la pediculosis en los niños es:

- a) Corte de cabello
- b) Permetrina
- c) Lindano
- d) Albendazol
- e) Ivermectina

4) Un recién nacido presenta una mácula de color violáceo intenso en la zona frontal y periocular izquierda, con compromiso del párpado y que no sobrepasa la línea media. El diagnóstico más probable es:

- a) Mancha salmón
- b) Nevus flammeus
- c) Hemangioma
- d) Nevo congénito
- e) Bolsa serosanguínea

5) Un paciente de 45 años, colecistectomizado, consulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos e imposibilidad para eliminar gases. Al examen físico se aprecia adolorido, con signos vitales normales. El abdomen está distendido, sensible difusamente, con bazuqueo y aumento de los ruidos intestinales. No presenta signos de irritación abdominal. Se realiza radiografía de abdomen que demuestra múltiples niveles hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con hidratación y ciprofloxacino por vía oral
- b) Administrar antiespasmódicos, antibióticos orales y observar evolución
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Iniciar reposición de volumen con suero fisiológico, antibióticos endovenosos y realizar descompresión neumática
- e) Iniciar reposición de volumen, antibióticos de amplio espectro y realizar laparotomía exploradora inmediatamente

6) Un hombre sufre caída de bicicleta golpeándose el hombro derecho, evolucionando con importante dolor e impotencia funcional. Al examen físico se observa acortamiento del hombro, con extremo en charretera y se palpa un aumento de volumen duro en la región infraclavicular derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Disyunción acromioclavicular
- b) Fractura de clavícula
- c) Luxación anterior
- d) Fractura de cuello humeral
- e) Fractura de escápula

7) ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en un melanoma?

- a) El diámetro de la lesión
- b) La presencia de ulceración
- c) La profundidad de la invasión cutánea
- d) La presencia de adenopatías
- e) El subtipo clínico

8) La primera causa de úlcera gástrica es:

- a) Gastrinoma
- b) Infección por *Helicobacter pylori*
- c) Consumo de antiinflamatorios no esteroideos
- d) Cáncer gástrico
- e) Malos hábitos de alimentación

9) Un paciente de 65 años, fumador, presenta 2 neumonías en el lóbulo superior derecho en un período de 2 meses. Se realiza una radiografía de control, 60 días después de terminado el tratamiento antibiótico, la que identifica un nódulo denso de 3 cm, espiculado, en la zona parahiliar del lóbulo superior derecho. No se cuenta con radiografías previas y el TAC de tórax observa el nódulo de consistencia sólida y de bordes irregulares. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar radiografías de control cada 3 meses
- b) Solicitar nuevo TAC en 6 meses y decidir manejo según hallazgos
- c) Realizar fibrobroncoscopía
- d) Realizar punción bajo TAC y biopsia
- e) Realizar biopsia excisional

10) El punto de reparo de la presentación de bregma es:

- a) La fontanela posterior
- b) La sutura sagital
- c) La fontanela anterior
- d) La frente
- e) La nariz

11) Usted desea iniciar un programa de pesquisa precoz de diabetes en una población de 60.000 habitantes. Para esto usted debe realizar glicemias de ayuno a toda la población. Una enfermera es capaz de tomar 20 muestras de sangre por hora y el valor que se le paga por hora es \$3.000. ¿Cuánto dinero necesita para costear las tomas de muestra?

- a) \$900.000
- b) \$1.000.000
- c) \$9.000.000
- d) \$10.000.000
- e) \$36.000.000

12) Un paciente de 24 años presenta cuadro de rinorrea serosa, estornudos frecuentes, prurito nasal y ocular, con escasa o nula obstrucción, que inicia en septiembre y dura hasta principios de enero, desde hace varios años. Al examen físico se observa mucosa nasal pálida. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar antihistamínicos orales
- b) Iniciar corticoides nasales
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios y decidir tratamiento farmacológico según los resultados
- e) Solicitar citología nasal y decidir tratamiento farmacológico según los resultados

13) Un niño de 7 años presenta fiebre, sudoración y dolor en las extremidades. Al examen se observan algunas petequias en el pecho, cara y extremidades inferiores y se palpa esplenomegalia. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 28%; Hb: 9,5; VCM: 86; blancos: 34.200; segmentados: 13%; baciliformes: 1%; mielocitos: 0%; promielocitos: 0%; blastos: 10%; Eosinófilos: 0%; basófilos: 0%; linfocitos: 73%; monocitos: 3%; plaquetas: 47.000. A. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar IgM VCA, IgM CMV y ELISA VIH
- b) Solicitar PCR, hemocultivos, urocultivo y radiografía de tórax
- c) Solicitar ecocardiografía, hemocultivos e iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro
- d) Solicitar estudio de médula ósea
- e) Iniciar corticoides sistémicos

14) La extrasístoles ventriculares se diferencian de las extrasístoles supraventriculares, ya que las primeras presentan:

- a) Complejo QRS ancho y presencia de pausa compensatoria
- b) Complejo QRS angosto y ausencia de pausa compensatoria
- c) Complejo QRS ancho y ausencia de pausa compensatoria
- d) Alargamiento del segmento QT y alteraciones de la repolarización
- e) Acortamiento del segmento QT sin alteraciones de la repolarización

15) El pensamiento del preescolar generalmente es:

- a) Abstracto y analítico
- b) Concreto y ejecutivo
- c) Prelógico y mágico
- d) Concreto y lógico
- e) Abstracto y emocional

16) Un paciente de 32 años, presenta historia de asma de difícil manejo, a pesar de uso de altas dosis de corticoides inhalados. En el último tiempo presenta crisis asmáticas frecuentes e inicia artralgias y hematuria. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes donde destaca hematuria dismórfica, creatininemia de 2,7 mg/dl y hemograma con eosinofilia. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso
- b) Síndrome de Good-Pasture
- c) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
- d) Granulomatosis de Wegener
- e) Poliangeitis microscópica

17) Un recién nacido, de 3 días de evolución presenta rechazo alimentario y disminución del estado de conciencia. Al examen físico de aprecia decaído, con algún grado de hipotonía. Los signos vitales son normales, al igual que el examen físico segmentario. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma
- b) Iniciar antibióticos orales y antipiréticos
- c) Solicitar hemograma, hemocultivos y exámenes de orina
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, electrolitos plasmáticos, calcemia y glicemia
- e) Solicitar glicemia, calcemia, electrolitos plasmáticos, pruebas de función renal, hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, radiografía de tórax y estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar antibióticos de amplio espectro

18) Un paciente de 66 años, cursando una septicemia de origen urinario, evoluciona con rápido deterioro del estado general y cognitivo, con gran compromiso respiratorio, presentando taquipnea hasta 40 respiraciones por minutos y desaturación arterial hasta 65%, con escasa respuesta a oxígeno a altas concentraciones. Al examen físico de auscultan crepitaciones difusas bilaterales. Se monitorea invasivamente con un catéter de Swan-Ganz que revela PVC: 8mmHg, PAP: 20mmHg y PCP: 12mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Edema pulmonar de origen cardiogénico
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Derrame pleural masivo
- d) Distrés respiratorio
- e) Neumonía hematógena

19) Un paciente de 65 años, presenta palidez y astenia, por lo que se realiza un hemograma que demuestra hematocrito: 28%, glóbulos rojos: 4 millones por mm³, anisocitosis, plaquetas: 145.000 por mm³, blancos: 6.300 por mm³, con neutrófilos 45%, linfocitos: 40%, monocitos: 9%, basófilos: 2%, eosinófilos: 4%. El diagnóstico más probable es:

- a) Ferropenia
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Aplasia medular
- e) Leucemia linfática crónica

20) La madre de un lactante de 3 meses de edad nota que su hijo presenta estrabismo convergente en algunas oportunidades, fijando la mirada normalmente en otras ocasiones. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata dicho estrabismo fluctuante. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución hasta los 6 meses de edad
- b) Derivar a oftalmólogo para resolución quirúrgica inmediata
- c) Indicar cobertura monocular alternada con parche
- d) Solicitar electromiografía y estudio de conducción nerviosa
- e) Solicitar anticuerpos anti-receptor de acetilcolina

21) Respecto a los niños con epilepsia es verdadero que:

- a) Habitualmente se manifiesta como crisis parciales
- b) Frecuentemente presentan antecedentes familiares
- c) Suelen acompañarse de retraso mental
- d) Generalmente presentan espasticidad de las extremidades
- e) La resonancia magnética nuclear suele aportar mucha información para el manejo de estos pacientes

22) Un paciente de 23 años, es muy apático, poco afectivo y muy desconfiado, al punto que cree que sus familiares están asociados con el FBI para realizar experimentos en él. Refiere que en algunas ocasiones escucha los pensamientos malignos de los demás. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Trastorno de personalidad paranoide
- e) Demencia frontotemporal

23) El factor de riesgo más importante para la rotura uterina es:

- a) Trabajo de parto prolongado
- b) Cicatriz uterina
- c) Embarazo gemelar
- d) Aceleración occitócica
- e) Multiparidad

24) Un paciente de 72 años, diabético e hipertenso, presenta cuadro de inicio brusco de hemiparesia y hemihipoestesia derechas, asociado a afasia y desorientación. Al examen físico se constata paciente el Glasgow 13, con hemiplejia faciobraquial derecha y hemiparesia M2 de la extremidad inferior ipsilateral. Los reflejos osteotendíneos están abolidos a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular hemorrágico de las arterias cerebrales penetrantes
- b) Accidente vascular isquémico de la arteria cerebral anterior
- c) Accidente vascular isquémico de la arteria cerebral media
- d) Trombosis de la arteria basilar
- e) Hemorragia de troncoencéfalo

25) Una paciente, cursando una diarrea aguda, evoluciona con astenia y oliguria. Luego de hidratación evoluciona con mejoría en la diuresis, sin embargo persiste con elevación de la creatinina. ¿Qué antecedente sería más sugerente de una necrosis tubular aguda?

- a) Hiponatremia
- b) Sodio urinario aumentado
- c) Fracción excretada de sodio disminuida
- d) BUN normal
- e) Ecografía renal con riñones pequeños de ecogenicidad aumentada

26) Una mujer de 46 años está muy preocupada porque perdió la memoria de lo sucedido durante 10 horas, luego enterarse que su hijo menor había sufrido un grave accidente. Lo último que recuerda es que ella estaba en su casa ordenando y que luego se encontraba en el hospital rodeada de sus familiares. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno disociativo
- c) Somatización
- d) Crisis de pánico
- e) Trastorno por estrés agudo

27) Un paciente de 68 años, se realiza ecografía abdominal por sospecha de patología biliar, que demuestra un aneurisma aórtico infrarrenal de 5 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar aortografía y decidir eventual cirugía según hallazgos
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis y decidir realización de eventual cirugía según hallazgos
- c) Resolver quirúrgicamente con recambio aórtico, de manera electiva, lo antes posible
- d) Iniciar IECAs y estatinas, tratando de mantener presiones arteriales menores a 120/80 mmHg
- e) Observar evolución indicando control en caso de aparición de signos de alarma

28) Usted identifica 2 grupos en una población. El primer grupo usa antiinflamatorios no esteroideos por diversas patologías y el segundo grupo no los usa. Usted sigue los grupos a largo plazo y observa la aparición de úlcera péptica. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Caso control
- b) Cohorte
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico
- e) Ecológico

29) Un paciente 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia edema blando de extremidades inferiores, párpados y escroto. Los signos vitales son normales y el niño se encuentra en buenas condiciones generales. Se solicitan exámenes con los siguientes resultados: creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, complemento normal, colesterol: 322 mg/dl, sedimento de orina con cruces de malta y proteinuria de 24 horas: 2,6 g/24 horas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Hospitalizar e iniciar corticoides intravenosos
- d) Iniciar un diurético y asociar una estatina
- e) Derivar a biopsia renal

30) Un niño de 18 meses acude a un control de niño sano. Habría recibido las vacunas del plan nacional de inmunizaciones, hasta los 6 meses de edad y no habría tenido controles ni vacunaciones posteriores. No ha presentado síntomas y el examen físico es normal. La conducta más adecuada

- a) Administrar la vacuna trivírica
- b) Administrar la vacuna DPT y polio
- c) Administrar la vacuna DPT, polio, VHB y Hib
- d) Administrar la vacuna trivírica, DPT y polio
- e) Administrar la vacuna trivírica, DPT, polio, VHB y Hib

31) Un paciente de 44 años consulta por astenia, fiebre y palidez. Al examen físico se observa pálido, con varias Petequias en las extremidades inferiores y con una esplenomegalia palpable, 4 cm bajo el reborde costal. Se solicita hemograma que demuestra: Hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,4 g/dl, plaquetas: 55.000, blancos: 2.900, con 90% de neutrófilos y 10% de linfocitos. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de médula ósea
- b) Solicitar biopsia esplénica
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Realizar plasmaféresis
- e) Administrar antibióticos de amplio espectro

32) Al nacer, un niño de término pesa y mide aproximadamente:

- a) 2.500 gr y 40 cm
- b) 3.000 gr y 40 cm
- c) 3.000 gr y 50 cm
- d) 3.500 gr y 50 cm
- e) 3.500 gr y 60 cm

33) ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce hiperkalemia?

- a) Losartán
- b) Furosemida
- c) Salbutamol
- d) Glibenclamida
- e) Nifedipino

34) Una paciente de 24 años, cesarizada anterior, cursando su segundo embarazo de 40 semanas, inicia dinámica uterina, que se ha ido intensificando. Al examen se constatan 4 contracciones uterinas cada 10 minutos y el tacto vaginal muestra un cuello totalmente borrado, con 6 cm de dilatación y membranas rotas. Se palpa la cabeza fetal en espinas 0, en posición occipitoiliaca izquierda anterior. El registro estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar el parto normalmente
- b) Iniciar occitocina
- c) Administrar antibióticos endovenosos hasta el término del parto, por vía vaginal
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

35) Un paciente de 66 años, fumador, diabético e hipertenso, mal controlado presenta dolor precordial opresivo de algunos minutos de duración, que aparece en relación al ejercicio y cede, con el reposo y que interfiere con sus actividades diarias, ya que no es capaz de caminar 3 cuadras sin necesidad de descansar por el dolor. Usa aspirina, enalapril, glibenclamida y atenolol, tomados de forma irregular. Se solicita un electrocardiograma que resulta normal. La conducta más adecuada:

- a) Optimizar el manejo de sus factores de riesgo cardiovascular y controlar en 3 meses
- b) Iniciar tratamiento con nitroglicerina y controlar periódicamente
- c) Agregar una estatina y controlar periódicamente
- d) Solicitar test de esfuerzo
- e) Solicitar coronariografía

36) Un adolescente de 18 años, sin antecedentes de importancia, regresa de un viaje por Europa de 30 días, muy agitado, con ideas paranoides de que es buscado por la Interpol para matarlo. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, realizar estudio toxicológico completo, analítica sanguínea general, imágenes cerebrales y administrar haloperidol, como tratamiento sintomático
- b) Hospitalizar, realizar estudio toxicológico, analítica sanguínea general, electroencefalograma y administrar benzodiacepinas, como tratamiento sintomático
- c) Solicitar hemograma, perfil bioquímico, electroencefalograma, administrar naloxona y flumazenil y decidir manejo según respuesta
- d) Diagnosticar esquizofrenia, educar a la familia e iniciar antipsicóticos atípicos por al menos un año
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear, drogas urinarias e iniciar antipsicóticos atípicos, evaluando respuesta cada 15 días

37) Un paciente de 50 años, consulta por disminución del chorro miccional, asociado a nicturia, polaquiuria y disuria de esfuerzo, de 8 meses de evolución, que se han intensificado en el último mes. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección urinaria
- b) Cáncer de próstata
- c) Estenosis uretral
- d) Hiperplasia prostática benigna
- e) Incontinencia de urgencia

38) Un paciente de 31 años sufre un accidente en moto. Usted acude en un servicio de rescate y lo observa con gran apremio respiratorio, hipotenso, taquicárdico, con yugulares ingurgitadas y clara asimetría de los hemicampos pulmonares, con abolición del murmullo pulmonar e hipersonoridad a derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Puncionar el segundo espacio intercostal
- b) Instalar un tubo pleural
- c) Realizar pericardiocentesis
- d) Realizar intubación orotraqueal y ventilar con ambú y oxígeno al 100%
- e) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación y suero fisiológico por una vía venosa periférica gruesa

39) Un recién nacido presenta cianosis marcada, que no mejora al administrar oxígeno al 100%, con saturaciones arteriales de oxígeno cercanas al 60%. ¿Qué patología es MENOS probable?

- a) Tetralogía de Fallot
- b) Atresia tricuspídea
- c) Tronco arterioso
- d) Ductus arterioso
- e) Transposición de grandes vasos

40) Una paciente presenta una placa hiperpigmentada, liquenificada, con pequeña descamación, de 6 cm, en la zona infraumbilical. No presenta otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Onfalitis
- b) Pitiriasis versicolor
- c) Psoriasis
- d) Liquen simple
- e) Dermatitis de contacto

41) Una mujer de 67 años, hipertensa bien controlada, sufre caída a nivel, golpeándose el muslo y cadera izquierdas. Presenta importante dolor e imposibilidad para levantarse. Al examen físico se observa adolorida, lúcida, eupneica, bien perfundida. Se observa la extremidad inferior izquierda acortada, en posición impúdica. El examen neurovascular distal resulta normal. Se solicita radiografía de caderas, que muestra una fractura intertrocantérica, Tronzo III. La analítica sanguínea y el ECG son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgesia oral con AINEs y opiáceos e inmovilizar con yeso pelvipedio
- b) Realizar reducción manual bajo anestesia raquídea e inmovilizar con yeso pelvipedio
- c) Iniciar analgésicos orales e indicar reposo en cama, sin inmovilización, por 3 meses
- d) Realizar osteosíntesis con tornillo dinámico (DHS)
- e) Instalar prótesis de cadera

42) Una paciente de 34 años, consulta por astenia y náuseas de algunas semanas de evolución. En el último tiempo se ha agravado, con gran debilidad muscular y escasa tolerancia al ejercicio. En el examen físico destaca hiperpigmentación de la cara, palmas y algunas zonas de la mucosa oral. El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Cortisol libre urinario
- b) Cortisol plasmático y ACTH plasmática matinales
- c) Cortisol basal y post-ACTH
- d) Prueba de supresión larga con dexametasona
- e) Electrolitos plasmáticos y clearance de creatinina

43) Un paciente de 70 años, diabético, inicia cuadro de tos con expectoración y fiebre hasta 38,5°C, asociado a malestar general. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, decaído, eupneico, con FC: 90x', PA: 130/72 mmHg, FR: 15x' y saturación arterial de oxígeno de 96% por pulsometría. Se auscultan crépitos localizados en la base pulmonar derecha. Se solicita radiografía de tórax que revela una condensación en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Claritromicina
- d) Ceftriaxona
- e) Ceftriaxona más levofloxacino

44) Una mujer de 28 años, consulta por hirsutismo. Al examen físico se observa vello facial y en el pecho. La paciente presenta además obesidad moderada, piel grasa y acantosis nigricans. Con alta probabilidad presentará además:

- a) Hiperpotasemia
- b) Hipotensión ortostática
- c) HDL elevado
- d) Reglas irregulares
- e) Estradiol disminuido

45) Un paciente de 30 años es traído por sus familiares ya que duerme poco y ha empezado a gastar gran parte de sus ahorros en distintos negocios, de forma muy desordenada y con malos resultados económicos. Él refiere sentirse muy bien y dice que su familia no es capaz de entender sus proyectos que de seguro serán muy exitosos. Habla rápido y pasa fácilmente de un tema a otro. El diagnóstico más probable es:

- a) Psicosis reactiva
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Manía
- e) Trastorno de personalidad narcicista

46) ¿Cuál de los siguientes pacientes puede ser catalogado como diabético?

- a) Un niño de 6 años, asintomático, con glicemia postprandial de 260 mg/dl
- b) Una mujer obesa, con TTOG con glicemia basal de 120 mg/dl y post 75 g de glucosa de 186 mg/dl
- c) Hombre con poliuria, polidipsia y baja de peso con glicemia de 177 mg/dl
- d) Mujer de 45 años, con glicemia de ayuno de 126 mg/dl y de 131 mg/dl en días distintos
- e) Embarazada con glicemias postprandiales cercanas a 120 mg/d

47) Un niño de 7 años presenta meningitis meningocócica. La conducta más adecuada para sus contactos cercanos es:

- a) Iniciar tratamiento con ceftriaxona endovenosa, por 7 días
- b) Iniciar tratamiento con amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral, por 5 días
- c) Administrar una dosis de eritromicina oral
- d) Iniciar profilaxis antibiótica con rifampicina oral, por 2 días
- e) Observar en su domicilio con indicación de consultar en caso de aparición de fiebre o algún otro síntoma

48) El aumentar el tamaño de la muestra es una estrategia utilizada para disminuir el error producido por:

- a) El azar
- b) Variables de confusión
- c) Sesgos de medida
- d) Sesgos de memoria
- e) Tipo 2

49) Un hombre de 67 años, consulta por disnea de esfuerzos, ortopnea de 2 almohadas y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se palpa choque de la punta desplazado al quinto espacio intercostal, a la altura de la línea axilar media y se ausculta un ritmo regular en 2 tiempos, con disminución de la intensidad del primer ruido y con la presencia de un soplo holosistólico III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia mitral
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Insuficiencia tricuspídea

50) Una paciente cursando un embarazo de 9 semanas por amenorrea se realiza ecografía transvaginal que demuestra un saco embrionario de 44 mm sin presencia de embrión. No presenta síntomas y el tacto vaginal no muestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el trabajo de aborto con misoprostol
- b) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta
- c) Realizar laparoscopia
- d) Administrar progestágenos
- e) Realizar cerclaje a las 12 semanas

51) Un paciente de 71 años consulta por dolor en la ingle derecha, que aumenta con la marcha, por lo que ha disminuido su actividad. El dolor varía de un día a otro y cede con el reposo. El examen físico se observa dolor a la abducción y rotación interna de la cadera derecha. Se solicita radiografía de cadera que muestra disminución del espacio articular, con reacción subcortical y presencia de algunos osteofitos acetabulares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol
- b) Solicitar hemograma, VHS, ANA, ANCA y factor reumatoideo
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Realizar infiltraciones con corticoides
- e) Resolver quirúrgicamente

52) Un paciente de 57 años presenta un cuadro caracterizado por importante agitación psicomotora, temblor y alucinaciones visuales de serpientes y lagartijas que lo atacan. El diagnóstico más probable es:

- a) Epilepsia
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Síndrome confusional agudo
- d) Esquizofrenia
- e) Síndrome de abstinencia de alcohol

53) La meningoencefalitis viral se caracteriza por:

- a) Ser causada principalmente por virus herpes
- b) El compromiso de los pares craneales oculomotores
- c) Un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear, glucosa normal y proteínas elevadas
- d) Ser una causa muy infrecuente de meningitis
- e) Tratar con corticoides endovenosos

54) Los delirios más frecuentemente identificados, en el curso de una depresión psicótica, son:

- a) Culpa y ruina
- b) Paranoide y ruina
- c) Duda y contaminación
- d) Culpa y paranoide
- e) Duda y culpa

55) Un paciente de 22 años presenta hipertensión arterial con valores cercanos a 170/110. En sus exámenes destaca Na⁺: 145 mEq/l; K⁺: 2,8; Cl⁻: 108. El diagnóstico de sospecha debe incluir:

- a) Feocromocitoma
- b) Insuficiencia renal
- c) Apnea obstructiva del sueño
- d) Hipertensión renovascular
- e) Insuficiencia suprarrenal

56) Un paciente asmático en tratamiento con salbutamol y corticoides inhalados discontinúa su tratamiento, evolucionando con tos y disnea sibilante. Al examen está disneico, sin cianosis, con frecuencia cardíaca de 97 lpm, presión arterial de 130/45 mmHg, frecuencia respiratoria de 25 rpm y saturación arterial de 91%. Presenta retracción intercostal y a la auscultación pulmonar se escuchan sibilancias inspiratorias y espiratorias. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio reiniciando su tratamiento habitual
- b) Administrar oxígeno a 2 litros/minuto, realizar set de nebulizaciones con salbutamol, administrar corticoides sistémicos y reevaluar en una hora
- c) Iniciar oxigenoterapia, realizar nebulización con salbutamol y si responde bien, enviar a domicilio con corticoides y antibióticos orales
- d) Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica y administrar dexametasona endovenosa, reevaluando cada 30 minutos
- e) Hospitalizar, iniciar oxígeno al 100%, corticoides endovenosos, nebulizaciones con salbutamol y antibióticos de amplio espectro

57) Un niño de 4 años es traído por su madre al servicio de urgencia pediátrico, por un cuadro de tos y disfonía, al que se agregó estridor inspiratorio y disnea. Al examen físico se observa el niño con taquipnea moderada, cianosis perioral, retracción intercostal y se escucha un estridor inspiratorio. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Solicitar radiografía de tórax y decidir manejo según hallazgos
- c) Nebulizar con adrenalina racémica y administrar corticoides sistémicos
- d) Nebulizar con salbutamol e iniciar corticoides inhalados
- e) Instalar tubo orotraqueal y conectar a ventilación mecánica, administrando oxígeno en alta concentración y broncodilatadores

58) Un hombre presenta diplopía y al examen físico se observa estrabismo convergente en algunas posiciones de la mirada. Al mirar a la derecha ambos ojos se mueven normalmente, en cambio al mirar a la izquierda el iris izquierdo se queda en la línea media, mientras que el iris derecho avanza hasta el canto ocular nasal. El nervio afectado es:

- a) Tercer nervio craneal derecho
- b) Cuarto nervio craneal izquierdo
- c) Sexto nervio craneal izquierdo
- d) Tercer nervio craneal izquierdo
- e) Sexto nervio craneal derecho

59) Una paciente de 23 años se somete a una cirugía de várices, con anestesia epidural, sin embargo por error se punciona la duramadre y se administra el anestésico intrarraquídeo. Evoluciona con compromiso de conciencia, hipotensión y apnea. Además convulsiona en una oportunidad. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cerebro con contraste
- b) Iniciar flumazenil endovenoso y conectar a ventilador mecánico
- c) Administrar naloxona y oxígeno terapia
- d) Iniciar soporte con ventilador mecánico y drogas vasoactivas, agregando un anticonvulsivante
- e) Iniciar oxigenoterapia por mascarilla y administrar suero fisiológico

60) Una paciente presenta una crisis de angustia en relación a una pelea con su marido. Una semana después presenta una nueva crisis de angustia, mientras estaba sola en su casa, sin poder identificar un desencadenante claro. Tiene mucho miedo de presentar una nueva crisis y de morir o volverse loca durante ella, por lo que ya no quiere quedarse sola en la casa. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome adaptativo
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Depresión
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno de pánico

61) Un paciente de 26 años, consulta por astenia, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico se palpan varias adenopatías inguinales derechas, de hasta 3,5 cm no dolorosas. No presenta otras alteraciones. El hemograma es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Enfermedad por arañazo de gato
- d) Tuberculosis
- e) Mononucleosis infecciosa

62) Un niño de 4 años llora con frecuencia y hace berrinches cuando su madre lo lleva al colegio o cuando lo deja al cuidado de otras persona. Es difícil de consolar, hasta que su madre regresa. La madre se siente muy angustiada por la situación ya que cree que puede pasarle algo a su hijo al dejarlo solo. Refiere además que no se queda dormido solo y que es necesario acompañarlo hasta que se duerme. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad dependiente
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno de conducta
- d) Trastorno por déficit atencional
- e) Trastorno por ansiedad de separación

63) Una mujer de 42 años presenta ojo rojo profundo, asociado a dolor intenso, fotofobia y blefarospasmo derechos. Las pupilas, los reflejos fotomotores, la agudeza visual y la oculomotilidad son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo de ángulo estrecho
- b) Epiescleritis
- c) Queratitis aguda
- d) Uveítis aguda
- e) Coriorretinitis

64) Un paciente de 71 años, con AVE isquémico hace 7 días, secuelado con hemiplejía izquierda, presenta una zona eritematosa de 6 cm en la región sacra, dolorosa a la palpación, de temperatura normal. No ha presentado fiebre ni otros síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina oral
- b) Iniciar cloxacilina endovenosa
- c) Asegurar cambios de posición frecuentes
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear
- e) Realizar aseo quirúrgico

65) ¿Cuál de las siguientes patologías NO suele confundirse con un trastorno de pánico?

- a) Hipertiroidismo
- b) Taquicardia paroxística supraventricular
- c) Feocromocitoma
- d) Fobia social
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

66) Un niño de 6 años presenta fiebre, malestar general y tos productiva, con abundante expectoración mucopurulenta. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin taquipnea, saturando 97% a oxígeno ambiental, con signos vitales normales. Se auscultan crepitaciones en la zona precordial derecha. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una condensación en relación al lóbulo medio derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con azitromicina oral por 3 días
- b) Enviar a domicilio con amoxicilina oral por 7 días
- c) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar e iniciar moxifloxacino oral
- e) Solicitar cultivo de esputo y decidir manejo según hallazgos

67) Un paciente sufre un traumatismo de hombro, evolucionando con anestesia en la zona deltoidea e imposibilidad para abducir la extremidad. La estructura más probablemente dañada es:

- a) Nervio musculocutáneo
- b) Nervio radial
- c) Nervio mediano
- d) Nervio axilar
- e) Nervio cubital

68) La conducta más adecuada ante el diagnóstico clínico de una corioamnionitis es:

- a) Iniciar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo al completar la madurez pulmonar
- b) Realizar amniocentesis
- c) Interrumpir el embarazo por una vía expedita bajo cobertura antibiótica endovenosa
- d) Administrar antibióticos intraamnióticos
- e) Solicitar test de tolerancia a las contracciones

69) Un paciente consulta por disnea y dolor torácico con tope inspiratorio. Se realiza radiografía de tórax que demuestra un derrame pleural derecho moderado, razón por la cual se realiza toracocentesis, con salida de líquido amarillo, transparente, con LDH: 70% de la plasmática, proteínas de 5,7 gramos, pH: 7,32, lactato: 3 mMol/dl, ADA: 15 U/lit y 1.000 células por mm³, de predominio polimorfonuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Derrame paraneumónico simple
- c) Empiema
- d) Cáncer
- e) Insuficiencia cardíaca

70) Un lactante de 8 meses consulta por un cuadro de irritabilidad y crisis de llanto de un par de horas de evolución, que cede espontáneamente, dando salida a deposiciones sanguinolentas. Al examen físico se observa en buenas condiciones, con actitud de dolor, especialmente a la palpación del cuadrante inferior derecho del abdomen. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales y rehidratación oral
- b) Hospitalizar, indicar régimen cero e iniciar hidratación endovenosa, asociado a antibióticos de amplio espectro
- c) Solicitar una ecografía abdominal
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Realizar laparotomía exploradora

71) De cada 100 pacientes que presentan una ecografía abdominal compatible con coleditiasis, 90 la presentan. Esto quiere decir que:

- a) La sensibilidad es 0,9
- b) La especificidad es 0,9
- c) El valor predictivo positivo es 0,9
- d) El valor predictivo negativo es 0,9
- e) El likelihood ratio es 0,9

72) ¿Qué antecedente clínico es MÁS sugerente de una disfunción eréctil de origen orgánico?

- a) Pérdida de la erección durante la relación sexual
- b) Antecedente de hipertensión y diabetes
- c) Disminución de la libido
- d) Antecedente de hipotiroidismo
- e) Pérdida de las erecciones matinales

73) Un paciente de 7 años presenta un cuadro de odinofagia intensa y fiebre, a lo que se agrega un exantema eritematoso, papular, palpable, con algunas Petequias lineales en los pliegues de las extremidades, descamación de la piel de los dedos y compromiso de la lengua, la que se vuelve saburral, con fácil visualización de las papilas. En el examen se observa lo descrito, más la presencia de exudado amigdalino blanquecino-grisáceo adherente. El agente etiológico más probable es:

- a) Parvovirus
- b) Virus Epstein-Barr
- c) Enterovirus
- d) Streptococo grupo A
- e) Staphylococo dorado

74) Un hombre de 47 años sufre un infarto al miocardio con supradesnivel del ST, de la pared anterolateral, el que es tratado con trombolisis, con buena respuesta, recuperando su estado basal luego de algunos días. 30 días después acude a control, con un electrocardiograma, que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones V1 a V4. No presenta síntomas y el examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis de la arteria descendente anterior
- b) Aneurisma ventricular
- c) Hipertrofia ventricular compensatoria
- d) Electrocardiograma esperable postinfarto
- e) Reinfarto

75) Un paciente de 54 años, consulta por dolor epigástrico muy intenso, de algunas horas de evolución, constante, irradiado al dorso y asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades. Al examen físico se observa abdomen muy doloroso, especialmente en el epigastrio, con algún grado de resistencia muscular y clara disminución de los ruidos hidroaéreos. Se observa además una zona equimótica en la fosa lumbar izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Perforación de úlcera péptica
- b) Aneurisma roto de la aorta abdominal
- c) Disección aórtica
- d) Trombosis mesentérica
- e) Pancreatitis aguda

76) Un paciente de 23 años presenta dolor y aumento de volumen de la pierna izquierda. Al examen se observa edema moderado, blando, con dolor a la palpación de los músculos gastrocnemios. También presenta dolor en los gastrocnemios al forzar la dorsiflexión del pie. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pletismografía de volumen
- b) Solicitar TAC de extremidades inferiores con contraste endovenoso
- c) Solicitar venografía
- d) Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores
- e) Iniciar cumarínicos

77) Una paciente gestante de 36 semanas consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se realiza un registro basal no estresante que resulta no reactivo y un test de tolerancia a las contracciones que demuestra desaceleraciones tardías en relación a la mayoría de las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Solicitar un perfil biofísico
- c) Administrar corticoides endovenosos a la madre
- d) Inducir parto con misoprostol
- e) Tranquilizar a la madre, explicándole que su embarazo cursa normalmente

78) El efecto adverso más frecuente de la risperidona es:

- a) Náuseas
- b) Sedación
- c) Disfunción sexual
- d) Síntomas extrapiramidales
- e) Agranulocitosis

79) Un paciente de 16 años, consulta por odinofagia de 2 días de evolución, que se ha hecho muy intensa, especialmente en el lado derecho, agregándose imposibilidad marcada para abrir la boca. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con exudado amigdalino grisáceo bilateral y abombamiento del pilar faríngeo anterior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Absceso periamigdalino
- c) Absceso retrofaríngeo
- d) Angina de Ludwig
- e) Angina de Vincent

80) El tratamiento más importante de la anemia de la insuficiencia renal consiste en:

- a) Ácido fólico y vitamina B12
- b) Eritropoyetina subcutánea
- c) Transfusiones seriadas
- d) Hierro endovenoso
- e) Hierro oral

81) ¿Cuál de los siguientes cambios no suele aparecer con el envejecimiento normal?

- a) Aumento de la base de sustentación durante la marcha
- b) Disminución de la filtración de filtración glomerular
- c) Disminución del hematocrito
- d) Disminución de las horas de sueño
- e) Disminución de la masa muscular

82) Calcule la incidencia de VIH, con los siguientes datos:

Población total: 5000 habitantes; enfermos de VIH al inicio del período: 500; casos nuevos de VIH: 100; muertes de pacientes VIH: 50; muertes totales: 200.

- a) 100/500
- b) 100/5000
- c) 50/500
- d) 50/5000
- e) 550/5000

83) Un niño de 6 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 38,2°C y tos seca, que evoluciona con dificultad respiratoria. Al examen se observa taquipneico, con retracción intercostal y subcostal y a la auscultación pulmonar se escuchan sibilancias bilaterales difusas. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Asma
- c) Laringitis obstructiva
- d) Bronquiolitis
- e) Bronquitis aguda

84) Un paciente de 60 años presenta aparición de un púrpura petequial generalizado, con algunas equimosis en extremidades inferiores, que comenzaron hace 10 días. Refiere además epistaxis en algunas ocasiones, autolimitadas. El examen físico sólo demuestra las alteraciones descritas. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 46%, Hb: 15,2 g/dl, blancos: 7.300, con fórmula diferencial normal, y plaquetas: 32.000. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar tiempo de sangría, TP y TTPA
- b) Administrar inmunoglobulina endovenosa
- c) Administrar vitamina K
- d) Iniciar corticoides orales
- e) Realizar transfusión de plaquetas

85) Una paciente de 76 años, con antecedente de hipertensión y artrosis en tratamiento, presenta exacerbación de sus artralgias, que le limitan la marcha y la realización de sus actividades normales, a pesar de aumentar la dosis de sus analgésicos, por lo que evoluciona con ánimo bajo, sensación de inutilidad e ideas de muerte. Le cuesta dormir y refiere que se siente solo y no tiene ganas de seguir viviendo. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Depresión mayor
- c) Demencia inicial
- d) Hipotiroidismo
- e) Arteritis de la temporal

86) Una paciente presenta metrorragia a la octava semana de un embarazo. Se realiza ecografía transvaginal que es compatible con un embarazo molar, razón por la que se realiza un legrado uterino. La biopsia demuestra tejido molar, sin formación de estructuras fetales ni invasión del miometrio. La conducta más adecuada es:

- a) Observa evolución, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar progestágenos puros
- c) Indicar anticonceptivos orales y solicitar niveles seriados de beta-HCG
- d) Realizar histerectomía
- e) Iniciar quimioterapia

87) La indicación más importante para prevenir la recurrencia de síntomas, en un paciente con historia de urolitiasis de oxalato de calcio, es:

- a) Indicar un diurético de asa
- b) Disminuir la ingesta de oxalato
- c) Disminuir la ingesta de calcio
- d) Aumentar la ingesta de calcio
- e) Aumentar la ingesta de agua

88) Un paciente de 50 años, fumador de 10 cigarrillos al día, presenta disnea progresiva, desde hace 4 meses, actualmente de pequeños esfuerzos. No presenta ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Al examen destacan uñas en vidrio de reloj y se auscultan crépitos gruesos difusos en ambos campos pulmonares, con disminución del murmullo pulmonar en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Insuficiencia cardíaca congestiva
- c) Hipertensión pulmonar primaria
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Cáncer pulmonar

89) El cáncer de cuello uterino se extiende fundamentalmente:

- a) Por invasión de parametrios y metástasis linfáticas pélvicas
- b) Por invasión de la vagina y recto y por metástasis linfáticas inguinales
- c) Por invasión del endometrio y metástasis linfáticas paraaórticas
- d) Por vía hematógena
- e) Por siembras peritoneales

90) Un niño corre, sube y baja escaleras alternando los pies y es capaz de pedalear en un triciclo. Además dice cerca de 250 palabras, armando frases de 3 a 4 palabras y es capaz de darse a entender con adultos distintos a sus padres, cometiendo pocos errores de lenguaje. La edad aproximada del niño es:

- a) 12 meses
- b) 18 meses
- c) 24 meses
- d) 36 meses
- e) 48 meses

Respuestas:

Prueba 1 Ensayo EUNACOM	
Preguntas	Respuestas
1	E
2	A
3	A
4	D
5	E
6	D
7	A

8	D
9	D
10	A
11	E
12	A
13	A
14	C
15	B
16	D
17	E
18	C
19	D
20	B
21	C
22	D(tb si exaltación)
23	B
24	E
25	D
26	A
27	D
28	E
29	B
30	A
31	D
32	C
33	E
34	B
35	C
36	A
37	C
38	A

39	A (Hoy:ColangioRMN)
40	D
41	A
42	E
43	D (Hoy ninguna)
44	A
45	C
46	B
47	D
48	C
49	D
50	A
51	E
52	A
53	B
54	E (A tb puede ser si endometrio es menor a 5 mm)
55	D
56	D
57	D
58	B
59	D
60	E
61	B
62	B
63	B
64	C
65	E
66	C
67	D
68	D
69	D

70	E
71	C
72	B
73	D
74	B
75	C
76	A
77	E
78	D
79	C
80	A
81	D
82	A
83	E
84	D
85	A
86	D
87	D
88	C
89	E
90	D

Prueba 1 Ensayo EUNACOM (segunda parte)

Preguntas	Respuestas
1	E
2	C
3	B
4	B
5	E
6	C
7	C
8	B

9	C
10	C
11	C
12	A
13	D
14	A
15	D
16	C
17	E
18	D
19	A (VCM=70)
20	A
21	B
22	B
23	B
24	C
25	B
26	B
27	C (hoy: Stent)
28	B
29	B
30	E (hoy tb neumococo)
31	A
32	D
33	A
34	A
35	D
36	A
37	D
38	A
39	D

40	E
41	D
42	C
43	B
44	D
45	D
46	D
47	D
48	A
49	C
50	A
51	A
52	E
53	C
54	A
55	D
56	B
57	C
58	C
59	D
60	E
61	A
62	E
63	C
64	C
65	E
66	B
67	D
68	C
69	B
70	C

71	C
72	E
73	D
74	B
75	E
76	A
77	A
78	D
79	B
80	B
81	C
82	B
83	D
84	D
85	B
86	C
87	E
88	D
89	A
90	D

Ensayo EUNACOM – Prueba 2

1) Un hombre de 48 años, asintomático, presenta en dos análisis de sangre rutinarios, glucemias basales de 132 y 130 mg/dl.

¿Cuál será la actitud correcta?:

- a) Se le diagnostica Diabetes Mellitus tipo 2 y se inicia tratamiento con dieta.
- b) Se le pide una curva de glucemia para diagnóstico.
- c) Se inicia tratamiento con antidiabéticos orales
- d) Se inicia tratamiento con dosis bajas de Insulina NPH
- e) Se le pide nueva analítica para dentro de un año.

2) Un paciente de 65 años, hipertenso bien controlado, usuario de aspirina, presenta hematoquezia en una oportunidad, sin compromiso hemodinámico, autolimitada. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Suspender la aspirina
- c) Iniciar ciprofloxacino
- d) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- e) Solicitar colonoscopia

3) La mortalidad general en Chile en el último quinquenio se ha caracterizado por ser:

- a) superior en mujeres / mayor en senescentes / tendencia ascendente
- b) superior en hombres / mayor en adultos jóvenes / tendencia ascendente
- c) superior en hombres / mayor entre 15 y 64 años / tendencia estable
- d) superior en hombres / mayor en edades extremas / tendencia estable
- e) superior en mujeres / mayor en lactantes / tendencia descendente

4) Una mujer de 35 años consulta por prurito vulvar y leucorrea. Al examen físico se observa leucorrea blanca, grumosa y signos inflamatorios de la pared vaginal. La prueba de KOH resulta negativa. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginitis irritativa
- b) Infección por Chlamydia
- c) Candidiasis
- d) Tricomoniasis
- e) Vaginosis

5) Lactante de 5 meses, con fiebre sobre 39°C, decaído, con rechazo alimentario. Hace 30 minutos presentó una convulsión tónico-clónica generalizada que cedió espontáneamente. Al examen: irritable, somnoliento, signos vitales estables, fontanela a nivel, sin signos meníngeos ni otros hallazgos.

¿Cuál es la conducta más apropiada?

- a) Administrar antipiréticos y observar por un mínimo de 12 horas
- b) Solicitar hemograma, VHS y proteína C reactiva
- c) Solicitar evaluación por neurólogo
- d) Realizar punción lumbar
- e) Indicar anti convulsivantes profilácticos

6) La primera medida a tomar ante una hiperkalemia severa es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar furosemida endovenosa
- c) Administrar adrenalina endovenosa
- d) Administrar calcio endovenoso
- e) Administrar amiodarona endovenosa

7) Una paciente de 75 años, sufre caída a nivel, resultando con fractura de cadera. ¿Qué espera encontrar en el examen físico?

- a) Extremidad inferior acortada, rotada hacia interno, con marcada aducción
- b) Extremidad inferior acortada, rotada hacia externo, con ligera abducción
- c) Extremidad inferior acortada, rotada hacia interno, con equimosis en la cara lateral del muslo
- d) Extremidad inferior con deformación en valgo a nivel del muslo y equimosis en la cara lateral del muslo
- e) Extremidad inferior con deformación en varo a nivel del muslo y equimosis en la cara medial del muslo

8) Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre, tos, disfonía y luego dificultad respiratoria, con estridor inspiratorio. Al examen físico se observa taquipneuco, con uso de musculatura accesoria y al examen pulmonar se ausculta un murmullo pulmonar simétrico y el estridor inspiratorio referido de la vía aérea. El agente causal más probable del cuadro descrito es:

- a) Mycoplasma
- b) Virus respiratorio sincicial
- c) Virus parainfluenza
- d) Estreptococo pyogenes
- e) Cuerpo extraño

9) Un hombre de 85 años, con historia de una demencia inicial, sufre una caída, resultando con una fractura de muñeca de resolución quirúrgica. ¿Qué medida NO aconsejaría para prevenir la aparición de un síndrome confusional agudo durante la hospitalización?

- a) Realizar caminatas o paseos en silla de ruedas durante el día, acompañado de un familiar
- b) Poner un reloj y un calendario en la sala
- c) Administrar una adecuada analgesia con antiinflamatorios no esteroideos
- d) Asegurar el uso de lentes o audífonos en caso de que los requiriera previamente
- e) Administrar benzodiacepinas durante la noche para ciclar adecuadamente el sueño y la vigilia

10)Cuál de las siguientes opciones corresponde a una indicación de cirugía en el contexto de una pancreatitis aguda:

- a) Necrosis
- b) Pseudoquiste de 4 cm
- c) Abscesos
- d) Colecciones peripancreáticas
- e) Distress respiratorio

11) Una paciente primigesta de 25 años, cursando embarazo de término, ingresa en trabajo de parto, con 6 centímetros de dilatación y feto en presentación de vértice, posición occipito púbica y espinas cero. El monitoreo cardíaco fetal demuestra desaceleraciones precoces en relación a la mayoría de las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Administrar un tocolítico por vía endovenosa
- c) Iniciar aceleración con oxitocina
- d) Realizar extracción fetal con forceps
- e) Realizar cesárea de urgencia

12) La principal diferencia clínica entre acné y rosácea:

- a) El compromiso de mucosas
- b) La presencia de pústulas y nódulos
- c) La presencia de cicatrices
- d) La presencia de comedones
- e) El curso fluctuante

13) Lo que básicamente diferencia una bulimia nerviosa de una anorexia nerviosa es:

- a) La pérdida de control sobre la comida.
- b) La preocupación excesiva por la figura y el peso.
- c) El ejercicio excesivo.
- d) La autoinducción del vómito.
- e) La utilización de laxantes.

14) ¿Cuál de las siguientes patologías no suele ser causa de metrorragia?

- a) Hiperplasia endometrial
- b) Miomatosis uterina
- c) Cáncer de endometrio
- d) Atrofia endometrial
- e) Disfuncional

15) Una enfermera de neonatología de 52 años nos consulta porque a su marido le acaban de diagnosticar de tuberculosis pulmonar activa. Tres meses antes de la exposición, esta mujer se realizó test tuberculínico (PPD) que fue negativo en 2 determinaciones, con una semana de intervalo. Refiere buena salud y la placa de tórax que se realizó tras la exposición, es normal. Se repite el test tuberculínico (PPD) a las 4 semanas de la exposición, apreciándose una induración de 8 mm. De las siguientes ¿cuál es la medida más adecuada para esta mujer?:

- a) Repetir el test tuberculínico (PPD) en un mes para comprobar si ha aumentado la induración a más de 10 mm. En este momento no requiere tratamiento y puede seguir trabajando.
- b) Repetir la placa de tórax ahora. Si negativa, realizar periódicamente placas de tórax, especialmente si desarrolla síntomas pulmonares. Puede continuar en su trabajo a menos que desarrolle síntomas pulmonares.
- c) Comenzar inmediatamente tratamiento con isoniácida durante un mínimo de 6 meses. Puede incorporarse al trabajo en 15 días.
- d) Repetir la placa de tórax ahora y si es negativa, comenzar profilaxis con isoniácida durante al menos 6 meses e incorporarse a su trabajo.**
- e) Realizar cultivo de micobacterias en esputo y comenzar tratamiento con isoniácida, rifampicina y piracinamida hasta tener el resultado.

16) Un hombre de 32 años, sin antecedentes de importancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea y en algunas oportunidades, también disnea paroxística nocturna. Actualmente es capaz de caminar una cuadra sin detenerse, cuando antes podía caminar kilómetros. Al examen presenta signos vitales normales y se palpa el choque de la punta en la línea axilar media, a la altura del quinto espacio intercostal. La auscultación cardíaca demuestra un ritmo de galope por un tercer ruido. En la auscultación pulmonar se aprecian algunos crépitos escasos, en ambas bases. Se solicita un electrocardiograma que muestra un ritmo sinusal, con signos de hipertrofia de aurícula y ventrículo izquierdos. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y algunos signos de congestión pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Pericarditis constrictiva
- c) Hipertensión pulmonar primaria
- d) Miocardiopatía dilatada
- e) Fibrosis pulmonar

17) Se realiza serología para VIH a una población de 10.000 habitantes, obteniéndose 100 resultados positivos, confirmandose todos ellos con Western blot. Esto quiere decir que:

- a) La incidencia acumulada de VIH es 1%
- b) La densidad de incidencia de VIH es 1%
- c) La prevalencia de VIH es 1%
- d) La letalidad de VIH es 1%
- e) La tasa de VIH es 1%

18) Un recién nacido de 27 días de vida, presenta ictericia de pocos días de evolución. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita bilirrubina total que resulta 7 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,4 mg/dl. El diagnóstico que debe considerarse como primera opción es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Hepatitis neonatal
- c) Ictericia hemolítica
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Atresia biliar primaria

19) Paciente de 75 años, sufre caída de 2 peldaños de la escalera, golpeándose la cabeza contra el suelo. No pierde la conciencia. Al examen se aprecia en Glasgow 15, sin signos neurológicos focales. Se observa pequeño hematoma de 1 cm en zona parietal derecha del cuero cabelludo. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con analgésicos orales
- b) Hospitalizar y observar evolución por 12 horas, sin necesidad de realizar imágenes
- c) Solicitar radiografía de cráneo AP y lateral y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar tomografía de cerebro, con ventana ósea, sin uso de medio de contraste
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear, con contraste endovenoso

20) Un paciente de 58 años, fumador, con antecedente de fibrosis pulmonar, secundaria al uso de nitrofurantoína durante la infancia, presenta un cuadro de tos, con expectoración y compromiso del estado general. Al examen físico se observa orientado, bien perfundido, decaído, febril hasta 38,5°C, con frecuencia cardíaca de 93x', frecuencia respiratoria de 19x', presión arterial de 108/66 mmHg y satura 95% con FiO2 ambiental. La auscultación pulmonar demuestra crépitos bilaterales, mucho más intensos en la base pulmonar izquierda. El examen cardíaco es normal. Se solicita radiografía de tórax que muestra una condensación en el lóbulo inferior izquierdo y los signos de fibrosis pulmonar en el resto de los campos pulmonares, similares a los que presentaba en radiografía previas. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar penicilina benzatina intramuscular y enviar a domicilio
- b) Iniciar amoxicilina oral y controlar de forma ambulatoria
- c) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico y controlar de forma ambulatoria
- d) Hospitalizar en sala e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Hospitalizar en UCI e iniciar ceftriaxona más claritromicina

21) El trastorno fóbico social se caracteriza fundamentalmente por:

- a) Incapacidad de establecer relaciones interpersonales
- b) Angustia que se presenta en lugares con mucha gente
- c) Expectación ansiosa
- d) Ansiedad intensa ante el escrutinio de los demás
- e) Angustia y desconcentración durante los exámenes escritos

22) ¿Cuál de las siguientes anemias NO suele ser macrocítica?

- a) Mielodisplasia
- b) Hipotiroidismo
- c) Consumo de alcohol
- d) Enfermedades crónicas
- e) Déficit de vitamina B12

23) Una paciente cursando un AVE isquémico de 24 horas de evolución, de arteria cerebral media, presenta hematocrito: 37,2%; hemoglobina: 12,6 g/dl; VCM: 90; blancos: 9.900; plaquetas: 398.000; VHS: 44 mm/h; Calcio: 9,0 mEq/l; glicemia: 200 mg/dl; sodio: 129 mEq/l; Cl: 97 mEq/l; potasio: 4 mEq/l. El examen físico sólo demuestra el déficit neurológico esperado. La causa más probable de la alteración de sus exámenes es:

- a) Diabetes insípida central
- b) Insuficiencia renal prerrenal
- c) Insuficiencia suprarrenal
- d) Secreción inadecuada de vasopresina
- e) Baja ingesta de sodio

24) Mujer de 63 años. 48 kg de peso. A las 3 horas post colecistectomía recibe 10 mg de morfina endovenosa. A los 6 minutos la paciente está en sopor profundo, cianótica, con pulso firme de 120 por minuto y extrasístoles ventriculares ocasionales. La frecuencia respiratoria es de 2 a 3 por minuto.

La conducta a seguir debe ser:

- a) Administrar oxígeno por mascarilla (10 litros/min) y control de gases arteriales
- b) Administrar naloxona y ventilar con Ambú
- c) Administrar naloxona y pedir gases arteriales
- d) Administrar oxígeno por mascarilla (10 litros/min) y lidocaína endovenosa
- e) Intubar y pedir gases arteriales

25) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre hitos del desarrollo psicomotor y la edad, es INCORRECTA?

- a) Fija la mirada: 1 mes
- b) Adquiere control cefálico: 3 meses
- c) Lloro frente a los extraños: 6 meses
- d) Se para afirmado de muebles: 10 meses
- e) Usa la pinza madura: 12 meses

26) El período fértil se extiende desde:

- a) Un día antes hasta un día después de la ovulación
- b) Cinco días antes hasta cinco días después de la ovulación
- c) Cinco días antes hasta el día de la ovulación
- d) Diez días antes hasta tres días después de la ovulación
- e) Siete días antes hasta tres días después de la ovulación

27) Un niño de 5 años presenta insuficiencia renal crónica, secundaria a enfermedad renal poliquística. Usted sabe que esta patología es de herencia autosómica recesiva. Los padres pretenden tener un nuevo hijo. ¿Cuál es la probabilidad que el nuevo niño presente la enfermedad?

- a) 50% ya sea hombre o mujer
- b) 25% ya sea hombre o mujer
- c) 50% si es hombre y 0% si es mujer
- d) 100% si es hombre y 50% si es mujer
- e) 100% si es hombre y 0% si es mujer

28) En una nulípara en trabajo de parto de término, se considera fase latente prolongada a aquella que dura más de:

- a) 2 horas
- b) 6 horas
- c) 12 horas
- d) 20 horas
- e) 48 horas

29) El primer examen, que debe solicitarse ante un testículo no palpable unilateral, es:

- a) Ecografía inguinal
- b) Tomografía de abdomen y pelvis
- c) Laparoscopia
- d) Testosterona y gonadotropinas
- e) Cariograma

30) Una paciente de 47 años, sin antecedentes de importancia, sufre pérdida de conciencia durante una discusión entre su marido y su hijo. Se recupera espontáneamente luego de 10 minutos. El examen físico, el electrocardiograma y la analítica sanguínea general, resultan normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síncope vasovagal
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno disociativo
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno por somatización

31) Mujer de 19 años que consulta por llevar 6 meses sin regla. Se manifiesta preocupada por su sobrepeso, ha estado a dieta y ha perdido 5 kg. en 8 meses. Actualmente pesa 47 Kg (mide 1,65). El test de gestación es negativo. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea?:

- a) Digenesia gonadal.
- b) Hipogonadismo hipogonadotropo.
- c) Síndrome de ovario poliquístico.
- d) Himen imperforado.
- e) Adenoma hipofisario.

32) Un paciente presenta súbitamente hemiplejia braquiocrural derecha, asociada a parálisis facial y del nervio abducente de la hemicara izquierda. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto talámico
- b) Hemorragia intracerebral, con compromiso de la cápsula interna y núcleos de la base
- c) Accidente vascular embólico de arteria cerebral media
- d) Infarto de troncoencéfalo
- e) Apoplejía hipofisiaria

33) Una mujer de 25 años consulta porque presentó un aborto espontáneo a las 8 semanas de su primer embarazo. Actualmente se encuentra usando anticonceptivos orales, pero desea un nuevo embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía transvaginal y decidir manejo según hallazgos
- b) Solicitar anticuerpos anticardiolipinas, progesterona plasmática de fin de ciclo, ecografía transvaginal, prueba de Hegar y decidir manejo según hallazgos
- c) Suspender anticonceptivos y administrar progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual
- d) Realizar seguimiento folicular y inducción de la ovulación con clomifeno
- e) Tranquilizarla e indicarle que puede intentar un nuevo embarazo sin necesidad de estudio

34) Una paciente de 33 años consulta por dismenorrea moderada, que responde parcialmente al uso de ácido mefenámico. Se realiza una ecografía transvaginal que demuestra un tumor anexial quístico, de 5,5 cm de diámetro, con paredes lisas y sin increencias. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Teratoma quístico
- c) Endometrioma
- d) Cuerpo lúteo
- e) Quiste folicular

35) Un paciente con antecedentes de un traumatismo de uretra presenta uretrorragia y retención de orina con globo vesical.

¿Cuál es la conducta inmediata?

- a) Solicitar una cistoscopia diagnóstica
- b) Realizar una cistostomía suprapúbica
- c) Indicar cateterismo uretral intermitente
- d) Solicitar ecotomografía pelviana
- e) Instalar sonda Foley uretrovesical

36) ¿Cuál de las enfermedades del tejido conectivo se asocia con mayor frecuencia a una neoplasia?

- a) Lupus sistémico
- b) Síndrome de Sjörgren
- c) Dermatomiositis
- d) Esclerodermia sistémica difusa
- e) Enfermedad mixta del tejido conectivo

37) Paciente de 32 años, diagnosticado de colitis ulcerosa tipo pancolitis, tratado, sin episodios de brotes en los últimos 4 meses. Refiere desde hace 15 días dolor sordo en hipocondrio derecho y astenia. Febrícula ocasional. La exploración física no objetiva ninguna alteración significativa y analíticamente tiene una bilirrubina total de 2,3 mg/dl (directa 1,2 mgs/dl); aspartato aminotransferasa 90 UI/l; alanino aminotransferasa 106 UI/l; Fosfatasa alcalina 1100 UI/l; gammaglutamiltransferasa 350 UI/l. Actividad de la protrombina 95%. Proteínas totales 8 grs% y albúmina 3,9 grs%. Anticuerpos antimitocondriales negativos. Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Coledocolitiasis.
- b) Hepatitis autoinmune.
- c) Hígado metastásico.
- d) Colangitis esclerosante primaria.
- e) Cirrosis biliar primaria.

38) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, aleteo nasal y quejido luego del nacimiento. Presenta desaturación arterial hasta 82%, que se normaliza con oxígeno al 24%. Al examen pulmonar presenta algunos crépitos escasos, difusos. La etiología más probable es:

- a) Infección por estreptococo grupo B
- b) Deficiencia de surfactante pulmonar
- c) Retraso en la reabsorción de líquido pulmonar
- d) Aspiración de meconio
- e) Malformación congénita

39) Una paciente de 44 años, consulta porque en el último tiempo ha notado que su cara ha cambiado respecto a años atrás. Su nariz es más grande y su boca también. Actualmente calza 41, cuando antes calzaba 37. Presenta además síndrome del túnel carpiano bilateral y al examen físico se observa macroglosia y rasgos faciales toscos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prueba de supresión corta con dexametasona
- b) Solicitar TSH y T4 libre
- c) Solicitar niveles plasmáticos de hormona de crecimiento
- d) Solicitar niveles plasmáticos de somatomedina (IGF-1)
- e) Solicitar niveles plasmáticos de GH, luego de estimulación con ejercicio

40) Paciente de 36 años que, debido a una hematemesis masiva por un úlcera péptica recibe una transfusión con 2U de concentrado de hematíes. A los 5-10 m. de iniciarse la transfusión comienza con fiebre, escalofríos, hipotensión, dolor en región lumbar y oliguria. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

- a) Contaminación bacteriana de la sangre.
- b) Sepsis secundaria al ulcus.
- c) Reacción febril secundaria a la transfusión.
- d) Reacción febril por el plasma que contamina los hematíes.
- e) Reacción transfusional hemolítica.

41) La conducta más adecuada ante una paciente de 36 años, con amenorrea de 4 meses de evolución y prueba de embarazo en orina negativa, es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona y gonadotropinas
- c) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- d) Solicitar prolactina, TSH y prueba de progesterona
- e) Solicitar prueba de estrógeno más progesterona

42) Un paciente de 33 años consulta por vértigo intenso, de algunos segundos de duración que aparece en relación a algunos movimientos de la cabeza y se asocia a vómitos. No ha presentado síntomas auditivos. Al examen físico no se observa nistagmo de reposo, sin embargo al mover la cabeza es posible desencadenar un nistagmo horizontal rotatorio con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular de troncoencéfalo
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Vértigo paroxístico postural benigno
- d) Neuronitis vestibular
- e) Accidente vascular de cerebelo

43) Gestante de 38 semanas que ingresa con trabajo de parto. Durante el período de dilatación presenta cuadro de dolor brusco. A la exploración usted objetiva metrorragia escasa y aumento del tono uterino a la palpación abdominal que resulta muy doloroso. ¿Cuál sería su diagnóstico?:

- a) Rotura uterina
- b) Placenta previa.
- c) Desprendimiento de placenta.
- d) Corioamnionitis hemorrágica.
- e) Rotura de vasos previos.

44) Un paciente de 22 años, consulta por dolor epigástrico urente, constante, que aparece en algunas ocasiones después de comer o con el ayuno prolongado y que suele exacerbarse en los momentos de estrés, sin guardar relación con las deposiciones. El examen físico no muestra alteraciones. Se solicita endoscopia digestiva alta, que no muestra lesiones y con presencia de *Helicobacter pylori*. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera péptica cicatrizada
- b) Reflujo gastroesofágico
- c) Acalasia
- d) Dispepsia funcional
- e) Gastritis crónica por *H. pylori*

45) Una paciente cursando embarazo de 7 semanas de amenorrea inicia dolor hipogástrico y metrorragia. La especuloscopia constata que la metrorragia proviene de la cavidad uterina. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una gestación intrauterina con latidos cardiorfetales presentes y el tacto vaginal no demuestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio indicando reposo
- b) Hospitalizar, administrar corticoides y antibióticos endovenosos
- c) Inducir el trabajo de aborto con misoprostol
- d) Realizar legrado uterino inmediatamente
- e) Solicitar niveles de subunidad beta de gonadotropina coriónica

46) Respecto a la CENABAST es verdadero que:

- a) Los hospitales públicos deben comprar todos sus insumos a través de este organismo
- b) Es la institución responsable de fiscalizar la calidad y el adecuado funcionamiento de los productos utilizados por el sistema público
- c) Corresponde a un conjunto de laboratorios que proveen al sistema de salud chileno de medicamentos y otros insumos
- d) Permite al sistema de salud chileno tener un mayor poder de negociación con los proveedores
- e) Vende sus productos al precio indicado por el mercado

47) La fase del expulsivo se denomina a aquella que sucede entre:

- a) La aparición de la cabeza fetal en el introito vaginal y la salida completa del feto
- b) La dilatación cervical completa y la salida completa del feto
- c) La aparición de la cabeza fetal en el introito vaginal y la salida de la placenta
- d) La salida del feto y la salida de la placenta
- e) La salida del feto y la sección del cordón umbilical

48) El patch test (test de parche) sirve para corroborar el diagnóstico de:

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Urticaria
- c) Dermatitis atópica
- d) Rinitis alérgica
- e) Impetigo

49) Un paciente de 60 años inicia hace un mes con constipación y dolor abdominal que antes no presentaba. El examen físico resulta normal. Trae un hemograma y un perfil bioquímico, que resultan normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar un antiespasmódico y una dieta liviana, rica en fibra
- b) Iniciar dieta rica en fibras y lactulosa
- c) Solicitar una colonoscopia
- d) Solicitar una ecografía abdominal
- e) Solicitar un TAC de abdomen y pelvis

50) Recién nacido de 27 semanas de gestación, que nace por cesárea debido a desprendimiento de placenta, presenta un síndrome de dificultad respiratoria (SDR) grave a las 3 hrs de vida.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) SDR transitorio
- c) Hipertensión pulmonar
- d) SDR por aspiración de sangre
- e) Bronconeumonía connatal

51) Un paciente fumador de 40 paquetes años consulta por disnea de esfuerzos de 1 mes de evolución. El examen físico sólo demuestra espiración prolongada, sin otras alteraciones. Trae una radiografía de tórax que presenta signos de hiperinsuflación pulmonar, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar abandono del hábito tabáquico, iniciar antibióticos y controlar en 7 días
- b) Iniciar corticoides orales y betaagonistas inhalados
- c) Solicitar test de metacolina
- d) Solicitar espirometría
- e) Solicitar TAC de tórax con contraste

52) ¿Cuál es la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrófico masculino?

- a) Prolactinoma.
- b) Criptorquidia.
- c) Orquitis post parotiditis.
- d) Uso de fármacos anti androgénicos.
- e) Síndrome de Klinefelter.

53) El agente etiológico más frecuente de la diarrea asociada al uso de antibióticos es:

- a) Virus
- b) Staphylococcus aureus meticilino resistente
- c) Enterococcus faecalis
- d) Bacteroides fragilis
- e) Clostridium difficile

54) Un paciente de 45 años consulta por un cuadro de instalación lenta, en varios meses, de parestesias en el 4° y 5° dedos de la mano derecha, asociados a debilidad para flexar dichos dedos. El resto del examen no demuestra alteraciones. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Dedos en gatillo
- b) Síndrome de túnel carpiano
- c) Atrapamiento del nervio cubital
- d) Tendinitis de Quervein
- e) Lesión del nervio radial

55) Un paciente de 45 años, fumador e hipertenso presenta un cuadro de dolor retroesternal intenso, opresivo, asociado a sudoración y disnea, de inicio súbito. Presenta presión arterial de 160/110 mmHg y frecuencia cardíaca de 115 lpm. Se solicita electrocardiograma que muestra un supradesnivel del ST en las derivaciones V1 a V4. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax y decidir manejo según hallazgos
- b) Solicitar CK y CK-mb y decidir manejo según hallazgos
- c) Administrar oxígeno, aspirina y nitroglicerina, solicitar troponinas y reevaluar en una hora con el resultado
- d) Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina y solicitar test de esfuerzo una vez recuperado el paciente
- e) Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina y realizar angioplastia coronaria de forma inmediata

56) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y expresión clínica es INCORRECTA?

- a) Fractura subcapital de húmero – equimosis en la cara interna del brazo
- b) Fractura de escafoides – dolor en la tabaquera anatómica
- c) Fractura de cúpula radial – imposibilidad de pronosupinar el antebrazo
- d) Luxación posterior de cadera – posición púdica
- e) Luxación anterior de hombro – signo de la tecla de piano

57) Paciente de 55 años, hipertenso y diabético, es llevado al servicio de urgencia por pérdida de conciencia y cese de la respiración de 8 minutos de evolución. Al examen físico se constata paciente sin movimientos respiratorios y sin pulso. Se inician maniobras de RCP y se instala monitor cardíaco que muestra taquicardia ventricular. Luego de cinco ciclos de masaje cardíaco, continúa sin pulso. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Realizar 5 ciclos más de masaje cardíaco
- b) Realizar cardioversión eléctrica, administrar amiodarona endovenosa y suspender el masaje cardíaco
- c) Realizar desfibrilación eléctrica y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco
- d) Administrar adrenalina 1 mg endovenoso y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco
- e) Administrar atropina 1 mg endovenoso y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco

58) Un paciente de 67 años presenta hematuria en varias oportunidades, sin otros síntomas. Al examen físico no se encuentran alteraciones. Se solicita sedimento de orina que muestra más de 100 glóbulos rojos por campo, sin dismorfia. Se solicita Ecografía renal y vesical que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar biopsia prostática transrectal
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar cistoscopia
- e) Solicitar creatininemia, BUN, ANA, ANCA y complemento

59) Una paciente, que cursa un embarazo de 31 semanas, inicia dinámica uterina intensa de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, que persiste durante una hora de observación a pesar de reposo e hidratación. EL tacto vaginal muestra un cuello uterino con 60% de borramiento y dilatación de 2 centímetros, con membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos y dejar evolución espontánea
- b) Administrar corticoides endovenosos e iniciar protocolo de tocolisis
- c) Iniciar antibióticos y tocolíticos y reevaluar en una hora
- d) Iniciar corticoides, antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Realizar cesárea

60) Un hombre de 54 años presenta disnea de esfuerzos y ortopnea de 3 almohadas. Al examen cardiopulmonar destaca un soplo diastólico, con refuerzo presistólico y aumento de la intensidad del primer ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia tricuspídea
- d) Insuficiencia mitral
- e) Insuficiencia aórtica

61) Una mujer de 68 años, dueña de casa, presenta desde hace 2 años olvidos frecuentes, los familiares refieren que repite varias veces las cosas. En el último tiempo presenta además dificultad para cocinar y realizar sus actividades habituales, como por ejemplo abrir un frasco. Al examen físico se observa orientada, atenta, presenta dificultad para nombrar algunos objetos y tiene positividad de algunos signos arcaicos, sin signos focales. EL diagnóstico más probable es:

- a) Envejecimiento normal
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Demencia vascular
- e) Delirium

62) Una mujer de 72 años con antecedentes de diabetes mellitas e infarto de miocardio hace un año, tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 0,30 y está en tratamiento habitual con aspirina, furosemida (20 mg/día) y captopril (25 mg/día). Acude a su consulta por disnea de pequeños esfuerzos. La exploración física es compatible con insuficiencia cardíaca, de predominio derecho. PA: 140/70 mmHg. FC: 70 lpm. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es de menor prioridad desde el punto de vista de mejorar su pronóstico?

- a) Cambiar el captopril por lisinopril (20 mg/día).
- b) Iniciar tratamiento con digoxina (0,25 mg/día).
- c) Iniciar tratamiento con espironolactona (25 mg/día).
- d) Iniciar tratamiento con bisoprolol (1,25 mg/día)
- e) Iniciar tratamiento con simvastatina (40 mg/día).

63) Un niño de 5 años inicia un cuadro de compromiso del estado general y luego ictericia, siendo diagnosticado de hepatitis A, por serología. Su hermano de 7 años, con quien comparte mucho tiempo, nunca ha sufrido de hepatitis. ¿Cuál es la conducta más adecuada para evitar que el niño de 7 años desarrolle la enfermedad?

- a) Administrarle la vacuna anti-hepatitis A
- b) Administrarle inmunoglobulina específica contra el virus hepatitis A
- c) Administrarle inmunoglobulina no específica
- d) Administrarle lamivudina
- e) Administrarle interferón + ribavirina

64) ¿Qué nombre tiene el cuadro, caracterizado por ánimo bajo o disfórico, de más de 2 años de duración, sin cumplir criterios de depresión mayor?:

- a) Acatisia
- b) Ciclotimia
- c) Distimia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Depresión atípica

65) La clínica más habitual de la colestasia intrahepática del embarazo es:

- a) Exantema papular pruriginoso, que compromete palmas y plantas
- b) Astenia e ictericia en la segunda mitad del embarazo
- c) Ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, que aparece al final del embarazo
- d) Prurito palmoplantar de la segunda mitad del embarazo, sin lesiones cutáneas primarias
- e) Prurito e ictericia autolimitado en el primer trimestre del embarazo

66) Usted recibe en el servicio de urgencia a un paciente que se entierra una espina en el ojo izquierdo, presentando intenso dolor y blefarospasmo. Al examen físico se observa la espina enterrada a nivel de la unión esclerocorneal, con epífora y ojo rojo profundo. La conducta más adecuada es:

- a) Retirar la espina y administrar analgésicos endovenosos y un ungüento antibiótico en el ojo, derivando al oftalmólogo de manera urgente
- b) Retirar la espina, instalar parche compresivo e iniciar analgésico
- c) Administrar analgésicos y antibióticos endovenosos, instalar protección ocular no compresiva y derivar al oftalmólogo de urgencia, sin retirar la espina
- d) Administrar colirios anestésico y antibióticos y derivar al oftalmólogo de urgencia, para que él retire la espina
- e) Realizar aseo con abundante suero fisiológico y administrar analgésicos endovenosos, derivando al oftalmólogo de manera urgente para el retiro del cuerpo extraño

67) Un niño de 18 meses no dice ninguna palabra ni tampoco obedece las órdenes que se le dan. El resto del desarrollo psicomotor es normal. La primera medida a realizar es:

- a) Evaluar su audición
- b) Realizar escáner de cerebro
- c) Enseñar mejores técnicas de disciplina a los padres
- d) Realizar evaluación por un profesional de salud mental
- e) Observar por 3 meses y decidir conducta según evolución

68) Una paciente presenta lesiones de larga data, consistentes en placas amarillentas, levemente deprimidas en la cara anterior de ambas piernas. Usted realiza el diagnóstico de necrobiosis lipoídea. ¿A qué enfermedad se asocia más frecuentemente esta manifestación cutánea?

- a) Lupus sistémico
- b) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- c) Diabetes mellitus
- d) Enfermedad de Basedow-Graves
- e) Cáncer pulmonar

69) En relación con el Tratamiento Hormonal sustitutivo combinado con estrógenos y gestágenos de forma prolongada, las siguientes afirmaciones son ciertas, EXCEPTO una. Señale ésta:

- a) Disminuye la descalcificación propia de la menopausia.
- b) Mejora el trofismo vaginal.
- c) Aumenta el riesgo de Cáncer de Mama.
- d) Aumenta el riesgo de Cáncer de Endometrio.
- e) Disminuye los síntomas del climaterio.

70) Un hombre de 40 años debe someterse a una cirugía de recambio mitral, debido a una insuficiencia mitral secundaria a una endocarditis bacteriana aguda. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

- a) Instalar una prótesis mecánica, sin necesidad de anticoagular
- b) Instalar una prótesis mecánica, y anticoagular con cumarínicos para alcanzar INR entre 3 y 4
- c) Instalar una prótesis biológica, sin necesidad de anticoagular
- d) Instalar una prótesis biológica, y anticoagular con cumarínicos para alcanzar INR entre 3 y 4
- e) Instalar una prótesis biológica, y anticoagular con cumarínicos para alcanzar INR entre 2 y 3

71) La diarrea del viajero es causada principalmente por:

- a) Virus
- b) Escherichia coli
- c) Campylobacter jejuni
- d) Shiguella
- e) Amebas

72) Un paciente de 33 años presenta anhedonia y ánimo muy triste desde hace 6 meses, momento en que murió su madre, producto de un cáncer de mama. Presenta insomnio de despertar precoz y ha bajado 7 kilogramos de peso. Está convencida de que padece de alguna enfermedad que la matará pronto, como por ejemplo un cáncer. El examen físico es normal y se realizan exámenes generales que no demuestran patología orgánica, sin embargo ella insiste en que está muy enferma y que le queda poco de vida. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Distimia
- d) Depresión bipolar
- e) Depresión atípica

73) Una mujer embarazada acude a su control obstétrico de la semana 36 del embarazo, por FUR y ecografía del primer trimestre, constatándose una altura uterina menor a la esperada, por lo que se realiza una fetometría que determina un peso fetal, correspondiente al percentil 7. La relación entre el diámetro cefálico y abdominal es normal (menor a 1). El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia placentaria
- b) RCIU constitucional
- c) Síndrome de Down
- d) Infección congénita
- e) Embarazo normal de menor edad gestacional

74) Un paciente de 45 años hospitalizado por una neumonía ATS III, en tratamiento antibiótico endovenoso, con buena respuesta, presenta los siguientes electrolitos plasmáticos: sodio: 130 mEq/l; potasio: 4,4 mEq/l y cloro 98 mEq/l. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar el aporte de cloruro de sodio oral
- b) Administrar suero fisiológico endovenoso
- c) Disminuir el aporte de agua
- d) Administrar un diurético de asa
- e) Administrar suero hipertónico endovenoso

75) La dilatación ureteral durante el embarazo se debe a:

- a) la presión uterina sobre la vejiga
- b) la presión de las venas ováricas dilatadas
- c) la acción de la progesterona
- d) la acción de los estrógenos
- e) el aumento de la filtración glomerular

76) Una paciente de 55 años se realiza un perfil bioquímico como parte de los exámenes de rutina por control de su obesidad e hipertensión, la que trata con enalapril. En los resultados destaca una hipercalcemia de 11,4 mg/dl, con albuminemia de 4,1 g/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el enalapril e iniciar un diurético
- b) Solicitar densitometría ósea
- c) Solicitar niveles plasmáticos de hormona paratiroidea
- d) Solicitar calcio iónico y niveles plasmáticos de vitamina D
- e) Solicitar nueva calcemia en 30 días

77) ¿Cuál de los siguientes casos clínicos es más sugerente de una taquicardia paroxística supraventricular?

- a) Paciente de 23 años con taquicardia de inicio súbito a 150 lpm, regular, con QRS angosto y presencia de ondas de serrucho en DII y DIII
- b) Paciente de 35 años con palpitaciones de inicio súbito, caracterizadas por una taquicardia regular, con QRS angosto, a 190 lpm
- c) Un niño de 8 años, con taquicardia a 200 lpm, con QRS ancho y ausencia de onda P
- d) Mujer de 22 años, con taquicardia a 130 lpm, con QRS ancho y signos electrocardiográficos de bloqueo completo de rama derecha
- e) Mujer de 55 años con palpitaciones recurrentes, caracterizadas por una taquicardia a 143 lpm, con ritmo irregular y ausencia de onda P

78) ¿Cuál de las siguientes situaciones NO sería cubierta por las mutuales de seguridad?

- a) Mujer de 65 años, que trabaja en industria de loza, es diagnosticada de silicosis
- b) Profesor de educación media sufre un infarto al miocardio, mientras realizaba una de sus clases
- c) Chofer del Transantiago sufre un choque contra otro bus, resultando con una fractura nasal
- d) Secretaria sufre una caída a nivel, con fractura de cadera, mientras iba a su trabajo
- e) Manipuladora de alimentos sufre corte con cuchillo, mientras preparaba vegetales en su lugar de trabajo

79) Un lactante de 12 meses ha presentado 3 crisis bronquiales obstructivas en 4 meses, que han respondido al tratamiento con salbutamol. La primera de ellas fue en relación a una infección por VRS. Actualmente se encuentra en buenas condiciones y el examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar salbutamol si presenta nuevas crisis, sin necesidad de uso de corticoides
- b) Iniciar salbutamol de forma horaria, aumentando la frecuencia de las inhalaciones si presenta crisis
- c) Iniciar salmeterol inhalado según horario y corticoides inhalados a demanda
- d) Iniciar corticoides inhalados según horario y salbutamol a demanda
- e) Solicitar radiografía de tórax y test del sudor

80) Un niño de 10 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de malestar general y náuseas, evolucionando con dolor abdominal y vómitos en 4 oportunidades. Algunas horas, previo a la consulta, se agrega desorientación y luego sopor. Al examen físico se aprecia deshidratado, en Glasgow 13, con respiraciones profundas, su pulso es regular a 139 lpm y su presión arterial es 90/60. El resto del examen físico no aporta mayor información. La saturación de oxígeno por pulsometría es 98%. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar hidratación con sales de rehidratación, por vía oral
- b) Administrar 20 cc/Kg de suero fisiológico por vía periférica y reevaluar en 1 hora
- c) Solicitar hemoglucotest e instalar vía venosa periférica
- d) Administrar suero fisiológico e hidrocortisona por vía endovenosa y solicitar hemograma, electrolitos plasmáticos, glicemia y calcemia
- e) Solicitar hemograma, electrolitos plasmáticos, glicemia, calcemia y TAC de cerebro y decidir conducta según hallazgos

81) La leucemia más frecuente de los niños es:

- a) Linfática crónica
- b) Linfática aguda
- c) Mieloide crónica
- d) Mieloide aguda
- e) De células T

82) ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio permite deducir si una anemia se debe preferentemente a pérdida de sangre, destrucción de eritrocitos o disminución de su producción?

- a) Determinación de índices hematimétricos (VCM HCM CHCM)
- b) Características morfológicas del glóbulo rojo, al frotis.
- c) Determinación de reticulocitos
- d) Determinación seriada de niveles de Hto y Hb.
- e) Proporción de elementos eritroides en médula

83) ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de una crisis asmática?

- a) Adrenalina racémica nebulizada
- b) Salbutamol
- c) Salmeterol
- d) Budesonida
- e) Prednisona

84) Una paciente de 45 años consulta por un cuadro de dolor abdominal de 5 horas de evolución, periumbilical, constante e intenso, que luego se localizó en la fosa ilíaca derecha. Al examen físico se aprecia adolorido y a la palpación abdominal destaca resistencia muscular y signo de Blumberg mayor en la fosa ilíaca derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, PCR y hemocultivos
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Iniciar ceftriaxona más metronidazol por vía endovenosa y decidir conducta según respuesta
- e) Resolver quirúrgicamente

85) ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la preeclampsia es FALSO?:

- a) Excepto en el contexto de la enfermedad trofoblástica gestacional, no aparece antes de las 20 semanas.
- b) Debe sospecharse en la embarazada frente a tensiones arteriales diastólicas > 90 mmHg o sistólicas > 140 mmHg.
- c) Para su diagnóstico debe evaluarse la proteinuria.
- d) En un elevado porcentaje de casos deriva en un eclampsia.
- e) La paciente con una preeclampsia requiere una cuidadosa valoración del crecimiento fetal

86) Un paciente de 29 años acude a la consulta acompañado de su esposa. Ella refiere que cuando él consume alcohol se pone agresivo y celoso y en algunas ocasiones hace escándalos frente a los demás. El diagnóstico más probable

- a) Trastorno de personalidad límite
- b) Trastorno adaptativo
- c) Síndrome de abstinencia de alcohol
- d) Embriaguez patológica
- e) Dependencia a alcohol

87) Una mujer puérpera de 3 días, cuyo parto fue por vía vaginal, presenta dolor en el hipogastrio y en la pierna y muslo derechos, de rápida instalación. Al examen se observa aumento de volumen de la extremidad inferior derecha y dolor a la palpación de las masas musculares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y AINEs por vía oral
- b) Realizar legrado uterino bajo cobertura antibiótica endovenosa
- c) Realizar revisión instrumental del canal del parto
- d) Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores
- e) Administrar sulfato de magnesio

88) Una mujer de 24 años, consulta por artralgias de manos y fiebre ocasional. El examen físico no aporta mayor información y los exámenes de laboratorio arrojan linfopenia y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de la temporal
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Leucemia aguda
- d) Artritis viral
- e) Vasculitis de vaso pequeño

89) Paciente de 24 años, vendedor viajero, presenta desde hace una semana compromiso del estado general, anorexia y dolor leve en hipocondrio derecho, asociado a ictericia y coluria.

¿Cuál es el tipo de hepatitis más probable en este paciente?

- a) Alcohólica
- b) Por virus de Epstein Barr
- c) Por drogas
- d) Por virus A
- e) Por virus C

90) Respecto a la insuficiencia suprarrenal es FALSO que:

- a) La insuficiencia suprarrenal primaria suele deberse a causas autoinmunes
- b) La insuficiencia suprarrenal secundaria se asocia frecuentemente a alteraciones de otros ejes hormonales
- c) La insuficiencia suprarrenal secundaria no presenta hiperpigmentación cutánea
- d) La insuficiencia suprarrenal primaria requiere exclusivamente de suplementación con glucocorticoides
- e) La insuficiencia suprarrenal aguda se presenta con hipotensión que no responde al tratamiento con suero fisiológico

SEGUNDA PARTE

1) Una paciente de 69 años presenta alteraciones de la memoria, de varios años de evolución, asociado a alucinaciones visuales y algunas alteraciones motoras, consistentes en temblor de reposo y disminución del parpadeo y braceo. En las últimas semanas los síntomas se han intensificado. Al examen físico se encuentra atenta, sin signos neurológicos focales. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Delirium
- c) Demencia frontotemporal
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Hidrocefalia normotensiva

2) Paciente de 66 años, diabético e hipertenso bien controlado. Refiere visión de cuerpos volantes (midesopsias), fotopsias y disminución de la visión periférica en una zona del campo visual. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico estabilizado.
- b) Degeneración macular senil.
- c) Desprendimiento de retina.
- d) Retinopatía hipertensiva.
- e) Retinopatía diabética.

3) ¿Cuál de los siguientes hallazgos se considera patológico en un recién nacido de término?

- a) Eritema tóxico
- b) Bolsa serosanguínea
- c) Hipotonía
- d) Reflejos arcaicos
- e) Hernia umbilical

4) La esplenomegalia suele encontrarse en las siguientes patologías, EXCEPTO:

- a) Leucemia mieloide aguda
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Púrpura trombocitopénica inmune
- d) Daño hepático crónico
- e) Mielofibrosis

5) ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más eficaz para aumentar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca severa?

- a) Bloqueadores Beta.
- b) Digitálicos
- c) Diuréticos.
- d) Bloqueadores del calcio.
- e) Ácido acetilsalicílico

6) Un paciente hipertenso de 67 años, mal controlado, presenta un cuadro de instalación rápida de dificultad para caminar y vértigo. Al examen presenta temblor de intención, imposibilidad para realizar movimientos alternantes, nistagmo multidireccional y ataxia de la marcha. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto de bulbo raquídeo
- b) Parálisis vestibular
- c) Infarto de cuerpo estriado
- d) Hemorragia de la sustancia nigra
- e) Hemorragia cerebelosa

7) Una paciente de 58 años presenta síntomas de hipotiroidismo, asociados a un bocio difuso, de moderado tamaño. Se solicita TSH que resulta 50 mUI/litro y anticuerpos anti TPO que resultan positivos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar corticoides orales
- b) Iniciar levotiroxina
- c) Solicitar ecografía de tiroides
- d) Solicitar T4 y T3
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

8) La conducta más adecuada ante una paciente de 80 años, quien sufre una fractura de la cadera derecha, de tipo intertrocanterica y desplazada, es:

- a) Inmovilizar con yeso pelvipedio y administrar analgesia endovenosa
- b) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar inmovilización con yeso pelvipedio
- c) Iniciar analgesia y antibióticos endovenosos y luego realizar cirugía de resección de la cabeza femoral (Cirugía de Girdlestone))
- d) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar osteosíntesis con tornillo dinámico de cadera (DHS)
- e) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina e instalar prótesis parcial de cadera

9) ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia es responsable de los procesos inflamatorios pelvianos?

- a) Escherichia coli
- b) Chlamydia trachomatis
- c) Gardnerella vaginalis
- d) Streptococcus beta hemolítico grupo B
- e) Enterococo

10) Un paciente de 65 años, fumador, hipertenso y diabético, con tratamiento farmacológico que cumple irregularmente, acude a un chequeo médico, en el que se detecta la presencia de un soplo carotídeo derecho. No ha presentado síntomas neurológicos y el resto del examen físico no aporta mayor información. Se solicita un ecodoppler carotídeo que demuestra una estenosis carotídea derecha de 50% y estenosis carotídea izquierda de 35%. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar para endarterectomía carotídea
- b) Solicitar una angiografía carotídea y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro y decidir manejo según hallazgos
- d) Iniciar anticoagulación con cumarínicos y controlar sus factores de riesgo cardiovascular
- e) Mejorar el manejo de sus factores de riesgo cardiovascular, agregando aspirina

11) Una mujer de 44 años se divorcia hace 1 mes, luego de haber estado casada por 15 años. Evoluciona con irritabilidad y ánimo disfórico. En algunas ocasiones se siente ansiosa y mantiene la casa mucho más desordenada de lo habitual. Se reúne mucho menos con sus amigas. No ha tenido cambios en el peso ni en sus hábitos de sueño. El diagnóstico más adecuado es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Depresión mayor
- c) Reacción normal al estrés
- d) Trastorno por estrés postraumático
- e) Trastorno disociativo

12) Un paciente con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, presenta ascitis moderada. Actualmente ya no bebe y se descarta la presencia de peritonitis bacteriana espontánea, mediante paracentesis diagnóstica. El tratamiento de elección es:

- a) Restricción hidrosalina, hidroclorotiazida y iECAs
- b) Restricción hidrosalina y betabloqueadores no selectivos
- c) Restricción hidrosalina, espironolactona y furosemida
- d) Albúmina endovenosa
- e) Paracentesis evacuadoras periódicas

13) El agente etiológico más frecuente de la meningitis neonatal es:

- a) Neumococo
- b) Meningococo
- c) Haemophilus
- d) Estreptococo grupo B
- e) Enterovirus

14) Un paciente de 67 años, fumador importante, consulta por un cuadro de disnea y tos con expectoración mucosa, asociada a baja de peso de 5 kilogramos en 2 meses. Al examen físico destaca hipocratismo digital y el examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) EPOC
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Tuberculosis
- d) Cáncer pulmonar
- e) bronquiectasias

15) Un mujer, multipara de 2, con ambos partos por vía vaginal, está cursando un tercer embarazo, en la semana 37 + 3 días. Inicia trabajo de parto, que se extiende por varias horas. Al examen físico presenta 3 contracciones en 10 minutos y el tacto vaginal muestra dilatación completa, con la cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en presentación de frente, naso-iliaca anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar prueba de parto, con aceleración oxitócica y rotura artificial de membranas
- b) Girar la cabeza hata posición naso-sacra
- c) Girar la cabeza hasta posición naso-púbica
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

16) Paciente de 68 años, hipertenso en tratamiento, presenta pérdida de fuerzas del hemicuerpo izquierdo, que llega al máximo en el curso de tres horas, instalándose una hemiplejía con hemianestesia izquierda y obnubilación de la conciencia. Una tomografía axial computada cerebral a las cuatro horas de evolución resulta normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Crisis isquémica transitoria.
- b) Infarto cerebral.
- c) Infarto cerebeloso
- d) Hemorragia subaracnoidea espontánea
- e) Hematoma subdural isodenso

17) Un niño de 8 años consulta por un cuadro de malestar general, fiebre, eritema facial y luego aparición de un exantema eritematoso, macular, reticulado en las extremidades y el tronco. Al examen físico destaca el eritema en ambas mejillas y el exantema descrito. El diagnóstico más probable es:

- a) Escarlatina
- b) Eritema infeccioso
- c) Exantema súbito
- d) Rubeola
- e) Sarampión

18) Un paciente de 21 años es traído por su madre, quien está preocupada porque no tiene amigos y se relaciona poco con otras personas. Él parece indiferente y refiere que no le interesan los amigos y que vive feliz con lo que tiene. También es indiferente a las críticas y halagos. No presenta síntomas anímicos y el examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Fobia social
- c) Autismo
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno de personalidad

19) Una niña de 3 años presenta una infección urinaria baja por E. coli multisensible. Se inicia tratamiento con cefadroxilo por 5 días, con buena respuesta clínica y negativización del urocultivo de control. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar urocultivos mensuales hasta los 5 años de edad
- b) Solicitar ecografía renal y vesical y uretrocistografía miccional
- c) Solicitar cistoscopia y cintigrafía renal
- d) Dejar profilaxis antibiótica con cefadroxilo hasta los 5 años de edad
- e) Observar evolución sin necesidad de mayor estudio

20) Un hombre de 31 años de edad consulta por la presencia de una masa palpable en el teste derecho, de un mes de evolución, no dolorosa. Su urólogo le realiza una ecografía testicular, en la que se evidencia una lesión hipoeogénica, bien delimitada, intratesticular. Los marcadores tumorales alfafetoproteína y beta HCG son negativos. La actitud más correcta de entre las siguientes sería:

- a) Dado que los marcadores tumorales son negativos, se descarta neoplasia testicular y requiere observación.
- b) Realizar tumorectomía transescrotal y realizar estudio histológico
- c) Realización de una tomografía axial computadorizada tóraco-abdomino-pélvica.
- d) Biopsia transescrotal del testículo.
- e) Orquiectomía radical y esperar resultado del patólogo.

21) Una paciente de 42 años se realiza un Papanicolaou que es informado como “presencia de células epiteliales con atipias de alto grado”. Se deriva a colposcopia, que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo PAP en un año
- b) Realizar nuevo PAP en un mes
- c) Realizar controles con colposcopia cada 6 meses
- d) Realizar biopsias en los cuatro cuadrantes del exocervix
- e) Realizar cono cervical y enviar la muestra a estudio anatomopatológico

22) En la pancreatitis aguda, en caso de duda diagnóstica por su presentación clínica atípica, con una situación clínica de gravedad, donde el dolor abdominal no es característico o el aumento de amilasa o lipasa sérica ha constituido un hallazgo inesperado, ¿qué prueba diagnóstica es la indicada en primer lugar para confirmar o no este diagnóstico?:

- a) Ecografía abdominal.
- b) Radiografías simples de abdomen, antero posterior y lateral.
- c) Tomografía axial computarizada abdominal.
- d) Colangiopacreatografía retrógrada endoscópica.
- e) Resonancia nuclear magnética.

23) El fármaco antihipertensivo de elección para un diabético es:

- a) Hidroclorotiazida
- b) Nitrendipino
- c) Hidralazina
- d) Atenolol
- e) Enalapril

24) El mejor indicador de la fuerza de asociación entre un factor de riesgo, como el alcohol, y una patología, como la cirrosis hepática, es:

- a) Riesgo atribuible
- b) Riesgo atribuible porcentual
- c) Incidencia acumulada en los expuestos
- d) Prevalencia en los expuestos
- e) Riesgo relativo

25) Un niño de 6 años consulta por odinofagia y fiebre hasta 38,4°C, asociado a tos seca y disfonía. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y destaca la faringe eritematosa, sin exudado, se palpan varias adenopatías cervicales pequeñas, bilaterales y el resto del examen físico es normal. Se solicita un hemograma que demuestra hematocrito: 43%, hemoglobina: 15,5 g/l, VCM: 90, blancos: 13.500, segmentados: 34%, baciliformes: 3%, linfocitos: 60%, monocitos: 3%. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección respiratoria alta
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Linfoma
- d) Leucemia linfática aguda
- e) Leucemia linfática crónica

26) La incidencia acumulada de una enfermedad es:

- a) La proporción de la población que padece la enfermedad en un momento dado.
- b) La proporción de sanos que contraen la enfermedad a lo largo de cierto período.
- c) La tasa de incidencia de la enfermedad.
- d) Una razón entre la odds de exposición de los casos y la odds de exposición de los controles.
- e) Muy útil en los estudios de estimación de las necesidades asistenciales.

27) Un paciente de 45 años se entierra una astilla en la mano derecha, evolucionando a los pocos días con dolor, aumento de volumen y eritema. Al examen se observa decaído, subfebril hasta 37,4°C, con aumento de volumen de la mano derecha, asociado a eritema cutáneo que se extiende hasta la muñeca, que es ligeramente doloroso y cuyos bordes son difíciles de definir. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- b) Hospitalizar e iniciar cloxacilina endovenosa
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Enviar a domicilio con amoxicilina + ácido clavulánico
- e) Administrar penicilina benzatina intramuscular, en una dosis de 2.400.000 UI

28) Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta y come con más sal de la prescrita, el resultado analítico esperable es:

- a) Mayor hipernatremia.
- b) Mayor hiponatremia.
- c) Mayor hiperpotasemia.
- d) Mayor hipopotasemia.
- e) Mayor acidosis.

29) Un paciente de 30 años, asintomático, presenta un quiste renal de 7 centímetros en una ecografía abdominal realizada como parte de estudio de patología biliar. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Realizar punción y biopsia
- d) Realizar marsupialización del quiste
- e) Realizar nefrectomía total

30) ¿Qué cardiopatía es más compatible con un lactante con cianosis persistente, que no responde a oxígeno al 100% y que se acompaña de un soplo sistólico?

- a) Ductus arterioso persistente
- b) Tetralogía de Fallot
- c) Coartación aórtica
- d) Comunicación interauricular
- e) Comunicación interventricular

31) Un paciente de 45 años presenta dolor lumbar intenso, de inicio súbito, que apareció luego de levantar unas cajas y que se irradia por la cara anterolateral del muslo y la cara medial de la pierna hasta el maléolo interno. Al examen se aprecia disminución del reflejo rotuliano ipsilateral al dolor. La raíz comprometida es:

- a) L2
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

32) Un paciente de 65 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, en tratamiento irregular con omeprazol, consulta por exacerbación importante de los síntomas, que incluso lo despiertan por la noche, a pesar de haber aumentado la dosis de omeprazol a 40 mg/día. El examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el omeprazol y agregar un bloqueador H2
- b) Solicitar manometría esofágica
- c) Realizar tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori*
- d) Solicitar pHmetría de 24 horas
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

33) Un paciente con un quiste hidatídico hepático de gran tamaño se somete a cirugía resectiva. Durante la cirugía es muy importante que el quiste no se rompa debido a que esto suele producir:

- a) Sobreinfección bacteriana
- b) Siembras hidatídicas a distancia
- c) Insuficiencia hepática
- d) Shock anafiláctico
- e) Hemorragias graves

34) Paciente joven, sin patología previa ni adicciones. Luego de un problema familiar grave, presenta bruscamente un episodio psicótico de 2 días, con incoherencias, ideas delirantes y alucinaciones. Sin antecedentes psiquiátricos personales ni familiares. Al término del episodio no se aprecia psicopatología mayor, sólo preocupación importante por lo sufrido, ya que no se lo explica fácilmente.

Se trata de un paciente con:

- a) psicosis esquizomorfa con pronóstico reservado
- b) un episodio psicótico breve que hay que observar ya que es probable que se trate de un trastorno delirante somático de pronóstico incierto
- c) psicosis reactiva breve de mal pronóstico, ya que ha presentado alteración del pensamiento en su contenido y en su forma
- d) psicosis reactiva breve de buen pronóstico
- e) un episodio psicótico alucinatorio delirante que debe ser controlado por tiempo prolongado

35) Un paciente de 66 años presenta disminución de la sensibilidad de ambos pies, especialmente la sensibilidad relacionada con la temperatura y la sensibilidad vibratoria. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Polineuropatía
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Mielitis transversa
- e) Síndrome de Guillain Barre

36) Un paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca, secundaria a cardiopatía coronaria y fibrilación auricular, evoluciona con empeoramiento de su estado basal, presentando disnea de reposo y desorientación. Al examen se observa pálido, sudoroso, con frialdad de los dedos. Se inicia estudio y soporte ventilatorio y hemodinámico con mejoría parcial. Entre sus exámenes destaca una creatininemia de 2,2 mg/dl. La causa más probable de esta alteración es:

- a) Prerenal
- b) Infarto renal
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Rabdomiolisis
- e) Acidosis láctica

37) La gastroscopia (EDA) es una prueba diagnóstica fundamental para el estudio del paciente con hemorragia digestiva, y la urgencia en la realización de la misma dependerá de la magnitud de la hemorragia digestiva. ¿Podría señalar cuál de las siguientes situaciones NO expresa una mayor magnitud y por tanto gravedad de la hemorragia?:

- a) Hipotensión y taquicardia.
- b) Disminución del hematocrito y hemoglobina,
- c) Pacientes que requieren transfusión para mantener la estabilidad hemodinámica.
- d) Lavado gástrico por sonda nasogástrica con abundante sangre roja, que no se aclara tras lavados repetidos con abundante volumen.
- e) Repetidos y frecuentes episodios de hematemesis con sangre roja y melenas.

38) Una paciente presenta hipertiroidismo, con TSH menor a 0,03 mUI/L, asociado a bocio de moderado tamaño, con frémito. Presenta además retracción palpebral bilateral y exoftalmo, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Hashimoto
- b) Enfermedad de Basedow-Graves
- c) Tiroiditis subaguda
- d) Bocio multinodular tóxico
- e) Adenoma tóxico

39) Hombre de 65 años, portador de enfisema pulmonar tabáquico. Ingresa con historia de tres días de aumento de su expectoración habitual y fiebre. Es traído en ambulancia donde recibe O₂, 6 lt / min. Durante el trayecto, presenta compromiso de conciencia.

La causa más probable de esta alteración de conciencia es:

- a) hipoxia grave.
- b) hipercapnia grave.
- c) neumotórax.
- d) shock séptico.
- e) meningoencefalitis

40) Un niño de 7 años presenta un cuadro de edema palpebral y hematuria en una ocasión. Al examen físico está hipertenso, con edema facial, escrotal y de extremidades inferiores. El sedimento de orina demuestra hematuria con 11% de dismorfia. Al interrogar a la madre, refiere que el niño habría sufrido una faringitis hace un par de semanas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Berger
- b) Nefrosis lipoídea
- c) Glomerulonefritis mesangiocapilar
- d) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- e) Síndrome hemolítico urémico

41) La otitis media aguda no suele complicarse. No obstante, cuando lo hace, es con más frecuencia con una:

- a) Petrooitis.
- b) Meningitis.
- c) Mastoiditis.
- d) Sordera súbita.
- e) Osteomielitis.

42) ¿Cuál de las siguientes alternativas es un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer endometrial?

- a) Diabetes mellitus
- b) Infección por virus papiloma
- c) Uso de anticonceptivos orales
- d) Uso de dispositivo intrauterino
- e) Multiparidad

43) Un niño de 10 años es de los más bajos del curso. Su padre mide 1,81 m y su madre mide 1,71 m. Se revisa su curva de crecimiento que lo sitúa en el percentil 10 de la curva talla/edad, con velocidad de crecimiento normal y la edad ósea es equivalente a 8,5 años. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Klinefelter
- b) Talla baja familiar
- c) Déficit de GH
- d) Retraso constitucional del crecimiento
- e) Enfermedad celíaca

44) Preescolar de 3 años presenta fiebre de cinco días de evolución, asociado a odinofagia intensa y decaimiento. Al examen destaca temperatura axilar de 39°C, faringe intensamente congestiva con placas blanquecinas en las amígdalas, adenopatías grandes y sensibles en ambas cadenas yugulares, edema palpebral leve y hepatomegalia sensible a 3 cm bajo el reborde costal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Leucemia linfoblástica aguda
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Herpangina
- d) Faringoamigdalitis estreptocócica
- e) Faringoamigdalitis por adenovirus

45) Una paciente de 24 años, asintomática, cursando un embarazo de 6 semanas de amenorrea se realiza una ecografía transvaginal que no observa gestación intrauterina. Se solicita beta-HCG plasmática que resulta 500 mU/ml. A los 2 días se repite la ecografía transvaginal, que tampoco observa gestación intrauterina y se solicita una nueva beta-HCG que resulta 1.050 mU/ml. Con alta probabilidad se trata de:

- a) Un embarazo normal, de menor edad gestacional
- b) Un aborto completo
- c) Un embarazo molar
- d) Un embarazo ectópico
- e) Un huevo anembrionado

46) Una paciente de 20 años, consulta por dolor perianal, de 2 días de evolución que aumenta al sentarse. Al examen se observa aumento de volumen en la zona perianal derecha, eritematoso, fluctuante y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar analgésicos orales, baños de asiento y un laxante
- b) Realizar trombectomía y administrar AINEs
- c) Puncionar con jeringa e iniciar tratamiento antibiótico oral
- d) Enviar a domicilio bajo tratamiento antibiótico oral
- e) Realizar drenaje quirúrgico e iniciar analgésicos orales

47) La presentación más habitual de la intoxicación por benzodiacepinas es:

- a) Compromiso de conciencia convulsiones y midriasis
- b) Compromiso de conciencia, depresión respiratoria y pupilas normales
- c) Compromiso de conciencia, hipotensión, depresión respiratoria y miosis
- d) Compromiso de conciencia, depresión respiratoria y convulsiones
- e) Compromiso de conciencia, hipotensión, depresión respiratoria y midriasis

48) Una paciente presenta un tumor que comprime el tallo hipofisiario. ¿Qué alteración NO esperaría encontrar?

- a) Niveles bajos de prolactina
- b) Síntomas de hipotiroidismo
- c) Niveles bajos de cortisol
- d) Poliuria
- e) Amenorrea

49) ¿A las cuántas semanas de atraso menstrual se ve por primera vez el saco gestacional en una ecografía transvaginal?

- a) 3
- b) 5
- c) 7
- d) 9
- e) 11

50) Una niña de 9 meses se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas, momento en que empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente con un estado visible de dolor. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. En la consulta emite una deposición de color rojo oscuro. El abdomen está distendido y con dolor discreto a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis pilórica.
- b) Apendicitis.
- c) Infección urinaria.
- d) Invaginación.
- e) Enfermedad ulcerosa péptica.

51) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS probable de encontrar en una paciente con síndrome de ovario poliquístico?

- a) Testosterona alta
- b) Progesterona alta
- c) Resistencia insulínica
- d) Menstruaciones irregulares
- e) Acné

52) Un paciente sufre quemadura facial durante un incendio. Al examen físico se aprecia eritema importante en la cara, con algunas pequeñas flictenas y con las cejas y pestañas quemadas. Presenta además una quemadura en el antebrazo derecho, de 4 cm de diámetro. ¿A qué complicación hay que poner especial atención en este paciente?

- a) Infección de la quemadura de la cara
- b) Quemaduras corneales
- c) Síndrome compartimental facial
- d) Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
- e) Quemadura de la vía aérea

53) Una paciente de 44 años consulta por exoftalmo y diplopía de instalación progresiva en las últimas 2 semanas. Al examen se observa proptosis leve bilateral, mayor a derecha, con retracción palpebral bilateral y signo de Graefe positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pseudotumor orbitario
- b) Enfermedad de Basedow-Graves
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Celulitis orbitaria
- e) Exoftalmo paraneoplásico

54) Un hombre de 75 años, consulta por dolor lumbar irradiado a ambas piernas y claudicación de la marcha, que le obliga a sentarse, con lo que cede. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia del núcleo pulposo
- b) Espondilitis anquilosante
- c) Lumbago tumoral
- d) Espondilolistesis
- e) Raquiostenosis

55) En un país de 15.000.000 de habitantes, del los cuales un 50% es de sexo femenino, se producen 750.000 muertes, de las que 1.500 son producidas por cáncer de próstata. La tasa de mortalidad por cáncer de próstata es:

- a) 2 / 100.000 habitantes
- b) 10 / 100.000 habitantes
- c) 20 / 100.000 habitantes
- d) 100 / 100.000 habitantes
- e) 200 / 100.000 habitantes

56) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un paciente con clínica y radiografías sugerentes de neumonía, con presencia de un exudado pleural de predominio polimorfonuclear con pH: 7,11 y lactato de 8 mMol/ml?

- a) Solicitar ADA y decidir manejo según resultado
- b) Tratar de extraer el máximo posible de líquido pleural a través de la toracocentesis
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Instalar un tubo pleural (toracostomía)
- e) Realizar videotoracoscopia

57) La conducta más adecuada ante un paciente diagnosticado de neumonía ATS 1, que no responde al tratamiento con amoxicilina oral, luego de 72 horas, es:

- a) Mantener el tratamiento con amoxicilina y reevaluar en 24 horas
- b) Iniciar tratamiento con amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax
- d) Solicitar cultivo de expectoración con antibiograma
- e) Iniciar tratamiento con moxifloxacino oral

58) Una paciente de 67 años, fumadora de 25 paquetes año, consulta por disfonía de 4 semanas de evolución, asociada a tos irritativa ocasional. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar suspensión del tabaco e iniciar AINEs y antibióticos
- b) Solicitar una radiografía de tórax
- c) Solicitar una tomografía axial computada de cuello
- d) Indicar suspensión del tabaco y reevaluar en 4 semanas
- e) Solicitar una nasofibroscopia

59) ¿Qué vacuna NO se administra a los 2 meses de edad, según el plan nacional de inmunizaciones?

- a) Polio oral
- b) Hepatitis B
- c) BCG
- d) Haemophilus influenza B
- e) DPT

60) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto del delirium, o síndrome confusional:

- a) Una característica clínica importante es la presencia de creencias falsas, irreductibles a la argumentación lógica y que no guardan relación con el entorno cultural del paciente.
- b) Su principal característica clínica es la alteración de la conciencia.
- c) Suele asociarse a alteraciones globales de las funciones cognitivas.
- d) Se acompaña a menudo de alteraciones del humor, la percepción y el comportamiento.
- e) No es infrecuente la presencia de temblor, asterixis, nistagmo, falta de coordinación motora e incontinencia urinaria.

61) Un recién nacido de 35 semanas de gestación, presenta ictericia hasta los muslos a las 10 horas de vida. No presenta otros síntomas y se observa en buen estado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubina total y directa y decidir manejo según hallazgos
- b) Realizar exangineotransfusión y fototerapia de inmediato
- c) Iniciar fototerapia sola y asegurar una adecuada hidratación y alimentación
- d) Solicitar bilirrubina plasmática, hemograma, prueba de Coombs directo, grupo-Rh y hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Observar evolución por 24 horas, asegurando una adecuada alimentación e hidratación, sin necesidad de mayor estudio

62) Un paciente de 18 años consulta por dolor torácico, retroesternal, intenso, de 12 horas de evolución, que aumenta con inspiración. Los signos vitales y el examen cardiovascular son normales. Se solicita radiografía de tórax que no presenta hallazgos patológicos. Se solicita electrocardiograma que demuestra elevación del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Costocondritis
- c) Pericarditis aguda
- d) Neumotórax espontáneo
- e) Taponamiento cardíaco

63) Un joven de 18 años presenta placas eritematosas, descamativas, de color rosado, con escamas amarillentas en la piel cercana a las cejas y la zona interiliar, desde hace varios meses, con períodos de mayor y menor actividad. Las lesiones no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Lupus discoide
- d) Liquen simple
- e) Dermatitis seborreica

64) ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocia a un mayor riesgo de caídas en un paciente anciano?

- a) Hidroclorotiazida
- b) Metformina
- c) Ampicilina
- d) Atorvastatina
- e) Ácido acetilsalicílico

65) ¿Cuál es la medida terapéutica inicial más adecuada para un niño de 3 años, constipado crónico, que no ha defecado en seis días?

- a) Laxante por vía oral
- b) Enema evacuante
- c) Incrementar el consumo de frutas y verduras
- d) Lubricante intestinal por vía oral
- e) Aumentar la ingesta de líquidos

66) ¿Cuál de las siguientes patologías NO tiene opción de parto vaginal?

- a) Placenta previa
- b) Desprendimiento de placenta
- c) Eclamsia
- d) Corioamnionitis
- e) Condiloma acuminado

67) La cianosis central sólo se debe a:

- a) Aumento del volumen minuto cardíaco.
- b) Aumento de la masa eritrocitaria.
- c) Aumento del valor hematocrito.
- d) Aumento de la hemoglobina reducida.
- e) Aumento de la carboxihemoglobina.

68) Una paciente hospitalizada por pielonefritis aguda, en tratamiento con ceftriaxona endovenosa, se realiza 3 hemocultivos, uno de los cuales resulta positivo para estafilococo áureo sensible. La paciente se encuentra en buenas condiciones generales y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Endocarditis bacteriana
- b) Sepsis asociada a dispositivo intravascular
- c) Osteomielitis aguda
- d) Pielonefritis estafilocócica
- e) Contaminación de la muestra

69) Un paciente presenta un síndrome alucinatorio crónico, con alucinaciones auditivas, asociado a un delirio paranoide que involucra a su familia y al gobierno. Presenta además una marcada apatía. El tratamiento de elección del cuadro descrito es:

- a) Fluoxetina
- b) Alprazolam
- c) Litio
- d) Haloperidol
- e) Clozapina

70) Una paciente de 49 años, presenta elevación persistente de las transaminasas, con valores cercanos a 120 mU/ml, con bilirrubina, GGT y fosfatasa alcalina normales. Refiere que toma una copa de vino con el almuerzo y que nunca se emborracha. Se solicitan exámenes que demuestran ANA(-), ANCA(-), ASMA(-), VHBsAc(-), VHBsAg(+), IgM anticore(-), VHC-Ac(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Hepatopatía por consumo de alcohol
- c) Esteatohepatitis no alcohólica
- d) Hepatitis B crónica
- e) Hepatitis B aguda, sobre hepatopatía crónica

71) Un paciente diagnosticado de rosácea consulta por ojo rojo, indoloro. Al examen físico se observa eritema de los párpados superiores, con fina descamación, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Chalazión
- b) Blefaritis
- c) Orzuelo
- d) Dacriocistitis
- e) Queratitis

72) Una niña de 10 años de edad acude para valoración de un posible hipocrecimiento. Su talla actual se encuentra en el percentil 10 de la población general. Su talla genética está situada en el percentil 15 de la población de referencia. Su desarrollo sexual corresponde a una pubarquia 1 y a una telarquia 1 de Tanner. Su edad ósea es de 9 años. La velocidad de crecimiento del último año ha sido de 5 centímetros/año. ¿Qué situación cree usted que presenta la niña?:

- a) Un crecimiento normal.
- b) Un hipocrecimiento por deficiencia de la hormona del crecimiento.
- c) Un hipocrecimiento por una enfermedad celíaca.
- d) Un hipocrecimiento por un síndrome de Turner.
- e) Un hipocrecimiento por un hipotiroidismo congénito.

73) Una paciente de 67 años consulta por astenia de algunas semanas de evolución. Se realizan exámenes generales en donde destaca un hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 8,3 g/dl, VCM: 81, HCM: 29, blancos: 8.900, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 440.000. El índice de reticulocitos está disminuido. Se solicita perfil de hierro que demuestra ferremia disminuida, transferrina disminuida, ferritina elevada y saturación de la transferrina normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Ferropenia
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Mielodisplasia
- d) Déficit de vitamina B12
- e) Anemia hemolítica

74) La principal utilidad del test cutáneo en la rinitis alérgica es que permite:

- a) Confirmar el diagnóstico en los pacientes con cuadro clínico clásico de rinitis alérgica
- b) Identificar el alérgeno causante de los síntomas, a modo de evitarlo
- c) Decidir el fármaco a utilizar como primera línea de tratamiento
- d) Identificar otras patologías alérgicas concomitantes, como el asma y la urticaria
- e) No tiene utilidad en la rinitis alérgica

75) Una paciente de 25 años presenta cefalea de algunos meses de duración, de carácter opresivo, pulsátil, frontoparietal, intensa, que en algunas ocasiones se ve precedida por visión de puntos brillantes. Se presenta especialmente cuando duerme poco y durante las crisis se exagera con la luz y los ruidos. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cefalea tensional
- b) Migraña
- c) Cluster
- d) Tumor cerebral
- e) Aneurisma cerebral sintomático

76) Paciente asmático que consulta por episodios de tos, sensación de pecho apretado y disnea nocturna, situación que lo obliga a usar Beta 2 agonista más de 4 veces al día.

¿Cuál es la recomendación terapéutica más adecuada?

- a) Aumentar la dosis del Beta 2 agonista
- b) Agregar Beta 2 agonista de acción prolongada
- c) Agregar corticoide inhalatorio
- d) Agregar teofilina
- e) Agregar antihistamínico

77) Un niño de 9 años de edad presenta desde los primeros años de vida, tendencia a la epistaxis y gingivorragia. También presenta petequias y equimosis recurrentes. El examen físico no aporta más información. El examen que con mayor probabilidad se encontrará alterado es:

- a) Recuento de plaquetas
- b) Tiempo de protrombina
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada
- d) Tiempo de sangría
- e) Fibrinogenemia

78) El tratamiento de elección de la incontinencia urinaria de urgencia, en la que las medidas generales y los ejercicios pélvicos son insuficientes, es:

- a) Diuréticos tiazídicos
- b) Anticolinérgicos
- c) Vaginoplastia anterior
- d) Cinta vaginal sin tensión (TVT)
- e) Restricción hidrosalina

79) La conducta más adecuada frente a un niño asintomático, con pie plano, cuyo arco plantar aparece al hiperextender el primer ортеjo, es:

- a) Observar
- b) Indicar uso de plantillas
- c) Indicar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura plantar
- d) Solicitar TAC de pie
- e) Resolver quirúrgicamente

80) Mujer de 38 años, puérpera hace 6 meses. Durante el parto presentó importante hemorragia, secundaria a inercia uterina. Desde el comienzo presentó agalactia, por lo que debió alimentar exclusivamente con fórmula a su hijo. A pesar de lo anterior, persiste en amenorrea y se ha agregado astenia y adinamia importante. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Sheehan
- b) Apoplejía apofisiaria
- c) Tiroiditis postparto
- d) Hiperprolactinemia
- e) Hipogonadismo hipergonadotrófico

81) Respecto al lupus eritematoso sistémico es verdadero que:

- a) Los anticuerpos anti-DNA de dos hebras no guardan relación con la actividad lúpica
- b) Los anticuerpos antinucleares son muy sensibles para el diagnóstico
- c) El complemento suele elevarse durante los brotes de actividad
- d) Los anticuerpos anti-RNP y anti-proteína P son característicos del lupus secundario a medicamentos
- e) Los anticuerpos anti-DNA de una hebra son muy específicos para lupus

82) Una paciente de 25 años consulta por dolor en fosa iliaca derecha, de inicio súbito, irradiado al labio mayor derecho y asociado a vómitos. Al examen físico el paciente se observa adolorida y cambia frecuentemente de posición. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar antiespasmódicos y enviar a domicilio
- b) Indicar reposo, AINEs y ejercicios de fortalecimiento de la musculatura lumbar, una vez que haya cedido el dolor
- c) Iniciar analgésicos endovenosos y solicitar un TAC de abdomen y pelvis sin contraste
- d) Solicitar urocultivo e iniciar analgésicos y antibióticos orales
- e) Solicitar radiografía de abdomen simple e iniciar AINEs por vía oral

83) Usted desea establecer la relación entre el hábito de fumar y la aparición de hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué diseño de estudio permitiría obtener una mejor información, desde el punto de vista estadístico y ético?

- a) Transversal
- b) Casos y controles
- c) Cohortes
- d) Ensayo clínico
- e) Ecológico

84) Un paciente de 32 años sufre una caída de altura, con golpe en el tórax y heridas penetrantes torácicas, evolucionando con taquicardia, hipotensión marcada y luego compromiso de conciencia. Al examen físico se observa pálido, frío y sudoroso, con yugulares planas, tórax simétrico y algunas heridas en el hemitórax izquierdo. La auscultación cardíaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos y la auscultación pulmonar resulta normal. Ingresa a pabellón, donde se monitoriza invasivamente con un catéter de Swan-Ganz, que muestra presión venosa central y presión de enclavamiento pulmonar muy bajas, con resistencias vasculares sistémicas muy aumentadas. La causa más probable de la hipotensión es:

- a) Cardiogénica
- b) Hipovolemia
- c) Vasodilatación
- d) Hipoxia
- e) Shock medular

85) Se seleccionan 300 pacientes con hipercolesterolemia y se aleatorizan a 3 grupos de 100 pacientes cada uno. El primer grupo recibe atorvastatina, el segundo grupo recibe gemfibrozilo y el tercero recibe una asociación entre gemfibrozilo y atorvastatina. Se comparan los niveles de colesterol luego de 3 meses de tratamiento. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) La "t" de Student
- b) Chi cuadrado
- c) La "r" de Pearson
- d) Prueba exacta de Fisher
- e) Análisis de varianza

86) Una paciente de 40 años, cursando embarazo de 33 semanas, multípara de 3, doble cesarizada anterior, presenta rotura de membranas, iniciando trabajo de parto espontáneo a la hora después. Al examen presenta 2 contracciones en 10 minutos y tiene 2 cm de dilatación cervical, con un borramiento de 80%. El registro basal no estresante resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos y dejar evolución espontánea
- b) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Realizar cesárea
- d) Administrar misoprostol por vía vaginal
- e) Administrar corticoides, antibióticos y tocolíticos, manteniendo una conducta expectante

87) ¿Cuál es la edad más temprana a la que la mayor parte de los niños son capaces de comprender que la muerte es permanente?:

- a) 0 a 2 años.
- b) 3 a 4 años.
- c) 5 a 10 años.
- d) 11 a 14 años.
- e) 15 a 18 años.

88) Un paciente de 17 años presenta un cuadro de tos con expectoración, rinorrea y disfonía de 3 semanas de duración. En los últimos 7 días ha ido empeorando, agregándose fiebre hasta 38,7°C y disnea de esfuerzos. Al examen físico se auscultan algunos crépitos y sibilancias en ambas bases. La radiografía de tórax demuestra imágenes de relleno alveolointersticial y de engrosamiento peribronquial en las bases. El agente etiológico más probable es:

- a) Mycoplasma
- b) Neumococo
- c) Virus respiratorio sincicial
- d) Virus Influenza
- e) Bordetella

89) Una paciente de 33 años presenció como un perro atacaba y mataba brutalmente a otro, lo que le causó mucha impresión. Algunas semanas después comienza con pesadillas del suceso y en algunas ocasiones también recuerdos vívidos, mientras está despierta. Ha presentado 2 crisis de pánico, una de ellas al ver un perro similar al que murió. Por eso evita cualquier encuentro con perros. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno agudo por estrés
- b) Fobia específica
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno de pánico

90) ¿Cuál de las siguientes opciones tiene menos importancia en el pronóstico de una pancreatitis aguda?

- a) Elevación marcada de las transaminasas
- b) Disminución importante del hematocrito
- c) Hipoxemia
- d) Elevación marcada de la lipasa
- e) Acidosis

Respuestas:

Primera parte

1	A	31	B	61	B
2	E	32	D	62	B
3	D	33	E	63	C
4	C	34	E	64	C
5	D	35	B	65	D
6	D	36	C	66	C
7	B	37	D	67	A
8	C	38	C	68	C
9	E	39	D	69	D
10	C	40	E	70	B
11	A	41	D	71	B
12	D	42	C	72	A
13	A	43	C	73	B
14	B	44	D	74	C
15	D	45	A	75	C
16	D	46	D	76	C
17	C	47	B	77	B
18	D	48	A	78	B
19	D	49	C	79	D
20	C	50	A	80	C
21	D	51	D	81	B
22	D	52	E	82	C
23	D	53	E	83	B
24	B	54	C	84	E
25	C	55	E	85	D
26	C	56	E	86	D

27	D	57	C	87	D
28	D	58	D	88	B
29	A	59	B	89	D
30	B	60	A	90	D

Segunda parte

1	D	31	B	61	D
2	C	32	E	62	C
3	C	33	D	63	E
4	C	34	D	64	A
5	A	35	A	65	B
6	E	36	A	66	A
7	B	37	B	67	D
8	D	38	B	68	E
9	B	39	B	69	E
10	E	40	D	70	D
11	A	41	C	71	B
12	C	42	A	72	A
13	D	43	D	73	B
14	D	44	B	74	B
15	E	45	A	75	B
16	B	46	E	76	C
17	B	47	B	77	D
18	E	48	A	78	B
19	B	49	B	79	A
20	E	50	D	80	A
21	E	51	B	81	B
22	C	52	E	82	C
23	E	53	B	83	C
24	E	54	E	84	B
25	A	55	C	85	E

26	B	56	D	86	C
27	B	57	C	87	C
28	D	58	E	88	A
29	A	59	C	89	C
30	B	60	A	90	D

Ensayo EUNACOM – Prueba 3

PRIMERA PARTE

1) ¿Cuál es la medida más importante para prevenir la insuficiencia renal aguda secundaria al uso de medio de contraste, durante una tomografía?

- a) N-acetyl cisteína
- b) Suero fisiológico
- c) Bicarbonato
- d) Diltiazem
- e) Ácido ascórbico

2) Una paciente de 22 años consulta porque en las últimas 2 semanas ha presentado pujo y tenesmo rectal, asociado a deposiciones diarreicas, con moco y sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis pseudomembranosa
- b) Colitis ulcerosa
- c) Colitis por Shiguella
- d) Cáncer de colon
- e) Colitis isquémica

3) Una mujer consulta por leucorrea de mal olor, que en la especuloscopia se aprecia de color grisáceo, espumosa y cuyo pH es 5,5. El agente etiológico más probable es:

- a) Candida albicans
- b) Escherichia coli
- c) Gardnerella vaginalis
- d) Trichomona vaginalis
- e) Chlamydia trachomatis

4) Un niño de 3 años presenta de manera brusca un episodio de agitación, llevándose las manos al cuello. No llora, tose ni habla. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar compresiones cardíacas
- b) Dar golpes interescapulares
- c) Realizar maniobra de Heimlich
- d) Tomarlo de los pies y sacudirlo
- e) Dar insuflaciones boca a boca

5) Un recién nacido de término, nacido por cesárea inicia taquipnea y quejido, luego de 20 minutos de nacer. Al examen físico se ausculta disminución del murmullo pulmonar en las bases, sin otros ruidos y la auscultación cardíaca es normal. Se solicita radiografía de tórax, que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión pulmonar persistente
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Aspiración meconial
- d) Taquipnea transitoria
- e) Neumonía neonatal

6) Paciente de 17 años, con obstrucción nasal derecha permanente desde hace algunos meses. Ha presentado tres episodios de epistaxis severas por la misma fosa nasal en el último mes. El diagnóstico más probable es:

- a) Desviación septal
- b) Angiofibroma nasal
- c) Rinitis alérgica
- d) Coagulopatía
- e) Sinusitis crónica

7) ¿Qué parámetro permite determinar con mayor precisión la severidad de una enfermedad obstructiva crónica?

- a) La capacidad vital forzada (CVF)
- b) El volumen de espiración forzada en el primer minuto (VEF1)
- c) La relación entre el VEF1 y CVF
- d) El flujo de espiración forzada entre el 25% y el 75% de la CVF (FEF 25-75)
- e) La capacidad de reserva inspiratoria

8) Un paciente de 64 años consulta por astenia. Ha presentado 4 infecciones bacterianas en los últimos 3 meses. Al examen físico se aprecia pálido, sin otras alteraciones. Tiene hematocrito 29%, plaquetas: 160.000, blancos: 6.000, creatinina de 2,3 y proteinuria de 4 gramos/24 horas. El estudio radiológico demuestra osteoporosis generalizada. El diagnóstico más probable es:

- a) Mieloma múltiple
- b) Mielofibrosis
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Anemia de enfermedades crónicas

9) Un niño de 4 años presenta un cuadro febril de 5 días de evolución, asociado a odinofagia y aparición de un exantema eritematoso generalizado. Al examen físico se observa ojo rojo bilateral, labios con costras, eritematoso y se palpan 2 adenopatías cervicales, la mayor de 3 cm. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por adenovirus
- b) Infección por virus Epstein Baar
- c) Escarlatina
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Sarampión

10) Una paciente de 33 años asintomática presenta elevación de las transaminasas en exámenes de chequeo, con GOT: 80 UI/l y GPT: 92 UI/l. La bilirrubina, GGT y fosfatasa alcalina son normales. Presenta ferritina de 360 ng/ml (VN: 50-150 ng/ml). Al examen físico destaca hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal y obesidad moderada a severa. La ecografía abdominal demuestra aumento de la ecogenicidad hepática. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemocromatosis
- b) Hepatitis viral
- c) Esteatohepatitis no alcohólica
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Cirrosis hepática

11) La incidencia de EPOC en los paciente que fuman es 40 por 100.000 y en los pacientes que no fuman, es 2 por 100.000. Calcule el riesgo relativo:

- a) 0,05
- b) 2
- c) 20
- d) 38
- e) 40

12) Una paciente de 33 años consulta por nerviosismo y dolor cervical. Al examen se palpa bocio difuso, doloroso a la palpación. Presenta TSH: 0,1 y T4: 20 mcg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento de esta patología es:

- a) Iniciar levotiroxina (levo-T4)
- b) Iniciar antitiroideos
- c) Administrar yodo radiactivo
- d) Iniciar triyodotironina (T3)
- e) Indicar AINEs

13) Un paciente de 34 años, presenta por primera vez presenta un cuadro de rápida instalación de dolor precordial, disnea, palpitaciones, sudoración, dificultad para tragar y parestesias en las extremidades superiores. El cuadro cede espontáneamente luego de 20 minutos. Los exámenes de laboratorio excluyen patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Hipocondría
- c) Trastorno adaptativo ansioso
- d) Crisis de pánico
- e) Trastorno de estrés agudo

14) Un recién nacido de 3 días de vida, con antecedente de asfixia severa durante el parto, presenta vómitos, distensión abdominal y eliminación de sangre en las deposiciones. Al examen físico está irritable, con distensión abdominal y timpanidad a la percusión abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Malrotación intestinal
- b) Atresia duodenal
- c) Enterocolitis necrotizante
- d) Estenosis hipertrófica del píloro
- e) Invaginación intestinal

15) Un niño ingiere una pila de reloj, evolucionando inicialmente con tos y sialorrea, que luego ceden espontáneamente. Se solicita radiografía que muestra la pila en el tercio inferior del esófago. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, sin necesidad de estudio a menos que presente síntomas
- b) Buscar la pila en las deposiciones hasta que aparezca
- c) Administrar líquidos por vía oral y controlar con radiografía en 1 hora
- d) Realizar control con radiografía en 6 horas
- e) Extracción inmediata

16) Un paciente con diabetes tipo 2 de larga data, tratada con dieta, que cumple de forma irregular, presenta hemoglobinas glicosiladas de 8,7% y creatinina de 2,1 mg/dl. La conducta más adecuada es iniciar:

- a) Clorpropamida
- b) Tolbutamida
- c) Glibenclamida más metformina
- d) Metformina
- e) Insulina

17) ¿Qué alteración del líquido cefalorraquídeo aparece más tempranamente y es más sugerente de una meningitis bacteriana aguda?

- a) Proteínas aumentadas
- b) Células mayores a 500 por mm³
- c) Predominio de polimorfonucleares
- d) Disminución de la glucosa
- e) Turbiedad

18) Lo más característico de la miastenia gravis es:

- a) Debilidad de instalación súbita de un hemicuerpo
- b) Debilidad proximal, asociada a elevación de la creatinfosfoquinasa (CK)
- c) Debilidad distal asimétrica que mejora con el ejercicio
- d) Debilidad proximal y distal simétricas, sin compromiso ocular
- e) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante

19) La aleatorización, en un ensayo clínico sirve para:

- a) Aumentar la precisión del estudio
- b) Mejorar la potencia del estudio
- c) Evitar sesgos de información
- d) Evitar sesgos por variable confundente
- e) Conseguir que ambos grupos sean del mismo tamaño

20) Un paciente de 69 años cursando neumonía, en tratamiento con ceftriaxona, presenta un derrame pleural con proteínas 5,7 g/dl, LDH: 558 UI/l, pH: 6,9, glicemia: 40 mg/dl. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar toracostomía con trampa de agua
- b) Cambiar la ceftriaxona por clindamicina endovenosa
- c) Iniciar ceftriaxona endovenosa, asociada a metronidazol y controlar con radiografía en 48 horas
- d) Realizar toracocentesis evacuadora
- e) Administrar antibióticos intrapleurales

21) Lactante de 9 meses presenta rash papular generalizado, con lesiones de pequeño tamaño, eritematosas, que respeta las plantas y palmas, asociado a eritema faríngeo. La madre refiere que durante los tres días anteriores presentó fiebre hasta 40°C y que cedió espontáneamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema infeccioso
- b) Herpangina
- c) Exantema enteroviral
- d) Exantema súbito
- e) Enfermedad de Kawasaki

22) Un niño de 7 años presenta edema generalizado y palidez. Presenta albuminemia de 2,0 g/dl, proteinuria de 50 mg/m²/hora y microhematuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Enfermedad de Berger
- e) Síndrome hepatorrenal

23) Una mujer de 26 años dice tener una relación amorosa con un famoso cantante y que éste le declaró su amor a través de una canción. Ha intentado contactarlo en varias oportunidades a través de cartas e incluso visitándolo en su casa, sin embargo nunca ha logrado encontrarse con él, ya que los guardias se lo impiden. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno psicótico reactivo
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno esquizoafectivo

24) Un niño de 11 años con mal rendimiento escolar y peleas frecuentes con sus compañeros de clases. Tiene antecedentes de haber maltratado algunos animales. No parece sentir culpa y responsabiliza a otros por sus actos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno de conducta disocial
- c) Trastorno por déficit atencional
- d) Depresión infantil
- e) Esquizofrenia

25) Mujer primigesta, cursando embarazo de 41+6 semanas, acude a control obstétrico, sin dinámica uterina. El tacto vaginal demuestra un cuello cerrado, duro, posterior, sin borramiento. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Observar evolución espontánea
- c) Realizar amniocentesis
- d) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- e) Inducir el parto con misoprostol

26) Una paciente de 33 años, usuaria de DIU, con antecedente de una gastrectomía parcial, consulta por astenia y debilidad. Al examen físico destaca palidez importante, sin otras alteraciones. Se solicita hemograma que muestra Hcto: 24%, Hb: 8, VCM: 66, HCM: 26, plaquetas: 255.000, Blancos: 7.500. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Anemia por déficit de vitamina B12
- d) Talasemia
- e) Aplasia medular

27) ¿Qué antidepresivo está contraindicado en la uropatía obstructiva baja?

- a) Moclobemida
- b) Sertralina
- c) Citalopram
- d) Amitriptilina
- e) Fluoxetina

28) Un hombre de 40 años presenta rigidez matinal de una hora y artralgiás de articulaciones metacarpofalángicas, muñecas y tobillos, desde hace 6 semanas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en las articulaciones descritas. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Artritis por cristales
- c) Artrosis
- d) Lupus eritematoso
- e) Artritis viral

29) un niño de 8 años presenta un cuadro de tos, odinofagia y rinorrea de 10 días de evolución, a lo que se ha agregado en las últimas horas fiebre hasta 38,5°C y disnea. El examen físico demuestra crepitaciones difusas, mayores en la base izquierda. La radiografía de tórax demuestra un infiltrado intersticial y peribronquial, bilateral, mayor en la base izquierda. El tratamiento de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Eritromicina
- c) Levofloxacino
- d) Ceftriaxona
- e) Clindamicina

30) Una paciente de 30 años, con atraso mensual y síntomas de gestosis, se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio de 11 mm, sin saco gestacional y una lesión anexial sólido-quística de 3 cm en el ovario derecho. La gonadotropina coriónica es de 400 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar metotrexato
- b) Solicitar nueva ecografía transvaginal en 2 días
- c) Solicitar nueva gonadotropina coriónica en 2 días
- d) Realizar laparoscopia
- e) Realizar biopsia endometrial

31) Un paciente de 58 años que usa ibuprofeno como tratamiento de cefalea crónica, inicia dolor epigástrico urente, recurrente, intenso, que en algunas ocasiones lo despierta por la noche. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar sucralfato al tratamiento con ibuprofeno
- b) Iniciar tratamiento sintomático y solicitar estudio endoscópico
- c) Iniciar omeprazol y reevaluar en 2 semanas
- d) Prohibir el uso de AINEs e iniciar otro tipo de analgésicos
- e) Erradicar Helicobacter pylori

32) Paciente de 58 años, con antecedente de síndrome de intestino irritable de 10 años de evolución, consulta por cambio de su hábito intestinal de algunas semanas de evolución, con tendencia a la constipación y que no ha cedido, a pesar de haber agregado fibra en la dieta. El examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar colonoscopia
- c) Agregar un proquinético
- d) Iniciar lactulosa
- e) Solicitar ecografía abdominal

33) Un paciente se molesta fácilmente con las críticas, reaccionando con ira y agresividad. Es muy celoso y se involucra fácilmente en discusiones. El trastorno de personalidad que padece este paciente es:

- a) Narcisista
- b) Antisocial
- c) Evitativo
- d) Histriónico
- e) Paranoide

34) Un paciente de 77 años presenta dolor abdominal intenso, fiebre e ictericia, asociados a hipotensión severa. Los exámenes de sangre demuestran elevación marcada de los glóbulos blancos y otros parámetros inflamatorios y la ecografía abdominal muestra coledocitis con dilatación de la vía biliar intrahepática y del colédoco. El tratamiento de elección es:

- a) Descomprimir la vía biliar por vía percutánea
- b) Descompresión biliar endoscópica
- c) Drenaje quirúrgico de la vía biliar y colecistectomía laparoscópica diferida
- d) Colecistectomía con colédocostomía precoz
- e) Antibioterapia endovenosa

35) Una paciente cursando embarazo de 7 semanas presenta dolor abdominal y metrorragia escasa. La ecografía transvaginal no visualiza gestación intrauterina y la subunidad beta de gonadotropina coriónica humana resulta 3400 UI/l. El diagnóstico más probable es

- a) Aborto completo
- b) Aborto incompleto
- c) Embarazo ectópico
- d) Desprendimiento de placenta
- e) Embarazo molar

36) Una paciente con embarazo de 39 semanas de gestación, en trabajo de parto, cuyo monitoreo fetal es sospechoso, por presencia de desaceleraciones variables. Está con aceleración oxitócica, logrando 4 contracciones uterinas en 10 minutos, al tacto vaginal presenta 6 cm de dilatación, en el segundo plano de Hodge y membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Realizar forceps
- c) Suspender el goteo oxitócico
- d) Realizar rotura artificial de membranas
- e) Aumentar al doble la velocidad del goteo de oxitocina

37) Un niño de 4 años con historia de fatigabilidad presenta crépitos escasos en la auscultación pulmonar. En la auscultación cardíaca se oye un soplo sistólico eyectivo, más intenso en la zona paraesternal izquierda, asociado a desdoblamiento fijo del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Ductus arterioso persistente
- b) Comunicación interauricular
- c) Comunicación interventricular
- d) Coartación aórtica
- e) Tronco arterioso

38) Una mujer de 33 años consulta por palpitaciones, intolerancia al calor, debilidad, diarrea e intolerancia al calor. Al examen presenta bocio de tamaño moderado, con frémito, exoftalmo bilateral, edema pretibial, con piel fina y húmeda. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hashimoto
- b) Bocio multinodular tóxico
- c) Tiroiditis de Riedel
- d) Enfermedad de Basedow Graves
- e) Tiroiditis subaguda

39) Una mujer de 23 años se ha alejado de su familia y otros conocidos, ha dejado de asistir a su trabajo y ha descuidado su aspecto personal. Además escucha voces que le obligan a realizar actos que ella no desea hacer. Su padre refiere que siempre fue retraída y si bien logró terminar su carrera de economía, nunca ha logrado mantener un trabajo estable. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Esquizofrenia
- d) Psicosis reactiva
- e) Trastorno esquizoafectivo

40) Una paciente de 53 años presenta una biopsia endometrial informada como hiperplasia endometrial atípica de alto grado y compleja. El tratamiento de elección es:

- a) Observación
- b) Tamoxifeno
- c) Histerectomía
- d) Hormonoterapia con estrógenos solos
- e) Hormonoterapia con estrógenos y progestágenos

41) Una mujer de 23 presenta desde hace 6 días ojo rojo derecho, con secreción serosa y sensación de arenilla. Hace 2 días los síntomas se extienden al ojo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Uveitis
- e) Epiescleritis

42) Una paciente de 65 años, con 15 años de amenorrea y con antecedente de cáncer de mama tratado con tamoxifeno, presenta metrorragia de 3 días de evolución. La ecografía transvaginal demuestra un endometrio de 12 mm, de ecogenicidad heterogénea, sin presencia de miomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Atrofia endometrial
- c) Adenomiosis
- d) Endometritis
- e) Endometriosis

43) Un paciente de 30 años presenta una taquicardia regular a 180 latidos por minutos, con QRS angosto. Se encuentra hemodinámicamente estable. El tratamiento farmacológico de elección es:

- a) Adenosina
- b) Verapamilo
- c) Amiodarona
- d) Digoxina
- e) Propanolol

44) Una paciente de 22 años presenta artritis de manos y síndrome nefrótico. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoidea
- b) Enfermedad de Wegener
- c) Enfermedad de Good-Pasture
- d) Lupus eritematoso sistémico
- e) Enfermedad de Berger

45) Una paciente de 24 años, cursando un episodio depresivo moderado, inicia tratamiento con fluoxetina 40 mg al día, con buena respuesta. A las 3 semanas de tratamiento la paciente presenta disminución de las necesidades de sueño, verborrea e irritabilidad. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar la fluoxetina por sertralina
- b) Mantener la dosis de fluoxetina y derivar a especialista
- c) Suspender la fluoxetina y derivar a especialista
- d) Disminuir la dosis de fluoxetina y controlar en 2 semanas
- e) Agregar una benzodiazepina al tratamiento

46) Paciente de 71 años de edad, que en los últimos meses presenta de manera progresiva algunas alteraciones cognitivas y de la memoria reciente, asociadas a torpeza motora, sin otras alteraciones en el examen físico general ni neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Demencia de Alzheimer
- c) Demencia frontotemporal
- d) Proceso expansivo intracraneano
- e) Depresión

47) ¿Cuál es el tratamiento de elección del trastorno obsesivo compulsivo?

- a) Benzodiazepinas
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos
- d) Litio
- e) Clorpromazina

48) Una mujer de 18 años presenta un exantema petequeial que compromete las extremidades inferiores. Presenta hematoquezia en una oportunidad, artritis de grandes articulaciones asimétricas y el análisis de orina demuestra presencia de microhematuria y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis postinfecciosa
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Enfermedad de von Willebrand
- d) Púrpura de Shoenlein Henoch
- e) Meningococcemia

49) Una paciente, cursando embarazo de 7 semanas por amenorrea, se realiza ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina y la HCG es 900 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar laparoscopia
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y beta-HCG en 2 a 3 días
- d) Realizar legrado uterino
- e) Controlar con ecografía y HCG en 7 días

50) Una paciente presenta ojo rojo bilateral, asociada a ardor, reacción tarsal folicular y presencia de una adenopatía preauricular derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Queratitis aguda
- e) Glaucoma agudo

51) Un paciente de 57 años presenta dolor anal intenso durante la defecación, seguido de rectorragia escasa. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso perianal
- b) Colitis ulcerosa
- c) Hemorroides
- d) Fístula perianal
- e) Fisura perianal

52) La primera causa de hemorragia subaracnoidea espontánea es:

- a) Hipertensión arterial
- b) Angiopatía amiloidea
- c) Malformación arteriovenosa
- d) Rotura de aneurismas saculares
- e) Meningitis viral

53) ¿Cuál de las siguientes alteraciones se puede encontrar en una otitis media crónica complicada?

- a) Otorrea purulenta
- b) Autofonía
- c) Vértigo
- d) Tinnitus
- e) Hipoacusia

54) Un niño de 7 años presenta lesiones papulares, pruriginosas especialmente en los pliegues cubitales y fosas poplíteas. Su madre es asmática. El diagnóstico más probable es:

- a) Prurigo
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Pitiriasis alba
- d) Pitiriasis versicolor
- e) Dermatitis atópica

55) Un paciente cursando una pancreatitis aguda, evoluciona con oliguria y desorientación. Al examen físico presenta FC:120x', PA: 90/60 mmHg. Se solicitan exámenes que demuestran Creatinina: 2,1; BUN: 80; Na: 138; K: 5,2; Cl: 103. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar suero glucosado al 30%, con 2 gramos de NaCl
- b) Administrar suero glucosado al 5%
- c) Administrar suero glucosado al 5%, con 2 gramos de NaCl y 1 gramo de KCl
- d) Administrar suero fisiológico
- e) Administrar suero glucosado al 10%, 2 gramos de KCl

56) Un paciente de 55 años, presentó influenza hace 15 días. Actualmente evoluciona con fiebre, tos con expectoración purulenta y disnea. Al examen físico presenta FC: 117 lpm, PA: 101/58 mmHg, FR: 33 rpm, con crepitaciones pulmonares difusas. Se realiza radiografía de tórax que muestra opacidades multifocales, que comprometen ambos pulmones, algunas de ellas con imágenes de cavitación. El agente causal más probable es:

- a) Anaerobios
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Klebsiella pneumoniae
- d) Staphylococcus aureus
- e) Mycoplasma pneumoniae

57) Un niño de 4 años consume una sustancia desconocida, evolucionando con agitación psicomotora, sequedad bucal, midriasis, ileo intestinal, taquicardia, sudoración y confusión. El cuadro clínico corresponde a un síndrome:

- a) Narcótico
- b) Opiáceo
- c) Muscarínico
- d) Anticolinérgico
- e) Adrenérgico

58) Un paciente de 68 años presenta temblor cefálico y de las extremidades superiores, especialmente al tomar alguna postura o al tomar un objeto. El resto del examen neurológico es normal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Sertralina
- b) Prolopa
- c) Diazepam
- d) Propanolol
- e) Carbamacepina

59) Un paciente presenta dolor en la cara lateral del codo, mayor con la actividad, especialmente con los movimientos habituales de pronosupinación. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la zona, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis de codo
- b) Epicondilitis
- c) Epitrocleítis
- d) Tendinitis tricipital
- e) Atrapamiento del nervio cutáneo antebraquial lateral

60) Una paciente de 30 años, consulta por dolor abdominal bajo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero normal y líquido libre en la cavidad peritoneal. La beta-HCG es de 7.000 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar laparoscopia
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y beta-HCG en 2 a 3 días
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar tocólisis de urgencia

61) ¿Qué patología se asocia con mayor frecuencia a cáncer de testículo?

- a) Varicocele
- b) Hidrocele
- c) Testículo en ascensor
- d) Síndrome de Down
- e) Criptorquidea

62) Una niña de 8 años es la más baja de su curso. Actualmente su talla está en el percentil 5 de la curva de crecimiento para su edad. Al nacer pesó 3.300 gramos y midió 47 cm. Su examen físico resulta normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para continuar el estudio de su talla?

- a) Evaluar la talla de los padres
- b) Solicitar radiografía de carpo, para calcular la edad ósea
- c) Confeccionar una curva de crecimiento
- d) Solicitar cariograma
- e) Solicitar pruebas de estimulación de hormona de crecimiento

63) Una paciente con antecedente de enfermedad de Wolf Parkinson White, con un haz paraespecífico, presenta una taquicardia irregular a 140 lpm, con complejos QRS anchos. El tratamiento de elección es:

- a) Verapamilo
- b) Adenosina
- c) Amiodarona
- d) Digoxina
- e) Propanolol

64) Una paciente de 22 años, con antecedente de parto prematuro a las 34 semanas, cursa un embarazo actual de 33 semanas, consulta por contracciones uterinas, algunas de ellas dolorosas. Se comprueba que presenta dinámica uterina de 3 contracciones en 10 minutos, la que persiste luego de un tiempo razonable de observación. La conducta más adecuada es:

- a) Hacer un tacto vaginal
- b) Medición de longitud cervical por ecografía
- c) Realizar test de fibronectina
- d) Realizar un perfil biofísico
- e) Realizar amniocentesis

65) ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos tiene un peor pronóstico en una paciente embarazada, con diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino?

- a) Feto creciendo entre los percentiles 5 y 10 para la edad gestacional
- b) Perímetro cefálico en el percentil 5 para la edad gestacional
- c) Ausencia de movimientos respiratorios
- d) Oligohidramnios
- e) Perímetro abdominal mayor al perímetro cefálico

66) ¿Cuál es el diagnóstico nutricional en un niño de 6 años que presenta los siguientes indicadores antropométricos: IPE: +2DS, IPT: +1DS, ITE: +1DS?

- a) Desnutrición
- b) Eutrófico
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

67) La fuerza de asociación entre un factor de riesgo y una patología, en un estudio de casos y controles, se estima mediante:

- a) Riesgo relativo
- b) Likelihood ratio
- c) Riesgo atribuible
- d) Odds Ratio
- e) La "t" de student

68) Una mujer de 17 años, cursando embarazo en el tercer trimestre presenta cefalea, seguida de una convulsión tónico clónica generalizada. Presenta presión arterial de 160/100, edemas y proteinuria (+). El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Hemorragia cerebral
- c) Epilepsia
- d) Eclamsia
- e) Síndrome de HELLP

69) Una mujer de 36 años, con una pareja sexual nueva consulta por dolor genital y aparición varias lesiones ulceradas, dolorosas en los labios vaginales y adenopatías inguinales bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Behcet
- b) Herpes genital
- c) Condilomas acuminados
- d) Linfogranuloma venéreo
- e) Sífilis primaria

70) Para el diagnóstico de preclamsia, durante un embarazo, se necesita la presencia de hipertensión arterial, asociada a:

- a) Exaltación neurológica
- b) Edema
- c) Elevación de la creatinina plasmática
- d) Proteinuria significativa
- e) Alteración de las transaminasas

71) Una paciente acude a control 3 semanas luego de una pancreatitis aguda, en buenas condiciones. Se realiza una ecografía abdominal que muestra una lesión quística de 10 cm de diámetro y paredes lisas, compatible con un pseudoquiste pancreático. La conducta más adecuada es:

- a) Drenaje por punción
- b) Marsupialización quirúrgica al duodeno
- c) Remoción quirúrgica del pseudoquiste
- d) Iniciar antibióticos
- e) Observar la evolución

72) Un recién nacido de término, de 3 días vida, hijo de madre primípara, inicia ictericia hasta los muslos. Es alimentado con leche materna exclusiva. Su grupo sanguíneo es O Rh(+) y el de la madre es A Rh(-). El hemograma es normal, la bilirrubina total es 12,2 mg/dl y la bilirrubina directa es 1,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Hemólisis por incompatibilidad Rh
- c) Ictericia por lactancia materna exclusiva
- d) Hepatitis neonatal
- e) Ictericia fisiológica

73) Un niño de 6 años consulta por malestar general, fiebre y odinofagia de 3 días de evolución. Refiere además un cuadro de astenia y palidez de un mes de evolución. Al examen físico se aprecia pálido y destacan algunas adenopatías cervicales. Tiene un hemograma con hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, blancos: 9.740 por mm³, linfocitos: 88%, neutrófilos: 12% y plaquetas: 38.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hodgkin
- b) Leucemia aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Infección por citomegalovirus
- e) Leucemia linfática crónica

74) Un lactante de 30 días de vida presenta vómitos postprandiales explosivos, que se han ido intensificando, asociados a constipación. Se ve enflaquecido, pero hambriento. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia hiatal
- b) Estenosis hipertrófica del píloro
- c) Invaginación intestinal
- d) Atresia duodenal
- e) Reflujo gastroesofágico

75) Una paciente de 43 años, presenta desde hace 4 meses disnea de esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores. Los síntomas han ido empeorando gradualmente y en la actualidad presenta disnea al realizar pequeños esfuerzos. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal, se palpa desplazamiento del choque de la punta al quinto espacio intercostal, a la altura de la línea axilar media y se ausculta un soplo holosistólico de regurgitación mitral. El tratamiento más adecuado para iniciar el tratamiento es:

- a) Enalapril, digoxina y furosemida
- b) Hidralazina, espironolactona y digoxina
- c) Carvedilol, enalapril, hidralazina y anticoagulante
- d) Losartán, hidroclorotiazida, aspirina y tratamiento anticoagulante
- e) Enalapril, carvedilol, espironolactona y furosemida

76) El tratamiento erradicador de Helicobacter pylori en los pacientes con úlcera péptica tiene como finalidad:

- a) Aumentar la velocidad de cicatrización
- b) Prevenir las recurrencias
- c) Disminuir la intensidad de las hemorragias
- d) Prevenir el cáncer gástrico
- e) Disminuir los síntomas

77) Una mujer embarazada de término está en trabajo de parto, con contracciones uterinas de 4 en 10 minutos, 6 centímetros de dilatación, membranas íntegras y feto en presentación de vértice, en espinas -2. Luego de 2 horas de evolución no hay cambios en la progresión del parto. El registro fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Hacer una cesárea por prueba de parto fracasada
- b) Iniciar aceleración oxitócica
- c) Administrar misoprostol
- d) Realizar rotura artificial de membranas
- e) Realizar fórceps

78) La medida más importante para prevenir la infección de una herida traumática es:

- a) Antibióticos locales
- b) Cubrir con apósito
- c) Antibióticos sistémicos
- d) Aseo quirúrgico
- e) Vacunación antitetánica

79) Un paciente sufre un golpe en el hombro derecho, presentando el signo de la charretera. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura subcapital
- b) Disyunción acromioclavicular
- c) Luxación anterior
- d) Fractura de clavícula
- e) Luxación posterior

80) Un paciente de 69 años, con antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, secundaria a una cardiopatía hipertensiva, de larga data, en tratamiento con enalapril, espironolactona, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina, consulta por aumento de su sintomatología y progresión de su disnea, que actualmente aparece ante mínimos esfuerzos. El examen físico demuestra FC: 87x', regular, PA: 130/80, crépitations pulmonares escasas bibasales, y un RR2T sin soplos. La conducta más adecuada para mejorar el pronóstico en este paciente es:

- a) Cambiar el enalapril por un inhibidor del receptor de angiotensina 2
- b) Iniciar digoxina
- c) Iniciar propanolol
- d) Iniciar furosemida
- e) Iniciar carvedilol

81) Un niño de 3 meses de edad presenta una hernia umbilical, con anillo palpable de un centímetro de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar en atención primaria, ya que cierra sola
- b) Derivar a resolución quirúrgica a los 6 meses de edad
- c) Derivar a resolución quirúrgica al año de edad
- d) Comprimirla con una faja
- e) Resolver quirúrgicamente a la brevedad

82) Un paciente sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis. Evoluciona con imposibilidad de orinar y globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar sonda Nelaton
- b) Instalar sonda Foley
- c) Instalar cistostomía
- d) Realizar cistoscopia
- e) Solicitar ecografía renal y vesical

83) ¿Qué parámetro es el más importante para manejar la prevención de las complicaciones micro y macrovasculares en la diabetes mellitus?

- a) Presión arterial menor a 130/80
- b) Realizar ejercicio periódico
- c) Hemoglobina glicosilada menor a 8%
- d) Suspender el tabaquismo
- e) Mantener glucosuria negativa

84) Se calculan los casos nuevos de una enfermedad infecciosa, a lo largo de un año. El parámetro descrito es:

- a) Prevalencia
- b) Tasa de morbilidad general
- c) Incidencia acumulada
- d) Densidad de incidencia
- e) Tasa de morbilidad específica

85) Un paciente de 33 años consulta por aparición de varias pápulas de 3 a 4 mm en el tronco, umbilicadas, no dolorosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Verrugas
- b) Pitiriasis rosada
- c) Psoriasis guttata
- d) Sífilis secundaria
- e) Molusco contagioso

86) Un paciente de 70 años pierde súbitamente la visión del ojo derecho. Al examen se aprecia pérdida del rojo pupilar de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Catarata
- b) Hemorragia vítrea
- c) Glaucoma agudo
- d) Trombosis de la arteria central de la retina
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

87) Una mujer de 23 años presenta un nódulo mamario de 3 cm, de consistencia gomosa, fácil de movilizar y de bordes lisos. Es indoloro a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de mama
- b) Tumor philloides
- c) Fibroadenoma
- d) Papiloma mamario
- e) Quiste mamario

88) ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una medida de prevención primaria?

- a) Realizar Papanicolaou
- b) Medir el antígeno prostático
- c) Tomar la presión arterial en pacientes sanos
- d) Fluoración del agua potable
- e) Tomar mamografía

89) ¿En cuál de las siguientes vacunas tenemos que valorar el grado de inmunosupresión, antes de su aplicación en pacientes inmunocomprometidos?

- a) DTP.
- b) Polio oral.
- c) Polio inactivada.
- d) Triple vírica.
- e) Hepatitis B.

90) ¿Cuál de las siguientes complicaciones NO es atribuible al preeclampsia grave?:

- a) Edema agudo de pulmón.
- b) Embolia pulmonar.
- c) Rotura hepática.
- d) Desprendimiento prematuro de placenta (abruptio placentae).
- e) El denominado síndrome de Hellp.

SEGUNDA PARTE

1) Un paciente está convencido de padecer un cáncer a pesar de contar con numerosos exámenes que demuestran lo contrario. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno psicótico residual
- c) Trastorno somatomorfo
- d) Depresión mayor
- e) Trastorno conversivo

2) Una mujer consulta por prurito vulvar de una semana de evolución y leucorrea. A la especuloscopia se observa abundante leucorrea grumosa, con signos inflamatorios en la pared vaginal. El agente etiológico más probable es:

- a) Candida albicans
- b) Escherichia coli
- c) Gardnerella vaginalis
- d) Trichomona vaginalis
- e) Clamidia trachomatis

3) Un paciente de 27 años presenta un cuadro de cefalea, coriza y tos de 7 días de evolución. Desde ayer se agrega disnea y fiebre hasta 37,8°C. Al examen físico presenta FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, FR: 19x' y se auscultan crépitos escasos difusos en ambos pulmones. La radiografía de tórax demuestra un patrón alveolo-intersticial bilateral, mayor en las bases. El agente causal más probable es:

- a) Streptococcus pneumoniae
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Mycoplasma pneumoniae
- d) Staphylococcus aureus
- e) Virus influenza

4) El mejor tipo de estudio para determinar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad poco frecuente es:

- a) Cohorte
- b) Caso control
- c) Ensayo clínico
- d) Transversal
- e) Doble ciego

5) Un recién nacido de 28 días de vida, alimentado con pecho materno exclusivo, inicia ictericia, asociado a coluria y acolia. Al examen físico presenta ictericia hasta los muslos y hepatomegalia. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia por lactancia materna
- b) Ictericia fisiológica
- c) Ictericia hemolítica tardía, por incompatibilidad de grupo
- d) Atresia biliar primaria
- e) Síndrome de Gilbert

6) Un paciente de 17 años sufre dos síncope en relación al esfuerzo. Al examen físico presenta un pulso amplio, regular, a 72 lpm, con presión arterial normal. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, mayor paraesternal izquierdo. Se solicita un electrocardiograma que muestra onda T negativa en algunas derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Estenosis aórtica
- d) Estenosis mitral
- e) Angina inestable

7) Una embarazada de 7 semanas presenta una glicemia de ayunos de 205 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar para manejo metabólico
- b) Iniciar hipoglicemiantes orales
- c) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- e) Solicitar hemoglobina glicosilada

8) Una paciente embarazada de 40 semanas de gestación ingresa en trabajo de parto, en dilatación completa, con feto en espinas -3, dinámica uterina de 4 en 10 minutos y membranas rotas. Luego de 2 horas no se produce descenso y se palpa feto en posición occipito ilíaca derecha transversa. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Realizar extracción con forceps
- c) Realizar rotación manual hasta posición OP
- d) Iniciar aceleración oxitócica
- e) Realizar cesárea

9) Un paciente de 66 años presenta un cuadro de constipación marcada de 3 días de evolución, sin poder presentar deposiciones, asociado a dolor abdominal. Luego presenta deposiciones diarreicas explosivas en una oportunidad. Refiere además historia de palidez y molestias abdominales de 1 mes de evolución. El examen físico muestra un paciente pálido, con abdomen blando, depresible y el tacto rectal demuestra una ampolla rectal sin deposiciones, sin hallar otras alteraciones.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vólvulo de colon sigmoide
- b) Cáncer de colon
- c) Obstrucción intestinal por bridas
- d) Síndrome de Ogilvie
- e) Diverticulitis

10) Una mujer cursando 33 semanas de gestación inicia contracciones uterinas muy dolorosas. Al examen se constata útero hipertónico y no se auscultan latidos cardíofetales. Se realiza ecografía obstétrica que confirma un óbito fetal y el tacto vaginal demuestra metrorragia escasa, de color oscuro. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Rotura de vasa previa
- c) Rotura uterina
- d) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- e) Embolia de líquido amniótico

11) Una mujer embarazada de 33 semanas, con antecedente de enfermedad reumática en su infancia presenta disnea y ortopnea de rápida instalación. Al examen físico se aprecia disnea, con frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, irregular, presión arterial de 90/60 mmHg, sudorosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Embarazo normal
- d) Fibrilación auricular
- e) Taquicardia ventricular

12) La conducta más adecuada ante un hematoma del tabique nasal es:

- a) Observación
- b) Antibioterapia de amplio espectro
- c) Compresión con apósitos
- d) Drenaje inmediato
- e) Taponamiento nasal anterior

13) Paciente de 50 años, con tos y expectoración de 3 días de evolución, asociado a disnea. Al examen físico presenta FR: 22x', PA: 120/80, FC: 99x', t°: 37,8°C. Se auscultan crépitos localizados en la base izquierda, con broncofonía. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo inferior izquierdo. El antimicrobiano de elección es:

- a) Clindamicina
- b) Cefuroxima
- c) Ceftriaxona
- d) Amoxicilina
- e) Metronidazol

14) Niño que luego de recibir su vacuna de los 2 meses, presenta una convulsión. ¿Cuál de los componentes de la vacuna es el más probable responsable?

- a) Pertusis
- b) Hepatitis B
- c) Polio
- d) Difteria
- e) Tétanos

15) Un hombre de 76 años presenta varios síncope en las últimas horas. Al examen físico está soporoso, hipoperfundido, tiene una frecuencia cardíaca de 34 latidos por minutos y una presión arterial de 86/48 mmHg. Se ausculta un primer ruido cardíaco de intensidad variable. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo AV completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Síncope vasovagal
- d) Síndrome coronario agudo
- e) Fibrilación auricular

16) Un hombre de 75 años presenta aumento de volumen escrotal, de 6 cm de diámetro, indoloro y de consistencia quística. El diagnóstico más probable es:

- a) Epididimitis
- b) Varicocele
- c) Cáncer de testículo
- d) Hidrocele
- e) Hernia inguinoescrotal

17) Un anciano de 78 años presenta síncope al incorporarse. Hace un año se realizó una artroplastia de cadera y está postrado hace 4 meses. ¿Cuál es la causa más probable de este cuadro?

- a) Síncope cardiogénico
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Epilepsia focal
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Enfermedad coronaria

18) Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas de las manos. Presenta rigidez matinal de 15 minutos de duración. Se solicita radiografía de manos que demuestra disminución del espacio interarticular, con presencia de algunos osteofitos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Artritis por cristales
- c) Artrosis
- d) Lupus eritematoso
- e) Artritis viral

19) La causa más frecuente de una tetraparesia flácida, con arreflexia y parálisis facial bilateral es:

- a) Crisis miasténica
- b) Polirradiculoneuritis
- c) Infarto de troncoencéfalo
- d) Lesión medular alta
- e) Mononeuritis múltiple

20) Un paciente de 44 años consulta por dolor torácico con tope inspiratorio de algunos días de evolución, asociado a disnea. Al examen físico se observa matidez en la base pulmonar derecha. Se solicita radiografía de tórax que demuestra un derrame pleural que ocupa toda la mitad inferior del hemitórax, el que se punciona, dando salida a un líquido amarillo, algo turbio, con LDH: 600 UI/l, glucosa: 40 mg/dl, proteínas: 6,1 g/dl, células: 1.000, con 85% mononucleares, ADA: 82 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Derrame paraneumónico simple
- b) Derrame paraneumónico complicado
- c) Tuberculosis pleural
- d) Insuficiencia cardíaca congestiva
- e) Invasión pleural maligna

21) Una paciente está en tratamiento con cirpofloxacino por una pielonefritis aguda por E. coli sensible, sin embargo permanece febril y con disuria, a pesar de llevar 5 días de tratamiento antibiótico. Además usa crónicamente omeprazol, salbutamol, aspirina, venlafaxina y calcio más vitamina D, por diversas patologías. ¿Cuál de los fármacos es el causante de esta situación, con mayor probabilidad?

- a) Salbutamol
- b) Aspirina
- c) Calcio / Vitamina D
- d) Venlafaxina
- e) Omeprazol

22) El examen más costoefectivo para evaluar la patología del manguito rotador es:

- a) Radiografía
- b) Ecografía
- c) Cintigrafía
- d) Tomografía axial computada
- e) Resonancia magnética nuclear

23) Un paciente de 33 años consulta por tos con expectoración mucopurulenta, asociada a fiebre hasta 38,8°C y dolor torácico derecho, que aumenta con la inspiración. Al examen presenta FC: 90x', PA: 144/76 mmHg, frecuencia respiratoria: 17x', y se ausculta disminución del murmullo pulmonar en la base derecha, asociada a crepitaciones en la misma zona. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo inferior derecho, asociado a un derrame pleural moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar clindamicina oral y realizar nueva radiografía de tórax en 48 horas
- b) Iniciar levofloxacino y controlar evolución clínica
- c) Hospitalizar y realizar estudio de líquido pleural
- d) Enviar a domicilio con amoxicilina por 7 días
- e) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico y realizar toracocentesis en 48 horas

24) Un paciente de 22 años, con antecedente de fiebre reumática en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna de 2 meses de evolución. Al examen físico presenta rubor facial, aumento de la intensidad del primer ruido, con un ruido de tonalidad alta al inicio del diástole, seguido de un soplo de tonalidad baja, rudo. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis tricuspídea
- c) Estenosis mitral
- d) Insuficiencia mitral
- e) Insuficiencia aórtica

25) Un recién nacido de término pesó 3.400 gramos al nacer. Es evaluado a los 10 días de vida y pesa lo mismo que al nacer. Es alimentado con lactancia materna exclusiva. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener lactancia materna y reevaluar en 3 días
- b) Mantener lactancia materna y reevaluar en 7 días
- c) Mantener lactancia materna e iniciar suplemento con fórmula
- d) Suspender lactancia materna e iniciar alimentación con fórmula de inicio
- e) Suspender lactancia materna e iniciar alimentación paraenteral

26) Una paciente de 33 años presenta debilidad muscular y amenorrea de 6 meses. Al examen físico destacan presión arterial: 160/100 mmHg, plétora facial, obesidad troncular y estrías abdominales violáceas. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) TAC de de glándulas suprarrenales
- b) RMN de silla turca
- c) Cortisol basal
- d) Cortisol post dexametasona
- e) ACTH basal

27) Una mujer de 33 años, con menometrorragia se realiza ecografía transvaginal que demuestra 3 miomas submucosos y un endometrio heterogéneo y de grosor aumentado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar miomectomía
- b) Realizar histerectomía
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- d) Iniciar progestágenos solos por vía transdérmica
- e) Solicitar biopsia endometrial

28) Mujer de 35 años, cesarizada anterior, cursando un nuevo embarazo de término, inicia trabajo de parto y 2 horas después evoluciona con intenso dolor abdominal y metrorragia escasa, asociada a hipotensión. El monitoreo fetal muestra bradicardia fetal sostenida. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- b) Rotura de vasa previa
- c) Embolía de líquido amniótico
- d) Placenta previa
- e) Rotura uterina

29) Un lactante presenta aumento de volumen escrotal, con prueba de transiluminación positiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Varicocele
- b) Torsión testicular
- c) Hidrocele
- d) Orquitis
- e) Hernia inguinal indirecta

30) Un paciente ha dejado de salir de su casa, ha descuidado el orden de la misma y también su aspecto personal. Es muy unido a la religión y lee la Biblia a diario. Escucha voces que comentan todos sus actos y que lo insultan. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Esquizofrenia paranoide
- d) Trastorno adaptativo
- e) Episodio psicótico reactivo

31) Una paciente de 31 años consulta por placas eritematosas que aparecen en los codos, tronco y cuero cabelludo, que aparecieron hace 4 meses, con periodos de remisión y exacerbación y que en el último tiempo han aumentado en tamaño y cantidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Pitiriasis rosada
- c) Dermatitis de contacto
- d) Psoriasis
- e) Liquen plano

32) Un niño de 4 años presenta inapetencia y prurito anal y oral. La madre detecta un gusanito de 5 mm en la zona perianal. El tratamiento de elección es:

- a) Tinidazol
- b) Mebendazol
- c) Prazicuantel
- d) Clindamicina
- e) Cotrimoxazol

33) La nefropatía diabética inicial se define como:

- a) Microalbuminuria, asociada a elevación discreta de la creatinina plasmática
- b) Macroalbuminuria, asociada a elevación discreta de la creatinina plasmática
- c) Microalbuminuria, con creatininemia normal
- d) Macroalbuminuria, con creatininemia normal
- e) Proteinuria significativa, con creatininemia normal

34) Una paciente consulta por metrorragia escasa y sinusorragia. A la especuloscopia se observa una lesión exofítica de 2x3 cm en el cuello uterino. Tiene un PAP hace 3 meses que resultó normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo PAP
- b) Solicitar histeroscopia
- c) Solicitar ecografia transvaginal
- d) Extirpar la lesión y enviarla a biopsia
- e) Derivar a crioterapia

35) Un niño de 5 años consulta por un cuadro de rinorrea, tos y fiebre, de 2 días de evolución. Al examen físico se observa con FC: 110x', FR: 22x', t°:38,2°C, sin cianosis, con instridor inspiratorio durante el llanto. La auscultación cardíaca muestra un ritmo regular en 2 tonos, sin soplos y la auscultación pulmonar demuestra un murmullo pulmonar simétrico, sin otros ruidos agregados. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiolitis aguda
- b) Asma
- c) Neumonía
- d) Laringitis obstructiva
- e) Epiglotitis

36) Un paciente presenta de forma aguda tos y disnea intensas, que luego se recuperan el gran medida. Al examen físico se constata asimetría del murmullo pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia pulmonar
- b) Cuerpo extraño bronquial
- c) Neumotórax espontáneo
- d) Tos convulsiva
- e) Bronquitis aguda

37) Un niño de 6 años cursando una diarrea evoluciona con palidez progresiva, asociado a oliguria y edema generalizado. Al examen físico se aprecia lo descrito e ictericia de piel y mucosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hepatorenal
- b) Hepatitis aguda grave
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Glomerulonefritis postestreptocócica
- e) Anemia hemolítica autoinmune

38) Un paciente de 25 años consulta por odinofagia, fiebre y varias adenopatías cervicales, dolorosas. Al examen físico se encuentra febril, con faringe eritematosa, con escaso exudado blanquecino. Se palpa esplenomegalia leve. El hemograma muestra linfocitosis con algunas atipias. Se realiza serologías en busca del agente causal, con los siguientes resultados:

IgM VCA: negativa; IgG VCA: positiva

IgM toxoplasma: negativa; IgG toxoplasma: positiva

IgM CMV: positiva; IgG CMV: negativa

El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por VIH
- b) Infección por citomegalovirus
- c) Infección por toxoplasma
- d) Infección por virus Epstein Barr
- e) Infección conjunta por toxoplasma y virus Epstein Barr

39) El examen de más alto rendimiento para diagnosticar el asma es:

- a) Prueba cutánea para alérgenos respiratorios
- b) Inmunoglobulina E específica
- c) Velocidad máxima de flujo espiratorio (PEF)
- d) Radiografía de tórax
- e) Espirometría basal y postbroncodilatador

40) Una paciente de 43 años con un nódulo mamario de 3 cm en la mama derecha. Se realiza una mamografía que demuestra un nódulo denso, con todos sus bordes espiculados y con varias micro calcificaciones agrupadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Displasia mamaria
- b) Fibroadenoma
- c) Tumor filloides
- d) Cáncer de mama
- e) Mastopatía fibroquística

41) El tratamiento de elección de la depresión severa, durante el embarazo es:

- a) Imipramina
- b) Venlafaxina
- c) Amitriptilina
- d) Litio
- e) Fluoxetina

42) Un paciente con dolor abdominal de 24 horas de evolución, muy intenso, asociado a ictericia. Los exámenes de laboratorio demuestran hematocrito: 42%, leucocitos: 7.600 x mm³, plaquetas: 340.000 x mm³, bilirrubina total: 5,9 mg/dl, bilirrubina directa: 90%, GOT: 107 UI/l, GPT: 88 UI/l, GGT: 600 UI/l, fosfatasas alcalinas: 326 UI/l, albúmina: 4,1 y protrombina: 93%. La ecografía abdominal muestra hígado de ecogenicidad conservada, vesícula biliar de paredes normales, sin presencia de cálculos y la vía biliar intra y extrahepática de calibre normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Colecistitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Pancreatitis aguda
- d) Hepatitis aguda
- e) Colédocolitiasis

43) Una paciente de 60 años, cursa con diarrea aguda, con deshidratación severa. Se solicitan electrolitos plasmáticos que demuestran Na: 127, K:3,9, Cl: 88. La conducta inicial más adecuada es administrar:

- a) Solución de NaCl al 0,9%
- b) Solución de NaCl al 3%
- c) Solución de NaCl al 3% con 2 gramos de KCl
- d) Solución glucosada al 5%, con 2 gramos de NaCl y 1 gramo de KCl
- e) Solución de NaCl al 1,5%

44) Una paciente de 17 años presenta equimosis cutáneas desde la infancia, alveolorragia en las extracciones dentales, hipermenorrea y equimosis frecuentes. El examen físico no aporta más información. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemofilia
- b) Púrpura trombocitopénica inmune
- c) Disfunción plaquetaria por uso de aspirina
- d) Enfermedad de von Willebrand
- e) Factor V de Leyden

45) Una paciente diabética tipo 2, con mal control, consulta por una herida en el cuarto orjeo derecho, de 1 centímetro de diámetro mayor, dolorosa y de bordes irregulares, eritematosos. Al examen físico se aprecia disminución. La radiografía del pie no revela compromiso óseo. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Ciprofloxacino + clindamicina
- b) Metronidazol
- c) Cefazolina
- d) Meropenem + Vancomicina
- e) Azitromicina

46) Un niño de 9 meses presenta leucocoria en el ojo derecho. ¿Qué alteración en el examen físico será más probable encontrar en este paciente?

- a) Alteración del rojo pupilar
- b) Alteración de la prueba de Hirschberg
- c) Alteración de la oculomotilidad
- d) Alteración de la tonometría digital
- e) Alteración del reflejo pupilar

47) Un hombre de 44 años insiste que su jefe quiere perjudicarlo y que le asigna tareas y actividades con el fin de hacerle daño, humillarlo y tratarlo mal. Se evalúa el ambiente laboral de la empresa en que trabaja y parece ser bueno. La familia del paciente niega los malos tratos de parte del jefe. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno psicótico breve
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno delirante crónico

48) Usted desea aplicar un plan de pesquisa de cáncer de cuello uterino, con toma de Papanicolaou en una población de 10.000 mujeres, con cobertura: 75%, concentración: 1. Una matrona tiene rendimiento de 5/h. ¿Cuántas horas matronas se necesitan?

- a) 750
- b) 7.500
- c) 1.500
- d) 2.000
- e) 1.000

49) ¿Cuál es la causa más frecuente de agitación psicomotora en un paciente de edad avanzada, con demencia y que vive en su domicilio?

- a) Trastorno metabólico o infeccioso intercurrente
- b) Progresión de su demencia
- c) Maltrato del anciano
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Arritmias

50) Un hombre de 30 años sufrió un accidente de tránsito hace 2 meses, en el que resultó ileso. Ahora empieza con recuerdo desagradables y recurrentes de lo sucedido. Se siente muy angustiado y con un sentimiento disfórico, que le cuesta describir. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por estrés agudo
- b) Trastorno adaptativo ansioso
- c) Depresión
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por estrés postraumático

51) Un paciente de 68 años presenta insomnio, tristeza, ánimo bajo, desconcentración y olvidos frecuentes. Su examen físico resulta normal y presenta minimental de Folstein de 25/30. El diagnóstico más probable

- a) Demencia de Alzheimer
- b) Depresión
- c) Hipotiroidismo
- d) Demencia frontotemporal
- e) Síndrome confusional agudo

52) Una paciente de 38 años, cursando con una pielonefritis por Escherichia coli multisensible inicia tratamiento antibiótico, con adecuada cobertura, sin embargo 5 días después permanece febril, con disuria y dolor lumbar. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el tratamiento antibiótico por uno de mayor cobertura
- b) Solicitar una tomografía axial computada
- c) Mantener el tratamiento antibiótico y reevaluar en 2 días
- d) Solicitar ecografía
- e) Solicitar nuevo urocultivo y decidir según antibiograma

53) Una mujer de 50 años presenta astenia y prurito de 3 meses de evolución. El examen físico resulta normal. Las pruebas hepáticas demuestran bilirrubina total: 2,3 mg/dl, bilirrubina conjugada: 2,0 mg/dl, fosfatasas alcalina: 921 UI/l, GOT: 102 UI/l, GPT: 112 UI/l, GGT: 644 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Esteatohepatitis no alcohólica
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hepatitis viral crónica
- e) Cirrosis biliar primaria

54) Una paciente cursando diarrea y vómitos, de 2 días de evolución, presenta deterioro del estado general y oliguria. En sus exámenes de laboratorio destaca nitrógeno ureico: 50 mg/dl, Creatininemia: 5,6 mg/dl, potasio plasmático: 6,0 mEq/l, sodio urinario: 40 mEq/l. EL diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Obstrucción urinaria
- e) Insuficiencia renal crónica

55) Paciente de 68 años presenta dificultad respiratoria, cianosis y taquipnea importante. Al examen físico se constata FR: 32x', PA: 100/60, FC: 110x'. Sus gases arteriales demuestran pH: 7,37, PaO₂: 57 mmHg, PaCO₂: 47mmHg. Se inicia oxígeno al 35%, evolucionando con sopor profundo. La conducta más adecuada es:

- a) Disminuir la FiO₂ de oxígeno
- b) Iniciar antibióticos y corticoides endovenosos
- c) Aumentar la FiO₂ de oxígeno
- d) Realizar apoyo ventilatorio no invasivo, con Bi-PAP
- e) Intubar y conectar a ventilador mecánico

56) Hombre de 32 años, consulta por un cuadro de una semana de evolución de cefalea, fiebre, odinofagia intensa y malestar general. En su examen físico destaca palidez y esplenomegalia de 2 cm bajo el reborde costal. Las amígdalas se encuentran hiperémicas, sin exudado. Se solicita un hemograma que demuestra hematocrito: 29%, leucocitos: 44.000, neutrófilos: 31%, linfocitos: 22%, blastos: 47%, plaquetas: 18.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Leucemia crónica
- c) Infección por virus Epstein Baar
- d) Mielofibrosis
- e) Linfoma

57) Una mujer de 26 años, primigesta, cursando embarazo de 37 semanas, consulta por mareos y disnea que aparecen al recostarse y que se han hecho muy frecuentes durante los últimos días. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar evaluación por neurólogo
- b) Solicitar Holter de arritmias
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Interrumpir el embarazo
- e) Educar a la paciente sobre la normalidad de estos síntomas

58) Un hombre de 62 años despierta por dolor precordial izquierdo de 2 horas de evolución, intenso, que persiste hasta ahora. Al examen físico se presenta FC: 110x', PA: 166/100 mmHg, con RR2T sin soplos y murmullo pulmonar simétrico, sin otros ruidos. El electrocardiograma demuestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DII, DIII y AVF. La primera toma de enzimas cardíacas resulta negativa. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Angina inestable
- c) Disección aórtica
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Fibrilación auricular

59) Un paciente de 66 años presenta desde hace 4 meses disminución del calibre del chorro miccional, asociado a nicturia y poliaquiuria, con algún grado de disuria de esfuerzo. Los síntomas se han ido intensificando progresivamente. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección urinaria
- b) Hiperplasia benigna de la próstata
- c) Cáncer de próstata
- d) Estenosis uretral
- e) Vejiga neurogénica

60) Un paciente presenta de forma brusca imposibilidad para evocar palabras. No es capaz de nombrar objetos, sólo puede decir algunas palabras cortas, con mucha dificultad, sin embargo repite con mayor facilidad. Presenta sólo mínima dificultad de la comprensión. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto silviano derecho
- b) Accidente isquémico frontal izquierdo
- c) Infarto postrolándico izquierdo
- d) Isquemia aguda de troncoencéfalo
- e) Infarto cerebeloso

61) Un paciente de 71 años presenta anemia macrocítica, hiporregenerativa. Se solicitan TSH, niveles de plasmáticos de vitamina B12 y folatos, ferritina y ferremia todas normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hierro, folatos y vitamina B12 por vía oral
- b) Iniciar vitamina B12 intramuscular
- c) Iniciar estudio de talasemia
- d) Solicitar estudio morfológico de médula ósea
- e) Iniciar eritropoyetina

62) Un paciente de 60 años consulta por una lesión en el ala nasa, solevantada, con una ulceración central, con borde perlado y una telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis actínica
- b) Granuloma telangiectásico
- c) Melanoma
- d) Carcinoma espinocelular
- e) Carcinoma basocelular

63) Una paciente de 34 años consulta por tos recurrente, de algunas semanas de evolución, especialmente nocturna y que en el último tiempo aparece además con la actividad física y se acompaña de disnea. Tiene antecedente de rinitis alérgica. El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) Coqueluche
- c) Tuberculosis
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Bronquitis crónica

64) Una mujer, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por cefalea, tinnitus y malestar general importante. Al examen físico presenta FC: 108x', PA: 180/100 mmHg, edema de extremidades inferiores y exaltación de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia moderada
- b) Preclamsia severa
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Eclamsia
- e) Hipertensión arterial crónica

65) ¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar la importancia de una enfermedad crónica?

- a) Tasa de incidencia
- b) Prevalencia
- c) Tasa de mortalidad general
- d) Tasa de mortalidad específica
- e) Tasa de morbilidad

66) Una paciente con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con prednisona 15 mg/día y metotrexato en una dosis semanal. Consulta por dolor en la ingle derecha, muy intenso, de 7 días de evolución, que le impide la marcha. Al examen físico se aprecia dolor con los movimientos de la cadera, especialmente con la abducción. Se solicita radiografía de caderas que muestran alteraciones de la cabeza femoral derecha, compatible con necrosis avascular. ¿Cuál es la causa más probable de la necrosis avascular en esta paciente?

- a) La artritis reumatoide
- b) La prednisona
- c) El metotrexato
- d) Traumática
- e) Idiopática

67) Un paciente portador de una enfermedad obstructiva crónica, ingresa durante una exacerbación, taquipneico y con gran disnea. Se solicitan gases arteriales que muestran pH: 7,39, PO₂: 55 mmHg, PCO₂: 49mmHg. Se inicia oxígeno al 28%, evolucionando con deterioro de la función respiratoria. Al examen se ve sudoroso, vigil, con cianosis y se controlan nuevos gases con pH: 7,26, PaO₂: 46 mmHg, PaCO₂: 67 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el oxígeno
- b) Administrar hidrocortisona endovenosa
- c) Realizar nebulizaciones con salbutamol, cada 20 minutos, por 3 veces
- d) Realizar apoyo ventilatorio no invasivo
- e) Intubar y conectar a ventilador mecánico

68) ¿Qué fármacos son más eficaces para el tratamiento de los síntomas en la uropatía obstructiva baja?

- a) Alfabloqueantes
- b) Betabloqueantes
- c) Anticolinérgicos
- d) Antiandrogénicos
- e) Diuréticos

69) Una niña de 10 años consulta por un cuadro de baja de peso de algunas semanas de evolución, asociada a nerviosismo, mal rendimiento escolar y dificultad para dormir. Al examen físico se observa temblor fino de extremidades y taquicardia.

- a) Anorexia nervosa
- b) Depresión
- c) Tumor hipofisiario
- d) Feocromocitoma
- e) Hipertiroidismo

70) Hombre de 24 años, con historia de un mes de malestar abdominal y febrícula ocasional, asociado a diarrea frecuente, que en el último tiempo se ha hecho sanguinolenta. Al examen físico presenta palidez, sensibilidad abdominal y aumento de los ruidos hidroaéreos. En sus exámenes destaca hematocrito: 32%, Hb: 10,1 g/dl, blancos: 13.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis parasitaria
- b) Colitis viral
- c) Colitis bacteriana
- d) Colitis ulcerosa
- e) Enfermedad de Cröhn

71) El mejor indicador del rendimiento asistencial de los médicos que trabajan en un programa de salud en atención primaria es:

- a) La relación entre el total de horas asistenciales y el total de horas trabajadas
- b) El número de pacientes atendidos por hora de trabajo
- c) La relación entre los días trabajados y los días laborales
- d) El total de pacientes atendidos en el año
- e) La relación entre el total de horas trabajadas y el total de horas disponibles

72) Un paciente de 67 años presenta hematoquezia de 3 días de duración, autolimitada. No presentó otros síntomas y el examen físico resulta normal. ¿Cuál es el examen de mayor rendimiento, para determinar la etiología del sangrado?

- a) Tomografía axila computada
- b) Hemograma y pruebas de coagulación
- c) Enema baritado
- d) Colonoscopia
- e) Test de sangre oculta en deposiciones

73) Una mujer se realiza un PAP que es informado como satisfactorio, sin presencia de células neoplásicas ni atípicas, con cambios inflamatorios inespecíficos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo PAP en un año
- b) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- c) Tratar la inflamación y repetir el PAP
- d) Realizar cono frío
- e) Derivar a patología cervical

74) Una mujer de 33 años, cursando embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, presenta salida de líquido claro por genitales. A la especuloscopia se aprecia escaso líquido saliendo por el orificio cervical externo, con test de cristalización positiva. El tacto vaginal muestra un cuello uterino cerrado, duro, en posición posterior. El primer gemelo está en presentación podálica y el segundo en cefálica, y el perfil biofísico de ambos fetos resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el parto en 2 días
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar amniocentesis
- e) Administrar antibióticos corticoides y tocolíticos y mantener conducta expectante

75) Un niño de 3 años presenta claudicación de la marcha y fiebre hasta 40°C. Al examen físico no mueve la extremidad inferior derecha y presenta dolor a la movilización de la cadera derecha. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Perthes
- b) Sinovitis transitoria
- c) Artritis séptica
- d) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- e) Osteomielitis

76) Un paciente que trabaja en un juzgado fue tomado como rehén durante una fuga de reos. Consulta 2 días después por sentirse muy angustiado, con recuerdos muy desagradables de lo acontecido. Refiere que no ha podido llorar y que no quiere volver a su trabajo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo ansioso
- b) Trastorno por estrés postraumático
- c) Trastorno por estrés agudo
- d) Depresión
- e) Trastorno disociativo

77) Un paciente de 74 años presenta astenia, dolor cervical y dorsal alto, con dificultad para incorporarse. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes se constata un hematocrito de 32%, blancos y plaquetas normales, VHS: 90 mm/h, CK normales, factor reumático (-), ANCA (-), ANA positivo en dilución 1/40. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Micropoliangéitis
- c) Granulomatosis de Wegener
- d) Polimiositis
- e) Polimialgia reumática

78) Un niño de 11 años presenta rinorrea purulenta, cefalea y malestar general, evolucionando con enrojecimiento periocular derecho, con proptosis y oftalmoplejia de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis preseptal
- b) Celulitis orbitaria
- c) Pansinusitis
- d) Mucormicosis
- e) Dacriocistitis aguda

79) Un paciente de 64 años consulta por dolor abdominal, asociado a distensión abdominal progresiva, sin eliminación de deposiciones en las últimas horas. Al examen físico presenta un abdomen distendido, doloroso difuso, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se solicita radiografía de abdomen simple que muestra dilatación de las asas intestinales, con niveles hidroaéreos y sin presencia de gas en el colon. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis pseudomembranosa
- b) Perforación de úlcera péptica
- c) Cáncer de colon
- d) Obstrucción intestinal
- e) Colitis ulcerosa

80) Una paciente embarazada a término ingresa en trabajo de parto. Al examen presenta dinámica uterina de 3 CU en 10 minutos, dilatación completa, feto en posición OIIA, 2 cm por sobre las espinas ilíacas, con membranas rotas y líquido amniótico claro. El monitoreo fetal muestra desaceleraciones variables, con variabilidad normal. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar el parto monitorizado
- b) Realizar cesárea
- c) Realizar extracción con forceps
- d) Realizar amnioinfusión
- e) Realizar tocólisis de urgencia

81) Un recién nacido presenta cianosis que no responde a oxígeno al 100%. Al examen físico se observa cianosis generalizada, con examen pulmonar normal y no se ausculta soplos. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Coartación aórtica
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Transposición de grandes vasos

82) ¿Cuál es el mejor examen para seguir la evolución del derrame pericárdico, durante una pericarditis aguda?

- a) Ecocardiografía
- b) Examen clínico
- c) Electrocardiograma
- d) TAC de tórax
- e) Radiografía de tórax

83) Un niño de 7 años consulta por un cuadro de dolor abdominal, artralgias de rodillas, aparición de un rash en los muslos y piernas y hematuria en una oportunidad. Al examen físico se aprecia el rash con lesiones palpables, que no blanquean con la compresión. En sus exámenes destaca hematuria con 15% de dismorfia. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia
- b) Meningococcemia
- c) Púrpura de Schoenlein Henoch
- d) Glomerulonefritis postinfecciosa
- e) Síndrome hemolítico urémico

84) Una paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 2 hace 3 meses, en tratamiento con dieta bien llevada, persiste con glicemias elevadas. La hemoglobina glicosilada resulta en 8,3%. ¿Cuál es el tratamiento que debe indicarse?

- a) Glibenclamida
- b) Metformina
- c) Metformina / Glibenclamida
- d) Insulina
- e) Mejorar el cumplimiento dietético y controlar en 3 meses

85) Una paciente diabética tipo 2, con control irregular, presenta dolor perianal y fiebre. Al examen físico está febril hasta 38,2°C, con presión arterial y pulso normales. Se aprecia una zona aumentada de volumen, eritematosa en la región perianal y el tacto rectal resulta muy doloroso, palpándose una zona abombada y dolorosa en la pared del recto. Se solicitan exámenes donde destaca un hemograma con hematocrito: 44%, leucocitos: 16.500, plaquetas: 189.000. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibioterapia
- b) Realizar drenaje inmediato
- c) Derivar para resolución quirúrgica
- d) Realizar baños de asiento
- e) Solicitar colonoscopia

86) Una mujer de 26 años sufre caída apoyándose en la mano derecha, con el codo en extensión. Evoluciona con dolor e impotencia funcional del codo, asociado a leve aumento de volumen. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura supracondílea
- b) Luxación de codo
- c) Fractura de olécranon
- d) Fractura de cúpula radial
- e) Fractura de epitroclea

87) Un niño de 2 años presenta un exantema popular generalizado, con compromiso de palmas y plantas. Refiere antecedente de cuadro febril de 5 días de evolución. Presenta inyección conjuntival bilateral y la boca está eritematosa, con lengua en fresa. El diagnóstico más probable es:

- a) Exantema súbito
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Infección por citomegalovirus
- d) Escarlatina
- e) Enfermedad de Kawasaki

88) La auscultación de un tercer ruido (R3) en un paciente cursando con un infarto agudo al miocardio, es sugerente de:

- a) Rotura del músculo papilar
- b) Infarto subendocárdico
- c) Infarto de ventrículo derecho
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Bloqueo AV

89) ¿Cuál de los siguientes agentes se ha demostrado capaz de reducir la mortalidad y la aparición de un nuevo infarto, cuando se administra a pacientes que han sufrido un infarto de miocardio?:

- a) Nifedipino.
- b) Verapamilo.
- c) Nitroglicerina.
- d) Betabloqueantes.
- e) Digoxina.

90) ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos NO apoyaría el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva en miembros inferiores?:

- a) Fasciculaciones.
- b) Atrofia muscular.
- c) Signo de Babinski.
- d) Hipo o arreflexia.
- e) Hipotonía.

Respuestas:

Prueba 3 EUNACOM 2009

PRIMERA PARTE

1	B
2	B
3	C
4	C
5	D
6	B
7	B
8	A
9	D
10	C
11	C
12	E

SEGUNDA PARTE

1	C
2	A
3	C
4	B
5	D
6	A
7	C
8	E
9	B
10	D
11	D
12	D

13	D	13	D
14	C	14	A
15	E	15	A
16	E	16	D
17	D	17	B
18	E	18	C
19	D	19	B
20	A	20	C
21	D	21	C
22	B	22	B
23	B	23	C
24	B	24	C
25	E	25	B
26	A	26	D
27	D	27	E
28	A	28	E
29	B	29	C
30	C	30	C
31	B	31	D
32	B	32	B
33	E	33	C
34	B	34	D
35	C	35	D
36	C	36	B
37	B	37	C
38	D	38	B
39	C	39	E
40	C	40	D
41	A	41	E
42	A	42	E
43	A	43	A

44	D	44	D
45	C	45	A
46	B	46	A
47	C	47	E
48	D	48	C
49	C	49	A
50	A	50	E
51	E	51	B
52	D	52	D
53	C	53	E
54	E	54	C
55	D	55	E
56	D	56	A
57	D	57	E
58	D	58	A
59	B	59	B
60	A	60	B
61	E	61	D
62	C	62	E
63	C	63	A
64	A	64	B
65	D	65	B
66	C	66	B
67	D	67	D
68	D	68	A
69	B	69	E
70	D	70	D
71	E	71	B
72	E	72	D
73	B	73	A
74	B	74	C

75	E	75	C
76	B	76	C
77	D	77	E
78	D	78	B
79	C	79	D
80	E	80	A
81	A	81	E
82	C	82	A
83	C	83	C
84	C	84	B
85	E	85	C
86	B	86	D
87	C	87	E
88	D	88	D
89	D	89	D
90	B	90	C

Ensayo EUNACOM – Prueba 4

1) Los nódulos tiroideos se caracterizan por:

- a) Palparse en relación al cartílago tiroides
- b) Ser dolorosos a la palpación
- c) Ascender con la deglución
- d) Ser fáciles de movilizar
- e) Ser difíciles de visualizar ecográficamente

2) Un paciente diabético, hipertendo, dislipidémico y fumador, en tratamiento con insulina, enalapril, aspirina y atorvastatina, que desde hace 4 meses presenta dolor precordial, que aparece al caminar dos cuadras, lo que le obliga a detenerse, cediendo con el reposo y que dura cerca de 3 minutos. Se solicita un electrocardiograma que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y controlar en un mes
- b) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y solicitar un test de esfuerzo
- c) Realizar coronariografía de urgencia
- d) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y solicitar ecocardiografía
- e) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular e iniciar anticoagulación oral

3) Una paciente de 30 años presenta un cuadro de palpitaciones, disnea, opresión precordial, parestesias y marcada angustia, de instalación relativamente rápida, mientras estaba en el metro. Luego de esa vez ha presentado 3 episodios similares, sin poder identificar un desencadenante claro. Está muy preocupada por lo que le ha pasado, porque cree que podría sufrir un infarto en alguno de esos eventos, razón por la cual evita ir al metro y sale siempre acompañada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de angustia con agorafobia
- c) Trastorno de pánico sin agorafobia
- d) Fobia social
- e) Fobia específica

4) Un niño de 6 años presenta fiebre, odinofagia leve y un exantema que compromete las mejillas y luego se extiende al tronco y a las extremidades, apareciendo como un rash macular eritematoso con tendencia a confluir en patrón reticular. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Eritema infeccioso
- c) Exantema súbito
- d) Rubeola
- e) Escarlatina

5) Una mujer embarazada de 38 semanas, en trabajo de parto, con 3 contracciones uterinas cada 10 minutos, presenta un registro fetal estresante con presencia de desaceleraciones luego de la mayoría de las contracciones uterinas, con un decalaje respecto de ellas, de alrededor de 20 segundos. El tacto vaginal demuestra feto en presentación de vértice, en posición occipito-iliaca anterior, en espinas cero, con dilatación cervical de 10 cm, borramiento del 100% y membranas rotas. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Iniciar aceleración occitócica
- c) Administrar un tocolítico y oxígeno al 100%
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea de urgencia

6) Un paciente de 79 años sufre caída a nivel, quedando con imposibilidad para caminar y mucho dolor. Al examen presenta acortamiento, leve abducción y rotación externa del muslo derecho, con pulsos y sensibilidad distales conservados. Se solicita radiografía de caderas que demuestra fractura de cuello femoral derecho, desplazada (Garden IV). La conducta más adecuada es:

- a) Inmovilizar con yeso pelvipedio y administrar analgesia endovenosa
- b) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar inmovilización con yeso pelvipedio
- c) Iniciar analgesia y antibióticos endovenosos y luego realizar cirugía de resección de la cabeza femoral (Cirugía de Girdlestone)
- d) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar osteosíntesis con tornillo dinámico de cadera (DHS)
- e) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina e instalar prótesis parcial de cadera

7) Un recién nacido de 5 horas de vida, presenta ictericia que afecta la cara y el tronco. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubinemia total
- b) Solicitar pruebas hepáticas, con bilirrubinemia diferenciada
- c) Solicitar bilirrubinemia, hemograma, grupo sanguíneo y Rh, prueba de Coombs directo y hemocultivos
- d) Iniciar fototerapia
- e) Iniciar fototerapia y realizar exangüíneo-transfusión

8) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) La glomerulonefritis aguda postestreptocócica presenta disminución transitoria del complemento
- b) La nefrosis lipoidea se presenta como un síndrome nefrótico puro
- c) El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por ser una insuficiencia renal aguda, con anemia y trombocitopenia
- d) La enfermedad de Berger es la glomerulonefritis más frecuente
- e) La glomerulopatía por cambios mínimos no responde a corticoides

9) La asociación entre un factor de riesgo y una patología se determina preferentemente a través de:

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible porcentual
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Likelihood ratio
- e) Incidencia acumulada

10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La candidiasis vaginal presenta como síntoma preponderante al prurito
- b) La vaginosis bacteriana presenta marcados signos inflamatorios en la pared vaginal
- c) La tricomoniasis vaginal presenta leucorrea verdosa y disuria
- d) La vaginosis bacteriana se caracteriza por mal olor, que suele ser más intenso en los días de menstruación
- e) La cervicitis aguda suele ser causada por gonococo y clamidia

11) Un paciente de 20 años consulta por un cuadro de años de evolución de obstrucción nasal marcada, estornudos, escasa rinorrea serosa, asociada a estornudos frecuentes y prurito nasal. Los síntomas suelen ser mucho más frecuentes durante los meses de primavera y tienden a ceder durante los meses de otoño e invierno. Al examen físico sólo destaca palidez de la mucosa nasal. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada, son respectivamente:

- a) Rinitis alérgica y solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios
- b) Rinitis alérgica e iniciar antihistamínicos orales, solicitando IgE específica plasmática
- c) Rinitis alérgica e iniciar corticoides tópicos nasales
- d) Rinitis vasomotora y solicitar rinomanometría
- e) Rinitis vasomotora e iniciar vasoconstrictores

12) Un paciente de 67 hospitalizado por shock séptico, presenta pérdida de conciencia, constatándose ausencia de respiración y pulso. Se inician ventilaciones y masaje cardíaco y se instala monitor electrocardiográfico. Luego de 5 ciclos continúa sin pulso y el monitor demuestra asistolia. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
- b) Realizar intubación orotraqueal, iniciar ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100% y continuar masaje cardíaco
- c) Administrar adrenalina 1mg por vía endovenosa y continuar con el masaje cardíaco
- d) Instalar marcapasos externo y suspender el masaje cardíaco
- e) Realizar 5 ciclos más de masaje cardíaco y reevaluar

13) Un paciente de 61 años, con antecedente de EPOC, en tratamiento con corticoides y broncodilatadores inhalados presenta aumento de su disnea basal, asociado a fiebre y expectoración abundante. Al examen se aprecia orientado, taquipneico, con FR: 27x', FC: 91x', PA: 140/100 mmHg, SatO₂: 80% a FiO₂ ambiental. Se ausculta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias intensas y estertores bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol y corticoides inhalados, oxígeno a bajas dosis e iniciar antibióticos de amplio espectro
- b) Realizar nebulización con salbutamol, administrando oxígeno a bajas dosis, sin necesidad de corticoides ni de antibióticos
- c) Administrar oxígeno en alta concentración, realizar nebulización con corticoides e iniciar antibióticos orales
- d) Administrar oxígeno al 24%, realizar nebulización con salbutamol, administrar corticoides sistémicos e iniciar antibióticos de amplio espectro endovenosos
- e) Administrar oxígeno a 2 litros por minuto, realizar nebulización con corticoides y broncodilatadores de corta acción e iniciar antibióticos endovenosos

14) Un paciente consulta por dolor epigástrico fluctuante, de carácter urente, que suele ser más intenso en los períodos de ayunas. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con omeprazol
- b) Realizar erradicación de *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar pH-metría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Realizar educación y controlar en un mes

15) Un paciente consulta en el servicio de urgencias, por dolor periocular muy intenso, asociado a rinorrea, epifora y miosis ipsilateral. El dolor suele presentarse diariamente durante la tarde, desde hace 2 días, durando algunos minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amitriptilina
- b) Solicitar resonancia magnética cerebral
- c) Administrar AINEs más corticoides endovenoso
- d) Administrar sumatriptán subcutáneo y oxígeno al 100%
- e) Solicitar radiografía de tórax, en busca de un tumor pulmonar

16) Un paciente es ingresado para una colecistectomía de urgencia, debido a una colecistitis aguda. Se decide manejarlo con anestesia general. La conducta más adecuada, para el manejo de la vía aérea, es:

- a) Administrar un inductor, realizar maniobra de Sellick, ventilar con ambú, provocar relajación pulmonar con succinilcolina y realizar intubación orotraqueal
- b) Preoxigenar, administrar un inductor, realizar maniobra de Sellick, provocar relajación pulmonar con succinilcolina y realizar intubación orotraqueal
- c) Administrar un inductor, ventilar con ambú, provocar relajación pulmonar con rocuronio, realizar maniobra de Sellick y realizar intubación orotraqueal
- d) Preoxigenar, provocar relajación pulmonar con rocuronio, administrar un inductor y realizar intubación orotraqueal
- e) Preoxigenar, provocar relajación pulmonar con succinilcolina, ventilar con ambú, administrar un inductor y realizar intubación orotraqueal

17) Paciente de 20 años, con menstruaciones previas irregulares, presenta atraso menstrual de 6 semanas por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal que no muestra saco embrionario intrauterino. Sólo se observa endometrio engrosado, sin líquido libre peritoneal. Se controlan niveles de gonadotropina coriónica (HCG,) cuyo resultado es 1.000 UI/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevos niveles de HCG y ecografía transvaginal en 2 días
- b) Indicar metotrexato
- c) Resolver quirúrgicamente, mediante laparoscopia
- d) Resolver quirúrgicamente, mediante laparotomía
- e) Dejar evolución espontánea, sin necesidad de nuevos controles ni tratamientos

18) Un paciente de 66 años se realiza exámenes de rutina, que demuestran una anemia moderada, con hematocrito de 28%, mactocítica, con VCM de 105 fl, asociadas a trombocitopenia y leucopenia, ambas leves con 95.000 plaquetas y 3.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. El examen físico no aporta mayor información. Se inicia tratamiento con hierro, vitamina B12 y folatos por vía oral y se controla un nuevo hemograma a los 60 días, que no muestra cambios significativos respecto al inicial. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de eritropoyetina
- b) Iniciar eritropoyetina
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Iniciar vitamina B12 y hierro, por vía parenteral
- e) Iniciar corticoides orales

19) Una mujer de 67 años presenta astenia y artralgias de una semana de evolución, asociado a fiebre intermitente. Hace 2 días comienza con marcado decaimiento, oligoanuria y hematuria. Al examen físico sólo se aprecian algunas lesiones eritematosas pequeñas en la piel de las extremidades inferiores. En sus exámenes destaca creatinina de 6,7 mg/dl, proteinuria escasa y hematuria con un 20% de dismorfia. Los ANA resultan negativos y los ANCA resultan positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Panarteritis nodosa
- b) Púrpura de Schoenlein Henoch
- c) Lupus eritematoso sistémico
- d) Poliangeítis microscópica
- e) Granulomatosis de Wegener

20) Un paciente sufre un atropello, con golpe en el tórax y evolucionando con intensa disnea. Al examen físico se observa FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, SatO₂: 83%. Destaca examen pulmonar con murmullo pulmonar conservado, simétrico y con crépitos difusos, mayores a izquierda. El examen cardíaco no presenta alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax
- b) Hemotórax
- c) Contusión pulmonar
- d) Tórax volante
- e) Parálisis frénica

21) Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Paracetamol
- b) Prednisona
- c) Ciclofosfamida + corticoides
- d) Alopurinol más AINEs
- e) Metotrexato

22) Un paciente de 39 años consulta por fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución, con marcado compromiso del estado general, a lo que se le ha agregado dolor torácico derecho, con tope inspiratorio. Al examen físico presenta signos vitales y saturación arterial de oxígeno normales, pero hay disminución del murmullo pulmonar en la base derecha y se auscultan crepitaciones localizadas en ese sector. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un área de condensación en el lóbulo inferior derecho, asociado a un derrame pleural moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con amoxicilina oral y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento
- b) Enviar a domicilio con amoxicilina más ácido clavulánico oral, indicando control en caso de empeoramiento
- c) Hospitalizar, realizar toracocentesis, con análisis de líquido pleural e iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar, instalar un tubo pleural e iniciar cefotaximo endovenoso
- e) Hospitalizar, administrar diuréticos, iniciar una cefalosporina de tercera generación endovenosa y controlar con nueva radiografía de tórax en 24 horas.

23) Una paciente presenta amenorrea secundaria a una falla ovárica prematura de origen autoinmune. La prueba de progesterona y la prueba de estrógenos más progesterona resultarán respectivamente:

- a) Positiva y positiva
- b) Positiva y negativa
- c) Negativa y positiva
- d) Negativa y negativa
- e) No podrán ser realizadas

24) Un recién nacido de 4 días de vida, nacido prematuro a las 33 semanas, presenta desde algunas hora dificultad para regular la temperatura corporal y debilidad para alimentarse. Al examen presenta tono muscular disminuido y debilidad del reflejo de succión. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis cerebral
- b) Hipoglicemia
- c) Hipocalcemia
- d) Sepsis
- e) Síndrome de Guillain Barré

25) Un paciente de 65 años, sin antecedentes de importancia, presenta un tumor renal ecográfico de 6 cm, sólido, en el riñón derecho, diagnosticado en el estudio de una hematuria indolora. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis que no visualiza adenopatías sospechosas ni invasión vascular. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Iniciar quimioterapia preoperatoria y resolver quirúrgicamente en una etapa posterior
- c) Iniciar radioterapia preoperatoria y resolver quirúrgicamente en una etapa posterior
- d) Iniciar quimioterapia y radioterapia
- e) Realizar nefrectomía parcial

26) En un ensayo clínico se administran anticoagulantes orales a 100 pacientes diagnosticados de trombosis venosa profunda y se administra heparina de bajo peso molecular a otros 100 pacientes. En el grupo con anticoagulante oral se producen 5 casos de hemorragias graves, mientras que en el grupo de heparina se producen 2. Así el riesgo relativo de hemorragias graves al usar anticoagulantes orales es:

- a) 3
- b) 2,5
- c) 1,4
- d) 0,6
- e) 0,25

27) Una paciente de 46 años presenta un cuadro de astenia y edema de EEII, progresivo, de 3 meses de duración. Al examen destaca hepatomegalia, edema blando de extremidades inferiores e ingurgitación yugular, con colapso "x" prominente en el pulso venoso. El examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda
- b) Miocardiopatía restrictiva
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Cardiopatía hipertensiva
- e) Pericarditis constrictiva

28) Un paciente de 45 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta de 4 semanas de evolución, asociado a fiebre intermitente, baja de peso y sudoración nocturna. En sus exámenes se aprecia anemia normocítica, con elevación de la VHS y leucocitosis de 11.000 células/mm³. La radiografía de tórax muestra bandas de fibrosis y retracción, asociadas a paquipleuritis en ambos ápices pulmonares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar espirometría basal y postbroncodilatador
- b) Solicitar fibrobroncoscopia y realizar biopsias bronquiales
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar baciloscopías de expectoración y cultivo para bacilo de Koch
- e) Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro

29) Un paciente cirrótico por consumo de alcohol ingresa por desorientación y fiebre. Al examen se constata ascitis moderada, ictericia y asterixis. Se decide realizar paracentesis diagnóstica, que da salida a líquido amarillo, transparente, con recuento celular de 490 células por mm³, con 90% polimorfonuclear. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar evaluación por cirujano.
- b) Realizar paracentesis evacuadora, asociada a antibióticos endovenosos.
- c) Iniciar Cefotaximo, sin evacuar la ascitis
- d) Administrar lactulosa, a fin de lograr 2 a 3 deposiciones diarias
- e) Administrar cristaloides endovenosos, asociados a terlipresina

30) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele encontrarse en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria?

- a) Hiperpigmentación
- b) Hipotensión
- c) Hipoglicemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipokalemia

31) Un paciente sufre un trauma lumbar, al caer de altura, presentando incontinencia urinaria. Al examen destaca anestesia en silla de montar de la zona perineal. La movilidad y sensibilidad de las extremidades inferiores son normales. El sitio más probable de la lesión es:

- a) Asta anterior de la médula
- b) Haz corticoespinal
- c) Haz espinotalámico
- d) Cauda equina
- e) Cono medular

32) Un paciente de 57 años, diabético, hipertenso, con antecedente de una fibrilación auricular crónica, en tratamiento con acenocumarol y betabloqueo, presenta fatigabilidad y palidez. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que demuestran un electrocardiograma en fibrilación auricular a 64 latidos, por minuto, sin otras alteraciones y un hemograma, con plaquetas y leucocitos normales, pero con hematocrito: 24%, Hemoglobina: 8,1 g/dl, VCM: 69 ft, HCM: 24 pg. El frotis sanguíneo presenta anisocitosis e hipocromía. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Anemia por déficit de folatos
- d) Anemia por hipotiroidismo
- e) Anemia hemolítica

33) Un paciente de 24 años es una persona solitaria que trabaja en una empresa de despacho de encomiendas. Sus compañeros de trabajo refieren que es muy apático, afectivamente plano y que tiene algunas ideas de que puede comunicarse con Dios. Él refiere que es el mesías y que Dios le ha encomendado la salvación del mundo y que le dice quiénes son buenos espíritus y quiénes malos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Delirium
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

34) Un paciente con hipertrigliceridemia de hasta 800 mg/dl, con tratamiento irregular con gemfibrozilo, consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos. El dolor es epigástrico y se irradia al dorso. Al examen físico presenta dolor a la palpación, muy intensa, con resistencia muscular en la zona. Se solicitan exámenes que muestran leucocitosis, hematocrito normal, glicemia de 197 mg/dl, protrombinemia de 86%, SGOT de 57 UI/l, bilirrubinemia de 2,3 mg/dl, calcemia de 9,1 mg/dl, natremia de 135 mEq/l, kalemia de 4,6 mEq/l, amilasemia de 546 UI/l, creatinina de 1,8 mg/dl y BUN de 41 mg/dl. La ecografía abdominal no es capaz de identificar alteraciones y es informada con presencia de asas intestinales con gas, que dificulta la visualización ecográfica. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar régimen cero, administrar cristaloides y analgésicos por vía endovenosa
- b) Resolver de manera quirúrgica de inmediato
- c) Solicitar radiografía de abdomen en posición de pie
- d) Iniciar cristaloides, analgésicos y antibióticos por vía endovenosa
- e) Indicar régimen hídrico e insistir en el adecuado uso del hipolipemiente

35) Un paciente presenta dolor lumbar de inicio súbito, que inició al movilizar unos muebles y que se irradia por la cara anterior del muslo y la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. Al examen físico destaca disminución del reflejo rotuliano. La raíz comprometida es:

- a) L1
- b) S1
- c) L2
- d) L4
- e) L5

36) Una mujer de 25 años es muy ordenada en su casa y en el trabajo. Suele seguir muchos rituales para sus actividades y es muy preocupada de los detalles. Además es frecuente que guarde muchas cosas que podrían ser consideradas inútiles, por la posibilidad de que en algún momento las necesite. Sin embargo suele molestarse cuando las cosas no se hacen a su modo, lo que le ha traído malas relaciones con algunos de sus compañeros de trabajo. Además, muchas veces ha debido postergar la entrega de algunos trabajos, ya que pierde mucho tiempo en los detalles. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad obsesiva compulsiva
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Manía
- d) Histeria
- e) Trastorno disociativo

37) La adrenarquia se caracteriza por:

- a) Aparición de vello púbico
- b) Aumento de la velocidad de crecimiento
- c) Inicio de la fertilidad
- d) Olor axilar adulto
- e) Pigmentación cutánea

38) Una mujer de 40 años, cursando su cuarto embarazo, de 12 semanas, presenta presión arterial cercana a 160/100 mmHg en varios controles. El resto del examen físico no presenta alteraciones y sólo presenta proteinuria cualitativa leve (una +). La ecografía obstétrica no presenta alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo molar
- b) Preclamsia moderada
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Hipertensión arterial crónica
- e) Preclamsia leve

39) Respecto a la endometriosis es VERDADERO que:

- a) El uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo
- b) Habitualmente se diagnostica mediante ecografía
- c) Es causa de oligomenorrea
- d) Se asocia al uso de dispositivo intrauterino
- e) Corresponde a tejido endometrial dentro del miometrio

40) ¿Cuál de las siguientes opciones supone una mayor gravedad en una amigdalitis pultácea?

- a) Fiebre
- b) Trismus
- c) Petequias palatinas
- d) Exudado
- e) Úlcera amigdalina

41) Un paciente de 70 años, diabético tipo 2, hipertenso, con antecedente de un infarto al miocardio hace 4 años, con buena función ventricular, en capacidad funcional 1, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, enalapril, aspirina y atorvastatina, presenta dolor precordial intenso, opresivo, asociado a disnea, desde hace 40 minutos. El examen físico constata un paciente taquipneico, bien perfundido, con FC: 101 lpm y PA: 146/100. La auscultación pulmonar demuestra RR3T, con presencia de R4 y . Se solicita electrocardiograma, que demuestra infradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar trombolisis inmediatamente
- b) Solicitar enzimas cardíacas y decidir manejo según resultado
- c) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar test de esfuerzo, una vez estabilizado el paciente
- d) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar coronariografía urgentemente
- e) Administrar aspirina y anticoagular con bomba de heparina, pasando a anticoagulación oral, con cumarínicos, una vez estabilizado el paciente

42) Un lactante de 8 meses consulta por un cuadro de irritabilidad y crisis de llanto de un par de horas de evolución, que cede espontáneamente, dando salida a deposiciones sanguinolentas. Al examen físico se observa en buenas condiciones, con actitud de dolor, especialmente a la palpación del cuadrante inferior derecho del abdomen. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales y rehidratación oral
- b) Hospitalizar, indicar régimen cero e iniciar hidratación endovenosa, asociado a antibióticos de amplio espectro
- c) Solicitar una ecografía abdominal
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Realizar laparotomía exploradora

43) Se realiza serología para VIH a una población de 10.000 habitantes, obteniéndose 100 resultados positivos, confirmándose todos ellos con Western blot. Esto quiere decir que:

- a) La incidencia acumulada de VIH es 1%
- b) La densidad de incidencia de VIH es 1%
- c) La prevalencia de VIH es 1%
- d) La letalidad de VIH es 1%
- e) La tasa de VIH es 1%

44) Una paciente de 33 años presenció como un perro atacaba y mataba brutalmente a otro, lo que le causó mucha impresión. Varias semanas después comienza con pesadillas del suceso y en algunas ocasiones también recuerdos vívidos, mientras está despierta. Ha presentado 2 crisis de pánico, una de ellas al ver un perro similar al que murió. Por eso evita cualquier encuentro con perros. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno agudo por estrés
- b) Fobia específica
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno de pánico

45) Un paciente de 65 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, en tratamiento irregular con omeprazol, consulta por exacerbación importante de los síntomas, que incluso lo despiertan por la noche, a pesar de haber aumentado la dosis de omeprazol a 40 mg/día. El examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el omeprazol y agregar un bloqueador H2
- b) Solicitar manometría esofágica
- c) Realizar tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori*
- d) Solicitar pHmetría de 24 horas
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

46) ¿Cuál de los siguientes trastornos puede ser desencadenado por la administración de insulina en un paciente cursando con una cetoacidosis?

- a) Hiponatremia
- b) Hipokalemia
- c) Acidosis
- d) Alcalosis
- e) Hipocalcemia

47) Un paciente consulta por un cuadro de astenia y palidez y en su hemograma se aprecia la presencia de anemia con hematócrito de 31% y hemoglobina de 10,5 mg/dl, VCM: 112 fl, HCM: 35 pg, blancos: 3.700 por mm³, plaquetas: 80.000 por mm³. Al frotis se describe macrocitosis e hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia de enfermedades crónicas
- b) Mielodisplasia
- c) Mielofibrosis
- d) Leucemia mieloide
- e) Anemia megaloblástica

48) Un paciente de 57 años presenta dolor anal intenso durante la defecación, seguido de rectorragia escasa. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso perianal
- b) Colitis ulcerosa
- c) Hemorroides
- d) Fístula perianal
- e) Fisura perianal

49) Una paciente cursando embarazo de 7 semanas presenta dolor abdominal y metrorragia escasa. La ecografía transvaginal no visualiza gestación intrauterina y la subunidad beta de gonadotropina coriónica humana resulta 3400 UI/l. El diagnóstico más probable es

- a) Aborto completo
- b) Aborto incompleto
- c) Embarazo ectópico
- d) Desprendimiento de placenta
- e) Embarazo molar

50) Una paciente embarazada de 40 semanas de gestación ingresa en trabajo de parto, en dilatación completa, con feto en espaldas -3, dinámica uterina de 4 en 10 minutos y membranas rotas. Luego de 2 horas no se produce descenso y se palpa feto en posición occipito ilíaca derecha transversa. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Realizar extracción con forceps
- c) Realizar rotación manual hasta posición OP
- d) Iniciar aceleración oxitócica
- e) Realizar cesárea

51) En Chile, las principales causas de insuficiencia cardíaca son:

- a) Cardiopatía hipertensiva y valvulopatías
- b) Cardiopatía coronaria y miocardiopatía dilatada
- c) Cardiopatía coronaria y cardiopatía hipertensiva
- d) Cardiopatía hipertensiva y miocardiopatía dilatada
- e) Cardiopatía coronaria y valvulopatías

52) Paciente de 20 años, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea leve. El examen físico sólo demuestra una leve asimetría en la intensidad del murmullo pulmonar entre ambos hemicampos pulmonares. El diagnóstico más probable y la conducta a seguir son respectivamente:

- a) Tromboembolismo pulmonar y solicitar angioTAC de tórax
- b) Neumonía y administrar antibióticos
- c) Neumotórax hipertensivo e instalar toracostomía
- d) Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax
- e) Tromboembolismo pulmonar e iniciar anticoagulación

53) Un paciente de 24 años consulta por dolor epigástrico recurrente, de características urentes. Usted solicita una endoscopia digestiva alta que demuestra una úlcera duodenal activa, sin estigmas de sangrado reciente. El test de ureasa resulta positivo. La medida terapéutica de primera línea es:

- a) Omeprazol en dos dosis diarias, a permanencia.
- b) Tratamiento de erradicación de H. pylori por 7 a 10 días.
- c) Dieta estricta, evitando grasas, condimentos e irritantes y control endoscópico cada 3 meses.
- d) Inhibidores H2 diarios, asociados a antiácidos, según síntomas.
- e) Prohibir el uso de AINEs y asociar un inhibidor de la bomba de protones en dosis única diaria.

54) Mujer de 39 años, consulta por astenia y adinamia de 4 meses de evolución, al que se le ha agregado prurito en las últimas semanas. En su analítica sanguínea destaca elevación de fosfatasas alcalinas por 5 veces el nivel normal y discreta elevación de la bilirrubina, con transaminasas normales. El cuadro clínico descrito y la prueba diagnóstica que debe solicitarse corresponden respectivamente a:

- a) Colangitis esclerosante primaria y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
- b) Colangitis esclerosante primaria y colangioresonancia
- c) Cáncer de páncreas y Colangioresonancia
- d) Colédocolitiasis y CPRE
- e) Cirrosis biliar primaria y anticuerpos antimitocondriales

55) Paciente de 45 años, se realiza perfil lipídico, como chequeo médico, con el siguiente resultado: HDL:34, LDL:210, Triglicéridos:580. La conducta terapéutica inicial debe ser:

- a) Dieta más ejercicio y control en 3 meses
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato
- d) Indicar una asociación entre una estatina y un fibrato
- e) Iniciar ácido nicotínico

56) Paciente de 50 años, consulta por dolor en hipocondrio izquierdo y fiebre recurrente. Al examen destaca esplenomegalia importante. El hemograma muestra Hcto: 39%, Hb: 13mg/dl blancos: 43.000, con 95% de neutrófilos, 24% de baciliformes, 5% de promielocitos y 1% de blastos; recuento de plaquetas: 460.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Fiebre tifoidea
- e) Mielodiplasia

57) De entre las siguientes alternativas, el mejor examen para determinar el origen prerrenal de una insuficiencia renal aguda es:

- a) El examen físico
- b) La relación entre BUN y creatinina
- c) El clearance de creatinina de 24 horas
- d) La fracción excretada de sodio
- e) La orina completa

58) Un hombre de 68 años, diabético, hipertenso, consulta por tos con expectoración y fiebre, a lo que luego se agrega pensamiento desorganizado, inatención, desorientación, alucinaciones visuales e ideas paranoides. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad, cluster A
- b) Psicosis aguda
- c) Demencia
- d) Síndrome confusional agudo
- e) Encefalitis

59) La complicación más frecuente de la apendicectomía es:

- a) Piloilebitis
- b) Infección de la herida operatoria
- c) Dehiscencia de la herida operatoria
- d) Atelectasia
- e) Filtración de contenido intestinal

60) Una mujer de 23 años, consulta para operarse los dedos de las manos, porque los considera horribles, al punto de usar guantes para ocultarlos de los demás. Al examen físico sus dedos son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno dismórfico corporal
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Esquizofrenia
- e) Depresión psicótica

61) Un niño de 10 años presenta una historia de 10 días de sensación de hormigueo y disestesias en las 4 extremidades, asociado a debilidad simétrica, progresiva. Al examen físico destaca arreflexia e hipotonía de las 4 extremidades. ¿Cuál es la complicación más temida de la patología descrita?

- a) Arritmias cardíacas malignas
- b) Insuficiencia respiratoria global
- c) Encefalitis necrotizante
- d) Síndrome de distrés respiratorio
- e) Tetraplejia definitiva

62) Un niño de 2 meses, presenta decaimiento y fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, reactivo, hidratado, bien perfundido, con temperatura de 38,3°C. El examen segmentario resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento
- b) Enviar a domicilio con antipiréticos y antibióticos orales
- c) Solicitar sedimento de orina y urocultivo y decidir manejo según resultados
- d) Solicitar sedimento de orina, urocultivo, hemograma, VHS y PCR y decidir manejo según resultados
- e) Solicitar sedimento de orina, urocultivo, hemograma, VHS, PCR y punción lumbar, e iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro

63) Un recién nacido de 35 semanas de gestación, presenta ictericia hasta los muslos a las 10 horas de vida. No presenta otros síntomas y se observa en buen estado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubina total y directa y decidir manejo según hallazgos
- b) Realizar exanguineotransfusión y fototerapia de inmediato
- c) Iniciar fototerapia sola y asegurar una adecuada hidratación y alimentación
- d) Solicitar bilirrubina plasmática, hemograma, prueba de Coombs directo, grupo-Rh y hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Observar evolución por 24 horas, asegurando una adecuada alimentación e hidratación, sin necesidad de mayor estudio

64) ¿A qué tipo de estudio corresponde el siguiente enunciado?: “Se selecciona una muestra de 5000 pacientes y se les miden los niveles de colesterol y triglicéridos, determinando el número de pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia”

- a) Transversal
- b) Ensayo de campo
- c) Ecológico
- d) Cohortes
- e) Intervención comunitaria

65) Paciente de 25 años, consulta por haber notado aumento de volumen testicular derecho. La ecografía testicular muestra tumor de aspecto sólido en testículo derecho. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Control ecográfico en 6 meses
- b) Realizar biopsia por punción del tumor
- c) Realizar tumorectomía y biopsia
- d) Solicitar marcadores tumorales (AFP, HGC y LDH) y decidir cirugía según resultados
- e) Realizar orquiectomía derecha, por vía inguinal, independientemente del resultado de los marcadores tumorales.

66) Una multipara de 38 años, cursando se cuarto embarazo, de 33 semanas consulta por aparición de prurito palmoplantar intenso, mayor en las noches, asociados a ictericia. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hígado graso agudo del embarazo
- c) Hepatitis viral
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Isoinmunización Rh

67) El punto de reparo de la presentación de cara es:

- a) Fontanela anterior
- b) Ojos
- c) Nariz
- d) Boca
- e) Mentón

68) El factor pronóstico más importante en el cáncer de cuello uterino es:

- a) El tipo histológico
- b) El tamaño de la lesión
- c) La invasión de parametrios
- d) La presencia de síntomas
- e) El serotipo de virus papiloma

69) Paciente de 35 años, consulta por dolor y disminución de la agudeza visual izquierda. Al examen se aprecia ojo rojo izquierdo, de tipo profundo, asociado a miosis y disminución del tono ocular ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Síndrome de Claude Bernard Horner
- c) Parálisis del tercer nervio craneal izquierdo
- d) Uveítis aguda
- e) Infección intraocular (endoftalmitis)

70) Un paciente de 45 años, consulta por fiebre, compromiso del estado general, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta FC: 110x', PA: 156/100, FR:34x', saturación de oxígeno: 88%. El examen pulmonar demuestra crépitos localizados en la mitad superior del hemicampo pulmonar izquierdo, asociado a matidez y aumento de transmisión de la voz. Se solicita radiografía de tórax que demuestra condensación del lóbulo superior izquierdo. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- c) Ceftriaxona endovenosa
- d) Ceftriaxona + eritromicina endovenosas
- e) Claritromicina oral

71) Una paciente de 25 años, presenta diarrea intermitente, desde hace 3 meses, asociado a distensión abdominal y dolor abdominal tipo cólico. Las deposiciones son blandas, con mucosidad, sin esteatorrea ni sangre. En el examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y destaca un abdomen blando, sensible mayor en hipogastrio, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. La causa más probable de la diarrea es:

- a) Viral
- b) Bacteriana
- c) Enfermedad inflamatoria intestinal
- d) Enfermedad celíaca
- e) Funcional

72) Un paciente con antecedente de insuficiencia renal crónica en etapa predialítica presenta en sus exámenes Na:130mEq/l, K:4,7mEq/l, Cl:99mEq/l. Se encuentra en buenas condiciones y su examen físico es normal. El tratamiento más adecuado para su hiponatremia es:

- a) Restricción de agua libre
- b) Aumentar la ingesta de sodio
- c) Agregar un diurético de asa
- d) Administrar suero hipertónico por vía endovenosa
- e) Hemodiálisis

73) Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartílago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio
- b) Iniciar AINEs y alopurinol oral
- c) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados
- d) Iniciar AINEs endovenosos y reposo
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

74) Un paciente de 56 años sufre inversión forzada del pie izquierdo, evolucionando con importante dolor. Al examen se observa edema y equimosis en relación a la zona inframaleolar derecha, con dolor importante a la palpación de dicha zona y a la mayoría de los movimientos del tobillo. La movilidad, sensibilidad y llene capilar distales son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio indicando reposo y analgesia oral
- b) Solicitar radiografías de tobillo
- c) Solicitar TAC de tobillo
- d) Inmovilizar con una bota ortopédica
- e) Inmovilizar con bota corta de yeso, abierta

75) Un paciente de 5 años presenta prurito intenso en las manos, pies, genitales y abdomen, respetando la cara y la espalda. Al examen se observan escoriaciones y descamación en las zonas comprometidas. Entre los dedos de las manos se observan algunos surcos y vesículas perladas. El tratamiento de elección es:

- a) Terbinafina tópica
- b) Permetrina tópica
- c) Lindano tópico
- d) Albendazol oral
- e) Corticoides tópicos

76) Un paciente presenta vértigo de 5 horas de evolución, de inicio súbito, muy intenso, asociado a vómitos, con lateropulsiones a derecha y un nistagmo de reposo, horizontal, con fase rápida a izquierda, muy marcado. No tiene signos cerebelosos, compromiso de otros pares craneales ni alteraciones sensitivas o motoras. No presenta síntomas auditivos. El nistagmo disminuye al pedirle que fije la mirada sobre un punto. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Accidente vascular encefálico cerebeloso
- d) Parálisis vestibular
- e) Infarto de troncoencéfalo

77) ¿Cuál de los siguientes cánceres suele presentar síntomas con mayor precocidad, mejorando considerablemente su pronóstico?

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Cáncer de ovario
- c) Cáncer de mama
- d) Cáncer de endometrio
- e) Cáncer de vagina

78) Un paciente de 70 años presenta fiebre alta, cefalea y desorientación. Al examen físico destacan signos meníngeos positivos y fiebre de 39,4°C. El resto del examen no aporta mayor información. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo turbio, con 10.000 células, con 94% polimorfonucleares, glucosa de 21 mg/dl y proteínas de 134 mg/dl. La tinción de Gram no muestra bacterias. El tratamiento farmacológico de elección es:

- a) Penicilina + Vancomicina
- b) Ceftriaxona sola
- c) Ceftriaxona + Vancomicina
- d) Cefotaximo + Ampicilina
- e) Cefotaximo + metronidazol

79) Una mujer de 62 años, obesa, con antecedente de ovario poliquístico durante su período fértil, presenta metrorragia escasa. A la especuloscopia se constata que la sangre proviene de la cavidad endometrial. El tacto vaginal es normal, al igual que la ecografía transvaginal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar anticonceptivos orales en altas dosis
- b) Solicitar biopsia endometrial
- c) Iniciar estrógenos locales
- d) Solicitar Papanicolau, colposcopia y biopsia cervical
- e) Observar y controlar en 7 días, decidiendo manejo según evolución

80) Traen a una niña de 4 años a su consultorio porque presenta edema en párpados y piernas. Hace tres semanas padeció fiebre, diarrea sanguinolenta y dolor abdominal que desaparecieron espontáneamente. Los exámenes de laboratorio revelan anemia, trombocitopenia leve, electrolitos normales, urea y creatinina elevadas, y proteinuria.

¿Cuál es la causa más probable de este cuadro?

- a) Síndrome nefrótico de comienzo agudo
- b) Enfermedad de Berger
- c) Síndrome urémico hemolítico
- d) Púrpura de Schölein-Henoch
- e) Glomerulonefritis postestreptocócica

81) Una paciente fumadora, multipara de 2, cursando embarazo de 32 semanas consulta por metrorragia y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia metrorragia escasa, oscura y se palpa útero hipertónico. El monitoreo fetal demuestra variabilidad disminuida y desaceleraciones variables complejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Rotura uterina
- d) Rotura de vasa previa
- e) Acretismo placentario

82) El tratamiento de elección para una paciente de 28 años con insuficiencia mitral grave, sintomática, de etiología reumática es:

- a) enalapril.
- b) diuréticos y digitálicos.
- c) valvuloplastia mitral percutánea con balón.
- d) cirugía valvular mitral.
- e) terapia anticoagulante.

83) Un escolar de 11 años consulta por talla baja. El padre mide 173 cm., la madre 156 cm., ambos son sanos. Al examen físico se constata una talla de 120 cm., peso de 19 kg, sin estigmas de genopatía.

¿Cuál es la información más útil para orientar el diagnóstico?

- a) Los antecedentes de crecimiento de la familia.
- b) Su curva de crecimiento.
- c) Sus niveles de T4 y TSH.
- d) Su edad ósea.
- e) Sus niveles de hormona de crecimiento.

84) Paciente hipertenso de 55 años, fumador de 20 cigarrillos/día. Consulta por fiebre de 38°C, tos irritativa y dolor en la base del hemitórax derecho. La radiografía de tórax revela un derrame pleural, cuyo examen citoquímico y bacteriológico muestra:

Proteínas 4 gr/dl, LDH 600 UI (LDH plasma 200 UI), linfocitos 90%, hematíes escasos, no se observan gérmenes con tinción de Gram, baciloscopia (-), células neoplásicas (-). La alternativa diagnóstica más probable es:

- a) Derrame paraneumónico simple (no complicado), tuberculosis
- b) Derrame paraneumónico simple (no complicado), insuficiencia cardíaca
- c) Derrame paraneumónico, no hay información para decidir entre simple y complicado.
- d) Tuberculosis, cáncer, insuficiencia cardíaca
- e) Tuberculosis, cáncer

85) ¿Cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico de la infección aguda por el virus de la hepatitis A?

- a) Anticuerpos IgE anti-virus A
- b) Anticuerpos IgM anti-virus A
- c) Anticuerpos IgG anti-virus A
- d) Reacción de polimerasa en cadena para virus A
- e) Anticuerpos IgA anti-virus A

86) Hombre de 24 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, que consulta por notar aumento de volumen cervical anterior. Trae pruebas de función tiroidea dentro de límites normales y una ecografía de poca resolución que muestra un nódulo sólido de 25 mm en el lóbulo derecho del tiroides. A la palpación el nódulo es de consistencia firme, se moviliza con la deglución y no es doloroso. El resto de la tiroides no está aumentada de tamaño.

¿Cuál es la conducta más apropiada?

- a) Solicitar cintigrama de tiroides
- b) Derivar para punción biopsia del nódulo
- c) Realizar tratamiento de prueba con tiroxina
- d) Medir marcadores tumorales en sangre
- e) Realizar tomografía computada de cuello

87) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta?

- a) Hipocalcemia – Tetania e hiperreflexia
- b) Déficit agudo de tiamina (vitamina B1) – Confusión, ataxia y estrabismo
- c) Hipofosfemia – Psicosis, hemólisis y rabdomiolisis
- d) Hipomagnesemia – Alargamiento del QT y arritmias cardíacas
- e) Hipokalemia – Arritmias, convulsiones y confusión

88) En la evaluación de un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada,

¿Cuál de los siguientes métodos imagenológicos resulta de mayor utilidad para descartar una uropatía obstructiva como causa de la falla renal?

- a) Radiografía renal simple
- b) Pielografía de eliminación minutada
- c) Tomografía axial computarizada con contraste yodado
- d) Ecotomografía abdominal
- e) Ecotomografía prostática transrectal

89) ¿Cuál de los siguientes es el principal factor de riesgo de endocarditis infecciosa intrahospitalaria?

- a) Uso de dispositivos intravasculares
- b) Hospitalización prolongada
- c) Cirugía mayor
- d) Antecedentes de drogadicción endovenosa
- e) Endocarditis previa

90) Paciente ingresa con un cuadro de deshidratación grave asociada a vómitos, precedido de dolor abdominal, baja de peso y astenia. Refiere el antecedente de oscurecimiento de la piel. Al examen físico se encuentra hipotenso.

Además de hidratar al paciente, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- a) Medir cortisol plasmático y administrar hidrocortisona endovenosa
- b) Medir cortisol en orina de 24 h
- c) Realizar un test de estimulación con ACTH
- d) Medir ACTH plasmático
- e) Iniciar terapia con prednisona

SEGUNDA PARTE

1) Paciente hombre de 75 años presenta marcha vacilante y caídas recurrentes desde hace 6 meses. Hace tres meses se agrega incontinencia urinaria y deterioro cognitivo acelerado. Al examen físico destaca equilibrio estático conservado, con alteración de la marcha.

El diagnóstico más probable es:

- a) hidrocefalia normotensiva.
- b) demencia vascular.
- c) enfermedad de Alzheimer.
- d) depresión mayor.
- e) síndrome post caída.

2) ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye una contraindicación para la cirugía del cáncer gástrico?

- a) Presencia de células neoplásicas en el líquido ascítico
- b) Ganglios perigástricos aumentados de tamaño en la ecografía
- c) Lesión tipo Bormann IV en la radiografía de estómago
- d) Desnutrición calórico proteica
- e) Masa abdominal palpable

3) Paciente de 64 años consulta por aumento de frecuencia de la micción, nicturia, disminución del calibre del chorro miccional, con cierto grado de disuria de esfuerzo, desde hace 6 meses.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer prostático
- b) Estenosis uretral
- c) Hiperplasia benigna prostática
- d) Litiasis vesical
- e) Vejiga neurogénica

4) Durante una visita para un control de rutina, usted lleva a una lactante hacia la posición sentada, la cabeza sigue al tronco sin retrasarse. Mantiene la posición sentada con sus brazos apoyados hacia delante sobre la camilla. Coge objetos y los pasa de una mano a otra estando acostada.

¿Cuál es la edad más probable de la niña?

- a) 4 meses
- b) 6 meses
- c) 8 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

5) Lactante de 10 meses de edad, febril y cuyo examen faríngeo muestra múltiples vesículas y úlceras en paladar blando, úvula y faringe posterior.

¿Cuál es el diagnóstico?

- a) Estomatitis herpética
- b) Herpangina
- c) Faringitis viral
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Candidiasis oral

6) Paciente múltipara de dos en trabajo de parto, cuyo monitoreo muestra una FC fetal basal de 130/min, buena variabilidad y presencia de aceleraciones.

La rotura artificial de membranas da salida a un líquido con meconio amarillo verdoso.

¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir?

- a) Interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea
- b) Reanimación fetal in útero con reevaluación en 20 minutos
- c) Reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo
- d) Mantener una conducta expectante y permitir que continúe el trabajo de parto
- e) Interrupción inmediata por la vía más expedita

7) Paciente de 46 años, esterilizada y con reglas irregulares, presenta una metrorragia profusa con coágulos.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Anticonceptivos orales en altas dosis
- b) Progestágenos en altas dosis
- c) Legrado biopsico-terapéutico
- d) Histerectomía de urgencia
- e) Ablación endometrial bajo histeroscopia

8) El trastorno bipolar se caracteriza por:

- a) presencia de episodio maníaco, hipomaníaco o mixto
- b) presencia de episodios maníacos y depresivos mayores
- c) fluctuación del ánimo entre depresión y manía
- d) antecedente de al menos un episodio depresivo mayor
- e) presencia de distimia

9) Paciente joven, sin patología previa ni adicciones. Luego de un problema familiar grave, presenta bruscamente un episodio psicótico de 2 días, con incoherencias, ideas delirantes y alucinaciones. Sin antecedentes psiquiátricos personales ni familiares. Al término del episodio no se aprecia psicopatología mayor, sólo preocupación importante por lo sufrido, ya que no se lo explica fácilmente.

Se trata de un paciente con:

- a) psicosis esquizomorfa con pronóstico reservado
- b) un episodio psicótico breve que hay que observar ya que es probable que se trate de un trastorno delirante somático de pronóstico incierto
- c) psicosis reactiva breve de mal pronóstico, ya que ha presentado alteración del pensamiento en su contenido y en su forma
- d) psicosis reactiva breve de buen pronóstico
- e) un episodio psicótico alucinatorio delirante que debe ser controlado por tiempo prolongado

10) ¿Qué sucede cuando se enfatiza la prevención y promoción de la salud?

- a) Aumentan las secuelas, pero baja la incidencia
- b) Aumentan las secuelas, pero baja la prevalencia
- c) Requiere menor cobertura de la intervención
- d) Disminuye el costo pero aumenta la prevalencia
- e) Mejora el costo/efecto de la intervención

11) Hombre de 62 años, obrero de la construcción, bebedor y fumador en alto grado, presenta una lesión erosiva con microcostras, de un año de evolución, asintomática, en labio inferior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Carcinoma espinocelular
- b) Candidiasis crónica
- c) Carcinoma basocelular
- d) Herpes labial recidivante
- e) Queilitis de contacto

12) Paciente de 66 años, diabético e hipertenso bien controlado. Refiere visión de cuerpos volantes (miodesopsias), fotopsias y disminución de la visión periférica en una zona del campo visual.

¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico estabilizado.
- b) Degeneración macular senil.
- c) Desprendimiento de retina.
- d) Retinopatía hipertensiva.
- e) Retinopatía diabética.

13) Mujer de 32 años que consulta por haber comenzado una hora antes con palpitaciones. Se realiza un ECG que muestra taquicardia regular de QRS estrecho a 180 l.p.m. Al aplicar masaje en el seno carotídeo se produce una disminución repentina de la frecuencia ventricular causada por la terminación de la taquicardia. ¿Qué tipo de arritmia padece esta paciente, con más probabilidad?:

- a) Taquicardia sinusal.
- b) Fibrilación auricular.
- c) Taquicardia ventricular.
- d) Taquicardia por reentrada de nodo AV.
- e) Taquicardia auricular con bloqueo.

14) ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas NO indica una patología bronquial obstructiva?:

- a) Disminución de la capacidad pulmonar total.
- b) Aumento del volumen residual pulmonar.
- c) Disminución de la relación FEV1/FVC.
- d) Disminución de la capacidad vital.
- e) Depresión del FEF 25-75.

15) Hombre de 56 años, bebedor de más de 150 g. de etanol al día, sin antecedentes conocidos de hepatopatía. Ingresa en Urgencias por hematesis copiosa, apreciándose en la endoscopia varices esofágicas de grado III que se esclerosan con éxito. En la exploración se aprecia ascitis abundante y el olor del aliento es claramente etílico. Aunque varias de las medidas posibles a tomar que a continuación se mencionan, pueden ser necesarias o convenientes en un momento dado. ¿Cuáles son especialmente importantes desde el primer momento?:

- a) Vitamina B12 + tiapride i.v.
- b) Vitamina B1 + ciprofloxacino i.v.
- c) Transfusión de hematíes + vitamina K i.v.
- d) Vitamina A + balón de Sengstaken.
- e) Ácido fólico + vasopresina i.v.

16) Una mujer de 30 años refiere un cuadro de mialgias, fiebre, palpitaciones, nerviosismo y dolor en el cuello. La velocidad de sedimentación globular está elevada, los niveles séricos de triiodotironina (T3) y tiroxina (T4) están elevados y los de tirotropina (TSH) están bajos. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para esta paciente?:

- a) Corticosteroides y antitiroideos.
- b) Antiinflamatorios no esteroideos y antitiroideos.
- c) Sólo antitiroideos.
- d) Antiinflamatorios no esteroideos y betabloqueantes.
- e) Sólo betabloqueantes.

17) Un paciente de 40 años, sin antecedentes relevantes, es traído a urgencias por haber presentado desviación de la cabeza hacia la izquierda, convulsiones que se iniciaron en miembros izquierdos y se generalizaron enseguida a los cuatro miembros, con pérdida de conciencia, incontinencia vesical y estado confusional de una media hora de duración. Independientemente de los hallazgos de la exploración clínica y la analítica clínica de rutina, debería realizarse con premura como primera medida:

- a) TAC cerebral.
- b) Determinación de alcoholemia.
- c) Determinación de opiáceos en sangre y orina.
- d) Electroencefalograma.
- e) Punción lumbar.

18) La causa más frecuente de metrorragia en la edad fértil es:

- a) Endometriosis
- b) Miomas
- c) Disfuncional
- d) Cáncer de cuello uterino
- e) Patología maligna de endometrio

19) ¿Cuál de los siguientes factores influye más a la hora de tomar la decisión de iniciar tratamiento antirretroviral?:

- a) Carga viral de VIH-1 en sangre
- b) Cifra de linfocitos CD4.
- c) Cociente linfocitos CD4/CD8.
- d) Presencia de linfadenopatía generalizada.
- e) Adherencia prevista del paciente al tratamiento.

20) Ante una mujer de 80 años con cefalea hemicraneal derecha incapacitante y claudicación al masticar. El primer estudio complementario que hay que solicitar, entre los siguientes, es:

- a) Hemograma, VSG y bioquímica sérica rutinaria.
- b) Tomografía computada de cráneo.
- c) Resonancia magnética de cráneo.
- d) Rx de la articulación témporo-mandibular.
- e) Ortopantomografía mandibular.

21) Un paciente de 70 años de edad, en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos por artrosis, acude a Urgencias por un cuadro de dolor abdominal de instauración brusca en epigastrio irradiado a fosa ilíaca derecha e íleo paralítico, presentando a la exploración clínica abdomen en «tabla». El examen de la sangre muestra leucocitosis y las pruebas de imagen no son concluyentes. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más adecuada?:

- a) Colocación de sonda nasogástrica, sueros y antibióticos.
- b) Alimentación parenteral, omeprazol i.v., antibióticos.
- c) Cirugía abdominal accediendo por incisión de Mc Burney.
- d) Cirugía abdominal accediendo por laparotomía media.
- e) Apendicectomía laparoscópica.

22) ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre el Deli-rium Tremens es la correcta?:

- a) Se trata del estado peculiar de intoxicación producido por el consumo de alcohol.
- b) Se caracteriza por la aparición de conductas impulsivas tras el consumo de una pequeña cantidad de alcohol.
- c) Es un cuadro clínico con elevado índice de complicaciones psiquiátricas y con pocas complicaciones orgánicas.
- d) Su tratamiento de elección son las benzodiazepinas.
- e) Aparece con mayor frecuencia entre los hombres alcohólicos a partir de los 50 años.

23) ¿Cuáles son los actos obsesivos más frecuentes en el trastorno obsesivo-compulsivo?:

- a) Comprobaciones y rituales de limpieza.
- b) Recuentos mentales.
- c) Evitar pisar las cruces en las baldosas.
- d) Jaculatorias repetitivas de conjura.
- e) Acumulación y colección de objetos.

24) Un recién nacido con grave distress respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pulmón poliquístico.
- b) Malformación adenomatoidea.
- c) Quiste pulmonar multilocular.
- d) Hernia diafragmática.
- e) Agenesia bronquial segmentaria.

25) Lactante de 2 meses de edad que hace tres días comenzó con mocos nasales acuosos, tos y estornudos. Desde ayer presenta taquipnea con 60 rpm, tiraje intercostal con aleteo nasal. Rechaza la alimentación. En Urgencias observan distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias y espiratorias y algunos crepitantes bilaterales. Una Rx de tórax muestra hiperinsuflación bilateral con una atelectasia laminar y corazón pequeño. Presenta: pH 7,24; pCO₂: 58 mmHg; CO₃H: 21 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Bronconeumonía bilateral.
- b) Crisis asmática de origen infeccioso.
- c) Miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva.
- d) Neumonitis intersticial.
- e) Bronquiolitis.

26) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las parasomnias en los niños?:

- a) Las pesadillas son más frecuentes en, el primer tercio del sueño.
- b) En los niños con terrores nocturnos el umbral del despertar es bajo, por lo que es habitual que se despierten durante el episodio.
- c) La edad típica de presentación de los terrores nocturnos es la adolescencia.
- d) Los terrores nocturnos aparecen en el estadio de sueño de ondas lentas.
- e) Es frecuente que los niños con terrores nocturnos recuerden, con angustia durante varios días, el episodio vivido.

27) ¿Por qué es importante estandarizar las tasas de mortalidad por edad?:

- a) Para ofrecer una información más detallada.
- b) Para conseguir tasas específicas por grupos de edad.
- c) Para obtener una cifra real de mortalidad.
- d) Para poder comparar tasas de diferentes lugares eliminando la confusión que genera el factor edad.
- e) Para obtener una medida cruda de la mortalidad.

28) Paciente de 61 años al que en un chequeo de rutina se le encuentra un Antígeno Prostático Específico (P.S.A.) de 6,3 ng/dl. El tacto rectal es normal. ¿Cuál sería, entre las siguientes, la actitud diagnóstica más adecuada?:

- a) TC abdominal para estudio de extensión local.
- b) Ecografía transrectal más biopsia prostática.
- c) Biopsia prostática y de vesículas seminales.
- d) Ecografía vesico-prostática con P.A.A.F.
- e) Actitud expectante. Repetir análisis de P.S.A. pasados dos meses.

29) ¿Cuál de las siguientes lesiones melanocíticas benignas muestra un mayor riesgo de degenerar en melanoma maligno?:

- a) Un nevo azul celular.
- b) Un nevo melanocítico de palmas o plantas.
- c) Un nevo melanocítico congénito gigante.
- d) Un nevo melanocítico muy hiperpigmentado.
- e) Un nevo de Spitz.

30) Gestante de 28 años en la 42 semanas más tres días y antecedentes de otro parto a término. El embarazo ha transcurrido normalmente. Ex-ploración: feto en Occipito Iliaca Anterior, Registro reactivo y cuello favorable. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más recomendable?:

- a) Esperar hasta que se ponga de parto.
- b) Controles cada 48 horas.
- c) Administrar corticoides a la madre e inducir el parto pasadas 48 horas.
- d) Inducir el parto.
- e) Hacer cesárea electiva.

31) Hombre de 50 años que acude a urgencias por cuadro brusco de cefalea, náuseas, y pérdida de visión del ojo derecho. A la exploración destaca amaurosis del ojo derecho, defecto del campo temporal del ojo izdo. y paresia del tercer par craneal derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma de arteria cerebral media derecha.
- b) Apoplejía hipofisaria.
- c) Accidente vascular cerebral isquémico en territorio vertebrobasilar.
- d) Arteritis de la temporal (Horton).
- e) Meningioma del agujero óptico.

32) ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio?

- a) Uso de anticonceptivos orales
- b) Hipertensión arterial
- c) Diabetes
- d) Obesidad
- e) Síndrome de ovario poliquístico

33) Una mujer de 86 años hospitalizada por un accidente cerebrovascular, es dada de alta enviándole a un centro de media estancia para rehabilitación física. A la exploración destaca una pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo grado 4/5 y mínimos déficit sensitivo. En una exploración rutinaria realizada hace 10 meses se detectó fibrilación auricular asintomática. Se realizó ecocardiograma que mostró una aurícula izquierda de 6,5 cm. diámetro. No se inició ningún tratamiento. Tomaba hidroclorotiacida y captopril para hipertensión arterial. Entre los siguientes, ¿cuál es el paso más indicado en el manejo de esta paciente?:

- a) Aspirina 100 mg al día.
- b) Dipyridamol 150 mg al día.
- c) Acenocumarol.
- d) Cardioversión eléctrica.
- e) Ecocardiograma transesofágico para demostrar un trombo auricular.

34) ¿Cuál de los siguientes marcadores de cromosomopatías del primer trimestre tiene más valor?:

- a) Gonadotropina coriónica.
- b) La alfafetoproteína.
- c) La PAPP-A.
- d) La sonolusencia nuchal.
- e) El acortamiento del fémur.

35) El síndrome del «distress» respiratorio del adulto se caracteriza por los siguientes hallazgos:

- a) Hiperpermeabilidad alveolocapilar, infiltrados pulmonares difusos e insuficiencia respiratoria aguda.
- b) Insuficiencia respiratoria crónica agudizada, aumento de la distensibilidad pulmonar y edema agudo de pulmón hemodinámico.
- c) Hipercapnia, infiltrados pulmonares difusos e insuficiencia cardíaca izquierda.
- d) Hipopermeabilidad alveolocapilar, edema agudo de pulmón cardiogénico y aumento de la presión de enclavamiento capilar pulmonar.
- e) Aumento de la presión de enclavamiento capilar pulmonar, anuria y aumento de la distensibilidad pulmonar.

36) Enfermo de 45 años diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica sin historia de hemorragia previa y sin consumo de alcohol desde hace un año. Durante una revisión se realiza una ecografía abdominal que no detecta lesiones focales y una endoscopia en la que se aprecian varices esofágicas de gran tamaño. La radiografía de tórax y el electrocardiograma son normales. ¿Cuál es la medida más adecuada para la prevención de un primer episodio de hemorragia por varices?:

- a) Escleroterapia endoscópica de varices esofágicas.
- b) No es necesaria la prevención por el escaso riesgo de rotura de las varices.
- c) Ligadura endoscópica con bandas elásticas de varices esofágicas.
- d) Administración de betabloqueantes no cardiosselectivos (propranolol, nadolol).
- e) Derivación esplenorrenal distal selectiva de Warren.

37) Varón de 45 años, gran fumador, sin antecedentes previos de enfermedad, diagnosticado dos meses antes de problema pulmonar no precisado. Ingresa de urgencias por deterioro progresivo, durante las dos últimas semanas, de sus funciones cognitivas. La familia niega traumatismo previo. La exploración muestra normotensión arterial y ausencia de edemas. Datos de laboratorio: Na⁺ plasmático 120 mEq/l, osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, glucemia normal, urea 20 mg/dl. Orina: 250 mOsm/kg, Na⁺ 35 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes cuadros es el más probable?:

- a) Insuficiencia suprarrenal crónica.
- b) Diabetes insípida central.
- c) Polidipsia compulsiva.
- d) Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética (SIADH).
- e) Reajuste del osmostato.

38) ¿Cuál de estos medicamentos se utiliza, muchas veces con éxito, en la profilaxis de la migraña?:

- a) El dipiridamol.
- b) La vitamina E.
- c) Las tiacidas.
- d) La amitriptilina.
- e) El clorfibrato.

39) Paciente de 72 años con aceptable estado general. Leucocitos 53.000/microl con linfocitosis del 93%; hemoglobina y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma de bajo grado.
- b) Leucemia linfoide aguda.
- c) Leucemia mieloide aguda.
- d) Leucemia mieloide crónica.
- e) Leucemia linfoide crónica.

40) El tratamiento antibiótico de primera línea para las infecciones del tracto urinario bajas, en el adulto mayor es:

- a) Observación
- b) Cefadroxilo
- c) Ceftriaxona
- d) Levofloxacino
- e) Gentamicina

41) En un varón de 65 años, con un ángor estable, se descubre, durante una exploración física sistemática, una prominente pulsación aórtica en el abdomen. Su médico de cabecera ordena la práctica de una TC abdominal que demuestra un aneurisma aórtico de 3,9 cm de diámetro, en situación infrarrenal. La conducta más recomendable en este caso es:

- a) Aortografía seguida de exploraciones anuales con TC.
- b) Una cuidadosa evaluación del estado cardíaco y reparación electiva del aneurisma si el riesgo es aceptable.
- c) Trombosis inducida del aneurisma y by-pass extraanatómico.
- d) Exámenes ecográficos seriados para valorar el incremento anual en el tamaño del aneurisma.
- e) No es necesario el seguimiento del paciente dado el pequeño tamaño del aneurisma.

42) Son efectos adversos de los opiáceos EXCEPTO:

- a) Compromiso de conciencia
- b) Retención urinaria
- c) Náuseas
- d) Depresión respiratoria
- e) Bradicardia

43) Atendemos a una chica de 16 años que nos cuenta que lleva un tiempo con menos apetito y durmiendo menos ya que le cuesta poder dormirse. Es una buena estudiante, pero en la última evaluación le han quedado cuatro asignaturas y le cuesta concentrarse en los estudios. Los dos últimos fines de semana no ha salido con sus amigas porque no le apetecía y se siente irritada con su familia, aunque no entiende porqué. Tiene dolores de cabeza y a veces le viene la idea de la muerte a la imaginación aunque piensa que no lo haría por sus sentimientos religiosos. Nunca le había sucedido algo parecido. El diagnóstico sería:

- a) Trastorno depresivo mayor.
- b) Trastorno ciclotímico.
- c) Trastorno distímico.
- d) Anorexia.
- e) Episodio depresivo mayor.

44) Un paciente de 24 años trasladado desde 400 km, hace 48 horas, a nuestro hospital, diagnosticado de fractura bilateral de fémures y tibias, ingresado con inmovilizaciones provisionales hasta ser intervenido, inicia bruscamente un cuadro de disnea intensa, petequias generalizadas, estupor y obnubilación. Debemos sospechar:

- a) Neumonía nosocomial con sepsis generalizada secundaria.
- b) Coagulación intravascular diseminada por coagulopatía de consumo.
- c) Tromboembolismo pulmonar masivo.
- d) Shock neurogénico por dolor.
- e) Síndrome de embolia grasa.

45) ¿Cuál de las siguientes es la más importante causa de diarrea grave con deshidratación en lactantes y niños menores de tres años, sobre todo en los países subdesarrollados, pero también en los desarrollados?:

- a) Salmonella.
- b) Rotavirus.
- c) Shigella.
- d) Escherichia coli.
- e) Adenovirus intestinales.

46) Un niño de 12 años sufre pérdida de conciencia breve tras caerse de una bicicleta. Al llegar a Urgencias está orientado y presenta signos de impacto en región parietal derecha. Dos horas más tarde aqueja cefalea de intensidad rápidamente creciente seguida de alteración del nivel de conciencia. La causa más probable del deterioro, entre las siguientes, es:

- a) Contusión cerebral parietal derecha.
- b) Hipertensión intracraneal aguda secundaria a edema cerebral vasogénico.
- c) Hematoma extradural agudo.
- d) Meningitis neumocócica fulminante por brecha meníngea secundaria a fractura de la base craneal.
- e) Hidrocefalia aguda secundaria a hemorragia subaracnoidea postraumática.

47) En un niño de 5 años en anasarca de 20 días de evolución y con una analítica de proteinuria muy selectiva de 6 g/24 horas, sedimento urinario normal, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, acompañando a una creatinina plasmática de 0,6 mg/dl, el diagnóstico más probable será:

- a) Hialinosis focal.
- b) Nefropatía de cambios mínimos.
- c) Nefropatía membranosa.
- d) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica.
- e) Nefropatía de cambios mínimos con insuficiencia renal evolucionada.

48) Está usted realizando un estudio para evaluar una nueva prueba de diagnóstico rápido de infección urinaria. Su patrón de referencia es el urocultivo y los datos encontrados son los siguientes: la prueba es positiva en 100 pacientes (75 con urocultivo positivo y 25 con urocultivo negativo) y negativa en 375 pacientes (125 con urocultivo positivo y 250 con urocultivo negativo). ¿Podría calcular el valor predictivo positivo (VPP) de su nueva prueba?:

- a) 75%.
- b) 33%.
- c) 50%.
- d) 37,5%.
- e) 66,6%.

49) ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado en una mujer de 55 años, menopáusica desde hace uno por habersele practicado una histerectomía con doble anexectomía, que padece un síndrome climatérico importante?:

- a) Calcio oral y benzodiacepinas.
- b) Estrógenos y progestágenos 19 norderivados.
- c) Estrógenos y veralipride.
- d) Estrógenos y progesterona natural.
- e) Estrógenos exclusivamente.

50) Una paciente secundigesta, con antecedente de parto vaginal anterior, ingresa en su 34ª semana de gestación por parto en curso. Mediante tacto vaginal se diagnostica dilatación de 6 cm y presentación pelviana (nalgas puras), variedad S.I.I.A., en II plano. Ecográficamente se estima que el peso fetal estará comprendido entre 2.100 y 2.300 g. Señale la conducta obstétrica correcta:

- a) Permitir la evolución espontánea evitando la ayuda manual durante el periodo expulsivo.
- b) Dejar evolucionar hasta periodo expulsivo y practicar maniobras de ayuda manual para abreviar el periodo expulsivo tras la salida del ángulo inferior de la escápula.
- c) Permitir la evolución hasta periodo expulsivo y finalizar éste mediante aplicación de forceps para evitar la distocia de cabeza última.
- d) Terminar el parto mediante cesárea.
- e) Determinar la actitud de la cabeza fetal mediante una radiografía simple del abdomen materno.

51) Cuando se administra sulfato de magnesio para el tratamiento de a preeclampsia-eclampsia y aparecen signos de sobredosificación ¿qué antídoto se debe emplear?:

- a) Carbonato sódico.
- b) Sulfato ferroso.
- c) Nitroprusiato.
- d) Simpaticomiméticos.
- e) Gluconato cálcico.

52) Paciente con historia de cólicos nefríticos de repetición expulsivos, cuyo estudio metabólico muestra una hipercalcemia idiopática no influenciada por el ayuno ni la ingesta. De los siguientes, ¿cuál es el tratamiento adecuado?:

- a) Fosfato de celulosa.
- b) Dieta hipoproteica y ortofosfatos.
- c) Alopurinol.
- d) Ingesta abundante de líquidos y tiazidas.
- e) Alcalinización de la orina y D-penicilamina.

53) Una mujer de 18 años cursa embarazo de 8 semanas. Consulta por cuadro de metrorragia, fiebre, ictericia, dolor abdominal y gran compromiso del examen general. Al examen se aprecia paciente febril hasta 39°C, icterica, hipotensa, con salida de líquido purulento por orificio cervical externo. Se sospechan maniobras abortivas. El agente microbiológico, que con mayor probabilidad es el causante de este cuadro es:

- a) Escherichia coli
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Staphylococcus aureus
- d) Bacteroides fragilis
- e) Clostridium perfringens

54) ¿Con qué ametropía se relaciona más frecuentemente un glaucoma de ángulo estrecho?:

- a) Miopía.
- b) Astigmatismo.
- c) Hipermetropía.
- d) Presbicia.
- e) Afaquia.

55) Enfermo de 40 años, que presenta desde hace tres meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos, acompañadas de prurito. El estudio histopatológico de una lesión muestra una dermatitis de interfase con degeneración vacuolar de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico?:

- a) Pitiriasis rosada.
- b) Papulosis linfomatoide.
- c) Psoriasis eruptiva.
- d) Liquen plano.
- e) Pápulas piezogénicas.

56) Un paciente de 24 años, consulta porque presenta pensamientos desagradables. Cada vez que escucha las palabras mal, malo y enfermedad tiene la sensación de que algo terrible le va a pasar a él o a su familia. Para evitar esto, se persigna 3 veces y reza un padre nuestro. Sabe que eso no es normal, pero no puede evitarlo y le causa mucha angustia. No presenta alucinaciones y sabe que estas ideas son producidas por su mente. Teme estar volviéndose loco y en el último tiempo se ha sentido triste y desesperado. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por desrealización

57) Un paciente de 20 años consulta por múltiples lesiones maculares, hipopigmentadas, que se distribuyen en la zona media de la espalda y del pecho. Las lesiones aparecieron hace cerca de un mes y no presentan dolor ni prurito. La etiología más probable es:

- a) Autoinmune
- b) Alérgica
- c) Viral
- d) Bacteriana
- e) Fúngica

58) Una paciente de 43 años, en amenorrea desde hace 2 meses, se realiza un test de embarazo que resulta positivo. Se solicita una ecografía transvaginal que visualiza saco gestacional de 45 mm de diámetro, sin presencia de embrión. La conducta más adecuada es:

- a) Diagnosticar aborto retenido y realizar legrado uterino
- b) Sospechar embarazo ectópico y realizar laparoscopia
- c) Sospechar mola completa e iniciar metotrexato
- d) Sospechar embarazo de menor edad gestacional y solicitar niveles de gonadotropina coriónica
- e) Diagnosticar mola parcial y realizar legrado aspirativo

59) ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar el dispositivo intrauterino (DIU), sin mayor contraindicación?

- a) Mujer con antecedente de endometriosis
- b) Mujer con antecedentes familiares de cáncer de mama
- c) Mujer con antecedente de hipermenorrea
- d) Mujer con promiscuidad sexual
- e) Mujer nupcial

60) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Los pacientes FONASA A no deben pagar por la atención médica en el sistema público
- b) Los consultorios se financian principalmente por el aporte per cápita
- c) La atención de los accidentes laborales se financia por el aporte que el trabajador hace a las mutuales
- d) Las ISAPRES pueden ofrecer planes de salud con un precio superior al 7% del sueldo del trabajador
- e) Los trabajadores sin contrato (independientes) no están obligados a cotizar en FONASA o en una ISAPRE

61) Un paciente de 32 años está convencido de que su mujer lo engaña con un amante. Ella lo niega rotundamente y dice que su esposo está volviéndose loco con ese tema. Por esto, él la sigue e incluso ha contratado un detective para que la espíe, sin lograr ninguna información. A pesar de esto él insiste en el engaño de su mujer, ya que ha visto manchas en las sábanas de la casa, que con toda seguridad son producto de la infidelidad. No ha presentado alucinaciones y el resto de su examen psiquiátrico es normal, al igual que el examen neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno bipolar

62) Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 36 semanas consulta por contracciones uterinas dolorosas. Se solicita monitoreo cardíaco fetal que muestra frecuencia cardíaca fetal entre 90 y 95 latidos por minuto, sin aceleraciones ni desaceleraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Iniciar aceleración oxitócica
- c) Administrar tocolíticos
- d) Administrar corticoides y antibióticos
- e) Dejar evolucionar el parto normalmente

63) Un paciente de 24 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y diarrea de 2 meses de evolución, que en el último tiempo se ha vuelto sanguinolenta. Refiere que además debió ser intervenido recientemente debido a un absceso perianal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amebiasis intestinal
- b) Criptosporidiasis
- c) Tuberculosis intestinal
- d) Enfermedad de Cröhn
- e) Colitis ulcerosa

64) Un enfermo manifiesta sensación de dificultad respiratoria, mareo con sensación de inestabilidad o desfallecimiento, palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de ahogo, náuseas, despersonalización, parestesias, sofocación que se alterna con escalofríos, opresión precordial, miedo a morir o a perder el control sobre sí mismo. ¿Cuál es, entre los siguientes, el diagnóstico más probable?:

- a) Brote esquizofrénico.
- b) Depresión endógena.
- c) Trastorno obsesivo compulsivo.
- d) Crisis de angustia.
- e) Síndrome de abstinencia.

65) Un paciente diabético está en tratamiento con insulina NPH matinal y nocturna, más refuerzos de insulina cristalina predesayuno, prealmuerzo y precena. Se controla habitualmente con hemoglucotest y presenta los siguientes valores promedio:

Predesayuno: 90 mg/dl	Postdesayuno: 120 mg/dl
Prealmuerzo: 100 mg/dl	Postalmuerzo: 110 mg/dl
Precena: 104 mg/dl	Postcena: 210 mg/dl

La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la insulina NPH matinal
- b) Aumentar la insulina NPH nocturna
- c) Aumentar la insulina cristalina predesayuno
- d) Aumentar la insulina cristalina prealmuerzo
- e) Aumentar la insulina cristalina precena

66) Un paciente hipertenso de 60 años de edad es traído por sus familiares por un cuadro de varios meses de evolución de astenia, prurito ocasional y en el último tiempo desorientación. Además refieren que orina menos de medio litro al día y que en frecuentemente presenta hipo. El examen físico demuestra palidez de piel y mucosas y edema de extremidades inferiores, asociado a asterixis, sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Daño hepático crónico
- b) Insuficiencia cardíaca
- c) Insuficiencia renal crónica
- d) Vasculitis sistémica
- e) Síndrome de secreción inadecuado de ADH

67) Un paciente hipertenso presenta de manera brusca imposibilidad para hablar, asociado a hemiparesia faciobraquial izquierda. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma
- b) Anticoagular con heparina
- c) Administrar aspirina
- d) Administrar nitratos endovenosos
- e) Solicitar TAC de cerebro

68) Una paciente de 43 años, presenta desde hace 4 meses disnea de esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores. Los síntomas han ido empeorando gradualmente y en la actualidad presenta disnea al realizar pequeños esfuerzos. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal, se palpa desplazamiento del choque de la punta al quinto espacio intercostal, a la altura de la línea axilar media y se ausculta un soplo holosistólico holosistólico. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia aórtica
- b) Estenosis aórtica
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Miocardiopatía dilatada

69) Paciente de 3 años, sin vacunaciones previas, es traída por su madre por presentar convulsiones y fiebre. Al examen se aprecia paciente en regulares condiciones generales, febril, hemodinámicamente estable, con signos meníngeos positivos y parálisis del cuarto nervio craneal derecho. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido turbio, con 500 células, 86% de mononucleares, proteínas aumentadas y glucosa de un 20% respecto a la glucosa plasmática. La tinción de Gram y tinta china resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningoencefalitis viral (enterovirus)
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Meningococcemia
- e) Panencefalitis esclerosante subaguda

70) Sobre el trastorno bipolar es verdadero que:

- a) La fase depresiva debe tratarse exclusivamente con antidepresivos, ya que el riesgo de viraje a fase maníaca es mínimo
- b) Los antecedentes familiares de bipolaridad no significan un aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad
- c) Los estabilizadores del ánimo, como el litio y los anticonvulsivantes, son la base del tratamiento
- d) Es muy frecuente y cerca de un 10% de la población lo padece en algún grado
- e) Los pacientes maníacos suelen presentar alucinaciones de tipo visual

71) Un paciente de 45 años consulta por dolor en el hombro izquierdo, de predominio nocturno, que comenzó hace cerca de 2 semanas y que ha empeorado en los últimos días. No refiere traumatismos y al examen físico sólo se aprecia dolor a la abducción contra resistencia del hombro izquierdo, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinitis bicipital
- b) Artrosis de hombro
- c) Tendinosis del manguito rotador
- d) Disyunción acromioclavicular
- e) Tumor de células gigantes

72) Un paciente ingresa para una colecistectomía electiva, la que es resuelta de manera exitosa, por medio de laparoscopia. El tipo de herida es:

- a) Limpia
- b) Limpia contaminada
- c) Contaminada
- d) Sucia
- e) Infectada

73) Un recién nacido de 32 semanas de edad gestacional presenta taquipnea pocos minutos después de nacer, asociada a aleteo nasal y a cianosis central. La saturación arterial de oxígeno por pulsometría es 80%, aumentando a 92% con oxígeno al 50%. Al examen físico se auscultan escasas crepitaciones difusas. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita cianótica
- b) Cardiopatía congénita acianótica
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Taquipnea transitoria
- e) Enfermedad de membrana hialina

74) Se decide iniciar una campaña de pesquisa de glaucoma en una población de 4.000 habitantes. Para esto se realizarán tonometría oculares al 75% de la población. Un técnico es capaz de realizar la prueba a 10 pacientes por hora y el costo de su hora de trabajo es \$2.000. ¿Cuánto dinero se necesita para cubrir las horas-técnico necesarias para implementar la campaña?

- a) \$ 8.000.000
- b) \$ 6.000.000
- c) \$ 3.000.000
- d) \$ 800.000
- e) \$ 600.000

75) Una mujer de 20 años consulta por amenorrea de cerca de 2 meses de evolución. Refiere que sus reglas son irregulares. Se solicita prueba de embarazo que resulta positiva. La conducta más adecuada para determinar la edad gestacional es:

- a) Preguntar la fecha de última regla
- b) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- c) Solicitar progesterona plasmática
- d) Palpar la altura uterina
- e) Realizar ecografía

76) ¿Qué vacunas recibe un niño a los 6 meses de edad, según el Programa Nacional de Inmunizaciones actual?

- a) DTP, polio oral y trivírica
- b) DTP, Haemophilus influenza B y polio oral
- c) DTP, Haemophilus influenza B, hepatitis B y polio oral
- d) DTP y trivírica
- e) DTP y polio oral

77) Una paciente presenta artritis de manos y del hombro izquierdo, asociado a astenia y algunas adenopatías cervicales. En sus exámenes de laboratorio destaca hemograma con anemia normocítica, normocrómica, con plaquetas y glóbulos blancos disminuidos. Además presenta elevación de la creatinina y de las transaminasas. Los anticuerpos antinucleares resultaron positivos y los anticitoplasma de neutrófilo fueron negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Mieloma
- b) Leucemia
- c) Lupus
- d) Enfermedad por arañazo de gato
- e) Vasculitis de vaso pequeño

78) Un niño de 13 meses aún no camina y el examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar hemograma, electrolitos y gases venosos
- c) Solicitar TAC cerebral
- d) Solicitar ecografía cerebral
- e) Indicar uso de andador

79) Una niña de 4 años presenta metrorragia de 1 día de evolución. No refiere traumatismos y al examen se aprecia secreción genital con mezcla de sangre y pus. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cuerpo extraño vaginal
- b) Candidiasis
- c) Vulvovaginitis inespecífica
- d) Vaginitis bacteriana
- e) Abuso sexual

80) Un paciente de 65 años presenta disnea y al examen físico se ausculta clara disminución del murmullo pulmonar en la base derecha, asociada a matidez a la percusión. ¿Cuál de las siguientes opciones es MENOS probable como diagnóstico?

- a) Atelectasia
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Derrame pleural
- d) Parálisis frénica derecha
- e) Neumotórax

81) Un niño de 5 años hace berrinches cada vez que lo llevan al jardín infantil. Una vez que es obligado a ir, llora por largo rato y es difícil de consolar, hasta que finalmente se calma y juega con sus compañeros. La madre refiere que le preocupa que el niño pueda ser víctima de maltrato por parte de sus compañeros o profesores y que esto sea la causa de su comportamiento. Al examen físico no se encuentra ningún tipo de lesión ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por ansiedad de separación
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno de conducta
- d) Trastorno depresivo
- e) Trastorno por déficit atencional

82) Un paciente de 45 años consulta por hiposmia, sensación de presión facial, cefalea ocasional y descarga posterior de 3 meses de evolución, que ha tratado con antialérgicos y descongestionantes. Se solicita TAC de cavidades paranasales que demuestra retención de secreciones y engrosamiento mucoso de los senos paranasales frontal y maxilar derecho. El tratamiento antibiótico de primera línea es:

- a) Clindamicina
- b) Cloxacilina + metronidazol
- c) Amoxicilina + ácido clavulánico
- d) Vancomicina
- e) Cefadroxilo

83) Un Lactante de 1 mes de edad presenta desde hace una semana vómitos explosivos luego de cada vez que es amamantado. La madre refiere que luego de eso queda hambriento y toma leche ávidamente. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar relleno
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Iniciar prokinéticos
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Mantener conducta expectante

84) El tratamiento de elección de la ascariasis intestinal es:

- a) Prazicuantel
- b) Albendazol
- c) Metronidazol
- d) Lactulosa
- e) Dieta

85) Una paciente de 44 años, consulta por disnea y tos de larga data, pero que en el último tiempo se ha hecho más intensa. Refiere que los síntomas son especialmente intensos después de realizar actividad física y que son más frecuentes en la noche. Al examen físico se ausculta alargamiento en la espiración y algunas sibilancias bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrosis pulmonar
- b) EPOC
- c) Asma
- d) Bronquiectasias
- e) Tuberculosis

86) La persistencia del ductus arterioso, luego del nacimiento, puede tratarse farmacológicamente con:

- a) Adenosina
- b) Prostaglandinas
- c) Furosemida
- d) Indometacina
- e) Digoxina

87) Un niño de 2 años inicia cuadro de tos intensa, de inicio súbito, persistiendo luego con tos, la que se hace rápidamente productiva. Al examen físico se ve de buen aspecto y la auscultación pulmonar demuestra sibilancias en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Bronconeumonía
- c) Bronquitis aguda
- d) Coqueluche
- e) Cuerpo extraño bronquial

88) Un niño de 3 años sufre caída a nivel mientras jugaba, golpeándose la cabeza contra un árbol y evolucionando con aparición de aumento de volumen en la zona del golpe. No perdió la conciencia ni presentó vómitos. Al examen se observa en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica. Se observa un hematoma de 3,5 cm en la zona frontal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con indicación de reconsultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Observar hospitalizado por 24 horas sin necesidad de realizar imágenes
- c) Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar TAC de cerebro y de cráneo, sin medio de contraste y decidir manejo según resultados
- e) Realizar punción del hematoma e iniciar analgesia endovenosa

89) Un paciente de 66 años, con antecedente de angina estable, en tratamiento con nitritos orales y aspirina, presenta desde hace uno minutos, dolor precordial de reposo y sudoración. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar angiografía
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Administrar nitritos endovenosos

90) La causa más frecuente de aborto es:

- a) Incompetencia cervical
- b) Alteraciones genéticas embrionarias
- c) Síndrome antifosfolípidos
- d) Alteraciones hormonales
- e) Malformaciones uterinas

Respuestas:

Prueba 4 Ensayo EUNACOM

PRIMERA PARTE

Preguntas

Respuestas

1

C

2

B

3

B

4

B

5

E

6

E

7

C

8

E

9

A

10

B

11

C

12

C

13

D

14

D

SEGUNDA PARTE

Preguntas

Respuestas

1

A

2

A

3

C

4

B

5

B

6

D

7

C

8

A

9

D

10

E

11

A

12

C

13

D

14

A

15	D
16	B
17	A
18	C
19	D
20	C
21	E
22	C
23	C
24	D
25	A
26	B
27	E
28	D
29	C
30	E
31	E
32	A
33	A
34	A
35	D
36	A
37	D
38	D
39	D
40	B
41	D
42	C
43	C
44	C
45	E

15	B
16	D
17	A
18	C
19	B
20	A
21	D
22	D
23	A
24	D
25	E
26	D
27	D
28	B
29	C
30	D
31	C
32	A
33	C
34	D
35	A
36	D
37	D
38	D
39	E
40	B
41	D
42	E
43	E
44	E
45	B

46	B
47	E
48	E
49	C
50	E
51	C
52	D
53	B
54	E
55	C
56	A
57	D
58	D
59	B
60	A
61	B
62	D
63	D
64	A
65	E
66	D
67	E
68	C
69	D
70	C
71	E
72	A
73	D
74	B
75	B
76	D

46	C
47	B
48	A
49	E
50	D
51	E
52	D
53	E
54	C
55	D
56	D
57	E
58	A
59	B
60	C
61	D
62	A
63	D
64	D
65	E
66	C
67	E
68	E
69	C
70	C
71	C
72	B
73	E
74	E
75	E
76	C

77	D	77	C
78	D	78	A
79	B	79	A
80	C	80	E
81	B	81	A
82	D	82	C
83	B	83	B
84	E	84	B
85	B	85	C
86	B	86	D
87	E	87	E
88	D	88	A
89	A	89	A
90	A	90	B

Ensayo EUNACOM – Prueba 5

PRIMERA PARTE

1) Un niño de 5 años presenta mal comportamiento en su casa. La madre refiere que es desobediente y que hace berrinches con frecuencia. Además cuando se lo contradice grita, se tira al suelo, rompe cosas y pateo. Tiene buen rendimiento escolar aunque en oportunidades no obedece las órdenes del profesor. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
- c) Depresión infantil
- d) Trastorno oposicionista desafiante
- e) Síndrome de Asperger

2) En la práctica anestésica suelen utilizarse con frecuencia a los analgésicos opiáceos, dada su alta efectividad, sin embargo presentan varios efectos adversos. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un efecto adverso de estos medicamentos?

- a) Diarrea
- b) Vómitos
- c) Retención urinaria
- d) Depresión respiratoria, potenciada por benzodiacepinas
- e) Dependencia

3) Un paciente de 8 años presenta un cuadro de cefalea y hematuria en varias oportunidades. Al examen físico se aprecia hipertenso, con edema facial y de extremidades inferiores. Se realizan exámenes que muestran creatininemia de 1,4 mg/dl, BUN: 33 mg/dl, orina completa con hematuria dismórfica y porteinuria ++. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hemolítico urémico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome nefrítico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Enfermedad de Berger

4) ¿Cuál de las siguientes alteraciones supone una MENOR gravedad en un paciente con un trauma ocular?

- a) Hifema
- b) Discoria
- c) Hemorragia subconjuntival
- d) Disminución de la agudeza visual
- e) Limitación de la visión hacia arriba

5) ¿Cuál de las siguientes situaciones requiere profilaxis antibiótica para el Estreptococo grupo B, en una paciente que inició el trabajo de parto?

- a) Antecedente de rotura prematura de membranas de 5 horas de evolución
- b) Edad gestacional de 36 semanas
- c) Antecedente de preclamsia
- d) Antecedente de diabetes mellitus gestacional
- e) Antecedente de colestasia intrahepática del embarazo

6) Un paciente fumador, con historia de disnea, es diagnosticado de EPOC, mediante una espirometría. Presenta disnea de esfuerzos, que le permite caminar 3 cuadras, antes de tener que detenerse. Sus gases arteriales de reposo son normales. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Suspender el cigarrillo e iniciar broncodilatadores inhalados
- b) Suspender el cigarrillo e iniciar corticoides inhalados
- c) Suspender el cigarrillo e iniciar corticoides orales
- d) Suspender el cigarrillo e iniciar broncodilatadores inhalados, corticoides inhalados y oxígeno domiciliario
- e) Suspender el cigarrillo e iniciar broncodilatadores inhalados, corticoides orales y oxígeno domiciliario

7) Una paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, consulta por deposiciones negras de olor penetrante, asociado a ortostatismo. No presenta otros síntomas y al examen físico está taquicárdica, con PA: 110/70 mmHg y al tacto rectal se constata melena. La conducta más adecuada, además de una adecuada reposición de la volemia, es:

- a) Indicar régimen cero y solicitar hemograma
- b) Iniciar omeprazol oral en dosis altas
- c) Transfundir glóbulos rojos
- d) Realizar endoscopia digestiva alta
- e) Administrar terlipresina endovenosa

8) Una paciente presenta una fractura de pierna derecho, la que es tratada ortopédicamente. Varios días después evoluciona con intenso dolor en la pierna y pie derechos. Al examen físico se aprecia adelgazamiento de la piel y pérdida de los fanéreos distales y dolor a la movilización pasiva de los dedos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Trombosis venosa profunda, con síndrome postflebítico
- c) Distrofia simpática refleja
- d) Retardo de la consolidación
- e) Neurotmesis

9) La probabilidad de morir si es que se enferma, se denomina:

- a) Mortalidad específica
- b) Incidencia acumulada
- c) Tasa de ataque
- d) Letalidad
- e) Gravedad

10) Un recién nacido presenta vómitos explosivos desde la primera ingesta de leche. Al examen físico se observa adolorido. Se solicita radiografía de abdomen que muestra una imagen de doble burbuja. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Invaginación intestinal
- c) Atresia duodenal
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Duplicidad intestinal

11) Una paciente de 30 años consulta por disuria y secreción genital. Al examen físico se aprecia mucosa vulvar y vaginal con marcada inflamación, petequias y se observa leucorrea abundante, verdosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginosi bacteriana
- b) Candidiasis
- c) Tricomoniasis
- d) Infección por Chlamydia
- e) Gonorrea

12) Un paciente de 16 años consulta por malestar general, fiebre hasta 38,7°C y odinofagia de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia decaído, con un tinte subictérico, faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño, exudado blanquecino, adherente y se palpan varias adenopatías cervicales sensibles. Además es posible palpar el bazo por 2 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que demuestra presencia de linfocitosis, con linfocitos atípicos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático y aciclovir oral
- b) Iniciar tratamiento sintomático y solicitar IgM VCA
- c) Iniciar tratamiento sintomáticos y antibióticos orales
- d) Iniciar corticoides orales
- e) Solicitar biopsia de médula ósea

13) ¿Qué parámetro permite estimar, de mejor manera, la proporción de casos de una enfermedad que se prevendrían si se retirara el factor de riesgo en el grupo de los pacientes expuestos?

- a) Riesgo atribuible poblacional
- b) Riesgo relativo
- c) Likelihood ratio
- d) Riesgo atribuible porcentual
- e) Tasa de incidencia

14) Un paciente de 61 años, cursando un infarto cardíaco transmural, anteroseptal, manejado con medidas generales y trombolisis endovenosa, presenta al segundo día de evolución un rápido deterioro, con tendencia a la hipotensión y con dificultad respiratoria. Al examen físico se constatan crépitos pulmonares difusos y se ausculta un soplo holosistólico intenso en todo el precordio, que antes no estaba descrito. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de pared libre
- b) Infarto de ventrículo derecho
- c) Rotura del septum interventricular
- d) Formación de aneurisma ventricular
- e) Reinfarto de la arteria circumfleja

15) Los miomas submucosos se manifiestan habitualmente como:

- a) Hipermenorrea
- b) Dismenorrea
- c) Metrorragia
- d) Tumor palpable
- e) Dispareunia profunda

16) ¿Cuál de las siguientes situaciones es diagnóstica de diabetes mellitus gestacional en una paciente embarazada?

- a) Paciente asintomática con una glicemia de ayuno de 200 mg/dl
- b) Dos glicemias de ayuno de 102 y 104 mg/dl
- c) Un test de tolerancia con 75g de glucosa, con glicemia basal: 99 mg/dl y glicemia post-sobrecarga: 150 mg/dl
- d) Un test de tolerancia con 75g de glucosa, con glicemia basal: 107 mg/dl y glicemia post-sobrecarga: 120 mg/dl
- e) Tres hemoglucotest postprandiales mayores a 125 mg/dl

17) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, presenta un tumor renal izquierdo, compatible con un carcinoma de células renales, de 4 cm de diámetro, con un TAC que no visualiza adenopatías ni invasión de los vasos renales.

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar quimioterapia preoperatoria y luego realizar una nefrectomía radical
- b) Realizar nefrectomía parcial, seguida de quimioterapia postoperatoria
- c) Realizar nefrectomía parcial, seguida de radioterapia postoperatoria
- d) Administrar radioterapia preoperatoria y luego realizar una nefrectomía radical
- e) Realizar nefrectomía radical

18) Una mujer de 25 años, consulta por palpitaciones, irritabilidad, diarrea, baja de peso y malestar general de un par de meses de evolución. Al examen físico se aprecia FC: 115 x' regular, piel fina, sudorosa, retracción palpebral bilateral, exoftalmo, temblor fino de extremidades superiores y mixedema pretibial. Además se palpa un bocio difuso, no doloroso. La TSH resulta 0,01 (VN: 0,4 – 4,0). El tratamiento de primera línea de la patología descrita es:

- a) Betabloqueo y AINES
- b) Betabloqueo y propiltiouracilo
- c) Yodo radiactivo
- d) Levotiroxina
- e) Cirugía

19) Un recién nacido prematuro presenta estridor inspiratorio. Al examen físico se aprecia reactivo, en buenas condiciones generales, sin cianosis ni taquipnea. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Laringomalacia
- c) Bronquiolitis
- d) Hemangioma subglótico
- e) Hipertrofia adenoidea

20) Un niño de 4 meses de edad presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,2°C, de dos días de evolución, seguido de dificultad respiratoria y retracción intercostal. Al examen físico se auscultan sibilancias espiratorias difusas bilaterales. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Mycoplasma pneumoniae
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Streptococcus agalactiae

21) ¿De qué fuente se financia principalmente el sistema público de salud?

- a) Del aporte de los trabajadores de una fracción de su sueldo
- b) Del aporte de los empleadores de una fracción de sus ganancias
- c) De los impuestos generales y la ley de presupuesto fiscal
- d) De los ingresos autogenerados por el sistema de salud
- e) De los aportes de las municipalidades

22) Un paciente de 40 años presenta un rash macular eritematoso generalizado, con descamación fina, que compromete las palmas y las plantas. Se realiza exámenes generales, entre los que destaca un RPR positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- b) Solicitar VDRL
- c) Administrar penicilina benzatina al paciente y a su parejas sexuales
- d) Solicitar FTA-ABS
- e) Solicitar microscopía de campo oscuro de secreción uretral

23) Una mujer de 30 años refiere que desde hace 3 años que no se siente feliz. En general su ánimo es disfórico y en ocasiones irritable. Se junta poco con sus amigos y no realiza muchas actividades, ya que no le llaman la atención. No sabe por qué se siente así y no presenta otros síntomas. Sus hábitos de sueño son normales y no ha presentado cambios importantes en su peso. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión melancólica
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno adaptativo
- d) Esquizofrenia
- e) Distimia

24) ¿Desde qué edad se debe iniciar la suplementación con hierro a los lactantes, nacidos de término, alimentados con leche materna exclusiva?

- a) No deben recibir suplementos e hierro
- b) A los 4 meses de edad
- c) A los 6 meses de edad
- d) A los 9 meses de edad
- e) A los 12 meses de edad

25) Un hombre de 30 años presenta una caída, con torsión de la rodilla izquierda mientras jugaba fútbol. Al examen físico se aprecia rodilla aumentada de tamaño, con derrame articular y es posible luxar la articulación moviendo la tibia hacia posterior (cajón posterior). El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de ligamento cruzado anterior
- b) Rotura de ligamento cruzado posterior
- c) Rotura de ligamento colateral medial
- d) Rotura de ligamento colateral lateral
- e) Rotura del tendón rotuliano

26) Una mujer multípara de 2, cursando un embarazo de 40 semanas, ingresa en trabajo de parto. Se palpan 4 contracciones uterinas en 10 minutos y se palpa borramiento completo, con dilatación de 6 cm, membranas rotas y feto en presentación de cara, en posición mentopúbica. La monitorización cardíaca fetal es tranquilizadora. La conducta más adecuada es:

- a) Permitir evolución del trabajo de parto
- b) Administrar un tocolítico
- c) Iniciar aceleración oxitócica
- d) Realizar fórceps
- e) Realizar cesárea

27) Un paciente presenta desde hace 7 días fiebre y artralgias, asociados a compromiso del estado general y parestesias. Evoluciona con oliguria y hematuria. Se solicitan exámenes que demuestran elevación de la creatinina plasmática a 4,5 mg/dl, hematuria dismórfica, cilindros eritrocitarios, proteinuria++ y positividad de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, en patrón citoplasmático. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliangeítis microscópica
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Crisis esclerodérmica
- d) Púrpura trombocitopénico trombótico
- e) Lupus

28) ¿Qué tratamiento indicaría a una paciente sin antecedentes de importancia ni cirugías previas, con marcados síntomas climatéricos?

- a) Estrógenos locales
- b) Estrógenos orales
- c) Progestágenos orales
- d) Estrógenos + progestágenos orales
- e) Raloxifeno

29) Un paciente de 60 años presenta desde hace algunos meses dolor epigástrico, urente e intermitente, sin relación con las comidas. Además refiere haber bajado 6 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. El examen físico no demuestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

30) Un recién nacido postérmino, nacido por parto normal, presenta un síndrome de dificultad respiratoria, desde poco tiempo después de nacer. Al examen físico se aprecia taquipneico, con cianosis facial y destaca un murmullo pulmonar disminuido bilateralmente, con presencia de crepitaciones y sibilancias difusas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Cardiopatía congénita
- c) Taquipnea transitoria
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Hipertensión pulmonar persistente

31) Una paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca y en el examen físico se observa “danza arterial” en el cuello, se palpa un pulso de gran amplitud y se ausculta un soplo paraesternal, diastólico, de intensidad III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Insuficiencia mitral
- c) Estenosis aórtica
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

32) Los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Poliglobulia
- c) Cardiopatías congénitas
- d) Displasia de cadera
- e) Síndrome aspirativo meconial

33) Una paciente de 30 años consulta por disuria y fiebre. Al examen físico se aprecia decaída, con fiebre 38,9°C, FC: 100x', PA: 120/70 mmHg y puño percusión derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico oral, por 5 días
- b) Indicar ciprofloxacino oral, por 7 días
- c) Administrar ceftriaxona endovenosa, por 5 días
- d) Indicar nitrofurantoína oral por 3 días
- e) Indicar cefadroxilo oral, en dosis única

34) Un paciente sufre una caída a nivel, resultando con una luxación anterior de hombro y lesión del nervio axilar. ¿Qué espera encontrar en el examen neurológico?

- a) Anestesia de la zona deltoidea e imposibilidad de abducir el brazo
- b) Anestesia de la zona medial del brazo e imposibilidad de extender el codo
- c) Anestesia de la zona lateral del brazo e imposibilidad de flexar el codo
- d) Anestesia de la zona medial del antebrazo e imposibilidad de extender la muñeca
- e) Anestesia de la zona lateral del antebrazo e imposibilidad de flexar la muñeca

35) Un niño que no habla puede ser considerado normal y por tanto no debe ser estudiado antes de:

- a) Los 12 meses de edad
- b) Los 15 meses de edad
- c) Los 18 meses de edad
- d) Los 21 meses de edad
- e) Los 24 meses de edad

36) Respecto al cáncer de ovario es FALSO que:

- a) Suele presentar síntomas precozmente
- b) Los anticonceptivos orales son un factor protector
- c) La nuliparidad es un factor de riesgo
- d) Suele elevar el marcador Ca-125
- e) Suele diseminarse por vía transcelómica

37) Un lactante de 3 meses presenta epífora izquierda crónica, sin otros síntomas. Al examen físico sus ojos son de tamaño normal y no presenta alteraciones en la inspección ni en la oculomotilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
- c) Atresia lagrimal
- d) Glaucoma congénito
- e) Conjuntivitis alérgica

38) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es INCORRECTA?

- a) La hipertensión renovascular presenta normalidad del índice de aldosterona / ARP
- b) Las metanefrinas urinarias son de utilidad diagnóstica ante la sospecha de feocromocitoma
- c) La hipertensión renovascular se trata preferentemente con cirugía
- d) El hiperaldosteronismo primario suele presentar hiperkalemia
- e) Se debe sospechar la presencia de hipertensión arterial secundaria en pacientes menores de 30 años o que no responden al tratamiento hipertensivo habitual

39) Una paciente de 38 años, cursando su segundo embarazo, de 35 semanas, bien controlado y sin complicaciones hasta el momento, presenta presión arterial 146/90 mmHg. Se decide semihospitalización, que muestra varias tomas con cifras tensionales similares. La proteinuria cualitativa es ligeramente positiva y la proteinuria cuantitativa de 24 horas resulta 200 mg. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial crónica
- b) Preclamsia
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Eclamsia
- e) Hipertensión secundaria a nefropatía médica
- e) Cáncer de endometrio

40) ¿Cuál de las siguientes opciones es una contraindicación absoluta del uso de anticonceptivos orales?

- a) Diabetes mellitus 2
- b) Hipertensión arterial
- c) Promiscuidad sexual
- d) Antecedentes familiares de lupus sistémico
- e) Metrorragia de origen no precisado

41) Un paciente de 55 años consulta por dolor torácico izquierdo, con tope inspiratorio, de 3 días de evolución. Se solicita radiografía de tórax que detecta la presencia de un derrame pleural, el que se punciona, dando salida a un exudado pleural de predominio mononuclear, con adenosindeaminasa (ADA) de 70 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Derrame tuberculoso
- c) Empiema
- d) Cáncer
- e) Síndrome nefrótico

42) ¿A qué edad inicia habitualmente la marcha un niño?

- a) 8 meses
- b) 10 meses
- c) 12 meses
- d) 18 meses
- e) 24 meses

43) Un niño de 3 años presenta retraso del lenguaje. La madre refiere que hay que gritarle para que escuche y obedezca. La otoscopia visualiza ambos tímpanos opacos y con leve eritema. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar audiometría
- b) Solicitar impedanciometría
- c) Solicitar nasofibroscopia
- d) Solicitar RMN de fosa posterior
- e) Indicar uso de audífonos

44) Un niño de 4 años cae a la piscina de su casa y es encontrado inconsciente por su madre, en el fondo. Usted lo recibe 5 minutos después y constata ausencia de respiración y pulso. Inicia ventilaciones y masaje cardíaco y se instala monitor electrocardiográfico, que muestra asistolia. Lo reevalúa 2 minutos después y continúa sin cambios. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar marcapasos externo transitorio
- b) Realizar desfibrilación eléctrica
- c) Administrar adrenalina endovenosa
- d) Administrar amiodarona endovenosa
- e) Suspender las maniobras de resucitación

45) Una paciente de 23 años consulta por haberse palpado un nódulo mamario. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, de bordes lisos, fácil de movilizar y de consistencia gomosa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar mamografía
- b) Solicitar ecografía mamaria
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Solicitar biopsia con aguja fina
- e) Solicitar biopsia estereotáxica con mamótomo

46) Un paciente de 76 años presenta síncope a repetición durante la última hora. Al examen físico se ve desorientado, con FC: 30 lpm, PA: 80/30 mmHg, frialdad de extremidades y sudoración. El monitor electrocardiográfico demuestra una frecuencia ventricular de 30 lpm y disociación AV, con onda P a 90 x'. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones más precordiales derechas
- b) Administrar adrenalina endovenosa
- c) Realizar desfibrilación eléctrica
- d) Administrar amiodarona endovenosa
- e) Instalar un marcapasos externo transitorio

47) Un recién nacido de 2 días de vida, nacido prematuro a las 35 semanas de gestación, por rotura prematura de membranas, presenta hipotermia y debilidad en la succión. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hipoglicemia
- b) Hipocalcemia
- c) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Sepsis neonatal

48) Una paciente de 13 años consulta por aparición de una lesión eritematosa en el brazo izquierdo. Al examen se aprecia una placa de 5 cm de diámetro, eritematosa, descamativa, con borde papular, arciforme, tendencia a la curación central y presencia de vellos quebrados en su superficie. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis
- b) Excema numular
- c) Granuloma anular
- d) Tiña corporis
- e) Pitiriasis rosada

49) Un paciente de 33 años, previamente sano, consulta por fiebre, tos y expectoración mucopurulenta de 3 días de evolución. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y saturación arterial de oxígeno de 94% a FiO2 ambiental. Se constata respiración soplante, matidez y crepitaciones en el ápice pulmonar izquierdo y la radiografía de tórax es compatible con un foco de condensación neumónico en el lóbulo superior izquierdo. El tratamiento de elección es:

- a) Clindamicina
- b) Amoxicilina
- c) Ácido clavulánico + amoxicilina
- d) Ceftriaxona
- e) Claritromicina

50) ¿Qué vacuna(s) recibe un niño a los 18 meses de edad?

- a) Trivírica
- b) DPT
- c) DPT y polio oral
- d) BCG
- e) DPT, polio oral, hepatitis B, Haemophilus influenza b

51) La medida más eficiente para prevenir la agitación psicomotora nocturna, en un paciente geriátrico, con demencia moderada, internado en un asilo, es:

- a) Administrar benzodiazepinas
- b) Administrar antipsicóticos
- c) Realizar contención mecánica
- d) Aumentar la ingesta de frutas, verduras y otros alimentos ricos en vitaminas del complejo B
- e) Realizar caminatas y otros ejercicios durante el día

52) Una mujer acude a control con su ginecólogo y en la especuloscopia se observa una lesión cervical solevantada, de ubicación posterior de 8 mm de diámetro. Su último PAP fue realizado hace un año y fue informado como satisfactorio sin visualización de células atípicas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo PAP
- b) Solicitar estudio de virus papiloma humano
- c) Realizar cono cervical
- d) Derivar a colposcopia y realizar biopsia de la lesión
- e) Realizar crioterapia local

53) Un paciente sufre un accidente de tránsito, presentado fractura de pelvis. Al examen físico se aprecia salida de sangre fresca por la uretra. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar sonda Foley
- b) Drenar con sonda Nelaton
- c) Solicitar ecografía renal y vesical
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Solicitar uretrocistografía retrógrada

54) Un paciente de 35 años refiere que es un enviado de Dios para ayudar a la salvación de la humanidad. Siempre fue muy religioso y desde hace 3 años comenzó con la idea de que Dios lo veía como alguien muy especial y que lo había elegido. Al pasar del tiempo fue evolucionando hasta autodefinirse como un enviado divino. No ha presentado alucinaciones, se desenvuelve bien en su trabajo y sus cercanos lo consideran un tipo sociable, sin embargo les preocupa esta situación. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Depresión psicótica
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno de personalidad esquizotípico
- e) Trastorno de personalidad esquizoide

55) Una niña de 6 años presenta rinorrea crónica y obstrucción nasal intermitente. Además refiere estornudar con frecuencia. Al examen físico se observa ojerosa, con palidez de la mucosa nasal. El diagnóstico más probable es:

- a) Rinitis viral
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Leucemia aguda
- d) Rinitis alérgica
- e) Hipertrofia de adenoides

56) ¿Qué asociación entre la patología y el resultado de los gases arteriales es FALSA?

- a) pCO₂: 33 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,30, HCO₃: 16 mEq/l – Gases venosos
- b) pCO₂: 58 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,29, HCO₃: 27 mEq/l – Enfermedad neuromuscular
- c) pCO₂: 36 mmHg, paO₂: 70 mmHg, pH: 7,44, HCO₃: 24 mEq/l – Fibrosis pulmonar
- d) pCO₂: 25 mmHg, paO₂: 92 mmHg, pH: 7,67, HCO₃: 29 mEq/l – Alcalosis respiratoria
- e) pCO₂: 35 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,49, HCO₃: 26 mEq/l – EPOC

57) De un total de 300 pacientes, 200 presentaron una prueba diagnóstica positiva, sin embargo sólo 150 de éstos estaban realmente enfermos. Además se sabe que hubo otros 50 enfermos más, que presentaron la prueba negativa. El valor predictivo positivo de la prueba es:

- a) 25%
- b) 33%
- c) 50%
- d) 66%
- e) 75%

58) Un paciente de 66 años, diabético tipo 2 de larga data, en tratamiento irregular con metformina y glibenclamida, presenta marcada disminución de la sensibilidad termalgésica y vibratoria de las extremidades inferiores, de predominio distal y de tipo simétrico. La conducta más adecuada, además de mejorar la adherencia a tratamiento, es:

- a) Revisar periódicamente los pies y usar un calzado adecuado
- b) Realizar kinesioterapia motora de las extremidades inferiores
- c) Iniciar antidepresivos tricíclicos
- d) Iniciar gabapentina
- e) Iniciar insulina

59) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es FALSA, entre la estructura dañada y el cuadro clínico?

- a) Segundo nervio craneal derecho – Amaurosis y escape pupilar derechos
- b) Tercer nervio craneal derecho – Midriasis y Ptosis derechas
- c) Cuarto nervio craneal derecho – Imposibilidad de mirar hacia inferolateral con el ojo derecho
- d) Sexto nervio craneal derecho – Imposibilidad de mirar a la derecha con el ojo derecho
- e) Fascículo longitudinal medial – Imposibilidad de mirar a la izquierda con el ojo derecho

60) El síndrome de cuello rojo (red neck syndrome) se produce por la administración endovenosa rápida de un antibiótico y se caracteriza por la aparición de un rash eritematoso en el cuello y en la zona dorsal alta. ¿Qué antibiótico es el responsable de este síndrome?

- a) Imipenem
- b) Vancomicina
- c) Ceftazidina
- d) Amicacina
- e) Clindamicina

61) ¿Cuál de las siguientes situaciones es MENOS probable de encontrar en una úlcera venosa?

- a) Ubicación en el maléolo medial
- b) Presencia de hiperpigmentación de la piel circundante
- c) Bordes regulares
- d) Dolor intenso
- e) Fondo violáceo y limpio

62) Una paciente multipara de 3, cursando embarazo de 32 semanas + 3 días, presenta rotura prematura de membranas, confirmada mediante test de cristalización. Se palpa feto en presentación podálica y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar corticoides y antibióticos a la madre e inducir el parto con misoprostol en 48 horas
- d) Administrar corticoides y antibióticos a la madre e interrumpir el embarazo mediante cesárea en 48 horas
- e) Administrar corticoides y antibióticos a la madre, manteniendo una conducta expectante

63) Un niño de 5 años presenta un soplo sistólico eyectivo, de intensidad IV/VI, asociado a clara disminución de los pulsos pedios, con normalidad de los pulsos radiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arteriosos persistente
- d) Coartación aórtica
- e) Situs inversus

64) Un paciente de 33 años, sin antecedentes previos de patologías ni de consumo de sustancias, presenta un cuadro caracterizado por movimientos involuntarios de la extremidad inferior izquierda, seguido de desconexión del medio y finalmente una convulsión tónicoclónica de 3 minutos de duración. Al examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma
- b) Solicitar resonancia magnética cerebral
- c) Iniciar carbamazepina oral a permanencia
- d) Administrar lorazepam endovenoso
- e) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio, indicando control en caso de volver a presentar síntomas

65) Un niño de 5 años se introduce un poroto en la nariz, el que luego no puede retirar. Al día siguiente presenta rinorrea purulenta por la fosa nasal obstruida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales y controlar en 7 días
- b) Irrigar con abundante suero fisiológico
- c) Extraer la semilla con una pinza
- d) Iniciar descongestionantes tópicos
- e) Derivar a otorrinolaringólogo

66) Un paciente de 66 años, diabético tipo 2, en tratamiento irregular con metformina y glibenclamida presenta un cuadro de tos con expectoración y fiebre de 2 días de evolución. Se agrega después poliuria y compromiso de consciencia. Al examen físico se aprecia deshidratado, en sopor superficial, hipotenso, taquicárdico y su hemoglucotest resulta "Hi". El diagnóstico más probable es:

- a) Cetoacidosis diabética
- b) Shock séptico
- c) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- d) Endocarditis infecciosa
- e) Hipercalcemia maligna

67) Una paciente de 64 años consulta por artralgias de varias semanas de duración, asociado a marcada rigidez matinal de 2 horas de duración. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de algunas articulaciones metacarpofalángicas. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Artrosis
- c) Artritis reumatoide
- d) Lupus
- e) Esclerodermia sistémica limitada (CREST)

68) Un recién nacido de 27 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia desde hace 4 días. Se solicita bilirrubina plasmática total que resulta 8,7 mg/dl y bilirrubina directa que resulta 1,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia hemolítica
- c) Hipotiroidismo
- d) Hepatitis neonatal
- e) Atresia biliar primaria

69) ¿Qué medidas aconsejaría a un paciente insuficiente renal crónico, con hiperparatiroidismo secundario?

- a) Aumentar la ingesta de fósforo y disminuir la ingesta de calcio
- b) Aumentar la ingesta de fósforo y aumentar la ingesta de calcio
- c) Disminuir la ingesta de fósforo y disminuir la ingesta de calcio
- d) Disminuir la ingesta de fósforo y aumentar la ingesta de calcio
- e) Mantener la ingesta de fósforo y disminuir la ingesta de calcio

70) Una mujer se realiza biopsia de endometrio con Pipelle, como parte del estudio de una metrorragia recurrente. Es informada como adenocarcinoma invasor de endometrio. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Realizar histerectomía
- c) Iniciar progestágenos en dosis altas
- d) Realizar legrado uterino
- e) Iniciar quimioterapia y radioterapia

71) Un paciente de 23 años presenta ictericia, dolor abdominal y fiebre. Al examen físico se palpa hepatomegalia sensible y se aprecia ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina total: 5,4 mg/dl, bilirrubina directa: 3,8 mg/dl, FA: 150 UI/l, GOT: 390 UI/l, GPT: 210 UI/l, GGT: 430 UI/l, albúmina: 3,4 g/dl, protrombina: 83%. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis aguda por virus A
- b) Hepatitis alcohólica
- c) Hepatitis autoinmune
- d) Esteatopatitis no alcohólica
- e) Hepatitis viral crónica

72) Un hombre de 68 años diagnosticado de anemia, en tratamiento con sulfato ferroso, se realiza hemograma que demuestra hematocrito: 30%, hemoglobina: 9,5 g/dl, VCM: 106 fl, HCM: 33 pg, blancos: 3.200 por mm³, linfocitos: 68%, segmentados: 30%, baciliformes: 2%, plaquetas: 67.000 por mm³. Se solicitan TSH, niveles plasmáticos de vitamina B12, pruebas hepáticas y de función renal, resultando todas normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de vitamina B12
- b) Mielodisplasia
- c) Anemia de enfermedades crónicas
- d) Leucemia aguda
- e) Leucemia crónica

73) Un lactante de 7 meses de edad presenta lesiones cutáneas recurrentes en las mejillas y las zonas extensoras de las extremidades. Al examen físico se observan pápulas y microvesículas en las zonas descritas, sobre una base eritematosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Dermatitis seborreica
- c) Lupus eritematoso
- d) Sarna
- e) Impétigo

74) Una mujer presenta importante hemorragia después del parto, siendo diagnosticada de inercia uterina. Se inicia masaje uterino y se administran cristaloides y uterotónicos, sin embargo la hemorragia persiste. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de uterotónicos
- b) Realizar revisión instrumental del canal del parto
- c) Administrar plasma fresco congelado
- d) Realizar ligadura de las arterias uterinas
- e) Realizar histerectomía de urgencia

75) Una paciente con 6 semanas de amenorrea se realiza test de embarazo en orina que resulta positivo. Acude a control ginecológico, quien realiza ecografía transvaginal que no demuestra gestación intrauterina y solicita beta-HCG plasmática, que resulta 300 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva beta-HCG plasmática en 2 días
- b) Realizar nueva ecografía en 2 días
- c) Realizar nueva ecografía en 7 días
- d) Administrar metotrexato
- e) Realizar laparoscopia

76) Una mujer de 22 años, cursando un embarazo de 35 semanas de evolución se realiza una ecografía que muestra al feto creciendo en el percentil 3 para su edad gestacional, con relación perímetro abdominal / craneano de 0,9. Se realiza eco-doppler umbilical que demuestra ausencia de flujo arterial durante la diástole. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Administrar corticoides a la madre e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Solicitar subunidad beta de gonadotropina coriónica humana
- d) Administrar corticoides endovenosos y mantener una conducta expectante
- e) Observar evolución y controlar con nueva ecografía en 2 semanas

77) ¿Qué alternativa representa mejor la presentación clínica más habitual de la torsión testicular?:

- a) Dolor testicular intenso, irradiado a la zona lumbar, asociado a náuseas y vómitos
- b) Dolor testicular intenso, asociado a fiebre y que aumenta con la palpación testicular
- c) Dolor testicular intenso de inicio súbito, asociado a aumento de volumen testicular
- d) Dolor testicular intenso, asociado a aumento de volumen con transluminación positiva
- e) Dolor testicular intenso, con varicocele de instalación brusca

78) Un paciente de 38 años, consulta por dolor abdominal intenso, especialmente en el hipocondrio derecho, asociado a fiebre y a vómitos alimentarios. Al examen físico se observa FC: 88x', PA: 120/80 mmHg, T°: 38,1°C, abdomen blando, doloroso, con dolor muy intenso a la palpación del hipocondrio derecho. El hemograma muestra leucocitosis, sin anemia y la lipasa plasmática resulta normal, al igual que las transaminasas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar régimen hídrico y antibióticos por vía oral (ciprofloxacino + metronidazol)
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar colangiografía retrógrada endoscópica
- e) Realizar laparotomía exploradora

79) Un niño de 6 años presenta astenia, baja de peso, enuresis nocturna y aumento de la ingesta de agua. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal
- b) Insuficiencia renal
- c) Diabetes mellitus 1
- d) Polidipsia primaria
- e) Acidosis tubular

80) Un paciente de 67 años, fumador, consulta por baja de peso y expectoración hemoptoica. Se realiza TAC de tórax que muestra un nódulo pulmonar de 5 cm, parahiliar izquierdo, de bordes espiculados. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia excisional
- b) Solicitar biopsias por broncoscopía
- c) Solicitar biopsias por punción transtorácica, guiada por TAC
- d) Realizar mediastinoscopía
- e) Solicitar baciloscopías de expectoración

81) ¿Cuál es la dislipidemia que con más frecuencia acompaña al paciente diabético?

- a) Hipercolesterolemia LDL aislada
- b) Hipercolesterolemia LDL + hipertrigliceridemia
- c) Hipercolesterolemia LDL + HDL bajo
- d) Hipertrigliceridemia + HDL bajo
- e) Hipertrigliceridemia + hipercolesterolemia HDL

82) Un paciente de 30 años, diagnosticado de esquizofrenia recientemente, consulta por sensación de incomodidad al estar quieto, por lo que cambia constantemente de posición y mueve las extremidades inferiores continuamente. Estos síntomas comenzaron poco tiempo después de iniciar el tratamiento antipsicótico con risperidona. El diagnóstico más probable es:

- a) Disonía
- b) Disquinesia
- c) Balismo
- d) Atetosis
- e) Acatisia

83) Un paciente presenta un accidente vascular encefálico de tipo hemorrágico, localizado en el tálamo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para este tipo de eventos?

- a) Hipertensión arterial
- b) Diabetes
- c) Edad
- d) Uso de antiagregantes
- e) Tabaquismo

84) Una mujer de 34 años presenta un aborto espontáneo, el que es manejado con legrado uterino. Posteriormente persiste en amenorrea 6 meses después, por lo que acude al ginecólogo, quien realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio fino, de 1 mm de grosor, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Neoplasia trofoblástica gestacional
- b) Disfunción hipotálamo-hipofisiaria
- c) Síndrome de Asherman (sinequias uterinas)
- d) Sinequias tuboováricas
- e) Hiperprolactinemia

85) Un hombre de 67 años presenta desde hace algunos un par de años problemas de memoria, asociados a dificultad para realizar sus actividades diarias. Además en los últimos meses ha presentado temblor de las extremidades superiores, algunos movimientos involuntarios y alucinaciones visuales complejas y recurrentes. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Esquizofrenia
- c) Hidrocefalia normotensiva
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Demencia frontotemporal

86) Un paciente cirrótico por alcohol, con 3 años de abstinencia, en tratamiento con lactulosa 15 cc cada 8 horas, por encefalopatía hepática, con furosemida 160 mg/d y con espironolactona 400 mg/d, debido a ascitis de difícil manejo, consulta por dolor abdominal y disnea. Al examen físico se constata ascitis a tensión. Se realiza paracentesis diagnóstica, que da salida a un líquido citrino, transparente, con albúmina de 1,5 mg/dl y 50 células por mm³, con 60% de neutrófilos y 40% de linfocitos. La conducta más adecuada es:

- a) Evacuar la ascitis y administrar albúmina endovenosa
- b) Iniciar ciprofloxacino oral y evacuar la ascitis
- c) Iniciar cefotaximo endovenoso, sin evacuar la ascitis
- d) Iniciar hidroclorotiazida
- e) Instalar un TIPS

87) ¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso de los antidepresivos tricíclicos?

- a) Sialorrea
- b) Diarrea
- c) Hipotensión arterial
- d) Baja de peso
- e) Insomnio

88) Un paciente joven, sin antecedentes de importancia, sufre un accidente de tránsito, con golpe en el tórax. Está muy adolorido y presenta algún grado de disnea. Al examen físico está vigil, orientado, con FC: 100x' regular, PA: 110/70 mmHg, FR: 20 x', saturación arterial de oxígeno: 93% a FiO₂ ambiental. Se ausculta disminución del murmullo pulmonar izquierdo, asociado a matidez. Se solicita radiografía de tórax que demuestra presencia de un derrame pleural izquierdo de tamaño moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos
- b) Realizar ventilación con ambú
- c) Realizar intubación orotraqueal
- d) Puncionar el segundo espacio intercostal
- e) Instalar una toracostomía con trampa de agua

89) Un adolescente de 17 años presenta un síncope mientras jugaba fútbol. Además refiere que desde hace unos meses presenta dolor torácico cuando realiza mucho ejercicio. El examen físico no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma que muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda
- b) Pericarditis constrictiva
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Válvula aórtica bicúspide
- e) Síndrome disautonómico

90) Un recién nacido, hijo de madre VIH en triterapia, nacido, por cesárea, se realiza Elisa para VIH, el que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar western blot
- b) Repetir el Elisa para VIH a los 6 meses de edad
- c) Indicar lactancia materna y seguir evolución, tratando a tiempo las infecciones oportunistas
- d) Solicitar recuento de linfocitos CD4(+)
- e) Tranquilizar a la madre, ya que lo más probable es que se trate de un falso positivo

SEGUNDA PARTE

1) ¿Cuál es el tratamiento de elección de la disentería por Shiguelia en el adulto?

- a) Metronidazol
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Ciprofloxacino
- d) Gentamicina
- e) Clindamicina

2) ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene MENOS probabilidades de desencadenar caídas en un anciano?

- a) Hidroclorotiazida
- b) Clonacepam
- c) Propanolol
- d) Atorvastatina
- e) Nifedipino

3) El tratamiento farmacológico de elección para lograr la completa remisión del trastorno de estrés postraumático (TEPT) es:

- a) Antipsicóticos
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos
- d) Benzodiacepinas
- e) Metilfenidato (derivado anfetamínico)

4) Un paciente de 33 años consulta porque cada vez que sube a una micro, su patente debe terminar en 7, 8 o en 9, ya que en caso contrario tiene la sensación de que chocará. Por esto muchas veces se demora varias horas en llegar de un lugar a otro, ya que no tiene vehículo propio y debe esperar mucho rato a que pase una micro con esta característica. Él reconoce esta situación como absurda, pero subirse a una micro, cuya patente termine en otro número, le causaría demasiada ansiedad. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Fobia simple
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Agorafobia

5) Un paciente de 67 años, fumador, diabético e hipertenso, en tratamiento con enalapril, metformina y aspirina, consulta por dolor precordial y disnea, de 4 horas de evolución, que se han intensificado en las últimas 2 horas. Refiere haber presentado un cuadro similar hace 10 horas, autolimitado, de 30 minutos de duración. Se solicita electrocardiograma que muestra inversión de la onda T en V1, V2 y V3. Se inicia aspirina, oxígeno, nitroglicerina y morfina y se solicitan troponinas, que resulta elevadas al doble de lo normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar coronariografía de urgencia
- b) Iniciar trombolisis endovenosa
- c) Iniciar anticoagulación con heparina endovenosa, por bomba de infusión continua
- d) Mantener una conducta expectante y solicitar un test de esfuerzo una vez resuelto el cuadro agudo
- e) Solicitar ecocardiograma

6) La diabetes insípida se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Poliuria
- b) Osmolaridad plasmática elevada
- c) Osmolaridad urinaria disminuida
- d) Hiponatremia
- e) Los diuréticos tiazídicos son de utilidad en la diabetes insípida nefrogénica

7) Un paciente de 55 años consulta por dolor perianal muy intenso, que inició de manera rápida hace 5 horas y que aumenta al sentarse. A la inspección perianal se observa aumento de volumen de 3 cm de largo en la zona perianal izquierda, de color violáceo, muy doloroso a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Fisura anal aguda
- b) Condiloma
- c) Absceso perianal
- d) Hemorroide externo trombosado
- e) Plicoma

8) El inicio de la pubertad en las niñas está determinado por:

- a) Olor axilar adulto
- b) Menarquia
- c) Aparición de vello púbico
- d) Telarquia
- e) Aceleración de la velocidad de crecimiento

9) En un ensayo clínico se determinó que un fármaco presenta un número necesario para dañar (NNH) de 7. Esto quiere decir que:

- a) El 7% de los pacientes que utilizan el fármaco presentan alguna reacción inconveniente
- b) Uno de cada 7 pacientes que utilizan el fármaco presentan algún efecto negativo causado por el fármaco
- c) Los pacientes que consumen el fármaco tienen 7 veces más probabilidades de presentar efectos adversos que los que no lo consumen
- d) El fármaco presenta un alto perfil de seguridad
- e) Se puede administrar hasta un máximo de 7 veces la dosis terapéutica, antes de producir efectos negativos importantes

10) Una mujer de 21 años, cursando su primer embarazo de 8 semanas, presenta metrorragia escasa, que a la especuloscopia, proviene de la cavidad endometrial. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar ecografía transvaginal
- b) Solicitar gonadotropina coriónica humana en orina
- c) Solicitar gonadotropina coriónica humana en sangre
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar metotrexato

11) Una mujer de 30 años, sexualmente activa, sin pareja estable, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre y leucorrea. Al examen físico se constata dolor a la palpación anexial y a la movilización cervical. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Tricomoniasis
- c) Proceso inflamatorio pélvico
- d) Apendicitis aguda
- e) Aborto séptico

12) La clindamicina es el tratamiento antibiótico de elección de:

- a) Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
- b) Absceso pulmonar
- c) Amigdalitis pultácea
- d) Neumonía por *Staphylococcus aureus*
- e) Derrame paraneumónico simple

13) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se identifica frecuentemente en la colitis ulcerosa?

- a) Absceso perianal
- b) Masa abdominal palpable
- c) Compromiso del intestino delgado
- d) Fístula enterocutánea
- e) Pseudopólipos intestinales

14) Una paciente de 30 años, en amenorrea desde hace 2 meses, presenta vómitos diarios y síntomas de hipertiroidismo. Al examen físico se palpa útero suprapúbico y se palpan tumores anexiales bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Struma ovarii
- b) Cáncer de ovario
- c) Síndrome poliglandular
- d) Mola completa
- e) Adenoma hipofisiario hiperproductor de TSH

15) Un paciente de 23 años terminó una relación amorosa de 2 años de duración, hace 1 mes y desde entonces se ha sentido intranquilo, ansioso y desmotivado. Sale menos con sus amigos de lo habitual y se ha emborrachado en varias oportunidades, a pesar que raramente lo hacía antes. No presenta ideación suicida ni ha variado sus hábitos de alimentación ni de sueño. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión atípica
- b) Distimia
- c) Trastorno adaptativo
- d) Trastorno de angustia
- e) Trastorno de estrés postraumático

16) ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un inductor?

- a) Propofol
- b) Fentanyl
- c) Meperidina
- d) Succinilcolina
- e) Atracurio

17) Un niño de 5 años presenta fiebre hasta 38,5°C y cefalea, asociada a rigidez de nuca esbozada. Se realiza punción lumbar, con salida de líquido transparente, incoloro, con glucosa 70 mg/dl, proteínas: 50 mg/dl, células: 105 x mm³, con 90% de mononucleares y sin visualización de bacterias a la tinción de Gram. El agente etiológico más probable es:

- a) Mycoplasma
- b) Neumococo
- c) Bacilo de Koch
- d) Enterovirus
- e) Virus Herpes simplex

18) ¿Cuál es el mecanismo más frecuente que causa las fracturas de muñeca?

- a) Caída a nivel
- b) Golpe directo
- c) Pronación forzada
- d) Valgo forzado
- e) Tracción forzada

19) Una mujer de 31 años consulta por aparición de un nódulo cervical ubicado en la línea media, en la zona supraesternal. Se solicita TSH que resulta normal y ecografía tiroidea que demuestra un nódulo de 2 cm de diámetro y consistencia sólida, sin presencia de adenopatías sospechosas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina en dosis bajas
- b) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- c) Administrar yodo radiactivo en dosis terapéutica
- d) Realizar biopsia por punción con aguja fina
- e) Realizar biopsia quirúrgica de tipo excisional

20) Un paciente VIH(+) en tratamiento antirretroviral consulta por edema de extremidades inferiores. Al examen físico destaca edema blando de ambas extremidades inferiores, asociado a edema palpebral, sin otras alteraciones. En sus exámenes presenta hemograma normal, creatininemia 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, colesterol: 250 mg/dl, complemento normal, sedimento de orina con 10 eritrocitos por campo y proteinuria de 5 gramos en 24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefrosis lipoidea
- b) Nefritis por citomegalovirus
- c) Tuberculosis renal
- d) Nefropatía membranosa
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

21) Un niño de 7 años presenta cefalea, fiebre, compromiso del estado general y claudicación de la marcha, de 7 días de evolución. Al examen físico se aprecia pálido, con algunas equimosis y petequias en las extremidades inferiores y dolor a la palpación de la tibia izquierda. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 27%, hemoglobina: 8,2 g/dl, plaquetas: 21.000 x mm³, glóbulos blancos: 5.000 x mm³, linfocitos: 85%, neutrófilos: 15%. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar corticoides
- b) Indicar tratamiento sintomático
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Realizar esplenectomía
- e) Solicitar IgM para citomegalovirus y para virus Epstein Barr

22) Un paciente de 67 años sufre una caída, golpeándose la cabeza contra un mueble. Inicialmente está bien, sin embargo evoluciona con cefalea persistente, progresiva y 15 horas después presenta sopor y lenguaje incoherente. El diagnóstico más probable es:

- a) Estatus epiléptico
- b) Hemorragia subaracnoidea
- c) Hematoma extradural
- d) Hematoma subdural
- e) Contusión cerebral

23) Además del minimental, ¿Qué otra prueba es útil como método de detección de deterioro cognitivo en los adultos mayores?

- a) Escala GDS
- b) Test del reloj
- c) TAC de cerebro
- d) Test de coeficiente intelectual de Raven
- e) Método CAM

24) Una paciente de 67 años consulta por dolor de la rodilla derecha, especialmente al caminar largas distancias. Al examen físico se aprecia movilidad completa dolorosa en la flexión extrema y signos de derrame articular. La radiografía muestra disminución del espacio articular y el estudio del líquido sinovial muestra un líquido filante, transparente, con 10 células por mm³. El tratamiento de primera línea de la patología descrita es:

- a) Paracetamol
- b) Indometacina
- c) Prednisona
- d) Metotrexato
- e) Ciclofosfamida

25) En un estudio de casos y controles se obtienen la siguiente información:

	Casos Cá. Gástrico	Pacientes Sanos	Total
Exposición a pesticidas (+)	50	50	100
Exposición a pesticidas (-)	200	250	450
Total	250	300	550

Calcule el Odds Ratio (OR):

- a) 1,00
- b) 1,20
- c) 1,25
- d) 1,50
- e) 2,50

26) En un paciente con una hemorragia cerebelosa NO esperaría encontrar:

- a) Hipotonía
- b) Temblor de reposo
- c) Dismetría
- d) Ataxia
- e) Adiadococinesia

27) El diagnóstico de la hepatitis fulminante requiere de:

- a) Ascitis
- b) Elevación de las transaminasas por sobre 5.000 UI/l
- c) Alargamiento significativo del tiempo de protrombina
- d) Biopsia hepática con necrosis hepatocelular
- e) Encefalopatía

28) Una mujer en trabajo de parto presenta monitoreo cardíaco fetal, con FCF basal de 105 lpm y presencia de desaceleraciones tardías en relación al 80% de las contracciones uterinas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Interrumpir por la vía más expedita
- b) Iniciar aceleración occitócica
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Solicitar ecografía doppler de las arterias umbilicales
- e) Mantener una conducta expectante

29) Un paciente de 5 años presenta diarrea aguda, que evoluciona con anuria, palidez e hipertensión arterial. Se solicitan exámenes generales que muestran anemia, trombocitopenia y marcada elevación de la creatinina hasta 8 mg/dl. Evoluciona con desorientación, asterixis y dolor precordial, constatándose la presencia de frotos pericárdicos. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar vasodilatadores endovenosos
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Iniciar IECAs orales
- d) Administrar hidrocortisona endovenosa
- e) Realizar hemodiálisis de urgencia

30) Un paciente de 20 años muy retraído y solitario presenta ideas de que los espíritus malignos se apoderan de él y de las cosas que lo rodean. Refiere que le hablan con frecuencia. La madre relata que en ocasiones se queda inmóvil por horas y que en otras habla solo y grita. Al examen físico destaca rigidez cérea de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia paranoide
- b) Esquizofrenia simple
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Esquizofrenia Catatónica
- e) Trastorno esquizoafectivo

31) Un hombre de 24 años presenta fiebre, astenia odinofagia y dolores en las costillas y en las tibias desde hace 7 días. Al examen físico se palpa esplenomegalia y se observan algunas petequias y equimosis en las extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Leucemia aguda
- c) Linfoma
- d) Púrpura trombocitopénico inmune
- e) Leucemia linfática crónica

32) Un recién nacido prematuro de 7 días de vida, alimentado exclusivamente con leche materna, presenta ictericia desde hace 3 días, que compromete hasta los muslos. Su grupo sanguíneo es O, Rh(-) y la bilirrubina total alcanza los 10 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Hemólisis por incompatibilidad de grupo Rh
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia por lactancia materna
- e) Atresia biliar primaria

33) Un paciente de 45 años, con antecedente de bronquiectasias presenta hemoptisis abundante, con tos y dificultad respiratoria, con requerimiento de oxígeno para mantener saturaciones arteriales mayores a 90%. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar intubación traqueal y ventilar a presión positiva
- b) Realizar intubación bronquial selectiva y realizar broncoscopía
- c) Administrar plasma fresco congelado y realizar broncoscopía
- d) Realizar apoyo ventilatorio con Bi-PAP
- e) Realizar embolización de las arteria bronquiales

34) Un paciente presenta entrada de un cuerpo extraño vegetal en el ojo izquierdo. Algunas horas después evoluciona con ojo rojo profundo, dolor ocular y fotofobia. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar colirios antibióticos cada 1 hora
- b) Realizar aseo con abundante agua y realizar sello ocular con ungüento antibiótico
- c) Indicar sello ocular no compresivo y administrar antibióticos sistémicos
- d) Realizar inversión palpebral y observar bajo tinción con fluoresceína
- e) Indicar analgésicos y lágrimas artificiales

35) Se eligen 100 paciente diagnosticados de asma persistente y se aleatorizan en 2 grupos de 50 pacientes cada uno. El primer grupo recibe fluticasona + salbutamol, mientras que el segundo grupo recibe budesonida + salbutamol. Se siguen por 6 meses, evaluándose la tasa de remisión y la de efectos adversos. Al cabo de ese tiempo los pacientes que estaban recibiendo la fluticasona + salbutamol suspenden ese tratamiento e inician la budesonida + salbutamol y viceversa. Se siguen por 6 meses más, evaluándose los mismos outcomes. Qué tipo de ensayo clínico es:

- a) Estratificado
- b) Cruzado
- c) Factorial
- d) Apareado
- e) Sesgado

36) Una mujer refiere que le tiene pánico a las arañas, al punto que se queda paralizada al ver una. Esto empezó cuando era niña y vio un reportaje de sobre las arañas de rincón. En una oportunidad debió estar encerrada en su cuarto por cerca de 5 horas, porque había una araña en la puerta y no se atrevía a matarla o a pasar por ahí. Ha presentado crisis de angustia en algunas oportunidades, en que una araña se ha subido a su ropa u a su cuerpo, y sólo imaginarse que hay una araña cerca la pone ansiosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia simple
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno de pánico
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

37) Un niño de 5 años presenta aparición de petequias generalizadas y una equimosis en la extremidad inferior izquierda. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 46%, glóbulos blancos: 7.800 x mm³, linfocitos: 38%, neutrófilos: 55%, monocitos: 5%, eosinófilos: 1%, basófilos: 1%, plaquetas: 50.000 x mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo y controlar hasta la resolución espontánea
- b) Iniciar prednisona
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Realizar esplenectomía
- e) Iniciar aspirina

38) Una paciente de 50 años presenta metrorragia de 3 días de evolución, abundante, con presencia de coágulos. La ecografía transvaginal muestra cavidad endometrial con abundante contenido, probablemente sangre. El test de embarazo es negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales en dosis habituales
- b) Iniciar anticonceptivos orales en altas dosis
- c) Administrar ácido tranexánico
- d) Realizar legrado biopsico-terapéutico
- e) Realizar histerectomía

39) Un paciente de 27 años consulta por disnea de esfuerzos y ortopnea de 2 almohadas. Al examen físico se constata desplazamiento del choque de la punta, hepatomegalia y edema de extremidades inferiores. La auscultación pulmonar demuestra crépitos bibasales y la auscultación cardíaca demuestra ritmo regular a 90 lpm, en tres tiempos por presencia de un tercer ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Comunicación interventricular
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Taponamiento pericárdico
- e) Miocardiopatía dilatada

40) Un lactante de 5 meses presenta retraso del crecimiento, además ha presentado varias infecciones respiratorias. La madre refiere que se cansa al tomar leche. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bibasales y un soplo cardíaco holosistólico. Satura 81% a FiO₂ ambiental, mejorando a 93% con oxígeno en altas concentraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Tetralogía de Fallot
- b) Endocarditis bacteriana
- c) Comunicación interventricular
- d) Comunicación interauricular
- e) Ductus arterioso persistente

41) Una paciente de 29 años consulta por fiebre, astenia, mialgias y debilidad, especialmente de las extremidades superiores, de predominio proximal. Además presenta eritema de los hombros y la zona superior del tronco. Se solicitan exámenes que demuestran anemia normocítica, con VHS de 45 mm/h, ANA(+), ANCA(-) y creatinfosfoquinasas muy elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Vasculitis de Wegener
- c) Polimialgia reumática
- d) Vasculitis de Takayasu
- e) Dermatomiositis

42) Una paciente de 35 años con antecedente de astenia de 3 meses de evolución, consulta por un cuadro de dolor abdominal, vómitos y lipotimias. Presenta PA: 80/40, FC: 125 x', regular, sin alteraciones en el examen físico segmentario. El monitoreo electrocardiográfico demuestra taquicardia sinusal. En sus exámenes destacan hemoglucotest: 72 mg/dl, Na+: 130 mEq/l, K+: 5,5 mEq/l, Cl-: 91 mEq/l. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico y administrar betabloqueo e.v.
- b) Administrar suero fisiológico e iniciar drogas vasoactivas e.v.
- c) Administrar suero glucosado + 2g NaCl + 1g KCl e iniciar insulina e.v.
- d) Administrar suero fisiológico y administrar hidrocortisona e.v.
- e) Realizar cardioversión eléctrica

43) Un paciente de 30 años consulta por tos y disnea sibilante, especialmente ante la exposición al frío y ante infecciones respiratorias altas. Tiene antecedente de rinitis alérgica, la que trata con loratadina. El examen físico muestra espiración prolongada y algunas sibilancias espiratorias, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar espirometría
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Solicitar prick test
- d) Solicitar niveles plasmáticos de IgE
- e) Iniciar tratamiento con salbutamol y prednisona

44) Una mujer de 23 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas, complicado con una preclamsia moderada, consulta por metrorragia escasa y contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico destaca útero hipertónico. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un tacto vaginal para determinar la vía más expedita de parto
- b) Solicitar ecografía obstétrica
- c) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- d) Administrar tocolítico
- e) Mantener conducta expectante e interrumpir por cesárea cuando el embarazo llegue a término

45) Un paciente de 27 años presenta desde hace varios meses aparición de lesiones eritematosas pseudopapulares (habonosas), intensamente pruriginosas que aparecen en la piel al contacto con el polvo o en relación al sudor, y que desaparecen con el lavado con agua fría. Las lesiones suelen aparecer diariamente en distintos lugares de la piel y aumentan de tamaño al rascarse. Además refiere que en ocasiones aparecen sin poder identificar un desencadenante claro. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

- a) Dermatitis atópica e indicar crema humectante
- b) Urticaria crónica e iniciar antihistamínicos orales
- c) Dermatitis atópica e iniciar corticoides tópicos
- d) Urticaria crónica e iniciar corticoides orales
- e) Vasculitis alérgica e iniciar corticoides orales

46) La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza por ser:

- a) Regenerativa
- b) Macrocítica
- c) Normocítica
- d) Microcítica
- e) Hipocroma

47) Una paciente de 40 años presenta crisis de pánico recurrentes, desde hace 3 meses. La primera de ellas se produjo mientras caminaba en una multitud, sin embargo las crisis posteriores han sido inesperadas, sin desencadenante claro. En algunas ocasiones presenta ansiedad previo a la crisis, y tiene miedo a morir en un nuevo episodio. ¿Qué alternativa representa el mejor tratamiento inicial para esta paciente?

- a) Fluoxetina 20 mg cada día y alprazolam 0,25 mg cada mañana
- b) Alprazolam 1 mg cada 12 horas
- c) Fluoxetina 40 mg cada día
- d) Alprazolam 0,5 mg cada 12 horas y fluoxetina 10 mg cada día
- e) Alprazolam 1 mg cada 8 horas y fluoxetina 60 mg cada día

48) Un niño de 5 años presenta una convulsión tónico-clónica, autolimitada, de 5 minutos de duración. La madre refiere que no había presentado otros síntomas y el examen físico y neurológico es normal, al igual que sus exámenes generales. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, sin necesidad de mayor estudio por el momento
- b) Iniciar fenitoína y derivar al especialista
- c) Solicitar electroencefalograma y derivar al especialista
- d) Solicitar TAC de cerebro
- e) Realizar punción lumbar

49) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, respecto a la fiebre tifoidea?

- a) Se diagnostica preferentemente mediante hemocultivos
- b) Su tratamiento de elección es el ciprofloxacino
- c) Se contrae por consumir carnes y huevos mal cocidos
- d) El agente causal es la Salmonella Typhi
- e) Su incidencia ha disminuido considerablemente en Chile, especialmente después de la campaña de erradicación del Cólera

50) Una paciente diabética e hipertensa, diagnosticada de estenosis mitral, presenta un cuadro de palpitaciones, por lo que se realiza un electrocardiograma que es compatible con una fibrilación auricular. Es manejada adecuadamente con amiodarona y anticoagulación con heparina endovenosa, la que se cambia por cumarínicos orales, cuya dosis es ajustada por otro médico. Acude a control 3 meses después, sin síntomas, constatándose ritmo sinusal e INR: 2,5. La conducta más adecuada, respecto a la anticoagulación es:

- a) Suspender los cumarínicos, sin necesidad de iniciar antiagregantes
- b) Suspender los cumarínicos e iniciar aspirina oral
- c) Disminuir la dosis de cumarínicos
- d) Mantener la dosis de cumarínicos
- e) Aumentar la dosis de cumarínicos

51) La complicación más frecuente del cáncer de colon es:

- a) Hemorragia
- b) Ascitis
- c) Obstrucción
- d) Perforación
- e) Infarto

52) Un hombre de 81 años, hospitalizado por una trombosis reciente de la vena poplítea izquierda, en tratamiento actual con heparina endovenosa, presenta desorientación temporoespacial y agitación psicomotora, con ideas de estar encarcelado. Al examen físico está inatento y le es imposible invertir series. No se aprecian signos neurológicos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Demencia senil
- c) Accidente isquémico transitorio
- d) AVE hemorrágico
- e) AVE isquémico, por foramen oval permeable

53) ¿Qué hallazgo es más constante en las pacientes con endometriosis?

- a) Infertilidad
- b) Elevación del marcador Ca-125
- c) Dismenorrea
- d) Disquexia
- e) Obstrucción al tracto de salida

54) ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una medida de “protección de la salud”?

- a) Saneamiento ambiental
- b) Educación de hábitos saludables
- c) Screening de enfermedades
- d) Campañas de vacunación
- e) Rehabilitación

55) Un paciente con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia presenta un cuadro de 4 horas de evolución de dolor abdominal bajo e imposibilidad de orinar. Al examen físico se palpa la vejiga urinaria distendida, dura y dolorosa. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides
- b) Administrar antagonistas alfa-adrenérgicos
- c) Instalar sonda Foley
- d) Drenar con sonda Nelaton
- e) Realizar cistostomía percutánea

56) Una mujer, sin patologías conocidas, cursando su 36ª semana de embarazo acude a control, constatándose en el examen físico la presencia de un soplo sistólico eyectivo III/VI, de mayor intensidad en la zona para esternal derecha, a la altura del segundo espacio intercostal. No presenta otros síntomas ni otros hallazgo en el examen físico, excepto por los cambio fisiológicos del embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar hemocultivos y ecocardiograma
- c) Solicitar electrocardiograma
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Interrumpir el embarazo

57) Un paciente con antecedente de enfermedad de colitis ulcerosa consulta por astenia, ictericia y prurito. Al examen además se palpa hepatomegalia leve. En sus exámenes destaca hiperbilirrubinemia de predominio directo, hasta 3,8 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 360 UI/l, GGT: 223 UI/l, GPT: 57 UI/l, GOT: 66 UI/l. Se solicitan anticuerpos antinucleares (-), anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (+) y anticuerpos antimitocondriales (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Cirrosis biliar primaria
- b) Hepatitis autoinmune
- c) Colangitis esclerosante primaria
- d) Cáncer de páncreas
- e) Colédocolitiasis

58) La causa más frecuente de metrorragia puerperal tardía, es decir, aquella que inicia después de 24 horas de ocurrido el parto, es:

- a) Inercia uterina
- b) Laceraciones del canal del parto
- c) Restos ovulares
- d) Endometritis puerperal
- e) Disfuncional

59) Una mujer de 45 años presenta una hemiparesia izquierda que se instala de manera progresiva en 3 días. Además en las últimas horas comienza con dificultad para ver con el ojo izquierdo y al examen físico se aprecia escape pupilar en dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular cerebral isquémico
- b) Accidente vascular cerebral hemorrágico
- c) Tumor cerebral
- d) Esclerosis múltiple
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

60) Un niño de 5 años presenta aumento de volumen facial, edema de extremidades inferiores y hematuria en 3 oportunidades. Al examen físico se observa además hipertenso y algo pálido. Se solicitan exámenes que muestran hematuria con 70 glóbulos rojo por campo y 20% de dismorfia, proteinuria de 24 horas de 300 mg/m2, creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, complemento disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- b) Enfermedad por cambios mínimos
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Glomeroesclerosis focal y segmentaria
- e) Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva

61) Un paciente de 34 años consulta por una placa eritematosa y pruriginosa en la cara medial del tobillo izquierdo, de varias semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa de 10 cm de diámetro, descamativa, con algunas escoriaciones y signos de grataje. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple crónico
- b) Psoriasis
- c) Dermatitis de contacto
- d) Liquen plano
- e) Dermatitis atópica

62) ¿Cuál es el(los) mejor(es) examen(es) ante la sospecha clínica de una enfermedad de Cushing?

- a) Cortisol plasmático basal
- b) Cortisol plasmático post-ACTH
- c) ACTH plasmática basal
- d) Cortisol urinario libre de 24 horas
- e) ACTH + cortisol plasmáticos basales

63) ¿Qué institución está encargada de confirmar los casos sospechosos de enfermedades importantes, como el VIH o las infecciones por Haemophilus influenza B?

- a) Instituto médico legal
- b) Servicio de salud
- c) Instituto de salud pública
- d) Instituto nacional de estadísticas
- e) Superintendencia de salud

64) El tratamiento antibiótico de elección de la otitis externa difusa, no complicada, en un niño de 5 años es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- c) Ciprofloxacino local
- d) Ceftazidina endovenosa
- e) Cefadroxilo oral

65) Un paciente de 50 años consulta por disnea. Al examen físico se aprecia matidez de la base pulmonar izquierda. Se solicita radiografía de tórax que identifica un derrame pleural izquierdo de tamaño moderado. Se realiza toracocentesis y el estudio de líquido pleural muestra un líquido transparente, con proteínas 2,5 g/dl, LDH: 97 UI/dl, células: 56 x mm³, con 90% de mononucleares, pH: 7,4. Las proteínas plasmáticas fueron 6,4 g/dl y la LDH plasmática resultó 250 UI/l. la etiología más probable del derrame pleural, de entre las siguientes, es:

- a) Cáncer
- b) Tuberculosis pleural
- c) Empiema
- d) Derrame paraneumónico simple
- e) Insuficiencia cardíaca

66) ¿Cuál de las siguientes vacunas no debe administrarse a un paciente severamente inmunodeprimido?

- a) Antitetánica
- b) Anti-varicela
- c) Anti-Hepatitis B
- d) Anti-influenza
- e) Anti-Hepatitis A

67) Un paciente consulta por tos crónica y disfonía, mayor en las mañanas. No fuma y la radiografía de tórax resulta normal. Usted sospecha que la etiología secundaria a reflujo gastroesofágico. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría?

- a) Ninguna
- b) pH-metría esofágica
- c) Endoscopia digestiva alta
- d) Manometría esofágica
- e) Radiografías baritadas de esófago

68) Un paciente presenta una fractura de codo, la que es tratada quirúrgicamente, con buenos resultados. Sin embargo, meses después evoluciona con parestesias en los dedos cuarto y quinto de la mano izquierda, asociado a disminución de la sensibilidad en los dedos descritos. El diagnóstico más probable es:

- a) Atrapamiento del nervio cubital
- b) Atrapamiento del nervio radial
- c) Atrapamiento del nervio mediano
- d) Neuroapraxia del nervio cubital
- e) Axonotmesis del nervio radial

69) Una paciente de 26 años, primigesta, con 38 semanas de embarazo + 4 días, consulta por contracciones uterinas intensas y persistentes. Al examen físico se observan 3 contracciones uterinas cada 10 minutos, feto en presentación de vértice, cuello uterino borrado, con 6 cm de dilatación y membranas rotas. El registro cardíaco fetal muestra FCF basal a 130 lpm, con variabilidad de 10 lpm, presencia de aceleraciones y escasas desaceleraciones variables de 30 lpm de amplitud y 30 segundos de duración. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aceleración occitócica
- b) Administrar fenoterol endovenoso
- c) Administrar sulfato de magnesio
- d) Realizar cesárea de urgencia
- e) Permitir evolución espontánea bajo monitoreo fetal

70) ¿Cuál de las siguientes alternativas es más sugerente de una neuritis vestibular?

- a) Vértigo periférico, asociado a sensación de oído tapado y tinitus, de curso fluctuante
- b) Vértigo intenso, de segundos de duración que aparece al agacharse o al realizar otros movimientos con la cabeza
- c) Vértigo con nistagmos multidireccional, de inicio súbito y varias horas de evolución
- d) Vértigo con ataxia, dismetría y parálisis del nervio facial
- e) Vértigo intenso y persistente, con nistagmos horizontal de fase rápida a derecha, lateropulsiones a la izquierda, de inicio súbito

71) Un paciente de 40 años, obeso, se realiza un test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que muestra glicemia basal: 102 mg/dl, glicemia 2 horas postsobrecarga: 175 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta y ejercicios
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar glibenclamida
- d) Iniciar insulina
- e) Observar evolución sin necesidad de tratamiento alguno

72) ¿Cuál es la etiología más frecuente de los aneurismas aórticos abdominales?

- a) Infecciosas
- b) Congénitas
- c) Obstructivas
- d) Traumáticas
- e) Ateromatosas

73) Un paciente VIH, sin tratamiento ni controles, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y baja de peso de 3 kilogramos. No ha presentado sangre en las deposiciones ni fiebre. Tiene exámenes antiguos, hace más de un año, con linfocitos CD4 de 102 x mm³. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Criptosporidiasis
- b) Toxoplasmosis
- c) Giardiasis
- d) Shigellosis
- e) Colitis por citomegalovirus

74) El tratamiento de la displasia de cadera diagnosticada en los niños menores de 6 meses suele ser:

- a) Doble pañal
- b) Kinesioterapia
- c) Correas de Pavlik
- d) Yeso pelvipedio
- e) Cirugía

75) ¿Cuál de las siguientes espirometrías es compatible con una fibrosis pulmonar idiopática?

- a) Basal CVF:105%, VEF1:71%, VEF1/CVF:61%; Post-salbutamol CVF:110%, VEF1:72%, VEF1/CVF:60%
- b) Basal CVF:91%, VEF1:66%, VEF1/CVF:54%; Post-salbutamol CVF:109%, VEF1:94%, VEF1/CVF:74%
- c) Basal CVF:50%, VEF1:66%, VEF1/CVF:86%; Post-salbutamol CVF:51%, VEF1:65%, VEF1/CVF:84%
- d) Basal CVF:88%, VEF1:88%, VEF1/CVF:80%; Post-salbutamol CVF:89%, VEF1:95%, VEF1/CVF:85%
- e) Basal CVF:85%, VEF1:90%, VEF1/CVF:82%; Post-salbutamol CVF:86%, VEF1:89%, VEF1/CVF:80%

76) Un paciente de 35 años consulta por dolor abdominal de larga data, tipo cólico, asociado a constipación. Refiere sensación de distensión abdominal frecuente, mucosidad en las deposiciones, sin sangre y alivio del dolor ante la evacuación de gases o de deposiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Colitis ulcerosa
- c) Colitis bacteriana
- d) Enfermedad diverticular
- e) Síndrome de intestino irritable

77) Un paciente de 67 años con hematuria no glomerular recurrente, sin otros síntomas, se realiza una ecografía renal y vesical que no visualiza alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia renal
- b) Solicitar citología urinaria
- c) Solicitar baciloscopías de orina
- d) Solicitar cistoscopia
- e) Solicitar pielotomía

78) Un hombre de 30 años, previamente sano, consulta por astenia disminución de la libido e impotencia sexual. Refiere haber perdido las erecciones matinales. Además presenta dificultades para ver, caracterizadas por cuadrantopsias ínfero-temporales bilaterales. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes es:

- a) Prolactinoma
- b) Apoplejía hipofisiaria
- c) Hipopituitarismo autoinmune
- d) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- e) Esclerosis múltiple

79) Un paciente de 30 años consulta por edema de extremidades inferiores y fatigabilidad. Al examen físico se aprecia hepatomegalia e ingurgitación yugular, con colapso “y” prominente. ¿Qué examen es más adecuado para establecer el diagnóstico?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiograma
- c) Test de esfuerzo
- d) Radiografía de tórax
- e) TAC de tórax

80) Una paciente de 34 años, ingiere una gran cantidad de pastillas, con intención suicida, evolucionando con compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecia en coma, con FC: 71x', PA: 110/70 mmHg, FR: 4 rpm. No presenta focalidad neurológica y las pupilas no presentan alteraciones. ¿Qué fármaco es el responsable?

- a) Benzodiacepina
- b) Anticolinérgico
- c) Opiáceo
- d) Hipoglicemiante
- e) Colinérgico

81) ¿Qué patología puede ser desencadenada por una preclamsia severa?

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Embolia de líquido amniótico
- c) Coagulación intravascular diseminada
- d) Macrosomía fetal
- e) Polihidramnios

82) Un hombre de 28 años consulta por malestar general, fiebre y disnea de 2 días de evolución. Refiere que desde hace 2 semanas presentaba tos, odinofagia y rinorrea. Al examen físico se auscultan crépitos pulmonares bilaterales, asociados a algunas sibilancias espiratorias. El agente causal más probable es:

- a) Virus influenza
- b) Virus sincicial
- c) Mycoplasma
- d) Pneumococo
- e) Estafilococo áureo

83) El tratamiento del trastorno oposicionista desafiante es:

- a) Antidepresivos
- b) Metilfenidato
- c) Benzodiazepinas
- d) Psicoterapia al niño
- e) Educación a los padres de técnicas de disciplina

84) Un hombre de 58 años de edad, hipertenso, presenta en pocos minutos una rápida caída de la agudeza visual del ojo izquierdo, hasta poder diferenciar sólo la luz de la sombra con dicho ojo. La oculomotilidad es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar fondo de ojo
- b) Solicitar campo visual
- c) Solicitar eco-doppler carotídeo
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- e) Solicitar punción lumbar

85) La principal característica de los trastornos psicóticos es:

- a) La presencia de signos negativos
- b) Las alucinaciones
- c) La excentricidad
- d) La pérdida del juicio de realidad
- e) La buena respuesta a los neurolepticos

86) Una mujer de 62 años consulta por constipación y dolor abdominal de 6 semanas de evolución de carácter sordo, mayor en la fosa iliaca derecha. No refiere síntomas previos y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático y observar evolución
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar test de detección de sangre oculta en deposiciones
- e) Solicitar colonoscopia

87) Un trabajador de la construcción sufre un accidente laboral, resultando con una fractura expuesta del antebrazo derecho. ¿Qué medida está MENOS indicada antes de la resolución definitiva?

- a) Aseo con suero fisiológico
- b) Administrar antibióticos
- c) Vacunación antitetánica
- d) Sutura de la herida
- e) Inmovilización transitoria con valva de yeso abierta

88) Un niño de 6 meses presenta de manera súbita agitación y cianosis de labios, mientras jugaba con piezas de lego, sin poder toser ni llorar. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar maniobra de Heimlich
- b) Dar golpes en la región interescapular
- c) Realizar compresiones torácicas
- d) Dar insuflaciones, cubriendo la nariz y la boca del lactante
- e) Ponerlo cabeza abajo y sacudirlo

89) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, enalapril y nifedipino, consulta por disnea de 4 horas de evolución, que ha empeorado considerablemente en los últimos minutos, hasta hacerse de reposo. Habría suspendido todos sus medicamentos hace 1 semana. Al examen físico presenta FC: 100x', PA: 240/150 mmHg, FR: 27x', MP disminuido, con crépitos intensos bilaterales difusos. Se solicita un electrocardiograma que muestra signos de sobrecarga ventricular izquierda y una radiografía de tórax que es compatible con un edema pulmonar agudo. La saturación de oxígeno es 79% y el monitoreo electrocardiográfico sólo muestra una taquicardia sinusal. Además de iniciar oxigenoterapia y apoyo ventilatorio, la conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecocardiograma
- b) Administrar furosemida endovenosa
- c) Iniciar nitratos endovenosos
- d) Solicitar coronariografía
- e) Solicitar troponinas

90) Una paciente de 60 años se realiza un Papanicolaou que es informa atrofia marcada, sin visualización de células atípicas. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el PAP en un año
- b) Repetir el PAP de inmediato
- c) Administrar estrógenos locales y repetir el PAP en 3 meses
- d) Derivar a colposcopia y biopsia
- e) Realizar cono cervical

Respuestas:

PRIMERA PARTE

Preguntas

Respuestas

1	D
2	A
3	C
4	C
5	B
6	A
7	D
8	C
9	D
10	C
11	C
12	B
13	D
14	C
15	A
16	C
17	E
18	B

19	B
20	A
21	C
22	D
23	E
24	B
25	B
26	A
27	B
28	D
29	E
30	D
31	D
32	A
33	B
34	A
35	C
36	A
37	C
38	D
39	C
40	E
41	B
42	C
43	B
44	C
45	B
46	E
47	E
48	D
49	B

50	C
51	E
52	D
53	E
54	A
55	D
56	A
57	E
58	A
59	C
60	B
61	D
62	D
63	D
64	B
65	E
66	C
67	C
68	C
69	D
70	B
71	B
72	B
73	A
74	B
75	A
76	A
77	C
78	C
79	C
80	B

81	D
82	E
83	A
84	C
85	D
86	A
87	C
88	E
89	C
90	E

SEGUNDA PARTE

Preguntas	Respuestas
1	C
2	D
3	C
4	D
5	A
6	D
7	D
8	D
9	B
10	A
11	C
12	B
13	E
14	D
15	C
16	A
17	D
18	A
19	D

20	D
21	C
22	D
23	B
24	A
25	C
26	B
27	E
28	A
29	E
30	D
31	B
32	C
33	B
34	D
35	B
36	A
37	A
38	D
39	E
40	C
41	E
42	D
43	A
44	A
45	B
46	C
47	D
48	C
49	C
50	D

51	C
52	A
53	E
54	A
55	C
56	A
57	C
58	C
59	D
60	A
61	A
62	D
63	C
64	C
65	E
66	B
67	B
68	A
69	E
70	E
71	A
72	E
73	A
74	C
75	C
76	E
77	D
78	A
79	B
80	A
81	C

82

C

83

E

84

A

85

D

86

E

87

D

88

B

89

C

90

C

Ensayo EUNACOM – Prueba 7

PRIMERA PARTE

1) Una paciente de 19 años presenta un cuadro de ánimo bajo, anhedonia y falta de motivación, desde hace 3 meses, momento en que obtuvo un menor puntaje en la PSU de lo que esperaba. Desde entonces ha aumentado 6 Kg de peso y duerme cerca de 10 horas al día, cuando antes solía dormir 7 horas. No presenta ideación suicida. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Distimia
- c) Ciclotimia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Hipotiroidismo

2) Un niño de 20 meses de edad presenta fiebre e irritabilidad. En el examen físico se aprecia otoscopia con tímpano derecho abombado y eritematoso. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a especialista
- b) Solicitar impedanciometría
- c) Iniciar un macrólido
- d) Iniciar un AINE y amoxicilina
- e) Iniciar un AINE

3) Un paciente de 55 años, fumador e hipertenso, inicia dolor precordial, opresivo, intenso, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico está taquicárdico a 105x', con presión arterial de 168/108 mmHg, se ausculta un ritmo regular en 3 tonos por presencia de un cuarto ruido. Se toma electrocardiograma que demuestra elevación del segmento ST en V1, V2, V3 y V4, con inversión de la onda T en todas las derivadas precordiales. ¿Cuál de las siguientes alternativa le parece más correcta, para el manejo de este paciente?

- a) Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina e iniciar el protocolo de trombolisis endovenosa
- b) Administrar aspirina, morfina, oxígeno y nitroglicerina y anticoagular con heparina endovenosa, ajustando la dosis por TTPA
- c) Iniciar AINEs orales en dosis altas y controlar con ecocardiografía
- d) Solicitar ecocardiografía transesofágica de urgencia
- e) Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar test de esfuerzo

4) Una paciente de 29 semanas de gestación presenta salida de abundante líquido claro por los genitales, confirmandose una RPO por medio del test de cristalización. No se palpan modificaciones cervicales y el registro basal no estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos a la madre y mantener una conducta expectante
- b) Administrar corticoides y tocolíticos
- c) Administrar corticoides antibióticos y tocolíticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea

5) La enfermedad de Basedow Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. En su cuadro clínico presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Macroglosia
- b) Retracción palpebral
- c) Exoftalmo
- d) Temblor
- e) Intolerancia al calor

6) La rinitis hormonal es característica de:

- a) Hipotiroidismo
- b) Hipertiroidismo
- c) Síndrome de Cushing
- d) Menopausia
- e) Embarazo

7) Un paciente presenta un asma persistente leve, con tos en relación al ejercicio y a veces al exponerse al polvo, pero en general sus síntomas son poco frecuentes. Su examen físico es normal, sin embargo el test de metacolina demostró hiperreactividad bronquial. El tratamiento de elección es:

- a) Salbutamol inhalado, según horario
- b) Salbutamol inhalado, según síntomas
- c) Corticoides inhalados, según síntomas
- d) Corticoides inhalados, según horario y salbutamol inhalado, según síntomas
- e) Corticoides inhalados, según síntomas y salbutamol inhalado, según horario

8) El mejor indicador de la importancia de una enfermedad infecciosa de corta duración es:

- a) Mortalidad
- b) Letalidad
- c) Incidencia
- d) Prevalencia
- e) Tasa de ataque

9) Un paciente de 25 años presenta diarrea acuosa, pujo y tenesmo, asociadas a dolor abdominal y fiebre ocasional desde hace 2 meses. En el último tiempo la diarrea se ha vuelto sanguinolenta. Al examen físico se aprecia pálido, con un abdomen blando, depresible, sensible de manera difuso, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Diarrea viral
- c) Colitis bacteriana
- d) Colitis ulcerosa
- e) Parasitosis intestinal

10) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un lactante diagnosticado de criptorquidea derecha, cuyo testículo se encuentra en el conducto inguinal?

- a) Observar hasta los 4 años de vida
- b) Solicitar alfafetoproteína y gonadotropina coriónica de manera periódica
- c) Iniciar testosterona subcutánea
- d) Realizar orquiectomía inmediatamente
- e) Realizar descenso testicular y orquidopexia durante el segundo año de vida

11) Una puérpera de 2 días consulta por aumento de volumen y dolor en relación a la zona axilar anterior. Se observa una tumoración de 5 cm de diámetro, dolorosa a la palpación con escaso eritema de la piel que la recubre. El diagnóstico más probable es:

- a) Mastitis abscedada
- b) Adenitis supurada
- c) Hidrosadenitis
- d) Glándula mamaria accesoria
- e) Mastitis linfangítica

12) Un paciente de 30 años consulta por síncope de esfuerzo. Al examen físico se palpa un pulso amplio, bifásico y se ausculta un soplo cardíaco eyectivo, que aumenta con la maniobra de Valsalva. El choque de la punta se palpa en la línea medio-clavicular, en el cuarto espacio intercostal. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Síncopes vasovagales
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Miocardiopatía dilatada

13) Un lactante de 2 meses, alimentado exclusivamente con leche materna, presenta deposiciones cada 5 días, de consistencia blanda y de color amarillo claro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar lactulosa
- b) Solicitar coprocultivo
- c) Agregar fórmula láctea y suspender la lactancia materna
- d) Solicitar test de sudán
- e) Observar

14) Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia presenta anemia con hematocrito de 30%, hemoglobina de 10,2 g/dl y VCM de 80 ft. Se solicita perfil de hierro que demuestra ferremia baja, con transferrina disminuida y ferritina elevada. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia por enfermedades crónicas
- b) Anemia ferropénica
- c) Talasemia
- d) Anemia hemolítica
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

15) Una paciente de 23 años, presenta un atraso menstrual de 7 semanas, por lo que se realiza una prueba de embarazo que resulta positiva. Se realiza ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nueva ecografía en 48 horas
- b) Solicitar subunidad beta-HCG plasmática
- c) Realizar legrado
- d) Iniciar metotrexato
- e) Resolver quirúrgicamente

16) Un paciente VIH positivo, sin triterapia, con niveles bajos de linfocitos CD4 presenta cefalea y dificultad para mover la extremidad inferior izquierda. En una instancia posterior sufre una convulsión tónicoclónica. Al examen físico se constata paresia de la extremidad inferior izquierda y en menor grado de la extremidad superior izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma cerebral
- b) Meningitis por critococo
- c) Leucomalacia multifocal progresiva
- d) Toxoplasmosis cerebral
- e) Encefalitis por citomegalovirus

17) Un paciente de 23 años es emocionalmente inestable e impulsivo. Abusa del alcohol y consume drogas de manera ocasional. Además presenta relaciones familiares y amorosas inestables e intensas, ya que se molesta fácilmente y reacciona de manera agresiva. Tiene cicatrices de cortes en sus brazos y fue hospitalizado en una oportunidad por intento de suicidio por ingesta de medicamentos. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno de adaptación
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno de personalidad
- e) Depresión atípica

18) Un paciente fumador de 37 paquetes-año, consulta por disnea de medianos esfuerzos, asociado a tos ocasional, con expectoración. Al examen físico se aprecia aumento del diámetro torácico, espiración prolongada y se ausculta un murmullo pulmonar disminuido globalmente, con campos pulmonares grandes y algunas sibilancias bilaterales. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica de este paciente?

- a) Radiografía de tórax
- b) TAC de tórax
- c) Biopsia pulmonar
- d) Test de metacolina
- e) Espirometría

19) Una paciente, multípara de 3, cursando un embarazo de 40 semanas inicia dinámica uterina persistente de 4 CU por minuto y al tacto vaginal se constata borramiento cervical completo y dilatación de 3 cm, con membranas íntegras y feto en presentación cefálica. Sus últimos 2 partos fueron mediante cesárea. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio e indicar reconsulta en 6 horas más
- b) Hospitalizar en parto y dejar evolución espontánea
- c) Realizar rotura de membranas
- d) Realizar cesárea
- e) Iniciar aceleración occitócica

20) La presencia de cilindros hemáticos en el sedimento de orina es característica de:

- a) Glomerulonefritis
- b) Nefropatía diabética
- c) Pielonefritis aguda
- d) Urolitiasis
- e) Necrosis tubular aguda

21) Un paciente sufre una fractura de fémur, la que es manejada de manera quirúrgica. Evoluciona con dificultad respiratoria y compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con desaturación arterial de oxígeno marcada y se observan petequias generalizadas en el tronco y las extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Distrofia simpático refleja
- c) Púrpura trombocitopénico trombótico
- d) Reacción transfusional aguda
- e) Embolia grasa

22) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es compatible con enuresis primaria?

- a) Disuria
- b) Predominio nocturno
- c) Seis años de edad
- d) Antecedentes familiares
- e) Osmolaridad urinaria normal

23) Un paciente de 70 años presenta temblor de ambas extremidades superiores, mayor a la derecha. Al examen físico se aprecia temblor postural de las extremidades superiores y ligero temblor de la cabeza. La marcha es normal, al igual que los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Síndrome cerebeloso
- c) Corea de Huntington
- d) Temblor esencial
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

24) Una mujer de 30 años, asintomática, se realiza una ecografía transvaginal como parte de un chequeo ginecológico que demuestra un tumor anexial derecho de 3 cm de diámetro y aspecto sólidoquístico. Refiere tener ciclos regulares y su última menstruación comenzó hace 20 días. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Teratoma maligno
- c) Teratoma quístico
- d) Cuerpo lúteo
- e) Torsión ovárica

25) Un paciente de 30 años consulta por astenia y debilidad de varias semanas de evolución. Al examen físico se aprecian máculas hiperpigmentadas en la cara y en la mucosa oral. Se realizan exámenes generales, en los que destaca una ligera hiperkalemia. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Insuficiencia suprarrenal primaria
- c) Hipopituitarismo
- d) Hipotiroidismo
- e) Hiperprolactinemia

26) Una mujer se realiza un Papanicolaou que es informado como satisfactorio, con presencia de células con displasia escamosa de alto grado. Se deriva a colposcopia que muestra una zona acetoblanca, la que se biopsia, siendo informada como una neoplasia intraepitelial grado 3 (NIE-3). La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar PCR de virus papiloma humano e identificar el serotipo
- c) Realizar crioterapia
- d) Realizar cono cervical
- e) Realizar histerectomía radical

27) Un paciente de 27 años consulta por ardor epigástrico, que asciende por el tórax y el cuello, asociado a pequeñas regurgitaciones ácidas de alimentos, especialmente después de algunas comidas. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar erradicación de H. pylori
- b) Iniciar un inhibidor de la bomba de protones
- c) Solicitar manometría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar radiografía baritada de esófago y estomago

28) Un paciente hipertenso, de larga data, en tratamiento irregular con nifedipino, presenta disnea progresiva de varios meses de evolución, que actualmente es de esfuerzos moderados. Además presenta disnea paroxística nocturna y ortopnea de 2 almohadas. Al examen físico tiene presión arterial 160/110 mmHg, FC: 75x', ligero edema de extremidades inferiores, y desplazamiento del choque de la punta. La auscultación cardíaca es normal, y la auscultación pulmonar sólo demuestra escasos crépitos en ambas bases. La radiografía de tórax demuestra cardiomegalia moderada y el electrocardiograma sólo demuestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma es compatible con una cardiopatía hipertensiva, con cardiomegalia moderada, sin hipertensión pulmonar y con normalidad de la fracción de acortamiento. El tratamiento farmacológico, más adecuado para este paciente, es:

- a) Aspirina, atorvastatina y furosemida
- b) Furosemida, espironolactona, acenocumarol y aspirina
- c) Amiodarona, digoxina, furosemida y diltiazem
- d) Hidralazina, isosorbide, hidroclorotiazida y amiodarona
- e) Enalapril, carvedilol y furosemida

29) Un paciente de 47 años presenta dolor abdominal tipo cólico, asociado a vómitos en varias oportunidades y distensión abdominal progresiva. Al examen físico presenta abdomen distendido, doloroso, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos aumentados y metálicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia mesentérica
- b) Obstrucción intestinal
- c) Colitis isquémica
- d) Diverticulitis aguda
- e) Colitis ulcerosa

30) La fluoxetina y otros antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina son el tratamiento farmacológico de elección de la depresión en los adultos mayores, dado su mayor perfil de seguridad. Sin embargo no están libres de efectos adversos. Los más frecuentes entre éstos son:

- a) Hipotensión arterial y alza de peso
- b) Náuseas, sensación de sequedad bucal y disfunción sexual
- c) Constipación, somnolencia y poliaquiuria
- d) Hipertensión arterial y náuseas
- e) Síntomas extrapiramidales

31) Una paciente de 41 años consulta por dolores articulares de las manos y de una rodilla de varias semanas de evolución, que han ido en aumento, asociado a dificultad para mover las manos al despertar, que va cediendo a lo largo de la mañana. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema, edema y dolor de las muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángeas e interfalángicas distales. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Lupus
- c) Artrosis
- d) Gota
- e) Artritis reactiva

32) Una mujer de 35 años, cursando un embarazo de 29 semanas inicia contracciones uterinas persistentes, a razón de 2 cada 10 minutos y salida de líquido claro por genitales. El registro fetal es tranquilizador y el tacto vaginal demuestra borramiento cervical completo y dilatación de 4 cm, con feto en cefálica, en espinas -3 y membranas rotas. La conducta MENOS indicada es:

- a) Administrar tocolíticos
- b) Administrar antibióticos
- c) Administrar corticoides
- d) Realizar monitoreo fetal continuo
- e) Realizar amniocentesis

33) Una mujer de 55 años, obesa, consulta por aparición de múltiples máculas hipopigmentadas en la zona media del pecho y de la espalda, que en algunas ocasiones presenta escaso prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Pitiriasis versicolor
- b) Pitiriasis alba
- c) Pitiriasis rosada
- d) Vitíligo
- e) Psoriasis guttata

34) ¿Qué sistema de manejo de la vía aérea es más adecuado para protegerla de aspirar contenido gástrico?

- a) Ventilación no invasiva a presión positiva
- b) Máscara laríngea
- c) Intubación orotraqueal
- d) Cánula mayo
- e) Aspiración del contenido gástrico por sondas nasogástrica

35) Una mujer de 35 años presenta abundante metrorragia luego del parto, el que fue por vía vaginal y que presentaba como antecedente, la presencia de polihidroamnios durante la fase final del embarazo. Al examen físico se palpa el útero distendido, con el fondo ubicado en el punto medio entre el ombligo y la apófisis xifoides. El diagnóstico más probable es:

- a) Inercia uterina
- b) Laceración del canal vaginal
- c) Hematoma del canal del parto
- d) Acretismo placentario
- e) Rotura uterina

36) Una mujer, que trabaja en una empresa química, sufre entrada de ácido clorhídrico en el ojo derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar sello ocular con ungüento antibiótico
- b) Aplicar un álcali en el ojo comprometido
- c) Realizar aseo con 100 ml de suero fisiológico
- d) Lavar con abundante agua durante al menos 20 minutos
- e) Tomar pH lagrimal y decidir conducta según resultado

37) Son síntomas de la endometriosis excepto:

- a) Dolor al defecar
- b) Infertilidad
- c) Dolor durante las relaciones sexuales
- d) Sangrado durante las relaciones sexuales
- e) Algia pélvica

38) Un paciente de 20 años presenta tos con expectoración abundante, especialmente en las mañanas, de tipo mucosa, pero que en algunas ocasiones se exacerba, volviéndose mucopurulenta, respondiendo al uso de antibióticos automedicados. Se realiza una radiografía de tórax que demuestra algunas imágenes de engrosamiento bronquial, que podrían corresponder a bronquitis difusas. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar antibióticos orales de amplio espectro de manera periódica
- b) Iniciar broncodilatadores inhalados, asociados a corticoides orales
- c) Solicitar tomografía axial computada de tórax, con cortes finos
- d) Realizar broncoscopia
- e) Resolver quirúrgicamente

39) ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

- a) Mujer con metrorragia en estudio
- b) Mujer con síndrome antifosfolípidos
- c) Mujer con marcados antecedentes familiares de cáncer de mama
- d) Mujer con hepatitis B activa
- e) Mujer con síndrome de ovario poliquístico

40) Un paciente hospitalizado por un accidente vascular encefálico reciente, con serias dificultades para tragar, inicia cuadro de tos con expectoración y fiebre hasta 38,7°C, con saturación de oxígeno de 92% a FiO2 ambiental. Al examen físico se auscultan crepitaciones y múltiples estertores en la base derecha, por lo que se solicita radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Vancomicina
- b) Cefotaximo más claritromicina
- c) Cefazolina más clindamicina
- d) Ceftriaxona más metronidazol
- e) Amoxicilina más ácido clavulánico

41) Un paciente presenta disminución de la sensibilidad de las manos y los pies, especialmente la sensibilidad vibratoria, la de temperatura y la de dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononeuritis múltiple
- b) Polineuropatía
- c) Esclerosis lateral amiotrófica
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Síndrome piramidal

42) Un paciente de 22 años, previamente sano, presenta súbitamente dolor torácico izquierdo, con tope inspiratorio y disnea al caminar 2 cuadras. Al examen físico se aprecia una disminución del murmullo pulmonar izquierdo, con hipersonoridad a la percusión. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax
- b) Solicitar angio-TAC de tórax
- c) Solicitar dímero D plasmático
- d) Puncionar el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

43) Un paciente de 30 años tiene la sensación de ser invadido por gérmenes al tocar cualquier tipo de superficie, razón por la que lava frecuentemente sus manos y usa alcohol gel muchas veces al día, lo que le ha significado problemas dermatológicos y la burla de sus pares. Sabe que estas ideas son ridículas y que provienen de su propia mente, pero no sabe cómo controlarlas. Por esto su autoestima ha bajado considerablemente e incluso ha pensado en suicidarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno de personalidad

44) Una mujer de 48 años consulta por cuadros de minutos de duración de calor en la cara y el pecho que inician de manera brusca y que son más frecuentes e intensos en las noches. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el cuadro descrito?

- a) Antidepresivos
- b) Levotiroxina
- c) Cortisol
- d) Estrógenos
- e) Benzodiacepinas

45) Una paciente de 35 años consulta por dolor abdominal de varios meses de evolución, asociado a distensión abdominal y constipación. El dolor suele aumentar con algunos alimentos y cede con la evacuación de gases o de deposiciones. Refiere que en algunas oportunidades presenta mucosidad en las heces. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis ulcerosa
- b) Giardiasis
- c) Síndrome de intestino irritable
- d) Malabsorción intestinal
- e) Cáncer de colon

46) Un paciente de 70 años desde hace algún tiempo sufre dolor precordial, al caminar 2 cuadras, el que cede luego de 3 minutos de reposo. Además ha presentado 2 síncope relacionados con el esfuerzo y se cansa fácilmente. Al examen físico se palpa un pulso periférico de poca amplitud y se ausculta un soplo sistólico, eyectivo, III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Estenosis mitral
- d) Estenosis aórtica
- e) Insuficiencia mitral

47) Un niño de 7 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a vómitos. Al examen físico se aprecia aumento de volumen testicular derecho, asociadas a enrojecimiento. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo y analgésicos
- b) Iniciar antibióticos y analgésicos
- c) Solicitar urocultivo
- d) Solicitar ecografía-doppler testicular
- e) Realizar exploración quirúrgica

48) Un paciente presenta un cólico renal, el que es manejado con AINEs endovenosos, con buena respuesta. Se solicita pielo-TAC que muestra un cálculo de 4 mm en el uréter derecho, el que es eliminado espontáneamente 3 días después, correspondiendo a un cálculo de oxalato de calcio. ¿Cuál es la conducta más adecuada para evitar recurrencias?

- a) Disminuir la ingesta de calcio
- b) Disminuir la ingesta de oxalato
- c) Aumentar la ingesta de calcio
- d) Aumentar la ingesta de oxalato
- e) Aumentar la ingesta de agua

49) Un niño sonríe, fija la mirada y es capaz de levantar la cabeza en posición prona. Su edad aproximada es:

- a) 1 mes
- b) 3 meses
- c) 5 meses
- d) 7 meses
- e) 9 meses

50) Un paciente de 76 años sufre caída a nivel, resultando con intenso dolor a la movilidad de la extremidad inferior derecha y con imposibilidad para caminar. Al examen físico destaca dicha extremidad con ligera abducción y con rotación externa del muslo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de cadera
- b) Luxación de cadera
- c) Fractura lumbar con compromiso de las raíces L3 y L4
- d) Lesión del nervio femoral
- e) Lesión del nervio ciático

51) Un hombre de 75 años presenta pérdida progresiva de la audición a lo largo de 5 años, sin vértigo. Se solicita una audiometría que muestra una hipoacusia sensorineural bilateral, simétrica, con mayor compromiso de los tonos altos del espectro de frecuencias. El diagnóstico más probable es:

- a) Otosclerosis
- b) Otitis media crónica
- c) Presbiacusia
- d) Enfermedad de Meniere
- e) Trauma acústico

52) Un paciente de 69 años, fumador importante, presenta desde hace algunos meses, tos con expectoración, en ocasiones hemoptoica, asociado a disnea progresiva y astenia, sin otros síntomas. Al examen cardiopulmonar no se detectan alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer pulmonar
- b) Derrame pleural
- c) Bronquiectasias
- d) Tuberculosis
- e) EPOC

53) Una mujer cursando embarazo de 28 semanas presenta test de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos, resultando con glicemia basal de 100 mg/dl y glicemia post-sobrecarga de 170 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar dieta y ejercicios
- c) Iniciar metformina
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Iniciar insulina

54) Un niño de 8 meses presenta tos, dificultad respiratoria y cianosis. Al examen físico se aprecia taquipnea moderada y se auscultan múltiples sibilancias bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis obstructiva
- b) Neumonía atípica
- c) Bronquitis
- d) Bronquiolitis
- e) Asma

55) Un paciente de 58 años, sin antecedentes de importancia y asintomático, acude a control con urólogo, quien realiza un tacto rectal, palpando un nódulo de 1cm en el lóbulo prostático derecho, de consistencia dura. Se solicita antígeno prostático específico (APE), que resulta 1,2 ng/ml (VN: menor a 4 ng/ml). La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar nuevo tacto rectal en 6 meses
- c) Solicitar antígeno prostático libre
- d) Realizar biopsias prostáticas transrectales
- e) Realizar resección transuretral

56) Un paciente de 67 años, fumador importante, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con enalapril, aspirina y atorvastatina, presenta dolor en la pantorrilla derecha, que le obliga a detenerse luego de caminar más de 100 metros. No presenta dolor de reposo y el examen físico sólo destaca disminución de los pulsos pedios y tibiales posteriores, mayor a la derecha, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el cigarrillo e indicar ejercicios
- b) Suspender el cigarrillo e iniciar anticoagulación
- c) Suspender el cigarrillo y solicitar angiografía femoral
- d) Suspender el cigarrillo y solicitar PVR
- e) Suspender el cigarrillo y realizar bypass arterial

57) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con glibenclamida, con mal control metabólico presenta pérdida súbita de la visión del ojo izquierdo, persistiendo sólo con visión en una pequeña zona periférica del campo visual temporal inferior. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Edema macular
- c) Trombosis de la vena central de la retina
- d) Hemorragia vítrea
- e) Retinopatía diabética proliferativa

58) Un niño de 4 años tiene IPE: +2,1 desviaciones estándar, IPT: +1,2 desviaciones estándar, ITE +0,9 desviaciones estándar. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

59) ¿Qué trastorno de personalidad se asocia mayormente a los delincuentes?

- a) Esquizoide
- b) Límitrofe
- c) Narcisista
- d) Antisocial
- e) Paranoide

60) El factor más importante, en la insuficiencia cardíaca crónica, es:

- a) Etiología coronaria
- b) Grado de cardiomegalia
- c) Fracción de eyección ventricular
- d) Presión de fin de diástole
- e) El grado de hipertensión pulmonar secundaria

61) Un paciente sufre un accidente laboral, resultando con una fractura expuesta del dedo índice derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar aseo con abundante suero fisiológico, administrar analgésicos y antibióticos endovenosos y realizar vacunación antitetánica según esquema
- b) Realizar aseo con abundante suero fisiológico, administra analgésicos y antibióticos endovenosos y realizar inmovilización con yeso
- c) Realizar aseo con abundante suero fisiológico, administrar analgésicos endovenosos y cubrir con apósito estéril
- d) Administrar analgésicos endovenosos, realizar curación de la herida, cubrir con apósito estéril y derivar a un centro especializado
- e) Administrar analgésicos y antibióticos endovenosos, suturar la herida y derivar a centro especializado de inmediato

62) En un estudio se escogen a 500 pacientes diagnosticados de lupus sistémico, de los cuales 200 son seleccionados para recibir prednisona más azatioprina, mientras que los otros 300 son seleccionados para recibir prednisona más leflunomide. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Caso y control
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico
- e) Ensayo de campo

63) Un paciente de 56 años, diagnosticado de daño hepático crónico por consumo de alcohol, con hábito alcohólico suspendido hace 3 años consulta por aumento del perímetro abdominal. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, orientado, con abdomen distendido y ascitis moderada. Se realiza paracentesis diagnóstica, que descarta presencia de peritonitis bacteriana. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar lactulosa
- b) Realizar paracentesis evacuadora
- c) Iniciar régimen hiposódico y diuréticos
- d) Iniciar antibióticos endovenosos
- e) Administrar albúmina endovenosa

64) Un paciente de 45 años, obeso, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina, presenta un cuadro de sudoración, temblor y luego compromiso de consciencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Cetoacidosis diabética
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- d) Síncope vasovagal
- e) Hipoglicemia

65) Una paciente de 40 años consulta por disuria y leucorrea abundante. A la especulocopia se observa leucorrea verde abundante y marcados signos inflamatorios de la pared vaginal, con algunas Petequias. El agente causal más probable es:

- a) Candida albicans
- b) Escherichia coli
- c) Gardnerella vaginalis
- d) Trichomona vaginalis
- e) Chlamydia trachomatis

66) Un paciente de 60 años presenta un cuadro de fiebre, artralgias y edema de las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes donde destacan BUN: 51 mg/dl, creatinina: 3,5 mg/dl, hematuria dismórfica, proteinuria +++, VHS: 50 mm/h, blancos: 10.000 x mm³, hematocrito: 32%, Hb: 11 g/dl, VCM: 89 ft, HCM: 32 pg, ANA(-) y ANCA(+) en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Crioglobulinemia
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Granulomatosis de Wegener
- e) Poliangeítis microscópica

67) Un niño de 5 años presenta fiebre alta y cefalea. Al examen físico se aprecia muy decaído, con signos meníngeos, por lo que se realiza punción lumbar que demuestra salida de un líquido turbio, con proteínas 80 mg/dl, glucosa: 20 mg/dl, células: 890 x mm³, polimorfonucleares: 87%, mononucleares: 13%. No se visualizan bacterias en la tinción de Gram. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningitis viral
- c) Encefalitis herpética
- d) Meningitis Tuberculosa
- e) Infección parameningea

68) Una mujer de 35 años presenta desde hace varios años crisis de pánico recurrentes, inesperadas, asociadas a ansiedad anticipatoria y conductas evitativas, por miedo a morir durante una nueva crisis. Su examen físico y exámenes generales son normales. El tratamiento farmacológico más importante para la patología descrita es:

- a) Antidepresivos
- b) Antipsicóticos
- c) Estabilizadores del ánimo
- d) Benzodiacepinas
- e) Ninguno

69) Un paciente de 46 años presenta un cuadro de dolor abdominal epigástrico, de intensidad moderada, que aumenta paulatinamente, hasta hacerse muy intenso y que migra a la fosa ilíaca derecha. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso difuso, mayor en la fosa ilíaca derecha, con signos de Blumberg y resistencia muscular en dicha zona. Los ruidos hidroaéreos están presentes. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro, analgésicos y régimen líquido
- b) Iniciar antibióticos de amplio espectro, analgésicos y régimen cero
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Resolver de manera quirúrgica de inmediato

70) Una primigesta de 19 años de edad, cursando embarazo de 31 semanas presenta edema de extremidades inferiores y presión arterial de 150/90 mmHg en varias tomas seriadas, realizadas durante 6 horas. El resto del examen físico no aporta mayor información. ¿Qué medida es más útil para definir el diagnóstico?

- a) Solicitar hemograma con frotis
- b) Solicitar clearance de creatinina
- c) Solicitar proteinuria de 24 horas
- d) Solicitar ecografía doppler de arterias uterinas
- e) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales

71) La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en los pacientes adultos es:

- a) Diabetes mellitus
- b) Glomerulonefritis
- c) Pielonefritis
- d) Hipertensión arterial
- e) Postrenal

72) La capacidad de obtener resultados favorables a menor costo se denomina:

- a) Eficacia
- b) Costo-beneficio
- c) Costo-efectividad
- d) Costo-utilidad
- e) Efectividad

73) Una paciente de 40 años presenta astenia, fiebre ocasional y dolor en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño por 10 cm bajo el reborde costal. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 40%, hemoglobina: 13,2 g/l, plaquetas: 440.000 por mm³, blancos: 38.000 por mm³, linfocitos: 16%, monocitos: 4%, segmentados: 61%, baciliformes 13%, mielocitos: 4%, promielocitos: 2%. El diagnóstico más probable es:

- a) Mielodisplasia
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Mieloptosis
- e) Mielofibrosis

74) La conducta más adecuada frente a un lactante con diarrea aguda, sin deshidratación, de 3 días de evolución, es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Iniciar antibióticos y líquidos rehidratantes por vía oral
- c) Iniciar antidiarreicos y líquidos rehidratantes por vía oral
- d) Iniciar corticoides, antiespasmódicos y líquidos rehidratantes por vía oral
- e) Iniciar líquidos rehidratantes por vía oral

75) ¿Cuál de las siguientes patologías puede confundirse frecuentemente con un trastorno de pánico?

- a) Hipoglicemias
- b) Cetoacidosis
- c) Hipotiroidismo
- d) Enfermedad de Cushing
- e) Trastorno de angustia generalizada

76) Un niño de 7 años presenta aumento de volumen facial y edema de extremidades, asociado a orinas espumosas y gotas de grasa en la orina. El examen físico no aporta mayor información y la creatininemia, BUN, ANA y sedimento de orina son normales, sin embargo la proteinuria de 24 horas resulta 1,3 g/m2. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Corticoides
- b) Diuréticos
- c) Antihipertensivos
- d) Inmunosupresores
- e) Observación

77) Se realiza un ensayo clínico que compara un nuevo fármaco antihipertensivo contra enalapril. Este nuevo fármaco muestra un riesgo relativo de efectos adversos de 5, con un intervalo de confianza de 95% de 2 a 20. ¿Cuál fármaco recomendaría?

- a) El nuevo fármaco porque es más eficaz
- b) El nuevo fármaco porque tienen menos efectos adversos
- c) El enalapril porque es más eficaz
- d) El enalapril porque tiene menos efectos adversos
- e) Cualquiera de los dos fármacos, ya que no muestran diferencias significativas

78) El examen más adecuado para proseguir el estudio de un paciente con historia clínica de angina crónica, examen físico normal y electrocardiograma normal, es:

- a) Holter de arritmias
- b) Test de esfuerzo
- c) Troponinas plasmáticas
- d) Ecocardiograma
- e) Coronariografía

79) Un niño de 3 años presenta síntomas de malabsorción intestinal. Se solicita test de Sudán que confirma esteatorrea. La biopsia de mucosa duodenal, obtenida mediante endoscopia digestiva alta, muestra atrofia de las vellosidades intestinales y en sus exámenes de laboratorio destaca anemia ferropénica y positividad de los anticuerpos antitrasglutaminasa. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Antibióticos
- b) Dieta
- c) Corticoides
- d) Suplementación enzimática
- e) Inmunosupresores

80) Un paciente de 73 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que se acentúa al tomar un objeto o adoptar alguna postura con las manos. Además se observa un pequeño temblor de la cabeza y del mentón. Camina normalmente y no presenta signos focales ni cerebelosos en el examen físico. El diagnóstico más probable es:

- a) Envejecimiento normal
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Corea de Huntington
- d) Temblor esencial
- e) Demencia frontotemporal

81) El tratamiento de elección para la erradicación del *Helicobacter pylori* consiste en:

- a) Omeprazol, levofloxacin y rifampicina por 6 meses
- b) Omeprazol, clindamicina y ampicilina por 14 días
- c) Omeprazol, bismuto y metronidazol, por 7 días
- d) Omeprazol, tetraciclina y ciprofloxacino
- e) Omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 7 días

82) Durante un trabajo de parto una paciente muestra un registro cardíaco fetal con variabilidad disminuida, presencia de desaceleraciones variables y frecuencia cardíaca cercana a 100 latidos por minuto. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un perfil biofísico
- b) Administrar oxígeno e indicar reposo en decúbito lateral izquierdo
- c) Observar evolución espontánea, bajo monitorización
- d) Administrar tocolíticos endovenosos
- e) Realizar un tacto vaginal, para determinar la vía más expedita de interrupción del embarazo

83) Un paciente de 8 años consulta por odinofagia, fiebre alta y aparición de un exantema papular eritematoso. En el examen físico se aprecia lengua saburral y se observan las amígdalas aumentadas de tamaño, con exudado grisáceo, adherente. Además se palpan adenopatías cervicales y se observan petequias lineales en las fosas cubitales. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Rubeola
- c) Escarlatina
- d) Mononucleosis
- e) Eritema infeccioso

84) Un paciente diabético tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina se realiza exámenes de control que demuestran presencia de microalbuminuria de 70 mg/dl, sin alteraciones en el clearance de la creatinina. Sus exámenes anteriores presentaban valores similares. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de insulina
- b) Agregar un diurético
- c) Iniciar un iECA
- d) Iniciar ácido acetilsalicílico
- e) Mantener tratamiento y controlar con nuevos exámenes en 3 meses

85) Una paciente de 2 años se aprecia enflaquecida y de una talla menor a la esperada para su edad. Al revisar su curva de crecimiento se aprecia que su velocidad de crecimiento fue normal hasta cumplir el año de edad, momento en que esta velocidad de crecimiento disminuyó marcadamente. La madre refiere que presenta diarrea frecuente y en sus exámenes destaca anemia ferropénica. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Turner
- b) Retraso constitucional del crecimiento
- c) Fibrosis quística
- d) Inmunodeficiencia humoral
- e) Enfermedad celíaca

86) ¿Qué parámetro es más adecuado para calcular la significancia estadística al comparar los porcentajes de pacientes que responden a distintos tratamientos, en 2 grupos distintos?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) Análisis de varianza
- d) Test z normal
- e) r de Pearson

87) Un niño de 6 años es traído por su madre, ya que presenta epistaxis recurrente, desde hace 2 días. Al examen físico se aprecian petequias generalizadas, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemofilia
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico
- c) Púrpura trombocitopénico inmune
- d) Enfermedad de Von Willebrand
- e) Meningococemia

88) ¿Cuál de las siguientes lesiones es más sugerente de un melanoma?

- a) Mujer de 60 años con una lesión oscura, solevantada con múltiples pelos gruesos, ubicada en la cara
- b) Hombre de 64 años, con una lesión hiperpigmentada, de lento crecimiento en el pecho, de superficie rugosa, indolora
- c) Hombre de 65 años, con una lesión hiperpigmentada en la mano derecha, de color homogéneo y bordes regulares
- d) Hombre de 73 años con lesión solevantada, con borde perlado y telangiectasias adyacentes, ubicadas en la cara
- e) Mujer de 55 años con lesión oscura, de color heterogéneo, que ha duplicado su tamaño en 2 años, alcanzando 1 cm de diámetro, ubicada en la pierna izquierda

89) Una paciente de 30 años, asintomática, presenta como hallazgo en una ecografía transvaginal, la presencia de un mioma uterino transmural de 4 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar anticonceptivos
- c) Indicar análogos de GnRH
- d) Realizar tumorectomía histeroscópica (resectoscopia)
- e) Realizar histerectomía

90) Un recién nacido de 8 horas de vida, cuyo grupo sanguíneo es A-Rh positivo, presenta ictericia. Su madre no había presentado embarazos previos y su grupo sanguíneo O-Rh negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Hemólisis por incompatibilidad Rh
- c) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- d) Atresia biliar primaria
- e) Déficit enzimático hepático

SEGUNDA PARTE

1) Un paciente de 31 años consulta por fiebre y aparición de un exantema macular, eritematoso con fina descamación, que compromete la cara, tronco y extremidades, con compromiso de las palmas y las plantas. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de pie-mano-boca
- b) Pitiriasis rosada
- c) Psoriasis
- d) Sífilis
- e) Escarlatina

2) Un paciente de 7 años presenta un cuadro de tos, con rinorrea y odinofagia, de 7 días de evolución, al que luego se agrega disnea y fiebre hasta 38,5°C. Se solicita radiografía de tórax que demuestra un patrón intersticial, con engrosamiento peribronquial. El tratamiento de elección es:

- a) Ceftriaxona
- b) Amoxicilina
- c) Penicilina benzatina
- d) Claritromicina
- e) Clindamicina

3) Una paciente primigesta ingresa en trabajo de parto, en fase activa. Está en buenas condiciones y se palpa un feto en presentación de tronco. La dinámica uterina es 2 CU/min y tiene 6 cm de dilatación cervical, con membranas rotas. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aceleración occitócica
- b) Administrar fenoterol endovenoso
- c) Realizar fórceps
- d) Realizar cesárea
- e) Realizar prueba de trabajo de parto

4) Una mujer de 45 años es muy ansiosa y se preocupa frecuentemente de que le pueda pasar algo malo a ella o a sus familiares. Por esto evita salir de la casa y no le gusta que sus hijos manejen o salgan por miedo a que sufran un accidente. Esto ha limitado considerablemente sus actividades. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de angustia generalizada
- b) Trastorno de pánico
- c) Agorafobia
- d) Fobia social
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

5) Un paciente de 58 años, diagnosticado de EPOC, evoluciona con fiebre tos y expectoración y marcado aumento de su disnea. Al examen físico está muy taquipneico, sudoroso, febril, desorientado y con cianosis perioral. La saturación arterial de oxígeno, medida por pulsometría es de 80%. ¿Cuál de las siguientes medidas está MENOS indicada?

- a) Oxígeno por mascarilla de recirculación, para conseguir saturaciones arteriales sobre 90%
- b) Salbutamol inhalado
- c) Corticoides endovenosos
- d) Antibióticos de amplio espectro, endovenosos
- e) Toma de gases arteriales

6) Calcule la prevalencia de VIH, al FINAL del período, con la siguiente información:

Población al inicio del período: 1.000.000

Población al final del período: 1.000.000

Número de pacientes diagnosticados de VIH a principio del período: 5.000

Número de pacientes que contraen VIH durante el período: 200

Número de paciente con VIH que mueren durante el período: 100

Porcentaje de los pacientes VIH que mueren a causa del VIH: 90%

- a) $90 / 5.000$
- b) $90 / 1.000.000$
- c) $5.090 / 1.000.000$
- d) $5.100 / 1.000.000$
- e) $5.200 / 1.000.000$

7) Un paciente sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis, sin desplazamiento. Evoluciona con imposibilidad de orinar y dolor abdominal bajo. Al examen físico se aprecia uretrorragia y se palpa un globo vesical. La conducta MENOS adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar AINEs
- c) Instalar sonda Foley
- d) Solicitar uretrocistografía retrógrada
- e) Realizar cistostomía

8) ¿Cuál de las siguientes vacunas puede ser administrada a un paciente severamente inmunocomprometido?

- a) Polio oral
- b) Trivírica
- c) Virus hepatitis A
- d) Varicela
- e) BCG

9) El examen de mayor utilidad ante la sospecha clínica de síndrome de Cushing es:

- a) Cortisol libre urinario de 24 horas
- b) Cortisol plasmático matinal
- c) Cortisol y ACTH plasmáticos
- d) Cortisol basal y post-ACTH
- e) ACTH plasmática matinal y nocturna

10) ¿A qué tipo de herida corresponde la amigdalectomía?

- a) Limpia
- b) Limpia contaminada
- c) Contaminada
- d) Sucia
- e) Infectada

11) Una mujer de 55 consulta por aparición de equimosis, petequias generalizadas y epistaxis en 3 oportunidades. Su examen físico no aporta mayor información y se solicitan exámenes generales, donde destaca un hemograma con hemoglobina: 15 g/dl, hematocrito: 46%, blancos: $8.400 \times \text{mm}^3$, con fórmula diferencial normal plaquetas: $46.000 \times \text{mm}^3$. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Quirúrgico
- b) Hidroxiurea
- c) Aspirina
- d) Corticoides
- e) Quimioterapia combinada

12) Un niño de 3 años ha presentado durante el último año 3 crisis convulsivas tónico-clónicas en relación a episodios febriles y 2 crisis sin desencadenante claro. Las crisis han sido autolimitadas y no muestra alteraciones en el examen físico.

La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a especialista, por sospecha de epilepsia
- b) Iniciar fenitoína
- c) Indicar AINEs y benzodiacepinas durante los episodios febriles
- d) Solicitar TAC de cerebro
- e) Observar evolución

13) Usted evalúa un paciente de 35 años, asintomático, que acude a chequeo médico. Su examen físico y sus exámenes de rutina son normales, sin embargo en su historia detecta que fuma entre 20 y 30 cigarrillos al día. Al preguntarle sobre su hábito tabáquico refiere que no tiene intención alguna de dejar de fumar. La conducta más adecuada es:

- a) Explicarle que por su edad puede seguir fumando sin mayor inconveniente
- b) Aconsejarle brevemente que deje de fumar
- c) Indicarle parches de nicotina
- d) Iniciar bupropion
- e) Solicitar espirometría

14) Un hombre de 69 años consulta por dolor en la ingle izquierda, especialmente al caminar. Al examen físico se aprecia dolor a los movimientos extremos de la cadera izquierda, sin otras alteraciones. Se solicita radiografía de caderas que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Necrosis avascular de la cabeza femoral
- c) Enfermedad de Paget
- d) Distrofia simpático-refleja
- e) Cáncer

15) Un paciente de 5 años, cursando una diarrea aguda, presenta oliguria, asociada a elevación de la creatininemia y marcada disminución de la excreción urinaria de sodio. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal prerrenal
- b) Acidosis tubular
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Glomerulonefritis aguda

16) Un paciente de 20 años consulta por ojo rojo bilateral, asociado a prurito ocular. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial, con reacción tarsal papilar. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Chalazión
- e) Blefaritis

17) Una mujer cursando un embarazo de 7 semanas de amenorrea, diagnosticado mediante un test de orina, consulta por dolor abdominal, metrorragia y ortostatismo. Al examen físico está pálida, hipotensa y taquicárdica. La ecografía transvaginal demuestra ausencia de gestación intrauterina, con visualización de un tumor anexial izquierdo de 3 cm de diámetro y presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico e iniciar metotrexato
- b) Administrar suero fisiológico y realizar cirugía de urgencia
- c) Administrar suero fisiológico y realizar legrado uterino de inmediato
- d) Administrar suero fisiológico y solicitar subunidad beta plasmática
- e) Administrar suero fisiológico y solicitar nueva ecografía en 48 horas

18) Un paciente presenta un cuadro de baja de peso compatible con una malabsorción intestinal, confirmada con test de Sudán. Se realiza endoscopia digestiva alta y se toman biopsias duodenales, que muestran atrofia de las vellosidades, alargamiento de las criptas mucosas y un infiltrado linfocitario en la mucosa intestinal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Colitis ulcerosa
- d) Giardiasis intestinal
- e) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

19) Un paciente presenta fiebre, tos y dolor torácico tipo puntada de costado. Al examen físico está en buenas condiciones, febril, con FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, FR: 16x' y saturación arterial de oxígeno normal. EL examen pulmonar demuestra crépitos en el ápice pulmonar derecho y matidez con disminución del murmullo pulmonar en la base derecha. Se realiza una radiografía de tórax que muestra un foco de condensación en el lóbulo superior derecho y un derrame pleural moderado ipsilateral, el que se punciona. El análisis del líquido pleural demuestra un exudado pleural de predominio polimorfonuclear, con pH de 7,0 y lactato de 8 mg/dl (VN: menor a 5 mg/dl). La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos e instalar un tubo pleural
- b) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos e intrapleurales
- c) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa, controlando con nueva radiografía en 48 horas
- d) Evacuar el derrame pleural, mediante una toracocentesis y enviar a domicilio con amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Enviar a domicilio con amoxicilina más ácido clavulánico y controlar con nueva radiografía en 48 horas

20) Un niño de 4 años presenta claudicación de la marcha, asociada a fiebre alta y marcado decaimiento. Al examen se aprecia dolor a la movilización de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Artritis séptica
- c) Artritis juvenil idiopática
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

21) Un adulto mayor de 76 años presenta desde hace unos meses apatía e ideas incoherentes, asociadas incontinencia urinaria. Además ha presentado varias caídas sin resultar con lesiones serias. Al examen físico se aprecia una marcha insegura y torpeza motora. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia senil
- b) Demencia vascular
- c) Delirium
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Hidrocefalia normotensiva

22) Es causa frecuente de amenorrea:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Hiperprolactinemia
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Cáncer de ovario
- e) Miomatosis uterina

23) Una paciente de 30 años presenta otorrea y otalgia recurrente en el oído izquierdo, de algunos meses de evolución, asociados a sensación de oído tapado. A la otoscopia se observa una perforación timpánica redonda, de diámetro igual a un tercio del diámetro del tímpano. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Miringitis
- c) Otitis fúngica
- d) Otitis media crónica
- e) Otitis externa complicada

24) Un paciente de 43 años consulta por disfagia alta y sensación de presión facial. Refiere que en algunas oportunidades siente prurito y parestesias en las extremidades inferiores. Además está en tratamiento con amitriptilina y trimebutino por fibromialgia y colon irritable. Su examen físico es normal y cuenta con una TAC de cavidades paranasales y con una endoscopia digestiva alta, ambas normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome paraneoplásico
- b) Trastorno por hipocondría
- c) Trastorno por somatización
- d) Trastorno por conversión
- e) Trastorno por disociación

25) Un paciente sufre una fractura de brazo, evolucionando con imposibilidad de extender la muñeca. ¿Qué estructura fue comprometida?

- a) Nervio músculocutáneo
- b) Nervio circunflejo
- c) Nervio radial
- d) Nervio cubital
- e) Nervio mediano

26) Una mujer de 19 años, cursando embarazo de término, ingresa en trabajo de parto, en fase activa y el registro fetal muestra frecuencia cardíaca fetal de 105x', con variabilidad mínima y presencia de desaceleraciones variables. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar amniocentesis
- b) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Administrar tocolíticos
- e) Observar evolución y dejar evolución espontánea

27) Un paciente de 60 años consulta por disnea. En el examen físico destaca abolición del murmullo pulmonar en la base derecha, asociada a matidez y egofonía. Se solicita radiografía de tórax que confirma la presencia de un derrame pleural moderado, el que se punciona, dando salida a un líquido transparente, amarillento, con proteínas de 1 g/dl, LDH de 18UI/l, células de 30 por mm³, con 70% de mononucleares y 30% de polimorfonucleares y pH de 7,4. EL diagnóstico más probable, de entre los mencionados, es:

- a) Empiema
- b) Tuberculosis pleural
- c) Cáncer
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Derrame paraneumónico simple

28) Un paciente de 47 años consulta por impotencia sexual, astenia y dificultad para ver. Al examen físico se aprecia pérdida del campo visual externo de ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow graves
- b) Enfermedad de Cushing
- c) Panhipopituitarismo
- d) Tumor hipofisiario
- e) Apoplejía hipofisiaria

29) Una primigesta de 32 semanas presenta metrorragia abundante, de color rojo brillante, sin otros síntomas. No presenta dinámica uterina y el registro fetal es tranquilizador. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo molar
- b) Placenta previa
- c) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- d) Rotura de vasa previa
- e) Liberación del tapón mucoso

30) Un paciente de 56 años presenta un cuadro de un año de evolución de dolor abdominal recurrente, de tipo cólico, asociado a constipación y diarrea en algunas oportunidades. Además ha presentado deposiciones con restos de sangre. Su examen físico no aporta mayor información y cuenta con exámenes generales, donde destaca la presencia de anemia ferropénica. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de intestino irritable
- b) Colitis infecciosa
- c) Enfermedad de Cröhn
- d) Enfermedad diverticular
- e) Cáncer de colon

31) Un niño de 4 años consulta por fiebre, cefalea y marcado decaimiento. Al examen físico destacan signos meníngeos, por lo que se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo turbio, con 1.100 células por mm³, con 90% de polimorfonucleares, glucosa de 20 mg/dl y proteínas de 70mg/dl. La tinción de Gram muestra presencia de cocáce Gram positivas en diplos y en cadenas cortas. El agente etiológico más probable es:

- a) Meningococo
- b) Estafilococo áureo
- c) Neumococo
- d) Listeria monocytogenes
- e) Haemophilus influenzae

32) Un paciente de 26 años consulta por aparición de una lesión en la cara lateral de la lengua, consistente en una placa blanquecina, de disposición reticular, indolora. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer
- b) Leucoplaquia
- c) Cándidiasis
- d) Líquen plano
- e) Síndrome de Steven Johnson

33) El agente causal más frecuente de diarrea en los lactantes es:

- a) Shiguella
- b) Escherichia coli
- c) Rotavirus
- d) Campilobacter jejuni
- e) Enterovirus

34) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO pertenece al síndrome nefrítico?

- a) Hematuria
- b) Elevación de la creatinina
- c) Hipertensión arterial
- d) Edema
- e) Dislipidemia

35) Un paciente sufre un infarto agudo al miocardio, de pared anterior, el que es manejado con tratamiento médico y trombolisis con estreptoquinasa. Inicialmente se encuentra estable, sin embargo el tercer día evoluciona con marcada disnea, de rápida instalación. Al examen físico se aprecia sudoroso, disneico, con crépitos pulmonares bilaterales y se ausculta un soplo cardíaco, holosistólico intenso, mayor en el ápex e irradiado a la axila. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de pared libre
- b) Reinfarto
- c) Infarto de ventrículo derecho
- d) Rotura de músculo papilar
- e) Aneurisma ventricular

36) La etiología más frecuente de la úlcera gástrica es:

- a) Consumo de AINEs
- b) Consumo de alcohol
- c) Hipersecreción de gastrina
- d) Infección por Helicobacter pylori
- e) Autoinmune

37) ¿Qué característica esperarías encontrar en un niño de 12 meses de edad?

- a) Desconoce a los extraños
- b) Corre
- c) Canta
- d) Dice frases de 2 a 3 palabras
- e) Patea una pelota

38) ¿Cuál es la dosis máxima de alcohol étílico que puede consumir una persona, sin mayor riesgo de desarrollar una hepatopatía crónica?

- a) 20 gramos al día las mujeres y 40 gramos al día los hombres
- b) 40 gramos al día las mujeres y 80 gramos al día los hombres
- c) 100 gramos al día las mujeres y 200 gramos al día los hombres
- d) 200 gramos al día las mujeres y 400 gramos al día los hombres
- e) 400 gramos al día las mujeres y 800 gramos al día los hombres

39) Un estudio evalúa la relación entre la exposición a alcohol y la aparición de rosácea, para esto seleccionan 1.340 pacientes que consumen alcohol y a 1.590 pacientes que no consumen alcohol y se siguen en el tiempo, observando el número de pacientes que desarrollan rosácea. ¿Qué tipo de estudio es?

- a) Caso y control
- b) De prevalencia
- c) Cohortes
- d) Ensayo clínico
- e) Ensayo de campo

40) Un paciente de 63 años consulta por dolor y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, fatigándose rápidamente al levantar los brazos y realizar actividades como peinarse y poner una ampollita. El examen físico no aporta mayor información y en sus exámenes presenta elevación de la VHS hasta 90 mm/hora, con CK normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Polimiositis
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Polirradiculoneuritis aguda
- d) Granulomatosis de Wegener
- e) Polimialgia reumática

41) ¿Qué tipo de demencia se caracteriza por presentar caídas frecuentes e incontinencia urinaria?

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Demencia frontotemporal
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Enfermedad de Creutzfeldt Jacob

42) Los pólipos endometriales son una causa relativamente frecuente de:

- a) Metrorragia
- b) Hipermenorrea
- c) Polimenorrea
- d) Oligomenorrea
- e) Dismenorrea

43) Un paciente de 26 años ha sufrido 2 trombosis venosas profundas en las extremidades inferiores y un tromboembolismo pulmonar, manejados adecuadamente con anticoagulación. Actualmente se encuentra asintomático y se suspende el tratamiento para realizar estudio de trombofilias, en el cual se detecta un déficit de proteína C. La conducta más adecuada es:

- a) Anticoagular a permanencia con cumarínicos orales
- b) Iniciar corticoides
- c) Iniciar aspirina
- d) Administrar crioprecipitado de manera periódica
- e) Observar evolución

44) Un paciente de 6 años presenta hipertensión, hematuria y edema generalizado. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Enfermedad de Berger
- e) Riñón poliquístico

45) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y cuadro clínico es correcta?

- a) Tiroiditis de Hashimoto – Bocio difuso, indoloro, con elevación de la TSH
- b) Adenoma tóxico – Bocio nodular con TSH elevada y exoftalmo
- c) Tiroiditis subaguda – Bocio difuso, de consistencia aumentada, no doloroso, asociado a síntomas de hipotiroidismo
- d) Enfermedad de Basedow Graves – Bocio multinodular, doloroso y con frémito
- e) Cáncer folicular de tiroides – Bocio nodular con abundantes adenopatías

46) Un lactante de 6 meses de edad presenta fiebre hasta 38,4°C sin otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, realizar estudio diagnóstico completo, incluyendo estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar antibióticos de amplio espectro, por vía endovenosa
- b) Solicitar hemograma, hemocultivo, sedimento de orina y PCR y decidir conducta según hallazgos
- c) Solicitar urocultivo y sedimento de orina por punción suprapúbica
- d) Enviar a domicilio con paracetamol y amoxicilina
- e) Enviar a domicilio con paracetamol y controlar en 48 horas

47) ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un paciente con una tetraparesia arrefléctica, que presentó un cuadro diarreico hace 10 días?

- a) Miastenia gravis
- b) Miastenia de Lambert Eaton
- c) Síndrome de Guillain Barré
- d) Botulismo
- e) Mononeuritis múltiple

48) Un lactante de 9 meses presenta palidez, por lo que se solicita hemograma, que muestra anemia microcítica, con hemoglobina de 9 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Talasemia
- d) Anemia por déficit de vitamina B12
- e) Microesferocitosis

49) Un paciente pos operado de una hemicolectomía derecha presenta oliguria. Se instala sonda Foley para cuantificar, constatándose una diuresis de 10 ml/hora. Se solicita creatinina que resulta 2,4 mg/dl y BUN que resulta 50 mg/dl. La fracción excretada de sodio es muy baja y los electrolitos urinarios muestran Na+: 5mEq/l, K+: 15mEq/l y Cl-: 16mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto renal
- b) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- c) Insuficiencia renal crónica
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Insuficiencia renal aguda postrenal

50) Un paciente de 49 años consulta por dolor en el hipocondrio derecho, asociado a vómitos alimentarios y fiebre hasta 38,5°C. Sus otros signos vitales son normales y presenta intenso dolor a la palpación del hipocondrio derecho, sin signos peritoneales. El hemograma demuestra leucocitosis hasta 16.500 x mm³, las pruebas hepáticas y la amilasa son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Perforación de úlcera gástrica
- b) Colecistitis aguda
- c) Pancreatitis aguda
- d) Coledocolitiasis
- e) Colangitis aguda

51)Cuál de las siguientes patologías es compatible con los gases arteriales presentados a continuación?

PaO₂: 79 mmHg, PaCo₂:54 mmHg, pH: 7,3 y diferencia alveolo arterial de oxígeno: 3 mmHg.

- a) Tromboembolía pulmonar
- b) Enfermedad neuromuscular
- c) Neumonía
- d) Asma
- e) Fibrosis pulmonar

52) Una puérpera de 4 días consulta por fiebre y malestar general, asociado a metrorragia. El diagnóstico más probable es:

- a) Restos ovulares
- b) Endometritis
- c) Tromboflebitis séptica de las venas pélvicas
- d) Hematoma del canal del parto
- e) Cuerpo extraño

53) ¿Cómo trataría a un paciente de 50 años con una taquicardia, a 160x', regular y complejo QRS ancho, que se encuentra bien perfundido y hemodinámicamente estable?

- a) Con digitales endovenosos
- b) Con amiodarona endovenosa
- c) Con adenosina endovenosa
- d) Con betabloqueo endovenoso
- e) Con cardioversión eléctrica

54) Los tratamientos de elección para la amebiasis y giardiasis intestinal son respectivamente:

- a) Metronidazol y Tinidazol
- b) Albendazol y metronidazol
- c) Claritromicina y claritromicina
- d) Ciprofloxacino y metronidazol
- e) Tinidazol y albendazol

55) Un paciente de 60 años, indigente, alcohólico, sufre un atropello en la vía pública. ¿Qué medida es especialmente importante considerar a la hora de administrar suero glucosado o alimentar a este paciente?

- a) Administrar insulina
- b) Administrar vitamina B1
- c) Administrar vitamina B12
- d) Administrar metanol
- e) Administrar benzodiacepinas

56) Un paciente de 63 años, con insuficiencia cardíaca, secundaria a un infarto al miocardio, que sufrió hace 2 años. Está en tratamiento con enalapril, carvedilol, furosemida, aspirina y atorvastatina, permaneciendo en capacidad funcional II. Es traído, por un cuadro de aumento marcado de su disnea, asociado a confusión, de 1 horas de evolución. Al examen se observa pálido, con livideces en las extremidades, en sopor superficial, con FC: 150x', irregular, PA: 74/32 mmHg, FR: 27x' y saturación arterial de oxígeno de 77%, por pulsometría. La auscultación cardíaca demuestra un ritmo irregular en 3 tiempos, por presencia de un tercer ruido y la auscultación pulmonar presenta crépitos difusos bilaterales. El monitoreo cardíaco demuestra una taquicardia irregular, a QRS angosto a 150x' La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones y decidir manejo según hallazgos
- b) Administrar amiodarona endovenosa e instalar una bomba de dopamina endovenosa
- c) Administrar suero fisiológico y adenosina
- d) Administrar heparina endovenosa y realizar cardioversión farmacológica con amiodarona
- e) Realizar cardioversión eléctrica de inmediato

57) Una mujer de 30 años, cursando su cuarto embarazo, de 8 semanas de gestación por FUR, con hiperémesis gravídica, presenta metrorragia y dolor hipogástrico. Al examen físico se palpa el útero a la altura del pubis y el tacto vaginal no muestra cambios cervicales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síntomas de aborto
- b) Aborto en evolución
- c) Embarazo ectópico roto
- d) Embarazo molar
- e) Aborto retenido

58) Un paciente de 87 años sufre un accidente vascular isquémico, resultando con una hemiplejia que le impide la marcha y con imposibilidad de hablar. Al quinto día de evolución se observa eritema en la zona sacra. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Asegurar cambios frecuentes de posición
- d) Cubrir la zona con apósito
- e) Resolver quirúrgicamente

59) Un recién nacido de 29 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria progresiva, asociada a desaturación arterial de oxígeno hasta 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita
- b) Taquipnea transitoria
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Enfermedad de membrana hialina

60) Una paciente de 17 años consulta por astenia, mialgias y artralgias de manos y hombros. Al examen físico se observan 2 úlceras orales y se realizó un hemograma, en el que destaca trombocitopenia y un análisis de orina completa en el que se aprecia proteinuria +++. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Enfermedad de Behcet
- c) Panarteritis nodosa
- d) Pelviespondiloartropatía
- e) Lupus eritematoso sistémico

61) ¿Qué alimentación indicaría a un niño de 4 meses de edad cuya madre ya no puede alimentarlo con leche materna?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

62) Un paciente de 38 años es diagnosticado de hipertensión arterial esencial, grado 1. Su examen físico no presenta alteraciones de importancia y además su electrocardiograma y exámenes generales son normales. Se inicia dieta hiposódica y ejercicios, sin embargo persiste con presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg, luego de 3 meses. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener las indicaciones y controlar en 3 meses
- b) Aumentar el programa de ejercicios y controlar en 3 meses
- c) Iniciar un bloqueador beta-adrenérgico
- d) Iniciar hidroclorotiazida
- e) Solicitar ecografía-Doppler de arterias renales, metanefrinas urinarias e índice de aldosterona sobre actividad de renina plasmática

63) Un paciente diabético tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas y glibenclamida 10 mg cada 12 horas presenta glicemias de ayuno cercanas a 140 mg/dl y glicemias postprandiales cercanas a 200 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada que resulta 8,8%. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener tratamiento
- b) Aumentar la dosis de glibenclamida
- c) Aumentar la dosis de metformina
- d) Iniciar atorvastatina
- e) Iniciar insulina

64) Una mujer de 23 años consulta por leucorrea grumosa y blanquecina, sin mal olor, asociada a prurito vaginal y signos inflamatorios moderados de la pared vaginal. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Fluconazol
- b) Metronidazol
- c) Clindamicina
- d) Corticoides locales
- e) Doxiciclina

65) Una paciente vio como un perro de la calle mató a un gato de una manera muy cruda. Tres meses después inicia pesadillas y recuerdos vivos del incidente, lo que le trae mucha angustia. De hecho ha presentado crisis de ansiedad en algunas oportunidades. Por eso evita cualquier contacto con perros o gatos. Refiere sentirse cansada y le cuesta expresar sus emociones. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés postraumático
- b) Trastorno adaptativo
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno de angustia
- e) Fobia específica

66) Una paciente de 28 años, cursando su segundo embarazo, de 35 semanas, consulta por compromiso del estado general, dolor epigástrico e ictericia. Al examen físico se constata FC: 100x'. PA: 150/100 mmHg e ictericia de piel y mucosas. En los exámenes generales se demuestra anemia, trombocitopenia y elevación de la bilirrubina y de las transaminasas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis aguda del embarazo
- b) Hígado graso agudo del embarazo
- c) Síndrome de HELLP
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Coroamnionitis

67) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con una fractura de pelvis desplazada. Evoluciona con ortostatismo, taquicardia y tendencia a la hipotensión. Además de administrar cristaloides endovenosos, la conducta inicial más adecuada es:

- a) Transfundir glóbulos rojos
- b) Administrar ácido tranexánico
- c) Estabilizar la fractura mediante férulas neumáticas o tutor externo
- d) Realizar ligadura de las venas pélvicas
- e) Realizar reducción quirúrgica y osteosíntesis con placa y tornillos

68) ¿Qué inductor se usa en pacientes con tendencia a la hipotensión?

- a) Tiopental
- b) Ketamina
- c) Fentanil
- d) Propofol
- e) Vecuronio

69) Un lactante de 9 meses ya tiene sus 4 incisivos afuera. ¿Qué medidas de higiene dental debe aconsejar a sus padres?

- a) Ninguna
- b) Aseo con un paño húmedo
- c) Lavado de dientes con pasta dental para niños
- d) Lavado de dientes con pasta dental convencional
- e) Enjuague bucal luego de cada comida

70) Una paciente de 65 años se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal, detectándose incidentalmente un tumor renal sólido, de 5 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Adenoma
- b) Lipoma
- c) Cáncer renal
- d) Hidatidosis
- e) Hemangioma

71) ¿Cuál es la causa más frecuente de constipación en la edad pediátrica?

- a) Bajo consumo de fibra
- b) Malos hábitos de defecación
- c) Enfermedad de Hirschsprung
- d) Fibrosis quística
- e) Giardiasis

72) Una paciente de 43 años consulta por astenia. El examen físico no aporta mayor información, por lo que decide tomar exámenes generales, que demuestran un hemograma normal, pruebas de función renal normales y pruebas hepáticas con elevación de las fosfatasa alcalinas hasta 350 UI/L, bilirrubina de 2,3 mg/dl, de predominio directo y normalidad de las transaminasas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Hepatitis viral
- c) Colangitis esclerosante primaria
- d) Cirrosis biliar primaria
- e) Hepatocarcinoma

73) Respecto al síndrome de transfusión feto-fetal es FALSO que:

- a) De no ser tratado, tiene una letalidad cercana al 25%
- b) Se diagnostica mediante ecografía
- c) Se caracteriza por oligohidramnios en un gemelo y polihidramnios en el otro
- d) Se presenta en los embarazos monocoriales-biamnióticos
- e) Se trata amniocópicamente, mediante coagulación selectiva de los vasos comunicantes

74) Un hombre de 67 años consulta por fatigabilidad y astenia. Al examen físico destaca palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,5 g/dl, VCM: 72 fl, HCM: 30 pg, blancos: 5.700 x mm³, linfocitos: 40%, neutrófilos: 70%, monocitos: 8%, eosinófilos: 2% y plaquetas: 370.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Anemia hemolítica
- d) Mielodisplasia
- e) Mieloma

75) Un niño de 9 años miente y roba a sus padres con frecuencia, se mete en peleas seguido, es cruel con los animales y presenta una actitud irrespetuosa e indiferente hacia sus padres y profesores. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión infantil
- b) Trastorno por ansiedad de separación
- c) Trastorno de conducta
- d) Trastorno oposicionista desafiante
- e) Síndrome de Asperger

76) ¿Qué institución es responsable de administrar los dineros asignados a la salud pública?

- a) Servicio de salud
- b) Municipalidad
- c) FONASA
- d) Instituto de salud pública
- e) Central de abastecimiento

77) Un paciente hospitalizado por un tromboembolismo pulmonar, con buena evolución, presenta sodio plasmático de 131 mEq/l. No tiene síntomas neurológicos y su examen físico no aporta información adicional. Usted sospecha un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar vasopresina
- b) Administrar una tiazida
- c) Instalar un catéter venoso central e iniciar suero hipertónico por esa vía
- d) Administrar suero glucosado
- e) Indicar restricción de la ingesta de agua libre

78) El tratamiento de elección de la uretritis gonocócica es:

- a) Claritromicina, pero suele tratarse además con tetraciclinas para cubrir Chlamydia
- b) Clindamicina, pero suele tratarse además con tetraciclinas para cubrir Chlamydia
- c) Penicilina, pero suele tratarse además con tetraciclinas para cubrir Chlamydia
- d) Ceftriaxona, pero suele tratarse además con tetraciclinas para cubrir Chlamydia
- e) Gentamicina, pero suele tratarse además con tetraciclinas para cubrir Chlamydia

79) Una mujer de 35 años consulta por dolor abdominal bajo, cíclico, que se presenta cada 30 días y dura 3 días. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de intestino irritable
- b) Cistitis intersticial
- c) Úlcera gastroduodenal
- d) Proceso inflamatorio pélvico
- e) Dismenorrea

80) Un niño de 5 años, con síndrome de déficit atencional hiperactivo, es traído por su madre, ya que presenta una voz ronca. Refiere que grita mucho y frecuentemente queda disfónico. El diagnóstico más probable es:

- a) Edema de Reinke
- b) Parálisis del nervio laríngeo recurrente
- c) Laringomalacia
- d) Nódulos vocales
- e) Papilomas laríngeos

81) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO daría a un paciente obeso?

- a) Realizar deporte aeróbico
- b) Consumir pocas grasas
- c) Reducir la ingesta de hidratos de carbono
- d) Consumir menos de 1000 calorías diarias hasta normalizar su peso
- e) Realizarse un perfil lipídico y glicemia basal

82) Un paciente de 3 años presenta fiebre, decaimiento y tos intensa. Evoluciona luego con dificultad respiratoria y estridor inspiratorio. La auscultación pulmonar es normal. El agente causal más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Mycoplasma
- d) Neumococo
- e) Enterovirus

83) Un paciente de 50 años consulta por disnea de 4 meses de evolución, progresiva, asociada a tos seca. Fuma cerca de 5 cigarrillos diarios, desde los 20 años de edad. Al examen físico se observa hipocratismo digital y se auscultan campos pulmonares pequeños, con abundantes crépitos bilaterales. La auscultación cardíaca es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) EPOC
- b) Asma
- c) Cáncer pulmonar
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Tuberculosis pulmonar

84) ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención secundaria?

- a) Tomar aspirina para prevenir un infarto
- b) Tomar aspirina luego de haber tenido un infarto
- c) Realizar kinesioterapia a un niño con parálisis cerebral
- d) Vacunar contra la influenza a pacientes de riesgo
- e) Controlar la presión arterial a pacientes sanos

85) Un paciente se realiza una gastrectomía parcial, debido a un síndrome pilórico secundario a una úlcera gástrica cicatrizada. Al segundo día posquirúrgico presenta disnea de inicio súbito, asociado a tos con expectoración hemoptoica. Al examen físico presenta FC: 92x', T°: 37,8°C, PA: 120/70 mmHg, FR: 16x' y se ausculta el murmullo pulmonar, con algunas crepitaciones bilaterales, mayores a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Atelectasia
- c) Neumotórax
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Bronquiectasia

86) ¿Qué manifestación clínica producirá un accidente vascular encefálico isquémico, por oclusión de la arteria cerebral posterior izquierda?

- a) Hemiparesia faciobraquial derecha y hemihipoestesia derecha
- b) Paraparesia y parálisis oculomotora derecha
- c) Hemianopsia homónima derecha y paresia crural derecha
- d) Hemihipoestesia derecha y parálisis oculomotora izquierda
- e) Hemiparesia izquierda y compromiso de conciencia

87) El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es:

- a) Tamaño del tumor
- b) Compromiso de ganglios linfáticos
- c) Presencia de receptores hormonales
- d) Invasión maligna vascular
- e) Grado de diferenciación histológica

88) Un paciente de 40 años consulta por dolor ocular intenso, que aumenta considerablemente con la luz, lo que le dificulta la apertura, asociado a epifora y sin alteraciones de la agudeza visual. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático y blefarospasmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo
- b) Queratitis aguda
- c) Uveítis
- d) Escleritis
- e) Conjuntivitis viral

89) Respecto a la violencia intrafamiliar es VERDADERO que:

- a) Son raros los casos de violencia psicológica
- b) Es muy infrecuente en los estratos socioeconómicos altos
- c) El nivel de violencia suele aumentar progresivamente a lo largo del tiempo
- d) Son raros los casos que no se denuncian
- e) Los agresores característicamente tienen una alta autoestima

90) Un paciente obeso, sin hábitos tóxicos, con hepatitis crónica, de causa desconocida se realiza estudio serológico para virus hepatotrópicos, presentando antígeno de superficie para VHB positivo, anticuerpos anti-VHBs negativos, anticuerpos IgM anti-core VHB negativos, anticuerpos IgM anti VHA negativos, anticuerpos IgG anti VHA positivos, anticuerpos anti-VHC negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis C
- d) Esteatohepatitis no alcohólica
- e) Hepatitis A sobre hepatitis B

Respuestas:

PRIMERA PARTE

Preguntas

Respuestas

1	A
2	D
3	A
4	A
5	A
6	E
7	D
8	C
9	D
10	E
11	D
12	D
13	E
14	A
15	B
16	D
17	D
18	E
19	D
20	A
21	E
22	A
23	D
24	D
25	B
26	D
27	B
28	E
29	B
30	B
31	A

32	A
33	A
34	C
35	A
36	D
37	D
38	C
39	E
40	D
41	B
42	A
43	D
44	D
45	C
46	D
47	E
48	E
49	B
50	A
51	C
52	A
53	B
54	D
55	D
56	A
57	D
58	C
59	D
60	C
61	A
62	D

63	C
64	E
65	D
66	E
67	A
68	A
69	E
70	C
71	A
72	C
73	C
74	E
75	A
76	A
77	D
78	B
79	B
80	D
81	E
82	E
83	C
84	C
85	E
86	B
87	C
88	E
89	A
90	C

SEGUNDA PARTE

Preguntas

Respuestas

1

D

2	D
3	D
4	A
5	A
6	D
7	C
8	C
9	A
10	B
11	D
12	A
13	B
14	A
15	A
16	C
17	B
18	A
19	A
20	B
21	E
22	B
23	D
24	C
25	C
26	B
27	D
28	D
29	B
30	E
31	C
32	D

33	C
34	E
35	D
36	D
37	A
38	A
39	C
40	E
41	D
42	B
43	A
44	A
45	A
46	E
47	C
48	A
49	B
50	B
51	B
52	B
53	B
54	A
55	B
56	E
57	D
58	C
59	E
60	E
61	A
62	D
63	E

64	A
65	A
66	C
67	C
68	B
69	B
70	C
71	B
72	D
73	A
74	A
75	C
76	C
77	E
78	D
79	E
80	D
81	D
82	B
83	D
84	E
85	D
86	C
87	B
88	B
89	C
90	B

Ensayo EUNACOM – Prueba 8

1) Un hombre de 22 años consulta por dolor abdominal, asociado a diarrea de 4 meses de evolución, que en oportunidades es sanguinolenta. Además refiere fiebre ocasional y ha presentado 2 abscesos perianales en el último tiempo. El diagnóstico más probable es:

- a) Amebiasis
- b) Enfermedad de Cröhn
- c) Shigellosis
- d) Colitis ulcerosa
- e) Poliposis adenomatosa familiar

2) Un paciente asmático, en tratamiento con fluticasona y salbutamol, suspende los inhaladores, evolucionando con un cuadro de disnea de reposo y tos, que no ha respondido al uso de salbutamol por inhalador. Al examen físico está taquipneico a 40 rpm, taquicárdico a 110 x', afebril, con cianosis perioral, satura 83% a FIO₂ ambiental, presenta uso de musculatura accesoria y sibilancias intensas bilaterales, audibles sin necesidad del fonendoscopio. La conducta MENOS apropiada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos
- b) Administrar antibióticos endovenosos
- c) Solicitar PEF seriados
- d) Solicitar gases de sangre arterial
- e) Hospitalizar

3) Un paciente de 16 años presenta fiebre, malestar general y astenia de 2 semanas de evolución. Al examen físico se palpa esplenomegalia, sin otras alteraciones. Se solicita hemograma que muestra hcto: 30%, plaquetas: 5.000 por mm³, blancos: 35.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Leucemia aguda
- c) Leucemia crónica
- d) Infección viral
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

4) Un paciente de 70 años presenta un cuadro de astenia, asociado a constipación y debilidad muscular, que ha empeorado en las últimas horas, agregándose desorientación. Al examen físico se aprecia deshidratado y soporoso, sin signos focales en el examen neurológico. Se solicita hemoglucotest, que resulta 290 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hiperglicémico, hiperosmolar
- b) Hipernatremia
- c) Hipocalcemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipercalcemia

5) Un paciente de 65 años, con disnea crónica, se realiza una espirometría que muestra lo siguiente:

Valores basales: VEF1 (%teórico): 54% CVF (%teórico): 89% VEF1/CVF: 62%

Post-broncodilatador: VEF1 (%teórico): 58% CVF (%teórico): 91% VEF1/CVF: 65%

El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) Fibrosis pulmonar
- c) EPOC
- d) Hipertensión pulmonar
- e) TEP crónico

6) Un paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, presenta de manera brusca hemiparesia derecha de predominio braquial. Al examen físico está desorientado, con dificultades para hablar, con la hemiparesia descrita y disminución del tono muscular y abolición de los ROT derechos. Se solicita TAC de cerebro, que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Tumor cerebral
- c) Epilepsia
- d) Miastenia gravis
- e) Accidente cerebrovascular

7) ¿Cuál de los siguientes pacientes puede recibir anestesia raquídea, sin mayor contraindicación?

- a) Paciente con hipotensión, secundaria a shock cardiogénico
- b) Paciente con TEC severo y edema de papila
- c) Paciente con coagulopatía no compensada
- d) Paciente con antecedente de síndrome neuroléptico maligno, en una cirugía previa con gases anestésicos
- e) Paciente con infección en el sitio de punción

8) ¿Qué examen es útil para la confirmación diagnóstica de la dermatitis de contacto alérgica?

- a) Biopsia cutánea
- b) Prick test
- c) Test de parche
- d) Prueba de respuesta a corticoides
- e) Niveles plasmáticos de IgE específica

9) Un paciente insuficiente renal crónico, debe iniciar hemodiálisis 3 veces a la semana, por lo que se solicitan pruebas para virus de hepatitis, obteniéndose los siguientes resultados:

VHBs IgG(+), VHBs Ag(-), VHBc IgM(-), VHBc IgG(+), VHC IgG(+), VHC IgM(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis B crónica
- b) Hepatitis B aguda
- c) Hepatitis B y C
- d) Hepatitis C
- e) Sano

10) Un paciente de 38 años acude a control por un tratamiento para el sobrepeso, en el cual se constata PA: 150/96 mmHg. Se realizan tomas seriadas en días distintos, obteniendo varios valores similares de PA. Se solicita creatinina: 1,0 mg/dl, Na: 143 mEq/l, Cl: 106 mEq/l, K: 4,8 mEq/l, glicemia: 110 mg/dl, Ca: 10 mEq/l, hematocrito: 45%, blancos: 8.300 por mm³, plaquetas: 390.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo
- b) Hipertensión renovascular
- c) Hipertensión esencial
- d) Hiperaldosteronismo primario
- e) Hipertensión secundaria a nefropatía médica

11) El hallazgo de un soplo pansistólico 3/6 en el 5to espacio intercostal izquierdo en el borde esternal en un lactante de un mes, sugiere la presencia de:

- a) comunicación interauricular de pequeño shunt.
- b) comunicación interventricular.
- c) conducto arterioso permeable.
- d) coartación de la aorta.
- e) soplo inocente

12) Una mujer de 30 años, sin antecedentes de importancia, se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo médico, que muestra un mioma subseroso de 1,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar análogos de la GnRH
- b) Realizar resección del mioma por histeroscopia
- c) Realizar histerectomía transvaginal
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Observar evolución

13) En un programa de salud, se entiende por eficiencia el:

- a) logro de los objetivos del programa
- b) costo del programa
- c) grado de satisfacción del usuario
- d) ahorro de muerte mediante el programa
- e) logro de los objetivos a menor costo

14) Mujer de 27 años en estudio en el Servicio de dermatología por presentar episodios de aftas bucales recidivantes. Es remitida a las consultas de Aparato Digestivo por objetivar en una analítica Hb 11,5 gr/dl Fe 38 AST 52 ALT 64 Ac antitrasglutaminasa IgA 177. La paciente sólo refiere presentar molestias abdominales difusas de forma ocasional. No refiere signos de hemorragia ni ictericia.. La exploración física es normal. ¿Qué prueba de las que se mencionan a continuación considera que es la más adecuada para realizar el diagnóstico?

- a) Cápsula endoscópica.
- b) Colonoscopia
- c) Serología para virus de la hepatitis b y c
- d) Biopsia intestinal
- e) Ecografía abdominal.

15) Una mujer, cursando embarazo de término, inicia trabajo de parto. En la fase activa presenta metrorragia, estando en buenas condiciones, sin embargo se aprecia rápido deterioro de las pruebas de bienestar fetal, con signos de sufrimiento fetal agudo. El diagnóstico es:

- a) Desprendimiento de placenta
- b) Rotura uterina
- c) Placenta previa
- d) Acretismo placentario
- e) Rotura de vasa previa

16) Se comparan la tasas de hemorragia grave entre un grupo tratado con un anticoagulante experimental y otro grupo tratado con heparina de bajo peso molecular. Se calculan las incidencias de hemorragias graves y se obtiene un un riesgo relativo de 3, con un intervalo de confianza de 95% de 2,3 a 3,5. Esto significa que:

- a) La probabilidad de sufrir una hemorragia grave es 3 veces mayor en los pacientes tratados con el nuevo anticoagulante
- b) La probabilidad de sufrir una hemorragia grave es 3 veces mayor en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular
- c) La probabilidad de sufrir una hemorragia es un 3% mayor en los pacientes tratados con el nuevo anticoagulante
- d) La probabilidad de sufrir una hemorragia es un 3% mayor en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular
- e) No existen diferencias significativas en la incidencia de hemorragias graves, entre ambos fármacos

17) Un paciente de 34 años consulta por dolor torácico de 48 horas de evolución, que ha aumentado en las últimas horas y que es especialmente intenso a la inspiración profunda. Al examen se aprecia PA: 120/80 mmHg, FC: 90x', RR2T con ruidos apagados, sin soplos, MP+, sin ruidos agregados. Se constata que la presión arterial desciende hasta 100/60 mmHg, con la inspiración profunda. El diagnóstico más probable es:

- a) TEP
- b) Neumotórax a tensión
- c) Pericarditis aguda
- d) Disección aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica

18) Las causas más frecuentes de muerte en los escolares son:

- a) Accidentes y cáncer
- b) Accidentes y enfermedades respiratorias
- c) Accidentes y enfermedades cardiovasculares
- d) Enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias
- e) Enfermedades cardiovasculares y cáncer

19) Mujer 30 años con palpitaciones muy intensas de inicio y término brusco, de minutos de duración en varias oportunidades en los últimos años. Ingres a urgencias por cuadro de palpitaciones intensas que esta vez no ha cedido. Al examen: FC:180x', PA:110/70. El ECG muestra taquicardia regular a QRS angosto. La primera medida a seguir es:

- a) Administrar adenosina endovenosa
- b) Administrar amiodarona endovenosa
- c) Realizar cardioversión eléctrica
- d) Realizar maniobras vagales
- e) Administrar propafenona o flecainida oral

20) Un adulto mayor, hipertenso, sufre una caída a nivel, golpeándose la cabeza. Se solicita TAC que resulta normal, sin embargo, algunos días después, el paciente evoluciona con miedo a caminar y caerse nuevamente, por lo que ha dejado de salir de su casa. ¿Qué alternativa es más adecuada?

- a) Deben indicarse benzodiacepinas para disminuir la ansiedad
- b) Debe discontinuar el uso de lentes, si los usa, ya que pueden afectar la percepción de las cosas y aumentar el riesgo de caídas
- c) Debe indicarse reposo relativo, limitando todo tipo de actividad física, a menos que sea estrictamente necesaria
- d) Deben evaluarse los antihipertensivos, como posibles causas de la caída
- e) Deben solicitarse TAC seriados de cerebro, por el riesgo de desarrollar un hematoma subdural

21) Paciente de 47 años de edad que consulta en el servicio de Urgencias por una pérdida brusca de conciencia. ¿Cuál entre los siguiente, tiene un mayor rendimiento diagnóstico?

- a) Historia clínica
- b) Electrocardiograma
- c) Registro Holter
- d) Electroencefalograma
- e) TC de cráneo

22) Una mujer de 55 años sufre de desmayos, con pérdida de conciencia en relación a peleas con sus familiares. Le ha sucedido en varias oportunidades, por lo que sus hijos se encuentran preocupados. Los síntomas no parecen ser manifestados intencionalmente. Su examen físico, exámenes de laboratorio y neuroimágenes son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno facticio
- b) Trastorno por simulación
- c) Trastorno conversivo
- d) Disautonomía
- e) Trastorno disociativo

23) Una paciente de 54 años en tratamiento con levofloxacin por neumonía adquirida en la comunidad, inicia dolor abdominal y diarrea acuosa. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Suspender el levofloxacin e iniciar amoxicilina más Ac. clavulánico
- b) Agregar metronidazol al tratamiento antibiótico
- c) Solicitar toxinas de Clostridium difficile en heces
- d) Solicita colonoscopia y manejar segun hallazgos
- e) Tranquilizar a la paciente y explicarle que es normal presentar diarrea al usar antibióticos de amplio espectro

24) La conducta de un médico general frente a un paciente con un episodio maniaco severo debe ser:

- a) derivarlo a psiquiatra para su tratamiento
- b) tratar la agitación psicomotora y derivarlo a psiquiatra
- c) tratar hasta que remita el episodio maniaco y derivarlo
- d) iniciar tratamiento con litio y derivarlo a psiquiatra
- e) tratar con ácido valproico y controlar

25) Una paciente de 28 años consulta por metrorragia intensa, de 3 días de evolución, con presencia de abundantes coágulos. El test de embarazo resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar ácido tranexánico
- c) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos
- d) Realizar legrado
- e) Iniciar anticonceptivos orales

26) La causa más frecuente de hemorragia post parto vaginal en una paciente con útero retraído es:

- a) Miomatosis uterina
- b) Trastornos de la coagulación
- c) Laceraciones del canal de parto
- d) Rotura uterina
- e) Restos placentarios

27) En una población se determina que el consumo de cigarrillos tiene un riesgo atribuible porcentual poblacional (RAP%) de 90% para el desarrollo de cáncer de pulmón. Esto quiere decir que:

- a) El 90% de los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón
- b) El 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores
- c) El cigarrillo aumenta en un 90% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón
- d) Cerca de la mitad de la población es fumadora y tienen 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, que aquellos que no fuman
- e) Sólo un 10% de los casos de cáncer de pulmón de esta población se deben a una causa distinta del cigarrillo

28) La mejor imagen para evaluar un aumento de volumen de una extremidad, compatible con un sarcoma de partes blandas es:

- a) Ecografía de partes blandas
- b) Cintigrafía
- c) Tomografía axial computarizada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Radiografías simples seriadas

29) El primer síntoma de cáncer de cuello uterino suele ser:

- a) el dolor pélvico
- b) la dispareunia
- c) la metrorragia
- d) la pérdida de peso
- e) el prurito vaginal

30) Un paciente de 36 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, asociados a edema de extremidades inferiores de un mes de evolución y que ha aumentado en el último tiempo. Refiere que se ahoga en la noche, por lo que debe dormir semisentado. Al examen físico se constata desplazamiento del choque de la punta y se auscultan crépitos pulmonares bibasales. El electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Insuficiencia aórtica

31) Una primigesta de 38 semanas de gestación consulta por una clara disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se realiza registro basal no estresante que muestra frecuencia cardíaca fetal a 150 lpm, con variabilidad normal y presencia de 3 aceleraciones en 20 minutos, 2 de ellas en relación a movimientos fetales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar perfil biofísico
- b) Realizar ecodoppler umbilical
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Prolongar el registro por 20 minutos más
- e) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio

32) Una niña de 5 años presenta leucorrea de mal olor y metrorragia. La madre se muestra muy preocupada. El diagnóstico más probable es:

- a) Abuso sexual
- b) Trocomoniasis
- c) Vulvovaginitis prepuberal inespecífica
- d) Cáncer de vagina
- e) Cuerpo extraño

33) Una paciente de 39 años consulta por dismenorrea importante, progresiva, que inició hace cerca de 8 meses y que se ha vuelto más intensa. Refiere reglas abundantes, regulares y al tacto vaginal se aprecia aumento del tamaño uterino, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo molar
- b) Endometriosis
- c) Cáncer de endometrio
- d) Miomatosis
- e) Adenomiosis

34) Una paciente de 68 años, asintomática, se realiza un hemograma que muestra VHS: 23 mm/h, hematocrito: 32%, Hb: 10,6 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 106 ft, plaquetas: 90.000 x mm³, glóbulos blancos: 3.900 x mm³, linfocitos: 65%, segmentados: 30%, monocitos: 5%. Se solicitan niveles plasmáticos de vitamina B12 y folatos, que resultan normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Mieloma múltiple
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis

35) Un recién nacido de 21 días presenta ictericia hasta los muslos. Se solicita bilirrubina diferenciada que resulta, bilirrubina total: 10 mg/dl y bilirrubina directa: 1,3 mg/dl. El diagnóstico más probable, entre los mencionados, es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad Rh
- b) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia fisiológica
- d) Atresia biliar primaria
- e) Hipotiroidismo congénito

36) Un lactante de 11 meses, inicia cuadro de fiebre hasta 38,5°C e irritabilidad, sin otros síntomas. Al examen físico se ve de buen aspecto y sólo destaca faringe eritematosa, congestiva, con exudado amigdalino blanquecino, adherente, bilateral, asociado a algunas adenopatías cervicales. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección respiratoria alta viral
- b) Amigdalitis estreptocócica
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Herpangina
- e) Difteria

37) Una paciente consulta por sensación de oído tapado y otorrea por el oído izquierdo, de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una perforación timpánica izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de oído
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis media con efusión
- d) Otitis externa localizada
- e) Otitis externa maligna

38) Un recién nacido de 35 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, que responde a oxígeno al 28%. Al examen físico se auscultan escasos crépitos en las bases. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita cianótica
- b) Cardiopatía congénita acianótica
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Neumonía neonatal
- e) Taquipnea transitoria

39) El período fértil se extiende desde:

- a) Un día antes hasta un día después de la ovulación
- b) Cinco días antes hasta cinco días después de la ovulación
- c) Cinco días antes hasta el día de la ovulación
- d) Diez días antes hasta tres días después de la ovulación
- e) Siete días antes hasta tres días después de la ovulación

40) Un niño de 5 años sufre caída de la escalera golpeándose la cabeza. Evoluciona con desorientación de 20 minutos, recuperándose totalmente, sin embargo 30 minutos más tarde presenta una convulsión tónico-clónica de 5 minutos de duración autolimitada. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, con Glasgow 15 y sin alteraciones neurológicas.

La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINEs e indicación de consultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar radiografía de cráneo y decidir según hallazgos
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- d) Solicitar TAC de cerebro, con ventana ósea
- e) Iniciar anticonvulsivantes y solicitar electroencefalograma

41) Un paciente de 70 años presenta fiebre, tos y disnea de 2 días de evolución. Al examen físico está taquicárdico, disneico, con FC: 102 x', PA: 120/80 mmHg, t°: 38,0°C, PaO2: 87% a FiO2 ambiental. La auscultación pulmonar muestra crepitaciones localizadas en la base izquierda. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un foco de condensación neumónica en el lóbulo inferior izquierdo. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Ceftriaxona
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Claritromicina
- d) Ceftazidina + vancomicina + metronidazol
- e) Clindamicina

42) Una paciente multipara de 3, cursa un nuevo embarazo de 41 + 6 semanas. Su examen físico es normal, al igual que las pruebas de bienestar fetal. No presenta dinámica uterina, ni modificaciones cervicales y se palpa el feto en presentación cefálica. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales
- c) Realizar cesárea
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Administrar ritodrina

43) Un paciente de 35 años presenta una hemorragia digestiva alta, la que es manejado con administración de cristaloides y omeprazol endovenoso. Se realiza una endoscopia digestiva alta, constatándose la presencia de una úlcera duodenal, la que es tratada mediante inyectoterapia endoscópica, evolucionando satisfactoriamente. Además se constata test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir nuevas hemorragias?

- a) Iniciar propanolol oral a permanencia
- b) Indicar uso de omeprazol a permanencia
- c) Indicar omeprazol y antibióticos orales, erradicando Helicobacter pylori
- d) Prohibir el consumo de AINEs
- e) Realizar resección quirúrgica del sitio de la úlcera

44) Un paciente sufre un trauma lumbar, al caer de altura, presentando incontinencia urinaria. Al examen destaca anestesia en silla de montar de la zona perineal. La movilidad y sensibilidad de las extremidades inferiores son normales. El sitio más probable de la lesión es:

- a) Asta anterior de la médula
- b) Haz corticoespinal
- c) Haz espinotalámico
- d) Cauda equina
- e) Cono medular

45) Usted atiende a un niño de 1 año que no viene a control de salud desde los 5 meses. ¿Qué vacunas le pondría y cuándo, según el PNI actualizado?

- a) Trivírica, DPT, Haemophilus influenza B, antineumocócica conjugada, polio y hepatitis B, todas al mismo tiempo
- b) Trivírica y antineumocócica conjugada
- c) Trivírica, y luego de 1 mes: DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B
- d) DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B, y luego de un mes: trivírica y antineumocócica conjugada
- e) BCG, DPT, trivírica, hepatitis B y polio, todas al mismo tiempo

46) ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al pensamiento de un niño de dos a cuatro años?

- a) Concreto, fundado en la acción
- b) Prelógico, egocéntrico
- c) Objetivo, centrado en la realidad
- d) Social, fundado en la interacción
- e) Preverbal, práctico

47) Un paciente cirrótico, por virus hepatitis C, se realiza una endoscopia digestiva, que muestra várices esofágicas grandes. No ha presentado hemorragias. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar propanolol y ajustar la dosis según la evolución del aspecto endoscópico de las várices
- b) Iniciar betabloqueantes y ajustar la dosis mediante la presión portal medida por ecografía
- c) Iniciar diuréticos y ajustarla dosis según evolución del aspecto endoscópico de las várices
- d) Iniciar betabloqueantes no selectivos y ajustar las dosis según la frecuencia cardíaca
- e) Realizar ligadura de várices e indicar betabloqueantes, a dosis estándar

48) ¿Cuál de las siguientes historias clínicas es más compatible con el cuadro clínico característico de la cirrosis biliar primaria?

- a) Mujer de 40 años, con astenia y prurito, con elevación marcada de las fosfatasa alcalinas y discreta de la bilirrubina
- b) Hombre de 60 años, con ictericia y presencia de ANCA
- c) Mujer de 60 años, con antecedente de vitiligo, con elevación persistente de transaminasas, sin hábitos tóxicos y con serología viral negativa
- d) Mujer de 30 años con ictericia fluctuante, de predominio indirecto y elevación de la GGT y fosfatasa alcalinas, con GOT y GPT normales
- e) Hombre de 60 años con ictericia, coluria y acolia, asociado a baja de peso

49) Paciente de 25 años, consulta por haber notado aumento de volumen testicular derecho. La ecografía testicular muestra tumor de aspecto sólido en testículo derecho. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Control ecográfico en 6 meses
- b) Realizar biopsia por punción del tumor
- c) Realizar tumorectomía y biopsia
- d) Solicitar marcadores tumorales (AFP, HCG y LDH) y decidir cirugía según resultados
- e) Realizar orquiectomía derecha, por vía inguinal, independientemente del resultado de los marcadores tumorales.

50) La presencia de un soplo diastólico, con refuerzo presistólico, aumento de la intensidad del primer ruido y presencia de chasquido de apertura son características de:

- a) Estenosis mitral
- b) Insuficiencia mitral
- c) Estenosis aórtica
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

51) ¿Cuál de los siguientes cánceres tiene mejor pronóstico?

- a) Cáncer de endometrio
- b) Cáncer de ovario
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Cáncer de mama
- e) Cáncer de vejiga urinaria

52) La asociación de asma, eosinofilia y hematuria dismórfica es característica de:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Vasculitis de Churg Strauss
- c) Púrpura de Schoenlein-Henoch
- d) Síndrome de Good-Pasture
- e) Panarteritis nodosa

53) Un paciente de 85 años, diabético e hipertenso, se realiza un tacto rectal que muestra un nódulo en el lóbulo prostático izquierdo, de 1 cm. No presenta síntomas, y además se mide el antígeno prostático específico, el que resulta 5,1 ng/dl. Por lo anterior, se indica una biopsia transrectal, que muestra un adenocarcinoma de próstata de grado moderado de diferenciación. El estudio complementario no visualiza invasión de otros órganos ni metástasis. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar hormonoterapia
- b) Realizar prostatectomía radical
- c) Indicar quimioterapia
- d) Realizar resección transuretral
- e) Observar evolución

54) ¿Cuál de las siguientes es una excelente alternativa para el tratamiento de una pielonefritis en un niño de 4 años?

- a) Cefalotina
- b) Nitrofurantoína
- c) Amoxicilina
- d) Cloxacilina
- e) Doxiciclina

55) En una mujer embarazada de 11 semanas que lleva tres días sangrando por genitales, con muchas náuseas, útero mayor que su amenorrea y unos valores de beta HCG muy elevados, ¿en cuál de las siguientes patologías debe pensarse?:

- a) Amenaza de aborto.
- b) Aborto diferido.
- c) Mola hidatídica.
- d) Amenaza de aborto en un útero con miomas.
- e) Aborto incompleto.

56) Un paciente de 30 años consulta por fiebre y presencia de un exantema macular generalizado, con compromiso de palmas y plantas. Se solicita VDRL y FTA-ABS que resultan positivos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina benzatina
- b) Iniciar cirpofloxacino
- c) Iniciar doxiciclina
- d) Iniciar metronidazol
- e) Observar evolución

57) El diagnóstico más probable frente a un niño de 6 años que cursa con hematuria dismórfica, hipertensión arterial y edema palpebral, asociado a creatinina plasmática de 1,2 mg/dl y disminución del complemento es:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- c) Enfermedad de Berger
- d) Glomerulonefritis pauciinmune
- e) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

58) Un niño de 5 años presenta cefalea y fiebre alta, asociados a vómitos en varias oportunidades. Hcae dos días había sido diagnosticado de otitis media aguda, por lo que había recibido amoxicilina oral. Al examen físico se aprecia decaído, con rigidez de nuca esbozada. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 600 células por mm³, de predominio polimorfonuclear, proteínas de 150 mg/dl y glucosa de 30 mg/dl. No se observan bacterias en el Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar baciloscopías y cultivo de Koch de líquido cefalorraquídeo
- b) Iniciar ceftriaxona más vancomicina endovenosa, asociadas a corticoides
- c) Enviar a domicilio con tratamiento sintomático
- d) Iniciar aciclovir endovenoso y solicitar PCR para virus herpes simplex
- e) Iniciar cefotaximo más ampicilina endovenosa

59) Un paciente inicia un antipsicótico evolucionando, al día siguiente, con movimientos de la boca, caracterizados por contractura de los labios y de la lengua, que en ocasiones le impide hablar, tragar y en otras le impide abrir la boca. El diagnóstico es:

- a) Disonía
- b) Acatisia
- c) Disquinesia
- d) Balismo
- e) Atetosis

60) En una mujer obesa de 42 años se le realiza determinación del cortisol en sangre, orina y saliva y en todas las determinaciones está elevado. Tras la realización del test de supresión nocturna con dexametasona, los niveles de cortisol en sangre permanecen elevados, por lo que se sospecha síndrome de Cushing ACTH independiente, ¿qué prueba adicional solicitaría para confirmar el diagnóstico en este momento?

- a) Un cateterismo de senos petrosos.
- b) Una gammagrafía con somatostatina marcada (Octreoscan).
- c) Una gammagrafía con Sesta-MIBI.
- d) Una ecografía abdominal.
- e) Una TC de suprarrenales.

61) Un niño se ríe a carcajadas, es capaz de levantar la cabeza sin problemas y coge objetos con su mano, llevándoselos a la boca. Su edad es:

- a) 2 meses
- b) 4 meses
- c) 6 meses
- d) 8 meses
- e) 10 meses

62) Una paciente quería saber si padecía cierta enfermedad, que es frecuente en la población. Se realizó un examen diagnóstico con una altísima especificidad y resultó positivo. Respecto a esto se puede afirmar que:

- a) Debe realizarse un nuevo examen que tenga una alta sensibilidad
- b) Debe realizarse un nuevo examen que tenga un alto valor predictivo negativo
- c) Hay que tranquilizarla y explicarle que lo más probable es que se trate de un falso positivo
- d) Debe repetirse el mismo examen para confirmar
- e) Es probable que padezca la enfermedad, ya que dependiendo de la prevalencia, los exámenes con alta especificidad suelen tener altos valores predictivos positivos

63) Un niño de 10 años presenta un cuadro de debilidad generalizada. ¿Qué alteración es MENOS compatible con un síndrome de Guillain Barré?

- a) Hipoestesia
- b) Hipercarbia
- c) Signo de Babinsky
- d) Hipotonía
- e) Arreflexia

64) Una mujer, cursando un embarazo de 5 semanas de amenorrea, inicia metrorragia escasa. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, de 15mm de diámetro, sin presencia de embrión. El tacto vaginal no muestra modificaciones cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar beta-HCG
- b) Administrar metotrexato
- c) Observar evolución, indicar reposo y solicitar control con nueva ecografía en 7 días o en caso de signos de alarma
- d) Realizar legrado
- e) Resolver mediante laparoscopia

65) Un recién nacido de 5 días de vida pesa 3.500 gr. Al nacer pesó 3.800 gr y se ha alimentado con lactancia materna exclusiva. La conducta más adecuada es

- a) Observar evolución, manteniendo la lactancia materna exclusiva
- b) Agregar fórmula láctea y mantener la lactancia materna
- c) Iniciar fórmula láctea y suspender la lactancia materna
- d) Solicitar test del sudor
- e) Iniciar nutrición parenteral

66) Un recién nacido de término, de 25 días de edad consulta por vómitos recurrentes, que acontecen pocos minutos después de alimentarse. Muchas veces se muestra hambriento y ha dejado de subir de peso. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Observar evolución
- c) Solicitar radiografía simple de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Iniciar domperidona oral

67) Una paciente en trabajo de parto, con feto en presentación de vértice presenta dinámica uterina de 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm, con borramiento completo, membranas íntegras y cabeza fetal en espinas 0. Se evalúa a las 2 horas, sin presentar cambios y el monitoreo fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aceleración oxitócica
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Administrar misoprostol
- d) Realizar fórceps
- e) Realizar cesárea

68) Un paciente de 55 años, asintomático, se realiza un perfil bioquímico, que muestra una hipercalcemia de 11,5 mg/dl, fosfemia: 5,9 mg/dl, con albúmina de 2,5 g/dl. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal
- b) Hipercalcemia maligna
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hipercalcemia ficticia
- e) Hiperparatiroidismo secundario

69) Un paciente de 68 años, muy fumador, consulta por disfagia lógica y progresiva. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis
- b) Solicitar videodeglución
- c) Solicitar endoscopia digestiva
- d) Solicitar radiografías baritadas
- e) Solicitar TAC de tórax y abdomen

70) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Huevo anembrionado – Aborto retenido
- b) Modificaciones cervicales – Aborto inevitable
- c) Quistes tecoluteínicos – Mola completa
- d) Metrorragia con hipotensión – Embarazo ectópico roto
- e) Incompetencia cervical – Abortos antes de las 10 semanas de edad gestacional, a repetición

71) El consumo de AINEs clásicamente produce

- a) Alargamiento del tiempo de protrombina
- b) Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada
- c) Alargamiento del tiempo de sangría
- d) Disminución del recuento de plaquetas
- e) Aumento del recuento de plaquetas

72) Un paciente presenta una lesión oscura, de pigmentación irregular en el tronco, que ha crecido a lo largo de 2 años, alcanzando los 15 mm de diámetro y que en ocasiones se ulcera y sangra. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevo atípico
- b) Nevo melanocítico
- c) Melanoma
- d) Léntigo
- e) Granuloma telangiectásico

73) Una paciente de 44 años consulta por dolor abdominal crónico, caracterizado por dolor tipo cólico, asociado a distensión abdominal y flatulencia. Refiere además constipación de larga data, con deposiciones caprinas, con mucosidad. El dolor suele ser más intenso cuando come mucho y cede con la evacuación de gases y de deposiciones. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Síndrome de intestino irritable
- c) Colitis ulcerosa
- d) Enfermedad celíaca
- e) Pancreatitis crónica

74) Un paciente hipertenso presenta brusca disminución de la visión del ojo izquierdo, sin otros síntomas. Al examen físico la oculomotilidad es normal y la agudeza visual es ojo izquierdo: cuenta dedos, ojo derecho: 20/20. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión maligna
- b) Oclusión de la arteria central de la retina
- c) Edema macular
- d) Trombosis de la vena central de la retina
- e) Desprendimiento de retina

75) La medida terapéutica más eficaz para aumentar las expectativas de vida y retardar el curso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es:

- a) uso de broncodilatadores inhalatorios.
- b) tratamiento con corticoides inhalatorios
- c) suspensión del hábito tabáquico.
- d) kinesiterapia respiratoria.
- e) antibioterapia profiláctica.

76) Una niña de cuatro años se presenta con fiebre de 39°C, edema periorbitario izquierdo y proptosis leve. Tiene limitación en el movimiento del globo ocular hacia arriba y hacia afuera. La agudeza visual es normal. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Conjuntivitis
- b) Celulitis orbitaria
- c) Pseudotumor orbitario
- d) Rabdomiosarcoma orbitario
- e) Celulitis preseptal

77) Un paciente se ve obligado a rematar su casa, debido a que presenta múltiples deudas y enfrenta la quiebra de su empresa. Su situación económica se estabiliza, sin embargo él y su familia deben disminuir el ritmo de gastos al que estaban acostumbrados, de manera drástica, arrendando un pequeño departamento. El paciente evoluciona con ánimo bajo, muy irritable, con sensación de fracaso e ideas de desesperanza. Refiere que siente mucha vergüenza, duerme gran parte del día y no tiene motivación para reactivar su empresa o buscar un empleo. Además ya no se junta con sus amigos y casi no habla con sus hijos ni esposa. Ella refiere que está muy preocupada, ya que previo a esto, era un hombre muy alegre, buen padre y buen esposo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno por estrés postraumático

78) Un paciente de 1 año, presenta diarrea explosiva, abundante, de 2 días de evolución, asociada a fiebre. Al examen físico está taquicárdico, con mucosas deshidratadas y soporoso. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con régimen líquido
- b) Enviar a domicilio con sales de rehidratación oral después de cada deposición diarreica
- c) Administrar sales de rehidratación oral 100 cc/kg en 4 a 6 horas y reevaluar
- d) Administrar suero fisiológico endovenoso
- e) Administrar suero glucosalino endovenoso

79) Un paciente de 65 años presenta hematuria en 3 oportunidades, sin otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina que muestra más de 100 GR por campo, sin presencia de dismorfia, ni otras alteraciones. El urocultivo es negativo. La conducta diagnóstica más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Solicitar una uretrocistografía miccional seriada
- b) Solicitar una pielografía de eliminación
- c) Solicitar un pielotAC
- d) Solicitar una ecografía renal y vesical
- e) Solicitar una cistoscopia

80) Un hombre de 45 años es mordido por el gato de su vecina, mientras le ayudaba a atraparlo, para llevarlo a control con su veterinario. Al examen físico se observan varios rasguños en los antebrazos y 4 lesiones puntiformes en el dorso de la mano y los dedos derechos sin signos de infección. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica, indicar amoxicilina más ácido clavulánico y observar al animal por 10 días
- b) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar cloxacilina
- c) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica y observar al animal por 10 días, sin necesidad de antibióticos
- d) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Realizar aseo y curación de la herida, administrar las vacunas antitetánica y antirrábica e indicar antibióticos de amplio espectro

81) Un paciente tuberculoso inicia tratamiento antibiótico, con buena respuesta clínica. Actualmente está en el tercer mes de tratamiento, en la fase bisemanal, con 2 fármacos y se ha controlado con baciloscopias mensuales con los siguientes resultados: 1(+), 2(+), 3(+). La conducta más adecuada es:

- a) Continuar el tratamiento antituberculoso con 2 fármacos
- b) Solicitar cultivo de esputo para mycobacterias
- c) Agregar ceftriaxona endovenosa
- d) Retomar el tratamiento antituberculoso de la fase mensual
- e) Derivar a especialista, por falla del tratamiento

82) Una paciente embarazada, se realiza un test de tolerancia a la glucosa a las 28 semanas, que muestra glicemia ayuno: 104mg/dl y postcarga de 75g glucosa: 150 mg/dl. El diagnóstico es:

- a) Resistencia a la insulina
- b) Diabetes gestacional
- c) Intolerancia a la glucosa
- d) Síndrome metabólico
- e) Embarazo normal

83) Una mujer de 50 años presenta lesiones vesiculares y ampollares, recurrentes, especialmente en las zonas de roce. Es frecuente que forme bulas ante mínimos golpes y éstas se rompen fácilmente. Al examen físico destaca signo de Nikolski. ¿Qué afirmación es VERDADERA, respecto a la patología descrita?

- a) Se trata de un caso de penfigoide
- b) Su tratamiento de elección son los corticoides tópicos
- c) La inmunofluorescencia demostrará inmunoglobulinas en las uniones entre queratinocitos
- d) La exposición solar es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad
- e) Suele ser una enfermedad autolimitada

84) ¿Cuál de las siguientes asociaciones, entre patología y presentación clínica, es INCORRECTA?

- a) Escleritis – Ojo rojo profundo, con hipopión
- b) Glaucoma agudo – Ojo rojo profundo, doloroso, con midriasis que no responde a la luz
- c) Uveítis aguda – Ojo rojo profundo, con miosis e hipotonía ocular
- d) Dacriocistitis – Ojo rojo superficial, asociado a epifora y aumento de volumen nasoorbital
- e) Queratitis herpética – Ojo rojo profundo, con ulceración dendrítica en la córnea

85) Un niño de 4 años continúa orinándose en la cama mientras duerme. Su continencia diurna es normal y no presenta otros síntomas ni alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía renal y vesical
- b) Solicitar osmolaridad urinaria y plasmática
- c) Solicitar glicemia de ayuno
- d) Solicitar sedimento de orina y urocultivo por sondeo
- e) Observar evolución

86) ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?

- a) Mantener la capacidad de arrugar la frente y cerrar el ojo derecho
- b) Compromiso de músculos masticatorios derechos
- c) Presencia de hemiparesia braquiocrural derecha
- d) Presencia de hemihipoestesia facial derecha
- e) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón

87) Un paciente realiza un viaje a Brasil. Dos semanas después inicia un cuadro de fiebre alta, malestar general, cefalea, náuseas, mialgias e ictericia. Al examen físico presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Se solicita hemograma que muestra Hcto: 30%, plaquetas: 80.000 por mm³, blancos: 3.500 por mm³, GOT: 120 UI, GPT: 90 UI, bilirrubina: 3,4 mg/dl, bilirrubina conjugada: 0,6 mg/dl, FA: 180 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Dengue
- b) Fiebre amarilla
- c) Malaria
- d) Distomatosis
- e) Tripanosomiasis (Chagas)

88) Paciente de 70 años sometido hace 10 días a un recambio total de cadera derecha por fractura, sin complicaciones hasta el alta.

Consulta por aumento de volumen y dolor de la extremidad inferior derecha.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Luxación de la prótesis
- b) Hematoma de herida operatoria
- c) Infección profunda
- d) Trombosis venosa profunda
- e) Fractura periprotésica

89) Se considera pubertad precoz el inicio del desarrollo puberal antes de:

- a) Los 6 años en los niños y los 7 años en las niñas
- b) Los 9 años en los niños y las niñas
- c) Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas
- d) Los 8 años en los niños y los 7 años en las niñas
- e) Los 8 años en los niños y los 9 años en las niñas

90) Un paciente de 65 años presenta un cambio progresivo en su conducta, caracterizada por lenguaje más grosero, de contenido sexual y además con escaso o nulo insight. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Encefalopatía de Korsakov
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Demencia frontotemporal

SEGUNDA PARTE

1) El tiopental es un barbitúrico habitualmente utilizado en la anestesia. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de este inductor, que obliga a remplazarlo por ketamina o etomidato, en pacientes susceptibles?

- a) Náuseas
- b) Hipotensión
- c) Depresión respiratoria
- d) Hipertermia maligna
- e) Tórax leñoso

2) Un paciente diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina, glibenclamida, hidroclorotiazida y enalapril, todos en dosis máximas, evoluciona con malestar, constatándose hiperkalemia de 6,0 mEq/l. Qué modificaciones realizaría a su tratamiento:

- a) Cambiar los hipoglicemiantes orales por insulina
- b) Cambiar el enalapril por losartán
- c) Cambiar el enalapril por atenolol
- d) Cambiar el enalapril por amlodipino
- e) Cambiar la hidroclorotiazida por atenolol

3) Paciente de 50 años consulta por presentar sangre fresca al defecar desde hace un mes . Refiere distensión abdominal intermitente en el último año. No presenta dolor abdominal ni cambio de hábito intestinal. Al examen se observan hemorroides mixtos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Rectoscopia y tratamiento médico de los hemorroides
- b) Rectoscopia y hemorroidectomía
- c) Colonoscopia y tratamiento médico de los hemorroides
- d) Tratamiento médico de los hemorroides
- e) Hemorroidectomía

4) Un paciente de 40 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 3 años, presenta tos crónica, con expectoración mucosa abundante, mayor en las mañanas, que en ocasiones es hemoptoica o mucopurulenta. Al examen físico se aprecian uñas en vidrio de reloj, sibilancias escasas en la base izquierda, sin otras alteraciones. La radiografía de tórax es inespecífica y las baciloscopías resultan negativas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un TAC de tórax de cortes finos
- b) Solicitar biopsia pleural
- c) Solicitar cultivo de expectoración
- d) Iniciar antibióticos
- e) Indicar mucolíticos y consumo de líquidos abundantes por vía oral

5) Paciente de 65 años sin antecedentes mórbidos. Hace 4 meses con conducta más apática y fallas reiteradas en la memoria. Los familiares se muestran muy preocupados y refieren que además ha presentado caídas en múltiples ocasiones y también incontinencia urinaria. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Alzheimer inicial
- b) AVE a repetición
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Demencia frontotemporal
- e) Hidrocefalia normotensiva

6) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es parte del envejecimiento normal?

- a) Caída del hematocrito
- b) Caída de la filtración glomerular
- c) Elevación de las transaminasas
- d) Impotencia sexual
- e) Pérdida de la memoria a corto plazo

7) Un paciente se palpa un nódulo tiroideo. Al preguntarle dirigidamente, acusa diarrea e intolerancia al calor, que antes no tenía. Al examen físico se constata taquicardia y piel final, húmeda y caliente. Se solicita TSH que resulta suprimida y ecografía cervical, que constata un nódulo sólido, de 1 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar punción con aguja gruesa
- b) Realizar tumorectomía
- c) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- d) Realizar tiroidectomía radical
- e) Solicitar anticuerpos TRAB y niveles plasmáticos de T4 y T3

8) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por constipación de un mes de evolución, que en las últimas horas se ha hecho mucho más marcada, siendo imposible eliminar gases ni deposiciones y presentando dolor abdominal tipo cólico y vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia distensión abdominal, con dolor a la palpación y aumento de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Íleo biliar
- b) Vólvulo de sigmoides
- c) Cáncer de colon
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Enfermedad diverticular complicada

9) Paciente de 20 años, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea leve. El examen físico sólo demuestra una leve asimetría en la intensidad del murmullo pulmonar entre ambos hemicampos pulmonares. El diagnóstico más probable y la conducta a seguir son respectivamente:

- a) Tromboembolismo pulmonar y solicitar angioTAC de tórax
- b) Neumonía y administrar antibióticos
- c) Neumotórax hipertensivo e instalar toracostomía
- d) Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax
- e) Tromboembolismo pulmonar e iniciar anticoagulación

10) ¿Cuál de las siguientes patologías se asocia a bajo riesgo de embolía sistémica?

- a) Fibrilación auricular
- b) Estenosis mitral
- c) Infarto anterior y apical
- d) Miocardiopatía dilatada
- e) Insuficiencia aórtica reumática

11) Usted recibe a un paciente de 67 años por compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecia edematoso, en sopor profundo, con frecuencia cardíaca de 42 x', temperatura: 35,0°C, FR: 12x', sin signos neurológicos focales. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 27%, VCM: 108 fl, VHS: 20 mm/h, blancos: 5.000 x mm³, plaquetas: 160.000 x mm³, y exámenes generales que constatan glicemia: 60 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, creatinina: 0,7 mg/dl, sodio: 131 mEq/l, potasio: 4,6 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal aguda
- b) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Hipotiroidismo

12) Identifique la asociación correcta:

- a) Signo de la tecla de piano – Fractura de clavícula
- b) Hombro en charretera – Disyunción acromioclavicular
- c) Dolor a la pronosupinación del antebrazo – atrapamiento cubital
- d) Dolor a la palpación de la tabaquera anatómica – fractura de extremo distal del radio
- e) Dolor a la movilidad activa y pasiva del hombro – capsulitis adhesiva

13) Una paciente de 40 años consulta por astenia. Recientemente fue diagnosticada de diabetes mellitus e inició tratamiento con metformina, con respuesta parcial. Refiere que su aspecto físico ha cambiado, sus labios se han hecho más gruesos y sus pies han crecido. Además presenta dificultades para ver, con disminución del campo visual, especialmente en los cuadrantes superiores temporales. ¿Qué prueba diagnóstica debe realizar?

- a) RMN de silla turca y prolactinemia
- b) RMN de silla turca, TSH y T4
- c) RMN de silla turca, cortisol y ACTH
- d) RMN de silla turca y GH
- e) RMN de silla turca e IGF-1

14) Un paciente de 55 años presenta debilidad de las extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia musculatura conservada, con aumento del tono muscular, hiperreflexia y reflejo plantar extensor. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis lateral amiotrófica
- b) Compresión medular
- c) Polineuropatía
- d) Miastenia gravis
- e) Síndrome extrapiramidal

15) Calcule el valor predictivo positivo con la siguiente información. Prevalencia: 20%, especificidad: 50%, sensibilidad: 80%.

- a) 15% aprox
- b) 28% aprox
- c) 40% aprox
- d) 66% aprox
- e) 95% aprox

16) La estimación precisa del área de superficie de una quemadura requiere conocer las proporciones de cada una de las diversas áreas del cuerpo con el área de superficie corporal total. La diferencia principal entre lactantes y adultos en cuanto al área de superficie consiste en que los lactantes tienen un área proporcionalmente:

- a) mayor para cabeza y cuello
- b) menor para los genitales
- c) mayor para regiones glúteas
- d) menor para manos y pies
- e) menor de tronco

17) Una paciente de 59 años, cursando el segundo día de un infarto agudo al miocardio de la pared anteroseptal, presenta marcado empeoramiento del estado general, evolucionando con palidez y disnea. Al examen físico se aprecia pulso a 115x', regular, PA: 100/70mmHg, se ausculta un soplo cardíaco holosistólico y se escuchan crépitos pulmonares bilaterales. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Disección aórtica
- b) Formación de aneurisma cardíaco
- c) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
- d) Rotura del músculo papilar
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

18) Un niño de 4 años se traga una moneda. Al examen físico no presenta alteraciones y las radiografías demuestran que la moneda está en el antro gástrico. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución e indicar reconsulta sólo en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar control radiológico cada 12 horas
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva
- e) Resolver quirúrgicamente

19) ¿Qué modificación recomendaría en el tratamiento de un paciente diabético tratado con insulina NPH matinal. Presenta buen control glicémico durante el día, confirmado mediante hemoglucotest, sin embargo presenta glicemias de ayuno cercanas a 200 mg/dl. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Agregar insulina cristalina durante la mañana
- b) Aumentar la dosis matinal de insulina NPH
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Agregar insulina cristalina nocturna
- e) Agregar colación durante la mañana

20) Una paciente de 12 años presenta una lesión solevantada en el segundo dedo de la mano izquierda, de larga evolución de color rojo, de 0,7 cm de diámetro, que se ulcera fácilmente y sangra. Al examen se aprecia húmedo, con eritema y descamación de la piel circundante. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma acral
- b) Verruga
- c) Punto rubí
- d) Granuloma piógeno
- e) Dishidrosis

21) Avisan al médico de guardia para valorar a un hombre de 30 años que tras sufrir un accidente de moto presentaba una fractura transversa de tibia derecha y al que en el área de urgencias se le inmovilizó la extremidad con un yeso cruropédico a la espera del tratamiento definitivo. El paciente presenta dolor que no controla con los analgésicos pautados y sensación de hormigueo en el primer espacio interdigital del dorso del pie, con buena movilidad, sensibilidad y presencia de pulso pedio.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- a) Es aconsejable medir la presión de los compartimentos de la pierna.
- b) Es aconsejable realizar una arteriografía.
- c) Es aconsejable abrir el yeso.
- d) Puede ser necesaria una fasciotomía quirúrgica.
- e) Es una emergencia.

22) Una paciente de 46 años consulta por oligomenorrea, seguida de amenorrea de 4 meses de evolución. Usted sospecha que la paciente está climatérica. ¿Qué examen de sangre le permite determinar esta situación de mejor manera?

- a) Estrógenos plasmáticos
- b) Estrógenos urinarios
- c) Progesterona plasmática
- d) LH plasmática
- e) FSH plasmática

23) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y metformina 850 mg c/8 horas, acude a control, objetivándose varios HGT sobre 200 mg/dl. Trae HbA1C que resulta 8,5%. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento
- b) Aumentar la dosis de metformina
- c) Agregar glibenclamida oral
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- e) Iniciar insulina

24) Un niño de 3 años presenta un IPE: +2DS, IPT: +0DS, ITE: +2DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Eutrofia
- d) Sobrepeso
- e) Obesidad

25) Una paciente de 50 años, diagnosticada de fibrosis pulmonar consulta por fiebre y tos productiva. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, con pulso 87x' regular, presión arterial: 120/80 mmHg, frecuencia respiratoria: 17x', temperatura axilar: 38,5°C y saturación arterial de oxígeno: 94%. Al examen pulmonar se auscultan crépitos bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar amoxicilina oral
- b) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar de forma ambulatoria
- c) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre un macrólido y una cefalosporina de tercera generación
- e) Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre una quinolona y una cefalosporina de tercera generación

26) ¿Cuál de las siguientes indicaciones entregaría a un paciente con litiasis renal por cálculos de oxalato de calcio?

- a) Disminuir la ingesta de agua
- b) Disminuir la ingesta de calcio
- c) Disminuir la ingesta de proteínas de origen animal
- d) Disminuir la ingesta de grasas saturadas
- e) Aumentar la ingesta de pescados (omega 3)

27) Ingresa un paciente con una fibrilación auricular rápida a 150 lpm, desorientado, disneico, sudoroso, con PA: 80/60 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en bolo
- c) Administrar adrenalina 1mg endovenoso
- d) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en infusión continua
- e) Realizar cardioversión eléctrica inmediata

28) Varón de 75 años que acude a la consulta por presentar parálisis facial derecha de lenta instauración. A la exploración se aprecia una tumoración preauricular derecha de 4 cm, de consistencia dura, que según refiere el paciente la tiene desde hace aproximadamente un año. No se palpan adenopatías cervicales, ¿Cómo orientaría el cuadro clínico?:

- a) Tumor maligno de glándula parótida.
- b) Colesteatoma.
- c) Parálisis facial a frigore.
- d) Tumor maligno de glándula submaxilar.
- e) Quiste de retención parotídeo.

29) Una mujer de 44 años, nulípara, con antecedente de hipertensión arterial, presenta metrorragia moderada de 3 días de evolución, que cede espontáneamente. El examen físico, así como la ecografía transvaginal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con indicación de control en caso de recurrencia de los síntomas
- b) Solicitar Papanicolaou
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Solicitar biopsia endometrial

30) Una paciente de 67 años, portadora de una insuficiencia cardíaca crónica, consulta por mayor disnea de la habitual. Se realiza una radiografía de tórax que demuestra un derrame pleural izquierdo moderado, el que se punciona, obteniéndose un líquido amarillo, transparente, con proteínas 2,1 g/dl, LDH: 50 UI/l, células: 130 x mm³, con 85% de mononucleares y 15% de polimorfonucleares. Las proteínas plasmáticas son 6,3 g/dl y la LDH plasmática es 150 UI/l. La conducta más adecuada es

- a) Solicitar pH y lactato del líquido
- b) Manejar la insuficiencia cardíaca
- c) Solicitar biopsias pleurales
- d) Solicitar baciloscopías y adenosindeaminasa (ADA) de líquido pleural
- e) Instalar tubo pleural

31) Un paciente presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, en pocos minutos, sin dolor ni otros síntomas. Al examen se aprecia desaparición del rojo pupilar de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Trombosis de arteria central de la retina
- c) Glaucoma
- d) Desprendimiento de retina
- e) Hemorragia vítrea

32) Un niño de 2 años, cursando infección respiratoria alta, con fiebre hasta 39°C, presenta una convulsión tónico clónica de 3 minutos de duración, autolimitada, recuperándose completamente. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, hidratado, bien perfundido, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. Sólo destaca eritema y congestión faríngea. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos
- b) Iniciar anticonvulsivantes a permanencia y antipiréticos durante nuevos episodios febriles
- c) Solicitar RMN de cerebro y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos y punción lumbar e iniciar antibióticos endovenosos
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle el carácter benigno del episodio, sin necesidad de mayor estudio ni de anticonvulsivantes

33) ¿Qué etiología habría que suponer ante una anemia de 5 gr/dl de Hb, VCM de 125 fl, reticulocitos de 2 por mil (VN: 5 a 20 por mil), LDH 5 veces superior al límite normal e hiperbilirrubinemia no conugada?

- a) Anemia de los trastornos crónicos
- b) Anemia hemolítica
- c) Talasemia
- d) Enfermedad de Wilson
- e) Anemia por carencia de vitamina B12

34) ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un paciente con dolor lumbar?

- a) Inicio agudo
- b) Intensidad 10/10
- c) Irradiación a la extremidad inferior
- d) Aumento de la intensidad con el reposo
- e) Limitación de los movimientos de la columna lumbar

35) Una mujer puérpera hace 7 días presenta dolor y enrojecimiento de la mama derecha. Al examen físico se observa mama eritematosa, indurado, muy dolorosa a la palpación, con una zona fluctuante de 3 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cefadroxilo oral, AINEs y mejorar la técnica de lactancia
- b) Realizar punción y drenaje en box y enviar a domicilio con tratamiento antibiótico con flucloxacilina oral
- c) Hospitalizar, iniciar cefazolina endovenosa, puncionar y aspirar el contenido con jeringa
- d) Hospitalizar, iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje en pabellón
- e) Hospitalizar, administrar vancomicina endovenosa y realizar drenaje en pabellón

36) Un paciente relata con mucha angustia, que siente que algo malo le pasará si sale después de las 8 de la mañana de su casa. Por esto se levanta temprano y sale, aunque no tenga nada que hacer y cuando se retrasa debe quedarse encerrado en su casa, aún cuando tenga compromisos. Refiere tener miedo a estar volviéndose loco. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Agorafobia
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno delirante crónico

37) ¿Cuál de los siguientes exámenes es necesario solicitar a una paciente embarazada en la que se sospecha hipertiroidismo?

- a) T3, T4, TSH
- b) T3, T4 libre y TSH
- c) T4 y TSH
- d) anticuerpos antitiroideos y TSH
- e) anticuerpos antitiroideos y T4 libre

38) ¿Qué método anticonceptivo, entre los mencionados, recomendaría a una paciente dislipidémica?

- a) Anillo vaginal medicado
- b) Anticonceptivos orales en macrodosis
- c) Estrógenos solos orales
- d) Progestágenos solos orales
- e) Progestágenos solos inyectables

39) Un paciente de 50 años presenta mucho miedo a tener un cáncer digestivo, ya que presenta molestias abdominales como distensión y flatulencia. Se realiza un TAC de abdomen y pelvis y una colonoscopia, resultando ambos normales. Sin embargo pide que le realicen más exámenes, ya que cree que padece de alguna enfermedad grave y que no fue detectada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno por somatización
- c) Trastorno por conversión
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

40) Paciente de 55 años, que luego de un accidente de tránsito presenta intenso dolor lumbar, que se irradia por el muslo y pierna derecha. Al examen se aprecia debilidad para extender los ortejos y abducir el muslo de la extremidad inferior derecha. Los reflejos son normales. La raíz nerviosa comprometida es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

41) La disminución del riesgo, que se lograría si se eliminara un factor de riesgo en el grupo de personas expuestas a dicho factor, se denomina:

- a) Riesgo atribuible
- b) Riesgo relativo
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Odds ratio
- e) Likelihood ratio

42) Niño de 2 meses que acude a urgencias por tos intensa. Dos semanas antes había comenzado con congestión respiratoria superior y tos leve, etiquetándose el cuadro por un pediatra como un cuadro catarral. La tos empeoró hasta causar vómitos y episodios de apnea con cianosis. Su madre también ha presentado tos durante varias semanas. Durante el examen físico el niño comenzó a toser, persistiendo ésta durante más de 30 segundos, con jadeo inspiratorio, y cierto grado de cianosis. Después de dejar de toser el niño estaba agotado, con llanto débil. Analíticamente se observó una leucocitosis de 34.000 con un 85% de linfocitos. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro?:

- a) Chlamydia trachomatis.
- b) Adenovirus.
- c) Virus respiratorio sincicial.
- d) Bordetella parapertussis.
- e) Rinovirus.

43) Una paciente de 25 años ha presentado en 4 oportunidades sensación de opresión precordial intensa, de instalación relativamente rápida, asociada a disnea, parestesias, sensación de muerte inminente y palpitaciones. No ha podido identificar un desencadenante claro y tiene mucho miedo de sufrir otro episodio similar y morirse o volverse loca en él. El examen físico, así como el Holter de arritmias es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno por somatización
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

44) Mujer de 25 años que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis simétrica en manos, erupción fotosensible, hipertensión arterial y febrícula. Analítica: hemograma con 3.500 leucocitos/mm³, plaquetas 85.000/mm³, creatinina y transaminasas normales. Anticuerpos antinucleares positivos 1/320, antiDNA nativo positivo e hipocomplementemia. ¿Cuál de las siguientes pruebas aportaría información más relevante para el manejo de este caso?

- a) Radiografía de manos
- b) Determinación de anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado
- c) Determinación de anticuerpos anti Sm.
- d) Sistemático de orina.
- e) Aspirado de médula ósea.

45) El tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, en un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia humana, es:

- a) Cefalosporina de 1ra generación
- b) Cefalosporina de 3ra generación
- c) Metronidazol
- d) Anfotericina B
- e) Sulfametoxazol + trimetoprim

46) Una paciente de 35 años consulta por dolor en los dedos de ambas manos. Refiere que frecuentemente se vuelven blancos y luego cianóticos, especialmente cuando los expone al frío, durando varios minutos en estas condiciones. Además refiere dificultad para tragar, intermitente, que se ha vuelto más frecuente en los últimos días. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Lupus
- d) Artrosis
- e) Artritis reumatoide

47) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de cesárea?

- a) Peso fetal de 4.700 gramos
- b) Condiloma acuminado
- c) Antecedente de conización cervical
- d) Antecedente de una cesárea previa
- e) Multípara de 5 hijos

48) Identifique la asociación CORRECTA:

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzo – Escape de grandes cantidades de orina
- b) Incontinencia urinaria de urgencia – Debilidad del piso pélvico
- c) Incontinencia urinaria de urgencia – Buena respuesta a bloqueadores alfa adrenérgicos
- d) Incontinencia urinaria de esfuerzo – Buena respuesta al tratamiento farmacológico con anticolinérgicos
- e) Fístula vesicovaginal – Goteo continuo de orina

49) Paciente de 51 años que en mamografía de cribado se detecta nódulo espiculado de 8 mm. En cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Biopsia con agua gruesa: carcinoma ductal infiltrante G IL Receptores hormonales positivos. Ki 67 10%, Her 2-neu negativo. Exploración clínica: nódulo no palpable, axila libre, Ecografía axilar: No ganglios sospechosos.

¿Cuál es el tratamiento primario de elección?:

- a) Hormonoterapia primaria.
- b) Quimioterapia neoadyuvante.
- c) Mastectomía y Linfadenectomía axilar.
- d) Tumorectomía y ganglio centinela.
- e) Trastuzumab.

50) ¿Qué situación define una mayor gravedad en un paciente con claudicación intermitente?

- a) Dolor de reposo
- b) Disminución del pulso pedio
- c) Pérdida de fanéreos
- d) Disminución de la sensibilidad vibratoria y termalgésica
- e) Impotencia sexual asociada

51) Un paciente de 35 años presenta dolor abdominal y vómitos. En sus exámenes destaca una elevación importante de la lipasa plasmática. La ecografía abdominal y las pruebas hepáticas son normales. Está en buenas condiciones pero adolorido. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen cero e iniciar analgesia e hidratación endovenosa
- b) Iniciar AINEs y antibióticos de amplio espectro, con régimen hídrico
- c) Indicar régimen cero y solicitar colangiografía retrógrada
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- e) Resolver quirúrgicamente

52) Un paciente de 36 años, sin antecedentes de importancia, trabajador de la construcción, es traído por su familia, ya que él refiere que su mujer lo engaña. La acusa de mantener relaciones con los profesores de su hijo menor, con un diputado y con un carabinero. Explica claramente cómo empezó a engañarlo para molestarlo y humillarlo, sin embargo nunca la ha sorprendido directamente. Contrató un detective privado, sin lograr conseguir pruebas, a lo que él argumenta que ella también lo engañó con dicho detective. La mujer se muestra muy preocupada y niega ser infiel, explicando que desde hace 5 años que su marido está con esas ideas y que en el último tiempo la situación se ha vuelto insostenible. Sus hijos también se muestran preocupados, y creen que su papá se está volviendo loco. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Demencia
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

53) Una paciente de 19 años, cursando un embarazo de 30 semanas, consulta por compromiso del estado general. Al examen físico destaca edema de extremidades inferiores y presión arterial 160/100 mmHg. Se solicita proteinuria cualitativa que resulta +++. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Síndrome de HELLP
- c) Hipertensión arterial crónica esencial
- d) Hipertensión transitoria del embarazo
- e) Hipertensión arterial crónica secundaria

54) Un paciente de 20 años ha presentado hematuria en varias oportunidades. Además refiere infecciones urinarias recurrentes y en sus exámenes de laboratorio se constata elevación de la creatinina plasmática. Al examen físico se palpa una masa abdominal en relación a cada riñón. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor de Wilms
- b) Cáncer de células renales
- c) Hidroureteronefrosis
- d) Cálculos renales coraliformes
- e) Riñón poliquístico

55) Un paciente hospitalizado presenta los siguientes resultados de gases arteriales

pH: 7.04 pO₂: 82 mmHg pCO₂: 38 mmHg HCO₃: 14 mEq/l

Esta situación describe una acidosis:

- a) respiratoria y metabólica
- b) respiratoria con la compensación metabólica esperada
- c) metabólica y alcalosis respiratoria
- d) metabólica con la compensación respiratoria esperada
- e) metabólica no compensada

56) ¿Qué aseveración es correcta?

- a) Las úlceras arteriales suelen ser indoloras
- b) Las úlceras arteriales se caracterizan por ubicarse en el maléolo interno
- c) Las úlceras venosas son un criterio diagnóstico de isquemia crítica crónica de extremidades inferiores
- d) Las úlceras venosas suelen tratarse con antibióticos y curaciones frecuentes
- e) Las úlceras venosas suelen asociarse a hiperpigmentación de la piel circundante

57) Paciente de 7 años de edad que consulta por aumento de tamaño de la bolsa escrotal derecha, siendo derivado a la consulta de Cirugía para descartar hidrocele o hernia inguinal. Es visto en la consulta de Cirugía tres semanas más tarde donde aprecian edema escrotal y de pene, edema palpebral y edema de miembros inferiores siendo remitido a Urgencias. No refiere oliguria. Exploración: FC: 90 l.p.m. T.A.: 105/65 mm Hg. Ta : 36,5°C. Sat O₂ : 98%. Buen estado general, color pálido de piel. Edemas palpebrales bilaterales. Edema con fovea hasta raíz de miembros inferiores. Edema escrotal y peneano. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen distendido, no doloroso, con aparente ascitis sin visceromegalias, ni masas anormales. ORL: normal. Antecedentes personales sin relevancia. Antecedentes familiares: Padre con diabetes insulínica. ¿Cuál sería su primera sospecha diagnóstica?:

- a) Insuficiencia cardíaca.
- b) Síndrome nefrótico.
- c) Glomerulonefritis proliferativa.
- d) Insuficiencia hepática.
- e) Insuficiencia renal.

58) Un hombre de 66 años consulta por astenia, cefalea y fiebre ocasional. Refiere que en ocasiones presenta claudicación mandibular durante la masticación. El examen físico no aporta mayor información y entre sus exámenes trae un hemograma con Hematocrito: 29%, VCM: 90 fl, HCM: 30 pg, blancos: 8.500 x mm³, plaquetas: 380.000 x mm³, VHS: 96 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de Takayasu
- b) Pelviespondilopatía seronegativa
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Lupus
- e) Poliangeítis microscópica

59) Un paciente de 70 años, cardiópata coronario, en CFIII, evoluciona con tos y expectoración mucopurulenta, agregándose disnea de reposo y rápido deterioro del estado general, con síncope y desorientación. Al examen físico se aprecia pálido, con extremidades frías y pulsos débiles. Se constata FC: 120x', PA: 66/31 mmHg, con RR3T y MP+ con crépitos bilaterales, mayor en lavase derecha. El monitoreo electrocardiográfico demuestra taquicardia sinusal. Se instala catéter de Swan-Ganz, obteniéndose PVC: 21 mmHg (VN: 0-8), PAP: 45/22 mmHg (VN: menor a 35) y PCP: 33 mmHg (VN: menor a 18). El diagnóstico más probable es:

- a) Shock cardiogénico
- b) Shock séptico
- c) Shock hipovolémico
- d) Shock anafiláctico
- e) Shock medular

60) Paciente joven, sin patología previa ni adicciones. Luego de un problema familiar grave, presenta bruscamente un episodio psicótico de 2 días, con incoherencias, ideas delirantes y alucinaciones. Sin antecedentes psiquiátricos personales ni familiares. Al término del episodio no se aprecia psicopatología mayor, sólo preocupación importante por lo sufrido, ya que no se lo explica fácilmente.

Se trata de un paciente con:

- a) psicosis esquizomorfa con pronóstico reservado
- b) un episodio psicótico breve que hay que observar ya que es probable que se trate de un trastorno delirante somático de pronóstico incierto
- c) psicosis reactiva breve de mal pronóstico, ya que ha presentado alteración del pensamiento en su contenido y en su forma
- d) psicosis reactiva breve de buen pronóstico
- e) un episodio psicótico alucinatorio delirante que debe ser controlado por tiempo prolongado

61) El síntoma más característico de la otitis media con efusión es:

- a) Hipoacusia
- b) Otagia
- c) Otorrea
- d) Fiebre
- e) Vértigo

62) Ante un paciente de 6 años que acude a urgencias tras haber sufrido una caída fortuita desde un columpio, presentando intenso dolor, deformidad e impotencia funcional en el codo izquierdo, deberemos sospechar en primer lugar:

- a) Fractura de cubito y radio con luxación de cabeza radial.
- b) Fractura-luxación de la cabeza radial.
- c) Fractura del olécranon y luxación de cabeza radial.
- d) Fractura supracondílea del codo.
- e) Fractura-epifisiolisis de epitróclea.

63) En los niños, la complicación más frecuente de la varicela es:

- a) Cerebelitis postvaricela
- b) Neumonía varicelatos
- c) Hepatitis viral
- d) Sobreinfección de las lesiones por bacterias Gram positivas
- e) Síndrome de Reye

64) Una paciente de 27 años sufre caída sobre hombro derecho, resultando en luxación anterior de dicha articulación, la que se reduce bajo analgesia profunda. Evoluciona con imposibilidad para abducir el hombro y en el examen físico destaca hipoestesia de la zona deltoidea. ¿Qué estructura resultó dañada con mayor probabilidad?

- a) Nervio mediano
- b) Nervio radial
- c) Nervio cubital
- d) Nervio axilar
- e) Nervio musculocutáneo

65) Un niño de 7 años consulta por malestar general, fiebre hasta 38,7°C, artralgias y aparición de un exantema macular rosado, generalizado. Al examen físico se ve de buen aspecto y se palpan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. El cuadro clínico corresponde a:

- a) Rubeola
- b) Sarampión
- c) Quinta enfermedad
- d) Escarlatina
- e) Exantema súbito

66) Hombre de 70 años, consulta por palidez y astenia de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones generales, pálido, eupneico, con presión arterial y frecuencia cardíaca normales. El examen segmentario resulta normal. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 27%, Hb: 8,9 mg/dl, VCM: 67, HCM: 23, Blancos: 6.200, plaquetas: 155.000. El perfil de hierro demuestra ferremia baja, transferrina elevada, con bajo índice de saturación y ferritina muy disminuida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sulfato ferroso oral, sin necesidad de realizar más exámenes
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta e iniciar hierro oral
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Realizar transfusiones periódicas de glóbulos rojos
- e) Realizar transfusión de glóbulos rojos, de manera urgente y luego iniciar hierro oral

67) ¿Cuál de los siguientes hemogramas es más característico de una leucemia linfocítica crónica?

- a) Hematocrito: 30%, plaquetas: 140.000 x mm³, blancos: 29.000 x mm³, 90% linfocitos, 8% segmentados, 2% monocitos
- b) Hematocrito: 45%, plaquetas: 460.000 x mm³, blancos: 35.000 x mm³, 10% linfocitos, 60% segmentados, 20% baciliformes, 5% mielocitos, 3% blastos, 2% monocitos
- c) Hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000 x mm³, blancos: 2.000 x mm³, 80% linfocitos, 20% segmentados
- d) Hematocrito: 35%, plaquetas: 100.000 x mm³, blancos: 18.000 x mm³, 50% linfocitos, 25% segmentados, 25% monocitos
- e) Hematocrito: 40%, plaquetas: 240.000 x mm³, blancos: 16.000 x mm³, 80% linfocitos, 15% segmentados, 5% monocitos

68) Un paciente presenta ojo rojo, asociado a marcada fotofobia. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático y blefarospasmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratitis aguda
- b) Uveítis aguda
- c) Escleritis
- d) Epiescleritis
- e) Glaucoma agudo

69) Respecto a los estudios epidemiológicos de cohorte es cierto que:

- a) Se utiliza la Odds Ratio como medida fundamental de asociación.
- b) Se denominan también estudios de prevalencia.
- c) El grupo de comparación se constituye con los sujetos no expuestos al factor de riesgo en estudio.
- d) Estudian las características de una muestra de sujetos en un momento dado, en el que se recogen todos los datos.
- e) Si existen pérdidas en el seguimiento de los sujetos, el estudio no puede analizarse.

70) Una paciente se realiza un RBNE que resulta no reactivo, por lo que se decide realizar un test de tolerancia a las contracciones, que muestra FCF: 140 x', con variabilidad normal y presencia de desaceleraciones precoces, en espejo con las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar prueba de parto
- c) Solicitar ecografía-Doppler de arterias umbilicales
- d) Solicitar perfil biofísico
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

71) Un niño de 5 años llora y grita cuando se lo lleva al jardín infantil, siendo difícil de consolar por parte de su parvularia. La madre también se muestra muy ansiosa con ese problema. El diagnóstico es:

- a) Depresión infantil
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Normal
- d) Trastorno de ansiedad por separación
- e) Maltrato infantil

72) ¿Qué debe sospechar usted ante un paciente al que en bipedestación se le ausculta un soplo sistólico, que aumenta con la maniobra de Valsalva y que casi desaparece al auscultarlo en cuclillas?:

- a) Fístula aorto-pulmonar.
- b) Comunicación interauricular.
- c) Miocardiopatía hipertrófica.
- d) Estenosis pulmonar.
- e) Insuficiencia mitral reumática.

73) Una niña de 4 años, que asiste a Jardín Infantil, acude a control de niño sano. La madre refiere que ha presentado tres episodios de otitis media aguda supurada bilateral en los últimos dos años, el último hace dos meses. Su examen físico es normal.

La conducta más adecuada es:

- a) Azitromicina 20 mg/kg/día por 6 días en el siguiente episodio.
- b) Amoxicilina 75-100 mg/kg/día por siete días en el siguiente episodio.
- c) derivar a especialista para estudio por otitis media aguda recidivante.
- d) derivar a especialista por riesgo de hipoacusia sensorineural.
- e) realizar estudio de anticuerpos anti-neumococo.

74) Un recién nacido, con antecedente de una bradicardia sostenida durante el trabajo de parto, nacido por cesárea de urgencia, presenta apgar 2 al minuto. Se inicia estimulación y se aporta oxígeno, reevaluándose a los 30 segundos, sin lograr mejoría y constatándose FC: 50 lpm. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar masaje cardíaco
- b) Iniciar ventilación a presión positiva
- c) Realizar intubación orotraqueal
- d) Administrar atropina endovenosa
- e) Administrar adrenalina endovenosa

75) Una paciente consulta por dismenorrea severa, que inició hace 6 meses y que ha ido en aumento. Se solicita una ecografía transvaginal que visualiza un tumor ovárico izquierdo, de 5 cm de diámetro, quístico, con contenido líquido, homogéneo, denso. El Ca-125 resulta el doble de lo normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Teratoma quístico benigno
- b) Cistoadenoma seroso
- c) Cistoadenocarcinoma
- d) Quiste folicular
- e) Endometrioma

76) Una paciente de 65 años presenta un cuadro de dolor abdominal, fiebre alta e ictericia de piel y mucosas de algunas horas de evolución. Al examen físico está taquicárdica, con PA: 100/60 mmHg. La ecografía muestra dilatación biliar intra y extrahepática. Se instala una vía venosa, se toman exámenes generales y se inicia administración de suero fisiológico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y realizar colecistectomía laparoscópica
- b) Iniciar antibióticos orales de amplio espectro e indicar régimen hídrico amplio
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro y realizar drenaje de la vía biliar por vía endoscópica
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso
- e) Indicar régimen cero e iniciar AINES

77) Una mujer de 39 años, cursando un embarazo de 8 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. Se solicitan niveles plasmáticos de beta-HCG, que resultan 1.000 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparoscopia
- b) Administrar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y nuevos niveles plasmáticos de beta-HCG en 2 días
- d) Solicitar nueva ecografía y nuevos niveles plasmáticos de beta-HCG en 7 días
- e) Observar evolución, indicando controles obstétricos habituales

78) Mujer de 47 años sin antecedentes psiquiátricos que es hospitalizada para estudio de metrorragias y a los 5 días de su ingreso es informada del diagnóstico de neoplasia uterina con metástasis. Se consulta a Psiquiatría porque 24 horas después muestra tristeza y llanto frecuente, refiere ideas de muerte y presenta insomnio. En la evaluación psiquiátrica no se recoge ningún antecedente psiquiátrico y la exploración detecta elevada ansiedad y desesperanza en relación con las consecuencias de su enfermedad neoplásica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno esquizoafectivo.
- b) Distimia.
- c) Trastorno de ansiedad generalizada.
- d) Trastorno por estrés postraumático.
- e) Reacción normal frente al estrés.

79) Una embarazada de 30 semanas de gestación consulta por malestar general y fiebre hasta 39°C. Al examen físico se constata taquicardia, sensibilidad a la palpación uterina y escasa leucorrea que proviene del orificio cervical externo. Se auscultan los latidos cardíacos fetales a 175 x'. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia sin necesidad de antibióticos maternos
- b) Realizar amniocentesis
- c) Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica
- d) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- e) Iniciar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo al alcanzar la madurez pulmonar

80) Un recién nacido de 3 días de vida presenta múltiples equimosis generalizadas, sin otros hallazgos. La madre refiere que no ha sufrido traumatismos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar biopsia de médula ósea
- c) Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas y pruebas de coagulación
- d) Realizar transfusión de plasma fresco congelado
- e) Iniciar corticoides sistémicos

81) ¿Cuál es la etiología más frecuente en un lactante que presenta fiebre, deposiciones líquidas con sangre y pujo rectal?

- a) Rotavirus
- b) Shigella sp.
- c) Giardia lamblia
- d) Entamoeba histolytica
- e) Escherichia coli enterohemorrágica

82) Se prueba la tolerabilidad de un nuevo fármaco, comparada con placebo y se aprecia que el 1% de los pacientes que reciben el fármaco presentan algún efecto adverso, mientras que sólo el 0,75% de quienes reciben el placebo los presentan. Calcule el NNH (número needed to harm).

- a) 40
- b) 75
- c) 100
- d) 133
- e) 400

83) Son contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, EXCEPTO:

- a) Metrorragia de origen no precisado
- b) Cáncer de endometrio
- c) Cáncer de mama
- d) Antecedentes personales de tromboembolismo pulmonar
- e) Diabetes mellitus

84) Un paciente consulta por astenia, debilidad muscular, náuseas e hiperpigmentación de la cara. En sus exámenes generales además se observa hiponatremia e hiperkalemia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- b) Solicitar ACTH basal y post-dexametasona
- c) Solicitar cortisol basal y post-dexametasona
- d) Solicitar ACTH y cortisol basales
- e) Solicitar cortisol basal y post-ACTH

85) El tratamiento de elección del delirium tremens es:

- a) Haldol
- b) Diazepam
- c) Etanol
- d) Risperidona
- e) Clorpromazina

86) Usted cuenta con la siguiente información:

Población total: 1.000 habitantes, muertes totales: 14, muertes por influenza: 2, casos de influenza: 140

Calcule la tasa de letalidad de la influenza

- a) 140/1.000
- b) 14/1.000
- c) 2/1.000
- d) 2/140
- e) 2/14

87) Una mujer de 21 años presenta pésimas relaciones familiares con sus padres y con su hermano. Pelean frecuentemente y ella incluso ha llegado a agredir a su madre. Además presenta una relación muy intensa e inestable con su novio, con quien ha terminado y vuelto en reiteradas ocasiones. En 2 oportunidades ha intentado suicidarse, la última de ellas con ingestión de benzodicepinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Depresión psicótica
- c) Esquizofrenia hebefrénica
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno de personalidad límite

88) Un paciente de 67 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de carácter urente, que apareció hace 3 meses y que se ha vuelto cada vez más frecuente y más intenso. Al examen físico se aprecia atrofia muscular de cuádriceps y gastrocnemios, sin alteraciones en la sensibilidad. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINES y aumentar la dosis de metformina
- b) Agregar glibenclamida e iniciar gabapentina
- c) Iniciar insulino terapia y un anitidepresivo tricíclico
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral e iniciar carbamacepina
- e) Indicar paracetamol en caso de dolor, manteniendo la dosis de metformina

89) Un paciente presenta dolor epigástrico urente, irradiado al tórax, que aparece frecuentemente, especialmente luego de comer. Se solicita endoscopia digestiva alta que muestra una esofagitis distal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar pH-metría
- c) Solicitar videodeglución
- d) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol
- e) Erradicar H. pylori

90) Un señor de 60 años, empleado de comercio, acude a urgencias acompañado de su familia; éstos cuentan que el día anterior, de forma bastante brusca, comenzó a decir cosas raras, a no responder a lo que le preguntaban y a mostrarse confuso incluso respecto de su propio nombre. Efectivamente en la exploración parece no entender lo que se le pregunta, no recuerda nada de lo que le ha pasado y no sabe ni el día, ni el lugar en el que está. El diagnóstico sería:

- a) Psicosis breve.
- b) Delirium.
- c) Alzheimer.
- d) Esquizofrenia.
- e) Trastorno de ansiedad.

Respuestas:

PRIMERA PARTE	
Preguntas	Respuestas
1	B
2	B
3	B
4	E
5	C
6	E
7	D
8	C
9	D
10	C

11	B
12	E
13	E
14	D
15	E
16	A
17	C
18	A
19	D
20	D
21	A
22	C
23	C
24	B
25	D
26	C
27	E
28	D
29	C
30	C
31	E
32	E
33	E
34	D
35	E
36	A
37	B
38	E
39	C
40	D
41	A

42	D
43	C
44	E
45	A
46	B
47	D
48	A
49	E
50	A
51	A
52	B
53	E
54	A
55	C
56	A
57	B
58	B
59	A
60	E
61	B
62	E
63	C
64	C
65	A
66	A
67	B
68	B
69	C
70	E
71	C
72	C

73	B
74	D
75	C
76	B
77	C
78	D
79	D
80	A
81	A
82	B
83	C
84	A
85	E
86	E
87	C
88	D
89	C
90	E

Ensayo EUNACOM – Prueba 9

PRIMERA PARTE

1) La mejor estrategia de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino es:

- a) Histerectomía precoz en el cáncer de cuello uterino
- b) Resección de la neoplasias intraepiteliales
- c) Vacunación contra el virus papiloma humano
- d) Técnicas de detección de virus papiloma humano
- e) PAP seriado

2) Usted recibe a una mujer de 59 años, que consulta por metrorragia. Su última regla fue a los 50 años y nunca utilizó anticonceptivos orales. Al examen físico está en buenas condiciones, presenta IMC: 35, presión arterial 150/100 mmHg y al tacto vaginal se constata un útero de tamaño aumentado, sin alteraciones anexas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Atrofia endometrial
- b) Cáncer de endometrio
- c) Adenomiosis
- d) Endometriosis
- e) Miomatosis

3) Una mujer de 34 años, dueña de casa, sufre la partida al extranjero de su única hija, con la que compartía mucho tiempo. Evolucionando con ánimo bajo y ansiedad, con preocupaciones del estado de salud y económico de su hija. Refiere que se siente algo sola y ha dejado de ir al gimnasio, a pesar de que antes iba de manera muy constante. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión mayor
- b) Trastorno de adaptación
- c) Trastorno de ansiedad generalizada
- d) Duelo patológico
- e) Trastorno disociativo

4) Un paciente con historia de constipación crónica, presenta dolor anal muy intenso al defecar, con sangrado, que persiste por cerca de 2 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de hemorroides internos
- b) Trombosis de hemorroides externos
- c) Fluxión hemorroidal
- d) Absceso perianal
- e) Fisura anal aguda

5) Un paciente de 50 años presenta lumbago mecánico, intenso, con irradiación del dolor por la cara posterior de la extremidad inferior izquierda, recorriendo el muslo, la pierna, hasta el pie. El diagnóstico más probable es:

- a) Espondilosis
- b) Artrosis facetaria
- c) Cáncer
- d) Hernia del núcleo pulposo
- e) Raquiestenosis

6) Un paciente de 60 años presenta disminución del calibre del chorro miccional, asociado a disuria de esfuerzo y goteo terminal, que iniciaron hace 6 meses y que han ido progresando lentamente. Refiere que en los últimos días presenta además nicturia de 2 veces. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección urinaria baja
- b) Urolitiasis
- c) Adenoma prostático
- d) Cáncer de próstata
- e) Estenosis uretral

7) Una mujer de 30 años, asmática desde niña, en tratamiento con salbutamol e ipratropio inhalados, consulta porque presenta con cierta frecuencia tos y respiración sibilante, especialmente cuando realiza actividad física y en la noche, que le dificultan el normal dormir. Al examen físico muestra aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias espiratorias. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar corticoides inhalados
- b) Agregar aminofilina
- c) Agregar betaagonistas de acción larga
- d) Agregar inhibidores de los leucotrienos
- e) Solicitar espirometría

8) Un paciente de 64 años sufre un accidente con una rama de árbol, la que le golpea directamente el ojo abierto. Inicialmente presenta dolor, que al día siguiente se hace más intenso, observándose ojo rojo profundo y una lesión blanquecina de 4 mm de diámetro en la córnea. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera corneal
- b) Endoftalmitis
- c) Uveítis
- d) Glaucoma agudo
- e) Conjuntivitis aguda

9) Un paciente diabético de 60 años, en tratamiento con metformina 850 mg al día y dieta, la que cumple con cierta rigurosidad. Acude a control con varios hemoglucotest sobre 150 mg/dl, con HbA1c de 7,4%. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de metformina
- b) Agregar glibenclamida
- c) Agregar insulina NPH
- d) Suspender la metformina e iniciar insulina en esquema intensificado
- e) Mantener el tratamiento

10) Un hombre de 69 años, con historia de infecciones urinarias a repetición, consulta por dolor lumbar intenso, de algunos días de evolución, que se irradia al glúteo derecho. Presenta fiebre hasta 38,8°C y dolor al flexionar la columna lumbar. Actualmente no presenta síntomas urinarios, el signo de Lasegue resulta negativo, al igual que la puño percusión. Se solicita hemograma, que muestra marcada elevación de la VHS, llegando a 98 mm/h, la PCR es 80 mg/l y el urocultivo resulta polimicrobiano. El diagnóstico más probable es:

- a) Prostatitis aguda
- b) Cáncer de próstata
- c) Pielonefritis aguda
- d) Espondilodiscitis
- e) Espondilitis anquilosante

11) Una mujer de 30 años presenta un cuadro de dismenorrea de un año de evolución. Se solicita una ecografía que muestra una lesión quística, con contenido en vidrio esmerilado. El Ca-125 resulta 127 UI/l (VN: menor a 35 UI/l). El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Quiste folicular
- c) Cuerpo lúteo
- d) Teratoma
- e) Endometrioma

12) ¿Qué medicamento es útil para el manejo inicial de la enfermedad de Alzheimer?

- a) Agonistas dopaminérgicos
- b) Antagonistas dopaminérgicos
- c) Anfetaminas
- d) Inhibidores de la acetilcolinesterasa
- e) Anticolinérgicos

13) ¿Qué diagnóstico se debe sospechar ante un lactante de 6 meses de edad que ha presentado múltiples episodios de conjuntivitis aguda izquierda?

- a) Déficit de IgA
- b) Dacriocistitis
- c) Dacrioadenitis
- d) Obstrucción de la vía lagrimal
- e) Glaucoma congénito

14) Una mujer está obsesionada con sus dientes, los que considera horribles y deformes, razón por la cual ha acudido a numerosos dentistas, el último de los cuales la derivó a salud mental, razón por la cual está muy molesta. Al confrontarla, dice que podría estar equivocada, pero que no puede evitar tener esas ideas acerca de sus dientes. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno dismórfico corporal
- d) Trastorno somatomorfo
- e) Trastorno delirante crónico

15) Una mujer de 48 años, presenta hipermenorrea, sin otros síntomas. Al examen ginecológico se aprecia un útero aumentado de tamaño, de consistencia nodular. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Miomatosis
- c) Adenomiosis
- d) Hiperplasia endometrial
- e) Cáncer de endometrio

16) Una multipara, cursando un embarazo de término inicia trabajo de parto. Al ser evaluada presenta feto en cefálica, con 6 cm de dilatación cervical, en buenas condiciones, con dinámica uterina de 4 CU cada 10 minutos. A los 15 minutos rompe las membranas, produciéndose bradicardia fetal de 70x'. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un tacto vaginal
- b) Realizar cesárea de urgencia
- c) Lateralizar
- d) Hidratar
- e) Administrar tocolíticos

17) Una mujer de 34 años presenta obesidad de disposición troncular y facial, con atrofia muscular, presencia de estrías abdominales oscuras, de color violáceo e hipertensión arterial. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Solicitar cortisol plasmático matinal
- b) Solicitar cortisol y ACTH basales
- c) Solicitar cortisol basal y post-ACTH
- d) Solicitar cortisol libre en orina, de 24 horas
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

18) Un paciente de 80 años, con antecedente de problemas de memoria de menos de una año de evolución, presenta un cuadro de desorientación temporoespacial de un día de evolución, en el que no reconoce su casa ni a sus familiares, presentando además alucinaciones de fantasmas y animales que rondan a su alrededor. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Demencia frontotemporal
- d) Esquizofrenia tardía
- e) Delirium

19) Un paciente de 60 años, hipertenso, aqueja disnea de grandes esfuerzos. AL examen físico presenta PA: 150/98 mmHg, con FC: 85 x', con auscultación de crepitaciones escasas en ambas bases, sin signos de cardiomegalia ni soplos. Se solicita ecografía que muestra hipertrofia moderada del ventrículo izquierdo, asociado a una disfunción sistólica moderada, con FE: 49%. La conducta más adecuada para mejorar el pronóstico de este paciente es iniciar:

- a) Digoxina y diuréticos
- b) ARAII y diuréticos
- c) iECA y betabloqueantes
- d) iECA y espironolactona
- e) Aspirina y TACO

20) Un paciente de 59 años, diagnosticado de cirrosis hepática, por consumo excesivo de alcohol, presenta hematemesis abundante, seguida de ortostatismo. Ingresó taquicárdico, e hipotenso. Luego de estabilizar la hemodinamia del paciente se debe proceder a:

- a) Iniciar betabloqueantes
- b) Iniciar omeprazol
- c) Instalar un TIPS
- d) Realizar una endoscopia digestiva alta
- e) Instalar un balón gastroesofágico

21) Un recién nacido de 21 días de vida, presenta estridor inspiratorio intenso. Al examen está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis obstructiva
- b) Bronquiolitis
- c) Laringomalacia
- d) Membrana laríngea
- e) Fístula traqueoesofágica

22) Un paciente de 60 años acude al servicio de urgencia de una zona rural, debido a un cuadro de dolor precordial opresivo, intenso, irradiado a la mandíbula, de 2 horas de evolución. Se solicita electrocardiograma, que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DII, DIII y AVF. El centro en el que está no cuenta con centro de angioplastia, sin embargo usted sabe que a 2 horas hay un centro que sí cuenta con angioplastia y además tiene disponibilidad de ambulancia. La conducta más adecuada es:

- a) Trombolizar inmediatamente al paciente con estreptoquinasa
- b) Derivar al paciente al centro de mayor complejidad, para realizar angioplastia
- c) Iniciar anticoagulación con heparina
- d) Realizar tratamiento médico conservador, con aspirina y nitroglicerina
- e) Solicitar troponinas y decidir conducta en base a los resultados

23) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 8 semanas se realiza una ecografía transvaginal que muestra un embarazo intrauterino de edad gestacional acorde, con visualización de un tumor anexial sólido-quístico de 5 cm de diámetro, con alto flujo sanguíneo en el doppler. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo gemelar con el segundo gemelo de implantación ectópica
- b) Embarazo molar
- c) Mioma con degeneración roja
- d) Saco vitelino
- e) Cuerpo lúteo

24) Una mujer obesa presenta parestesias en la mano derecha, que se extienden por los 4 primeros dedos, respetando la cara lateral del 4º dedo y el 5º dedo por completo. Los síntomas son más intensos en la noche y se asocian a debilidad para la prensión de los 3 primeros dedos. El diagnóstico más probable es:

- a) Atrapamiento cubital
- b) Síndrome del túnel carpiano
- c) Síndrome del opérculo torácico
- d) Estenosis de la arteria braquial
- e) Cervicobraquialgia mecánica

25) Un recién nacido de término, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria luego de nacer, que responde a oxígeno a bajas concentraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra engrosamiento de las cisuras pulmonares. El diagnóstico es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Quilotórax
- c) Neumonía
- d) Taquipnea transitoria
- e) Aspiración meconial

26) Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico que muestra colesterol total: 250 mg/dl, HDL: 31 mg/dl, LDL: 107 mg/dl, Triglicéridos: 560 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar una estatina
- b) Iniciar un fibrato
- c) Iniciar una asociación entre un fibrato y una estatina
- d) Iniciar niacina
- e) Indicar dieta baja en grasas e hidratos de carbono, sin necesidad de iniciar hipolipemiantes

27) Un hombre de 70 años presenta incontinencia urinaria, con poliaquiuria, un ritmo miccional muy frecuente, con 10 micciones durante el día y 5 durante la noche. Ha presentado varios episodios de infecciones urinarias y al examen físico destaca temblor de reposo de las extremidades superiores, que desaparece cuando realiza movimientos. ¿Cuál es la causa de la incontinencia urinaria?

- a) De esfuerzos
- b) Vejiga inestable
- c) Funcional
- d) Por rebalse
- e) Prostatismo

28) El mejor indicador para un estudio en el que se evalúa la aparición de efectos adversos a un neuroléptico es:

- a) Tasa de prevalencia de efectos adversos
- b) Tasa de incidencia de efectos adversos
- c) Porcentaje de efectos adversos
- d) Porcentaje de pacientes sin efectos adversos
- e) Razón de efectos adversos

29) ¿Cuál es la causa más probable de amenorrea, una vez descartado el embarazo?

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Hiperprolactinemia
- c) Hipotiroidismo
- d) Hipogonadismo
- e) Falla uterina

30) Un paciente con sobrepeso se realiza un test de tolerancia a la glucosa que muestra glicemia basal: 100 mg/dl y glicemia post 75 gr de glucosa: 138 mg/dl. El diagnóstico es:

- a) Normal
- b) Diabetes mellitus 1
- c) Diabetes mellitus 2
- d) Intolerancia a la glucosa
- e) Prediabetes

31) Una mujer de 30 años presenta desde hace 2 días artralgias generalizadas, con aparición de un exantema que compromete la cara, tronco y extremidades, asociado a hematuria en varias ocasiones y parestesias en las 4 extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura de Shoenlein Henoch
- b) Vasculitis sistémica
- c) Púrpura trombocitoénico inmune
- d) Dermatomiositis
- e) Lupus eritematoso sistémico

32) Un paciente de 56 años, sin cambios de hábito en la dieta, presenta constipación desde hace 6 meses. No ha tenido melena, ni baja de peso, ni alteración alguna. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Aumentar la ingesta de agua y fibra
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitar test de sangre oculta en las deposiciones

33) Un paciente de 60 años, con un cuadro de 2 semanas de tos y dolor torácico con tope inspiratorio, se realiza una radiografía de tórax que demuestra un exudado pleural izquierdo, de tamaño moderado. Se realiza punción y se obtiene un líquido pleural con LDH: 250 UI/l, proteínas: 5,8 g/dl, 800 células por mm³, con 90% de mononucleares, ADA: 60 UI/l y glucosa de 30 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame pleural secundario a cáncer
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Tuberculosis
- e) Transudado pleural

34) Un niño de 5 años tomó 10 pastillas de imipramina hace 2 horas. Actualmente está en perfectas condiciones, con el estado hemodinámico estable, sin compromiso de conciencia, ni otras alteraciones. Además de monitorizar con un ECG, ¿qué alternativa es MÁS aconsejable?

- a) Hidratar con suero fisiológico
- b) Realizar lavado gástrico
- c) Administrar carbón activado
- d) Indicar jarabe de Ipeca
- e) Administrar N-acetyl-cisteína

35) Una mujer adicta a la cocaína es ingresada por un cuadro de agitación psicomotora, el que debe ser manejado con administración de Haldol intramuscular. Al día siguiente presenta contractura permanente del cuello hacia la derecha, con desviación de la mirada. El diagnóstico más probable es:

- a) Crisis epiléptica
- b) Disquinesia tardía
- c) Distonía aguda
- d) Acatisia
- e) Atetosis

36) Un paciente de 60 años, agricultor, consulta por una lesión en el ala nasal izquierda, eritematosa, con telangiectasias y bordes solewantados, brillantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Rosácea
- b) Granuloma telangiectásico
- c) Carcinoma basocelular
- d) Queratosis seborreica
- e) Queratosis actínica

37) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 7 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que ve un embrión de 3 mm de longitud, sin latidos cardiorfetales. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el trabajo de aborto con misoprostol intravaginal
- b) Realizar legrado uterino
- c) Administrar metotrexato
- d) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- e) Repetir la ecografía en 10 días

38) Una mujer de 26 años, con antecedente de una neumonía adquirida en la comunidad hace un mes, tratada exitosamente con amoxicilina, consulta por un cuadro de diarrea de 2 semanas de evolución, acuosa, asociada a dolor abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea por clostridium difficile
- b) Enfermedad inflamatoria intestinal
- c) Colitis viral
- d) Colitis bacteriana por E. coli
- e) Colitis parasitaria

39) Una paciente de 36 años, diabética gestacional, en tratamiento con dieta, ingresa a las 36 semanas + 4 días de edad gestacional, con síntomas de trabajo de parto. Se aprecia feto en presentación cefálica, con cuello uterino con 60% de borramiento, y un centímetro de dilatación, asociado a contracciones uterinas de 3 cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Iniciar tocolisis con nifedipino
- c) Iniciar tocolisis con fenoterol
- d) Administrar corticoides a la madre
- e) Iniciar goteo oitócico

40) En un consultorio, normalmente se atienden 80 pacientes desde las 17:00 a las 24:00 horas. Si la demanda aumenta en un 50% y se sabe que el rendimiento de los médicos es de 10 pacientes por hora, ¿Cuántas horas médicas diarias adicionales se deben contratar?

- a) 3,5
- b) 4,0
- c) 6,5
- d) 7,0
- e) 11,4

41) Un adolescente presenta amigdalitis con exudado blanco amigdalino bilateral y fiebre alta. Al examen físico presenta además múltiples adenopatías cervicales, con compromiso de las cadenas linfáticas anteriores y también posteriores. Se solicita hemograma que muestra Hcto: 38%, plaquetas: 180.000 por mm³, blancos: 18.000, con 90% linfocitos, 6% de monocitos y 4% de neutrófilos. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Infección por citomegalovirus
- c) Faringoamigdalitis estreptocócica
- d) Infección por virus herpes simplex
- e) Leucemia aguda

42) El tratamiento del hematoma traumático del pabellón auricular es:

- a) Punción
- b) Observación
- c) Drenaje por incisión y vendaje compresivo
- d) Antibióticos y analgésicos orales
- e) Compresión externa

43) Un hombre de 60 años se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de una hematuria monosintomática, en la que se identifica un tumor renal izquierdo de 3 cm de diámetro, de consistencia sólida. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Realizar nefrectomía parcial
- c) Realizar nefroureterectomía
- d) Observar evolución, realizando seguimiento ecográfico de la lesión
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste

44) Se observa que la tasa de incidencia de una patología es de 7 x 100.000 en los sujetos expuestos a un factor de riesgo y es de 5 x 100.000 en los sujetos no expuestos. Calcule el riesgo atribuible:

- a) 0,71
- b) 1,4
- c) 12 por 100.000
- d) 2 por 100.000
- e) 75%

45) ¿Cuál de las siguientes alteraciones tiene mayor riesgo de desarrollar ambliopía?

- a) Catarata congénita bilateral
- b) Estrabismo
- c) Neuritis óptica
- d) Atresia del conducto lagrimal
- e) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis

46) Una mujer de 20 años presenta “pánico” a hablar en público, al punto que no es capaz de hacer discursos ni exposiciones ante sus compañeros de universidad. Al preguntarle, refiere que no tiene problemas de hacerlo frente a sus familiares y amigos más cercanos. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica situacional
- b) Agorafobia
- c) Fobia social
- d) Trastorno de angustia
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

47) Una mujer presenta flujo genital aumentado, de mal olor, sin prurito. A la especuloscopia se aprecia leucorrea blanquecina, espumosa, maloliente. El agente causal más probable es:

- a) Gardnerella vaginalis
- b) Candida albicans
- c) Trichomona vaginalis
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Chlamydia trachomatis

48) Una niña de 7 años consulta por talla baja. Se revisa su curva de crecimiento y se constata que su talla corresponde al percentil 3 para la edad y que ha venido creciendo en el mismo carril, desde los 3 años. La edad ósea es equivalente a 7 años. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Turner
- b) Talla baja familiar
- c) Retraso constitucional del crecimiento
- d) Enfermedad celíaca
- e) Pubertad precoz

49) Una mujer de 55 años, con antecedente de amigdalitis a repetición en la infancia, presenta desde hace algún tiempo disnea de esfuerzo que ha ido en aumento y que en ocasiones se acompaña de tos y hemoptisis. Al examen físico destacan crépitos bibasales y la auscultación de un soplo cardíaco. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Estenosis mitral cerrada
- c) Estenosis aórtica
- d) Tuberculosis
- e) Endocarditis bacteriana

50) Un paciente de 68 años, gastrectomizado por un cáncer gástrico incipiente, presenta astenia y palidez. El examen físico no aporta mayor información y se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito: 26%, Hb: 8,9 g/dl, VCM: 112 fl, Plaquetas: 80.000 por mm³, Blancos: 3.900 por mm³. Además cuenta con LDH: 1.060 UI/l. ¿Qué examen debe solicitar para determinar la etiología de la anemia?

- a) Biopsia de medula ósea
- b) Mielograma
- c) Perfil de hierro
- d) Niveles plasmáticos de vitamina B12
- e) Prueba de Coombs directo

51) Una mujer joven, con IMC normal, asintomática, en un control de salud se pesquiza una glicemia de ayuno de 220 mg/dl. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemoglobina glicosilada
- b) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- c) Repetir la glicemia de ayuno
- d) Iniciar metformina más cambios en la dieta y actividad física
- e) Iniciar cambios en la dieta y actividad física

52) Un recién nacido, previamente asintomático, empieza a los 10 días de vida con dificultad para alimentarse. Al examen físico destaca un soplo cardíaco sistólico 3/6, con hepatomegalia, llene capilar disminuido en los pies y pulsos femorales ausentes. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interventricular
- b) Coartación aórtica
- c) Comunicación interauricular
- d) Transposición de grandes vasos
- e) Tetralogía de Fallot

53) Un niño de 9 años presenta parestesias en las piernas, que en 10 días van progresando, acompañándose de debilidad, hasta comprometer la mecánica ventilatoria. Al examen físico destaca hiporreflexia generalizada. El diagnóstico es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Tétanos
- c) Botulismo
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Miastenia gravis

54) Una paciente de 28 años presenta una mácula en el tórax, de color rosado y 5 cm de diámetro, con collarete solevantado. Algunos días después aparecen múltiples lesiones similares, pero de menor tamaño distribuidas por todo el tronco. El diagnóstico más probable es:

- a) Pityriasis versicolor
- b) Pityriasis rosada
- c) Tiña corporis
- d) Psoriasis
- e) Exantema viral

55) Una mujer de 29 años presenta placas eritematosas, en la cara, de hasta 2 cm de diámetro, con descamación blanquecina, adherente, que suelen aparecer y exacerbarse luego de exponerse al sol. El diagnóstico más probable es:

- a) Rosácea
- b) Lupus cutáneo subagudo
- c) Psoriasis
- d) Dermatitis seborreica
- e) Reacción fotoalérgica

56) Un paciente de 69 años, hipertenso y diabético, sin hábito tabáquico ni alcohólico, presenta dolor abdominal de larga data, que se intensifica al comer, apareciendo a los pocos minutos tras la ingesta. Además refiere diarrea ocasional. Al examen físico se aprecia abdomen blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéreos conservados y sin presencia de soplos. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina mesentérica
- b) Cáncer de colon
- c) Cáncer gástrico
- d) Pancreatitis crónica
- e) Síndrome de intestino irritable

57) Un lactante de 11 meses de edad presenta fiebre hasta 38,9°C. La madre refiere que desde hace una semana no ha gateado y al examen se aprecia que llora al movilizarle la cadera. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Enfermedad de Perthes
- c) Artritis séptica
- d) Osteomielitis aguda
- e) Leucemia aguda

58) Un paciente de 30 años sufre un accidente de tránsito, con traumatismo lumbar. Evoluciona con paresia de las extremidades inferiores, asociada a incontinencia urinaria, disminución del tono del esfínter anal y dolor lumbar intenso. EL diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de hemisección medular
- b) Sección medular completa
- c) Síndrome de cauda equina
- d) Raquiestenosis
- e) Síndrome de arteria espinal anterior

59) Paciente de 64 años de edad, fumador e importante, presenta disfonía de larga data (2 meses) sin otros síntomas. El examen físico no aporta mayor información. ¿Con qué examen enfrentaría inicialmente a este paciente?

- a) Laringoscopia directa
- b) TAC de cuello
- c) Ecografía de cuello
- d) Nasofibroscopia
- e) Control clínico luego de reposo vocal

60) Un paciente ha presentado varios episodios de taquicardia de inicio y término brusco, de algunos minutos de duración, a frecuencias sobre los 160x', que en 2 ocasiones han requerido de atención en el servicio de urgencia, cediendo ante el masaje carotídeo. El electrocardiograma de reposo muestra una frecuencia cardíaca de 69 x', con acortamiento del segmento PR. Ensanchamiento del complejo QRS y presencia de una onda delta. EL tratamiento definitivo de esta condición es:

- a) Marcapasos definitivo
- b) Amiodarona a permanencia
- c) Betabloqueantes a permanencia
- d) Verapamilo a permanencia
- e) Fulguración con radiofrecuencia

61) Una paciente de 56 años presenta dolor abdominal intenso, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico está taquicárdica, con PA: 100/60 mmHg, fiebre hasta: 38,9°C y dolor a la palpación del abdomen, mayor en la zona iliaca izquierda, con presencia de signo de Blumberg esbozado en dicha zona. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Diverticulitis aguda
- c) Enfermedad de Chron
- d) Colitis isquémica
- e) Pseudo-obstrucción intestinal

62) El diagnóstico de nefropatía diabética incipiente se realiza con:

- a) Proteinuria con elevación de la creatinina plasmática
- b) Microalbuminuria persistente con elevación discreta de la creatinina plasmática
- c) Macroalbuminuria con elevación discreta de la creatinina plasmática
- d) Microalbuminuria persistente con creatinina plasmática normal
- e) Macroalbuminuria persistente con creatinina plasmática normal

63) Un paciente de 75 años presenta un cuadro de 30 minutos de duración de disartria, más hemiparesia derecha, de predominio braquial, que iniciaron de manera brusca. Se solicita TAC de cerebro que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar ácido acetilsalicílico
- b) Iniciar anticoagulación con heparina e.v.
- c) Iniciar anticoagulación con cumarínicos orales
- d) Realizar trombolisis endovenosa con r-TPA
- e) Solicitar nuevo TAC en 1 hora

64) En un recién nacido con cianosis, ¿cómo se puede diferenciar si la cianosis es de origen cardíaco o respiratorio?

- a) Presencia de crepitaciones en el examen pulmonar
- b) Desaturación arterial que no responde a oxígeno en alta concentración
- c) Frecuencia respiratoria elevada
- d) Cianosis central
- e) Aumento de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno

65) Un hombre de 55 años, con antecedente de una estenosis mitral reumática, consulta por palpitaciones intensas, asociadas a disnea. Al examen físico se aprecia hipoperfundido, con FC irregular a 150 latidos por minuto, PA de 90/60 mmHg, saturación O₂: 84% y RI2T con soplo diastólico en rodada. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia irregular con complejos QRS angostos y ausencia de onda P. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar propafenona endovenosa
- b) Administrar amiodarona endovenosa
- c) Administrar heparina endovenosa y propanolol endovenoso
- d) Iniciar aspirina y betabloqueantes por vía oral
- e) Realizar cardioversión eléctrica inmediata

66) Un niño de 6 años, con antecedente de asma, presenta prurito en las fosas polplíteas y cubitales. Se observa ligero eritema y algunas pápulas en esas zonas. El diagnóstico más probable es:

- a) Urticaria
- b) Dermatitis atópica
- c) Vasculitis de Churg-Strauss
- d) Eccema numular
- e) Dermatitis de contacto alérgica

67) Una mujer con dolor articular y derrame articular en la rodilla izquierda se realiza estudio de líquido sinovial, que muestra un líquido claro, con menos de 800 células por mm³, 75% de mononucleares, 25% polimorfonucleares, filante. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis por cristales
- b) Artrosis
- c) Sinovitis facetaria
- d) Artritis reumatoide
- e) Artritis séptica

68) Una mujer de 25 años, trabajadora sexual, consulta por lesiones muy dolorosas en la zona genital. Al examen físico se aprecian varias lesiones ulceradas, con halo eritematoso, de fondo blanquecino. El agente etiológico más probable es:

- a) Treponema pallidum
- b) Chlamydia trachomatis
- c) Haemophilus ducreyi
- d) Virus herpes simplex tipo 2
- e) Neisseria gonorrhoeae

69) Un lactante presenta tos en accesos, que en ocasiones es muy intensa, llegando a producir cianosis facial importante. Se solicita hemograma que muestra leucocitosis de 20.000 con 79% de linfocitos. El agente causal más probable es:

- a) VRS
- b) Bordetella pertussis
- c) Virus parainfluenza
- d) Adenovirus
- e) Virus influenza

70) Un lactante de 3 meses de edad presenta diarrea desde hace 14 días. Evoluciona con con deshidratación y marcado decaimiento. Al examen físico está deshidratado, se aprecia su escroto hiperpigmentado y en sus exámenes destaca hiponatremia e hiperkalemia. El diagnóstico es:

- a) Diarrea por rotavirus
- b) Acidosis tubular renal
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Síndrome de Bartter
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita

71) Un paciente de 68 años, operado de una prostatectomía radical hace 2 días, presenta dolor torácico, con tope inspiratorio. El examen cardiopulmonar no aporta información adicional, por lo que se solicita un electrocardiograma que muestra ritmo sinusal a 115 x' y radiografía de tórax que muestra el hilio pulmonar derecho prominente. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Neumonía
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Metástasis pulmonares de cáncer prostático

72) Un hombre de 34 años presenta un cuadro de dolor precordial opresivo, intenso, de inicio súbito, irradiado a ambos hombros y asociado a disnea y sensación de muerte. No refiere antecedentes de relevancia y el examen cardiopulmonar, así como el resto del examen físico, no aporta mayor información. Se hospitaliza para estudio, constatándose electrocardiograma normal, al igual que la radiografía de tórax. Se solicitan troponinas seriadas y electrocardiogramas seriados durante 24 horas, obteniéndose sólo resultados normales. Se decide el alta hospitalaria. ¿Qué examen es más importante para ser realizado en este paciente previo al alta?

- a) Test de esfuerzo
- b) Ecocardiografía
- c) Holter de arritmias
- d) Coronariografía
- e) Angio-TAC de tórax

73) Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, intenso, asociado vómitos alimentarios explosivos e imposibilidad de eliminar gases. Al examen físico se aprecia abdomen marcadamente distendido, doloroso a la palpación, con claro aumento de los ruidos hidroaéreos y bazuqueo. ¿Cuál es el mejor examen para determinar la etiología de la obstrucción intestinal en este paciente?

- a) Radiografía de abdomen de pie
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Ecografía abdominal
- d) Colonoscopia
- e) Resonancia magnética nuclear

74) Una mujer de 60 años, con antecedente de dolor abdominal tipo cólico en el hipocondrio derecho, que se presenta varias veces a la semana, durando algunas horas, presenta además ictericia de piel y escleras y fiebre intermitente. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran elevación de la bilirrubina hasta 5 mg/dl, de predominio directo, con GGT: 521 UI/l, FA: 544 UI/l, GOT: 68 UI/l y GPT: 80 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Colédocolitiasis
- d) Colecistitis aguda
- e) Cáncer de páncreas

75) Un paciente de 50 años consulta por tos con expectoración purulenta de algunos días de evolución. Al examen físico se constata matidez a la percusión en la base derecha, con disminución del murmullo pulmonar y aumento de las vibraciones vocales en esa zona. Se solicita una radiografía de tórax que muestra una imagen redondeada de 5 cm de diámetro, con un nivel hidroaéreo. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Absceso pulmonar
- c) Cáncer de pulmón
- d) Pneumonía pneumocócica
- e) Quiste hidatídico pulmonar

76) Un paciente diabético tipo 2, mal controlado, pierde súbitamente la visión de uno de sus ojos, sin dolor, el cual fue precedido por entopsias algunos minutos antes. El reflejo fotomotor y la oculomotilidad son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia vítrea
- b) Desprendimiento de retina periférico
- c) Edema macular
- d) Trombosis de la vena central de la retina
- e) Oclusión de la arteria central de la retina

77) Un hombre diagnosticado de cáncer pulmonar, presenta hiponatremia crónica, con valores cercanos a 125 mEq/l. No ha presentado síntomas relacionados con su alteración hidroelectrolítica. La conducta más adecuada para el manejo de esta condición es:

- a) Aumentar la ingesta de sodio
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar furosemida
- d) Restringir la ingesta de agua a 1 litro al día
- e) Indicar dieta con 6 gramos de sodio al día

78) Un hombre de 28 años presenta un cuadro de cefalea, mialgias y aparición de un exantema petequeial. Como antecedente refiere haber visitado Brasil recientemente. Al tomar la presión arterial, se aprecia aparición de un gran número de petequias en la zona del manguito de presión. El diagnóstico más probable es:

- a) Malaria
- b) Triquinosis
- c) Dengue
- d) Fiebre amarilla
- e) Sarampión

79) Una niña de 14 años aún no ha iniciado sus menstruaciones. Presenta desarrollo mamario en Tanner III y vello púbico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar prueba de progesterona
- c) Solicitar prueba de estrógeno más progesterona
- d) Solicitar 17-OH progesterina
- e) Observar evolución y controlar en 6 meses

80) Una paciente de 80 años presenta un cuadro de olvidos frecuentes y apatía, asociado a dificultades para oír. Al examen físico no se aprecian signos focales, está atenta y se aprecian los reflejos osteotendíneos disminuidos y lentos. ¿Qué examen debe pedir en primer lugar?

- a) VDRL
- b) Niveles plasmáticos de vitamina B12
- c) RMN de cerebro
- d) TAC de cerebro
- e) TSH

81) Una paciente embarazada, de 36 semanas + 4 días de edad gestacional, comienza con sangrado genital escaso, con sangre fresca, sin dinámica uterina. El monitoreo cardíaco fetal resulta tranquilizador. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de placenta
- b) Rotura uterina
- c) Rotura de vasa previa
- d) Salida del tapón mucoso
- e) Placenta previa sangrante

82) Se realiza un estudio, en el que se eligen 2 grupos de trabajadores de la salud, separándolos en aquellos en contacto con pacientes pediátricos y aquellos que no tienen contacto con estos pacientes y se comparan las tasas de incidencia de enfermedades respiratorias en ambos grupos. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) De intervención comunitaria
- d) Ensayo de campo
- e) Ecológico

83) Una mujer fue despedida hace un mes de su trabajo, por políticas de reducción de personal, propias de la empresa. Hace 10 días inicia ánimo bajo, con dificultades para dormir, disminución del apetito e irritabilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo de tipo depresivo
- b) Depresión mayor
- c) Trastorno por estrés postraumático
- d) Trastorno por ansiedad
- e) Duelo patológico

84) Un paciente de 24 años consulta por hematoquezia y diarrea, de varios días de evolución, asociado a dolor abdominal sordo, con exacerbaciones cólicas. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis viral
- b) Colitis parasitaria
- c) Colitis bacteriana
- d) Colitis ulcerosa
- e) Colitis por enfermedad de Crohn

85) Un adolescente de 16 años sufre una caída en bicicleta, golpeándose el muslo derecho. No presenta equimosis, sin embargo se aprecia un aumento de volumen, de 8 x 10 cm de diámetro, adherido a planos profundos, indoloro. La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar calor local e iniciar AINES
- b) Realizar drenaje quirúrgico
- c) Realizar drenaje en pabellón e iniciar antibióticos endovenosos
- d) Observa evolución
- e) Solicitar resonancia magnética y derivar a oncología

86) Un hombre de 23 años presenta un cuadro de 10 días de evolución de exaltación del ánimo, con hiperactividad, asociado a un delirio de grandeza y presencia de alucinaciones auditivas de aplausos y voces que lo felicitan y resaltan sus habilidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno bipolar en fase maníaca
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Episodio hipomaniaco
- e) Trastorno esquizoafectivo

87) ¿Cuál de las siguientes es una causa de hipermenorrea?

- a) Endometriosis
- b) Pólipo endometrial
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Proceso inflamatorio pélvico
- e) Cáncer de cuello uterino

88) Un niño de 2 años presenta un cuadro de diarrea de 6 meses de evolución, sin otras molestias. Los síntomas son intermitentes, presentando periodos de remisión y luego recaídas. La diarrea es acuosa, sin visualización de sangre, ni otros elementos de importancia. Su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amebiasis
- b) Giardiasis
- c) Diarrea crónica inespecífica
- d) Colitis ulcerosa
- e) Enfermedad celíaca

89) Una paciente de 30 años presenta un episodio de angustia, llanto, palpitaciones, disnea y sensación de muerte mientras estaba en un Mall. Al ser interrogada habría presentado 2 episodios similares en su casa. Actualmente no quiere regresar al Mall, porque presenta ansiedad y miedo a presentar una nueva crisis y morir. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de pánico
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Agorafobia
- e) Fobia social

90) Un adolescente de 15 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y un exantema papulo-vesicular muy pruriginoso, que inició en el cuero cabelludo y que actualmente se ha generalizado. El diagnóstico más probable es:

- a) Varicela
- b) Prurigo
- c) Escarlatina
- d) Eritema infeccioso
- e) Infección por enterovirus (Coxsackie)

SEGUNDA PARTE

1) Un hombre de 30 años sufre caída de una altura de 2 metros de pie. A su llegada a Urgencias, está ciego, con sondaje vesical con orina clara. Muestra tumefacción de talón izquierdo, así como hormigueos leves por cara anterior de muslo derecho y escroto, así como disestesias en ambos pies. El paciente se despide del camillero con un apretón de manos, con una palmada simultánea en el hombro. La rotación de los MMII en la camilla cogidos por los tobillos es indolora y la compresión de la pelvis es asintomática. A continuación:

- a) Lo sentaremos en la camilla para poder explorar la columna cervical.
- b) Remitiremos a Rx para realizar estudio de extremidades inferiores.
- c) Palparemos el abdomen y lo rotaremos en bloque para palpar la columna toraco-lumbar.
- d) Le colocaremos un collarín cervical y remitiremos a radiología para estudio de imagen de columna cervical y extremidades inferiores.
- e) Solicitaremos una eco abdominal

2) Un paciente de 58 años, hospitalizado hace 24 horas por una neumonía adquirida en la comunidad, en tratamiento con ceftriaxona endovenosa, se realiza un test pack para influenza A, que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento con ceftriaxona
- b) Cambiar la ceftriaxona por oseltamivir oral y completar el tratamiento de manera ambulatoria
- c) Agregar levofloxacino e indicar aislamiento de gotitas
- d) Agregar oseltamivir y dar aislamiento respiratorio en cohorte
- e) Agregar oseltamivir e indicar aislamiento de contacto

3) Una mujer de 25 años, primigesta, cursando embarazo de término, inicia trabajo de parto con buena evolución. Sin embargo súbitamente inicia metrorragia, con dolor abdominal. Al examen físico se aprecia útero hipertónico y el monitoreo cardíaco fetal demuestra FCF de 101 x', con múltiples desaceleraciones variables. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Rotura de vasa previa
- c) Rotura uterina
- d) Acretismo placentario
- e) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

4) Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de odinofagia, rinorrea y malestar general de varios días de evolución. Al séptimo día comienza con tos, fiebre hasta 38°C y disnea. Al examen físico se aprecia espiración prolongada y sibilancias bilaterales y la radiografía de tórax demuestra signos de relleno alveolar bibasales. El agente más probable es:

- a) Virus
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Staphylococcus aureus

5) Un paciente de 60 años, presenta un cuadro de astenia, ictericia y baja de peso de 10Kg en los últimos meses, asociados a diarrea ocasional. El examen físico no muestra alteraciones adicionales y se solicitan exámenes que muestran GOT: 56 UI/L, GPT: 40 UI/L, GGT: 340 UI/L, FA: 344 UI/L, Bilirrubina: 6,8 mg/dl, Bili directa: 6,4 mg/dl, Protrombinemia: 80%. La ecografía abdominal demuestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, sin poder visualizar el páncreas. El diagnóstico más probable es:

- a) Colédocolitiasis
- b) Colangiocarcinoma
- c) Cáncer de páncreas
- d) Hepatocarcinoma
- e) Hepatitis crónica

6) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 35 semanas, ingresa por un cuadro de malestar general, cefalea, tinnitus y fotopsias. Al examen físico se aprecia PA: 195/45 mmHg, con reflejos osteotendíneos exaltados. ¿Qué medida es más importante?

- a) Administrar sulfato de magnesio
- b) Administrar suero fisiológico
- c) Administrar labetalol
- d) Administrar hidralazina
- e) Administrar alfametildopa

7) Una mujer de 39 años, nulípara, diabética tipo 2, en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta deseos de embarazarse. Cuenta con HbA1c de 7,4%. ¿Qué recomendación de daría antes de embarazarse?

- a) Mantener el tratamiento
- b) Mantener sólo la metformina y suspender la glibenclamida
- c) Suspender ambos medicamentos e iniciar tratamiento exclusivo con dieta
- d) Suspender ambos medicamentos e iniciar insulina
- e) Desaconsejar el embarazo, dada la edad y comorbilidad de la paciente

8) Un paciente de 70 años presenta anemia con Hb: 8,6 g/dl, sin alteración de las otras líneas celulares. Destaca VCM: 100 fl y reticulocitos de 12%. Al frotis se describe policromasia y anisocitosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia por déficit de folatos
- b) Anemia por hemólisis
- c) Anemia por déficit de hierro
- d) Anemia por déficit de vitamina B12
- e) Mielodisplasia

9) Usted recibe en el servicio de urgencia a un niño, que tendría un insecto en su oído izquierdo, causándole mucho dolor e incomodidad. A la otoscopia se precia el insecto vivo. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Retirar el insecto mediante un cotonito
- b) Retirar el insecto con una pinza
- c) Realizar lavado de oído con agua tibia
- d) Aplicar vaselina líquida en el conducto auditivo externo
- e) Derivar al otorrino, sin realizar ninguna intervención previa

10) Una mujer de 22 años, con historia de oligomenorrea, presenta metrorragia desde hace 45 días. Al examen físico está en buenas condiciones, sin evidencia de compromiso hemodinámico, ni de anemia. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Iniciar progestágenos
- c) Realizar legrado terapéutico y diagnóstico
- d) Realizar seguimiento ecográfico
- e) Iniciar estrógenos + progestágenos en altas dosis, asociados a sulfato ferroso

11) El mejor examen para la sospecha de urolitiasis es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Pielografía de eliminación
- c) Radiografía de abdomen simple
- d) TAC helicoidal sin contraste
- e) Resonancia magnética nuclear con contraste endovenoso

12) Una mujer de 50 años, con síntomas climatéricos, sin otras molestias presenta un mioma uterino de tamaño equivalente a un embarazo de 8 semanas, confirmado con ecografía. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Tratar con agonistas de la GnRH
- c) Iniciar anticonceptivos orales
- d) Realizar histerectomía
- e) Realizar miomectomía por histeroscopia

13) Usted recibe a un paciente que fue encontrado en la vía pública con equimosis en abdomen y extremidades, con trauma cerrado del abdomen y compromiso hemodinámico, pese a la reanimación, con administración de cristaloides endovenosos.

La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparoscopia
- b) Realizar laparotomía de urgencia
- c) Realizar TAC de abdomen y pelvis
- d) Realizar ecografía abdominal
- e) Realizar lavado peritoneal diagnóstico por punción

14) ¿Qué tipo de estudio es el más adecuado para calcular la incidencia de una patología infecciosa?

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ecológico
- e) Ensayo clínico

15) ¿Qué alteración se debe descartar en las primeras 24 horas después de una fractura nasal?

- a) Fractura de órbita
- b) Compromiso del meato medio
- c) Disminución de la capacidad olfativa
- d) Hematoma del tabique nasal
- e) Fractura del seno maxilar

16) Un recién nacido de pocos días de vida, con antecedente de ictericia neonatal, en tratamiento actual con fototerapia, presenta varias ampollas flácidas alrededor del ombligo, algunas de las cuales se rompieron espontáneamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Impétigo buloso
- b) Fasceítis necrotizante
- c) Epidermolisis bulosa
- d) Síndrome de piel escaldada
- e) Quemadura por fototerapia

17) Una mujer consulta por genitorragia escasa. Refiere atraso menstrual d 12 semanas de amenorrea. Se realiza especuloscopia, que visualiza que la sangre proviene del OCE y se palpa el útero levemente aumentado de tamaño. Se solicita beta-HCG, que resulta 700 UI/l y ecografía transvaginal, que no visualiza gestación intrauterina ni otros hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la ecografía y la beta-HCG en 48 horas
- b) Administrar misoprostol
- c) Realizar legrado
- d) Realizar laparoscopia
- e) Iniciar metotrexato

18) Un recién nacido de 21 días de vida, presenta vómitos a los pocos minutos de tomar leche. Los vómitos son no biliosos, abundantes y se observa que toma leche ávidamente. Además presenta sequedad de las mucosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Reflujo gastroesofágico del lactante
- b) Atresia esofágica
- c) Atresia duodenal
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Estenosis pilórica hipertrófica

19) Una mujer de 60 años presenta un tumor anexial derecho de 7 cm de diámetro, de aspecto sólido-quístico, tabicado, con presencia de líquido libre peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste hidatídico
- b) Cáncer de ovario
- c) Quiste folicular
- d) Teratoma quístico benigno
- e) Endometrioma

20) Un hombre de 30 años presenta fiebre y al examen físico se constata esplenomegalia importante. Se realiza hemograma que muestra Hcto: 39%, plaquetas: 450.000 por mm³, blancos: 33.000, con abundantes baciliformes y otras formas de neutrófilos inmaduros, con un 2% de blastos. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática crónica
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia aguda
- d) Mielofibrosis
- e) Leucocitosis secundaria a infección

21) Un paciente de 68 años consulta por tristeza y anhedonia, que iniciaron después del fallecimiento de uno de sus mejores amigos. Refiere sentirse cansado, ha bajado 6 kg de peso y tiene problemas para dormir, ya que despierta temprano en la mañana y le es imposible volver a dormirse. Piensa en la muerte y cree que la suya está próxima. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por adaptación
- b) Trastorno por estrés agudo
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Demencia

22) Un paciente diabético, en tratamiento con metformina en dosis altas, acude a control con HbA1c: 6,1%, albuminuria de 24 horas: 50 mg/día, colesterol HDL: 38 mg/dl, colesterol LDL: 100 mg/dl, TG: 155 mg/dl, presión arterial promedio 155/90 mmHg. ¿Qué medida es más importante?

- a) Agregar una estatina
- b) Agregar un fibrato
- c) Agregar glibenclamida
- d) Agregar insulina
- e) Agregar enalapril

23) Un paciente con tuberculosis pulmonar bacilífera, diagnosticado con baciloscopía, inicia tratamiento estándar, controlándose con baciloscopías mensuales que resultan: -/+/. ¿Qué alternativa es más correcta?

- a) Debe plantearse la sospecha de fracaso del tratamiento
- b) Debe plantearse la sospecha de recaída
- c) Debe mantenerse el tratamiento, en el esquema de fase bisemanal
- d) Debe retomarse el tratamiento con el esquema de la fase diaria
- e) Se debe realizar PCR para Mycobacterium tuberculosis en esputo

24) Un joven de 17 años presenta dolor testicular izquierdo de inicio súbito, muy intenso, de 45 minutos de evolución, asociado a aumento de volumen del testículo en cuestión. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar al especialista urgente
- b) Tranquilizar al paciente, explicando lo benigno de la situación
- c) Solicitar ecografía-doppler testicular
- d) Iniciar analgesia con AINES
- e) Administrar corticoides sistémicos

25) Una mujer obesa, de 65 años presenta dolor en las rodillas, que aumenta cuando sube y baja escaleras. Al examen físico no se detectan alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Disfunción patelofemoral
- b) Condrocálculos
- c) Artrosis
- d) Bursitis rotuliana
- e) Síndrome de Osgood-Schlatter

26) Un paciente de 40 años presenta placas descamativas, costrosas en el cuero cabelludo y las cejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Queratosis seborreica
- c) Psoriasis
- d) Tiña capitis
- e) Liquen simple

27) Usted recibe en la urgencia a un hombre de 35 años que tras una pelea con su padre presenta disartria y luego mutismo aquinético. El examen físico no presenta otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Miastenia gravis
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno disociativo

28) Un joven de 24 años presenta diarrea desde hace 3 semanas, asociada a marcado compromiso del estado general y hematoquezia en algunas oportunidades. Al examen físico se aprecia abdomen blando depresible, sensible, con ruidos hidroaéreos presentes. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar coprocultivo
- b) Solicitar parasitológico seriado de deposiciones
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Iniciar tratamiento antibiótico e hidratación por vía oral
- e) Iniciar tratamiento antibiótico e hidratación por vía parenteral

29) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más sugerente de un vértigo de origen central?

- a) Inicio súbito
- b) Curso fluctuante
- c) Otorrea
- d) Hipoacusia
- e) Nistagmo multidireccional

30) Una paciente de 26 años presenta debilidad muscular de predominio proximal, con dificultad para peinarse o cambiar una ampollita. Al examen físico se aprecia un rash eritematoso en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Esclerodermia
- c) Vasculitis de vaso pequeño
- d) Dermatomiositis
- e) Polimialgia reumática

31) Un niño de 13 años presenta un cuadro de odinofagia, fiebre y aparición de pápulas y vesículas dolorosas en la faringe y en las palmas y plantas. ¿Qué medicamento debe administrarle como medida más importante?

- a) Paracetamol
- b) Aciclovir
- c) Eritromicina
- d) Amoxicilina
- e) Oseltamivir

32) Un paciente de 55 años, diagnosticado de infección por el VIH, presenta problemas para tragar desde hace unos días. Al examen físico se aprecia algarra en la cavidad oral. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar fluconazol oral
- b) Solicitar recuento de CD4
- c) Tratar con anfotericina B
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Tratar con nistatina tópica

33) Una mujer de 30 años presenta un VDRL positivos y un FTA-ABS también positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina
- b) Solicitar MHA-TP
- c) Iniciar ciprofloxacino
- d) Iniciar azitromicina
- e) Iniciar doxiciclina

34) Un niño de 6 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de fiebre, odinofagia marcada y conjuntivitis bilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Kawasaki
- b) Infección por adenovirus
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Sarampión
- e) Infección por Chlamydia

35) Un paciente diabético, con mal control metabólico, ve entopsias y fotopsias localizadas en el hemicampo temporal izquierdo. Dos días después evoluciona con pérdida súbita de la visión de dicha zona del campo visual. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de rama de arteria retinal
- b) Trombosis de rama de la vena retinal
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma
- e) Hemorragia vítrea

36) Un paciente cursando con un síndrome nefrótico, con marcado edema y albúmina de 1,9 g/dl, presenta creatinina basal de 1,0 mg/dl. Se inician diuréticos de asa por vía endovenosa, como tratamiento del edema, lográndose clara disminución del mismo, sin embargo evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina a 2,8 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefritis por diuréticos
- b) Estenosis de la arteria renal
- c) Insuficiencia renal prerrenal
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

37) Un paciente diabético, en tratamiento con metformina 1 gramos cada 12 horas y glibenclamida 10 mg cada 12 horas, mantiene HbA1c cercanas a 8,9%. Su creatinina es de 0,8 mg/dl y la albuminuria es negativa. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar NPH nocturna
- b) Suspender los hipoglicemiantes orales e iniciar insulino terapia en esquema intensificado
- c) Suspender la glibenclamida e iniciar insulino terapia en esquema intensificado, asociado a metformina
- d) Aumentar la dosis de metformina
- e) Aumentar la dosis de glibenclamida

38) Un paciente de 73 años consulta por un cuadro de dolor abdominal intenso, asociado a náuseas, vómitos y constipación. Al examen físico se aprecia distensión abdominal y ruidos intestinales metálicos, aumentados en intensidad. Se solicita radiografía de abdomen, que muestra un asa de intestino dilatada, con presencia del signo del “grano de café”. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer gástrico
- b) Vólvulo de sigmoides
- c) Vólvulo de intestino delgado
- d) Hernia atascada
- e) Obstrucción por bridas

39) Si en una radiografía de tórax se observa una zona de opacidad parenquimatosa, asociada a disminución del volumen de dicho pulmón, se establece el diagnóstico de:

- a) Condensación
- b) Atelectasia
- c) Cáncer
- d) Derrame pleural
- e) Bronquiectasia

40) Se realiza una comparación entre dos regiones de Chile, en base a los datos obtenidos en la encuesta nacional de salud. Para esto se utilizan las prevalencias de obesidad y el nivel socioeconómico de ambas regiones y se investiga la asociación entre ambos parámetros. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Ecológico
- b) Transversal
- c) De intervención comunitaria
- d) De cohortes
- e) De casos y controles

41) Un paciente de 70 años, hipertenso, diagnosticado de EPOC, en tratamiento con enalapril, salbutamol y budesonida, presenta desde hace 4 días un cuadro de conducta agresiva con sus familiares, asociado a ideas paranoides y de robo. El diagnóstico más probable es:

- a) Alteraciones conductuales, asociadas a enfermedad de Alzheimer
- b) Encefalopatía hipercálica
- c) Accidente vascular encefálico
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Delirium

42) Un paciente de 26 años presenta un cuadro de paresia en las extremidades inferiores, que se van intensificando en los días sucesivos, hasta imposibilitar la marcha, extendiéndose también a las extremidades superiores. Al examen físico destaca parálisis facial bilateral y abolición de los ROT. El diagnóstico más probable es:

- a) Polineuropatía distal simétrica
- b) Síndrome miasténico
- c) Esclerosis lateral amiotrófica
- d) Polirradiculoneuritis aguda
- e) Esclerosis múltiple

43) Un recién nacido prematuro, nacido a las 30 semanas de edad gestacional, presentó apgar 2 al minuto y 7 a los 5 minutos de vida. Es alimentado con fórmula de inicio. A la semana de edad inicia distensión abdominal, vómitos de retención y deposiciones con sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hirshsprung
- b) Atresia duodenal
- c) Invaginación intestinal
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Alergia a la proteína de la leche de vaca

44) Una mujer de 30 años, con antecedente de haber utilizado amoxicilina hace algunas semanas, por una sinusitis bacteriana, comienza con prurito vulvar, asociado a leucorrea grumosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Vaginitis
- c) Tricomoniasis
- d) Gonorrea
- e) Infección por Chlamydia

45) Un hombre de 30 años presenta un nódulo tiroideo de 25 mm de diámetro, de consistencia sólida. Se solicita TSH que resulta: 2,4 UI/L y T4 que resulta 10 ug/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar anticuerpos anti-TPO
- b) Resolver quirúrgicamente
- c) Iniciar levotiroxina
- d) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- e) Derivar para punción-aspiración con aguja fina

46) Un paciente de 40 años inicia dolor abdominal tipo cólico, intenso, en el hipocondrio derecho, que inició luego de la ingesta de abundantes grasas y que se asoció a vómitos abundantes. Los vómitos inicialmente fueron alimentarios, luego biliosos y finalmente presentó hematemesis en 2 oportunidades, seguida de melena. ¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia digestiva?

- a) Várices esofágicas
- b) Úlcera gastroduodenal
- c) Síndrome de Mallory Weiss
- d) Gastritis aguda
- e) Cólico biliar

47) Un paciente asmático, en tratamiento con fluticasona y salbutamol inhalados, ingresa al servicio de urgencia muy disneico y agitado, a pesar del uso frecuente del salbutamol. Al examen físico está taquicárdico, PA: 140/100 mmHg, saturación arterial de oxígeno: 85%, presenta sibilancias intensas bilaterales, con retracción intercostal y subcostal y tiraje. ¿Cuál es la primera medida a realizar?

- a) Administrar oxígeno
- b) Administrar salbutamol inhalado
- c) Realizar intubación orotraqueal
- d) Administrar corticoides sistémicos
- e) Indicar apoyo ventilatorio con presiones positivas

48) Un hombre de 28 años presenta beta-HCG elevada. ¿Qué enfermedad padecerá con mayor probabilidad?

- a) Cáncer de testículo
- b) Cáncer de páncreas
- c) Hepatocarcinoma
- d) Linfoma
- e) Cáncer medular de tiroides

49) Un paciente de 60 años, con antecedente de un infarto cardiaco hace 3 años, consulta por malestar general marcado y disnea. Al examen físico se aprecia FC: 130x', PA: 90/60 mmHg, con frialdad de extremidades. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia regular, con complejo QRS de 140 milisegundos y ondas P disociadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Flutter auricular
- c) Fibrilación auricular
- d) Fibrilación ventricular
- e) Taquicardia ventricular

50) El tratamiento farmacológico de elección en el trastorno de ansiedad generalizada es:

- a) Anticonvulsivantes
- b) Litio
- c) Antipsicóticos
- d) Benzodiacepinas
- e) Antidepresivos

51) Un lactante de 15 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 38,7°C, asociado a tos intensa, que en los últimos minutos se ha acompañado de respiración ruidosa y dificultad para respirar. Al examen físico se aprecia estridor inspiratorio y uso de musculatura accesoria. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Virus parainfluenza
- d) Virus influenza
- e) Adenovirus

52) Una paciente multipara de 2, cursando un nuevo embarazo de 39 semanas de edad gestacional inicia contracciones uterinas persistentes e intensas. Al examen físico está con 3 contracciones cada 10 minutos, con cuello uterino completamente borrado, dilatación de 6 cm de diámetro y membranas rotas. Se palpa el feto en presentación de vértice, occipito iliaca derecha posterior, en espinas 0 y se constata registro fetal con 140 lpm, variabilidad conservada y presencia de aceleraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar goteo oxitócico
- b) Realizar cesárea
- c) Realizar Fórceps
- d) Realizar rotación manual de la cabeza fetal hasta ubicarla en una posición anterior
- e) Dejar evolución espontánea

53) Un paciente de 70 años, diabético de larga data, con control metabólico irregular, subóptimo, presenta dolor lumbar de larga data y astenia. En sus exámenes destaca anemia con Hb: 9,8 g/dl, con VCM: 88 fl, creatinemia: 6,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas: 3,3 gr. Se solicita una ecografía abdominal que muestra riñones de tamaño normal. La causa más probable de su insuficiencia renal es:

- a) Nefropatía diabética
- b) Nefropatía secundaria a mieloma múltiple
- c) Prerenal
- d) Glomerulonefritis mesangiocapilar
- e) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

54) Un hombre de 22 años, apático, presenta retraimiento social marcado desde hace algunos meses, que en el último tiempo se asocia a alucinaciones sobre extraterrestres que experimentan sobre él. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno de personalidad esquizotípico
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Trastorno bipolar

55) Una mujer de 40 años presenta serios daños en su casa, a causa de un terremoto, en el que una de las paredes cayó sobre sus hijos aplastándolos temporalmente, logrando ser rescatados sin lesiones de consideración. Siete días después presenta recuerdos del acontecimiento y pesadillas en la que sus hijos mueren aplastados, anda muy alerta ante cualquier temblor y corre fuera de la casa ante las más mínimas réplicas. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno de ansiedad
- e) Trastorno de estrés agudo

56) Una mujer de 80 años, hipertensa y diabética, presenta una arritmia completa por fibrilación auricular, bien tolerada, con escasos síntomas y sin síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué medicamento(s) debe indicar?

- a) Aspirina + amiodarona
- b) Aspirina + digoxina
- c) Atenolol + amiodarona
- d) Acenocumarol
- e) Amiodarona sola

57) Un hombre de 26 años presenta lumbago de algunas semanas de evolución, que aumenta con el reposo, disminuyendo con la actividad. En los últimos días se agrega dolor torácico que aumenta con la inspiración. ¿Con qué examen(es) debería iniciar el estudio?

- a) ANA, ANCA y factor reumatoideo
- b) Radiografía de tórax
- c) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
- d) Hemograma y VHS
- e) Radiografía de articulaciones sacroilíacas

58) Un lactante de dos meses de edad presenta ictericia de escleras. Está alimentado con leche materna exclusiva y no presenta otras alteraciones en su examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Bilirrubinemia total y directa
- b) TSH plasmática
- c) Ecografía abdominal
- d) Prueba de Coombs directo
- e) Prueba de Coombs indirecto

59) Un paciente sufre una sección medular a nivel de T9. ¿Qué alteración sería más IMPROBABLE de hallar en las extremidades inferiores?

- a) Signo de Babinsky
- b) Fasciculaciones
- c) Clonus
- d) Hiperrreflexia
- e) Anestesia

60) ¿Cuál de las siguientes condiciones se asocia más al desarrollo de falla renal posterior al uso de medio de contraste endovenoso?

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Urolitiasis bilateral no obstructiva
- c) Insuficiencia cardíaca descompensada
- d) Edad mayor a 50 años
- e) Hipertensión arterial

61) Un paciente sufre un accidente de tránsito de alta energía, con múltiples fracturas. Evoluciona con imposibilidad de orinar en su exploración destaca sangre en el meato urinario y globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cistostomía suprapúbica
- b) Instalar sonda Foley
- c) Solicitar ecografía renal y vesical
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Forzar la diuresis con suero fisiológico

62) Una mujer de 56 años, colecistectomizada hace 5 años por una coleditiasis sintomática, consulta por un nuevo cuadro de dolor abdominal intenso, asociado a vómitos e ictericia con coluria y acolia. Las pruebas hepáticas determinan colestasia y la ecografía biliar demuestra una vía biliar de 14 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar colangiografía
- d) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- e) Iniciar ácido ursodeoxicólico

63) Una mujer de 39 años asegura que desde hace varios años está embarazada de Dios. Al confrontarla no es capaz de reconocer que esto no es cierto. Esta descripción corresponde a:

- a) Delirio
- b) Alucinación
- c) Ilusión
- d) Esquizofrenia
- e) Alucinosis

64) Una mujer, usuaria de DIU, comienza con leucorrea, asociada a dolor abdominal bajo. Al examen ginecológico se constata que la leucorrea proviene del OCE y se produce dolor a la movilización cervical. La primera medida a realizar es:

- a) Retirar el DIU
- b) Tomar cultivos de secreción vaginal
- c) Iniciar antibióticos
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar beta-HCG plasmática

65) Un paciente de 19 años, delgado, cuyo padre murió a los 28 años, de manera súbita, inicia un cuadro de dolor torácico intenso, de inicio súbito. Al examen físico destaca asimetría en la intensidad del pulso entre ambas extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Trombofilia, con TEP masivo
- d) Síndrome de Brugada
- e) Disección aórtica

66) Un paciente de 17 años presenta cefalea de algunas semanas de evolución, de localización hemisférica, pulsátil, de intensidad moderada, que en ocasiones presenta fotopsias previo al inicio del dolor, las que desaparecen, dando paso a la cefalea. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor del sistema nervioso central
- b) Jaqueca
- c) Cefalea cluster
- d) Epilepsia focal
- e) Cefalea tensional

67) Un paciente de 69 años, diabético, presenta un síndrome coronario agudo, con supradesnivel del segmento ST, con síntomas que iniciaron hace 4 horas. Al examen físico está con dolor, sudoroso, con FC: 94x' y PA: 120/80. La conducta más adecuada, que traerá mejores expectativas de mejoría, es:

- a) Realizar angioplastia con stent
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Iniciar nitroglicerina endovenosa por bomba de infusión
- d) Solicitar marcadores de daño miocárdico y decidir conducta según hallazgos
- e) Realizar trombolisis endovenosa

68) Una mujer de 26 años, presenta amenorrea de 2 meses de evolución, asociado a dolor pélvico desde hace 4 horas. Como método anticonceptivo utiliza el DIU. Se solicita beta-HCG, que resulta 3.500 UI/l y ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 12 milímetros de grosor, con líquido libre en el fondo de saco peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Retirar el DIU
- b) Observar evolución
- c) Solicitar nueva beta-HCG y nueva ecografía en 48 horas
- d) Iniciar metotrexato
- e) Realizar laparoscopia

69) Un recién nacido prematuro, nacido a las 32 semanas de vida, presenta un síndrome de dificultad respiratoria severa, que inició una hora después de nacer y que ha ido empeorando progresivamente. La radiografía de tórax muestra relleno pulmonar bilateral, en patrón de vidrio esmerilado y presencia de broncograma aéreo. El diagnóstico es:

- a) Enfermedad por aspiración meconial
- b) Neumonía por Streptococo grupo B
- c) Enfermedad de membrana hialina
- d) Cardiopatía congénita
- e) Hipertensión pulmonar persistente

70) Un paciente de 50 años, hipertenso, diagnosticado de insuficiencia renal crónica en etapa 2, en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas, acude a control. Presenta presiones arteriales cercanas a 140/85mmHg. El examen cardiopulmonar es normal y no presenta edema. En sus exámenes se aprecia Na: 140 mEq/l. K: 4,9 mEq/l. Cl: 104 mEq/l, creatinina: 1,4 mg/dl. Qué actitud es más adecuada:

- a) Aumentar la dosis de enalapril a 20 mg cada 12 horas
- b) Agregar hidoclorotiazida
- c) Cambiar el enalapril por amlodipino
- d) Cambiar el enalapril por losartán
- e) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses

71) Una mujer de 20 años, asintomática, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un tumor anexial de 5 cm de diámetro, de contenido sólido, heterogéneo. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Endometrioma
- c) Teratoma ovárico
- d) Absceso tuboovárico
- e) Cuerpo lúteo

72) Un paciente de 65 años consulta por dolor intenso en la rodilla izquierda. Al examen físico se aprecia rodilla aumentada de volumen, caliente, con eritema y signos de derrame articular. La temperatura axilar es de 40,5°C y se constata leucocitosis de 19.000, con baciliformes: 14%, VHS muy elevada y PCR 10 veces por sobre el valor normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Gota
- b) Condrocalcinosis
- c) Artrosis
- d) Artritis reumatoide
- e) Artritis séptica

73) El tratamiento de la tricomoniasis vaginal es:

- a) Clotrimazol
- b) Cotrimoxazol
- c) Albendazol
- d) Metronidazol
- e) Clindamicina

74) Un lactante de 30 días de vida presenta dificultad respiratoria, tos y dificultad para alimentarse. Ha presentado un mal incremento ponderal y al examen físico se observa taquipneico, con aleteo nasal y crepitaciones pulmonares. Se solicita radiografía de tórax que muestra cardiomegalia, hilios pulmonares prominentes y pequeño derrame pleural. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Neumonía
- c) Bronquiolitis
- d) Bronquitis
- e) Fibrosis quística

75) Un lactante de 8 meses de edad presenta dolor cólico abdominal, asociado a deposiciones mucosanguinolentas, abundantes. El diagnóstico es:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Divertículo de Meckel
- c) Diarrea aguda viral
- d) Shigellosis
- e) Invaginación intestinal

76) Un paciente de 60 años, con reflujo gastroesofágico de larga data, controlado con omeprazol 20 mg cada 12 horas, se realiza una endoscopia digestiva alta, que muestra cambios de la mucosa del esófago distal, que se biopsia, demostrándose presencia de esófago de Barret en los cuatro cuadrantes del esófago distal, sin displasia. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de omeprazol
- b) Realizar cirugía antirreflujo
- c) Realizar seguimiento endoscópico periódico
- d) Solicitar pH-metría de 24 horas
- e) Suspender el omeprazol e iniciar lanzoprazol

77) Un paciente de 60 años pierde súbitamente la visión del ojo derecho, la cual se recupera por completo 20 minutos después. La sospecha diagnóstica es:

- a) Neuritis óptica
- b) Accidente isquémico transitorio
- c) Accidente cerebral de lóbulo occipital
- d) Edema macular
- e) Desprendimiento de retina

78) Un paciente de 55 años presenta angina al caminar 3 cuadras. Además refiere tres episodios de síncope, en relación al esfuerzo. Al examen físico destaca pulso amplio y un soplo eyectivo de intensidad III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía dilatada

79) Una mujer presenta baja de peso de 8 kg en 4 meses, asociadas a debilidad y poliuria. Se solicitan exámenes generales entre los que destaca calcio de 13,5 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hiperparatiroidismo secundario
- d) Hipertiroidismo
- e) Hipercalemia renal primaria

80) Una mujer de 30 años se realiza un PAP, que es informado como satisfactorio, con presencia de atipias glandulares. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a biopsia endometrial
- b) Observar evolución
- c) Solicitar pruebas de detección de VPH
- d) Realizar cono biopsico
- e) Derivar a colposcopia

81) Se cuenta con un grupo de 70 pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas y se descubre que el 75% de ellos tenía DM2, por lo que los investigadores aseguran que la diabetes sería un factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer. ¿Por qué esta aseveración es incorrecta?

- a) Porque se desconoce la prevalencia de diabetes en el resto de la población
- b) Porque no se cuenta con un grupo de control que permita identificar la asociación
- c) Porque la asociación entre la diabetes y el cáncer de páncreas se debe a un sesgo por variable confundente
- d) Porque los pacientes con diabetes tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, que los pacientes sanos
- e) Porque no se puede calcular el riesgo atribuible

82) Una mujer de 30 años embarazada, presenta epistaxis recurrentes, asociada a aparición de lesiones en las piernas. Al examen físico se constatan petequias, por lo que se solicitan exámenes que muestran Hematocrito: 40%, plaquetas: 18.000 por mm³, blancos: 8.300 por mm³, GOT: 35 UI/l, GPT: 28 UI/l, Bilirrubina: 0,8 mg/dl, GGT: 41 UI/l, FA: 68 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de HELLP
- b) Trombocitopenia gravídica
- c) Púrpura trombocitopénica inmune
- d) Púrpura trombocitopénica trombótica
- e) Listeriosis

83) Una mujer de 39 años presenta un cuadro de varios meses de evolución de decaimiento, ánimo bajo y astenia. En las últimas horas su condición empeora marcadamente, presentando desorientación y síncope. Llega al servicio de urgencia taquicárdica e hipotensa, con PA: 80/40 mmHg. Su hemoglucotest es 33 y su natremia es de 132 mEq/l. Se realiza reanimación, con aporte de suero fisiológico y corrección de la hipoglicemia, sin embargo persiste con hipotensión. El diagnóstico más probable es:

- a) Shock séptico
- b) Diabetes descompensada
- c) Hipotiroidismo
- d) Insuficiencia suprarrenal
- e) Hiperparatiroidismo primario

84) Un niño es diagnosticado de hemofilia. Tiene una hermana menor sana y un hermano mayor también sano. ¿Qué afirmación es verdadera?

- a) Sus próximos hermanos varones tendrán un 25% de padecer la enfermedad
- b) Sus próximas hermanas tendrán un 50% de padecer la enfermedad
- c) La aparición de petequias es característica
- d) La aparición de hemorragias de origen mucoso (epistaxis, gingivorragia, es característica)
- e) Suelen estar alargados los tiempos de coagulación

85) Un niño con talla baja, creciendo en el percentil 3 para la edad presenta una edad ósea menor de la esperada para su edad. No presenta síntomas y su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Talla baja constitucional
- b) Enfermedad celíaca
- c) Síndrome de Klinefelter
- d) Hiperplasia suprarrenal
- e) Pubertad precoz

86) Un paciente diagnosticado de fibrosis pulmonar, secundaria al uso de amiodarona, de larga data, presenta un cuadro de tos, expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,3°C. Al examen físico está en buenas condiciones con FR: 18 x', PA: 88x', PA: 120/80 mmHg, saturación arterial de oxígeno de 95%. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones difusas, mayores en la base derecha. Además sea precian uñas en vidrio de reloj. Se solicita radiografía de tórax, que muestra engrosamiento intersticial bilateral, mayor en las bases, con una zona de relleno alveolar en el LID. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar oxígeno, salbutamol y antibióticos endovenosos
- b) Hospitalizar, iniciar ceftriaxona y solicitar gases en sangre arterial
- c) Hospitalizar, iniciar ceftriaxona endovenosa y apoyo ventilatorio con presiones positivas
- d) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico por vía oral y citara control ambulatorio en 48 horas
- e) Iniciar amoxicilina y manejo ambulatorio

87) Un niño de 7 años, diagnosticado de amigdalitis pultácea, recibe una dosis de penicilina benzatina intramuscular. Algunos minutos más tarde inicia un cuadro de malestar general, asociado a tos y aparición de un rash pseudopapular, con presión arterial: 80/40 mmHg, FC: 128x', edema de los labios y los párpados. La primera medida a realizar es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Solicitar electrocardiograma
- c) Administrar adrenalina
- d) Administrar hidrocortisona
- e) Administrar clorfenamina

88) Un lactante de 10 meses de edad presenta diarrea con sangre, de 4 días de evolución. Presenta deterioro del estado general, con palidez, oliguria y escasa hematuria. El diagnóstico más adecuado es:

- a) Síndrome hemolítico urémico
- b) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- c) Púrpura de Shoenlein Henoch
- d) Glomerulonefritis postes infecciosa
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

89) Un paciente de 29 años, presenta un cuadro de tos de 3 semanas de evolución. Al examen físico presenta una clínica compatible con un derrame pleural izquierdo, el que se confirma con la radiografía de tórax, ocupando la mitad del campo pulmonar izquierdo. Se realiza toracocentesis, obteniéndose un exudado pleural de predominio mononuclear, con glucosa: 60 mg/dl, células mesoteliales: 1%, ADA: 55 UI/l y pH: 7,3. EL diagnóstico más probable es:

- a) Derrame paraneumónico simple
- b) Derrame secundario a neoplasia pulmonar
- c) Mesotelioma maligno
- d) Derrame tuberculoso
- e) Derrame secundario a artritis reumatoide

90) Un recién nacido de 10 días de vida acude a control. Está alimentado con lactancia materna exclusiva y se ve de buen aspecto. Se constata Peso: 3.400 gr y como antecedente se tiene que pesó lo mismo al nacer. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender la lactancia materna y agregar fórmula de inicio
- b) Mantener la lactancia materna y agregar fórmula de inicio
- c) Mantener la lactancia materna, sin necesidad de aportes adicionales
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Suspender lactancia materna e iniciar alimentación con derivados de la soya, sin lactosa

Respuestas:

PRIMERA PARTE

Preguntas

Respuestas

1	E
2	B
3	B
4	E
5	D
6	C
7	A
8	A
9	A
10	D
11	E
12	D
13	D
14	C
15	B
16	A
17	D
18	E
19	C

20	D
21	C
22	A
23	E
24	B
25	D
26	B
27	B
28	B
29	A
30	E (Glicemia ayuno alterada)
31	B
32	D
33	D
34	C (por ser un ADTC sí podría servir el lavado, a pesar de llevar más de una hora, pero el carbón activado es más importante)
35	C
36	C
37	E
38	A
39	A
40	B
41	A
42	C
43	E
44	D
45	B
46	C
47	A
48	B
49	B
50	D

51	C
52	B
53	D
54	B
55	B
56	A
57	C
58	C
59	D
60	E
61	B
62	D
63	D
64	B
65	E
66	B
67	B
68	D
69	B
70	E
71	B
72	A
73	B (etiología)
74	C
75	B
76	A (es difícil, pero por lo rápido, es más una HV, que un DR)
77	D
78	C
79	E
80	E
81	E

82	B
83	A
84	D
85	E
86	B
87	B
88	C
89	B
90	A

SEGUNDA PARTE

Preguntas

Respuestas

1	C
2	E
3	E
4	B
5	C
6	A
7	D (hoy también es aceptable mantener los HGO, pero en este caso, por tener un mal control metabólico, la única opción aceptable es esa)
8	B
9	D
10	C
11	D
12	A
13	B
14	B
15	D
16	A
17	A
18	E
19	B

20	B
21	C
22	E
23	A
24	A
25	C
26	A
27	C
28	C
29	E
30	D
31	A
32	A
33	A
34	B
35	C
36	C
37	A
38	B
39	B
40	A
41	E
42	D
43	D
44	A
45	E
46	C
47	A
48	A
49	E
50	E

51	C
52	E
53	B
54	B
55	E
56	D
57	E
58	A
59	B
60	C
61	A
62	C
63	A
64	C (tema muy discutido, pero recomiendo dar ATB y luego retirar el DIU, aunque la evidencia no lo avale).
65	E
66	B
67	A
68	E
69	C
70	B
71	C
72	E
73	D
74	A
75	E
76	C
77	B
78	B
79	A
80	E
81	B (falta un grupo de control con características similares de edad, sexo, etc; sin

embargo también falta la secuencia temporal, aunque no sale en las alternativas)

82	C
83	D
84	E
85	A
86	D
87	C
88	A
89	D
90	C

Ensayo EUNACOM – Prueba 10

PRIMERA PARTE

1) Una paciente cursando diarrea y vómitos, de 2 días de evolución, presenta deterioro del estado general y oliguria. En sus exámenes de laboratorio destaca nitrógeno ureico: 50 mg/dl, Creatininemia: 5,6 mg/dl, potasio plasmático: 6,0 mEq/l, sodio urinario: 40 mEq/l. EL diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Obstrucción urinaria
- e) Insuficiencia renal crónica

2) Un hombre de 76 años presenta varios síncope en las últimas horas. Al examen físico está soporoso, hipoperfundido, tiene una frecuencia cardiaca de 34 latidos por minutos y una presión arterial de 86/48 mmHg. Se ausculta un primer ruido cardíaco de intensidad variable. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo AV completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Síncope vasovagal
- d) Síndrome coronario agudo
- e) Fibrilación auricular

3) Niña de 13 años presenta fiebre de baja intensidad, adenopatías occipitales, exantema maculopapular tenue en tronco y artralgias. No tiene inmunizaciones completas.

El diagnóstico más probable es:

- a) eritema infeccioso
- b) rubéola
- c) sarampión
- d) mononucleosis infecciosa
- e) escarlatina

4) Un niño de 5 años sufre una convulsión tónicoclónica, mientras jugaba con su madre. No ha presentado otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales (hemograma, pruebas hepáticas, electrolitos y pruebas de función renal). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Convulsión febril benigna
- b) Epilepsia
- c) Tumor cerebral
- d) Meningitis viral
- e) Síndrome hemolítico urémico

5) Una mujer de 20 años, puerpera hace 5 días, consulta por fiebre hasta 38,6°C y dolor mamario. Al examen físico se aprecia eritema de ambas mamas, mayor a izquierda, doloroso a la palpación, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar cabergolina
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Iniciar penicilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- e) Iniciar eritromicina oral

6) Mujer de 30 años, asintomática, se detecta hace una semana un nódulo en el cuello. Al examen físico se confirma nódulo cervical bajo de 2 x 3 cm al lado derecho, firme y no doloroso. El resto del examen físico es normal. Tiene hemograma, perfil hepático y lactato deshidrogenasa normales. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento del mediastino superior concordante con adenopatías.

¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Enfermedad por arañazo de gato
- c) Linfoma
- d) Metástasis de carcinoma digestivo
- e) Tuberculosis

7) La manifestación clínica más frecuente en la etapa sintomática de la infección por VIH es:

- a) tuberculosis
- b) neumonía por *Pneumocystis carinii*
- c) sarcoma de Kaposi
- d) Herpes zoster
- e) candidiasis de mucosas

8) Paciente de 26 años, dos hijos vivos, puérpera de 30 días de un parto vaginal, dando actualmente lactancia exclusiva. Entre sus antecedentes destacan una endometritis severa en el puerperio y alergia al látex. Desea un método anticonceptivo.

¿Cuál de los siguientes es el más recomendable para esta paciente?

- a) Preservativo.
- b) Dispositivo intrauterino
- c) Progestágeno solo.
- d) Etinil estradiol + Progestágeno.
- e) Esterilización.

9) La menopausia aumenta el riesgo de:

- a) osteoporosis
- b) cáncer de mama
- c) diabetes mellitus
- d) cáncer de ovario
- e) hiperplasia endometrial

10) Un paciente de 18 años, alérgico a los macrólidos y a los betalactámicos, consulta por un cuadro de odinofagia, tos seca y rinorrea, de 12 días de evolución, que en las últimas 48 horas se han acompañado de malestar general, disnea y fiebra hasta 38,5°C. Se solicita radiografía de tórax que muestra un infiltrado alveolointersticial bilateral difuso, mayor en la base izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona
- b) Iniciar vancomicina
- c) Iniciar clindamicina
- d) Iniciar azitromicina
- e) Iniciar levofloxacino

11) Un hombre de 63 años consulta en urgencia por presentar desde hace 55 minutos palpitaciones sostenidas, rápidas e irregulares.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Fibrilación auricular paroxística
- c) Extrasistolia ventricular polimorfa
- d) Torsades de Pointes (torsión de las puntas)
- e) Bloqueo aurículo-ventricular avanzado

12) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hipocalcemia?

- a) Constipación, poliuria, astenia y acortamiento del segmento QT
- b) Poliuria, desorientación, taquicardia y parestesias
- c) Debilidad, espasmos musculares, hiperreflexia y arritmias
- d) Ensanchamiento del complejo QRS, ondas T picudas y debilidad muscular
- e) Tetraparesia, arreflexia y disminución del tono muscular

13) ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar hipokaliemia con normotensión arterial?

- a) Adenoma suprarrenal
- b) Estenosis bilateral de arterias renales
- c) Hiperplasia suprarrenal
- d) Tumor secretor de renina
- e) Abuso de laxante

14) Una mujer de 26 años sufre caída apoyándose en la mano derecha, con el codo en extensión. Evoluciona con dolor e impotencia funcional del codo, asociado a leve aumento de volumen. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura supracondílea
- b) Luxación de codo
- c) Fractura de olécranon
- d) Fractura de cúpula radial
- e) Fractura de epitroclea

15) ¿Cuál de los siguientes medicamentos esta contraindicado en el infarto agudo del miocardio?

- a) Nifedipino
- b) Enalapril
- c) Lidocaina
- d) Heparina
- e) Tiazidas

16) El agente etiológico más frecuente en las neumonías de pacientes con bronquitis crónica es:

- a) Haemophilus influenzae
- b) Legionella pneumophila
- c) Staphylococcus aureus
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Moraxella (Branhamella) catharralis

17) Un hombre de 44 años insiste que su jefe quiere perjudicarlo y que le asigna tareas y actividades con el fin de hacerle daño, humillarlo y tratarlo mal. Se evalúa el ambiente laboral de la empresa en que trabaja y parece ser bueno. La familia del paciente niega los malos tratos de parte del jefe. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno psicótico breve
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno delirante crónico

18) La inserción velamentosa del cordón se asocia a:

- a) rotura prematura de membranas.
- b) hemorragia fetal antes del parto.
- c) torsión del cordón umbilical.
- d) malformaciones fetales.
- e) malformaciones uterinas.

19) Una mujer embarazada, de 38 semanas de gestación se realiza un test de tolerancia a las contracciones que muestra frecuencia cardíaca fetal basal: 105 lpm, variabilidad 3 lpm, presencia de aceleraciones y presencia de desaceleraciones variables. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía doppler de arterias uterinas
- b) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales
- c) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- d) Observar evolución, bajo monitorización con registro cardíaco fetal
- e) Solicitar perfil biofísico

20) La recomendación más apropiada en un paciente anciano que sufre una caída por hipotensión ortostática es:

- a) indicar vasoconstrictores
- b) aumentar la ingesta de líquidos.
- c) usar medias elásticas.
- d) ácido acetilsalicílico 100 mg/día.
- e) aumentar la ingesta de sal.

21) Un niño de 10 meses presenta fiebre hasta 38,5°C. No presenta otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas
- b) Solicitar sedimento de orina, urocultivo y hemograma
- c) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar en 24 horas
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de tórax y decidir conducta según hallazgos
- e) Solicitar hemograma, hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de tórax e iniciar antibióticos de amplio espectro, por vía endovenosa

22) En un screening para diagnosticar una determinada enfermedad, 235 de 250 personas enfermas resultan positivas para el test aplicado y 600 de 680 personas normales resultan negativas para el mismo test.

La especificidad del test empleado es:

- a) 15/250
- b) 80/680
- c) 15/80
- d) 235/250
- e) 600/680

23) Embarazada de 34 semanas consulta por metrorragia. Al examen se advierte útero hipertónico con 3 cms de dilatación cervical y latidos cardiorfetales normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar una operación cesárea
- b) Indicar tocolisis y corticoides
- c) Realizar rotura artificial de membranas y esperar parto vaginal
- d) Administrar sulfato de magnesio y practicar monitoreo fetal
- e) Mantener vía venosa permeable y realizar perfil biofísico

24) La situación que mejor expresa el control de los factores de riesgo de enfermar, es la disminución de la tasa de:

- a) letalidad.
- b) prevalencia.
- c) mortalidad.
- d) incidencia.
- e) ataque secundario.

25) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se identifica frecuentemente en la colitis ulcerosa?

- a) Absceso perianal
- b) Masa abdominal palpable
- c) Compromiso del intestino delgado
- d) Fístula enterocutánea
- e) Pseudopólipos intestinales

26) Hombre de 24 años, sin antecedentes mórbidos. Luego de una ingesta exagerada de alimentos y alcohol, presenta vómitos violentos, seguidos de hematemesis.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Várices esofágicas.
- b) Síndrome de Mallory Weiss.
- c) Úlcera duodenal.
- d) Úlcera gástrica.
- e) Gastritis aguda erosiva.

27) Paciente múltipara de dos en trabajo de parto, cuyo monitoreo muestra una FC fetal basal de 130/min, buena variabilidad y presencia de aceleraciones.

La rotura artificial de membranas da salida a un líquido con meconio amarillo verdoso.

¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir?

- a) Interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea
- b) Reanimación fetal in útero con reevaluación en 20 minutos
- c) Reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo
- d) Mantener una conducta expectante y permitir que continúe el trabajo de parto
- e) Interrupción inmediata por la vía más expedita

28) Un paciente de 70 años, fumador, presenta una placa blanquecina indolora en la cara lateral de la lengua, de lento crecimiento, a lo largo de 5 años, con 2×3 cm de diámetro. Al examen es imposible removerla. La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar corticoides tópicos
- b) Realizar biopsia de la lesión
- c) Aplicar antimicóticos tópicos
- d) Indicar antimicóticos orales
- e) Observar evolución

29) Un paciente de 40 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor muy intenso en la zona dorsal alta, de 4 horas de evolución, que inició de manera súbita luego de levantar una caja. Al examen físico presenta signos vitales normales y se constata dolor importante a la flexión y rotación lateral a derecha de la columna dorsal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de columna dorsal
- b) Solicitar ecografía de partes blandas
- c) Solicitar TAC de columna dorsal
- d) Solicitar RMN de columna
- e) Indicar AINES y reposo relativo

30) Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal intenso, de un día de evolución, constante, asociado a vómitos y sensación febril. Al examen físico se constata dolor a la palpación epigástrica y fiebre, sin signos de irritación peritoneal. Se solicita hemograma que muestra leucocitosis, pruebas hepáticas y lipasa que resultan normales y una ecografía abdominal que muestra dilatación de la vesícula biliar, con presencia de un cálculo impactado en el bacinete, edema de la pared y presencia de barro biliar. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Administrar analgésicos y cristaloides por vía endovenosa e indicar régimen cero
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Administrar analgésicos y antibióticos y realizar cirugía diferida

31) El tratamiento inicial de una meno-metrorragia importante en una paciente con miomatosis uterina es:

- a) Raspado uterino
- b) Histerectomía
- c) Progesterona
- d) Miomectomía
- e) Retractores uterinos

32) La lesión de la cintilla óptica izquierda se traduce clínicamente es:

- a) Hemianopsia heterónima binasal
- b) Hemianopsia heterónima bitemporal
- c) Hemianopsia homónima derecha
- d) Hemianopsia homónima izquierda
- e) Amaurosis

33) Una paciente de 60 años se realiza un Papanicolaou que es informa atrofia marcada, sin visualización de células atípicas. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el PAP en un año
- b) Repetir el PAP de inmediato
- c) Administrar estrógenos locales y repetir el PAP en 3 meses
- d) Derivar a colposcopia y biopsia
- e) Realizar cono cervical

34) ¿Cómo debe tratar una escarlatina en un paciente alérgico a los betalactámicos?

- a) Macrólidos
- b) Quinolonas
- c) Aminoglicósidos
- d) Vancomicina
- e) Cefazolina

35) Una paciente de 29 años consulta por fiebre, astenia, mialgias y debilidad, especialmente de las extremidades superiores, de predominio proximal. Además presenta eritema de los hombros y la zona superior del tronco. Se solicitan exámenes que demuestran anemia normocítica, con VHS de 45 mm/h, ANA(+), ANCA(-) y creatinfosfoquinasas muy elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Vasculitis de Wegener
- c) Polimialgia reumática
- d) Vasculitis de Takayasu
- e) Dermatomiositis

36) Una paciente presenta hipoacusia derecha que ha aumentado en el último tiempo. La otoscopia no muestra alteraciones por lo que se realizan pruebas de diapasones, que muestran Rinne (+) a izquierda y (-) a derecha y Weber que lateraliza a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otitis media fibroadesiva
- c) Otosclerosis
- d) Sordera súbita
- e) Trauma acústico

37) Una paciente de 67 años consulta por dolor de la rodilla derecha, especialmente al caminar largas distancias. Al examen físico se aprecia movilidad completa dolorosa en la flexión extrema y signos de derrame articular. La radiografía muestra disminución del espacio articular y el estudio del líquido sinovial muestra un líquido filante, transparente, con 10 células por mm³. El tratamiento de primera línea de la patología descrita es:

- a) Paracetamol
- b) Indometacina
- c) Prednisona
- d) Metotrexato
- e) Ciclofosfamida

38) Un paciente de 56 años, cirrótico por consumo crónico de alcohol, consulta por aumento del perímetro abdominal, asociado a dolor abdominal. Al examen físico se aprecia tinte subictérico de las escleras, abdomen con matidez desplazable y signos de la ola. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 100 UI/l, GPT: 69 UI/l, GGT: 120 UI/l, FA: 120 UI/l, Bili total: 2,8 mg/dl, Bili directa: 2,0 mg/dl. Se realiza paracentesis que muestra salida de líquido peritoneal amarillo, transparente con proteínas de 2,0 g/dl, 350 células por mm³, con 90% de polimorfonucleares. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar antibióticos endovenosos
- c) Realizar paracentesis evacuadora
- d) Realizar paracentesis evacuadora e iniciar antibióticos endovenosos
- e) Iniciar furosemida + espironolactona

39) Un paciente presenta debilidad de las extremidades inferiores. Al examen físico se constata atrofia muscular y debilidad de predominio distal, con presencia de fasciculaciones y disminución del tono muscular y abolición de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Polineuropatía (denervación)
- d) Síndrome piramidal
- e) Síndrome extrapiramidal

40) Un paciente de 34 años consulta por dolor periocular izquierdo muy intenso, asociado a ptosis, epifora y rinorrea ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia primaria del trigémino
- b) Neuralgia secundaria del trigémino
- c) Cefalea en racimo (cluster)
- d) Infarto de troco cerebral
- e) Glaucoma agudo

41) Un paciente presenta hipercalcemia e hipofosfemia, asociadas a litiasis renal y osteoporosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal crónica
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hiperparatiroidismo secundario
- d) Hipercalcemia maligna
- e) Hipervitaminosis D

42) El tratamiento correcto de un hematoma del pabellón auricular consiste en:

- a) hielo local y antibióticos profilácticos.
- b) excisión del hematoma.
- c) aspiración con aguja y jeringa.
- d) observación.
- e) incisión, drenaje y vendaje compresivo.

43) Paciente de 50 años, con tos y expectoración de 3 días de evolución, asociado a disnea. Al examen físico presenta FR: 22x', PA: 120/80, FC: 99x', t°: 37,8°C. Se auscultan crépitos localizados en la base izquierda, con broncofonía. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo inferior izquierdo. El antimicrobiano de elección es:

- a) Clindamicina
- b) Cefuroxima
- c) Ceftriaxona
- d) Amoxicilina
- e) Metronidazol

44) Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina suelen presentar los siguientes efectos secundarios:

- a) Boca seca, constipación e hipotensión ortostática.
- b) Sedación y priapismo.
- c) Inquietud, temblor y convulsiones.
- d) Nausea, insomnio y disfunción sexual.
- e) Confusión y pérdida de memoria.

45) El trastorno bipolar se caracteriza por:

- a) presencia de episodio maníaco, hipomaníaco o mixto
- b) presencia de episodios maníacos y depresivos mayores
- c) fluctuación del ánimo entre depresión y manía
- d) antecedente de al menos un episodio depresivo mayor
- e) presencia de distimia

46) Un niño de 4 años consume una sustancia desconocida, evolucionando con agitación psicomotora, sequedad bucal, midriasis, ileo intestinal, taquicardia, sudoración y confusión. El cuadro clínico corresponde a un síndrome:

- a) Narcótico
- b) Opiáceo
- c) Muscarínico
- d) Anticolinérgico
- e) Adrenérgico

47) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos tiene más probabilidad de desencadenar una insuficiencia respiratoria global?

- a) Atelectasia subsegmentaria por cuerpo extraño.
- b) Intoxicación por benzodiazepinas.
- c) Pleuresía tuberculosa.
- d) Neumonía lobar.
- e) Neumonitis intersticial.

48) Una paciente de 65 años, con 15 años de amenorrea y con antecedente de cáncer de mama tratado con tamoxifeno, presenta metrorragia de 3 días de evolución. La ecografía transvaginal demuestra un endometrio de 12 mm, de ecogenicidad heterogénea, sin presencia de miomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Atrofia endometrial
- c) Adenomiosis
- d) Endometritis
- e) Endometriosis

49) Un paciente de 5 años consulta por otalgia derecha intensa, asociada a otorrea. Al examen físico se aprecia eritema difuso del conducto auditivo externo, con secreción purulenta. El tratamiento más adecuado es:

- a) Analgésicos y amoxicilina oral
- b) Analgésicos y ciprofloxacino tópico
- c) Analgésicos y ceftazidima endovenosa
- d) Analgésicos y cloxacilina oral
- e) Analgésicos y penicilina intramuscular

50) Lactante de 18 meses de edad, inasistente a controles de salud. Se comprueba inmunizaciones hasta la vacuna de los 6 meses. (Para efectos de esta pregunta no considere la vacuna antineumocócica conjugada, que actualmente está indicada a los 2,4,6 y 12 meses de edad).

Se debe vacunar con:

- a) DPT y polio ahora / En 2 meses parotiditis-rubéola-sarampión
- b) Parotiditis-rubéola-sarampión ahora / En 2 meses DPT y polio
- c) DPT y polio ahora / En 1 mes parotiditis-rubéola-sarampión
- d) DPT, polio y parotiditis-rubéola-sarampión, todas ahora
- e) DPT, polio y parotiditis-rubéola-sarampión, todas en 2 meses más

51) La nefropatía diabética inicial se define como:

- a) Microalbuminuria, asociada a elevación discreta de la creatinina plasmática
- b) Macroalbuminuria, asociada a elevación discreta de la creatinina plasmática
- c) Microalbuminuria, con creatininemia normal
- d) Macroalbuminuria, con creatininemia normal
- e) Proteinuria significativa, con creatininemia normal

52) En una esquizofrenia incipiente sin agitación, el tratamiento farmacológico de elección es:

- a) Medicación ansiolítica
- b) Antidepresivo tricíclico
- c) Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
- d) Neuroléptico de depósito
- e) Neuroléptico oral

53) Lactante de 12 meses de edad, que consulta en policlínico por un cuadro febril de 5 días de evolución, sin gran compromiso del estado general. Examen físico normal.

El sedimento presenta leucocituria y bacteriuria significativa.

El cultivo demuestra Escherichia coli, más de 100.000 colonias por ml.

El tratamiento más apropiado es:

- a) cotrimoxazol
- b) cefadroxilo
- c) nitrofurantoína
- d) cefotaxima
- e) amikacina

54) ¿Cuál de los siguientes marcadores inmunológicos es útil en el diagnóstico de la cirrosis biliar primaria?

- a) Anticuerpo antinuclear
- b) Anticuerpo antimúsculo liso
- c) Anticuerpo antigliadina
- d) Anticuerpo antimitocondrial
- e) Anticuerpo antiendomisio

55) ¿Cuál de los siguientes exámenes es el más eficaz para diagnosticar endometriosis?

- a) Tomografía axial computada pelviana
- b) Ecotomografía transvaginal
- c) Ca 125 plasmático
- d) Laparoscopia
- e) Histerosalpingografía

56) Un recién nacido prematuro de 7 días de vida, alimentado exclusivamente con leche materna, presenta ictericia desde hace 3 días, que compromete hasta los muslos. Su grupo sanguíneo es O, Rh(-) y la bilirrubina total alcanza los 10 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Hemólisis por incompatibilidad de grupo Rh
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia por lactancia materna
- e) Atresia biliar primaria

57) Un paciente con antecedente de hiperplasia benigna de la próstata, en tratamiento con tamsulosina, consulta por imposibilidad de orinar, de 6 horas de evolución, asociado a intenso dolor abdominal. Al examen físico se palpa globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cistostomía suprapúbica
- b) Drenar con sonda Nelaton
- c) Instalar sonda Foley a permanencia
- d) Indicar sondeo vesical intermitente
- e) Administrar anticolinérgicos endovenosos

58) Un paciente de 33 años, sin antecedentes previos de patologías ni de consumo de sustancias, presenta un cuadro caracterizado por movimientos involuntarios de la extremidad inferior izquierda, seguido de desconexión del medio y finalmente una convulsión tónicoclónica de 3 minutos de duración. Al examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma
- b) Solicitar resonancia magnética cerebral
- c) Iniciar carbamazepina oral a permanencia
- d) Administrar lorazepam endovenoso
- e) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio, indicando control en caso de volver a presentar síntomas

59) Lactante de 8 meses de edad, nacido de término. Actualmente asintomático, eutrófico.

Se observa palidez. El resto del examen físico y el desarrollo psicomotor son normales.

Se solicita un hemograma, cuyo resultado es:

Hematocrito: 26%, hemoglobina: 7,5 g / dl., Volumen Corpuscular Medio: 68, Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media: 27, reticulocitos: 2%, Plaquetas 285.000 / mm³. Usted diagnostica anemia:

- a) por déficit de folato
- b) fisiológica
- c) por déficit de hierro
- d) aplástica
- e) hemolítica

60) Un recién nacido de 35 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria luego de nacer, que responde a oxígeno al 28%. Al examen físico se auscultan escasos crépitos en las bases. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita cianótica
- b) Cardiopatía congénita acianótica
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Neumonía neonatal
- e) Taquipnea transitoria

61) Las características principales del trastorno de personalidad limítrofe son:

- a) Autoestima baja e inseguridad
- b) Escisión, agresividad e impulsividad
- c) Inseguridad y dificultad para mostrar desacuerdo
- d) Apatía y falta de motivación
- e) Ideas de referencia y estilo de vida "extraño"

62) ¿Cuál de los siguientes trastornos se caracteriza por la simulación y autoprovocación de síntomas?

- a) Hipocondríaco
- b) Disociativo
- c) Facticio
- d) Conversivo
- e) De somatización

63) La mejor imagen para evaluar un nódulo tiroideo, con TSH normal, es:

- a) Cintigrafía con yodo radiactivo
- b) Ecografía
- c) TAC
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Radiografía

64) Un escolar con hepatitis A se debe hospitalizar si:

- a) las transaminasas se mantienen elevadas por más de un mes
- b) la bilirrubinemia es mayor de 12 mg/dl
- c) el tiempo de protombina es igual o menor a 30%
- d) presenta anorexia persistente
- e) presenta intenso prurito

65) Una niña de 4 años presenta metrorragia escasa, con leucorrea de mal olor, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Tricomoniasis
- b) Vulvovaginitis inespecífica
- c) Cuerpo extraño vaginal
- d) Vulvovaginitis estreptocócica
- e) Abusos sexual

66) ¿Cuál de las siguientes situaciones es más sugerente de una insuficiencia suprarrenal crónica primaria?

- a) Hiperpigmentación cutánea asociada a hipokalemia severa
- b) Debilidad muscular asociada a hiperglicemia severa
- c) Hipotensión sostenida en presencia de hiperkalemia
- d) Hipotensión sostenida en presencia de hipernatremia
- e) Debilidad muscular asociada a hipernatremia e hiperkalemia

67) El hallazgo de un soplo pansistólico 3/6 en el 5to espacio intercostal izquierdo en el borde esternal en un lactante de un mes, sugiere la presencia de:

- a) comunicación interauricular de pequeño shunt.
- b) comunicación interventricular.
- c) conducto arterioso permeable.
- d) coartación de la aorta.
- e) soplo inocente

68) ¿Cuál de las siguientes situaciones requiere profilaxis antibiótica para el Estreptococo grupo B, en una paciente que inició el trabajo de parto?

- a) Antecedente de rotura prematura de membranas de 5 horas de evolución
- b) Edad gestacional de 36 semanas
- c) Antecedente de preclamsia
- d) Antecedente de diabetes mellitus gestacional
- e) Antecedente de colestasia intrahepática del embarazo

69) La edad máxima aceptable para el cierre del bregma en un niño normal es:

- a) 6 meses
- b) 10 meses
- c) 12 meses
- d) 18 meses
- e) 24 meses

70) La medida más eficiente para prevenir la agitación psicomotora nocturna, en un paciente geriátrico, con demencia moderada, internado en un asilo, es:

- a) Administrar benzodiazepinas
- b) Administrar antipsicóticos
- c) Realizar contención mecánica
- d) Aumentar la ingesta de frutas, verduras y otros alimentos ricos en vitaminas del complejo B
- e) Realizar caminatas y otros ejercicios durante el día

71) La forma más certera de diagnosticar edad gestacional en el tercer trimestre de embarazo es:

- a) biometría por ecografía.
- b) altura uterina medida en centímetros.
- c) fecha de última regla segura.
- d) momento de inicio de percepción de movimientos fetales.
- e) evaluación de líquido amniótico por amniocentesis.

72) El tratamiento farmacológico de elección para lograr la completa remisión del trastorno de estrés postraumático (TEPT) es:

- a) Antipsicóticos
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos
- d) Benzodiacepinas
- e) Metilfenidato (derivado anfetamínico)

73) ¿Cuál es la utilidad de emplear el agujero estenopecico en la consulta médica general?

- a) Reconocer la presencia de cataratas.
- b) Diferenciar causas refractivas de otras patologías oculares.
- c) Identificar magnitud del daño retinal en la retinopatía diabética no proliferativa.
- d) Calcular la presión intraocular.
- e) Facilitar el examen del fondo de ojo.

74) Las complicaciones cardiovasculares postoperatorias son más frecuentes en pacientes con antecedentes de:

- a) hipertensión arterial
- b) insuficiencia cardíaca
- c) edad mayor de 65 años
- d) fibrilación auricular
- e) angina de pecho

75) Un tumor de colon palpable por vía abdominal, se ubica probablemente en:

- a) colon sigmoides
- b) región cecal del colon
- c) angulo esplénico del colon
- d) colon izquierdo
- e) unión rectosigmoidea

76) Un paciente con epigastralgia crónica se realiza una endoscopia digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal, sin estigmas de sangrado. La biopsia gástrica demuestra una gastritis crónica atrófica y presencia de Helicobacter pylori. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar omeprazol a permanencia
- c) Solicitar test de ureasa
- d) Erradicar Helicobacter pylori
- e) Resolver quirúrgicamente

77) Lactante menor, que según tablas vigentes (NCHS), presenta una relación peso/edad de +1 desviación standard, peso/talla normal y talla/edad de +1 desviación standard.

¿Cuál es su diagnóstico nutricional?

- a) Obeso
- b) Sobrepeso
- c) Eutrófico
- d) Riesgo de desnutrición
- e) Desnutrido

78) Un paciente de 57 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y metformina en dosis máxima desde hace 6 meses, sin daño a órgano blanco, presenta hemoglobina glicosilada de 8% y varios hemoglucotest sobre los niveles óptimos. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- b) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- c) Agregar glibenclamida oral al tratamiento
- d) Iniciar insulina cristalina junto con las comidas
- e) Iniciar insulina NPH en dos dosis diarias

79) ¿Qué parámetro permite estimar, de mejor manera, la proporción de casos de una enfermedad que se prevendrían si se retirara el factor de riesgo en el grupo de los pacientes expuestos?

- a) Riesgo atribuible poblacional
- b) Riesgo relativo
- c) Likelihood ratio
- d) Riesgo atribuible porcentual
- e) Tasa de incidencia

80) ¿Cuál de los siguientes hemogramas es más característico de una leucemia linfóide crónica?

- a) Hematocrito: 30%, plaquetas: 140.000 x mm³, blancos: 29.000 x mm³, 90% linfocitos, 8% segmentados, 2% monocitos
- b) Hematocrito: 45%, plaquetas: 460.000 x mm³, blancos: 35.000 x mm³, 10% linfocitos, 60% segmentados, 20% baciliformes, 5% mielocitos, 3% blastos, 2% monocitos
- c) Hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000 x mm³, blancos: 2.000 x mm³, 80% linfocitos, 20% segmentados
- d) Hematocrito: 35%, plaquetas: 100.000 x mm³, blancos: 18.000 x mm³, 50% linfocitos, 25% segmentados, 25% monocitos
- e) Hematocrito: 40%, plaquetas: 240.000 x mm³, blancos: 16.000 x mm³, 80% linfocitos, 15% segmentados, 5% monocitos

81) Un examen diagnóstico tiene sensibilidad: 90%, especificidad: 85%, valor predictivo positivo: 50%, valor predictivo negativo: 98%. Un paciente se realiza dicho examen y resulta positivo. ¿Qué probabilidad tiene de estar enfermo?

- a) 90%
- b) 85%
- c) 50%
- d) 98%
- e) 100%

82) Una paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca y en el examen físico se observa “danza arterial” en el cuello, se palpa un pulso de gran amplitud y se ausculta un soplo paraesternal, diastólico, de intensidad III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Insuficiencia mitral
- c) Estenosis aórtica
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

83) ¿Qué caracteriza a una dermatitis de contacto aguda?

- a) Pápulas y pústulas
- b) Eritema, microvesículas, rezumación
- c) Aumento del cuadrículado cutáneo.
- d) Descamación y liquenificación
- e) Hiperpigmentación y prurito

84) El tratamiento más adecuado ante la sospecha de absceso perianal profundo es:

- a) drenaje quirúrgico.
- b) administrar antibióticos para Gram (-) y anaerobios.
- c) esperar fluctuación del absceso aplicando calor húmedo.
- d) punción
- e) baños de asiento

85) Paciente de 25 años, traído al servicio de urgencia por agitación psicomotora, ideofugacidad y verborrea desde hace dos días.

¿Cuál de los siguientes tratamientos inmediatos es el más adecuado?

- a) Clorpromazina 25 mg intravenosa
- b) Haloperidol 5 mg intramuscular
- c) Midazolam 5 mg intramuscular
- d) Diazepam 10 mg intramuscular
- e) Lorazepam 2 mg intramuscular

86) Un paciente de 30 años consulta por fiebre y presencia de un exantema macular generalizado, con compromiso de palmas y plantas. Se solicita VDRL y FTA-ABS que resultan positivos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina benzatina
- b) Iniciar ciprofloxacino
- c) Iniciar doxiciclina
- d) Iniciar metronidazol
- e) Observar evolución

87) Una mujer de 40 años, con antecedente de una hemiparesia derecha, consulta por imposibilidad de ver con el ojo izquierdo, que se instaló en 8 horas. Actualmente presenta amaurosis izquierda total, asociada a un defecto pupilar aferente.

El diagnóstico más probable es:

- a) Apoplejía hipofisiaria
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Esclerosis múltiple
- d) Tumor cerebral
- e) Accidente vascular encefálico

88) Un paciente de 70 años pierde súbitamente la visión del ojo derecho. Al examen se aprecia pérdida del rojo pupilar de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Catarata
- b) Hemorragia vítrea
- c) Glaucoma agudo
- d) Trombosis de la arteria central de la retina
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

89) Una mujer embarazada Rh negativa se realiza una prueba de Coombs indirecto a las 28 semanas, que resulta negativa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Coombs directo materno
- b) Solicitar Coombs directo fetal
- c) Solicitar ecografía transvaginal
- d) Administrar una dosis de inmunoglobulina anti-D (Rhogam)
- e) Observar evolución, sin necesidad de administrar fármacos

90) Un niño de 6 años presenta un cuadro meníngeo, que se estudia mediante punción lumbar, que da salida a un líquido con 1.200 células por mm³, con 95% de polimorfonucleares, glucosa: 30 mg/dl y proteínas: 160 mg/dl. El agente etiológico más probable es:

- a) Bacilo de Koch
- b) Enterovirus
- c) Neumococo
- d) Virus herpes simplex
- e) Estafilococo áureo

SEGUNDA PARTE

1) Paciente de 26 años consulta por presentar, desde la adolescencia, miedo intenso y persistente a hablar en público, por temor a ser mal evaluado por los demás. A causa de ello no asiste a dar su examen de título. Se descarta patología somática concomitante.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por ansiedad generalizada
- b) Fobia Social.
- c) Agorafobia.
- d) Fobia específica, tipo ambiental.
- e) Fobia específica, tipo situacional.

2) Un paciente de 17 años sufre dos síncope en relación al esfuerzo. Al examen físico presenta un pulso amplio, regular, a 72 lpm, con presión arterial normal. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, mayor paraesternal izquierdo. Se solicita un electrocardiograma que muestra onda T negativa en algunas derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Estenosis aórtica
- d) Estenosis mitral
- e) Angina inestable

3) En un paciente con una placa blanquecina reticulada adherente en mucosa yugal, la primera posibilidad diagnóstica es:

- a) Cáncer oral
- b) Candidiasis
- c) Liquen plano
- d) Estomatitis aftosa recurrente
- e) Línea alba

4) Un paciente de 60 años, fumador importante, consulta por disnea de esfuerzos moderados. Al examen físico se aprecia aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ruidos cardíacos apagados y murmullo pulmonar disminuido globalmente, con algunas sibilancias escasas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que muestra aplanamiento del diafragma. Además de dejar de fumar, la conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de metacolina
- b) Solicitar espirometría
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Iniciar corticoides inhalados según horario, asociados a salbutamol inhalado según síntomas
- e) Iniciar corticoides orales, asociados a salbutamol inhalado según síntomas

5) La etiología más frecuente de leucorrea patológica en mujeres adultas es:

- a) gonococo.
- b) oxiuros.
- c) candida.
- d) anaerobios.
- e) tricomonas.

6) Un niño de 6 años presenta astenia, baja de peso, enuresis nocturna y aumento de la ingesta de agua. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal
- b) Insuficiencia renal
- c) Diabetes mellitus 1
- d) Polidipsia primaria
- e) Acidosis tubular

7) El tratamiento de elección después de una segunda convulsión febril en un lactante es:

- a) fenobarbital por 2 años
- b) fenitoína por 2 años
- c) ácido valproico por 3 años
- d) carbamazepina por 2 años
- e) diazepam en las alzas térmicas

8) Debe sospecharse hipotiroidismo congénito en todo recién nacido que presente:

- a) irritabilidad
- b) bajo peso para la edad gestacional
- c) ictericia prolongada
- d) temblor fino
- e) llanto frecuente

9) En un ensayo clínico se determinó que un fármaco presenta un número necesario para dañar (NNH) de 7. Esto quiere decir que:

- a) El 7% de los pacientes que utilizan el fármaco presentan alguna reacción inconveniente
- b) Uno de cada 7 pacientes que utilizan el fármaco presentan algún efecto negativo causado por el fármaco
- c) Los pacientes que consumen el fármaco tienen 7 veces más probabilidades de presentar efectos adversos que los que no lo consumen
- d) El fármaco presenta un alto perfil de seguridad
- e) Se puede administrar hasta un máximo de 7 veces la dosis terapéutica, antes de producir efectos negativos importantes

10) En un niño de 4 años con un púrpura trombocitopénico idiopático, con escasas manifestaciones hemorragíparas y recuento plaquetario de 70.000 por mm, la conducta correcta es indicar:

- a) concentrado de plaquetas
- b) corticoides orales
- c) transfusión de glóbulos rojos
- d) reposo y observación cuidadosa
- e) gamma globulina endovenosa en altas dosis

11) Una paciente de 33 años consulta por nerviosismo y dolor cervical. Al examen se palpa bocio difuso, doloroso a la palpación. Presenta TSH: 0,1 y T4: 20 mcg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento de esta patología es:

- a) Iniciar levotiroxina (levo-T4)
- b) Iniciar antitiroideos
- c) Administrar yodo radiactivo
- d) Iniciar triyodotironina (T3)
- e) Indicar AINEs

12) Un niño de 8 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre hasta 38,6°C, de 7 días de evolución, que en el último tiempo se ha acompañado de orinas oscuras e ictericia. Se solicitan exámenes generales, en los que destaca bilirrubina total: 6,2 mg/dl, bilirrubina directa: 5,3 mg/dl, GGT: 130 UI/l, GOT: 1.206 UI/l, GPT: 988 UI/l, FA: 213 UI/l, TP: 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia biliar primaria
- b) Colédocolitiasis
- c) Hepatitis A
- d) Síndrome hemolítico urémico
- e) Microesferocitosis familiar

13) ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una contraindicación absoluta para la terapia de sustitución en una mujer postmenopáusica de 52 años?

- a) Hipercolesterolemia
- b) Hipertensión arterial
- c) Diabetes mellitus
- d) Cáncer de mama
- e) Migrañas a repetición.

14) Un paciente de 8 años presenta un cuadro de cefalea y hematuria en varias oportunidades. Al examen físico se aprecia hipertenso, con edema facial y de extremidades inferiores. Se realizan exámenes que muestran creatininemia de 1,4 mg/dl, BUN: 33 mg/dl, orina completa con hematuria dismórfica y porteinuria ++. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hemolítico urémico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome nefrítico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Enfermedad de Berger

15) Mujer de 40 años, casada, 5 hijos, relata angustiada que hace una semana vió al diablo y teme ser agredida por él. Horas antes del episodio, se enteró de que su marido tenía una amante. Refiere un episodio similar hace dos años, al enterarse de la muerte de su madre. Su afecto es modulado, con un relato fluido y sin alteración del curso formal del pensamiento.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia paranoídea.
- b) Trastorno depresivo mayor recurrente con síntomas psicóticos.
- c) Trastorno de pánico.
- d) Trastorno bipolar, episodio maníaco.
- e) Trastorno disociativo.

16) ¿Cuál de las siguientes alternativas es más sugerente de una neuritis vestibular?

- a) Vértigo periférico, asociado a sensación de oído tapado y tinitus, de curso fluctuante
- b) Vértigo intenso, de segundos de duración que aparece al agacharse o al realizar otros movimientos con la cabeza
- c) Vértigo con nistagmos multidireccional, de inicio súbito y varias horas de evolución
- d) Vértigo con ataxia, dismetría y parálisis del nervio facial
- e) Vértigo intenso y persistente, con nistagmos horizontal de fase rápida a derecha, lateropulsiones a la izquierda, de inicio súbito

17) Ingresa un paciente con una fibrilación auricular rápida a 150 lpm, desorientado, disneico, sudoroso, con PA: 80/60 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en bolo
- c) Administrar adrenalina 1mg endovenoso
- d) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en infusión continua
- e) Realizar cardioversión eléctrica inmediata

18) En un paciente cirrótico con ascitis a tensión. ¿Cuál es el parámetro que mejor predice los resultados del tratamiento y evolución de la ascitis?

- a) Medición del perímetro abdominal
- b) Concentración del sodio plasmático
- c) Excreción de sodio en orina de 24 horas
- d) Protrombinemia
- e) Medición del volumen urinario de 24 horas

19) Hombre de 57 años, consulta en el servicio de urgencia por melena de 3 días de evolución sin dolor abdominal. Al examen presenta ortostatismo, conjuntivas pálidas, anictéricas, telangectasias en tórax superior, hepatoesplenomegalia, ruidos intestinales aumentados sin dolor a la palpación. Hematocrito: 30%. ¿Cuál es la conducta inmediata más apropiada?

- a) Efectuar endoscopia digestiva alta
- b) Colocar una sonda de Sengstaken-Blakemore
- c) Realizar lavado gástrico con suero fisiológico
- d) Colocar sonda nasogástrica a caída libre
- e) Colocar vía intravenosa y administrar volumen

20) Paciente en tratamiento por tuberculosis pulmonar que presenta las siguientes baciloscopías:

1er mes (+), 2do mes (-), 3er mes (-), 4to mes (+)

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Continuar tratamiento bisemanal con las mismas drogas
- b) Reiniciar la fase diaria de tratamiento
- c) Diagnosticar fracaso de tratamiento y derivar a centro especializado
- d) Solicitar cultivo de Koch; en espera del resultado cambiar tratamiento a drogas de 2a línea
- e) Suspender tratamiento, solicitar cultivo de Koch y decidir conducta de acuerdo a resultados.

21) ¿Cuál de los siguientes datos clínicos o de laboratorio constituye un factor de mal pronóstico en una enferma que inicia una artritis reumatoidea?

- a) Mayor edad
- b) Sobrepeso
- c) Leucocitosis
- d) Anemia
- e) Exantema

22) Un paciente presenta una taquicardia regular a 150 lpm, con complejo QRS de 0,10 segundos y con presencia de “ondas de serrucho” en las derivaciones DII y DIII. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Torsión de puntas
- c) Taquicardia ventricular
- d) Taquicardia paroxística supraventricular
- e) Flutter auricular

23) En el tratamiento del alcoholismo es útil la naltrexona, ya que actúa:

- a) Como un fármaco aversivo
- b) Como un fármaco desmotivante
- c) Sustituyendo el efecto del alcohol en el sistema nervioso central
- d) Aumentando la metabolización hepática del alcohol
- e) Disminuyendo la metabolización hepática del alcohol

24) Una paciente de 34 años acude a control ginecológico, en el que le palpan un tumor anexial izquierdo. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra un tumor anexial quístico de 4,2 cm de diámetro y de contenido anecogénico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia por punción con aguja fina
- b) Iniciar ACO y realizar seguimiento ecográfico
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Realizar ooforectomía bilateral
- e) Realizar tumorectomía laparoscópica

25) Paciente de 30 años ingresa con traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis estable y contusión pulmonar. Tres días después presenta una trombosis venosa profunda proximal a la rodilla.

La conducta más apropiada es:

- a) administrar trombolíticos sistémicos
- b) instalar un filtro en la vena cava inferior
- c) indicar compresión neumática intermitente
- d) iniciar tratamiento anticoagulante con heparina fraccionada
- e) indicar vendas de compresión elástica graduada y deambulacion precoz

26) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por constipación de un mes de evolución, que en las últimas horas se ha hecho mucho más marcada, siendo imposible eliminar gases ni deposiciones y presentando dolor abdominal tipo cólico y vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia distensión abdominal, con dolor a la palpación y aumento de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Íleo biliar
- b) Vólvulo de sigmoides
- c) Cáncer de colon
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Enfermedad diverticular complicada

27) Recién nacido de 3 semanas de vida, que presenta bronconeumonía y conjuntivitis.

La radiografía de tórax muestra infiltrado intersticial.

La etiología más probable es:

- a) *Treponema pallidum*
- b) *Chlamydia trachomatis*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Candida albicans*
- e) *Streptococcus pneumoniae*

28) Mujer de 54 años con secuelas pulmonares por tuberculosis, que consulta por una exacerbación infecciosa, presenta los siguientes gases arteriales, respirando aire ambiental: pH 7.431, $p\text{aO}_2$ 55 mmHg y $p\text{aCO}_2$ 54 mmHg.

¿Qué fracción inspirada de oxígeno es la adecuada para iniciar la corrección de la hipoxemia?

- a) 21 %
- b) 24 %
- c) 35 %
- d) 50 %
- e) 60 %

29) ¿Cuántos días antes de la fecha probable de parto comienza el período de descanso prenatal?

- a) 28 días
- b) 35 días
- c) 42 días
- d) 56 días
- e) 84 días

30) Paciente de 17 años previamente sano, consulta por presentar hace dos días un cuadro de diarrea líquida no disintérica, temperatura axilar de 37.5 C, sin deshidratación clínica.

¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

- a) Administración de antiespasmódicos.
- b) Suspensión de alimentación oral.
- c) Administración oral de antidiarreicos.
- d) Reposición de líquidos por vía oral.
- e) Administración de antibióticos.

31) Identifique la asociación incorrecta entre el tumor óseo y su característica:

- a) Osteocondroma – Reacción perióstica en sol naciente
- b) Osteosarcoma – Discontinuidad de la cortical ósea
- c) Osteoma osteoide – Dolor mayor en la noche
- d) Sarcoma de células gigantes – Rápido crecimiento y destrucción ósea local
- e) Sarcoma de Ewing – Rápido crecimiento en ubicación diafisaria

32) ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería recomendable en un paciente de 60 años con insuficiencia aórtica severa?

- a) Sólo bloqueadores de enzima de conversión
- b) Recambio valvular aórtico
- c) Plastía con balón
- d) Plastía quirúrgica
- e) Betabloqueadores.

33) Ante una niña de 10 años que consulta por aumento de volumen y dolor en zona retroareolar derecha, es válido suponer que:

- a) su Tanner mamario se encuentra en grado III
- b) su menarquia se presentará en los próximos 6 meses
- c) tiene una mastitis puberal derecha
- d) comenzará su fase de crecimiento acelerado
- e) el vello pubiano aparecerá en 18 a 24 meses más

34) Una mujer de 67 años presenta lesiones maculares hiperpigmentadas, de color homogéneo y bordes regulares, de hasta 4 mm de diámetro en el dorso de las manos y en la zona frontal. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevos melanocíticos
- b) Queratosis seborreicas
- c) Léntigos malignos
- d) Queratosis actínicas
- e) Lentigos solares

35) Un paciente con varicocele tiene indicación quirúrgica si:

- a) se asocia a disfunción eréctil.
- b) el reflujo venoso al doppler es mayor de 3 cm/s.
- c) el nivel de hormona folículoestimulante está elevado.
- d) hay oligoastenoespermia.
- e) se asocia a hematoespermia.

36) Un paciente diabético de 60 años, consulta por un cuadro de 3 días de visión de luces y puntos negros, al que hoy se le agregó pérdida de una parte importante de la visión del ojo derecho, permaneciendo con visión inferonasal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia vítrea
- b) Edema macular
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Desprendimiento de retina
- e) Glaucoma

37) El medio más útil para evaluar respuesta al tratamiento en un paciente con un ataque agudo de asma es la:

- a) evolución de la frecuencia cardíaca
- b) oximetría de pulso
- c) modificación de las sibilancias
- d) observación del uso de los músculos accesorios.
- e) determinación del flujo espiratorio máximo (PEF).

38) La anticoagulación con heparina no fraccionada y con heparina fraccionada se controla respectivamente con:

- a) TTPA y TP
- b) TP y TTPA
- c) TTPA y tiempo de sangría
- d) Tiempo de sangría y TTPA
- e) TTPA y no necesita control

39) El tratamiento no farmacológico de la litiasis renal cálcica, incluye la siguiente medida:

- a) Restringir la ingesta diaria de calcio en la dieta.
- b) Restringir la ingesta de proteínas de origen animal.
- c) Aumentar la ingesta de sal común.
- d) Restringir la ingesta de cítricos.
- e) Restringir la ingesta de líquidos azucarados.

40) Mujer de 57 años ha dejado de usar el transporte público, porque teme que la asalten. Por esto sale cada vez menos de su casa. También presenta miedo a que puedan entrar a su casa y le roben. No le gusta que sus hijos manejen, ya que siente que pueden chocar y morir, lo que le causa mucha angustia. Pareciera que está esperando que algo malo suceda. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de pánico
- c) Depresión mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Trastorno de personalidad evitativa

41) Un ensayo clínico pretende evaluar la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cuello uterino en el largo plazo. Sin embargo se sabe que la actividad sexual es un factor que se relaciona tanto con el uso de ACO como con el desarrollo de CCU. ¿Qué solución plantearía para evitar este problema?

- a) Realizar una aleatorización estratificada
- b) Aumentar el tamaño de la muestra
- c) Hacer doble ciego
- d) Utilizar métodos diagnósticos de CCU que sean sensibles y específicos
- e) Realizar el estudio sólo con mujeres que no mantengan actividad sexual

42) Una mujer de 36 años presenta amenorrea de 4 meses de evolución. Se realiza un test de embarazo en orina que resulta negativo y el examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de HCG
- b) Solicitar niveles plasmáticos de FSH y LH
- c) Solicitar TSH y prolactinemia
- d) Solicitar estradiol y progesterona plasmática
- e) Solicitar seguimiento folicular ecográfico

43) Un paciente de 34 años, presenta por primera vez presenta un cuadro de rápida instalación de dolor precordial, disnea, palpitaciones, sudoración, dificultad para tragar y parestesias en las extremidades superiores. El cuadro cede espontáneamente luego de 20 minutos. Los exámenes de laboratorio excluyen patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Hipocondría
- c) Trastorno adaptativo ansioso
- d) Crisis de pánico
- e) Trastorno de estrés agudo

44) Un paciente de 55 años consulta por tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y dolor tipo puntada de costado. Se realiza una radiografía de tórax que visualiza un derrame pleural izquierdo moderado, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con 1.200 células por mm³, 95% de polimorfonucleares, proteínas: 4,8 g/dl, LDH: 250 UI/l, pH: 7, ADA: 52 UI/l, lactato: 9 mmol/l. Las proteínas plasmáticas son: 6,5 g/dl y la LDH plasmática es: 280 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Derrame paraneumónico simple
- b) Empiema
- c) Cáncer
- d) Tuberculosis
- e) Transudado pleural

45) Una paciente de 35 años, cursando embarazo de 35 semanas, consulta por contracciones uterinas persistentes. Al examen físico presenta 2 contracciones cada 10 minutos y al tacto vaginal presenta un cm de dilatación y borramiento de 50%, con membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y tocolíticos
- b) Administrar tocolíticos
- c) Administrar tocolíticos y antibióticos de amplio espectro
- d) Administrar corticoides y antibióticos de amplio espectro
- e) Dejar a evolución espontánea

46) Un paciente de 29 años, con antecedente de una neumonía por adenovirus en la infancia, presenta un cuadro de varios años de evolución, de broncorrea mucosa, mayor en las mañanas, que en algunas ocasiones se vuelve mucopurulenta. Ha presentado varias infecciones respiratorias bajas y en oportunidades también ha presentado hemoptisis. El examen con mejor rendimiento para el diagnóstico es:

- a) Biopsia pulmonar
- b) TAC de cortes finos
- c) Radiografía de tórax
- d) Baciloscopías de expectoración + cultivo de Koch
- e) PPD

47) Una paciente de 33 años asintomática presenta elevación de las transaminasas en exámenes de chequeo, con GOT: 80 UI/l y GPT: 92 UI/l. La bilirrubina, GGT y fosfatasa alcalina son normales. Presenta ferritina de 360 ng/ml (VN: 50-150 ng/ml). Al examen físico destaca hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal y obesidad moderada a severa. La ecografía abdominal demuestra aumento de la ecogenicidad hepática. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemocromatosis
- b) Hepatitis viral
- c) Esteatohepatitis no alcohólica
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Cirrosis hepática

48) Un paciente con dolor abdominal de 24 horas de evolución, muy intenso, asociado a ictericia. Los exámenes de laboratorio demuestran hematocrito: 42%, leucocitos: 7.600 x mm³, plaquetas: 340.000 x mm³, bilirrubina total: 5,9 mg/dl, bilirrubina directa: 90%, GOT: 107 UI/l, GPT: 88 UI/l, GGT: 600 UI/l, fosfatasa alcalina: 326 UI/l, albúmina: 4,1 y protrombina: 93%. La ecografía abdominal muestra hígado de ecogenicidad conservada, vesícula biliar de paredes normales, sin presencia de cálculos y la vía biliar intra y extrahepática de calibre normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Colecistitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Pancreatitis aguda
- d) Hepatitis aguda
- e) Colédocolitiasis

49) Un niño de 6 años consulta por malestar general, fiebre y odinofagia de 3 días de evolución. Refiere además un cuadro de astenia y palidez de un mes de evolución. Al examen físico se aprecia pálido y destacan algunas adenopatías cervicales. Tiene un hemograma con hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, blancos: 9.740 por mm³, linfocitos: 88%, neutrófilos: 12% y plaquetas: 38.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hodgkin
- b) Leucemia aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Infección por citomegalovirus
- e) Leucemia linfática crónica

50) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más típico de la colitis ulcerosa?

- a) Dolor cólico abdominal, diarrea pastosa y pujo rectal
- b) Dolor cólico abdominal, constipación y masa palpable en fosa ilíaca derecha
- c) Malestar abdominal, deposiciones mucosanguinolentas y pujo rectal
- d) Distensión abdominal, masa palpable en fosa ilíaca izquierda y esteatorrea
- e) Distensión abdominal, úlceras bucales y esteatorrea

51) ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un inductor?

- a) Propofol
- b) Fentanyl
- c) Meperidina
- d) Succinilcolina
- e) Atracurio

52) ¿Cuál de los siguientes exámenes es necesario solicitar a una paciente embarazada en la que se sospecha hipertiroidismo?

- a) T3, T4, TSH
- b) T3, T4 libre y TSH
- c) T4 y TSH
- d) anticuerpos antitiroideos y TSH
- e) anticuerpos antitiroideos y T4 libre

53) Una paciente diabética tipo 2, con mal control, consulta por una herida en el cuarto ortojo derecho, de 1 centímetro de diámetro mayor, dolorosa y de bordes irregulares, eritematosos. Al examen físico se aprecia disminución de los pulsos pedios. La radiografía del pie no revela compromiso óseo. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Ciprofloxacino + clindamicina
- b) Metronidazol
- c) Cefazolina
- d) Meropenem + Vancomicina
- e) Azitromicina

54) Un paciente de 40 años sufre la muerte de su esposa, evolucionando con tristeza, falta de concentración, insomnio e ideas de muerte. Refiere que se siente muy solo y que la muerte sería una buena solución a su sufrimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Depresión psicótica
- c) Depresión melancólica
- d) Depresión doble
- e) Depresión atípica

55) Una mujer de 25 años, primigesta, de 39 semanas de edad gestacional, inicia trabajo de parto. Es ingresada a la sala de parto, recibiendo anestesia epidural. En un control intraparto se palpa dinámica uterina 2 CU cada 10 minutos, con el cuello uterino completamente borrado, 7 cm de dilatación, membranas rotas, feto en presentación de vértice y posición OIIA, en el primer plano de Hodge. Dos horas después no presenta cambios. Las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar forceps
- b) Iniciar goteo oxitócico
- c) Realizar cesárea
- d) Iniciar antibióticos endovenosos
- e) Observar evolución

56) Los síntomas y signos de la enfermedad arterioesclerótica de la bifurcación de la aorta abdominal (Síndrome de Leriche) incluyen:

- a) claudicación del glúteo y pierna
- b) dolor de la extremidad inferior
- c) eyaculación retrógrada
- d) gangrena del pie
- e) rubor del pie

57) La capacidad de una intervención de dar resultados favorables a menor costo se denomina:

- a) Eficacia
- b) Efectividad
- c) Utilidad
- d) Eficiencia
- e) Beneficio

58) ¿Qué asociación entre la patología y el resultado de los gases arteriales es FALSA?

- a) pCO₂: 33 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,30, HCO₃: 16 mEq/l – Gases venosos
- b) pCO₂: 58 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,29, HCO₃: 27 mEq/l – Enfermedad neuromuscular
- c) pCO₂: 36 mmHg, paO₂: 70 mmHg, pH: 7,44, HCO₃: 24 mEq/l – Fibrosis pulmonar
- d) pCO₂: 25 mmHg, paO₂: 92 mmHg, pH: 7,67, HCO₃: 29 mEq/l – Alcalosis respiratoria
- e) pCO₂: 35 mmHg, paO₂: 57 mmHg, pH: 7,49, HCO₃: 26 mEq/l – EPOC

59) Un paciente con antecedentes de un traumatismo de uretra presenta uretrorragia y retención de orina con globo vesical.

¿Cuál es la conducta inmediata?

- a) Solicitar una cistoscopia diagnóstica
- b) Realizar una cistostomía suprapúbica
- c) Indicar cateterismo uretral intermitente
- d) Solicitar ecotomografía pelviana
- e) Instalar sonda Foley uretrovesical

60) Un paciente de 45 años consulta por astenia y debilidad muscular, asociado a aumento de peso. Al examen físico se aprecia obesidad de disposición centrípeta, con atrofia muscular en las extremidades y estrías abdominales de color oscuro.

La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol basal y post-ACTH
- b) Solicitar cortisol y ACTH basales
- c) Solicitar ACTH basal y post-dexametasona
- d) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- e) Iniciar cortisol oral

61) Hombre joven con una herida penetrante en la cara anterior del tórax 1 cm medial al pezón izquierdo, ingresa agitado al Servicio de Urgencia. Su presión arterial es de 70/50, presenta distensión de las venas del cuello y ruidos respiratorios normales bilateralmente.

La conducta inmediata a seguir es:

- a) solicitar radiografía de tórax
- b) solicitar electrocardiograma
- c) realizar drenaje pleural
- d) realizar pericardiocentesis
- e) realizar intubación traqueal

62) ¿Qué medida es MENOS importante para prevenir la recurrencia de artritis por ácido úrico?

- a) Iniciar alopurinol
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar probenecid
- d) Disminuir la ingesta de alcohol
- e) Disminuir la ingesta de carnes rojas

63) Un recién nacido pretérmino, de 30 semanas de edad gestacional, presenta compromiso de conciencia algunas horas después de nacer. Al examen físico se aprecia abombamiento de la fontanela anterior y anisocoria. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis neonatal
- b) Hidrocefalia congénita
- c) Infección congénita por citomegalovirus
- d) Edema cerebral
- e) Hemorragia periventricular

64) Una mujer de 20 años, primigesta, sin antecedentes de importancia, cursando un embarazo de 36 semanas, presenta salida de líquido claro abundante por los genitales hace 12 horas, sin presentar dinámica uterina. Al examen físico se palpa feto en presentación cefálica, con cuello uterino sin dilatación ni borramiento. Se solicita test de cristalización, que muestra cristalización en hojas de helecho y el perfil biofísico resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Administrar antibióticos y tocolíticos
- c) Administrar antibióticos y corticoides a la madre y mantener conducta expectante
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea de urgencia

65) Una paciente presenta ciclos menstruales más cortos que lo normal. Por lo tanto presenta:

- a) Oligomenorrea
- b) Menometrorragia
- c) Hipomenorrea
- d) Hipermenorrea
- e) Polimenorrea

66) Un paciente de 57 años se realiza un APE que resulta 6,8 mg/dl. No presenta síntomas y el tacto rectal es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía prostática y vesical
- b) Solicitar biopsia prostática transrectal
- c) Controlar en 1 año con APE y tacto rectal
- d) Solicitar urodinamia
- e) Realizar resección transuretral

67) Un lactante de 3 meses de edad, previamente sano, es traído a consultorio por haber presentado hace 2 horas un episodio descrito como de cese de la respiración por unos 20 segundos y palidez intensa, que se recuperó al estimularlo. Al examen, se ve de buen aspecto, afebril, rosado. Llama la atención la presencia de restos de sangre en la boca y nariz del niño.

La principal sospecha diagnóstica que usted debe plantear es:

- a) maltrato infantil
- b) apnea primaria.
- c) apnea secundaria a reflujo gastroesofágico
- d) ALTE (Apparent Life Threatening Event) de causa neurológica
- e) ALTE y sangramiento por reanimación vigorosa

68) Una paciente de 40 años, consulta por dolores en la mejilla derecha. El dolor es progresivo, tiene exacerbaciones durante algunos momentos y luego se alivia, sin desaparecer del todo. Al examen físico se encuentra disminución del reflejo corneal derecho además de hipoestesia dolorosa y táctil de la frente, párpado y mejilla hasta el labio superior.

La sospecha diagnóstica es:

- a) cefalea en racimos (cluster headache)
- b) neuralgia esencial de trigémino
- c) neuralgia sintomática de trigémino
- d) sinusitis maxilar derecha
- e) craneocefalalgia atípica

69) Un paciente relata que mientras corría sintió un dolor agudo en la parte inferior de la pierna, similar a un pedrazo. Al examen se comprueba claudicación franca, aumento de volumen, equimosis y signo de Thompson. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esguince grave de tobillo
- b) Luxación de tendones peroneos
- c) Rotura del gemelo interno
- d) Rotura del tendón de Aquiles
- e) Rotura del tendón tibial posterior

70) Una paciente de 30 años, consulta por dolor abdominal bajo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero normal y líquido libre en la cavidad peritoneal. La beta-HCG es de 7.000 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar laparoscopia
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y beta-HCG en 2 a 3 días
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar tocólisis de urgencia

71) Paciente asintomática de 49 años, multipara de 5, esterilizada quirúrgicamente, presenta menstruaciones regulares. Al examen ginecológico presenta útero aumentado de tamaño equivalente a embarazo de 10 semanas, compatible con leiomioma. En control efectuado hace un año el útero presentaba iguales características. La conducta más adecuada es:

- a) controlar cada 6 meses
- b) indicar agonista de hormona liberadora de gonadotropina
- c) iniciar terapia con progestágenos
- d) realizar histerectomía
- e) iniciar terapia hormonal combinada

72) Una paciente de 38 años, cursando con una pielonefritis por Escherichia coli multisensible inicia tratamiento antibiótico, con adecuada cobertura, sin embargo 5 días después permanece febril, con disuria y dolor lumbar. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el tratamiento antibiótico por uno de mayor cobertura
- b) Solicitar una tomografía axial computada
- c) Mantener el tratamiento antibiótico y reevaluar en 2 días
- d) Solicitar ecografía
- e) Solicitar nuevo urocultivo y decidir según antibiograma

73) Un paciente de 60 años se realiza una ecografía abdominal que identifica un aneurisma aórtico infrarrenal, de 5,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar seguimiento ecográfico y mejorar los factores de riesgo cardiovascular
- b) Solicitar angioresonancia
- c) Solicitar angiografía de urgencia
- d) Resolver quirúrgicamente, mediante endoprótesis
- e) Solicitar TAC de abdomen

74) Paciente de 71 años de edad, que en los últimos meses presenta de manera progresiva algunas alteraciones cognitivas y de la memoria reciente, asociadas a torpeza motora, sin otras alteraciones en el examen físico general ni neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Demencia de Alzheimer
- c) Demencia frontotemporal
- d) Proceso expansivo intracraneano
- e) Depresión

75) La ecografía para cuantificar la translucencia nuchal del feto se debe efectuar entre las semanas de gestación:

- a) 5 y 10
- b) 11 y 14
- c) 15 y 19
- d) 20 y 24
- e) 25 y 29

76) Paciente de 22 años consulta por atraso menstrual de 6 semanas, con prueba de embarazo (+). La ecotomografía pelviana transabdominal revela saco gestacional de 14 mm de diámetro, sin embrión.

¿Cuál es la conducta mas adecuada?

- a) Repetir la ecotomografía en 10 días
- b) Solicitar una ecotomografía transvaginal
- c) Realizar legrado uterino.
- d) Solicitar niveles de beta HCG
- e) Solicitar doppler color para detectar actividad cardíaca

77) La incidencia de EPOC en los paciente que fuman es 40 por 100.000 y en los pacientes que no fuman, es 2 por 100.000. Calcule el riesgo relativo:

- a) 0,05
- b) 2
- c) 20
- d) 38
- e) 40

78) ¿Cuál es la conducta más importante en la atención del recién nacido, cuando se observa presencia de meconio espeso en el líquido amniótico durante el parto?

- a) Aspiración orofaríngea al asomar la cabeza.
- b) Observar aparición de distress respiratorio
- c) Aspiración cuidadosa de la tráquea.
- d) Visualización laríngea y aspiración traqueal.
- e) Ventilación con ambú post aspiración.

79) ¿Qué esperarías encontrar en la curva de crecimiento y en la edad ósea de un niño con talla baja debida a un retraso constitucional del crecimiento?

- a) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea acorde con la edad cronológica
- b) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea mayor que la edad cronológica
- c) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea menor que la edad cronológica
- d) Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea acorde con la edad cronológica
- e) Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea menor que la edad cronológica

80) Un paciente VIH(+) en tratamiento antirretroviral consulta por edema de extremidades inferiores. Al examen físico destaca edema blando de ambas extremidades inferiores, asociado a edema palpebral, sin otras altecraciones. En sus exámenes presenta hemograma normal, creatininemia 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, colesterol: 250 mg/dl, complemento normal, sedimento de orina con 10 eritrocitos por campo y proteinuria de 5 gramos en 24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Nefritis por citomegalovirus
- c) Tuberculosis renal
- d) Nefropatía membranosa
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

81) En una anemia por deficiencia de hierro, el tratamiento sustitutivo oral debe suspenderse cuando se ha normalizado:

- a) la hemoglobinemía
- b) la ferremia
- c) el hematocrito
- d) la saturación de la transferrina
- e) la ferritina plasmática

82) Una paciente de 38 años, cursando su segundo embarazo, de 35 semanas, bien controlado y sin complicaciones hasta el momento, presenta presión arterial 146/90 mmHg. Se decide semihospitalización, que muestra varias tomas con cifras tensionales similares. La proteinuria cualitativa es ligeramente positiva y la proteinuria cuantitativa de 24 horas resulta 200 mg. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial crónica
- b) Preclamsia
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Eclamsia
- e) Hipertensión secundaria a nefropatía médica
- e) Cáncer de endometrio

83) Un niño de 4 meses presencia ausencia del testículo izquierdo, el que no es posible de ser palpado con un adecuado examen físico. Se revisan sus controles previos, en los que no se describe el examen testicular. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía inguinoescrotal
- b) Observar evolución
- c) Solicitar cariograma
- d) Iniciar andrógenos
- e) Solicitar testosterona plasmática y gonadotropinas

84) Una paciente de 50 años presenta metrorragia de 3 días de evolución, abundante, con presencia de coágulos. La ecografía transvaginal muestra cavidad endometrial con abundante contenido, probablemente sangre. El test de embarazo es negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales en dosis habituales
- b) Iniciar anticonceptivos orales en altas dosis
- c) Administrar ácido tranexánico
- d) Realizar legrado biopsico-terapéutico
- e) Realizar histerectomía

85) Un paciente de 30 años presenta dificultad para tragar, de localización baja, especialmente de los líquidos, que algunos días es más intensa y en otros se manifiesta menos. En algunas ocasiones presenta regurgitación no ácida de alimentos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Reflujo gastroesofágico
- b) Divertículo esofágico
- c) Cáncer de esófago
- d) Esófago de Barret
- e) Acalasia esofágica

86) Identifique la asociación INCORRECTA entre la vasculitis y los vasos que afecta:

- a) Arteritis de Takayasu – Aorta y sus ramas
- b) Panarteritis nodosa – Arterias mesentéricas
- c) Poliangeítis microscópica – Capilares y arteriolas renales y pulmonares
- d) Arteritis de células gigantes – Vasa nervorum , arteriolas y capilares del sistema nervioso central
- e) Arteritis de Churg-Strauss – Capilares pulmonares y capilares glomerulares

87) El síndrome de vena cava superior se caracteriza por:

- a) Hipertensión arterial, palidez y dilatación de las venas torácicas y de las extremidades superiores
- b) Tos y edema facial y de extremidades superiores
- c) Dolor torácico intenso, asociado a disnea
- d) Ingurgitación yugular, asociado a hipotensión
- e) Compromiso de conciencia y dolor torácico

88) Primigesta de 24 años, con embarazo de 36 semanas de evolución fisiológica, consulta por cefalea y tinitus. Presenta presión arterial de 170/100 mmHg, edema generalizado y reflejos osteotendíneos exaltados. Los exámenes muestran proteinuria cualitativa (+++), hematocrito de 27%, plaquetas 35.000/mm³.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Preeclampsia moderada
- b) Crisis hipertensiva
- c) Hipertensión arterial crónica
- d) Preeclampsia severa
- e) Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada

89) Hombre de 74 años, con demencia tipo Alzheimer. Por sus frecuentes períodos de irritabilidad, negativismo y agresividad, recibe haloperidol 2 mg cada 6 horas desde hace un mes. Actualmente consulta por somnolencia excesiva, períodos de mutismo akinético y temblor del mentón. Al examen físico destaca bradiquinesia y temblor de reposo del mentón y mano derecha.

¿Cuál es la conducta más apropiada?

- a) Mantener haloperidol y agregar levodopa y carbodopa.
- b) Cambiar el haloperidol por clorpromazina.
- c) Reducir la posología del haloperidol.
- d) Suspende el uso de haloperidol.
- e) Verificar niveles séricos del haloperidol.

90) Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial, tabaquismo y un infarto cardíaco hace 4 años, se realiza un electrocardiograma que muestra extrasístoles ventriculares frecuentes. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar coronariografía
- d) Iniciar amiodarona oral
- e) Iniciar betabloqueantes orales

Respuestas:

PRIMERA PARTE	
Preguntas	Respuestas
1	C
2	A
3	B
4	B
5	C
6	C
7	E
8	C
9	A
10	E
11	B
12	C
13	E
14	D
15	A
16	D
17	E
18	B
19	C

20	C
21	A
22	E
23	A
24	D
25	E
26	B
27	D
28	B
29	E
30	D
31	A
32	C
33	C
34	A
35	E
36	C
37	A
38	B
39	C
40	C
41	B
42	E
43	D
44	D
45	A
46	D
47	B
48	A
49	B
50	D

51	C
52	E
53	B
54	D
55	D
56	C
57	C
58	B
59	C
60	E
61	B
62	C
63	B
64	C
65	C
66	D
67	B
68	B
69	D
70	E
71	C
72	C
73	B
74	B
75	B
76	D
77	C
78	C
79	D
80	A
81	C

82	D
83	B
84	A
85	B
86	A
87	C
88	B
89	D
90	C

SEGUNDA PARTE

Preguntas	Respuestas
1	B
2	A
3	C
4	B
5	D
6	C
7	E
8	C
9	B
10	D
11	E
12	C
13	D
14	C
15	E
16	E
17	E
18	C
19	E
20	A

21	A
22	E
23	B
24	B
25	B
26	C
27	B
28	B
29	C
30	D
31	A
32	B
33	D
34	E
35	D
36	D
37	E
38	E
39	B
40	D
41	A
42	C
43	D
44	B
45	E
46	B
47	C
48	E
49	B
50	C
51	A

52	B
53	A
54	C
55	B
56	A
57	D
58	A
59	B
60	D
61	D
62	B
63	E
64	D
65	E
66	B
67	A
68	C
69	D
70	A
71	A
72	D
73	D
74	B
75	B
76	A
77	C
78	A
79	C
80	D
81	E
82	C

83

A

84

D

85

E

86

D

87

B

88

D

89

D

90

D

Ensayo EUNACOM – Prueba 11

PRIMERA PARTE

1) ¿Cuál de los siguientes marcadores se encuentra elevado con más frecuencia en el cáncer de ovario?

- a) Beta-HCG
- b) Alfafetoproteína
- c) Antígeno carcinoembrionario
- d) Ca-125
- e) Ca-19.9

2) Lo más característico de la miastenia gravis es:

- a) Debilidad de instalación súbita de un hemicuerpo
- b) Debilidad proximal, asociada a elevación de la creatinfosfoquinasa (CK)
- c) Debilidad distal asimétrica que mejora con el ejercicio
- d) Debilidad proximal y distal simétricas, sin compromiso ocular
- e) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante

3) Una mujer es diagnosticada de VIH en relación a un screening realizado en la primera consulta al obstetra. Se encuentra asintomática. ¿Cuál de las siguientes alternativas supone un MENOR riesgo para el feto, al momento del parto?:

- a) Ausencia de infecciones oportunistas
- b) Recuento de linfocitos helper CD4(+) mayor a 1.000
- c) Carga viral indetectable
- d) Tratamiento antirretroviral
- e) Cesárea

4) La probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad infecciosa durante un período de tiempo se denomina:

- a) Incidencia acumulada
- b) Prevalencia
- c) Letalidad
- d) Riesgo atribuible
- e) Riesgo atribuible porcentual

5) Una mujer presenta ciclos menstruales irregulares, con tendencia a la oligomenorrea. Al examen físico se observa piel grasa, con acné facial y acantosis nigricans. El diagnóstico más probable es:

- a) Intolerancia a la glucosa
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Hiperplasia suprarrenal
- d) Hipotiroidismo
- e) Síndrome de hiperestimulación ovárica

6) La mejor conducta ante la sospecha clínica de EPOC es:

- a) Iniciar broncodilatadores, asociados a corticoides inhalatorios
- b) Iniciar terapia broncodilatadora con salbutamol e ipratropio
- c) Solicitar radiografía de tórax e iniciar tratamiento según hallazgos
- d) Solicitar espirometría
- e) Indicar oxigenoterapia domiciliaria, asociando broncodilatadores inhalatorios

7) Un paciente de 14 meses es traído por su madre, ya que presenta diarrea acuosa abundante, asociada a fiebre hasta 38,4°C de un día de evolución. Al examen físico se observa en buenas condiciones, animado, afebril y con signos vitales normales. Las mucosas están húmedas, la piel turgente y llora con lágrimas. La conducta más adecuada es

- a) Enviar a domicilio con régimen liviano, sin residuos e hidratación oral con sales de rehidratación luego de cada deposición diarreica
- b) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral, según plan A
- c) Indicar reposición hídrica con sales de rehidratación oral con 50-100cc/Kg y reevaluar en 4 a 6 horas
- d) Indicar antidiarreicos y sales de rehidratación oral, según plan B
- e) Enviar a domicilio con régimen liviano sin residuos, hidratación oral, según plan A, antibióticos y antidiarreicos

8) Un paciente de 35 años inicia un cuadro diarreico una semana después de utilizar amoxicilina por una amigdalitis. Se solicitan toxinas de Clostridium difficile A y B en las heces, resultando positivas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ciprofloxacino oral
- b) Iniciar clindamicina oral
- c) Iniciar vancomicina oral
- d) Iniciar metronidazol oral
- e) Iniciar cotrimoxazol oral

9) El síntoma de presentación más frecuente del cáncer glótico es:

- a) Disnea
- b) Tos
- c) Disfonía
- d) Expectoración hemoptoica
- e) Masa cervical

10) Hombre de 55 años, que cursa el segundo día post operatorio de una colecistectomía laparoscópica. Súbitamente presenta disnea y desaturación arterial hasta 85% (aire ambiental). No hay historia de enfermedad cardiovascular o pulmonar.

Examen físico: Temperatura 38,5°C, FC 110 x reg, PA 90/60 mmHg (la PA pre-op fue 120/80 mmHg). Recibiendo oxígeno al 100% sus gases en sangre arterial son: pH 7,50 PaCO₂ 29,0 mmHg, PaO₂ 125 mmHg (Sat 97%). Radiografía de tórax: normal. Electrocardiograma: taquicardia sinusal 110 x. Media hora más tarde, la PA cae a 75/50 mmHg. Se instala catéter de Swan Ganz cuyas lecturas son: presión de capilar pulmonar enclavada 6 mmHg., presión pulmonar 45/22 mmHg; presión de aurícula derecha: 18 mmHg; presión de ventrículo derecho: 40/20 mmHg; gasto cardíaco 2 lt/min y resistencia sistémica 1600 dinas/seg/cm-5. El diagnóstico más probable es:

- a) Taponamiento pericárdico
- b) Tromboembolismo pulmonar masivo.
- c) Insuficiencia suprarrenal aguda.
- d) Shock séptico secundario a colangitis.
- e) Infarto de miocardio y shock cardiogénico.

11) Una mujer cursando un embarazo de 15 semanas por FUR segura y confiable, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto de sólo 10 semanas de edad, tanto por longitud cefalonalgas, como por diámetro biparietal. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la edad gestacional?

- a) Mantener la edad gestacional determinada por la FUR
- b) Tomar la nueva edad gestacional, dada por la ecografía
- c) Calcular un promedio entre ambas edades gestacionales y ocupar dicha información para el cálculo de la edad gestacional
- d) Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana y determinar la edad gestacional según el resultado
- e) Solicitar nueva ecografía en 14 días y determinar la edad gestacional según el resultado

12) Un paciente sufre una caída en bicicleta, golpeándose el hombro derecho. Al examen se aprecia hombro derecho en charretera, con imposibilidad de abducirlo, asociado a anestesia de la zona deltoidea. El diagnóstico más probable es:

- a) Disyunción acromioclavicular con compromiso del nervio radial
- b) Disyunción acromioclavicular con compromiso del nervio axilar o circunflejo
- c) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio radial
- d) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio axilar o circunflejo
- e) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio musculocutáneo

13) Un hombre sufre un accidente laboral, resultando con múltiples fracturas en la extremidad superior izquierda. Al examen presenta imposibilidad de extender el codo y la muñeca. ¿Qué estructura está presuntamente dañada?

- a) Nervio mediano
- b) Nervio cubital
- c) Nervio musculocutáneo
- d) Nervio radial
- e) Nervio axilar

14) Paciente de 23 años, presenta cefalea, fiebre y odinofagia leve de 6 días de evolución. Al examen físico presenta congestión faríngea sin exudados y adenopatías cervicales pequeñas bilaterales. Hígado a 2 cm bajo el reborde costal; bazo aumentado de tamaño.

Laboratorio: Leucocitos 9.700/mm, 50% linfocitos (5% atípicos). SGOT 104 U/L; SGPT 96 U/L; bilirrubina total 1.05 mg/dL; IgG VCA Epstein Barr (+), IgM VCA Epstein Barr (-). IgG Toxoplasma gondii (+), IgM Toxoplasma gondii (-), IgG Citomegalovirus (-), IgM citomegalovirus (+) IgM virus hepatitis A (-) IgG virus hepatitis A (+); VIH (-).

El diagnóstico más probable es:

- a) Infección aguda por Toxoplasma gondii
- b) Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein Barr
- c) Síndrome retroviral agudo por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- d) Infección por hepatitis A
- e) Infección aguda por citomegalovirus

15) Paciente de 55 años, consulta por disnea de esfuerzos CF II, asociada a edema de EEII y disnea paroxística nocturna. Al examen cardíaco destaca desplazamiento del choque de la punta a 5° espacio intercostal en línea axilar anterior y ritmo regular en 2 tiempos, con soplo holosistólico III/VI, mayor en ápex. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Estenosis tricuspídea

16) ¿En qué momento se debe administrar la vacuna BCG a un recién nacido prematuro?

- a) A los 2 meses de edad
- b) A los 6 meses de edad
- c) Al alcanzar los 2 kilogramos de peso
- d) Al doblar el peso de nacimiento
- e) Al momento de nacer

17) Un paciente presenta súbitamente dolor de la extremidad inferior izquierda, asociado a parestesias. Al examen físico se aprecia que desde la zona media del muslo en adelante existe palidez y se constata ausencia de los pulsos poplíteo, tibial posterior y pedio. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores
- b) Iniciar anticoagulación con heparina y realizar estudio de trombofilias
- c) Administrar heparina endovenosa y realizar angiografía de urgencia
- d) Solicitar pletismografía de volumen (PVR)
- e) Resolver quirúrgicamente

18) Una vez diagnosticada clínicamente una hernia inguinal no complicada en un lactante, la actitud CORRECTA es:

- a) esperar hasta los 7 años, ya que hay un 50% de resolución espontánea
- b) cirugía de urgencia
- c) control mensual
- d) cirugía electiva lo más pronto posible
- e) solicitar ecografía inguinal para corroborar diagnóstico

19) Un paciente de 64 años de edad, presenta hematuria en una oportunidad, por lo que se realiza una ecografía que muestra un tumor renal sólido de 6 cm en el riñón derecho. La tomografía axial computada no visualiza adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía parcial
- b) Realizar nefrectomía radical
- c) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
- d) Realizar tumorectomía más quimioterapia
- e) Realizar tumorectomía más radioterapia

20) Un paciente de 59 años, agricultor, presenta lesiones cutáneas ásperas, de hasta 4 mm de diámetro, localizadas en el dorso de ambas manos, en la frente y la nariz, que han crecido lentamente a lo largo de años y que no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis seborreica
- b) Léntigos solares
- c) Carcinomas basocelulares
- d) Queratosis actínicas
- e) Rosácea

21) Paciente con dolor lumbar irradiado desde la cara lateral del muslo y la pierna hasta el hallux. Al examen físico presenta reflejos osteotendinosos normales, signo de Laségue positivo y claudicación al caminar sobre los talones.

¿Cuál es la raíz nerviosa comprometida?

- a) L2
- b) L3
- c) L4
- d) L5
- e) S1

22) Para evitar sesgos por variable confundente se debe:

- a) Aumentar el tamaño de la muestra
- b) Aleatorizar estratificadamente
- c) Enmascarar la información (doble ciego)
- d) Utilizar un grupo de control
- e) Calcular el error alfa

23) Un paciente de 30 años, diagnosticado de pancreatitis aguda, mediante lipasa y TAC abdominal, con contraste, evoluciona con oliguria marcada. Se solicita creatininemia que resulta 3,1 mg/dl, con BUN: 70 mg/dl. La osmolaridad urinaria está muy aumentada, con potasio urinario de 20 mEq/l y sodio urinario de 8 mEq/L. El sedimento de orina no muestra alteraciones. La causa más probable de su insuficiencia renal es:

- a) Prerenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefritis intersticial
- d) Nefropatía por medio de contraste
- e) Infarto renal

24) Un paciente de 63 años se realiza neumonectomía del lóbulo medio derecho como parte del tratamiento de un adenocarcinoma bronquial. ¿A qué tipo de herida corresponde esta cirugía?

- a) Herida limpia
- b) Herida limpia contaminada
- c) Herida contaminada
- d) Herida sucia
- e) Herida infectada

25) Paciente hipertenso, de 67 años, con dolor torácico intenso, de inicio súbito. Al examen físico FC: 110x', regular, PA:230/128, asimetría en los pulsos radiales y a la auscultación cardíaca destaca un soplo diastólico. La conducta inicial más adecuada a seguir, además de tomar un ECG es:

- a) Realizar coronariografía urgente
- b) Administrar oxígeno, morfina, nitroglicerina y aspirina inmediatamente
- c) Realizar ecocardiograma transesofágico urgente
- d) Realizar pericardiocentesis
- e) Solicitar radiografía de tórax

26) Un paciente de 45 años consulta por dolor epigástrico muy intenso, asociado a vómitos alimentarios, ictericia y coluria. Al examen se aprecia de buen aspecto, con signos vitales normales e ictericia marcada. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,6 mg/dl, GGT: 430 UI/l, GOT: 58 UI/l, GPT: 60 UI/l, FA: 402 UI/l, lipasa: 45 UI/l, hematocrito: 40%, blancos: 8.500 por mm³. La ecografía muestra una vía biliar de 9 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Cólico biliar simple
- e) Celédocolitiasis

27) Un niño de 7 años presenta un cuadro de astenia, fiebre intermitente y sudoración de 3 semanas de duración, que ha tratado con paracetamol. Presenta además dolor en el hombro derecho y el tobillo izquierdo que limita los movimientos de dichas articulaciones. Al examen físico destaca palidez y algunas petequias en abdomen y extremidades inferiores. La auscultación cardiopulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico agudo
- b) Artritis séptica
- c) Endocarditis infecciosa subaguda
- d) Leucemia aguda
- e) Mononucleosis infecciosa

28) El diseño “cruzado”, en un ensayo clínico, puede utilizarse en un estudio que compare las diferencias entre:

- a) Dos tratamientos antibióticos diferentes, para la peritonitis bacteriana espontánea
- b) El tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico de la pancreatitis crónica
- c) Dos fármacos fibrinolíticos para el tratamiento del infarto agudo al miocardio con supradesnivel de segmento ST
- d) Dos broncodilatadores de larga acción en el manejo sintomático del EPOC
- e) Dos pruebas de screening para cáncer de colon

29) El eritema multiforme menor se caracteriza clínicamente por:

- a) Pápulas, vesículas y pústulas sobre una base eritematosa, que comprometen el tronco
- b) Placas en el tronco y zona proximal de las extremidades con disposición en “tiro al blanco”
- c) Pápulas y pústulas pruriginosas que afecta la cabeza y posteriormente se generalizan al tronco y las extremidades.
- d) Pápulas, placas y bulas que se rompen fácilmente, asociado a compromiso de mucosas
- e) Placas eritematosas que evolucionan a vesículas, confluentes, con gran extensión cutánea y presencia de signo de Nokolski

30) Un paciente de 56 años, cursando un síndrome neumónico, se realiza una radiografía de tórax, que muestra una zona de condensación, asociado a derrame pleural, el que se punciona, dando salida a un líquido amarillento, con características de exudado, con pH: 7,0, lactato: 9 mmol/l, sin visualización de bacterias a la tinción de Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos e instalar tubo pleural
- b) Iniciar antibióticos endovenosos y drenar el líquido por toracocentesis
- c) Iniciar antibióticos endovenosos e intrapleurales
- d) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar videotoracoscopia
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y observar la evolución del derrame

31) Son ventajas de los estudios de casos y controles EXCEPTO:

- a) Son baratos
- b) Permiten inferir causalidad
- c) Presentan relativamente pocos sesgos
- d) Permiten relacionar una enfermedad con distintos factores de riesgo
- e) Son útiles en enfermedades poco frecuentes o que demoran muchos años en manifestarse

32) Paciente de 71 años de edad, que en los últimos meses presenta de manera progresiva algunas alteraciones cognitivas y de la memoria reciente, asociadas a torpeza motora, sin otras alteraciones en el examen físico general ni neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Demencia de Alzheimer
- c) Demencia frontotemporal
- d) Proceso expansivo intracraneano
- e) Depresión

33) Un paciente de 66 años diabético, mal controlado, presenta aumento de volumen y dolor facial de rápida instalación asociado a escasa secreción nasal. Al examen se observa eritema y edema facial, con un área necrótica negruzca en relación a la prominencia malar izquierda. El agente etiológico más probable es:

- a) Pseudomona aureginosa
- b) Neumococo
- c) Staphylococcus aureus
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Mucor

34) Un paciente de 60 años debe realizarse una prostatectomía radical. En la evaluación preanestésica, se constata hipertrofia amigdalina grado IV. ¿Cuál de las siguientes le parece una buena alternativa para el manejo anestésico de este paciente?

- a) Anestesia general con intubación en secuencia rápida
- b) Anestesia general con intubación a 6 manos
- c) Anestesia general con intubación por traqueostomía
- d) Anestesia regional combinada y cirugía vigil
- e) Anestesia local y cirugía vigil

35) La complicación más grave del hipotiroidismo congénito no detectado a tiempo es:

- a) Retraso mental
- b) Epilepsia
- c) Mixedema
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Insuficiencia renal crónica

36) Paciente ingresa con un cuadro de deshidratación grave asociada a vómitos, precedido de dolor abdominal, baja de peso y astenia. Refiere el antecedente de oscurecimiento de la piel. Al examen físico se encuentra hipotenso.

Además de hidratar al paciente, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- a) Medir cortisol plasmático y administrar hidrocortisona endovenosa
- b) Medir cortisol en orina de 24 h
- c) Realizar un test de estimulación con ACTH
- d) Medir ACTH plasmático
- e) Iniciar terapia con prednisona

37) El tratamiento inicial de un trastorno de pánico debe ser:

- a) Diazepam 10 mg cada 12 horas v.o.
- b) Fluoxetina 40 mg al día v.o.
- c) Fluoxetina 10 mg al día v.o. + alprazolam 0,5 mg cada 12 horas
- d) Clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o. + risperidona 1 mg al día v.o.
- e) Fluoxetina 40 mg al día v.o. + clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o.

38) Un niño de 7 meses ha presentado 5 infecciones respiratorias bajas desde el nacimiento. Se fatiga rápidamente durante la succión, por lo que no ha aumentado correctamente de peso. Al examen físico se ausculta un soplo holosistólico intenso y algunas crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. No presenta cianosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Tetralogía de Fallot

39) Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, inadecuadamente tratado, suelen complicarse con:

- a) Depresión
- b) Manía
- c) Delirio
- d) Síntomas disociativos
- e) Síntomas conversivos

40) Un paciente de 32 años está convencido de que su mujer lo engaña con un amante. Ella lo niega rotundamente y dice que su esposo está volviéndose loco con ese tema. Por esto, él la sigue e incluso ha contratado un detective para que la espíe, sin lograr ninguna información. A pesar de esto él insiste en el engaño de su mujer, ya que ha visto manchas en las sábanas de la casa, que con toda seguridad son producto de la infidelidad. No ha presentado alucinaciones y el resto de su examen psiquiátrico es normal, al igual que el examen neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno bipolar

41) Una mujer de 39 años asegura que desde hace varios años está embarazada de Dios. Al confrontarla no es capaz de reconocer que esto no es cierto. Esta descripción corresponde a:

- a) Delirio
- b) Alucinación
- c) Ilusión
- d) Esquizofrenia
- e) Alucinosis

42) ¿Qué alteración es más probable de ser pesquisada en un paciente pediátrico cursando con un síndrome nefrótico por cambios mínimos (nefrosis lipoídea)?

- a) Hipertensión arterial
- b) Hiperlipidemia
- c) Hematuria dismórfica
- d) Hematuria no dismórfica
- e) Hiperproteinemia

43) Un paciente de 68 años consulta por baja de peso, sensación de saciedad precoz y dolor abdominal epigástrico intermitente, de un mes de evolución. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar radiografía de abdomen simple
- d) Solicitar TAC de abdomen
- e) Iniciar omeprazol oral

44) Una paciente de 28 años es traída por su madre, ya que desde hace unos días anda muy “rara”. Refiere que dice que puede escuchar el pensamiento de las personas que están en la calle, quienes la odian y quieren hacerle daño. Previo a esto era muy tranquila, poco expresiva, pero nunca le había pasado algo así. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno de personalidad paranoide
- e) Trastorno de personalidad esquizoide

45) La triada de cefalea, vómitos y papiledema, es característica de:

- a) Hidrocefalia
- b) Meningitis viral
- c) Glaucoma congénito
- d) Hipertensión endocraneana
- e) Migraña

46) Un paciente de 49 años presenta un nódulo tiroideo de un centímetro de diámetro, que en la ecografía se muestra con microcalcificaciones, sin adenopatías asociadas. Se realiza punción con aguja fina, cuya citología es compatible con un carcinoma papilar de tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de tiroglobulina
- b) Iniciar levotiroxina en dosis altas
- c) Realizar tiroidectomía total y en una segunda etapa administrar yodo radiactivo
- d) Administrar yodo radiactivo
- e) Realizar tiroidectomía + linfadenectomía y controlar con calcitonina

47) Un lactante de 6 meses de edad, sin antecedentes de importancia, presentó un cuadro de dificultad respiratoria, asociado a retracción intercostal y cianosis perioral. Este cuadro fue manejado con salbutamol y oxígeno y luego fue enviado a domicilio con buena evolución. Usted lo evalúa 5 días después y está en excelentes condiciones, sin alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución e indicar reconsulta en caso de reaparición de los síntomas, sin necesidad de fármacos
- b) Indicar corticoides inhalados según horario y salbutamol en caso de síntomas
- c) Indicar salbutamol inhalado según horario
- d) Indicar salmeterol inhalado según horario y salbutamol en caso de síntomas
- e) Solicitar test del sudor

48) El aumento de los niveles plasmáticos de algunos medicamentos en el anciano, se debe principalmente a:

- a) incremento de la biodisponibilidad
- b) disminución de la excreción renal
- c) aumento de la fracción libre de los fármacos básicos
- d) incremento de la velocidad de absorción intestinal
- e) disminución de la capacidad metabólica

49) Paciente de 22 años, con diagnóstico reciente de esquizofrenia, inicia tratamiento hace 5 días con risperidona. Evoluciona con espasmos musculares del cuello y movimientos rápidos de los ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Acatisia
- b) Disquinesia tardía
- c) Disonía
- d) Catatonía
- e) Balismo

50) Un paciente sufre un golpe en la cara, resultando con un hematoma del tabique nasal, con dolor. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar drenaje quirúrgico inmediato
- b) Realizar taponamiento anterior
- c) Realizar taponamiento posterior
- d) Realizar nasofibroscopía
- e) Iniciar analgésicos y enviar a domicilio

51) Una paciente es diagnosticada de una neoplasia intraepitelial de alto grado (NIE-3). La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con Papanicolaou mensualmente
- b) Controlar con Papanicolaou cada 6 meses
- c) Realizar legrado biopsico
- d) Indicar conización cervical
- e) Indicar histerectomía total

52) Paciente de 35 años, cesarizada anterior, cursando embarazo de 36 semanas, presenta RPO de 10 horas de evolución. No se registran contracciones uterinas ni modificaciones cervicales y el registro basal no estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar espontáneamente, sin necesidad de fármacos
- b) Dejar evolucionar, bajo cobertura antibiótica y bajo corticoides para asegurar la maduración fetal
- c) Indicar reposo, antibióticos, corticoides e interrumpir cuando se cumplan 37 semanas de gestación
- d) Inducir el parto inmediatamente con misoprostol
- e) Realizar cesárea

53) Una paciente de 45 años, deportista, sin hábitos tóxicos ni patologías previas, presenta astenia, por lo que se realiza exámenes generales, en donde destaca una elevación de las transaminasas por 4 veces el valor normal. El hemograma, pruebas de función renal, glicemia, perfil lipídico y el resto de las pruebas hepáticas son normales. Se solicitan exámenes adicionales que muestran IgM anti-VHA(-), Antígeno de superficie VHB(-), anticuerpos anti-HBs(+), IgM anticore(-), anticuerpos anti-VHC(-), ANA(-), ANCA(-), ASMA(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis viral
- b) Cirrosis biliar primaria
- c) Colangitis esclerosante primaria
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Esteatohepatitis no alcohólica

54) Un niño de 4 años se traga una moneda. Al examen físico no presenta alteraciones y las radiografías demuestran que la moneda está en el antro gástrico. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución e indicar consulta sólo en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar control radiológico cada 12 horas
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva
- e) Resolver quirúrgicamente

55) Una mujer de 39 años se realiza una mamografía que muestra una lesión densa, de bordes irregulares, en la mama derecha, informada como Bi-Rads 4. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la mamografía, debido a que la edad de la paciente hace poco probable la presencia de una lesión maligna
- b) Iniciar anticonceptivos orales y controlar con nueva mamografía en un año
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Iniciar tamoxifeno
- e) Derivara para biopsia

56) Un paciente de 50 años, fumador, consulta por tos seca y disnea de esfuerzo, progresiva, de 2 meses de evolución, que actualmente le permite caminar una cuadra. Al examen físico se aprecian campos pulmonares de pequeño tamaño, con crepitaciones intensas bilaterales, mayor en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Insuficiencia cardíaca
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) Bronquiectasias

57) ¿De dónde se obtienen los recursos para el manejo de los accidentes laborales y del trayecto?

- a) Del aporte fiscal directo
- b) Del aporte per cápita
- c) Del aporte de las municipalidades
- d) Del aporte de las mutuales de seguridad
- e) Del aporte de los empleadores

58) Una mujer de 30 años, con antecedente de haber utilizado amoxicilina hace algunas semanas, por una sinusitis bacteriana, comienza con prurito vulvar, asociado a leucorrea grumosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Vaginitis
- c) Tricomoniasis
- d) Gonorrea
- e) Infección por Chlamydia

59) Un adolescente de 17 años consulta por diarrea de 4 semanas de evolución, asociada a dolor abdominal y sensación febril ocasional. En el último tiempo la diarrea se ha vuelto disintérica. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ciprofloxacino
- b) Iniciar metronidazol
- c) Solicitar coprocultivo
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitar tomografía de abdomen y pelvis

60) Una mujer de 59 años acude a control ginecológico, en el cual se le palpa un tumor anexial izquierdo, el que se confirma con ecografía, siendo de aspecto quístico, de 6 cm de diámetro, con incrementos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar estrógenos orales y controlar periódicamente con ecografía
- b) Realizar paracentesis y estudio de líquido peritoneal
- c) Iniciar progestágenos orales y controlar periódicamente con ecografía
- d) Realizar biopsia por punción con aguja fina
- e) Realizar anexectomía y biopsia excisional

61) Un paciente de 67 años, hipertenso, en tratamiento con dosis bajas de nifedipino, consulta por ortopnea y disnea de esfuerzos de grandes esfuerzos, de 3 meses de evolución. Al examen físico se constata PA: 150/90 mmHg, FC: 77x', sin otras alteraciones. La radiografía de tórax muestra un corazón de tamaño normal y cierto grado de redistribución de la vasculatura pulmonar hacia los ápices. El electrocardiograma demuestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. La etiología más probable de su insuficiencia cardíaca es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Cardiopatía hipertensiva
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Miocardiopatía restrictiva
- e) Pericarditis constrictiva

62) Un paciente de 22 años consulta por dolor lumbar de algunas semanas de evolución, asociados a rigidez matinal, que aumenta con el reposo y cede con la actividad física. Se solicita radiografía de zona lumbosacra, que muestra signos de sacroileítis, con calcificación de los ligamentos longitudinales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de columna lumbar
- b) Indicar ejercicios e iniciar AINEs por vía oral
- c) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
- d) Indicar reposo e iniciar hidroxycloquin
- e) Resolver de modo quirúrgico

63) Un paciente sufre una puñalada en el abdomen. Al examen físico está en buenas condiciones y se aprecia una herida de 2 cm de largo, con escaso sangrado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparotomía de urgencia
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar radiografía de abdomen y pelvis
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Realizar exploración digital con anestesia local

64) Lactante de 8 meses de edad, nacido de término. Actualmente asintomático, eutrófico.

Se observa palidez. El resto del examen físico y el desarrollo psicomotor son normales.

Se solicita un hemograma, cuyo resultado es:

Hematocrito: 26%, hemoglobina: 7,5 g / dl., Volumen Corpuscular Medio: 68, Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media: 27, reticulocitos: 2%, Plaquetas 285.000 / mm³. Usted diagnostica anemia:

- a) por déficit de folato
- b) fisiológica
- c) por déficit de hierro
- d) aplásica
- e) hemolítica

65) En un paciente con EPOC estable, ¿qué criterio es el más adecuado para determinar la severidad?

- a) Respuesta a corticoides inhalados
- b) Respuesta a broncodilatadores
- c) Relación VEF1/CVF
- d) VEF1
- e) Gases en sangre arterial

66) Primigesta de 24 años, embarazo de 36 semanas de evolución fisiológica, consulta por cefalea y tinnitus. Al examen presenta presión arterial de 170/100 mmHg, edema generalizado y reflejos osteotendíneos exaltados.

Exámenes de laboratorio: proteinuria (+++), hematocrito 27%, plaquetas 35.000/mm³

El diagnóstico más probable es:

- a) preeclampsia moderada.
- b) hipertensión arterial transitoria.
- c) hipertensión arterial crónica.
- d) preeclampsia severa.
- e) hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada.

67) Un lactante de 10 meses cae de la cama, golpeándose la cabeza. No pierde la conciencia ni convulsiona. Al examen se observa irritable, con signos vitales normales, sin signos neurológicos focales. Se observa un pequeño hematoma en la zona parietal derecha del cuero cabelludo. La conducta más importante es:

- a) Enviar a domicilio para observación y reconsultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Hospitalizar en sala y administrar analgesia endovenosa, con AINEs
- c) Solicitar radiografía de cráneo
- d) Solicitar TAC de cráneo y cerebro sin contraste
- e) Hospitalizar en UCI

68) Un paciente de 75 años, consulta porque le detectaron la presión arterial elevada a 160/110 mmHg. Se toman varias mediciones de presión arterial, obteniendo varias cifras cercanas a 160/100. Previo a esto sus presiones arteriales habían resultado normales. Se solicita creatinina: 1,0 mg/dl, Hcto: 41%, blancos: 7.000 x mm³, plaquetas: 370.000 x mm³, VHS: 20 mm/h, sodio plasmático: 140 mEq/l, Cloro plasmático: 102 mEq/l, potasio plasmático: 3,0 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Feocromocitoma
- c) Hipertensión arterial esencial
- d) Nefropatía médica
- e) Sano

69) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS probable de encontrar en un paciente con catarata senil?

- a) Leucocoria
- b) Empeoramiento de la visión en lugares con mucha luz
- c) Defecto pupilar aferente
- d) Disminución de la agudeza visual mayor en un ojo que en el otro
- e) Pupilas isocóricas

70) ¿Qué hallazgo se considera normal en un recién nacido?

- a) Nevo congénito gigante
- b) Exantema petequial
- c) Hipotonía
- d) Fiebre
- e) Signo de Babinsky

71) ¿Cuál de las siguientes opciones es MENOS probable de encontrar en una paciente con endometriosis?

- a) Infertilidad
- b) Dispareunia profunda
- c) Hipermenorrea
- d) Elevación del Ca-125
- e) Algia pélvica crónica cíclica

72) Un paciente de 44 años presenta varias úlceras confluentes y dolorosas en el glande, asociadas a adenopatías inguinales. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis primaria
- b) Herpes genital
- c) Linfogranuloma venéreo
- d) Chancroide
- e) Condiloma acuminado

73) Una paciente de 65 años, obesa, sin terapia hormonal de reemplazo, presenta un episodio de metrorragia de una semana de duración. Al examen físico se constata un útero levemente aumentado de tamaño. El resto de la evaluación clínica es normal.

Usted debe plantear el diagnóstico de:

- a) Cáncer de endometrio.
- b) Cáncer de cuello uterino.
- c) Atrofia genital avanzada sintomática.
- d) Atrofia endometrial.
- e) Cáncer de colon.

74) La clínica más característica de la hemofilia es:

- a) Niños con equimosis, hemartrosis y hematomas profundos ante traumas pequeños
- b) Adolescentes con equimosis recurrentes y menstruaciones abundantes
- c) Niños con epistaxis, gingivorragia y petequias a repetición
- d) Niños con petequias, equimosis y tendencia a formar cicatrices hipertróficas, ante traumas menores
- e) Niños con equimosis, hematuria y hemorragias digestivas recurrentes

75) Un paciente de 65 años presenta hemograma con hemoglobina: 9,6 g/dl, VCM: 106, plaquetas: 150.000 x mm³ y blancos: 4.100 x mm³. Le indican vitamina B12 y folatos, los que recibe por 4 meses. Se controla un nuevo hemograma que presenta valores similares. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Mieloma
- b) Leucemia aguda
- c) Mielodisplasia
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Talasemia

76) ¿Desde qué edad gestacional es posible ver el saco gestacional por una ecografía transvaginal?

- a) 4 semanas
- b) 5 semanas
- c) 6 semanas
- d) 7 semanas
- e) 8 semanas

77) La cinética de fierro que más orienta a anemia de enfermedades crónicas es:

- a) Ferremia alta, transferrina baja y ferritina baja
- b) Ferremia alta, transferrina alta y ferritina alta
- c) Ferremia baja, transferrina alta y ferritina baja
- d) Ferremia baja, transferrina baja y ferritina alta
- e) Ferremia baja, transferrina alta y ferritina alta

78) Un hombre de 44 años, afirma ser capaz de controlar el clima y está seguro de que él es responsable de evitar la mayoría de los huracanes, que azotan el mundo. Al ser interrogado de cómo puede ser eso posible, explica con lujo de detalles la manera como adquirió ese don hace muchos años y no acepta ninguna otra explicación. No ha presentado alucinaciones y se desempeña bien en su trabajo. Tiene buenas relaciones con sus amigos y familiares y nunca habla de su poder porque sabe que no lo entenderían. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad
- e) Psicosis reactiva

79) Un paciente se ve obligado a rematar su casa, debido a que presenta múltiples deudas y enfrenta la quiebra de su empresa. Su situación económica se estabiliza, sin embargo él y su familia deben disminuir el ritmo de gastos al que estaban acostumbrados, de manera drástica, arrendando un pequeño departamento. El paciente evoluciona con ánimo bajo, muy irritable, con sensación de fracaso e ideas de desesperanza. Refiere que siente mucha vergüenza, duerme gran parte del día y no tiene motivación para reactivar su empresa o buscar un empleo. Además ya no se junta con sus amigos y casi no habla con sus hijos ni esposa. Ella refiere que está muy preocupada, ya que previo a esto, era un hombre muy alegre, buen padre y buen esposo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno por estrés postraumático

80) Un paciente de 33 años presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, caracterizado, por ánimo irritable, agresividad e impulsividad en el gasto de dinero, que ha ido empeorando. Al examen se aprecia muy molesto, habla rápido, cambiando fácilmente de un tema a otro y menciona que tiene pensado postularse para senador de la república, ya que de seguro será electo, pues él cuenta con numerosas influencias en el gobierno. El diagnóstico más probable es:

- a) Psicosis reactiva
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Trastorno bipolar en fase maníaca
- e) Esquizofrenia

81) Un niño se sienta solo por largo rato, sin ningún apoyo, se pone de pie afirmado de algunos muebles, desconoce a los extraños y dice “mamá” y “papá”. La edad del niño es:

- a) 4 meses
- b) 6 meses
- c) 8 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

82) Un paciente con test de Sudán positivo, presenta disminución marcada de la excreción urinaria de D-xilosa en la prueba de D-xilosa oral. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

- a) Enfermedad celíaca
- b) Déficit de enzimas pancreáticas
- c) Sobrecrecimiento bacteriano
- d) Intolerancia a la lactosa
- e) Resección de íleon distal

83) Un recién nacido de 32 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, que inicia 2 horas después de nacido y que va empeorando al pasar de las horas. Se solicita radiografía de tórax que muestra pulmones radiopacos en patrón de vidrio esmerilado, con broncograma aéreo. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Oxigenoterapia
- b) Soporte respiratorio más surfactante endotraqueal
- c) Corticoides endovenosos
- d) Antibióticos endovenosos y soporte ventilatorio
- e) Broncodilatadores inhalados y corticoides sistémicos

84) ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos puede encontrarse en una otitis media aguda no complicada?

- a) Otorrea.
- b) Vértigo.
- c) Paresia facial.
- d) Nistagmus espontáneo.
- e) Cefalea intensa.

85) La asociación de ojo rojo profundo, efecto Tyndall y miosis es característico de:

- a) Queratitis
- b) Uveítis
- c) Glaucoma agudo
- d) Glaucoma crónico
- e) Endoftalmitis

86) Un paciente de 64 años, asintomático, se realiza un electrocardiograma que muestra frecuencia cardíaca de 70 lpm, con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz II, asociado a bloqueo completo de rama izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Holter de Arritmias
- b) Iniciar amiodarona
- c) Iniciar verapamilo
- d) Instalar marcapasos definitivo
- e) Observar evolución

87) Hombre de 63 años con antecedentes de soplo sistólico detectado hace 8 años, consulta por haber presentado un síncope durante ejercicio intenso.

¿Cuál de las siguientes es la causa más probable del síncope?

- a) Origen vaso-vagal
- b) Bloqueo aurículo-ventricular
- c) Infarto del miocardio
- d) Insuficiencia mitral
- e) Estenosis aórtica

88) En las dietas de los pacientes diabéticos se debe aconsejar fundamentalmente:

- a) Mantener los hidratos de carbono de absorción rápida y suprimir los de absorción lenta.
- b) Restringir tanto los hidratos de carbono de absorción rápida como los de absorción lenta.
- c) Reducir los hidratos de carbono de absorción rápida y mantener los de absorción lenta.
- d) Suprimir los alimentos con alto contenido en sacarosa y glucosa y restringir los alimentos ricos en fibra.
- e) Utilizar alimentos especiales para diabéticos.

89) La enfermedad de Cushing presenta las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Atrofia muscular
- b) Estrías violáceas
- c) Osteoporosis
- d) Hipoglicemia
- e) Hipertensión arterial

90) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con múltiples contusiones, fracturas costales y fractura de pelvis desplazada. Evoluciona con imposibilidad de orinar. Al examen físico se aprecia uretrorragia. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión renal
- b) Laceración renal
- c) Sección de uréter
- d) Lesión de la vejiga urinaria
- e) Lesión de uretra

SEGUNDA PARTE

1) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una indicación de administrar inmunoglobulina anti-D a una paciente embarazada Rh negativo?

- a) Prueba de Coombs indirecto positiva
- b) Amniocentesis
- c) Postparto
- d) Aborto completo
- e) 28 semanas de gestación

2) El hecho de que la producción de un síntoma y la obtención de alguna ventaja no se encuentren bajo control voluntario orienta a:

- a) trastorno facticio con síntoma psicológico
- b) simulación
- c) trastorno por conversión
- d) trastorno facticio con síntomas físicos
- e) trastorno orgánico

3) Un niño de 2 años presenta tos y disnea de inicio súbito, que ceden parcialmente mientras la madre lo llevaba a la urgencia. Al examen físico se aprecia asimetría del murmullo pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis obstructiva
- b) Neumotórax espontáneo
- c) Cuerpo extraño bronquial
- d) Bronquitis obstructiva
- e) Asma

4) Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aparece en el reposo y desaparece al tomar un objeto o al adoptar alguna posición. Se constata además disminución de la frecuencia del pestañeo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Síndrome cerebeloso
- d) Síndrome piramidal
- e) Envejecimiento normal

5) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación láctea de un lactante de 8 meses, que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

6) Un paciente de 45 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta de 4 semanas de evolución, asociado a fiebre intermitente, baja de peso y sudoración nocturna. En sus exámenes se aprecia anemia normocítica, con elevación de la VHS y leucocitosis de 11.000 células/mm³. La radiografía de tórax muestra bandas de fibrosis y retracción, asociadas a paquipleuritis en ambos ápices pulmonares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar espirometría basal y postbroncodilatador
- b) Solicitar fibrobroncoscopia y realizar biopsias bronquiales
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar baciloscopías de expectoración y cultivo para bacilo de Koch
- e) Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro

7) ¿En cuál de las siguientes pacientes aconsejaría el uso de anticonceptivos por vía transdérmica en lugar de vía oral?

- a) Mujer con cáncer de endometrio
- b) Mujer con antecedente familiar de cáncer de mama
- c) Mujer con lupus eritematosos sistémico
- d) Mujer con hipertrigliceridemia
- e) Mujer puérpera, dando lactancia

8) Un paciente obeso de 45 años, asintomático, presenta los siguientes niveles de lípidos:

Colesterol total: 340 mg/dl, LDL: 194 mg/dl, HDL: 32 mg/dl, Triglicéridos: 570 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta y ejercicios y controlar en 3 meses
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato
- d) Iniciar una asociación entre una estatina y un fibrato
- e) Iniciar una asociación entre ácido nicotínico, una estatina y un fibrato

9) Niña de 13 años presenta fiebre de baja intensidad, adenopatías occipitales, exantema maculopapular tenue en tronco y artralgias. No tiene inmunizaciones completas.

El diagnóstico más probable es:

- a) eritema infeccioso
- b) rubéola
- c) sarampión
- d) mononucleosis infecciosa
- e) escarlatina

10) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre los resultados de gases arteriales y patología es INCORRECTA?

- a) PaO₂: 40 mmHg, PaCO₂: 46 mmHg, Ph: 7,36 Bic: 25 mEq/l – Muestra de sangre venosa
- b) PaO₂: 60 mmHg, PaCO₂: 60 mmHg, Ph: 7,32 Bic: 30 mEq/l – Hipoventilación alveolar
- c) PaO₂: 80 mmHg, PaCO₂: 35 mmHg, Ph: 7,33 Bic: 18 mEq/l – Acidosis metabólica pura
- d) PaO₂: 92 mmHg, PaCO₂: 40 mmHg, Ph: 7,40 Bic: 24 mEq/l – Gases normales
- e) PaO₂: 70 mmHg, PaCO₂: 20 mmHg, Ph: 7,50 Bic: 17 mEq/l – Alcalosis metabólica

11) Una paciente de 20 años, cursando un embarazo de 30 semanas, inicia dinámica uterina. Al examen se constata 3 contracciones cada 10 minutos. Se realiza tacto vaginal que corrobora borramiento cervical de un 60%, sin dilatación. Se solicita una cervicometría ecográfica, que muestra un cuello uterino de 10 mm de longitud. Además se constata persistencia de la dinámica uterina, luego de 30 minutos de observación. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos e iniciar protocolo de tocolisis
- b) Iniciar corticoides y antibióticos por vía endovenosa
- c) Realizar amniocentesis
- d) Iniciar progestágenos y controlar en 48 horas
- e) Observa evolución, dejando a evolución espontánea

12) Un niño de 6 años, presenta desde hace unos meses, diarrea y baja de peso, asociado a piel seca, glositis y caída del cabello. Refiere que presenta diarrea acuosa, con gotas de grasa, sin presencia de sangre en las deposiciones. La etiología más probable es:

- a) Enfermedad inflamatoria intestinal
- b) Giardiasis
- c) Mala absorción intestinal
- d) Invaginación intestinal
- e) Estenosis pilórica hipertrófica

13) Una paciente de 59 años, cursando el segundo día de un infarto agudo al miocardio de la pared anterolateral, manejado con trombolisis con estreptoquinasa, presenta súbitamente pérdida de conciencia. Al examen físico se aprecia pulso débil, a 125x', regular, PA: 50/20mmHg y se observan las yugulares marcadamente ingurgitadas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Taquicardia ventricular
- b) Flutter auricular
- c) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
- d) Rotura del músculo papilar
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

14) Una paciente de 35 años presenta amenorrea de 4 meses de duración. El examen físico es normal, por lo que se solicita test de embarazo, que resulta negativo; prolactina y TSH, que resultan normales; prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógenos + progesterona, que resulta positiva; FSH y LH, que resultan elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Anovulación
- b) Hipogonadismo hipotalámico
- c) Amenorrea de origen uterino
- d) Insuficiencia ovárica primaria
- e) Hipopituitarismo

15) Una paciente de 30 años, consulta por dolor abdominal bajo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero normal y líquido libre en la cavidad peritoneal. La beta-HCG es de 7.000 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar laparoscopia
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y beta-HCG en 2 a 3 días
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar tocólisis de urgencia

16) La dermatitis del pañal se caracteriza por:

- a) Comprometer los pliegues y carecer de lesiones satélites
- b) Comprometer los pliegues y presentar lesiones satélites
- c) Respetar los pliegues y carecer de lesiones satélites
- d) Respetar los pliegues y presentar lesiones satélites
- e) Ser intensamente pruriginosa

17) ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección del púrpura trombocitopénico inmunológico primario en el adulto?

- a) Inmunosupresores
- b) Esplenectomía
- c) Corticoides
- d) Interferon
- e) Inmunoglobulina

18) ¿Qué vacuna puede recibir un niño severamente inmunodeprimido?

- a) Varicela
- b) Pentavalente (Difteria, Tétano, Pertusis, Hib y VHB)
- c) BCG
- d) Sarampión
- e) Polio Sabin

19) Un recién nacido de término, que pesó 3.000 Kg, presenta una zona de hipetricosis lumbar, de 3 cm de diámetro. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Síndrome de Down
- b) Neurofibromatosis
- c) Espina bífida
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita
- e) Recién nacido normal

20) El signo oftalmoscópico que indica mayor riesgo de hemorragia vítrea en un paciente con retinopatía diabética es la presencia de:

- a) edema macular difuso.
- b) microaneurismas en torno al polo posterior.
- c) manchas algodinosas.
- d) hemorragias redondas asociadas a dilataciones venosas.
- e) vasos de neoformación en el disco óptico.

21) Un paciente consulta por dolor epigástrico fluctuante, de carácter urente, que suele ser más intenso en los períodos de ayunas. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con omeprazol
- b) Realizar erradicación de *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar pH-metría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Realizar educación y controlar en un mes

22) ¿Cuál es la causa más frecuente de desaceleraciones variables durante el monitoreo electrónico intraparto de un embarazo de término?

- a) Compresión de la cabeza fetal
- b) Acidosis metabólica del feto
- c) Compresión del cordón umbilical
- d) Sufrimiento fetal
- e) Sueño fetal

23) Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de memoria desde hace 3 a 4 años. Hace una semana lo notan apático y con comportamiento extraño. Hace tres días, salió de compras y un vecino debió traerlo a casa pues no recordaba el camino. Desde hace dos días habla incoherencias, se agita y presenta insomnio. El diagnóstico más probable es::

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Trastorno psicótico
- d) Demencia frontotemporal
- e) Delirium

24) Hombre de 47 años consulta por fiebre de inicio brusco, calofríos y disuria. Al tacto rectal se constata próstata muy dolorosa a la palpación. Sin antecedentes de infecciones urinarias a repetición.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Prostatitis aguda
- b) Hiperplasia prostática benigna
- c) Infección urinaria baja
- d) Uretritis no bacteriana
- e) Prostatitis granulomatosa

25) La causa más frecuente de hipercalcemia en los pacientes ambulatorios es:

- a) Cáncer
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hipercalcemia ficticia
- d) Hipercalcemia farmacológica
- e) hipervitaminosis D

26) Una paciente de 31 años consulta por placas eritematosas que aparecen en los codos, tronco y cuero cabelludo, que aparecieron hace 4 meses, con periodos de remisión y exacerbación y que en el último tiempo han aumentado en tamaño y cantidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Pityriasis rosada
- c) Dermatitis de contacto
- d) Psoriasis
- e) Liquen plano

27) Un hombre de 45 años es mordido por el gato de su vecina, mientras le ayudaba a atraparlo, para llevarlo a control con su veterinario. Al examen físico se observan varios rasguños en los antebrazos y 4 lesiones puntiformes en el dorso de la mano y los dedos derechos sin signos de infección. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica, indicar amoxicilina más ácido clavulánico y observar al animal por 10 días
- b) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar cloxacilina
- c) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica y observar al animal por 10 días, sin necesidad de antibióticos
- d) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Realizar aseo y curación de la herida, administrar las vacunas antitetánica y antirrábica e indicar antibióticos de amplio espectro

28) Una paciente presenta eritema y pápulas faciales, asociadas a blefaritis y chalaziones a repetición. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Lupus sistémico
- c) Rosácea
- d) Demodexidiosis
- e) Dermatitis atópica

29) Un niño de 6 años presenta episodio de inicio súbito de compromiso de conciencia, asociado a contracción en flexión de las extremidades superiores y en extensión de las extremidades inferiores, seguido de movimientos repetitivos de todas las extremidades, de cerca de 3 minutos de duración. Al examen físico está en buenas condiciones, sin signos focales y no recuerda lo sucedido. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor cerebral
- b) Epilepsia primaria
- c) Epilepsia focal
- d) Esclerosis múltiple
- e) Convulsión inocente

30) Un paciente de 70 años consulta por palidez, baja de peso y fiebre recurrente. Al examen físico se palpa una masa axilar izquierda de 6 cm de diámetro, con varias adenopatías más pequeñas alrededor. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia
- b) Linfoma
- c) Mieloma
- d) Tuberculosis
- e) Enfermedad por arañazo de gato

31) Una paciente de 35 años con antecedente de hipermenorrea y anemia ferropénica, acude a control ginecológico, en el cual se palpa un útero nodular, aumentado de tamaño. El diagnóstico más probable es:

- a) Adenomiosis
- b) Endometriosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Miomatosis
- e) Cáncer de endometrio

32) La causa más común de muerte perinatal en Chile es:

- a) Hipoglicemia
- b) Infección
- c) Malformaciones congénitas
- d) Traumatismos
- e) Prematurez

33) Una niña de 8 años presenta IPT en p50, ITE en p5 e IPE: en p5. La curva de crecimiento muestra una velocidad de crecimiento normal. Se realiza radiografía de carpo que es compatible con una edad ósea de 6 años. El diagnóstico más probable es:

- a) Desnutrición
- b) Retraso puberal
- c) Síndrome de Turner
- d) Retraso constitucional del crecimiento
- e) Talla baja familiar

34) Un paciente de 66 años presenta un cuadro de constipación marcada de 3 días de evolución, sin poder presentar deposiciones, asociado a dolor abdominal. Luego presenta deposiciones diarreicas explosivas en una oportunidad. Refiere además historia de palidez y molestias abdominales de 1 mes de evolución. El examen físico muestra un paciente pálido, con abdomen blando, depresible y el tacto rectal demuestra una ampolla rectal sin deposiciones, sin hallar otras alteraciones.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vólvulo de colon sigmoide
- b) Cáncer de colon
- c) Obstrucción intestinal por bridas
- d) Síndrome de Ogilvie
- e) Diverticulitis

35) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta?

- a) Distrofia simpático refleja – Disminución de los pulsos distales
- b) Embolia grasa – Rash petequial
- c) Embolia grasa – Edema pulmonar no cardiogénico
- d) Distrofia simpático refleja – Cambios en la piel y vellos distales
- e) Síndrome compartimental – Dolor a la movilización distal

36) Una mujer multipara está en trabajo de parto en fase activa. Presenta 3 contracciones cada 10 minutos, feto en cefálica, cuello uterino completamente borrado, con dilatación de 5 cm y membranas íntegras. Dos horas después se mantiene igual, sólo que con una dilatación de 6 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar rotura de membranas
- b) Dejar evolucionar espontáneamente
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar fórceps
- e) Iniciar goteo oxitócico

37) Respecto a la pancreatitis aguda es FALSO que:

- a) Se diagnostica preferentemente con la determinación de los niveles plasmáticos de lipasa
- b) Su causa más frecuente es la litiasis biliar
- c) Inicialmente debe ser manejada con régimen cero
- d) El tratamiento quirúrgico está indicada en cerca de la mitad de los casos
- e) El TAC es la mejor imagen para evaluarla, sirviendo como factor pronóstico

38) La capacidad de una intervención (por ejemplo dar un fármaco) de generar resultados positivos (ejemplo mejoría de cierta enfermedad), en condiciones controladas o ideales, se denomina:

- a) Utilidad
- b) Riesgo relativo
- c) Eficacia
- d) Riesgo atribuible
- e) Eficiencia

39) ¿Qué medicamento es más útil para prevenir la recurrencia de episodios depresivos o maníacos en un paciente diagnosticado de trastorno bipolar?

- a) Fluoxetina
- b) Ácido valproico
- c) Benzodiazepinas
- d) Inhibidores de la monoamino-oxidasa
- e) Clozapina

40) Con propósitos clínicos, la hipoventilación alveolar se identifica en la gasometría arterial por uno de los siguientes trastornos:

- a) Aumento de la PO₂ venosa.
- b) Disminución de la PO₂ arterial.
- c) Aumento de la PCO₂ arterial.
- d) Disminución de la PCO₂ arterial.
- e) Disminución de la PCO₂ venosa y la PCO₂ arterial.

41) ¿Qué fracturas son frecuentes y deben buscarse dirigidamente en un paciente que cae de pie desde 3 metros de altura?

- a) Rodilla y cadera
- b) Cadera y columna
- c) Calcáneo y tobillo
- d) Columna y calcáneo
- e) Rodilla y tobillo

42) En una presentación cefálica, ¿a qué variedad de posición corresponde la palpación de la sutura lambda en relación al centro del pubis?

- a) Occipito transversa
- b) Occipito sacra
- c) Occipito ilíaca izquierda anterior
- d) Occipito pubiana.
- e) Occipito posterior.

43) Una mujer de 21 años presenta pésimas relaciones familiares con sus padres y con su hermano. Pelean frecuentemente y ella incluso ha llegado a agredir a su madre. Además presenta una relación muy intensa e inestable con su novio, con quien ha terminado y vuelto en reiteradas ocasiones. En 2 oportunidades ha intentado suicidarse, la última de ellas con ingestión de benzodicepinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Depresión psicótica
- c) Esquizofrenia hebefrénica
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno de personalidad límite

44) Identifique la asociación incorrecta entre la historia clínica y la patología mamaria

- a) Mujer de 65 años, con nódulo mamario irregular, que ha aumentado de tamaño y se asocia a “piel de naranja” de la mama comprometida – Cáncer de mama infiltrante
- b) Mujer de 20 años con nódulo mamario de 3 cm, y consistencia gomosa, fácil de movilizar – Fibroadenoma
- c) Mujer de 45 años con mastalgia premenstrual y mamas con nódulos de pequeño tamaño, bilaterales, sensibles – Carcinoma ductal in situ
- d) Puérpera con aumento de volumen doloroso de 4 cm en la axila derecha – Glándula mamaria accesoria
- e) Puérpera con eritema y dolor mamario bilateral – Mastitis linfangítica

45) Un paciente presenta súbitamente hemiparesia izquierda, asociada a parálisis del nervio oculomotor derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto talámico
- b) Accidente vascular embólico de arteria cerebral anterior
- c) Accidente vascular embólico de arteria cerebral media
- d) Accidente vascular embólico de arteria cerebral posterior
- e) Infarto de mesencéfalo

46) ¿Cuál de las siguientes es una manifestación de la artritis reumatoide?

- a) Sacroileítis
- b) Hematuria
- c) Pericarditis
- d) Trombocitopenia
- e) Úlceras orales

47) Un paciente de 60 años, con un cuadro de 2 semanas de tos y dolor torácico con tope inspiratorio, se realiza una radiografía de tórax que demuestra un exudado pleural izquierdo, de tamaño moderado. Se realiza punción y se obtiene un líquido pleural con LDH: 250 UI/l, proteínas: 5,8 g/dl, 800 células por mm³, con 90% de mononucleares, ADA: 60 UI/l y glucosa de 30 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame pleural secundario a cáncer
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Tuberculosis
- e) Transudado pleural

48) Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico trombótico
- b) Síndrome de Reiter
- c) Enfermedad de Behcet
- d) Vasculitis de Wegener
- e) Crioglobulinemia

49) Una paciente con historia de disnea se realiza una espirometría, con los siguientes resultados:

Basal: CFV: 44% del teórico VEF1: 40% del teórico VEF1/CVF: 78%

Postbroncodilatador: CFV: 46% del teórico VEF1: 48% del teórico VEF1/CVF: 80%

De entre los siguientes, ¿qué diagnóstico es compatible con estos resultados?

- a) EPOC
- b) Asma
- c) Bronquiectasias
- d) Fibrosis pulmonar idiopática
- e) Hipertensión pulmonar primaria

50) El examen confirmatorio para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico patológico es:

- a) endoscopia
- b) radiografía de esófago, estómago y duodeno
- c) determinación de pH esofágico de 24 hrs
- d) manometría esofágica
- e) cintigrama esofágico

51) Un niño de 1 mes de edad presenta ambos testículos en el conducto inguinal, sin embargo es posible descenderlos hasta el escroto, volviendo inmediatamente al conducto inguinal al soltarlos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral lo antes posible
- c) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral durante el segundo año de vida
- d) Solicitar marcadores tumorales anuales
- e) Solicitar cariograma

52) ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un paciente con trastorno conversivo?

- a) Mujer de 50 años, obesa, hipertensa, con cefaleas recurrentes, dolor abdominal crónico, prurito faríngeo y parestesias recurrentes, que se ha realizado múltiples exámenes sin encontrar alteraciones
- b) Mujer de 67 años, que pierde súbitamente la vista de ambos ojos, durante una pelea con su marido y recuperándola posteriormente. Se realiza el estudio pertinente, sin hallazgos.
- c) Hombre de 45 años que finge estar enfermo para conseguir cuidados por parte de sus familiares
- d) Mujer de 26 años que presenta dolor epigástrico cada vez que se siente angustiada o presionada
- e) Hombre de 36 años que considera que sus orejas son horribles, razón por la cual se deja el pelo largo para ocultarlas y ha pensado en operarlas en varias oportunidades. Al examen sus orejas son normales

53) Una paciente de 80 años presenta un cuadro de olvidos frecuentes y apatía, asociado a dificultades para oír. Al examen físico no se aprecian signos focales, está atenta y se aprecian los reflejos osteotendíneos disminuidos y lentos. ¿Qué examen debe pedir en primer lugar?

- a) VDRL
- b) Niveles plasmáticos de vitamina B12
- c) RMN de cerebro
- d) TAC de cerebro
- e) TSH

54) Se eligen 2 ciudades distintas y se comparan los índices de mortalidad infantil y las tasas de escolaridad de la población adulta, de modo de encontrar alguna relación entre el nivel de escolaridad de los padres y la tasa de mortalidad infantil. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Cohortes
- b) Casos y controles
- c) Ecológico
- d) Intervención comunitaria
- e) Ensayo de campo

55) Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Se le observa TA de 200/120 mmHg, edema en pies, hematuria macroscópica, urea 140 mg/dl, creatinina 3,4 mg/dl y proteinuria de 2 g/24 horas. Tiene muy probablemente:

- a) Síndrome nefrótico.
- b) Hipertensión vásculo-renal.
- c) Glomerulonefritis membranosa.
- d) Síndrome nefrítico agudo.
- e) Pielonefritis aguda.

56) Un paciente de 20 años presenta mucha ansiedad al realizar actividades en público, como hablar en público, disertar o incluso comer frente a los demás. Esto le ha traído problemas en su universidad, ya que sufrió una crisis de pánico previo a una presentación, por lo que obtuvo una baja nota. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de personalidad evitativa
- c) Agorafobia
- d) Fobia simple situacional
- e) Fobia social

57) Un paciente de 65 años sufre una caída de altura golpeándose el tórax contra el suelo. Evoluciona con cierto grado de dificultad respiratoria y al examen se constata abolición del murmullo pulmonar de la mitad inferior del campo pulmonar derecho y matidez en dicha zona. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Contusión pulmonar
- c) Neumotórax
- d) Hemotórax
- e) Derrame pericárdico

58) Una mujer de 55 años presenta miedo a que la asalten, por lo que ha dejado de salir de su casa. Además no le gusta que su marido ni que su hijo manejen por miedo a que puedan chocar. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Fobia social
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de personalidad evitativo
- d) Depresión
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

59) Un paciente de 30 años, previamente sano, presenta dolor epigástrico intenso, constante, irradiado al dorso y acompañado de vómitos alimentarios en varias oportunidades. Presenta FC: 97x', t°: 36,9°C, PA: 120/80 mmHg. El examen abdominal demuestra dolor a la palpación epigástrica, ruidos hidroaéreos presentes y ausencia de signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y solicitar radiografía simple de abdomen y pelvis
- b) Administrar suero fisiológico, analgésicos y antibióticos endovenosos
- c) Administrar analgesia y solicitar ecografía abdominal, hemograma y lipasa plasmática
- d) Administrar analgesia y solicitar un TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar laparotomía exploradora

60) La combinación de anemia, hipercalcemia, elevación de la creatinina y dolores óseos, debe hacer sospechar:

- a) Linfoma
- b) Mieloma
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Hipervitaminosis D
- e) Malaabsorción intestinal

61) Se realiza un estudio que compara el fármaco A contra el tratamiento habitual en la encefalitis herpética, obteniéndose los siguientes resultados:

Mueren Mejoran Total
Fármaco A 40 120 160
Tratamiento habitual 50 100 150
Total 80 170 250

Calcule el riesgo relativo

- a) 0,67
- b) 0,71
- c) 0,75
- d) 1
- e) 1,33

62) Una paciente de 22 años, cursando embarazo de término inicia trabajo de parto. El registro estresante muestra desaceleraciones tardías en relación al 80% de las contracciones uterinas. La frecuencia cardíaca basal del feto es 130 lpm y la variabilidad es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un tacto vaginal para determinar la vía de interrupción inmediata
- b) Solicitar ecodoppler umbilical
- c) Realizar perfil biofísico
- d) Esperar evolución espontánea
- e) Administrar corticoides endovenosos, antibióticos y tocolíticos

63) Un paciente de 20 años de edad presenta ojo rojo derecho, periférico, asociado a sensación de arenilla ocular y secreción serosa. Al día siguiente inicia síntomas en el ojo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis bacteriana
- b) Conjuntivitis viral
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Queratitis punctata
- e) Chalazión

64) Un paciente presenta un nódulo tiroideo derecho, asociado a síntomas de hipertiroidismo. Se solicita TSH que resulta menor a 0,02 UI/l, razón por la cual se realiza una cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo que muestra hipercaptación a nivel del nódulo, con ausencia de captación en el resto de la tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar betabloqueantes y propiltiouracilo
- b) Realizar tumorectomía
- c) Realizar tiroidectomía total
- d) Iniciar levotiroxina en dosis bajas
- e) Administrar yodo radiactivo

65) Una mujer de 19 años, primigesta, cursando embarazo de 30 semanas, presenta presión arterial de 156/98 mmHg en su control obstétrico. No presenta síntomas y la proteinuria cualitativa resulta +, sobre un máximo de 4+. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar alfa-metildopa
- b) Solicitar proteinuria cuantitativa, de 24 horas
- c) Solicitar hemograma, tiempos de coagulación, pruebas hepáticas, LDH, pruebas de función renal y proteinuria de 24 horas
- d) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
- e) Indicar semihospitalización y controlar la presión arterial frecuentemente, durante las próximas horas

66) Un paciente consulta por palpitaciones intensas. Al examen físico presenta una taquicardia a 160 lpm, regular, con PA: 120/90 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia regular con complejos QRS anchos (mayores a 0,12 segundos). La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar masaje carotideo
- b) Anticoagular con heparina
- c) Administrar amiodarona
- d) Administrar adenosina
- e) Administrar sulfato de magnesio

67) Un paciente de 30 años presenta un tumor testicular derecho, de consistencia sólida. Se solicita ecografía testicular que confirma el carácter sólido del tumor, por lo que se realiza una orquiectomía radical, cuya biopsia demuestra la presencia de un carcinoma embrionario. Los marcadores tumorales pre y postquirúrgicos son negativos y el TAC de abdomen y pelvis NO visualiza adenopatías retroperitoneales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar quimioterapia combinada
- b) Realizar radioterapia retroperitoneal
- c) Iniciar hormonoterapia
- d) Realizar linfadenectomía lumboaórtica (LALA modificada)
- e) Solicitar TAC de cerebro

68) Un paciente de 51 años, diagnosticado de cirrosis hepática por consumo crónico de alcohol, actualmente suspendido, consulta por aumento del perímetro abdominal. Al examen se constata ascitis moderada. Se solicita paracentesis diagnóstica que muestra albumina: 1,0 mg/dl, células: 139 por mm³, de predominio polimorfonuclear. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cefotaximo endovenoso
- b) Iniciar ciprofloxacino oral
- c) Realizar paracentesis evacuadora, con reposición de albúmina
- d) Indicar restricción hidrosalina e iniciar espironolactona y furosemida
- e) Derivar para instalar un TIPS

69) Un recién nacido de 3 días de vida presenta letargo, debilidad en la succión e hipotermia. En el examen físico se aprecia además un cierto grado de hipotonía. La conducta más adecuada es:

- a) Asegurar un ambiente temperado y administrar líquidos tibios, hasta recuperar la temperatura normal, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar cefadroxilo oral y enviar a domicilio explicando los signos de alarma
- c) Regular la temperatura y solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos y pruebas de función renal, decidiendo el manejo según hallazgos
- d) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de ceftriaxona y vancomicina endovenosa, inmediatamente
- e) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de cefotaximo y ampicilina endovenosa, inmediatamente

70) Un adolescente de 15 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y un exantema papulo-vesicular muy pruriginoso, que inició en el cuero cabelludo y que actualmente se ha generalizado. El diagnóstico más probable es:

- a) Varicela
- b) Prúrigo
- c) Escarlatina
- d) Eritema infeccioso
- e) Infección por enterovirus (Coxsackie)

71) Una paciente presenta un bocio difuso moderado, no doloroso. Se solicita TSH que resulta 12 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Riedel
- b) Tiroiditis de Hashimoto
- c) Enfermedad de Basedow-Graves
- d) Tiroiditis subaguda de Querverin
- e) Cáncer de tiroides

72) Una paciente presenta hipoacusia derecha que ha aumentado en el último tiempo. La otoscopía no muestra alteraciones por lo que se realizan pruebas de diapasones, que muestran Rinne (+) a izquierda y (-) a derecha y Weber que lateraliza a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otitis media fibroadesiva
- c) Otoesclerosis
- d) Sordera súbita
- e) Trauma acústico

73) Una mujer de 28 años presenta atraso menstrual, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Acude a control, realizándose una ecografía transvaginal, que muestra saco gestacional intrauterino de 10 mm de diámetro, sin visualización de embrión. Se dispone además de beta-HCG que resulta 2.000 UI/L. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado
- b) Repetir la beta-HCG en 48 horas
- c) Repetir la ecografía en 7 días
- d) Resolver quirúrgicamente
- e) Iniciar metotrexato

74) Un niño consume, accidentalmente, una sustancia desconocida, evolucionando con compromiso de consciencia y depresión respiratoria. Al examen físico presenta presión arterial y pulso normales, con frecuencia respiratoria de 6 rpm, sopor profundo y presencia de miosis bilateral, marcada, sin signos focales en el examen neurológico. ¿Qué sustancia fue consumida con mayor probabilidad?

- a) Anticolinérgicos
- b) Organofosforados
- c) Benzodiacepinas
- d) Opiáceos
- e) Agonistas adrenérgicos

75) Un recién nacido de 5 días de vida pesa 3.500 gr. Al nacer pesó 3.800 gr y se ha alimentado con lactancia materna exclusiva. La conducta más adecuada es

- a) Observar evolución, manteniendo la lactancia materna exclusiva
- b) Agregar fórmula láctea y mantener la lactancia materna
- c) Iniciar fórmula láctea y suspender la lactancia materna
- d) Solicitar test del sudor
- e) Iniciar nutrición parenteral

76) Una paciente de 28 años, con IMC: 32, presenta cuadros de temblor, sudoración y palpitaciones que aparecen 3 a 4 horas después de ingerir algunos alimentos. En una oportunidad se controló un hemoglucotest con valor de 50 mg/dl. La etiología de la patología descrita es:

- a) Tumoral
- b) Resistencia a la insulina
- c) Autoinmune
- d) Psicógena
- e) Hereditaria, autosómica dominante

77) ¿Cómo se contrae la hidatidosis?

- a) Por consumo de carne de cerdo o cordero, contaminada
- b) Por contacto con deposiciones humanas
- c) Por contacto con deposiciones de perro
- d) Por consumo de berros contaminados
- e) Por consumo de pescado contaminado

78) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia tratamiento antituberculoso con rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol durante 2 meses y luego sólo con rifampicina e isoniacida. Se controlan baciloscopías mensuales, obteniéndose los siguientes resultados: Mes 1: positiva, Mes 2: negativa, Mes 3: positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cultivo de Koch y ajustar el tratamiento antibiótico según el antibiograma
- b) Mantener el tratamiento con Isoniacida y rifampicina e iniciar pirazinamida
- c) Retomar el tratamiento inicial con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol
- d) Derivar a especialista para tratamiento con 5 fármacos antituberculosos
- e) Mantener el tratamiento con isoniacida y rifampicina, controlando con resultado del cultivo y nueva baciloscopía en un mes

79) Una paciente de 65 años ha notado algunas dificultades para ver. Al examen físico se aprecia una agudeza visual normal, sin embargo ha perdido gran parte de la visión periférica, manteniendo la visión central. El diagnóstico más probable es:

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma crónico
- c) Catarata
- d) Tumor de hipófisis
- e) Edema macular

80) Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el último tiempo se agrega compromiso del estado general, fiebre, hematuria y oliguria. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Vasculitis de Wegener
- c) Púrpura de Schoenlein Henoch
- d) Panarteritis nodosa
- e) Esclerodermia

81) La sección medular completa a nivel de C5 produce:

- a) Hipotensión, bradicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las 4 extremidades
- b) Hipertensión, taquicardia y paraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores
- c) Hipotensión, taquicardia y paraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores
- d) Hipertensión, bradicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las 4 extremidades
- e) Hipotensión, taquicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores

82) ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene contraindicación absoluta durante el embarazo?

- a) Fluoxetina
- b) Ergotamina
- c) Aspirina
- d) Hidralazina
- e) Insulina

83) Un paciente presenta dolor torácico de 2 días de evolución, con tope inspiratorio, que luego se asoció a marcado malestar general y síncope. Al examen físico se aprecia hipotenso, con yugulares ingurgitadas y colapso “y” prominente en el pulso venoso. El examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome coronario agudo
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Disección aórtica
- d) Taponamiento cardíaco
- e) Neumotórax

84) La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es:

- a) Enfermedad diverticular
- b) Cáncer de colon
- c) Angiodisplasia
- d) Hemorroides externos
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

85) Un niño de 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. Se ve de buen aspecto y sus signos vitales son normales. Se solicita hemograma que resulta normal, sedimento de orina con cilindros hialinos y gotas de grasa, sin hematuria; índice proteinuria/creatininuria de 3,1 y albuminuria de 2,7 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis postinfecciosa
- b) Enfermedad de Berger
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Glomerulopatía por cambios mínimos

86) Una paciente de 28 años, con dismenorrea crónica de 2 años de evolución, refiere que sus síntomas se han hecho cada vez más intensos y se ha agregado dispareunia profunda en los últimos meses. No presenta otros síntomas. La especuloscopia es normal y al tacto vaginal destaca dolor a la movilización cervical, siendo ésta difícil de realizar. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Endometriosis
- d) Cáncer de endometrio
- e) Adenomiosis

87) En un screening para diagnosticar una determinada enfermedad, 235 de 250 personas enfermas resultan positivas para el test aplicado y 600 de 680 personas normales resultan negativas para el mismo test.

La especificidad del test empleado es:

- a) 15/250
- b) 80/680
- c) 15/80
- d) 235/250
- e) 600/680

88) Lactante de 3 meses, peso de nacimiento 3.200 grs. En los últimos 2 meses se alimenta con lentitud y se pone sudoroso. Ha presentado bronquitis obstructivas a repetición.

Al examen: peso 4200 g, polipneico, saturación de hemoglobina 80% que se corrige al aportar oxígeno. Presenta crepitaciones basales bilaterales, hígado a 4 cm bajo reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Bronconeumonía en lactante hiperreactivo bronquial
- b) Displasia broncopulmonar
- c) Cardiopatía congénita cianótica
- d) Fibrosis quística
- e) Cardiopatía congénita no cianótica

89) El hiperparatiroidismo primario se presenta clásicamente como:

- a) Osteoporosis acelerada, asociada a hipercalcemia e hipercalcinuria
- b) Constipación crónica, asociada a hipercalcemia e hiperfosfemia
- c) Astenia y debilidad muscular, asociado a hipocalcemia e hiperfosfemia
- d) Contracturas musculares e hiperreflexia, asociado a hipercalcemia e hipocalciuria
- e) Hipercalcemia, hipocalciuria e hipofosfemia

90) La “danza arterial” es característica de:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Transposición de grandes vasos
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

Respuestas:

PRIMERA PARTE

Preguntas

Forma A

1

D

2

E

3

C

4

A

5

B

6

D

7

A

8

D

9

C

10

B

11

B

12

D

13

D

14

E

15

D

16

C

17

C

18

D

19

B

20

D

21

D

22

B

23

A

24

B

25

C

26	E
27	D
28	D
29	B
30	A
31	C
32	B
33	E
34	D
35	A
36	A
37	C
38	D
39	A
40	D
41	A
42	B
43	A
44	B
45	D
46	C
47	A
48	B
49	C
50	A
51	D
52	E
53	D
54	A
55	E
56	B

57	E
58	A
59	D
60	E
61	B
62	B
63	E
64	C
65	D
66	D
67	D
68	A
69	C
70	E
71	C
72	B
73	A
74	A
75	C
76	B
77	D
78	C
79	C
80	D
81	D
82	A
83	B
84	A
85	B
86	D
87	E

88	C
89	D
90	E

SEGUNDA PARTE

Preguntas	Forma A
1	A
2	C
3	C
4	B
5	B
6	D
7	D
8	C
9	B
10	E
11	A
12	C
13	C
14	D
15	A
16	C
17	C
18	B
19	C
20	E
21	D
22	C
23	E
24	A
25	B
26	D

27	A
28	C
29	B
30	B
31	D
32	E
33	D
34	B
35	A
36	A
37	D
38	C
39	B
40	C
41	D
42	D
43	E
44	C
45	E
46	C
47	D
48	B
49	D
50	C
51	A
52	B
53	E
54	C
55	D
56	E
57	D

58	E
59	C
60	B
61	C
62	A
63	B
64	E
65	E
66	C
67	D
68	D
69	E
70	A
71	B
72	C
73	C
74	D
75	A
76	B
77	C
78	E
79	B
80	B
81	A
82	B
83	D
84	A
85	E
86	C
87	E
88	E

89

A

90

B

Ensayo EUNACOM – Prueba 12

PRIMERA PARTE

1) Un paciente pierde mucho tiempo en el trabajo, ya que debe revisar si ha hecho correctamente las cosas. Por ejemplo, corrobora varias veces al día si ha enviado los e-mails y si ha adjuntado los archivos, ya que tiene la sensación de que se pudo haber enviado mal, o que se equivocó al escribir la dirección e-mail del receptor, o que ha adjuntado un archivo distinto. En una oportunidad envió 3 veces el mismo mail a su jefe, para asegurarse que le llegara. Refiere que está muy preocupado, ya que entiende que eso no es normal y algunos compañeros de trabajo han empezado a burlarse de él, sin embargo no puede controlarlo. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Benzodiacepina
- b) Litio
- c) Antipsicóticos típicos
- d) Antipsicóticos atípicos
- e) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina

2) Un paciente de 68 años, sin antecedentes de importancia, presenta deposiciones con estrías de sangre en varias oportunidades durante una semana. No presenta otros síntomas y su examen físico, incluyendo un tacto rectal, es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Solicitar colonoscopia
- c) Solicitar TAC abdominal
- d) Solicitar tiempo de sangría, recuento de plaquetas y tiempos de coagulación
- e) Observar evolución

3) ¿Cuál de los siguientes tratamientos anticonceptivos le indicaría a una paciente diagnosticada de Síndrome de ovarios poliquísticos?

- a) DIU medicado con levonorgestrel
- b) ACO combinados con etinil estradiol y drospirenona
- c) ACO con estrógeno solo
- d) ACO con progestágeno solo
- e) Anticonceptivos combinados de depósito

4) Usted atiende a un paciente de 25 años, con promiscuidad sexual, que consulta por un cuadro de malestar general, fiebre hasta 38,8°C y odinofagia, al que se ha agregado un exantema macular eritematoso generalizado. Al examen se palpan adenopatías generalizadas. Usted sospecha un síndrome retroviral agudo. ¿Qué examen le parece más adecuado para diagnosticarlo?

- a) Elisa VIH
- b) Western blot para VIH
- c) Recuento de linfocitos CD4(+)
- d) PCR para VIH y detección del antígeno p24
- e) Biopsia de ganglio linfático

5) Un paciente de 66 años presenta hematuria en 2 oportunidades. Además refiere que desde hace algún tiempo presenta disuria de esfuerzo, que ha ido en aumento. El tacto rectal demuestra la presencia de un nódulo derecho de 2 cm de diámetro y el APE es de 10 ng/ml. El diagnóstico más probable es:

- a) Prostatitis crónica
- b) Prostatitis aguda
- c) Cáncer de próstata
- d) Hiperplasia benigna de la próstata
- e) Estenosis uretral

6) Una paciente de 25 años inicia metrorragia abundante, asociada a dolor abdominal. Se solicita un test de embarazo en orina que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- b) Solicitar ecografía transvaginal
- c) Realizar legrado
- d) Realizar laparoscopia
- e) Indicar reposo y progestágenos

7) Un paciente hipertenso de 67 años, consulta por hemiparesia izquierda, de inicio súbito hace una hora. Al examen físico se aprecia hemiparesia izquierda de predominio Facio-braquial, con hemihipoestesia ipsilateral. Se solicita un TAC de cerebro sin contraste que demuestra la presencia de un hematoma intraparenquimatoso de 2 cm de diámetro, de localización talámica, sin signos de herniación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar angiografía carotídea de urgencia
- b) Iniciar medidas de neuroprotección, administrar oxígeno, prevenir la hiperglicemia e hipertermia, mantener presiones arteriales menores a 170/110 y controlar frecuentemente
- c) Realizar drenaje quirúrgico de inmediato
- d) Realizar trombolisis endovenosa
- e) Solicitar punción lumbar

8) Un niño de 5 años se cae de la cama, mientras saltaba en ella, golpeándose la cabeza contra el suelo. No perdió la consciencia, pero lloró por algunos minutos. Al examen físico está en buenas condiciones, con un pequeño hematoma de cuero cabelludo en la zona frontal. Su examen neurológico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, con indicación de reconsulta en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar TAC de cerebro con contraste
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- d) Solicitar radiografía simple de cráneo
- e) Hospitalizar para observación por 24 horas

9) Se realiza un estudio que pretende evaluar la utilidad de los anticuerpos contra el péptido citrulinado en los pacientes con artritis reumatoide. Se obtiene que están presentes en el 68% de los pacientes con artritis reumatoide y en el 2% de los pacientes sanos. Esto quiere decir que:

- a) La sensibilidad es 98%
- b) La especificidad es 98%
- c) El valor predictivo positivo es 98%
- d) El valor predictivo negativo es 98%
- e) Es un examen muy útil para descartar la artritis reumatoide

10) Un paciente de 64 años, cursando un infarto de pared inferior de una hora de evolución, presenta importante deterioro, constatándose una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar lidocaína endovenosa
- c) Administrar beta-bloqueador endovenoso
- d) Administrar atropina endovenosa
- e) Administrar adrenalina endovenosa

11) Un recién nacido presenta un cuadro de dificultad respiratoria severa al nacer. Al examen se auscultan ruidos hidroaéreos en el tórax. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía neonatal
- b) Síndrome de aspiración meconial
- c) Hernia diafragmática
- d) Atresia duodenal
- e) Enterocolitis necrotizante

12) Un paciente de 45 años sufre una caída a nivel, golpeándose el hombro contra el suelo. Al examen físico se aprecia hombro en charretera. Además presenta imposibilidad de abducir el hombro y anestesia en la zona deltoidea. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de hombro con lesión del nervio cubital
- b) Luxación posterior de hombro con lesión de nervio radial
- c) Luxación anterior de hombro con lesión del nervio radial
- d) Luxación posterior de hombro con lesión del nervio axilar
- e) Luxación anterior de hombro con lesión del nervio axilar

13) Un paciente sufre un asalto con pistola por un par de delincuentes, mientras se dirigía a su casa. Durante los días siguientes está muy angustiado, pensando frecuentemente en el hecho y con pesadillas recurrentes de que lo asaltan o le disparan. Refiere que se asusta con cualquier ruido y que tiene miedo a salir a la calle, por lo que ha limitado sus actividades normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de ansiedad generalizada
- d) Trastorno por estrés agudo
- e) Reacción normal

14) Un paciente hipertenso de larga data, de 60 años de edad, consulta por disnea y ortopnea, de cerca de un mes de evolución, que aparece al caminar 200 metros o más. Refiere además que en ocasiones se despierta ahogado en la noche, por lo que debe sentarse y respirar profundo. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y electrocardiograma que muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sin otras alteraciones. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Holter de arritmias
- b) Ecocardiograma
- c) Angiografía coronaria
- d) Test de esfuerzo
- e) Niveles plasmáticos de troponinas

15) Una paciente de 29 años presenta lesiones muy pruriginosas en ambos antebrazos. Al examen físico se aprecian pápulas eritemato-violáceas, con fina descamación en la cara anterior de las muñecas y la zona distal de los antebrazos. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen plano
- b) Dermatitis seborreica
- c) Dermatitis atópica
- d) Liquen simple
- e) Pitiriasis risada de Gibert.

16) Un paciente de 21 años consulta por lumbago de cerca de un mes de duración, que responde al uso de ibuprofeno. Refiere que es mayor en al despertar y que va disminuyendo a medida que realiza actividad física. Además ha presentado talalgia bilateral en el último tiempo. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el diagnóstico?

- a) Factor reumatoideo
- b) Anticuerpos antinucleares y anti-citoplasma de neutrófilo
- c) Hemograma – VHS y CK plasmáticas
- d) Radiografías simples de columna lumbosacra y articulaciones sacroiliacas
- e) Resonancia magnética nuclear de columna

17) Una paciente de 30 años consulta por leucorrea abundante, asociada a disuria. A la especuloscopia se aprecia leucorrea verdosa abundante, con marcados signos inflamatorios en la mucosa vulvar y cuello uterino. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginosi bacteriana
- b) Candidiasis vaginal
- c) Tricomoniasis
- d) Gonorrea
- e) Vulvovaginitis inespecífica

18) Un paciente de 60 años, diagnosticado de cáncer de pulmón, presenta un cuadro de desorientación. Al examen físico está enflaquecido, normotenso y en sus exámenes destaca una natremia de 118 mEq/L. ¿Qué diagnóstico es más probable?

- a) Síndrome de secreción ectópica de ACTH
- b) Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- c) Diabetes insípida
- d) Insuficiencia suprarrenal
- e) Síndrome

19) Una mujer está en trabajo de parto, con 7 cm de dilatación, 100% de borramiento, feto en presentación de vértice, en espaldas cruzadas, con membranas rotas. En el registro de la frecuencia cardiopulsofetal se constata desaceleraciones tardías (DIP) en relación a cada contracción uterina. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Realizar fórceps
- c) Administrar tocolíticos
- d) Solicitar ecografía doppler de arterias uterinas
- e) Realizar cesárea de urgencia

20) ¿Cuál de los siguientes fármacos puede agravar la situación de un paciente con hipokalemia?

- a) Enalapril
- b) Atenolol
- c) Ibuprofeno
- d) Furosemida
- e) Sulfato de magnesio

21) Un paciente de 65 años relata un cuadro que sufrió hace una semana, consistente en una hemiplejía izquierda de inicio súbito y 20 minutos de duración, que desapareció espontáneamente. Al examen físico se aprecia un soplo cervical derecho. El TAC de cerebro es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar angiografía carotídea
- b) Solicitar ecografía doppler de carótidas
- c) Indicar anticoagulación a permanencia
- d) Solicitar angioTAC de tórax y cuello
- e) Solicitar TSH, T4 libre y anticuerpos TRAB

22) Un niño de 3 años presenta odinofagia y fiebre hasta 38,5°C, asociado a rinorrea y tos escasa. Al examen físico se aprecia la faringe eritematosa, sin lesiones y se palpan algunas adenopatías cervicales bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático
- b) Indicar ibuprofeno + amoxicilina
- c) Solicitar cultivo de secreción faríngea
- d) Solicitar test pack para Streptococcus pyogenes
- e) Solicitar hemograma-VHS y PCR y decidir manejo según hallazgos

23) Un paciente de 50 años presenta disnea de esfuerzos desde hace cerca de un mes. Además refiere que debe dormir con 2 almohadas, ya que de lo contrario se ahoga. Al examen físico presenta un soplo distólico y su electrocardiograma sólo demuestra una onda "p" ancha. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Estenosis mitral

24) Una paciente de 60 años consulta por astenia y palidez, siendo diagnosticado de anemia, mediante un hemograma, con hematocrito de 28%, hemoglobina de 9 g/dl, VCM: 119, HCM: 35, plaquetas 140.000 y blancos 5.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia perniciosa
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Anemia ferropénica
- d) Mielodisplasia
- e) Aplasia medular

25) Una mujer de 30 años ha presentado 3 abortos espontáneos. Se realiza una ecografía transvaginal que visualiza un mioma submucoso de 1,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar histerectomía total
- b) Realizar biopsia Pipelle
- c) Realizar tumorectomía histeroscópica
- d) Indicar anticonceptivos orales
- e) Solicitar histerosalpingografía

26) Una paciente de 29 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al repetir el mismo ejercicio. Además refiere visión doble en algunas ocasiones. En su examen físico destaca ptosis izquierda y cierto grado de estrabismo divergente. El diagnóstico más probable es:

- a) Miastenia gravis
- b) Síndrome de Guillain Barré
- c) Esclerosis múltiple
- d) Lesión del tercer nervio craneal
- e) Síndrome de Claude Bernard Horner

27) Un paciente es diagnosticado de otitis media crónica. ¿Qué situación indicaría una mayor gravedad?

- a) Otorrea
- b) Presencia de una perforación timpánica
- c) Vértigo
- d) Hipoacusia
- e) Tinnitus

28) Una paciente de 4 años, es traída por su madre, ya que desde hace 3 días ha presentado orinas oscuras y de mal olor, no asociado a otros síntomas. La paciente se encuentra en buenas condiciones generales. Se estudia con urocultivo que muestra crecimiento de E.coli multisensible, por lo que se inicia tratamiento antibiótico con buena respuesta clínica y obteniendo cultivo negativo dos días luego de completar tratamiento antibiótico. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la acción más adecuada a realizar con la paciente? :

- a) Dar alta sin necesidad de control ni estudios
- b) Estudiar con ecografía renal y vesical
- c) Dejar con profilaxis antibiótica y realizar uretrocistografía
- d) Realizar cintigrafía renal para evaluar presencia de cicatrices renales
- e) Estudiar con cistomanometría

29) Un paciente cursando una neumonía inicia tratamiento con amoxicilina, sin embargo no mejora luego de 3 días de tratamiento, presenta mayor fiebre y dolor con tope inspiratorio. Se solicita una radiografía de tórax que confirma la presencia de un derrame, el que se punciona mostrando abundantes polimorfonucleares, con pH: 6,9. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar la amoxicilina por amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Hospitalizar, drenar el derrame mediante toracocentesis e iniciar ceftriaxona endovenosa + metronidazol
- c) Hospitalizar, iniciar ceftriaxona endovenosa e instalar un tubo pleural, con trampa de agua
- d) Hospitalizar, iniciar cloxacilina endovenosa y administrar fibrinolíticos intrapleurales
- e) Mantener el tratamiento

30) Una mujer de 38 años, cursando un embarazo de 33 semanas presenta metrorragia abundante, de color rojo brillante. No hay contracciones uterinas y el registro basal no estresante es reactivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo molar
- b) Placenta previa
- c) Desprendimiento de placenta
- d) Rotura de vasa previa
- e) Salida del tapón mucoso

31) Una paciente de 24 años consulta por una cuadro de malestar general y palpitaciones, que inició hace cerca de 3 meses y que ha ido en aumento. Refiere que se ha sentido muy acalorada, que suda mucho y que su tránsito intestinal se ha acelerado, presentando 3 deposiciones al día. Al examen físico se aprecia retracción palpebral bilateral, con piel húmeda, FC: 105 x', PA: 120/80 mmHg. Además se constata la presencia de un bocio difuso de 5 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Querverlein
- b) Bocio multinodular tóxico
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Cáncer folicular de tiroides
- e) Enfermedad de Basedow Graves

32) Una paciente presenta de 40 años pierde la consciencia de manera súbita, mientras peleaba con su marido, recuperándose 15 minutos después. No tiene antecedentes de importancia y su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. Ella no parece muy preocupada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por somatización
- b) Trastorno conversivo
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno disociativo
- e) Accidente isquémico transitorio

33) Un recién nacido prematuro, de 4 días de vida, presenta deterioro general, vómitos y deposiciones sanguinolentas. Al examen físico se aprecia distensión abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Invaginación intestinal
- d) Malrotación intestinal
- e) Enfermedad de Hirschsprung

34) Un paciente de 60 años fumador, presenta tos con expectoración hemoptoica desde hace unas semanas. Además ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen está delgado, afebril, sin alteraciones en el examen pulmonar. El diagnóstico es:

- a) Tuberculosis
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Cáncer de pulmón
- d) Bronquitis crónica
- e) Bronquiectasias

35) Un paciente de 34 años consulta por dolor ocular izquierdo y ojo rojo. Presenta fotofobia intensa y epifora. Al examen físico se aprecia blefarospasmo, con ojo rojo profundo. El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis aguda
- b) Conjuntivitis viral
- c) Glaucoma agudo
- d) Queratitis aguda
- e) Endoftalmitis aguda

36) Una mujer, cursando un embarazo de 40 semanas, complicado con una diabetes mellitus gestacional, se realiza una ecografía obstétrica que muestra peso fetal de 4.500 gramos. El feto está en cefálica, sus pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras y el tacto vaginal muestra un cuello blando, cerrado, anterior, sin borramiento. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Inducir el parto con oxitocina
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Realizar cesárea
- e) Solicitar hemoglobina glicosilada

37) Un paciente de 24 años presenta un cuadro de dolor abdominal y diarrea de 4 semanas de evolución, asociado a febrículas ocasionales y pujo rectal. En algunas oportunidades las deposiciones han presentado estrías de sangre. Al examen físico se palpa una masa abdominal sensible en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Fecaloma
- c) Enfermedad de Cröhn
- d) Colitis ulcerosa
- e) Enfermedad celíaca

38) Una niña recibe, por error, una dosis de lidocaína mucho mayor a la aceptada para su peso, durante un procedimiento de cirugía menor, con anestesia local. La conducta más adecuada es:

- a) Dar soporte circulatorio y administrar naloxona
- b) Dar soporte circulatorio, administrar anticonvulsivantes en caso de convulsiones y administrar solución de lípidos por vía endovenosa, en caso de estar disponible.
- c) Dar soporte circulatorio, administrar suero fisiológico y administrar bicarbonato endovenoso
- d) Administrar suero fisiológico y administrar gluconato de calcio endovenoso
- e) Indicar sedación con etomidato y conectar a ventilador mecánico

39) Un paciente de 8 años presenta disnea tos y sibilancias, que aparecen con el ejercicio. En ocasiones usa salbutamol, con alivio de los síntomas, sin embargo es frecuente que presente tos en la noche y en ocasiones respiración ruidosa. Nunca ha requerido de tratamiento de urgencia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Prick test
- b) Iniciar tratamiento con salmeterol inhalado cada 12 horas y salbutamol en caso de síntomas
- c) Iniciar tratamiento con fluticasona inhalada cada 12 horas y salbutamol en caso de síntomas
- d) Iniciar tratamiento con fluticasona inhalada cada 12 horas y salmeterol en caso de síntomas
- e) Iniciar tratamiento con prednisona oral y salbutamol en caso de síntomas

40) Un paciente de 56 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 1g cada 8 horas, glibenclamida 10 mg cada 12 horas y enalapril 20 mg cada 12 horas, acude a control. Su presión arterial promedio es 136/76 mmHg, sus hemoglucotest de ayuno promedio son 140 mg/dl, y los postprandiales, 167 mg/dl. Su hemoglobina glicosilada es 7,8%. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento igual y controlar en 3 meses
- b) Agregar hidroclorotiazida al tratamiento
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- d) Agregar insulina cristalina al tratamiento
- e) Agregar insulina NPH al tratamiento

41) Un niño de 7 años presenta un cuadro de edema palpebral, asociado a hipertensión y hematuria. Se solicitan exámenes donde se constata creatininemia: 1,0 y complemento disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis estreptocócica
- b) Nefrosis lipoidea
- c) Enfermedad de Berger
- d) Pielonefritis aguda
- e) Síndrome hemolítico urémico

42) Un paciente de 59 años, cirrótico por hepatopatía alcohólica, se realiza una endoscopia digestiva alta de control, que demuestra várices esofágicas de tamaño moderado. Un año atrás sufrió una hemorragia variceal que fue tratada mediante ligadura endoscópica, con buena evolución. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar propranolol y realizar ligadura de várices
- b) Iniciar propranolol
- c) Instalar un TIPS
- d) Iniciar tratamiento diurético y realizar ligadura de várices
- e) Observar evolución y controlar con nueva endoscopia en 6 meses

43) Un paciente de 68 años presenta pérdida de consciencia mientras miraba televisión. El episodio fue presenciado por su mujer, que afirma que perdió la consciencia de manera súbita, estuvo inconsciente e inmóvil por cerca de 30 segundos y que se recuperó completamente de manera rápida. El diagnóstico más probable es:

- a) Síncope vasovagal
- b) Síncope por ortostatismo
- c) Síncope cardiogénico
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Accidente isquémico transitorio

44) Un niño de 12 años presenta desde hace 3 días aparición de múltiples lesiones eritematosas en ambas extremidades inferiores y los glúteos, indoloras, que partieron como petequias, pero que han aumentado algo de tamaño. Además ha presentado dolor abdominal y hematuria en algunas oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis posestreptocócica
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Meningococcemia
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Púrpura de Schönlein Henoch

45) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de diarrea crónica de 6 meses de duración, que en el último tiempo se ha vuelto disintérica. Además presenta dolor abdominal frecuente y fiebre. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar anticuerpos anti-transglutaminasa
- c) Solicitar coprocultivo y parasitológico seriado
- d) Iniciar antibióticos orales
- e) Solicitar ecografía abdominal

46) Se desean conocer los factores de riesgo involucrados en la patogénesis de una enfermedad muy infrecuente en la población. ¿Qué diseño de estudio es el más adecuado?

- a) Cohortes
- b) Casos y controles
- c) Ensayo clínico
- d) Ecológico
- e) De prevalencia

47) Una mujer de 35 años se realiza un PAP que muestra presencia de células glandulares atípicas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de endometrio
- b) Realizar cono biopsico
- c) Realizar colposcopia y curetaje endocervical
- d) Solicitar test de detección de virus papiloma humano
- e) Observar evolución

48) Un paciente de 45 años, con antecedente de estenosis mitral consulta por disnea y malestar general de 2 semanas de evolución. Al examen físico se aprecia FC: 100x', t°: 38,9°C, FR: 15 rpm, crepitaciones pulmonares escasas bibasales y examen cardíaco compatible con su valvulopatía. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Enfermedad reumática
- c) Pericarditis aguda
- d) Endocarditis bacteriana
- e) Neumonía adquirida en la comunidad

49) Un paciente de 40 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos y sensación febril, de 24 horas de evolución. Al examen físico presenta FC: 90x', PA: 120/80 mmHg, T°: 38,0°C. El abdomen es especialmente doloroso a la palpación del hipocondrio derecho, los ruidos hidroaéreos están presentes y no tiene signo de Blumberg. El hemograma muestra leucocitosis, además tiene elevación de la PCR, discreta elevación de la bilirrubina, con transaminasas y lipasa en rangos normales. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Radiografía simple de abdomen
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC abdominal
- d) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- e) Endoscopia digestiva alta

50) Una mujer de 34 años se realiza un test de embarazo, por atraso menstrual, que resulta positivo. La ecografía transvaginal no visualiza gestación intrauterina. Se visualiza un tumor anexial derecho de 3,5 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- b) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- c) Resolver quirúrgicamente
- d) Iniciar metotrexato
- e) Realizar legrado

51) Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, dolor abdominal y náuseas de 3 días de evolución. En el último día se agregaron vómitos y desorientación. Al examen físico se aprecia deshidratado, con FC: 110x', PA: 100/68 mmHg, FR: 20x'. Está desorientado y su hemoglutest resulta 510 mg/dl. En sus exámenes de sangre destaca pH: 7,25, bicarbonato: 16mEq/L, Na: 145 mEq/L, K: 4,0 mEq/L, Cl: 102 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Debut de diabetes, con cetoacidosis diabética
- b) Debut de diabetes, con síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- c) Insuficiencia suprarrenal aguda
- d) Tormenta tiroidea
- e) Sepsis de origen abdominal

52) Un recién nacido de 17 días de vida, presenta ictericia que llega hasta los muslos, sin otros síntomas. Se solicita bilirrubinemia diferenciada, que demuestra hiperbilirrubinemia de predominio conjugado. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia por leche materna
- c) Hipotiroidismo congénito
- d) Atresia biliar primaria
- e) Ictericia hemolítica

53) Un paciente de 40 años, que vive en la región de la araucanía, presenta un cuadro de malestar general, con mialgias muy intensas, asociada a fiebre hasta 40°C. Su examen físico no aporta mayor información, pero su hemograma muestra eosinofilia marcada de 40%. El diagnóstico más probable es:

- a) Larva migrante visceral
- b) Triquinosis
- c) Hidatidosis
- d) Distomatosis
- e) Teniasis

54) Una mujer de 35 años consulta por dolor abdominal, asociado a leucorrea escasa y fiebre. Al examen físico se constata dolor a la palpación hipogástrica, la especuloscopia muestra leucorrea proveniente del OCE y el tacto vaginal revela dolor a la palpación abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Aborto séptico
- c) Tricomoniasis
- d) Cervicitis aguda
- e) Proceso inflamatorio pélvico

55) Una mujer de 55 años de personalidad ansiosa, presenta miedo a que le pase algo malo a ella o a sus hijos, como un accidente de tránsito o un asalto, o bien que haya un terremoto que pueda dañarla a ella o a sus familiares. Por eso sale poco de su casa y se angustia mucho cuando sus hijos salen o llegan tarde. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de angustia
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno de estrés postraumático
- e) Trastorno delirante crónico

56) Usted atiende a un paciente de 78 años, que acude a un control rutinario con un perfil bioquímico, con los siguientes resultados: BUN: 21 mg/dl, glicemia: 89 mg/dl, albumina: 3,5 g/dl, proteínas totales: 6,3 g/dl, calcio: 13,2 mg/dl, fósforo: 6,3 mg/dl, colesterol total: 180 mg/dl, triglicéridos: 150 mg/dl, bilirrubina: 0,8 mg/dl, fosfatasa alcalina: 412 UI/L, GOT: 35 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de vitamina D
- b) Déficit de vitamina B12
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hipercalcemia secundaria a cáncer
- e) Sano

57) Un paciente de 60 años presenta un cuadro de baja de peso y vómitos frecuentes. Refiere además epigastralgia urente frecuente y astenia. El examen físico muestra palidez, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar pH-metría esofágica
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Iniciar omeprazol oral a permanencia

58) Un niño de 4 años es diagnosticado de coqueluche. Tiene un hermano de 1 año y otro de 5 años, ambos con sus esquemas de vacunación al día. La conducta más adecuada para con sus hermanos, según la norma actual de manejo de contactos de coqueluche, es :

- a) Administrar la vacuna DPT al de 1 año y la vacuna DPaT acelular al de 5 años
- b) Administrar la vacuna DPT al de 1 año y observar al de 5 años
- c) Administrar profilaxis antibiótica al de 1 año y la vacuna DPT al de 5 años
- d) Administrar la vacuna DPT al de 1 año y profilaxis antibiótica al de 5 años
- e) Administrar profilaxis antibiótica a ambos

59) Un paciente un infarto al miocardio de pared lateral. Mientras era manejado con tratamiento conservador (aspirina, nitroglicerina, oxígeno), presenta pérdida de consciencia. Usted lo evalúa a los dos minutos, constatando que no presenta pulso, por lo que activa el botón de paro, iniciando masaje cardíaco. Luego de 2 minutos de masaje constata que permanece sin pulso y que el monitoreo electrocardiográfico muestra una fibrilación ventricular. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar adrenalina endovenosa y proseguir con el masaje cardíaco
- b) Desfibrilar eléctricamente, administrar adrenalina endovenosa y proseguir con el masaje cardíaco
- c) Desfibrilar eléctricamente, administrar amiodarona endovenosa y proseguir con el masaje cardíaco
- d) Desfibrilar eléctricamente y proseguir con el masaje cardíaco
- e) Desfibrilar eléctricamente, administrar adrenalina y amiodarona endovenosa e proseguir con el masaje cardíaco

60) Un paciente de 75 años consulta por disminución lenta y progresiva de la agudeza visual, sin otros síntomas. Refiere que el problema se agrava en condiciones con mucha luz y que mejora en situaciones más oscuras. El diagnóstico más probable es:

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Catarata
- c) Glaucoma crónico
- d) Retinopatía diabética
- e) Uveítis

61) Un paciente está en tratamiento con un fármaco por una patología psiquiátrica no precisada. Evoluciona con marcado malestar general, vómitos, náuseas y dolor abdominal y se aprecia temblor de las extremidades superiores. ¿Qué fármaco es con mayor probabilidad?

- a) Risperidona
- b) Amitriptilina
- c) Citalopram
- d) Litio
- e) Carbamazepina

62) Un paciente de 65 años presenta aumento de volumen cervical de lento crecimiento en el último año, asociado a fiebre ocasional. Al examen físico se aprecian varias adenopatías cervicales izquierdas y submandibulares, indoloras, de entre 2 y 5 cm de diámetro. También presenta algunas adenopatía axilares ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer gástrico metastatizado
- b) Linfoma
- c) Leucemia
- d) Enfermedad por arañazo de gato
- e) Arteritis de la temporal

63) Un paciente sufre un accidente laboral, resultando con traumatismo de tórax. Evoluciona con gran dificultad respiratoria y luego compromiso de consciencia. Al ser evaluado, está hipotenso, satura 80% a FiO2 ambiental y se constata asimetría torácica y yugulares ingurgitadas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax de urgencia
- b) Realizar intubación orotraqueal de inmediato
- c) Administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla de recirculación
- d) Realizar punción inmediata del segundo espacio intercostal
- e) Realizar ventilaciones a presión positiva con Ambú

64) Un paciente de 6 años de edad presenta un cuadro de odinofagia y tos seca, de 15 días de evolución, que ha ido en aumento, volviéndose productiva. Al examen físico se aprecian sibilancias y crepitaciones bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolointersticial bilateral, mayor en las bases. El agente etiológico más probable es:

- a) Mycoplasma
- b) Neumococo
- c) Virus respiratorio sincicial
- d) Adenovirus
- e) Alergeno respiratorio

65) Un paciente de 69 años consulta por dolor torácico intenso de 2 horas de evolución. Al examen físico presenta FC: 110x', PA: 190/120 mmHg, se ausculta un ritmo regular en 2 tiempos, con soplo diastólico III/VI en el precordio y algunos crépitos pulmonares. La radiografía de tórax demuestra signos de edema pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Disección aórtica
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Pericarditis aguda
- e) Distrés respiratorio

66) Un recién nacido prematuro presenta un cuadro de taquipnea y quejido, que inició una hora después de nacer. Al examen físico se auscultan algunos crépitos pulmonares bilaterales. La radiografía de tórax muestra pulmones con relleno en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. El diagnóstico es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Neumonía neonatal
- e) Secuestro pulmonar

67) Una mujer embarazada de término inicia trabajo de parto. Al momento de la rotura de membranas se produce metrorragia, seguida pocos minutos después de bradicardia fetal a 60x'. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura uterina
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- c) Placenta previa sangrante
- d) Procidencia de cordón
- e) Rotura de vasa previa

68) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia tratamiento antituberculoso asociado. Alcanza a tomar los fármacos por 3 meses, sin embargo no acude a los controles siguientes. Usted lo revalúa luego de dos meses después de haber abandonado el tratamiento bisemanal y está asintomático, sin alteraciones en su examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Reiniciar el tratamiento desde el comienzo, con 4 fármacos
- b) Solicitar PPD y radiografía de tórax y decidir manejo según resultado
- c) Retomar el tratamiento en donde quedó, continuando con 2 fármacos
- d) Solicitar baciloscopía y decidir manejo según resultado
- e) Derivar a especialista para tratamiento con 5 fármacos

69) un paciente sufre una torsión de rodilla mientras jugaba fútbol, evolucionando con dolor, aumento de volumen e inestabilidad de la rodilla izquierda. Al examen físico presenta signo de cajón anterior y signos de derrame articular, el que se punciona, dando salida a sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del ligamento colateral lateral
- b) Lesión meniscal
- c) Lesión del ligamento cruzado anterior
- d) Lesión del ligamento cruzado posterior
- e) Fractura de rodilla

70) Un paciente de 80 años presenta fiebre y malestar general de 2 semanas de evolución, asociado a cefalea y debilidad para masticar. Ha bajado de peso y en una oportunidad perdió la visión del ojo izquierdo por completo, recuperándola algunos minutos después. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor cerebral
- b) Absceso cerebral
- c) Arteritis de la temporal
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Esclerosis múltiple

71) Un niño dice varias palabras, muchas de ellas de manera incorrecta, aunque se hace entender perfectamente por personas ajenas a su familia. Es capaz de formar frases de 2 a 3 palabras. Pedalea en un triciclo, ayuda a desvestirse y es capaz de correr, pararse en un pie y saltar con ambos pies. ¿Qué edad tiene aproximadamente?

- a) 12 meses
- b) 18 meses
- c) 24 meses
- d) 36 meses
- e) 48 meses

72) Una paciente de 26 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias. Ha tenido 2 abortos espontáneos y su examen de orina muestra microhematuria y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por VIH
- b) Enfermedad de Chagas
- c) Sífilis
- d) Lupus sistémico
- e) Vasculitis de Wegener

73) Un paciente de 70 años, calvo, presenta varias lesiones ásperas en la frente y en las zonas expuestas del cuero cabelludo. Se aprecian como pápulas eritematosas, descamativas, hiperqueratósicas. No presentan dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Carcinoma basocelular
- b) Dermatitis seborreica
- c) Carcinoma espinocelular
- d) Queratosis seborreica
- e) Queratosis actínica

74) Un paciente de 45 años, presenta elevación de las transaminasas hasta 3,5 veces por sobre el valor normal. Al examen físico se aprecia con sobrepeso, con hepatomegalia sensible. Su serología viral es negativa y la ecografía abdominal muestra aumento de la ecogenicidad hepática. El diagnóstico más probable es:

- a) Cirrosis biliar primaria
- b) Colangitis esclerosante primaria
- c) Hepatitis autoinmune
- d) Esteatohepatitis no alcohólica
- e) Hemocromatosis

75) Una mujer de 25 años, multipara de 2, con ambos partos por cesárea, está cursando un nuevo embarazo de 36 semanas, sin embargo presenta rotura de membranas, confirmada con test de detección de alfa microglobulina placentaria. El feto se palpa en cefálica. El registro cardíaco fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Dejar a evolución espontánea
- c) Administrar tocolíticos
- d) Administrar antibióticos y corticoides y observar evolución
- e) Administrar antibióticos y observar evolución

76) Un paciente se realiza una ecografía abdominal en busca de patología biliar, la que no visualiza cálculos biliares, sin embargo, como hallazgo, identifica un tumor de 8 cm de diámetro en el riñón izquierdo, de aspecto sólido. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Solicitar TAC con contraste
- c) Realizar punción con aguja gruesa y biopsia
- d) Realizar quimioterapia + radioterapia
- e) Observar evolución

77) El rendimiento de una matrona, que trabaja en la atención primaria, se ve reflejado de mejor forma es:

- a) Número de horas trabajadas por semana
- b) Número de pacientes vistos por hora de trabajo
- c) Relación días trabajados / días del mes
- d) Número de reclamos promedio por paciente evaluado
- e) Número de muertes por paciente evaluado

78) Una paciente ingiere altas dosis de diazepam con intención suicida, evolucionando con compromiso de conciencia. Al examen físico está en coma, con FR: 2 respiraciones por minuto. ¿Qué alteración es más probable de ser encontrada en su gasometría arterial?

- a) PaO₂: 55mmHg, PCO₂: 70mmHg, HCO₃: 29 mEq/L, pH: 7,25
- b) PaO₂: 95mmHg, PCO₂: 70mmHg, HCO₃: 14 mEq/L, pH: 7,40
- c) PaO₂: 65mmHg, PCO₂: 25mmHg, HCO₃: 22 mEq/L, pH: 7,50
- d) PaO₂: 58mmHg, PCO₂: 49mmHg, HCO₃: 35 mEq/L, pH: 7,45
- e) PaO₂: 40mmHg, PCO₂: 45mmHg, HCO₃: 15 mEq/L, pH: 7,25

79) Un niño no acudió a vacunarse cuando cumplió un año de edad, sin embargo usted lo recibe a los 18 meses, en buenas condiciones, asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada desde el punto de vista de sus inmunizaciones con el nuevo calendario PNI?

- a) Administrar la vacuna pentavalente y polio oral
- b) Administrar la vacuna pentavalente, polio oral, trivírica y antineumocócica conjugada
- c) Administra la vacuna trivírica y antineumocócica conjugada
- d) Administar la vacuna pentavalente y antineumocócica conjugada, y en un mes administrar la trivírica y la polio oral
- e) Administrar la vacuna trivírica y antineumocócica conjugada, y en un mes administrar la vacuna pentavalente y polio oral

80) Un paciente de 30 años consulta por cefalea recidivante, que en ocasiones es muy molesta, de localización occipito-temporal y que suele ser mayor en la tarde. Al examen físico no presenta signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia de Arnold
- b) Migraña
- c) Cefalea cluster
- d) Cefalea tensional
- e) Síndrome de hipertensión endocraneana

81) Un paciente presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 horas de evolución, muy intenso, asociado a hematuria en una oportunidad. El dolor se irradia a los genitales y ha presentado vómitos en varias oportunidades. El examen más adecuado para este paciente es:

- a) Pielo TAC
- b) Ecografía abdominal
- c) Resonancia magnética nuclear
- d) TAC de abdomen con contraste endovenoso
- e) Exploración quirúrgica

82) Una mujer embarazada de 10 semanas por amenorrea, confirmado con test de embarazo en orina, presenta náuseas y vómitos frecuentes. Al examen se palpa útero suprapúbico y un tumor anexial a cada lado. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo gemelar
- b) Polihidroamnios
- c) Embarazo ectópico
- d) Embarazo molar
- e) Embarazo normal

83) Un paciente consulta por dolor en un oído, muy intenso y cree que tiene un bicho dentro. A la otoscopia se observan las patas de un insecto, que se mueve dentro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar lavado de oído con agua tibia
- b) Realizar lavado de oído con suero fisiológico
- c) Retirarlo con una pinza
- d) Llenar el conducto auditivo externo con vaselina
- e) Derivar de inmediato

84) Una paciente de 25 años, cursando su 30ª semana de embarazo, presenta tristeza y anhedonia marcada. Lloro frecuentemente y ha pensado en abortar, aunque dice que no lo hará. Además refiere insomnio e ideas de su vida se arruinarán con el embarazo. No presenta ideación suicida. ¿Qué tratamiento le parece más adecuado?

- a) Terapia electroconvulsiva
- b) Psicoterapia + fluoxetina
- c) Psicoterapia + imipramina
- d) Psicoterapia + bupropión
- e) Psicoterapia + risperidona

85) Para evitar sesgos de selección en un ensayo clínico es recomendable:

- a) Hacer doble ciego
- b) Tener un buen tamaño muestral
- c) Aleatorizar
- d) Solicitar consentimiento informado
- e) Usar un placebo

86) Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes año, presenta disnea de esfuerzo. Se solicita una espirometría que muestra CVF: 90% del teórico, VEF1: 65% del teórico, relación VEF1/CVF: 58%. Al administrar salbutamol, los valores son CVF: 92% del teórico, VEF1: 68% del teórico, relación VEF1/CVF: 60%. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión pulmonar
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Cáncer pulmonar
- d) Asma bronquial
- e) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

87) Un paciente de 50 años está convencido de que un grupo de narcotraficantes quiere matarlo. Explica que hay un automóvil que con frecuencia lo sigue y que suele estacionarse cerca de su casa para espiarlo e intervenir su teléfono. Cuenta que hace cerca de un año realizó una denuncia de que en el colegio de su hijo vendían drogas y que por eso la banda delictual lo acosa. La familia está muy preocupada, ya que no han visto nada especial y creen que algo raro le pasa a su padre. No ha presentado alucinaciones y se desempeña normalmente en sus otras actividades. El diagnóstico es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Esquizofrenia
- d) Depresión psicótica
- e) Episodio maniaco

88) Una mujer de 60 años, asintomática, presenta un tumor anexial al tacto vaginal. Se solicita ecografía que lo muestra como un tumor sólido-quístico de 6 cm de diámetro, con increspaciones y sin líquido libre. El Ca-125 resulta 130 (VN: menor a 35). El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Quiste folicular
- c) Endometrioma
- d) Teratoma
- e) Cuerpo albicans

89) Un paciente de 60 años, diabético, consulta por edema marcado de extremidades inferiores. Al examen físico presenta PA: 120/80 mmHg, FC: 72x', RR2T sin soplos y examen pulmonar normal. Se constata edema blando ++++ en las extremidades inferiores, con algo de edema palpebral. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 0,7 mg/dl; índice proteinuria/creatininuria: 3,2; sedimento de orina: normal; albuminemia: 2,7 g/dl, colesterol: 260 g/dl, TG: 210 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Nefropatía diabética
- c) Síndrome nefrótico
- d) Glomerulonefritis por depósito de IgA
- e) Poliangeítis microscópica

90) Un paciente de 9 meses presenta un cuadro diarreico severo, con sequedad de mucosas, ojos hundidos y sopor profundo. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar sales de rehidratación por boca
- b) Administrar sales de rehidratación por sonda nasogástrica
- c) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
- d) Administrar suero glucosado al 5% + 1g KCl + 2g NaCl por vía endovenosa
- e) Administrar suero hipertónico de NaCl al 3% por vía endovenosa

SEGUNDA PARTE

1) Un niño de 1 año presenta palidez. Se solicita hemograma que muestra anemia microcítica, con hemoglobina de 9,0 g/dl y VCM de 75 ft. El diagnóstico más probable es:

- a) Talasemia
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Anemia ferropénica
- d) Anemia fisiológica del lactante
- e) Microesferocitosis familiar

2) Una paciente de 29 años presenta algunas lesiones en la piel, las que detectó hace una semana. Además ha presentado epistaxis en varias oportunidades en el último mes y sus reglas se han vuelto más abundantes. Al examen físico se aprecia un rash petequeal que compromete en especial las extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un hemograma con recuento de plaquetas
- b) Iniciar aspirina
- c) Solicitar TTPA y tiempo de protrombina
- d) Solicitar orina completa y biopsia de alguna de las lesiones cutáneas
- e) Solicitar sedimento de orina y niveles plasmáticos de IgA

3) Una mujer presenta embarazo de 16 semanas y acude a control obstétrico habitual, constatándose PA: 150/95 mmHg. Se realiza toma de presión varias veces en las siguientes horas, con varios valores sobre 140/90. La proteinuria cualitativa resulta 1+. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial crónica
- b) Hipertensión arterial transitoria del embarazo
- c) Preclamsia moderada
- d) Preclamsia severa
- e) Eclamsia

4) Una paciente de 60 años consulta por artralgias de manos de un mes de evolución. Refiere rigidez matinal de pocos minutos de duración y que el dolor aumenta al hacer actividades con las manos. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia ósea en algunas articulaciones interfalángicas distales. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Artrosis
- c) Artritis reumatoide
- d) Lupus
- e) Artritis psoriática

5) En un estudio de cohortes, se determina que fumar tiene un riesgo relativo de 5 para el desarrollo de cierta patología, con un intervalo de confianza de 95% de 4,8-5,2. Se puede afirmar que:

- a) El 5% de los pacientes que fuman, desarrollarán la patología
- b) El 95% de los pacientes que fuman, tienen mayor riesgo de presentar esa patología
- c) Los pacientes que fuman tienen entre un 4,8% y un 5,2% más riesgo de enfermar que aquellos que no fuman
- d) Los pacientes que fuman tienen 5 veces más riesgo de enfermar la patología en cuestión, comparados con los no fumadores
- e) No existe un mayor riesgo de enfermar de dicha enfermedad, si es que se fuma

6) Un paciente de 65 años, portador de una cardiopatía hipertensiva, en capacidad funcional 2, consulta por aumento de su disnea basal de cerca de una semana de evolución que en el último día se ha hecho de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia FC: 120x', PA: 150/90 mmHg, taquipneico, con crepitaciones pulmonares basales y ritmo irregular en 2 tiempos. Satura 88% a FiO2 ambiental y su electrocardiograma muestra fibrilación auricular. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar propafenona endovenosa
- b) Realizar cardioversión eléctrica inmediata
- c) Administrar adenosina oral
- d) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y morfina y solicitar electrocardiograma y marcadores de daño miocárdico seriados
- e) Administrar un digital endovenoso e iniciar anticoagulación con heparina

7) Un paciente de 18 años presenta un cuadro de 10 días de diarrea, asociada a fiebre alta. Al examen físico se aprecia FC: 60x', PA: 120/80 mmHg, T°: 39,6°C. Se palpa esplenomegalia y algunas adenopatías cervicales y es posible ver algunas lesiones eritematosas maculares. Su hemograma muestra blancos: 3.400 por mm³, con 70% de neutrófilos, 15% de baciliformes, 0% de eosinófilos, plaquetas: 160.000 y hemoglobina: 15 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para establecer el diagnóstico en este cuadro clínico?

- a) Hemocultivo
- b) IgM para leptospira
- c) Examen de gota gruesa
- d) Biopsia de médula ósea
- e) IgM-VCA e IgM-CMV

8) Un niño de 5 meses de edad presenta decaimiento y fiebre hasta 38,4°C. Al examen físico está en buenas condiciones, algo decaído, sin alteraciones en el examen físico, salvo t°: 38,3°C. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar paracetamol y controlar ambulatoriamente
- b) Solicitar hemograma, hemocultivos y exámenes de orina y decidir manejo según resultados
- c) Iniciar antipiréticos y antibióticos orales y controlar ambulatoriamente
- d) Solicitar hemograma, hemocultivo, exámenes de orina, punción lumbar y decidir manejo según resultados
- e) Solicitar hemograma, hemocultivo, exámenes de orina, punción lumbar e iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa, a la espera de los resultados

9) Un paciente de 68 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de fiebre, malestar general y tos con expectoración mucopurulenta. Al examen físico presenta crepitaciones en la base derecha. Su estado general el bueno, respira normalmente y tiene saturación arterial de 96% a FiO2 ambiental. Su hemograma demuestra leucocitosis de 16.000, con desviación izquierda y su radiografía muestra una imagen de condensación en todo el lóbulo inferior derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona + cloxacilina ev
- b) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona + levofloxacino
- c) Hospitalizar e iniciar clindamicina ev
- d) Enviar a domicilio con amoxicilina + ácido clavulánico y controlar de modo ambulatorio
- e) Enviar a domicilio con amoxicilina y controlar de modo ambulatorio

10) Es una contraindicación absoluta del uso de anticonceptivos orales:

- a) Antecedentes familiares de cáncer de mama
- b) Promiscuidad sexual
- c) Diabetes mellitus
- d) Metrorragia de origen no precisado
- e) Endometriosis

11) Un paciente de 65 años presenta un cuadro clínico compatible con una depresión mayor. ¿Qué examen le parece más adecuado para descartar el hipotiroidismo como diagnóstico alternativo?

- a) T4 + T3
- b) T4 libre
- c) Tioglobulina
- d) Hormona tiroestimulante
- e) Anticuerpos anti-TPO

12) Un recién nacido de un día de vida, presenta ictericia generalizada, que empezó a las pocas horas de vida. Se constata Hcto: 39%, Bilirrubina: 14 mg/dl, Bilirrubina directa: 0,4 mg/dl. Su madre es de grupo O-Rh(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia biliar primaria
- b) Hipotiroidismo congénito
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
- e) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico

13) Un paciente de 56 años consulta por dolor anal muy intenso, que inició hace 24 horas, mientras manejaba. El dolor aumenta con la defecación y al sentarse y al examen físico se aprecia aumento de volumen perianal, de 2 cm de diámetro, de color violáceo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis hemorroidal externa
- b) Fluxión hemorroidal
- c) Absceso perianal
- d) Fisura anal aguda
- e) Fístula perianal

14) Un paciente termina una relación amorosa de 2 años de duración, evolucionando con ánimo bajo, algo irritable durante el mes siguiente. Ha descuidado su aspecto y consume más alcohol de lo habitual, sin embargo mantiene normalmente sus actividades laborales y no ha cambiado de peso. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por estrés agudo
- b) Depresión
- c) Trastorno por adaptación
- d) Trastorno de personalidad dependiente
- e) Distimia

15) Un paciente sufre un traumatismo facial, observándose un hematoma del tabique nasal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar taponamiento anterior
- b) Puncionarlo con aguja
- c) Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso y observar evolución
- d) Indicar analgésicos y observar evolución
- e) Realizar drenaje quirúrgico de inmediato

16) Una paciente de 48 años consulta por un cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal tipo cólico, asociado a deposiciones diarreicas acuosas, abundantes de 5-8 veces por día. Al examen físico se aprecia hidratada, con abdomen sensible, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis parasitaria
- b) Colitis bacteriana
- c) Colitis viral
- d) Colitis ulcerosa
- e) Trombosis mesentérica

17) Un paciente diabético tipo 2, consulta por visión de luces y manchas negras con el ojo derecho, de un día de evolución. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Retinopatía diabética proliferativa
- c) Glaucoma
- d) Desprendimiento de retina
- e) Hemorragia vítrea

18) Una mujer de 40 años presenta reglas muy abundantes, regulares. Al examen físico se palpa un útero aumentado de tamaño, de consistencia nodular. En sus exámenes de sangre destaca anemia ferropénica. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Adenomiosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Miomatosis uterina
- e) Endometriosis

19) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por astenia y disfunción sexual. Refiere que desde hace algún tiempo presenta dificultad para mantener las erecciones y además su deseo sexual ha bajado considerablemente. Su estado de ánimo en general es bueno, sin embargo está preocupado por su situación. Al examen físico se aprecia disminución del vello corporal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipotiroidismo
- b) Insuficiencia suprarrenal
- c) Impotencia sexual del tipo vascular
- d) Hipogonadismo
- e) Envejecimiento normal

20) Un lactante de 6 meses de edad presenta un cuadro de llanto inconsolable de una hora de duración, que luego es seguido de deposiciones rojas explosivas. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia mesentérica
- b) Invaginación intestinal
- c) Vólvulo
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Púrpura de Schönlein Henoch

21) Un paciente de 71 años, portador de una cardiopatía hipertensiva, consulta por dolor abdominal muy intenso, de inicio súbito, de ubicación periumbilical, asociado a vómitos y deposiciones explosivas. Al examen físico está adolorido, taquicárdico, con pulso irregular y se constata abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica tipo B
- b) Aneurisma aórtico abdominal roto
- c) Embolia mesentérica
- d) Diverticulitis aguda
- e) Úlcera péptica perforada

22) Un paciente de 40 años consulta por dificultad para tragar, que inició hace 2 meses y que ha ido en aumento, afectando tanto a la ingesta de sólidos, como a la de líquidos, aunque en ocasiones es menos intensa. Ha bajado cerca de 4 Kg de peso. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de esófago
- b) Esófago de Barret
- c) Divertículo esofágico
- d) Estenosis esofágica por reflujo
- e) Acalasia esofágica

23) Un paciente de 8 meses de edad, previamente sano, presenta un cuadro de rinorrea y tos, que al día siguiente se acompaña de taquipnea y cianosis perioral con el llanto. Al examen físico presenta FC: 110x', FR: 24x', saturación de O₂: 96% y se constatan sibilancias bilaterales espiratorias escasas y retracción intercostal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol nebulizado y oxígeno y reevaluar
- b) Administrar corticoides sistémicos, adrenalina racémica inhalada y oxígeno y reevaluar
- c) Enviar a domicilio con corticoides inhalados y salbutamol en caso de síntomas
- d) Administrar antibióticos endovenosos, oxígeno y salbutamol en caso de síntomas
- e) Hospitalizar en UCI, con oxígeno por mascarilla de recirculación, salbutamol inhalado, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos

24) Un paciente de 35 años presenta placas eritematosas y descamativas en el cuero cabelludo, sin pasar la línea de implantación del pelo, algo pruriginosas, con algunas lesiones similares en el puente nasal. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis
- b) Dermatitis de contacto
- c) Dermatitis atópica
- d) Queratosis actínicas
- e) Dermatitis seborreica

25) Un paciente de 50 años, obeso, presenta dolor torácico intenso, de carácter opresivo, que inició hace 60 minutos y que se irradia al dorso. Se solicita un electrocardiograma que demuestra supradesnivel del ST en las derivaciones V1 a V4. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Pericarditis aguda
- c) Pericarditis constrictiva
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Tromboembolismo pulmonar

26) Una paciente de 40 años asegura que un famoso cantante está enamorado de ella y que mantiene una relación con él a distancia. Cuenta que las canciones que escribe están dedicadas a ella y que no están juntos, porque el manager del cantante se lo impide, para no dañar su carrera. Al ser confrontada, no es capaz de aceptar que pudiese estar equivocada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno bipolar en fase maníaca
- d) Trastorno de personalidad histriónica
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

27) Una mujer está en trabajo de parto, a las 39 semanas de gestación. Presenta dilatación de 2 cm, con membranas íntegras, feto en cefálica y 4 contracciones cada 10 minutos. Se constata presencia de vesículas localizadas en el labio mayor izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar aciclovir endovenoso
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar tocolíticos
- d) Realizar rotura artificial de membranas
- e) Dejar a evolución espontánea

28) Un paciente presenta debilidad a los movimientos masticatorios, asociado a pérdida de la sensibilidad de la hemicara izquierda. El reflejo corneal izquierdo está disminuido. No presenta otras alteraciones. ¿Qué estructura está afectada?

- a) Nervio trigémino
- b) Nervio oculomotor
- c) Fascículo longitudinal medial
- d) Nervio facial
- e) Nervio troclear

29) Una mujer presenta un quiebre en su relación hace un mes, evolucionando con ánimo disfórico y ansiedad. Consulta por un cuadro de inicio súbito, de llanto, disnea, sensación de opresión torácica, palpitaciones, vértigo y la idea de que presentará un infarto cerebral y se morirá. En las últimas 3 semanas ha presentado 4 episodios similares, que cedieron espontáneamente luego de 15-30 minutos y está muy preocupada. El examen físico es normal y no consume fármacos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Depresión
- c) Trastorno adaptativo
- d) Crisis de pánico inespecífica
- e) Trastorno de estrés agudo

30) Un paciente de 60 años, hospitalizado por un infarto, presenta diuresis sólo una vez al día, que él refiere como "concentrado". La conducta más adecuada, de entre las siguientes es:

- a) Solicitar creatinemia e instalar sonda Foley para cuantificar la diuresis
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Administrar diuréticos de asa por vía endovenosa
- d) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
- e) Solicitar sedimento de orina y urocultivo

31) Un niño aún no habla, pero se ríe a carcajadas al interactuar con un adulto. No puede mantenerse sentado, pero levanta la cabeza sin problemas y es capaz de girar de la posición supina a la prona. Además toma un objeto y se lo lleva a la boca. ¿Qué edad tiene aproximadamente?

- a) 2 meses
- b) 4 meses
- c) 6 meses
- d) 8 meses
- e) 10 meses

32) Un paciente de 18 años, estudiante de primer año de ingeniería comercial, empieza a consumir ritalín (metilfenidato) con la intención de obtener mejores calificaciones en la universidad. Inicialmente presenta buenas notas, sin embargo algunas semanas después comienza con la idea de que ya no necesita estudiar porque sabe todo lo que necesita para ser exitoso, incluso irrumpe en la oficina del rector para exigirle que lo titulen ese año o que se atengan a las consecuencias de una demanda que interpondrá. Al entrevistarle habla toda la entrevista y en ocasiones pasa de fácilmente de un tema a otro. El diagnóstico más probable es:

- a) Manía aguda
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno de personalidad narcisista
- e) Psicosis aguda por fármacos

33) Un paciente diabético tipo 2 está en tratamiento con metformina en dosis máxima, asociada a insulina NPH matinal 26 UI por vía subcutánea. Se realiza control metabólico, constatándose glicemia de ayuno por sobre 160 mg/dl, aunque las glicemias durante el día son cercanas a lo normal. Su hemoglobina glicosilada es 8%. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar insulina cristalina matinal
- b) Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Agregar glibenclamida al tratamiento
- e) Reemplazar la insulina NPH por insulina cristalina

34) En un consultorio se atienden cerca de 100 pacientes al día, durante 5 días a la semana (lunes a viernes). Se estima que en el invierno, la demanda por atención aumentará en un 50% por lo que se ha decidido contratar a nuevos médicos. Como antecedente sabe que cada médico es capaz de ver 5 pacientes por hora. ¿Cuántos médicos adicionales y por cuántas horas semanales se deben contratar para cubrir el incremento esperado de la demanda?

- a) Se necesita un médico, por 11 horas semanales
- b) Se necesita un médico, por 22 horas semanales
- c) Se necesita un médico, por 44 horas semanales
- d) Se necesitan dos médicos, por 44 horas semanales cada uno
- e) Se necesitan tres médicos, por 44 horas semanales cada uno

35) Un recién nacido de término presenta taquipnea y cianosis, que no responde a oxígeno. Se aprecia excavación abdominal y la radiografía de tórax muestra imágenes circulares aéreas en el tórax. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita cianótica
- b) Síndrome de aspiración meconial
- c) Hernia diafragmática
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Secuestro pulmonar

36) Una paciente de 30 años presenta palidez, por lo que se decide realizar un hemograma que muestra hematocrito: 30%, VCM: 74 ft, plaquetas: 300.000 por mm³ y blancos: 6.400 con fórmula diferencial normal. Los niveles plasmáticos de ferritina están disminuidos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hierro oral
- b) Solicitar ferremia y niveles plasmáticos de transferrina
- c) Solicitar recuento de reticulocitos y electroforesis de proteínas para descartar talasemia
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitan niveles plasmáticos de vitamina B12

37) Una paciente acude a control ginecológico, constatándose en la especuloscopia la presencia de una lesión polipoidea de 1 cm de diámetro en el cuello uterino. Su último PAP fue realizado hace 6 meses y fue informado como normal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar nuevo PAP
- c) Realizar cono
- d) Realizar colposcopia y biopsia de la lesión
- e) Realizar crioterapia

38) Recientemente se han producido varios casos de meningitis bacteriana aguda por *meninococo W135*, razón por la cual el gobierno ha decidido implementar un programa de vacunación a toda la población pediátrica de riesgo. ¿A qué tipo de medida corresponde esta acción?

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Minimización de costos
- e) Maximización de beneficios

39) Un paciente de 54 años presenta astenia y malestar general de algunos meses de evolución. Se solicitan exámenes entre los que destacan GOT y GPT cercanas a 200 UI/L, por lo que se decide solicitar serología viral que muestra: IgG-VHA(+), IgM-VHA(-), IgG-VHC(+), IgM-VHC(-), IgG-anti VHBc(-), IgM-anti VHBc(-), IgG-anti VHBs(+), IgM-anti VHBs(-), Antígeno VHBs(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B aguda
- c) Hepatitis B crónica
- d) Hepatitis C
- e) Hepatitis B y C

40) Un lactante presenta pápulas y eritema en las mejillas y en los codos. Al examen físico se ve de buen aspecto. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema tóxico
- b) Dermatitis de contacto
- c) Dermatitis atópica
- d) Sarna
- e) Dermatitis seborreica

41) Un paciente de 60 años sufre una endocarditis aguda, la que es tratada con gentamicina + cloxacilina endovenosa, ketoprofeno y soporte. Durante su evolución, presenta elevación de la creatinina a 4,3 mg/dl, con BUN: 50 mg/dl. Su sodio urinario resulta 30 mEq/L y la fracción excretada de sodio es 5%, con sedimento de orina con cilindros granulosos. La ecografía abdominal es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Glomerulonefritis aguda asociada a endocarditis
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Nefritis intersticial
- e) Embolia renal séptica

42) La policía encuentra a un hombre de entre 30 y 40 años caminando solo por la calle. Cuenta que estuvo paseando por el río y que siempre ha vivido ahí. Al examinarlo no tiene lesiones y no recuerda su nombre ni nada respecto a su biografía. Parece indiferente, coopera con el interrogatorio y está orientado en el tiempo y espacio. Su examen físico, así como su estudio, descartan patología orgánica.

Un par de días después aparece su familia, diciendo que había desaparecido hace una semana, sin llevarse nada y sin tomar contacto con ellos. Estaría pasando por serios problemas laborales, económicos y familiares. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno esquizotípico de la personalidad
- c) Trastorno disociativo
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno delirante crónico

43) Un paciente de 30 años sufre una caída apoyando ambas manos en el suelo. Evoluciona con dolor en la mano derecha y al examen se constata dolor al presionar la tabaquera anatómica derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión de mano
- b) Fractura de la apófisis estiloides
- c) Luxación carpo-metacarpiana
- d) Fractura de escafoides
- e) Atrapamiento del nervio mediano

44) Un niño de 3 años presenta un cuadro de disentería, evolucionando con deterioro del estado general. Al examen físico se aprecia hipertensión arterial y edema de extremidades inferiores. Además se observan algunas Petequias en el tronco y las extremidades. El examen cardiovascular es normal. Su orina muestra hematuria y el hemograma muestra Hb: 7 g/dl, Hcto: 21%, plaquetas: 31.000 por mm³ y blancos: 16.400 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Sepsis por shigella
- b) Glomerulonefritis postinfecciosa
- c) Púrpura de Schönlein Henoch
- d) Coagulación intravascular diseminada
- e) Síndrome hemolítico urémico

45) Un paciente de 44 años consulta por dolor tipo puntada de costado derecho, de una semana de evolución, con tope inspiratorio. Al examen físico se constata matidez y disminución del murmullo vesicular derecho. Se realiza una radiografía de tórax que confirma la presencia de un derrame pleural, el que se punciona, dando salida a líquido claro, con LDH: 200 UI/L, proteínas: 5,0 g/dl, células: 1.030 por mm³, con 90% de mononucleares. La LDH plasmática es de 270 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Empiema
- d) Derrame paraneumónico simple
- e) Insuficiencia cardíaca

46) Una paciente de 60 años se realiza una mastectomía parcial, debido a un cáncer de mama, con buen resultado quirúrgico. Sin embargo al tercer día postquirúrgico inicia fiebre y se observa eritema y exudado purulento en la herida. ¿Qué tratamiento antibiótico recomendaría?

- a) Cloxacilina
- b) Ceftriaxona
- c) Ceftriaxona + metronidazol
- d) Penicilina
- e) Ciprofloxacino

47) Un paciente hipertenso de 60 años está en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg/día. Acude a control, constándose presiones arteriales cercanas a 150/100 mmHg, por lo que se inicia enalapril 20mg cada 12 horas. Lo controla un mes después con presiones arteriales cercanas a 120/80 mmHg, sin embargo el paciente refiere que ha presentado mucha tos seca desde que cambió el tratamiento. El examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Disminuir la dosis de enalapril a 10 mg c/12 horas
- b) Suspender la hidroclorotiazida
- c) Reemplazar el enalapril por amlodipino
- d) Reemplazar el enalapril por losartán
- e) Mantener el tratamiento y observar evolución

48) Una paciente de 30 años presenta amenorrea de 8 semanas, con test de embarazo positivo. Se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. Los niveles plasmáticos de beta-HCG resultan 7.000 UI/L. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- b) Solicitar nueva beta-HCG en 2 días
- c) Realizar legrado
- d) Administrar metotrexato
- e) Resolver de manera quirúrgica

49) Un paciente, con antecedente de Enfermedad de Von Willebrand, ingresa de urgencia, para tratamiento quirúrgico de una hernia inguinal atascada. ¿Cómo debe ser manejado este paciente desde el punto de vista anestésico?

- a) Debe recibir anestesia general, con máscara laríngea para el manejo de su vía aérea
- b) Debe recibir anestesia local
- c) Debe recibir anestesia general, con intubación en secuencia rápida
- d) Debe recibir anestesia general, con intubación guiada por fibroscopía
- e) Debe recibir anestesia raquídea

50) Una mujer de 50 años enviudece hace 6 meses, evolucionando ánimo bajo marcado, anhedonia y la idea de que morirá pronto. Sale poco de su casa, se junta muy poco con sus hijos y refiere que su cuerpo está muerto, como el de un "zombie" y que no hay forma de salvarla. Come muy poco y ha bajado cerca de 10 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. Su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Duelo normal
- c) Depresión mayor
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno delirante crónico

51) Un paciente de 30 años consulta por ardor ocular y ojo rojo bilateral. Al examen físico se aprecia ojo rojo periférico, con reacción tarsal folicular y presencia de una adenopatía preauricular derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis alérgica
- b) Conjuntivitis viral
- c) Conjuntivitis bacteriana
- d) Uveítis aguda
- e) Queratitis aguda

52) Un paciente de 68 años es hospitalizado tras una prostatectomía radical por cáncer de próstata, quedando con una sonda Foley. Al cuarto día, presenta malestar general y fiebre, asociado a disuria dolorosa. Se constata puñopercusión positiva a izquierda y el urocultivo es positivo para Pseudomona aureginosa sensible. ¿Qué tratamiento antibiótico le parece más adecuado para este paciente?

- a) Cefadroxilo oral
- b) Cefazolina endovenosa
- c) Ceftazidima + amikacina endovenosa endovenosa
- d) Ceftriaxona endovenosa
- e) Imipinem + vancomicina endovenosa

53) Una mujer de 20 años consulta por leucorrea. Al examen se ve una leucorrea grisácea, con olor a pescado, sin cambios inflamatorios en las paredes vaginales. El tratamiento de elección es:

- a) Clotrimazol tópico
- b) Fluconazol oral
- c) Cotrimoxazol oral
- d) Metronidazol oral
- e) Cefprofloxacino + doxicilina oral

54) Un paciente de 38 años presenta disnea de esfuerzo de una cuadra, que inició hace un mes. Al examen físico presenta FC: 81x', PA: 110/70, se constata desplazamiento del choque de la punta y edema de extremidades inferiores. La auscultación cardíaca muestra un ritmo regular en 3 tiempos, con presencia de un tercer ruido, sin soplos y la auscultación pulmonar demuestra crépitos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Cardiopatía coronaria
- c) Pericarditis constrictiva
- d) Tromboembolismo pulmonar crónico
- e) Valvulopatía mitral

55) Un lactante de 12 meses de vida presenta diarrea acuosa abundante, con deposiciones explosivas de color amarillo. Su temperatura es 38,6°C y presenta deshidratación moderada. El agente causal más probable es:

- a) Rotavirus
- b) Shiguella
- c) Salmonella
- d) Escherichia coli
- e) Estafilococo áureo

56) Un paciente de 10 años es atropellado por un auto, resultando con golpe en la cabeza contra el pavimento. Inicialmente está consciente, adolorido, sin embargo algunos minutos después evoluciona con compromiso de consciencia. Usted lo evalúa 20 minutos después del accidente, está en coma, con anisocoria. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma subdural
- b) Concusión
- c) Hemorragia subaracnoidea
- d) Hematoma epidural
- e) Contusión cerebral

57) Una mujer de 40 años, hipertensa y obesa, presenta metrorragia de 3 días de evolución. Se solicita ecografía transvaginal que muestra endometrio de 12 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado uterino
- b) Iniciar anticonceptivos orales
- c) Iniciar agonistas de la GnRH
- d) Realizar biopsia endometrial
- e) Solicitar laparoscopia

58) Un paciente de 20 años presenta astenia, asociado a baja de peso. Refiere que previo a esto presentaba deposiciones frecuentes, pastosas con dolor abdominal ocasional y meteorismo, que él atribuía al estrés. En sus exámenes generales destaca anemia ferropénica y calcemia de 8 mg/dl. Su parasitológico y coprocultivos son negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Colitis ulcerosa
- c) Enfermedad de Crohn
- d) Enfermedad celíaca
- e) Síndrome de intestino irritable

59) El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por:

- a) Agresividad, inestabilidad emocional y autoagresión
- b) Poco interés en las relaciones interpersonales
- c) Sentimiento de superioridad respecto a los demás y mal trato a quienes considera inferiores
- d) Falta de empatía, ausencia de culpa y conductas que van contra las normas legales y morales
- e) Sentido crítico de la sociedad, deseos de cambiar el sistema y preocupación por los más pobres

60) El tratamiento más adecuado para un niño de 7 años, cursando un púrpura trombocitopénico inmune, con 70.000 plaquetas por mm³ y escasas manifestaciones hemorrágicas es:

- a) Reposo y observación
- b) Corticoides orales
- c) Corticoides endovenosos
- d) Esplenectomía
- e) Transfusión de plaquetas

61) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis, siendo tratado según la norma chilena. Usted lo controla al cuarto mes de tratamiento, estando en fase bisemanal y corrobora sus baciloscopias: Mes 1: +++ ; Mes 2: ++ ; Mes 3: ++ ; Mes 4: +.

La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento y controlar con una nueva baciloscopía en un mes
- b) Solicitar PPD y radiografía de tórax
- c) Diagnosticar recaída y reiniciar el tratamiento
- d) Solicitar cultivo de Koch y derivar a especialista por fracaso al tratamiento
- e) Retomar el tratamiento en la fase diaria

62) Una paciente se realiza una histerectomía radical por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con escape continuo de orina por los genitales. No presenta dolor ni otros síntomas. El diagnóstico es:

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzo
- b) Incontinencia urinaria de urgencia
- c) Fístula vesico-vaginal
- d) Incontinencia por rebalse
- e) Vejiga neurogénica

63) Un paciente de 45 años consulta por fiebre alta y malestar general, asociado a disuria de 2 días de evolución. El tacto rectal es muy doloroso. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso perianal
- b) Prostatitis aguda
- c) Pielonefritis aguda
- d) Diverticulitis aguda
- e) Cólico renal

64) Un paciente de 12 años inicia tratamiento antibiótico endovenoso por una meningitis bacteriana aguda, sin embargo evoluciona con lesiones cutáneas generalizadas, dolorosas, que comenzaron como eritema y luego se transformaron en vesículas algunas hemorrágicas, abarcando cerca de un 60% del cuerpo. Se aprecia signo de Nikolski positivo. El diagnóstico es:

- a) Meningococcemia
- b) Síndrome de piel escaldada
- c) Necrosis epidermotóxica
- d) Síndrome de Steven Johnson
- e) Pénfigo

65) ¿Cuál es el mejor tipo de estudio para determinar la eficacia de un medicamento en el tratamiento de la hipercolesterolemia?

- a) Ensayo clínico
- b) Cohortes
- c) Casos y controles
- d) De intervención comunitaria
- e) Ecológico

66) Un paciente de 72 años consulta por astenia. Al examen físico se aprecia pálido, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 26%, VCM: 102 ft, hemoglobina: 8,9 g/dl, plaquetas: 54.000 x mm³, blancos: 2.800 por mm³, con fórmula diferencial normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina B12 y folatos
- b) Iniciar tratamiento con hierro oral
- c) Iniciar tratamiento con vitamina B12 intramuscular
- d) Solicitar biopsia de médula ósea
- e) Solicitar TSH y anticuerpos anti-TPO

67) Un paciente de 54 años consulta en el servicio de urgencia por astenia y malestar general de cerca de una semana de evolución. Refiere que orina mucho y que ha estado sediento, por lo que ingiere mucha agua. Además ha bajado 5 Kg de peso en el último mes. El examen físico es normal. Se solicita una glicemia que resulta 420 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta, ejercicios y metformina y derivar a policlínico de diabetes
- b) Indicar dieta, ejercicios, metformina y glibenclamida y derivar al policlínico de diabetes
- c) Administrar insulina cristalina 10 unidades por vía subcutánea y enviar a domicilio con dieta, ejercicio y metformina
- d) Administrar suero fisiológico 1.000 cc endovenosos y enviar a domicilio con dieta, ejercicio, metformina e insulina NPH
- e) Hospitalizar, administrar suero fisiológico e insulina cristalina y solicitar exámenes generales

68) Un paciente de 60 años presenta caída del calibre del chorro miccional, asociado a disuria de esfuerzo y latencia para orinar, de cerca de un año de evolución. Su tacto rectal es normal y su antígeno prostático es menor a 4 ng/ml. En un estudio de rutina se detecta creatininemia de 2,0 mg/dl y la ecografía abdominal muestra hidroureteronefrosis bilateral y residuo postmiccional elevado. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar bloqueadores alfa adrenérgicos
- b) Iniciar finasteride
- c) Realizar cistoscopia
- d) Realizar biopsia prostática transrectal
- e) Instalar sonda Foley y programar resección quirúrgica del adenoma prostático

69) La atención primaria en el sistema público de salud se financia mayormente a partir de:

- a) El aporte de los pacientes atendidos en la atención primaria del sistema público
- b) El aporte de los cotizantes de Fonasa
- c) El aporte estatal per cápita
- d) El aporte de los empleadores
- e) El aporte de las municipalidades

70) Un paciente de 40 años, fumador de 10 cigarrillos al día, se realiza una radiografía de tórax que muestra un nódulo pulmonar de 1,5 cm de diámetro, de bordes lisos en el lóbulo inferior izquierdo. Está asintomático y su examen físico es normal. No tiene radiografías previas. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con nueva radiografía en 3 meses
- b) Observar evolución
- c) Solicitar TAC de tórax con contraste
- d) Solicitar broncoscopia
- e) Realizar lobectomía inferior izquierda

71) Un niño de 4 años presenta cefalea y fiebre alta, constatándose rigidez de nuca. Se realiza una punción lumbar que da salida a un líquido con 900 células, con 95% polimorfonucleares, proteínas 108 mg/dl y glucosa: 29 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis tuberculosa
- b) Meningitis bacteriana aguda
- c) Meningitis viral
- d) Meningitis herpética
- e) Líquido cefalorraquídeo normal

72) Una paciente de 24 años presenta debilidad muscular de predominio proximal, asociada a fiebre ocasional y astenia. Cuenta que se le cansan los brazos al levantarlos mucho tiempo como para lavarse el pelo o peinarse. Además ha presentado artralgias. Su examen físico revela eritema sobre los nudillos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Lupus sistémico
- d) Vasculitis de vaso pequeño
- e) Arteritis de la temporal

73) Una paciente embarazada, de 30 semanas, consulta por disminución de los movimientos fetales. Al examen está en buenas condiciones y se solicita un registro basal no estresante (RBNE) que resulta "no reactivo" luego de 20 minutos de evaluación. La conducta más adecuada es:

- a) Extender el RBNE por 20 minutos más
- b) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Realizar cesárea de urgencia
- e) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio

74) Un paciente de 68 años, presenta un cuadro de malestar general, asociada a hematuria, sin otros síntomas. Su examen físico es normal y se solicita sedimento de orina, que confirma una hematuria de 80 GR por campo, con 20% de eritrocitos dismórficos. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de células renales
- b) Cáncer de vejiga urinaria
- c) Glomerulonefritis aguda
- d) Síndrome nefrítico
- e) Glomerulopatía membranosa

75) Una paciente de realiza su primera ecografía obstétrica, para confirmar edad gestacional, observando 2 sacos gestacionales intrauterinos, con el signo de la "T". Se puede afirmar que el embarazo gemelar es:

- a) Dicigótico
- b) Monocigótico
- c) Bicorial
- d) Monocorial
- e) Monoamniótico

76) Un paciente de 40 años presenta astenia, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia un bocio difuso de tamaño moderado y caída de la cola de las cejas. En sus exámenes se demuestra anemia moderada y TSH: 18 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow Graves
- b) Tiroiditis subaguda de Quervein
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Bocio multinodular tóxico
- e) Síndrome de eutiroideo enfermo

77) Una mujer de 20 años se realiza una histerectomía + anexectomía por un cáncer de ovario, con buena evolución desde el punto de vista oncológico, sin embargo presenta bochornos frecuentes y muy molestos. ¿Qué terapia de remplazo hormonal indicaría?

- a) Estrógeno solo oral
- b) Progestágeno solo oral
- c) Estrógeno + progestágeno oral
- d) Raloxifeno
- e) Ninguna

78) Un paciente de 80 años presenta lumbago crónico, irradiado a ambas extremidades inferiores y asociado a parestesias. El dolor aumenta al caminar, obligándolo a detenerse y cede al sentarse. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia del núcleo pulposo
- b) Espondilitis anquilosante
- c) Raquiostenosis
- d) Cáncer de próstata
- e) Enfermedad arterial periférica

79) Un lactante de 4 meses se alimenta exclusivamente de leche materna, sin embargo su madre deja de producir leche, por lo que decide iniciar leche en fórmula. ¿Qué alternativa le parece adecuada para este niño?

- a) Leche purita fortificada al 10% + azúcar al 2,5% + aceite al 1,5%
- b) Leche purita fortificada al 10% + azúcar al 2,5% + cereal al 3%
- c) Leche purita fortificada al 7,5% + azúcar al 2,5% + aceite al 1,5%
- d) Leche purita fortificada al 7,5% + azúcar al 2,5% + cereal al 3%
- e) Leche purita fortificada al 5% + azúcar al 2,5% + cereal al 3%

80) Un paciente presenta disminución de la sensibilidad en las cuatro extremidades, mayor en las extremidades inferiores, con afectación predominantemente distal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Tabes dorsal
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Polineuropatía

81) Un paciente de 60 años presenta vértigo muy intenso, asociado a hipoacusia y tinitus izquierdos. Al examen físico presenta nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo periférico
- b) Infarto cerebeloso
- c) Infarto de mesencéfalo
- d) Infarto de puente
- e) Infarto de bulbo raquídeo

82) Una mujer embarazada de 32 semanas inicia metrorragia, asociada a dolor abdominal. Se constata metrorragia escasa, con contracciones uterinas dolorosas e hipertensión uterina. No hay modificaciones cervicales. Se auscultan los latidos cardíacos a 110 x'. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar cesárea de urgencia
- c) Realizar fórceps
- d) Iniciar goteo oxitócico intravenoso
- e) Administrar nefedipino oral

83) Un paciente de 35 años de edad, bebedor habitual, consulta por malestar general, dolor abdominal, vómitos y fiebre de algunas horas de evolución. Al examen físico presenta hálito alcohólico y se aprecia ictericia de escleras, con abdomen sensible, pequeña matidez desplazable e hígado palpable y doloroso. En sus exámenes destaca Bilirrubinemia de 4,3 mg/dl, de predominio directo, GOT: 340 UI/L, GPT: 160 UI/L, GGT: 360 UI/L, FA: 120 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Peritonitis bacteriana espontánea
- b) Hepatitis viral aguda
- c) Cirrosis hepática
- d) Colédocolitiasis
- e) Hepatitis alcohólica

84) Una paciente de 78 años sufre una caída a nivel, evolucionando con imposibilidad de caminar. Al examinarla, no puede levantar el talón izquierdo de la camilla y se aprecia la extremidad inferior izquierda con cierto grado de abducción y rotación externa. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de pelvis
- b) Fractura de cadera
- c) Luxación anterior de cadera
- d) Luxación posterior de cadera
- e) Fractura de diáfisis femoral

85) Un niño de 3 años presenta claudicación de la marcha, asociada a fiebre hasta 41°C. Al examen físico está decaído y llora ante la movilización pasiva de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Perthes
- b) Sarcoma de Ewing
- c) Sinovitis transitoria
- d) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- e) Artritis séptica

86) Una paciente de 55 años consulta por disnea de esfuerzo y tos seca, de un mes de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, se aprecian crepitaciones pulmonares bilaterales, mayores en las bases. Además se aprecia hipocratismo digital. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis pulmonar
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Bronquiectasias
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Cáncer de pulmón

87) Una mujer de 30 años está en trabajo de parto, con adecuado avance, sin embargo luego de la salida de la cabeza fetal se produce una retención de hombros. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar fórceps
- b) Realizar cesárea
- c) Hiperflexar las caderas
- d) Iniciar goteo oxitócico
- e) Realizar compresión abdominal

88) Un paciente de 60 años presenta un cuadro de deterioro cognitivo progresivo, que inició hace 5 meses. Además ha presentado múltiples caídas y los familiares refieren que tiene incontinencia urinaria desde hace algún tiempo. Al examen está en buenas condiciones, sin signos focales en el examen neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Demencia vascular
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Enfermedad de Alzheimer

89) Una paciente de 24 años, primigesta, cursando su embarazo de 30 semanas, presenta salida de líquido claro por los genitales, constatándose salida de líquido amniótico por el OCE en la especuloscopia. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos por vía endovenosa y mantener una conducta expectante
- b) Administrar corticoides y antibióticos por vía endovenosa e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Realizar cesárea
- d) Interrumpir el embarazo con misoprostol
- e) Administrar corticoides y tocolíticos

90) Un paciente sufre una caída de 4 metros de altura, cayendo de pie. Presenta dolor en los talones, que le dificulta la marcha. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación astrágalo-calcánea
- b) Compresión del nervio ciático
- c) Talalgia benigna
- d) Fractura de calcáneo
- e) Esguince de tobillo

Respuestas:

PRIMERA PARTE	
Preguntas	Forma A
1	E
2	B
3	B

4	D
5	C
6	B
7	B
8	A
9	B
10	D
11	C
12	E
13	D
14	B
15	A
16	D
17	C
18	B
19	E
20	D
21	B
22	A
23	E
24	A
25	C
26	A
27	C
28	B
29	C
30	B
31	E
32	B
33	B
34	C

35	D
36	D
37	C
38	B
39	C
40	Anulada(ByE)
41	A
42	A
43	C
44	E
45	A
46	B
47	C
48	D
49	B
50	A
51	A
52	D
53	B
54	E
55	A
56	D
57	A
58	C
59	D
60	B
61	D
62	B
63	D
64	A
65	B

66	B
67	E
68	D
69	C
70	C
71	D
72	D
73	E
74	D
75	A
76	B
77	B
78	A
79	B
80	D
81	A
82	D
83	D
84	B
85	C
86	E
87	B
88	A
89	C
90	C

SEGUNDA PARTE

Preguntas	Forma A
1	C
2	A
3	A
4	B

5	D
6	E
7	A
8	A
9	D
10	D
11	D
12	E
13	A
14	C
15	E
16	C
17	D
18	D
19	D
20	B
21	C
22	E
23	A
24	E
25	D
26	A
27	B
28	A
29	A
30	A
31	Anulada
32	A
33	C
34	Anulada
35	C

36	A
37	D
38	A
39	D
40	C
41	C
42	C
43	D
44	E
45	A
46	A
47	D
48	E
49	C
50	C
51	B
52	C
53	D
54	A
55	A
56	D
57	D
58	D
59	D
60	A
61	D
62	C
63	B
64	C
65	A
66	D

67	E
68	E
69	C
70	C
71	B
72	B
73	A
74	C
75	Anulada (ByD)
76	C
77	A
78	C
79	C
80	E
81	A
82	B
83	E
84	B
85	E
86	B
87	C
88	D
89	A
90	D